



Centar

EESTI RAKENDUSUURINGUTE
KESKUS CENTAR

Turu-uuringute AS

Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti
tuleviku heaks



SOTSIAALMINISTEERIUM

Tallinn 2017

Uuringu autorid tänavad Eesti Puuetega Inimeste Koda abi eest puudega laste vanemate ühingute esindajatega läbiviidud fookusgrupi korraldamisel. Samuti täname kõiki fookusgrupis osalenud inimesi väärtusliku sisendi eest tulemuste mõtestamisel. Uuring põhineb puudega laste vanemate küsitlusel – täname kõiki laste vanemaid ja lähedasi, kes leidsid aja ja panustasid küsitlusele vastamisega uuringu valmimisse. Uuringu esialgse versiooni kohendamisse panustasid mitmed Sotsiaalministeeriumi ametnikud kommentaaride ja ettepanekutega uuringuraporti parandamiseks. Kommentaaride eest täname Mari Sarve, Hede Sinisaart, Signe Riisalo, Merit Korbet, Mari Kreitzbergi ja Tiina Linnot. Metoodika väljatöötamisse antud panuse eest kuulub tänu Kaja Sõstrale ja Andres Roostalule.

Küsitlusuuringu aluseks olev ankeet valmis uuringu **töörühma** koostöös. Töörühma kuulusid lisaks uuringu autoritele järgmised inimesed: Mari Sarv, Signe Riisalo, Merit Korbe, Mari Kreitzberg, Tiina Linno, Pille Vaiksaar, Kati Karelson, Anu Rentel, Ebeli Berkman, Merlin Murumets, Airi Nõmm. Täiendavalt andsid oma panuse ankeedi koostamisse: Aire Vares, Tiia Sihver, Mare Toompuu, Anu Irval, Raimo Saadi, Lemme Palmet ja Marina Runno.

Uuringu tellis Sotsiaalministeerium. Uuring on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused".

Uuringu autorid on:

Epp Kallaste, Ailen Lang, Marko Sõmer, Siiri-Lii Sandre, Sten Anspal Eesti Rakendusuuringu Keskusest Centar ja

Vaike Vainu Turu-Uuringute AS-st.

Lühikokkuvõtte tõlge inglise keelde: Eele Prints-De Tisi

Sisukord

MÕISTED	7
LÜHIKOKKUVÕTE	8
UURINGU EESMÄRK JA LÄBIVIIMINE.....	8
PUUDEGA LASTE ARV JA SELLE MUUTUS	8
PUUDEGA LASTEGA LEIBKONNAD JA LAPSE EEST PEAMISELT HOOLITSEV INIMENE	9
SOTSIAALMAJANDUSLIK OLUKORD	10
HOOLDUSKOORMUS	13
KÕRVALABI VAJADUS.....	14
HARIDUSTEENUSED	15
TERVISHOIUTEENUSED.....	17
ABIVAHENDITE VAJADUS JA KASUTAMINE	18
SOTSIAALTEENUSED	20
<i>Sotsiaalteenuste vajadus.....</i>	<i>20</i>
<i>Sotsiaalteenuste kättesaadavus.....</i>	<i>21</i>
TEAVE.....	22
SUMMARY	24
RESEARCH OBJECTIVE AND HOW RESEARCH WAS CONDUCTED	24
DISABLED CHILDREN: NUMBERS AND TRENDS	24
HOUSEHOLDS WITH DISABLED CHILDREN AND THE MAIN CARER OF THE CHILD.....	25
SOCIO-ECONOMIC SITUATION	26
CARE LOAD	29
NEED FOR EXTERNAL HELP.....	30
EDUCATION SERVICES.....	31
HEALTH CARE SERVICES	33
NEED FOR AND USE OF DISABILITY AIDS	35
SOCIAL SERVICES	36
<i>Need for social services</i>	<i>36</i>
<i>Availability of social services</i>	<i>37</i>
INFORMATION	38
SISSEJUHATUS	40
1 UURINGU METOODIKA.....	43
1.1 KÜSITLUSE METOODIKA	43
1.1.1 <i>Küsitluse taust</i>	<i>43</i>
1.1.2 <i>Küsitluse sihtrühm</i>	<i>43</i>
1.1.3 <i>Valimibaas.....</i>	<i>43</i>
1.1.4 <i>Valim ja kaalumine.....</i>	<i>44</i>
1.1.5 <i>Küsitlusmeetodite kirjeldus</i>	<i>46</i>
1.2 FOKUSGRUPP	48
1.3 ANALÜÜSI METOODIKA.....	48
1.3.1 <i>Tulemuste analüüs</i>	<i>48</i>
1.3.2 <i>Osakaalude hinnangud ja usalduspiirid</i>	<i>49</i>
1.3.3 <i>Logistiline regressioon.....</i>	<i>50</i>
1.3.4 <i>Kohandatud keskmised prognoosid</i>	<i>50</i>
1.3.5 <i>Tulemuste tõlgendamise näide</i>	<i>51</i>
1.3.5.1 <i>Osakaalude hinnangute näide</i>	<i>51</i>

1.3.5.2	Kohandatud keskmiste prognooside näide	52
2	PUUDEGA LAPSED JA NENDE PERED	54
2.1	PUUDEGA LASTE ARV JA PROFIIL	54
2.2	PUUDEGA LASTE LEIBKONNAD	58
2.3	PUUDEGA LAPSE EEST PEAMISELT HOOLITSEV INIMENE	60
3	PUUDEGA LASTE TOIMETULEK.....	63
3.1	PUUDEST TULENEVA KÕRVALABI VAJADUS	63
3.2	ABIVAHENDITE VAJADUS JA KASUTAMINE	70
3.2.1	<i>Abivahendite tagamise korraldus ja abivahendite vajadus</i>	<i>70</i>
3.2.2	<i>Abivahendite kasutamine ja nende vastavus vajadustele.....</i>	<i>77</i>
3.2.3	<i>Põhjused, miks abivahendit ei kasutata või miks abivahend ei vasta lapse vajadustele</i>	<i>78</i>
3.2.3.1	Vajatava abivahendi mitte kasutamine	78
3.2.3.2	Kasutatava abivahendi mittevastavus lapse vajadustele.....	79
3.3	KOKKUVÕTE	81
4	TERVISHOIUTEENUSED	83
4.1	ÕIGUS TERVISHOIUTEENUSTELE	83
4.2	TERVISHOIUTEENUSEID VAJANUD JA KASUTANUD PUUDEGA LAPSED	83
4.2.1	<i>Probleemid tervishoiuteenustega.....</i>	<i>85</i>
4.3	PEREARSTI VAJANUD LASTE OSAKAAL, TEENUSE KASUTAMISE SAGEDUS JA SEONDUVAD PROBLEEMID	85
4.4	ERIARSTI TEENUST VAJANUD LASTE OSAKAAL, KASUTAMISE SAGEDUS JA TEENUSEGA SEONDUVAD PROBLEEMID	90
4.5	ERAKORRALISE MEDITSIIINI TEENUSEID VAJANUD LASTE OSAKAAL, KASUTAMISE SAGEDUS JA TEENUSEGA SEONDUVAD PROBLEEMID	97
4.6	HAMBARAVI VAJANUD LASTE OSAKAAL, KASUTAMISE SAGEDUS JA TEENUSEGA SEONDUVAD PROBLEEMID.....	102
4.7	HAIGLARAVI VAJANUD LASTE OSAKAAL, KASUTAMISE SAGEDUS JA TEENUSEGA SEONDUVAD PROBLEEMID	107
4.8	TAASTUSRAVI, RAVIASUTSES ÖÖPÄEVARINGSE ÕENDUSABI JA KODUÕENDUSTEENUSE VAJADUS JA KASUTAMINE	111
4.8.1	<i>Ööpäevaringse õendusabi vajaduse ja saamisega seotud taustatunnused.....</i>	<i>113</i>
4.8.2	<i>Koduõendusteenuse vajadust ja saamist mõjutavad tegurid</i>	<i>115</i>
4.8.3	<i>Taastusravi vajadust ja kättesaadavust mõjutavad tegurid.....</i>	<i>115</i>
4.9	ALTERNATIIVMEDITSIIINI POOLE PÖÖRDUMINE	119
4.10	KOKKUVÕTE	121
5	SOTSIAALTEENUSED	123
5.1	ÜLDINE VAJADUS JA KÄTTESAADAVUS	123
5.2	SOTSIAALTEENUSTE VAJADUS JA KASUTAMINE TEENUSTE KAUPA GRUPPIDE LÖIKES.....	127
5.2.1	<i>Tugiisik.....</i>	<i>127</i>
5.2.2	<i>Sotsiaaltransport.....</i>	<i>129</i>
5.2.3	<i>Lapsehoiuteenus.....</i>	<i>131</i>
5.2.4	<i>Sotsiaaltöötaja poolne nõustamine</i>	<i>132</i>
5.2.5	<i>Rehabilitatsiooniplaani koostamine, täitmise juhendamine või tulemuste hindamine</i>	<i>134</i>
5.2.6	<i>Rehabilitatsiooniplaan</i>	<i>136</i>
5.2.7	<i>Füsioterapeut</i>	<i>140</i>
5.2.8	<i>Tegevusterapeut.....</i>	<i>142</i>
5.2.9	<i>Loovterapeut</i>	<i>145</i>
5.2.10	<i>Logopeed.....</i>	<i>147</i>
5.2.11	<i>Eripedagoog</i>	<i>149</i>
5.2.12	<i>Psühholoog.....</i>	<i>151</i>
5.2.13	<i>Kogemusnõustaja.....</i>	<i>153</i>
5.2.14	<i>Kokkuvõte.....</i>	<i>155</i>

5.3	PROBLEEMID SOTSIAALTEENUSTE SAAMISEL	157
5.3.1	<i>Probleemide üldine levik</i>	157
5.3.2	<i>Täiendavad probleemid ja põhjendused, miks teenus ei vastanud vajadustele</i>	159
6	HARIDUS	162
6.1	KOOLIEELES HARIDUSASUTUSES JA KOOLIS KÄIMINE.....	162
6.2	KOOLIEELNE HARIDUSASUTUS	164
6.2.1	<i>Lasteaia ja rühma liik</i>	164
6.2.2	<i>Lasteaias või sõimes käimisega seonduvad probleemid</i>	166
6.2.2.1	Sissejuhatus	166
6.2.2.2	Tugimeetmete kättesaadavus ja olemasolu haridusasutuses	166
6.2.2.3	Õppe vastavus vajadustele	170
6.2.2.4	Sotsiaalne keskkond	170
6.2.2.5	Füüsiline kaugus ja ruumidele ligipääs	171
6.2.2.6	Muud probleemid.....	171
6.2.3	<i>Kokkuvõte</i>	173
6.3	KOOLID	173
6.3.1	<i>Kooli, klassi ja õppekava liik</i>	173
6.3.2	<i>Kooliga seonduvad probleemid</i>	178
6.3.2.1	Sissejuhatus	178
6.3.2.2	Tugimeetmete kättesaadavus ja olemasolu haridusasutuses	178
6.3.2.3	Õppe vastavus vajadustele	180
6.3.2.4	Sotsiaalne keskkond	181
6.3.2.5	Füüsiline kaugus ja ruumidele ligipääs	182
6.3.2.6	Õppevormi vastavus vajadustele ja muud probleemid	183
6.3.2.7	Muud probleemid.....	183
6.3.3	<i>Kokkuvõte</i>	185
7	HOOLDUSKOORMUS	186
7.1	PUUDEGA LAPSE VANEMA TEADMISED LAPSE KASVATAMISEGA SEOTUD VALDKONDADES.....	186
7.2	PUUDEGA LAPSE LAPSEHOIUVÕIMALUSED.....	187
7.3	PUUDEGA LAPSE HOIDMISE VÕIMALUSTE TÄIENDAV VÕI SENISEST SUUREM VAJADUS.....	192
7.4	PUUDEGA LAPSE EEST HOOLITSEVA ISIKU SPETSIAALNE ETTEVALMISTUS	196
7.5	PUUDEGA LAPSE VANEMA HOOLDUSKOORMUS.....	200
7.6	HOOLDUSKOORMUSEGA KAASNEVAD PROBLEEMID	203
7.7	KOKKUVÕTE	212
8	SOTSIAAL-MAJANDUSLIK TOIMETULEK	214
8.1	ELURUUM JA SELLE KOHANDAMISVAJADUS	214
8.2	AUTO KASUTAMISE VÕIMALUS	219
8.3	SISSETULEKUD JA KULUTUSED	219
8.3.1	<i>Pere sissetulekud, toetused ja üldine hakkamasaamine</i>	219
8.3.2	<i>Puudega laste tarbeks tehtud kulutused ja nende katmine</i>	226
8.3.2.1	Kulude liigid	226
8.3.2.2	Kulude suurus	228
8.3.2.3	Rahaliste vahendite piisavus puudega laste vajaduste katmiseks	232
8.4	KOKKUVÕTE	233
9	TEAVE TOETUSTE JA TEENUSTE KOHTA	236
10	SOTSIAALSED SUHTED JA VÕRGUSTIKUD	243
10.1	KUULUMINE PUUDEGA LAPSE PEREDE ÜHENDUSTESSE.....	243
10.2	HOIAKUD.....	244

11	TULEMUSED, JÄRELDUSED JA SOOVITUSED	249
11.1	PUUDEGA LASTE ARV JA JAGUNEMINE.....	249
11.2	KÕRVALABI VAJADUS.....	249
11.3	ABIVAHENDID.....	250
11.4	TERVISHOIUTEENUSED.....	251
11.5	SOTSIAALTEENUSED	251
11.6	HARIDUS	254
11.7	HOOLDUSKOORMUS	254
11.8	ELURUUMIDE KOHANDAMISE VAJADUS	255
11.9	PUUDEGA LASTEGA PEREDE RAHALINE TOIMETULEK JA KULUD	255
11.10	TEAVE.....	257
11.11	SOOVITUSED JÄRGNEVATEKS UURINGUTEKS	257
LISA.	KÜSITLUSE ANKEET	259

Mõisted

Puue - inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega takistab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel.

Puudeliik - e. domineeriva puude liik - ekspertarsti poolt tuvastatud suurimaid piiranguid põhjustav valdkond. Eristatakse keele- ja kõne-, kuulis-, liikumis-, nägemis-, vaimupuue, psüühikahäire ja muu puuet. Mitmeid samatasemelisi piiranguid põhjustava valdkonna korral määratletakse puuet liitpuudena. Muupuue määratakse, kui suurimad piirangud on näiteks enesehoolduse valdkonnas, aga ka mitmete krooniliste haiguste korral nagu astma, allergia, diabeet jne. mida sageli saab kontrolli all hoida ravimite või range dieediga.

Meelepuue - kuulis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Puude raskusaste - Sügav, raske, keskmine puue

Keskmine puue - 0-15-aastastel - inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik regulaarset kõrvalabi või juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt korra nädalas. **16-17-aastastel** - igapäevases tegutsemises või ühiskonnaelus osalemises esineb raskusi.

Raske puue - 0-15-aastastel - inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet igal ööpäeval. **16-17-aastastel** - igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on piiratud.

Sügav puue - 0-15-aastastel - inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet ööpäevaringselt. **16-17-aastastel** - igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on täielikult takistatud.

Puudega laps - 0-17-aastane isik, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud puude raskusastme kehtiv otsus (e ametlikult tuvastatud puue).

Leibkond - inimesed, kes jagavad ühte elamispinda ning kasutavad ühiseid rahalisi ja/või toiduressursse. Leibkonna hulka kuuluvad ka need inimesed, kes elavad ajutiselt mujal kas õpingute, töö, kohustusliku ajateenistuse või muude sarnaste põhjuste tõttu, kuid sõltuvad majanduslikult leibkonnast. Raportis kasutatakse leibkonna sünonüümina **pere**.

Puudega lapse vanem - Puudega lapse leibkonnas olev liige, kellele langeb puudega lapse hoidmise- ja hoolduse suurim koormus. Uuringu raportis kasutatakse ka uuringu küsimustikule vastaja tähenduses. St inimesed, kes on puudega lapse eest peamiselt hoolitsevad, ka juhul kui nad ei ole puudega lapse vanemad.

Ööpäevaringne õendusabi raviasutuses ehk **iseseisev statsionaarne õendusabi** – endise nimetusega hooldusravi on mõeldud patsientidele, kes ei vaja pidevat arstiabi, kuid vajavad pärast traumat, rasket haigust, kroonilise haiguse ägenedes või raskest haigusest tingitud vaevuste leevendamisel abi. Statsionaarsele õendusabi teenusele suunab perearst või eriarst.

Koduõendusteenus ehk **ambulatoorne õendusabi** on suunatud inimestele, kes vajavad meditsiinilist abi, kuid mitte haiglas viibimist. Teenus hõlmab õendusplaani koostamist, õendusala nõustamist, patsiendi põetamist ning raviprotseduuride ja teatud laboriuuringute tegemist. Koduõendusteenusele suunab perearst või eriarst saatekirjaga, kus on märgitud vajalik arstiabi ning kirjeldatud õendusabi vajadus.

Lühikokkuvõte

Uuringu eesmärk ja läbiviimine

Käesoleva uuringu eesmärk oli kaardistada puudega lastega perede toimetulek ja vajadused. Selleks viidi 2017. aasta augustis-septembris puudega laste leibkondade seas läbi küsitlusuuring. Küsitluse valim koostati Sotsiaalkindlustusameti (SKA) registri põhjal 0-17-aastastest puudega lastest. Igas valimisse sattunud leibkonnas küsitleti puudega lapse eest peamiselt hoolitsevat inimest (edaspidi nimetatud kui puudega lapse vanem). Küsitlusankeedile vastas 1904 isikut.

Analüüsiraport keskendub küsitlustulemuste kirjeldamisele, võimaluste piires võrreldakse tulemusi 2009. aastal läbi viidud analoogse küsitluse andmetega ning võrreldakse ka lastega perede olukorraga Eestis üldisemalt, kasutades selleks Statistikaameti 2016. aasta Eesti Sotsiaaluuringu andmeid. Küsitlusandmete tulemustele tõlgenduste lisamiseks viidi läbi fookusgrupiintervjuu puudega laste peresid ühendavate organisatsioonide esindajatega.

Analüüsis kasutatakse valimipõhise küsitluse andmeid, millest tehakse järeldusi puudega laste kohta Eestis tervikuna (üldkogum). Selleks, et küsitluse andmetest teha järeldusi üldkogumi kohta, esitatakse hinnangud üldkogumi väärtustele 95%liste usaldusvahemikena. Vahemikud näitavad, milline on 95%lise tõenäosusega nähtuse levik puudega laste seas Eestis.

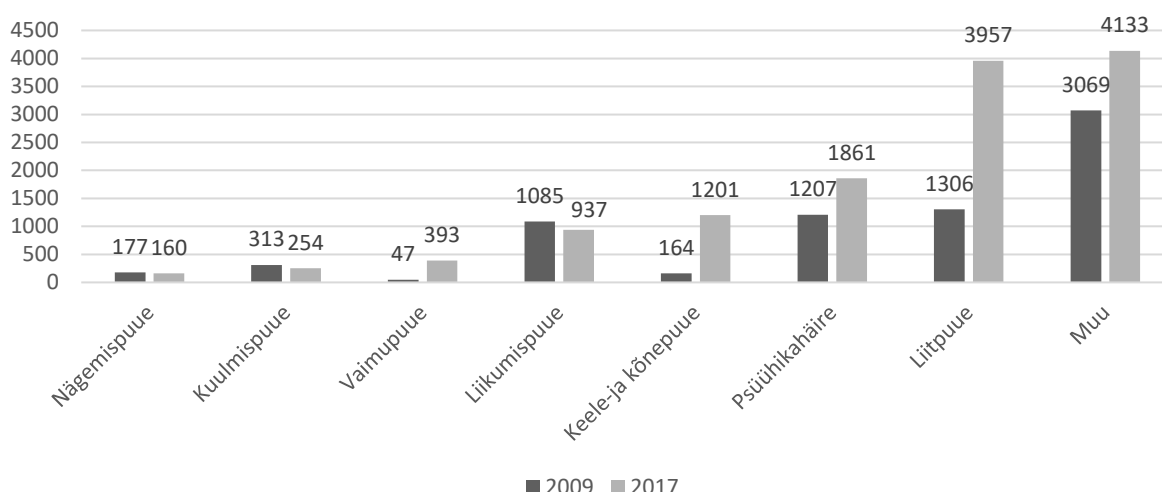
Uuringu tellis Sotsiaalministeerium, küsitlustööd ja analüüsi viisid läbi Turu-uuringute AS ja Eesti Rakendusuuringu Keskus Centar. Uuring on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused".

Puudega laste arv ja selle muutus

1. jaanuaril 2017. aastal oli puudega laste arv 12 896. Puudega laste arv on 2017. aastaks võrreldes 2009. aastaga pea kahekordistunud: 2009. aasta 1. jaanuari seisuga oli puudega lapsi 7 368. Puudega laste osakaal 0-17-aastastest Eesti lastest on samuti kasvanud: 3%lt 5,2%ni.

Sotsiaalkindlustusameti andmetel on 2017. aastal enimlevinud puude liigid liitpuue ja muu puue – kumbagi puuderühma kuulub ligi 4 000 last (Joonis 1). Psüühikahäirega laste arv on 1 861 ja sageduselt järgmisi – keele- ja kõnepuudega lapsi – on oluliselt vähem (1 201 last). Sagedamini esinevate puudeliikidega laste arv on kasvanud, samas on neist harvemini esinevate meelepuudega ja liikumispuudega laste arv mõnevõrra langenud. Kõige suurem on olnud kasv keele- ja kõnepuudega, vaimupuudega ja liitpuudega laste arvudes. Neist veidi väiksem on olnud psüühikahäire ja muu puudega laste arvu kasv.

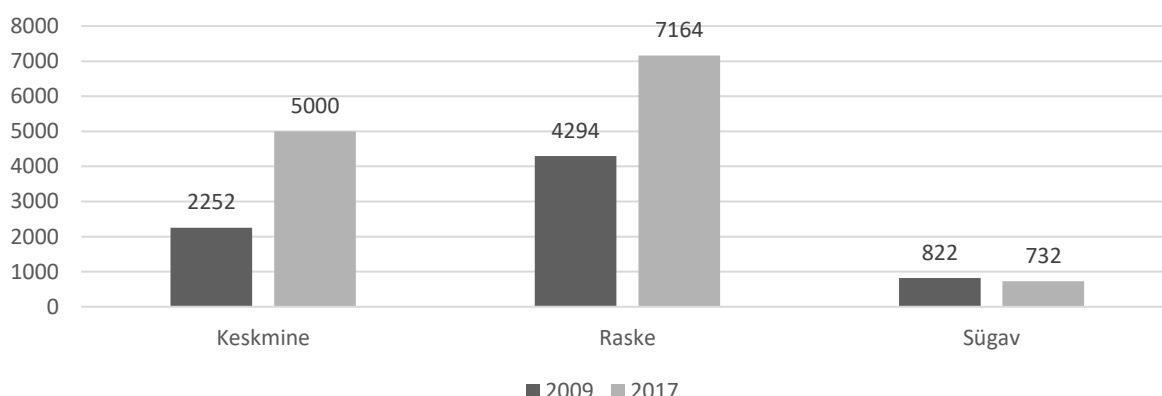
Joonis 1. 0-17-aastaste puudega laste arv domineeriva puude liigi järgi 1. jaanuari seisuga



Allikas: Sotsiaalkindlustusameti andmed

Puude raskusastmete lõikes on kõige rohkem lapsi raske puudega (Joonis 2). Võrreldes 2017. aastat 2009. aastaga, on sügava puudega laste arv jäänud üldjoontes samaks, kuid raske ja keskmise puudega laste arv on kasvanud. Seejuures kõige enam on kasvanud keskmise puudega laste arv.

Joonis 2. 0-17-aastaste puudega laste arv puude raskusastmete järgi 1. jaanuari seisuga



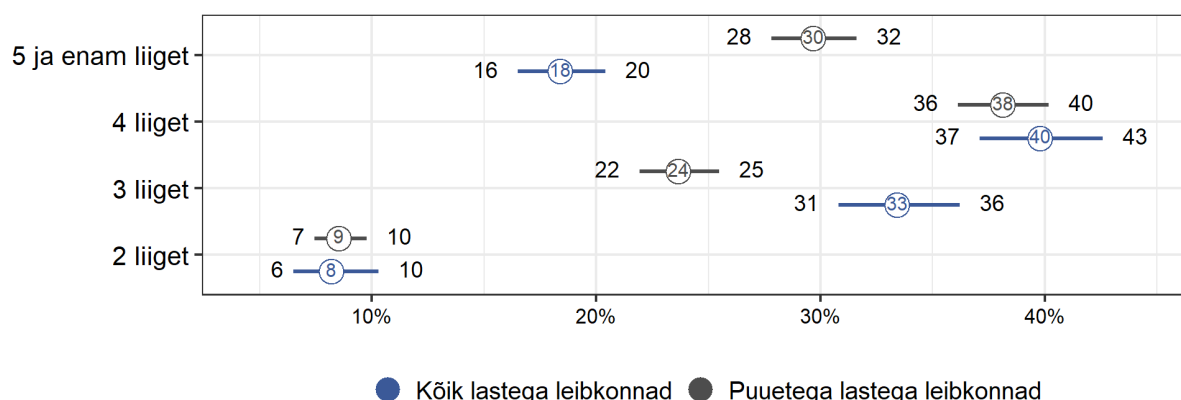
Allikas: Sotsiaalkindlustusameti andmed

Puudega lastega peresid ühendavate organisatsioonide esindajate sõnul on puudega laste arvu kasvul mitmeid põhjusi. Ühelt poolt on kasvanud puude määramise aluseks olevate haiguste diagnoosimine, samuti võib ravi efektiivsuse kasvu tõttu olla vähenenud puudega laste surmade arv. Teiselt poolt on laienenud võimalused puudega lastele vajalike teenuste ja rahaliste toetuste saamiseks ja samal ajal kasvanud lapsevanemate teadlikkus sellest, et puue annab mõnede teenuste tasuta ligipääsu ja seetõttu võidakse lapsele puuet ka sagedamini taotleda.

Puudega lastega leibkonnad ja lapse eest peamiselt hoolitsev inimene

Puudega lastest 7-10% elavad leibkondades, kus on kaks inimest (Joonis 3), 58-65% elavad 3-4-liikmelistes leibkondades ja 28-32% viie või enama liikmega leibkondades. 2016. aasta Eesti Sotsiaaluuringu (ESU) järgi moodustavad viie või enama liikmega leibkonnad Eesti lastega leibkondadest 16-20%. Seega kõigi Eestis elavate lastega võrreldes kuuluvad puudega lapsed sagedamini viie või enama liikmega leibkondadesse.

Joonis 3. Puudega lastega leibkonnad ja kõik lastega leibkonnad Eestis leibkonna suuruse järgi (% leibkondadest)



Allikad: Eesti Sotsiaaluuring 2016, puudega lastega perede küsitlus 2017, autorite arvutused

Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

81-84% puudega lastest elavad leibkondades, kus nad on ainukeseks puudega lapseks. Ülejäänud puudega lapsed elavad leibkondades, kuhu kuulub kaks või enam puudega last. Puudega lastest 33-37% elab ühe lapsega leibkondades, 39-43% kahe ja 23-26% kolme või enama lapsega leibkondades.

17-21% puudega lastest elab leibkonnas, kus on vaid üks täiskasvanu ja 2-4% leibkonnas, kus see täiskasvanu on puudega. Puudega last hooldavatest vanematest 9-12% on endal samuti puue.

8-11% puudega lastest elab leibkondades, kus ei ole ühtegi tööga hõivatud täiskasvanut. Ühe töötava liikmega leibkondades elab 38-42% ja kahe töötava liikmega leibkondades 48-53% puudega lastest.

Küsitlusele vastama paluti pereliige, kes puudega lapse eest hoolitsemisega kõige rohkem tegeleb. Enamasti on puudega lapse eest peamiselt hoolitsevaks isikuks lapse vanem (95-97% juhtudest), enamasti ema (90-92%). 1-2% puudega laste eest hoolitses peamiselt vanavanem. Üksikutel juhtudel oli peamiseks lapse eest hoolitsejaks keegi teine (õde, vend, muu sugulane vm). Kuna pea kõik küsitlusele vastanud on puudega lapse vanemad, kasutatakse seetõttu raportis puudega lapse eest peamiselt hoolitsevast isikust rääkides mõistet „vanem“.

Reeglina hoolitseb puudega lapse eest naine (94-96%) ja ta on vanuses 25-54 (95-97%). 66-69% puudega last hooldavatest lapsevanematest töötavad, seega on 30-44% mittetöötavad. Mittetöötamise põhjusena nimetati ligi pooltel (43-50%) juhtudel vajadust hoolitseda puudega lapse eest, ülejäänud põhjuste hulgas olid enim levinud lapsehoolduspuhkus (27-34%) ja enda puue või terviseprobleem (19-25%), samuti sobiva töökoormuse või -graafikuga töö mitteleidmine (18-24%) .

Sotsiaalmajanduslik olukord

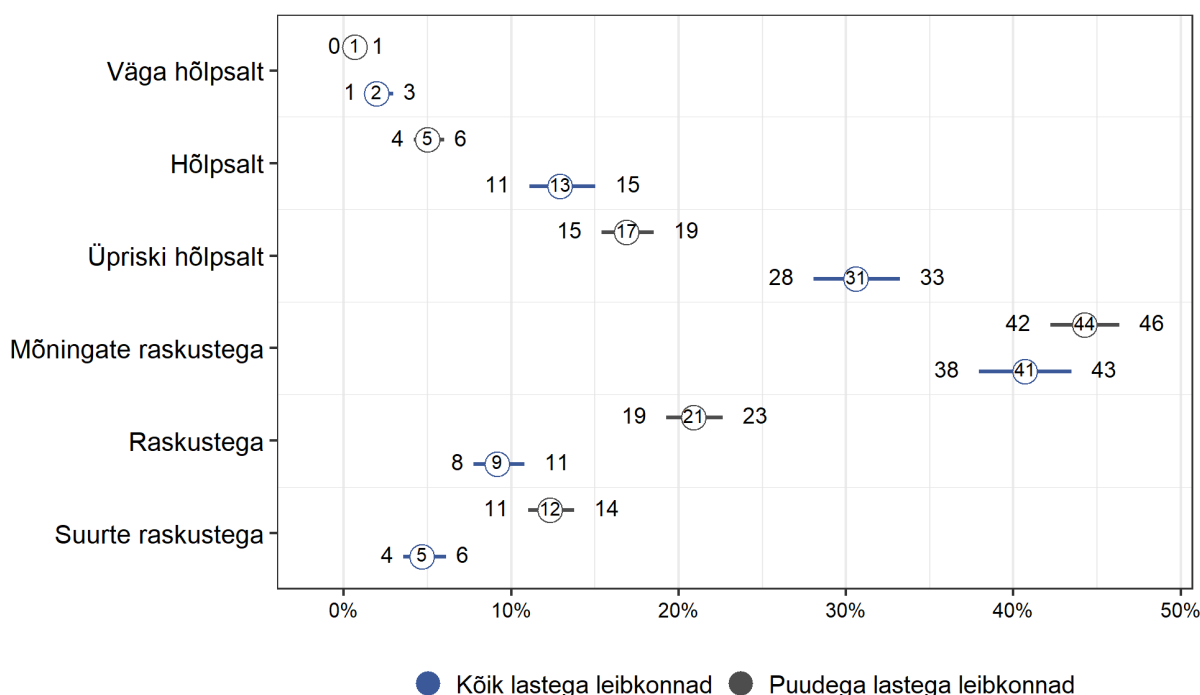
Puudega lastega leibkonnad elavad keskmiselt sama suurtes eluruumides kui kõik lastega leibkonnad Eestis üldiselt. Keskmise eluruumi suurus on puudega lastega perekondadel 20,7–24,2 m² elaniku kohta. 2011. aasta rahva- ja eluruumide loenduse põhjal¹ oli Eestis keskmine eluruumi pind 22,6 m² elaniku kohta peredes, kus oli 0–17-aastaseid lapsi. Puudega lastega leibkondadest 23-28% on kodu kohandanud puudega lapse vajaduste järgi ja teinud seda valdavalt oma finantsidega. 16–21% puudega laste vanemaist hindavad, et kodudes tuleks teha veel osalist või täielikku kohandamist. Kodu kohandamise teenust, st

¹ Statistikaamet, veebiandmebaas, tabel RL0807: Asustatud tavaeluruumide keskmine pind ja keskmine tubade arv elaniku kohta, 31. detsember 2011 (24.10.2017)

kohalike omavalitsuste toetust kodude füüsiliseks kohandamiseks puudega lapse vajadustele vastavaks, on kasutanud vähem kui 7% kõikidest puudega lastega peredest.

Puudega laste leibkondade hinnang enda majanduslikule toimetulekule on halvem kui kõikidel lastega leibkondadel Eestis keskmiselt. Kõikidest puudega lastega leibkondadest tajub vaid 19–26%, et tuleb toime hõlpsalt (sh vastusevariandid „üpriski hõlpsalt“, „hõlpsalt“, „väga hõlpsalt“). Kõikide lastega leibkondade hulgas on selliseid peresid 40–51% (Joonis 4). Samuti on puudega lastega leibkondade seas Eesti keskmisega võrreldes rohkem neid, kellel on vähemalt ühel korral viimase aasta jooksul olnud raskusi kommunaalkulude maksmisel. Kui Eesti kõikide lastega leibkondade seas, kellel oli kommunaalkulusid, oli raskusi nende maksmisel 8-13%, siis puudega lastega perede seas, kellel oli kommunaalkulusid, esines raskusi nende maksmisel 28-34%.

Joonis 4. Kas leibkond tuleb vajalike kulutuste tegemisel ots otsaga kokku? (% kõigist lastega leibkondadest ja % puudega lastega leibkondadest)

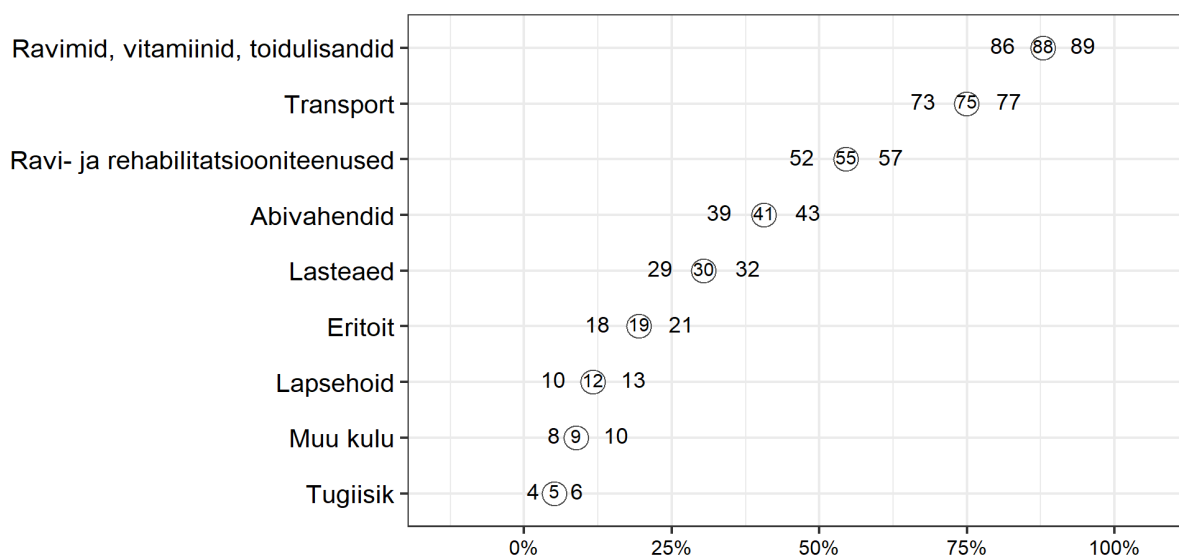


Allikad: Puudega lastega leibkonnad: Puudega lastega perede küsitlus 2017; Kõik lastega leibkonnad: Statistikaamet, Eesti Sotsiaaluuring 2016

Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

Pea kõigi puudega laste vanemate hinnangul on leibkond puudega lapse tarbeks teinud kulutusi uuringus käsitletud kululiikide lõikes, ühtegi kulu polnud vaid 2-3%l puudega lastega leibkondadest. Sagedamini on tehtud kulutusi ravimitele, vitamiinidele või toidulisanditele (86-89% puudega lastest) (Joonis 5), aga enam kui pooltel puudega lastega leibkondadel on puudega lapse tarbeks olnud kulusid ka transpordile (73-77%) või ravi- ning rehabilitatsiooniteenustele (52-57%). Kulusid abivahenditele on 39-43%l puudega laste leibkondadest.

Joonis 5. Puudega lapse tarbeks tehtud kulude esinemine leibkonnas (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Suurimad puudega lapse tarbeks tehtud kulud on seotud eritoiduga, mille mediaankulu peredes, kus see kulu esineb, on 80 eurot kuus. Samas on tegemist üsna varieeruva kuluga, pooltel leibkondadel, kellel esineb kulusid eritoidule, on need 40-120 eurot kuus. Tugiisiku mediaankulu ei ole küll nii suur (61 eurot kuus), kuid on samuti väga varieeruv, olles poolte leibkondade jaoks, kellel tugiisikule raha kulus, 25-153 eurot kuus. Nii transpordi kui lastehoiu kulu mediaan on 50 eurot kuus ja mõlemad kulud varieeruvad umbes 20 eurost kuni 100 euroni kuus pooltele leibkondadele, kellel neid kulusid on. Lasteaia mediaankulu kuus on suurem (70 eurot) ja see varieerub vähem (poolte leibkondade jaoks 50-90 eurot kuus). Eelnevatest väiksemad on mediaankulud ravi- ja rehabilitatsiooniteenustele (30 eurot kuus), ravimitele, vitamiinidele, toidulisanditele (25 eurot kuus) ja abivahenditele (20 eurot kuus).

Sügava ja raske puude raskusastmega kaasnevad suuremad kulud. 50% leibkondade puudega lapse tarbeks tehtud kulud jäävad sügava puudega lapse korral vahemikku 119-339 eurot kuus, aga võivad ulatuda ka kuni 600 euroni. Lapse raske puude korral kulutavad pooled leibkonnad puudega lapse erivajadustele 60-219 eurot ja keskmise puude korral 48-159 eurot kuus.

Paljude vanemate hinnangul pole kulutused katnud puudega lapse vajadusi piisaval määral. Kõige enam esineb seda olukorda tugiisikuteenusega, millele tehtud kulutused pole olnud piisavad 29-48% puudega laste leibkondadel, kellel selliseid kulusid oli. Samas oli tugiisikule kulusid küll väga vähestel (4-6% puudega laste leibkondadest). Eritoidule kulutusi teinud leibkondadest (18-21%) hindavad veerand kuni kolmandik (25-35%), et kulutused ei olnud piisavad lapse vajaduste katmiseks. Lapsehoiule kulutusi teinud leibkondadest (10-13%) hindavad 25-37%, et need ei olnud piisavad. Ravi- ja rehabilitatsiooniteenustele on kulutusi pooltel puuetega laste leibkondadest (52-57%) ja neist 28-33% leiavad, et need on olnud puudega lapse vajaduste katmiseks liialt väikesed.

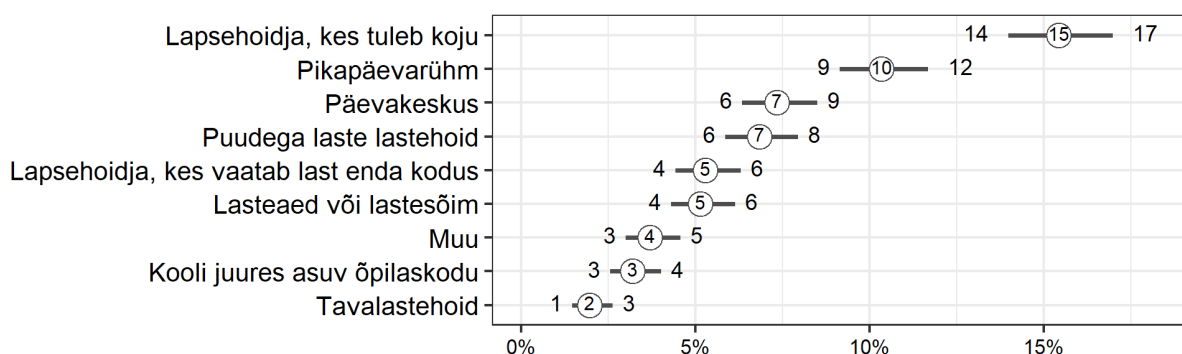
Enamasti ei ole peredele lapse puudega kaasnevad lisakulutused kaetud puudega laste toetusega, mis 2017. aastal on keskmise puude raskusastme korral 69,04 eurot kuus, raske ja sügava puude korral 80,55 eurot kuus. Üle poole (53-60%) on selliseid puudega lapsi, kelle puudest tulenevad lisakulutused on vähesel määral või ei ole üldse toetustega kaetud. Kolmandiku (30-36%) puudega laste puudest tulenevad lisakulutused on kaetud kas täiel või suurel määral puudega lastele suunatud toetustega.

Hoolduskoormus

Enam kui pooled puudega laste vanematest (53-57%) on viimase 12 kuu jooksul kasutanud mõnda puudega lapse hoidmise võimalust. Sagedamini kasutatakse puudega laste hoidmiseks lasteaia või -sõime teenuseid (29-33% puudega lastest) ja pikapäevarühma (13-16%). Lapsehoidmise võimaluste kasutamine on seotud eelkõige lapse vanusega – vanemate puudega laste jaoks on lapsehoidmise võimalusi kasutatud märkimisväärselt vähem kui nooremate laste hoidmiseks: 16-17-aastaste puudega laste hoidmiseks ei ole viimase 12 kuu jooksul kasutanud ühtegi lapsehoidmise võimalust 73-86% puudega laste peredest, seevastu 0-6-aastaste laste hoidmiseks ei ole kasutanud ühtegi lapsehoidmise võimalust 10-15% puudega laste peredest.

Senisest rohkem või täiendavaid lapsehoidmise võimalusi vajavad 35-42% puudega laste peredest. Kõige sagedasem on vajadus lapsehoidja järele, kes tuleb lapse koju last hoidma (14–17% puudega lastest, vt Joonis 6). Pikapäevarühma täiendav vajadus on 9-12% puudega laste peredel ja iga ülejäänud laste hoidmise võimalust üksikult võetuna vajavad täiendavalt vähem kui kümnendik puudega lastega vanematest.

Joonis 6. Puudega lapse hoidmiseks senisest rohkem või täiendavalt vajatavad lapsehoidmise võimalused (% puudega laste vanematest)

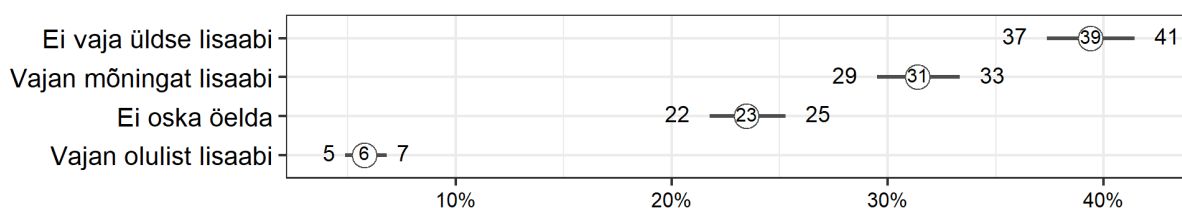


Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

Ligikaudu pooled (53-57%) puudega laste vanemad saavad puudega lapse hoidmisel abi teistelt leibkonnaliikmetelt kord nädalas või sagedamini. Neljandiku (24-27%) puudega laste hoidmisel aitab lapsevanemat pereliige või sugulane väljastpoolt leibkonda vähemalt kord nädalas. Teisi abilisi puudega lapse hoidmisel on nädalas vähemalt korra võimalik kasutada vähem kui kümnendikul puudega laste vanematel. 11-13% puudega lastest on sellised, kelle hoidmisel või hooldamisel ei abista lapsevanemat mitte ükski teine isik.

Lisaabi puudega lapse või teiste hooldatavate eest hoolitsemisel vajaks 34–40% puudega laste vanematest. Sealjuures mõningat lisaabi vajab 29-33% puudega laste vanematest ja olulist lisaabi vajavad 5-7% (Joonis 7). Puudega lapse vanema vajadus lisaabi järele on seotud lapse puude raskusastmega. Sügava puudega laste vanematest vajavad lisaabi 47-65%, raske puudega laste vanematest 40-46% ja keskmise puudega laste vanematest 24-30%. Samuti on puudega lapse vanema lisaabi vajadus seotud lapse puudeliigi ja vanema haridustasemega. Lisaabi vajab 45-52% liitpuudega laste vanematest ja 44-56% psüühikahäirega laste vanematest, samas kui puudliiki „muu puue“ kuuluvate laste vanematest vajab lisaabi 22-29%. Kõrgharidusega lapsevanemad tunnetavad lisaabi vajadust enam kui kesk-, kutse- või põhihariduse või madalama haridusega vanemad.

Joonis 7. Lisaabi vajadus puudega lapse või teiste hooldatavate abistamisel või hooldamisel (% puudega laste vanematest)

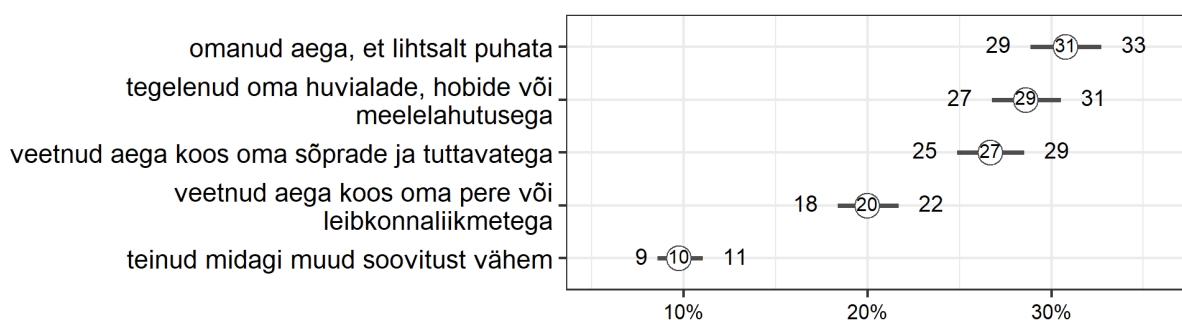


Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

Kaks kolmandikku puudega laste vanematest on pidanud hoolduskohustuste tõttu viimase 12 kuu jooksul töö või õpingute osas tegema järeleandmisi. Kõige enam esineb tööga seotud järeleandmisi: tööst vabu päevi või tunde on rohkem kui ühel korral viimase 12 kuu jooksul pidanud võtma 33-37% puudega laste vanematest, 24-27% on pidanud korduvalt võtma hoolduslehe, 14-17% korduvalt vähendama töökoormust. Tööl käimisest on pidanud loobuma vähemalt ühel korral viimase 12 kuu jooksul 15-20% puudega laste vanematest.

Puudega laste vanematest ligi 80% on viimase 12 kuu jooksul teinud mingit tegevust soovitus vähem. Ligi kolmandikul (29-33%) puudega laste vanematest on sageli olnud soovitus vähem aega, et lihtsalt puhata (Joonis 8), 27-31% on sageli tegelenud soovitus vähem huvialade, hobide või meelelahutusega ning 25-29% on sageli soovitus vähem veetnud aega koos sõprade ja tuttavatega.

Joonis 8. On sageli viimase 12 kuu jooksul puudega lapse/laste hoidmise või hooldamise tõttu soovitus vähem... (% puudega laste vanematest)

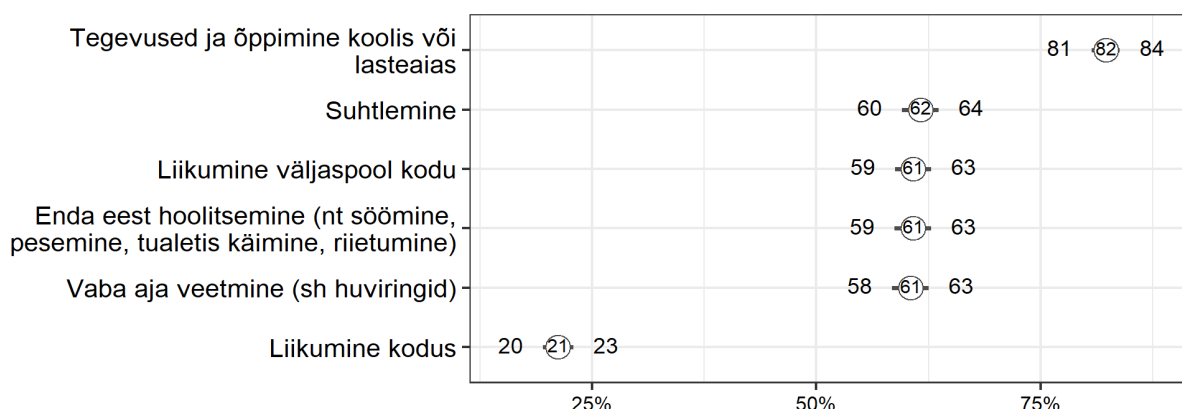


Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

Kõrvalabi vajadus

Enamus puudega lapsi vajab vanema hinnangul puudest tulenevalt kõrvalabi (Joonis 9) koolis või lasteaias (81-84%), suhtlemisel (59-64%), väljaspool kodu liikudes (59-63%), vaba aja veetmisel (58-63%) või enese eest hoolitsemisel (59-63%). Vaid ca 8% puudega lastest ei vaja puude tõttu ühegi uuringus käsitletud tegevuse juures kõrvalabi.

Joonis 9. Puudest tulenev kõrvalabi vajadus (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

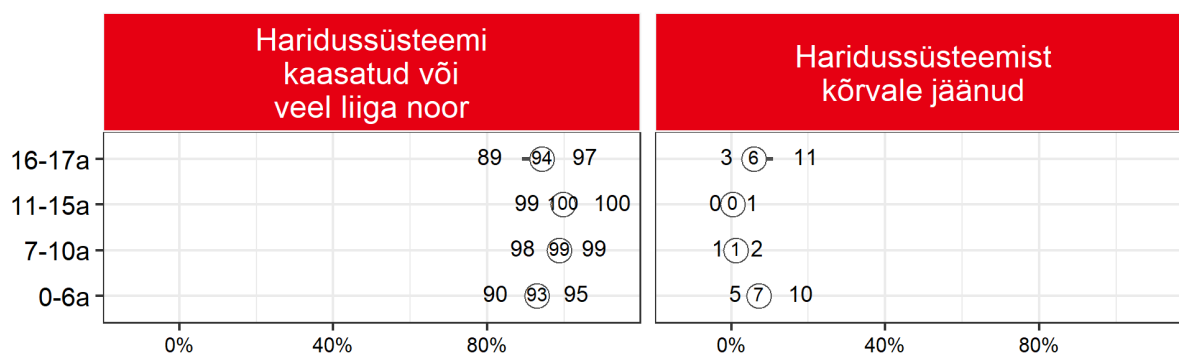
Taustatunnuste lõikes vaadati kõrvalabi vajadust vaid nende seas, kes käsitletud tegevustega tegelevad. Puude liigiti hinnati kõrvalabi vajadust erinevalt, sealjuures on abi vajaduse spetsiifika ootuspärane – nt kodus liikumisel puudest tulenevat kõrvalabi vajavaid on enim liikumispuudega laste seas, suhtlemisel kõrvalabi vajavaid on enim psüühikahäirega, keele- ja kõnepuudega ning liitpuudega laste seas. Küll aga ei ole ühegi uuringus käsitletud tegevuse juures kõrvalabi vajadus piiratud ainult ühe puudeliigiga, kõigi tegevuste puhul esines kõrvalabi vajavaid lapsi igast puude liigist.

Pea kõigi uuringus käsitletud tegevuste juures (v.a suhtlemine) on sügava puudega laste seas puudest tuleneva kõrvalabi vajajaid oluliselt enam kui keskmise ning raske puudega laste seas. Vaba aja veetmisel vajab puudest tulenevat kõrvalabi 90-99% sügava puudega lastest, mis on oluliselt kõrgem võrreldes raske puudega (71-76%) või keskmise puudega (58-66%) lastega. Enda eest hoolitsemisel vajab sügava puudega lastest kõrvalabi 85-96%, raske puudega lastest 62-68% ja keskmise puudega lastest 50-57%. Väljaspool kodu liikumisel vajab kõrvalabi 86-96% sügava puudega, 64-69% raske puudega ja 51-58% keskmise puudega lastest. Kodus liikumisel vajavad kõrvalabi sügava puudega lastest 52-70%, raske puudega lastest 19-24% ning keskmise puudega lastest 14-19%. Koolis või lasteaias vajab kõrvalabi 92-99% sügava puudega, 89-93% raske puudega ning 75-81% keskmise puudega lastest.

Haridusteenused

0-17-aastastest puudega lastest 62-66% käis 2016/2017 õppeaastal koolis (sh koduõppe või haiglaõppe vormis). Lasteaia või -sõimes käis 28-32% puudega lastest ning 3-4% lastest ei käinud ei lasteaia, sõimes ega koolis, sest olid lapsevanema hinnangul liiga noored. Kokkuvõttes on 2-4% puudega lastest jäänud üldharidus- või alusharidussüsteemist kõrvale mingitel muudel põhjustel kui vanus. Rohkem on selliseid lapsi koolieelses vanuserühmas ja 16-17-aastaste seas (Joonis 10). 7-10-aastastest ei käinud koolis ega lasteaia 1-2% ja 11-15-aastastest 0,1-1%.

Joonis 10. Haridussüsteemist muul põhjusel kui vanus kõrvale jäänud puudega lapsed (% puudega lastest vanuserühmas)

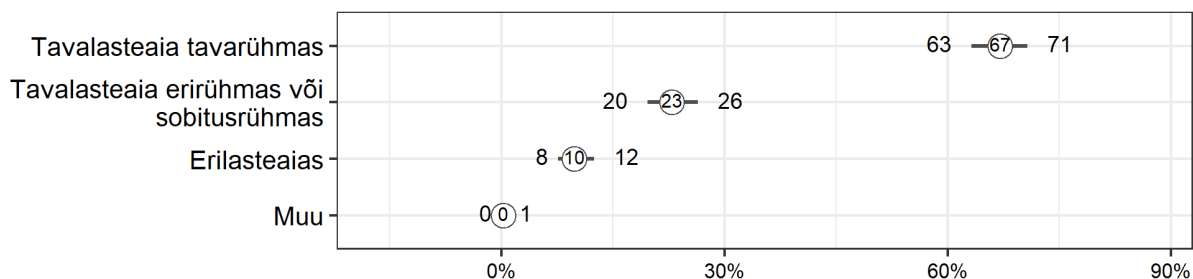


Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

Vaadates haridusasutustest välja jäämist nende laste seas, kes ei ole liiga noored, et käia lasteaias või -sõimes, ilmneb seos puude raskusastmega. Sügava puudega lastest on haridusasutustest välja jäänud 10-24%, raske puudega lastest 2-4% ja keskmise puudega lastest 1-3%. 2009. aastaga võrreldes on haridussüsteemist kõrvale jäänud laste osakaal ligikaudu samas suurusjärgus. 2009. a uuringu raporti järgi oli haridussüsteemist kõrvalejäänute osakaal kokku 8% (GfK 2009:34)².

Valdav osa puudega lastest käivad tavakoolis või tavalasteaias tavarühmas või -klassis. Koolis käivatest puudega lastest õpib tavakooli tavaklassis 53-59% (Joonis 12), lasteaias käivatest puudega lastest käib tavalasteia tavarühmas 63-71% (Joonis 11). Lasteaias käivatest puudega lastest on erilasteaias 8-12% ja tavalasteia erirühmas või sobitusrühmas 20-26%.

Joonis 11. Millises lasteaias ja rühmas laps 2016/2017. õppeaastal käis? (% lasteaias käivatest puudega lastest)



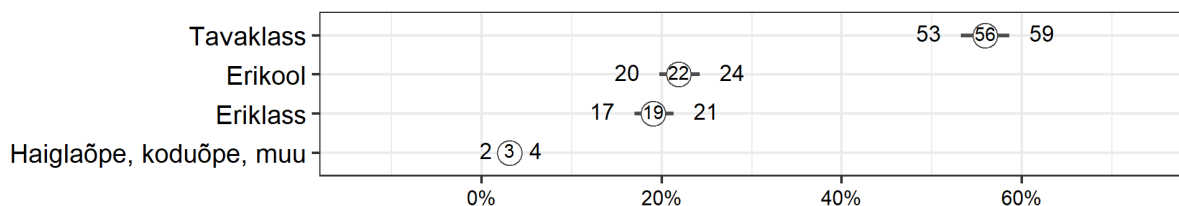
Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

² GfK (2009) Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring.

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/Puudega_laps/puudega_laste_perede_toimetulek_2009.pdf

Koolis käivatest puudega lastest on erikoolis 20–24% ja eriklassis 17–21%.

Joonis 12. Millises klassis ja koolis laps 2016/2017. õppeaastal õppis? (% koolis käivatest puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

Erilasteaegades ja erikoolides õpivad suurema tõenäosusega sügava või raske puude raskusastmega lapsed. Erilasteaegas käib 12-48% sügava puudega, 10-17% raske puudega ja 2-7% keskmise puudega lasteaegas käivatest puudega lastest. Erikoolis õpib 68-88% sügava puudega, 24-30% raske puudega ja 4-9% keskmise puudega koolis käivatest lastest.

Enim levinud probleemiks puudega lastele on nii koolis kui ka lasteaegas tugimeetmete kättesaadavus haridusasutuses kohapeal. 40-48%l lasteaegas käivatest ja 31-36%l koolis käivatest puudega lastel oli probleemiks rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus haridusasutuses kohapeal. Muude tugiteenuste kättesaadavusega esines probleeme vähem.

Erikoolis ja erilasteaegades õppivatest puudega lastel on tugiteenuste saamise ning õppekvaliteedi vastavusega õpilase vajadustele ja võimetele vähem probleeme kui tavakoolis õppivatest puudega lastel. Näiteks oli psühholoogi teenuse saamisega probleeme erilasteaegas käivatest lastest 30-62%l, tavalasteaegas sobitusrühmas 59-78% ja tavarühmas 48-60%; füsioterapeudiga erilasteaegas 29-59%, sobitusrühmas 61-79%, tavarühmas 49-61%. Koolis on näiteks õpetajate teadmiste ja oskustega probleeme harvem erikoolis (11-20%) kui tavakooli eriklassis (37-50%) ja tavaklassis (22-29%), samuti on õppekava jõukohasus enam probleemiks tavakooli tavaklassides (18-24%) ja eriklassides (23-35%) kui erikoolis (8-16%) õppivatest õpilastel. Samas on erikoolis ja erilasteaegades õppivatest lastel sagedamini probleemiks kooli või lasteaegas kaugus ja transpordi kulud. Lasteaegas kaugus on erilasteaegas või sobitusrühmas käivatest lastest probleemiks vastavalt 24-51% erilasteaegas ja 15-30% sobitusrühmas, samas kui tavalasteaegas käivatest lastest vaid 6-12% jaoks. Erikoolis õppivatest lastest on kooli kaugus probleemiks 21-32%le tavakooli tavaklassis õppivatest lastest 10-15%le.

Tervishoiuteenused

Tervishoiuteenustest on enamikul puudega lastest olnud viimase 12 kuu jooksul vaja perearsti (90–93%), eriarsti (90–93%) ja hambaarsti (80–83%). Kiirabi ja haiglaravi vajasid vähemad, vastavalt 33-37% ja 30-33% puudega lastest.

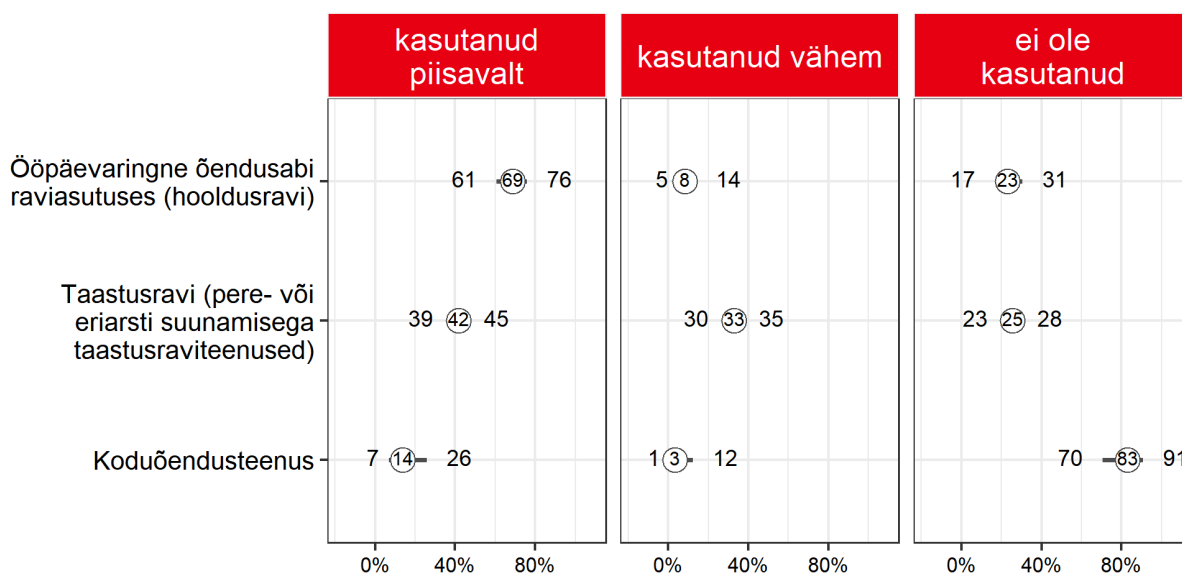
Neid, kes küll vajasid teenust, aga ei saanud seda üldse kasutada, on üsna vähe. Perearsti juurde pole viimase 12 kuu jooksul üldse saanud 0,2-0,9% neist puudega lastest, kellele oleks seda vaja olnud. Eriarstile ei ole saanud 0,9-2,1% teenust vajanutest, kiirabi ja hambaarsti vajanud puudega lastest ei kasutanud neid kordagi 2-5% ja haiglaravi 5-8%. Seega on need, kellele on teenust olnud vaja, valdavalt saanud seda kasutada. See ei näita aga, et kasutatud teenuste maht oleks olnud piisav.

Eriarstiabi teenuse kasutamisel on esinenud probleeme pooltel (50-54%) teenust kasutanud puudega lastest. Perearsti, hambaarsti, haiglaravi ja erakorralise meditsiini teenusega on esinenud probleeme ligi kolmandikul teenust kasutanud puudega lastest (vastavalt perearstiga 29-32%, hambaarstiga 27-31%, haiglaraviga 26-34% ja erakorralise meditsiini teenusega 33–40%). Perearsti, eriarsti ja hambaarsti teenuse kasutamisel sagedamini esinenud probleemid on pikk ootejärjekord (16-19% perearsti, 40-44% eriarsti ja

18-22% hambaravi teenust kasutanud puudega lastest) ja raskused aja broneerimisega (9-12% perearsti, 21-24% eriarsti ja 6-8% hambaravi teenust kasutanud puudega lastest). Erakorralise meditsiiniabi ja haiglaravi teenusega seoses oli samuti peamiseks probleemiks pikk ootejärjekord (23-30% erakorralise meditsiini ja 13-19% haiglaravi teenust kasutanud puudega lastest). Kõiki muid probleeme esineb oluliselt vähem (vähem kui 7%l teenust kasutanud puudega lastest). Võrdlusandmete puudumisel pole võimalik hinnata, kas puudega laste tervishoiuteenuste vajadus, kasutamise sagedus ja esinenud probleemid erinevad ülejäänud Eesti laste omadest.

Taastusraviteenuse vajadus oli 12 viimase kuu jooksul enam kui pooltel puudega lastest (57–61% puudega lastest), ööpäevaringset õendusabi raviasutuses vajasid 6–8% puudega lastest ja koduõendusteenust 2–3%. Neist teenustest on kõige paremini kättesaadav olnud ööpäevaringne õendusabi, mida said piisavalt kasutada 61-76% teenust vajanud puudega lastest, samas kui taastusravi teenust sai piisavalt kasutada 39-45% teenust vajanud puudega lastest. Keerukas on olukord juhul, kui lapsel on vaja koduõendusteenust – vaid 7-26% teenust vajanud puudega lastest on saanud seda kasutada piisavalt ning 70-91% teenust vajanutest pole seda üldse saanud kasutada (Joonis 13). Kuna koduõendusteenust on vaja väga vähestel, moodustavad lapsed, kes teenust vajavad, kuid seda ei saanud, kõigist puudega lastest väikese osa (2-3%).

Joonis 13. Tervishoiuteenuste kättesaadavus (% puudega lastest, kes nimetatud tervishoiuteenust vajavad)



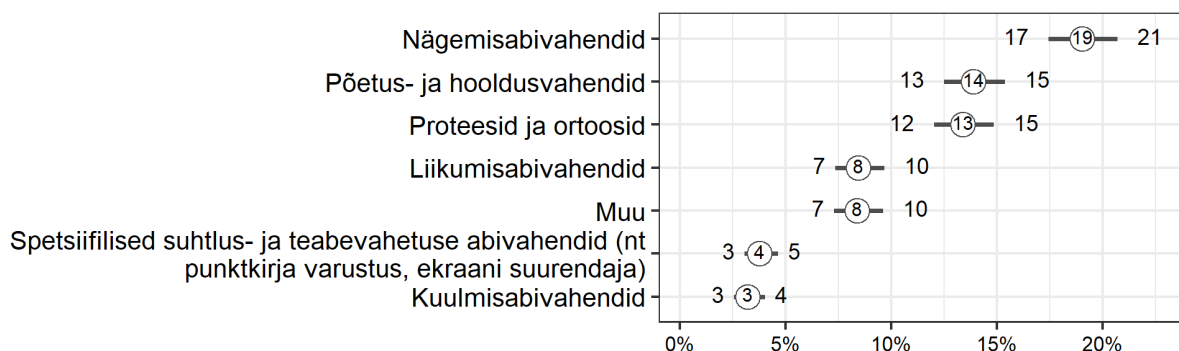
Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

Alternatiivmeditsiini poole on pöördunud alla viiendiku puudega laste vanematest (15-19%). Suurema tõenäosusega on pöördunud alternatiivmeditsiini poole kõrgharidusega lapsevanemad (22-28%). Alternatiivmeditsiini poole pöördumise põhjendusena nimetati vabades vastustes enamasti, et alternatiivmeditsiini on kasutatud lisavõimalusena või on esinenud halbu kogemusi tavameditsiiniga nagu nt halb suhtumine, abi mittesaamine, pettumus.

Abivahendite vajadus ja kasutamine

Abivahenditest on puudega lastel kõige sagedamini vaja (Joonis 14) nägemisabivahendeid (17-21% puudega lastest). Põetus- ja hooldusvahendeid vajab 13-15%, proteese ja ortoose 12-15%, liikumisabivahendeid 7-10%, spetsiifilisi suhtlusvahendeid 3-5% ja kuulmisabivahendeid 3-4% puudega lastest. Ligi pooled (45-49%) puudega lastest vajavad toimetulekuks vähemalt ühte uuringus käsitletud kategooriasse kuuluvat abivahendit.

Joonis 14. Abivahendite vajadus (% puudega lastest)



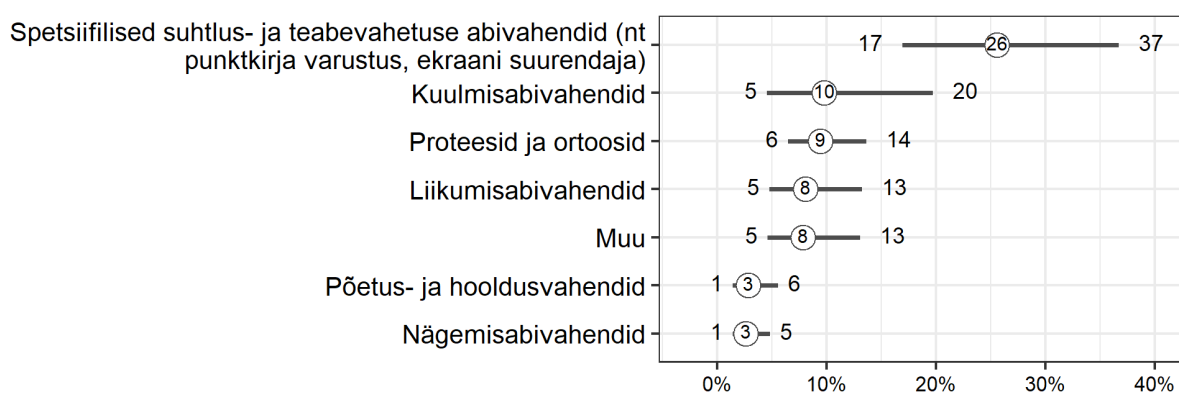
Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

Abivahendite vajadust taustatunnuste lõikes vaatame vaid nende laste vanemate seas, kes andsid vajadusele sisulise hinnangu ehk analüüsist on jäetud välja need, kes ei osanud abivahendi vajadust hinnata. Abivahendite vajadus on küllaltki puudespetsiifiline – nii on vajadus nägemisabivahendite järele kõrgeim nägemispuudega lastel (vajab 80-99%) ja vajadus kuulmisabivahendite järele kuulmispuudega lastel (vajab 85-99%). Liikumisabivahendeid on vaja 23-39% liikumispuudega lastest ja sageduselt järgmised on liitpuudega lapsed, kelle seas on liikumisabivahendi vajajaid 13-19%. Proteese ja ortoose vajavaid lapsi esineb kõige enam liikumispuudega (38-55%) ja liitpuudega (19-25%) laste seas, teiste puudeliikidega laste seas on proteeside ja ortooside vajajaid oluliselt vähem.

Juhul, kui lapsel on abivahendit vaja, siis tavaliselt ta seda ka kasutab. Küll aga esineb kõigi abivahendite kategooriate puhul ka selliseid olukordi, kui vajavat abivahendit erinevatel põhjustel ei üldse kasutata (nt abivahendit pole saada, pole jõutud veel hankida või olemasolev vahend ei vasta vajadustele). Kõige probleemsemaks abivahendite kategooriaks on siinkohal spetsiifilised suhtlus- ja teabevahetusabivahendid, mille vajajaid oli küll vaid 3-5% puudega lastest, kuid mille puhul abivahendit vajavatest lastest 17-37% neid ei kasuta (Joonis 15).

Vajatavate abivahendite mitte kasutamise põhjustena tuuakse vabades vastustes välja, et abivahendid on kallid, sobivat abivahendit ei ole/ei pakuta, ootejärjekorrad on pikad või puudub info, kuidas neid saada ja kasutada.

Joonis 15. Erinevatel põhjustel ei kasuta vajavat abivahendit (% puudega lastest, kes vastava kategooria abivahendeid vajavad)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

Kasutatavad abivahendid vastavad tavaliselt puudega laste vajadustele. Lastest, kellel oli abivahendeid vaja, kasutasid vajadustele vastavat abivahendit sõltuvalt vahendist 91-96% nägemisabivahendeid

vajavatest kuni 48-70% spetsiifiliste suhtlus- ja teabevahenditeni. Samas esineb kõigi abivahendite kategooriate puhul olukordi, mil kasutatav abivahend lapse vajadustele ei vasta. Abivahendid ei vasta vajadustele ligi kümnendikul puudega lastest, kellel on abivahendeid vaja kasutada. Kõige enam esineb probleeme liikumisabivahenditega, mille puhul 8-18% nende abivahendite vajajatest kasutavad sellist abivahendit, mis lapse vajadustele lapsevanema hinnangul ei vasta. Teiste abivahendite puhul jääb nende osakaal, kes abivahendit vajavad, kuid kasutavad lapse vajadustele mitte vastavat abivahendit, alla kümnendiku abivahendi vajajatest.

Lapse vajadustele mittevastavate abivahendite kasutamise põhjused, mida selgitati küsitluse vabades vastustes, on sageli küllaltki abivahendispetsiifilised. Üldisemate põhjendustena on nimetatud näiteks, et abivahend on ebamugav, lapse kiire kasvu tõttu on vaja pidevalt uusi vahendeid ning perel ei ole majanduslikult võimalik soetada lapsele sobivat abivahendit.

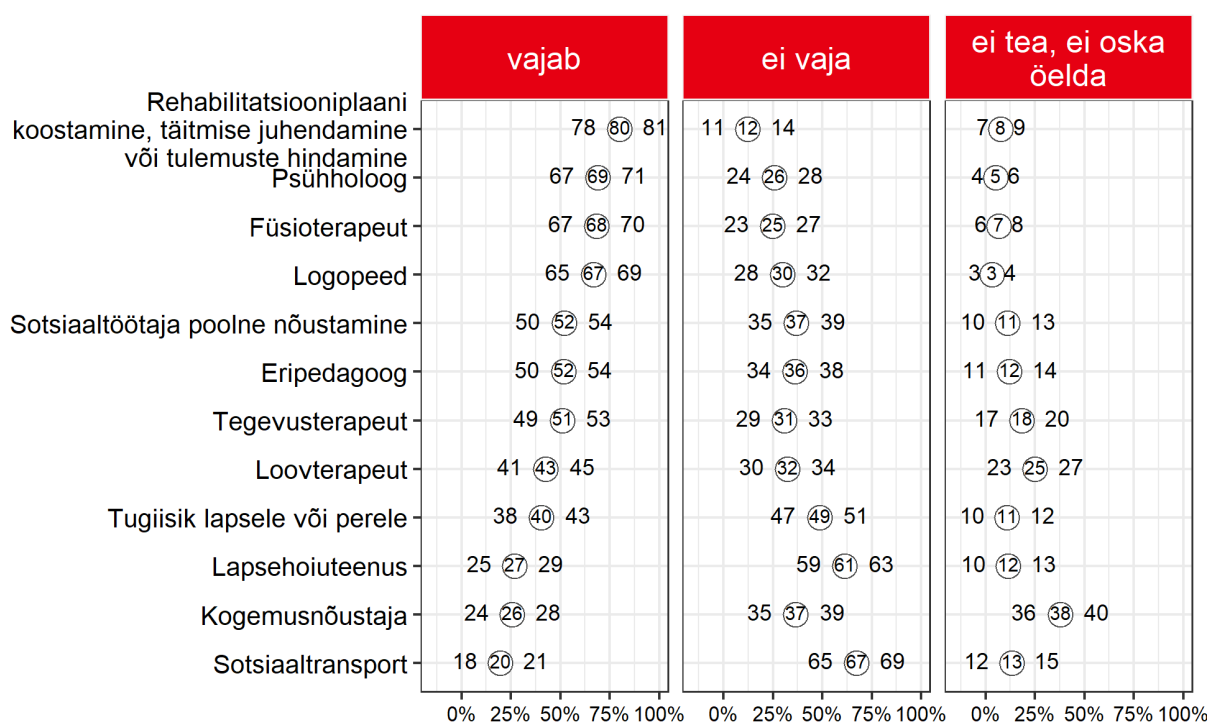
Sotsiaalteenused

Sotsiaalteenuste vajadus

Peaaegu kõigil puudega lastel on vajadus vähemalt ühe sotsiaalteenuse järele (96-97%). Sotsiaalteenustest on puudega laste seas kõige levinum rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise juhendamise ja tulemuste hindamise teenus³ (Joonis 16). Viimase aasta jooksul on seda vaja olnud 78-81%l puudega lastest. Kahel kolmandikul või enamatelgi puudega lastest on nende vanemate hinnangul vaja psühholoogi (67-71%), füsioterapeudi (67-70%) või logopeedi (65-69%) teenust. Umbes pooltel puudega lastest on nende vanemate hinnangul vaja sotsiaaltöötaja nõustamist (50-54%), eripedagoogi (50-54%) või tegevusterapeudi (49-53%) teenust. Loovterapeudi ja tugiisikuteenust on vaja ca 40%l puudega lastest (vastavalt 41-45% ja 38-43%). Veerandil on vaja lapsehoiu (25-29%) või kogemusnõustaja (24-28%) teenust ja viiendikul (18-21%) sotsiaaltranspordi teenust.

³ Rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise juhendamise või tulemuste hindamise teenus on teistest käsitletud teenustest erinev, kuna see on eeldus rehabilitatsiooniteenuste saamiseks. 2016. aastal lisandusid rehabilitatsiooniplaanile alternatiividena rehabilitatsiooniprogramm ja tegevuskava. Kuna rehabilitatsiooniplaan on varasemalt olnud eeldus rehabilitatsiooniteenuste saamiseks, siis võib olla tunnetatud vajadus selle teenuse järele sisuliselt erinev teiste teenuste tunnetatud vajadusest.

Joonis 16. Sotsiaalteenuste vajadus viimase 12 kuu jooksul (% puudega lastest)



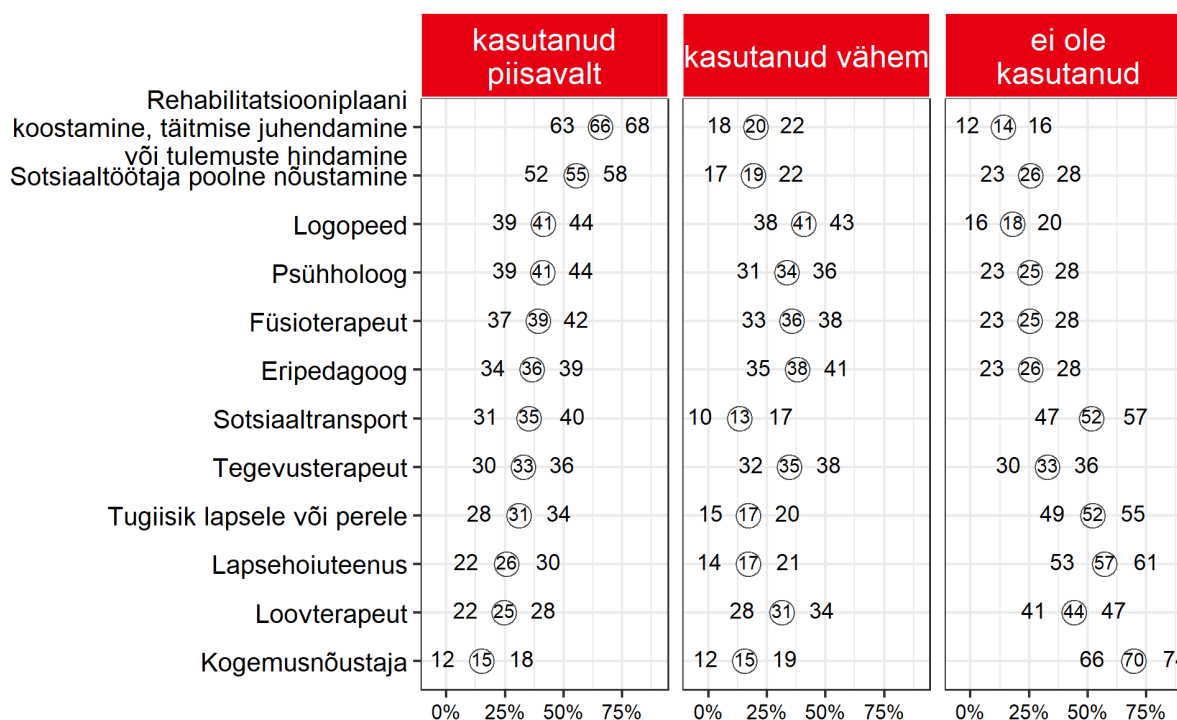
Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

Paljud lapsevanemad ei oska seisukohta võtta tegevusterapeudi, loovterapeudi ja eriti kogemusnõustaja teenuste kohta. Kui psühholoogi, füsioterapeudi ja logopeedi teenust ei tea või ei oska selle kohta seisukohta avaldada 3-8% puudega laste vanematest, siis tegevusterapeudi kohta on selliseid vanemaid 17-20%, loovterapeudi kohta 23-27% ja kogemusnõustaja teenuse kohta 36-40%. Selline tulemus viitab asjaolule, et tegevusterapeudi, loovterapeudi ja eriti kogemusnõustaja teenused on uued, inimesed ei ole nende teenuste olemasolust teadlikud ning seega ei oska paljud vanemad formuleerida oma seisukohta nende vajaduse osas. Võrreldes 2009. a uuringu tulemustega on kõigi sotsiaalteenuste puhul kasvanud teenust vajavate puudega laste osakaal ligi 5-10 protsendipunkti võrra.

Sotsiaalteenuste kättesaadavus

Kaks kolmandikku puudega lastest, kelle vanemad on viimase 12 kuu jooksul tunnetanud teenuse vajadust, on saanud enamikke teenuseid vajatust vähem või pole üldse saanud (Joonis 17). Kõige paremini on kättesaadav rehabilitatsiooniplaani koostamise ja täitmise juhendamise teenus ning sotsiaaltöötajapoolne nõustamine, mida on saanud piisavas mahu enam kui pooled teenust vajanud lastest (vastavalt 63-68% ja 52-58%). Kõiki teisi sotsiaalteenuseid on piisavas mahu saanud kasutada vähem kui pooled puudega lastest, kellel neid on vaja olnud. Eriti halb on kogemusnõustaja teenuse kättesaadavus: 66-74% teenust vajanutest ei saanud seda üldse. Probleemsed on ka kohalike omavalitsuste korraldatavatest teenustest sotsiaaltranspordi, tugiisiku ja lapsehoiu teenused. Neid teenuseid pole üldse saanud kasutada ligi pooled teenust vajanud puudega lastest (sotsiaaltransporti 47-57%, tugiisikut 49-55% ja lapsehoiuteenust 53-61%).

Joonis 17. Puudega laste sotsiaalteenuste kasutamine viimasel 12 kuul (% puudega lastest, kellel oli teenuseid vaja)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

Umbes viiendikul puudega lastest pole olnud probleeme sotsiaalteenuste taotlemisel või saamisel (21-24%). Sotsiaalteenuste saamisel ja taotlemisel on levinumad probleemid pakutavate teenuste liialt väike maht (27-31% puudega lastest), liiga pikk järjekord (25-29%) ja asjaajamise keerukus (22-25%). Probleemi, et teenuseid pakutakse liiga kaugel, tõi välja 14-17% puudega laste vanematest. Iga ülejäänud küsitud probleemidest esineb vähem kui 15%l puudega lastest.

Võrreldes 2009. aastaga ei ole 2017. aastal sotsiaalteenustega probleeme kohanud isikute osakaal oluliselt suurem.

Teave

Teabe puudumine puudega lastele mõeldud abi ja toetuste kohta on suureks probleemiks. Pooled (46-50%) puudega lastega peredest leiavad, et teave lastele suunatud toetuste, teenuste ja abi kohta on kas pigem raskesti või väga raskesti kättesaadav. Lisaks ei oska 22–26% info kättesaadavust hinnata. Seega neid, kelle jaoks on info pigem kergesti või väga kergesti kättesaadav, on 26-30% puudega lastega leibkondadest.

Jättes kõrvale need, kes ei oska hinnata info kättesaadavust, on vene keelt koduse keelena kõnelevatele peredele info kättesaadavus sagedamini probleemiks kui eesti keelt kõnelevatele. Eesti keelt kõnelevatest peredest 57-63%l on info olnud väga raskesti või pigem raskesti kättesaadav ja vene keelt kõnelevatest 65-74%l. Puudega laste vanemate fookusgrupis kirjeldati olukorda kui topeltmüüri taga olemist. Esmalt on teabe saamine toetuste ja teenuste kohta üldiselt väga keeruline, kuna süsteemid on killustunud ja puudub inimene, kellel üldse on olemas ülevaade puudega laste toetamise süsteemist erinevates valdkondades. Teiseks leidub vähe venekeelset infot ning inimestele, kelle emakeeleks ei ole eesti keel, pole eestikeelne info täielikult mõistetav. Isegi eesti keelt teatud tasemel oskavale võõrkeelsele inimesele on puudega laste toetusi ja teenuseid puudutav eestikeelne info raskesti mõistetav spetsiifiliste terminite tõttu.

Kuna puudega laste toetamise ja abi süsteem on killustunud riigi- ja kohaliku omavalitsuse tasandite ning sotsiaal-, haridus- ja tervishoiusüsteemi vahel, siis ei ole ka ühte valdavalt kanalit, mille kaudu puudega

laste pered toetuste, teenuste ja abi kohta infot saavad. Teabe saamiseks tuleb pöörduda mitmete erinevate nii ametlike kui ka mitteametlike allikate poole. Infokanalitest on kõige levinumad rehabilitatsiooniasutused (30-34% puudega laste vanematest), teised lapsevanemad (30-34%), interneti teemakohased lehed (28-32%) ja SKA (28-31%). Igast neist kanalitest on saanud infot veerand kuni kolmandik puudega lastega peredest. Levikult teise grupi moodustavad kohalikud omavalitsused (22-26%) ja eriarstid (21-24%), kust on saanud infot viiendik kuni veerand puudega laste vanematest. Kolmanda grupi, kust on saanud infot teenuste ja toetuste ja abi kohta 10-20% puudega laste peredest, moodustavad lähedased ja tuttavad, internetifoorumid ning perearstid. Ülejäänud kanalite tähtsus on väiksem ning igast neist kanalist on saanud infot alla 10% puudega lastega peredest.

Puudega lastega vanemad töid vabades vastustes välja mitmeid soovitusi, kuidas teavitussüsteemi ja info jagamist paremaks muuta. Laias laastus pakuti välja kolm soovitusi, kuidas seda teha:

- 1) teavitada e-maili teel kõiki puudega lastega peresid võimalikest toetustest, teenustest ja soodustustest ning muudatuste korral uuendustest
- 2) koondada kõikne info nii riikliku, KOVi tasandi kui ka erinevate valdkondade (tervishoid, haridus ja sotsiaal) kohta ühele veebilehele
- 3) kõikides KOVides peaks olema eraldi isik, kellel on ülevaade kõikidest teenustest ja toetustest ning abist, kellel on kohustus puudega laste peredele anda kõikne ülevaade.

Fookusgrupis toodi välja, et kõigi kolme nimetatud kanali loomine puudega lastega perede paremaks informeerimiseks on vajalik.

Summary

Research objective and how research was conducted

The objective of this research was to map the needs and living standards of families with disabled children. For this purpose, in August–September 2017 a survey was carried out among households with disabled children. The survey sample, which included disabled children aged 0–17 years, was compiled on the basis of the register kept by the Estonian National Social Insurance Board (SKA). In each sampled household, the main carer of the disabled child (hereinafter referred to as the parent of the disabled child) was asked to fill in a questionnaire. The questionnaire was completed by 1,904 people.

The analysis report focuses on describing survey results; comparing the results, where possible, to the results of a similar survey conducted in 2009; and comparing it also to the situation of families with children in Estonia in general by using the data from the Estonian Social Survey conducted by Statistics Estonia in 2016. In order to interpret the survey data, focus group interviews were carried out with representatives from organisations that unite families with disabled children.

The analysis uses sample-based survey data to make generic conclusions about disabled children in Estonia (population). The survey data was used to draw conclusions about the whole population, the population values have been estimated in 95% confidence intervals. The intervals on figures show the 95% probability of the prevalence of a phenomenon among disabled children in Estonia.

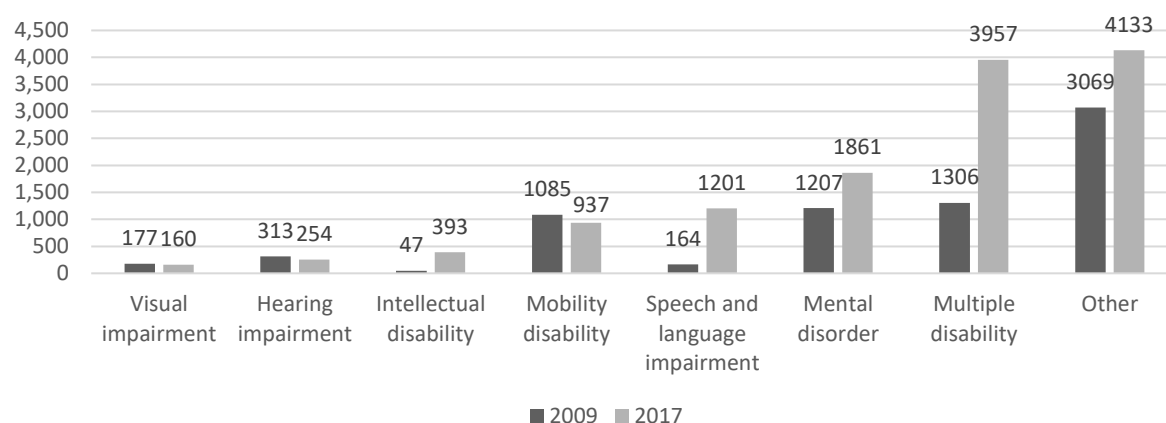
The research was commissioned by the Ministry of Social Affairs; survey work and the analysis were carried out by Turu-uuringute AS and Centar, Estonian Centre for Applied Research. The research was funded from the European Social Fund aid condition “Welfare services supporting labour market participation”.

Disabled children: numbers and trends

On 1st January 2017, there were 12,896 disabled children in Estonia. The number has nearly doubled since 2009 having been 7,368 on 1st January 2009. The proportional share of disabled children among all children in Estonia aged 0–17 years has also increased: from 3% to 5.2%.

According to SKA, most prevalent types of disability in 2017 are multiple disability and other disability – approx. 4,000 children belong to each of these groups (Figure 1). There are 1,861 children with mental disorders, followed by a significantly smaller group of (1,201) children with speech and language impairments. The number of children with more prevalent disabilities has increased, whereas the number of children with less prevalent disabilities, such as sensory and mobility disabilities, has decreased somewhat. Biggest increases compared to 2009 are in the numbers of children with speech and language impairments, intellectual disability and multiple disability. Somewhat smaller increases have occurred in the numbers of children with mental disorders and other disability.

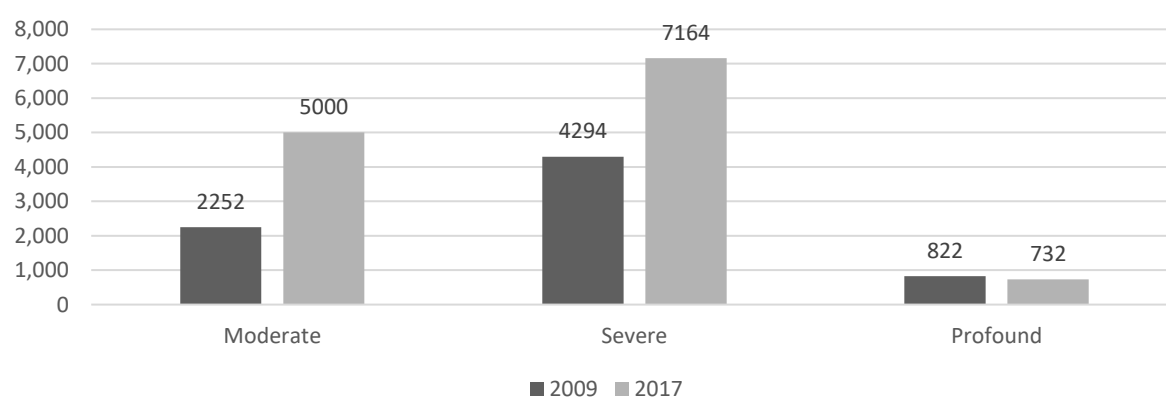
Figure 1. Number of disabled children aged 0–17 years by dominant disability type on 1 January



Source: Data from Social Insurance Board

By degree of disability, the majority of disabled children have a severe disability (Figure 2). Comparing the data of 2017 to 2009 reveals that the number of children with a profound disability has largely remained the same, whereas the cases of severe and moderate disability have increased. The biggest increase has occurred in the number of children with a moderate disability.

Figure 2. Number of disabled children aged 0–17 years by degree of disability on 1 January



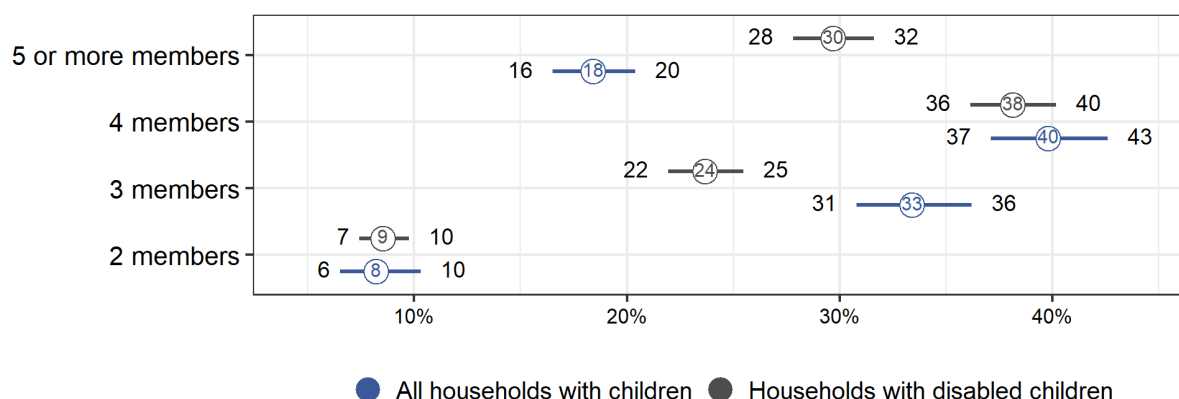
Source: Data from Social Insurance Board

According to representatives from the organisations that unite families with disabled children, there are several reasons behind the increased number of disabled children. On the one hand, diagnosing of diseases that underlie disabilities has improved and the number of deaths among disabled children may have declined due to increased effectiveness of treatment. On the other hand, appropriate care services for disabled children have become more readily available and parents have become more aware that a disability can provide access to financial support and certain services for free, which may result in more parents applying for a certification of the degree of disability.

Households with disabled children and the main carer of the child

About 7–10% of disabled children live in households consisting of two people (Figure 3), 58–65% in households with three to four people and 28–32% in households with five or more people. According to the Estonian Social Survey of 2016, households with five or more members form 16–20% of all Estonian households with children. This means that disabled children are more likely to live in households with five or more members than all children living in Estonia.

Figure 3. Households with disabled children and all households with children in Estonia by size of household (% of households)



Sources: Estonian Social Survey 2016, Survey of Families with Disabled Children 2017, authors' calculations

Note: Circles denote point estimates of the mean, numbers beside them denote the lower and upper bounds of the 95% confidence interval

81–84% of disabled children live in households where they are the only child with a disability. The rest of the disabled children live in households where there are two or more children with disabilities. 33–37% of disabled children live in households with one child, 39–43% in households with two children and 23–26% in households with three or more children.

17–21% of disabled children live in households with only one adult and 2–4% in households where that one adult has a disability. 9–12% of parents who care for a disabled child have a disability themselves.

8–11% of disabled children live in households where there are no working adults. 38–42% of disabled children live in households with one working member and 48–53% in households with two working members.

The survey was aimed at the person who was the main carer of the disabled child. In the majority of cases, the main carer of the child was the child's parent (95–97%), Puudega lapse eest peamiselt hoolitsev inimene on enamikul juhtudest tema vanem (95–97% juhtudest), mostly the mother (90–92%). 1–2% of disabled children were mainly cared for by their grandparent. In a few cases, the main carer of the child was somebody else (sister, brother, other relative, etc.).

As a rule, the disabled child is cared for by a female (94–96%) and she is aged 25–54 years (95–97%). 66–69% of parents who are carers to their child work, which means that the remaining 30–44% of parents are non-working. In nearly half the cases (43–50%) the reason for non-working was the need to care for a disabled child, followed by parental leave (27–34%), person's own disability or health problem (19–25%) and not being able to find a job with a suitable work load or schedule (18–24%).

Socio-economic situation

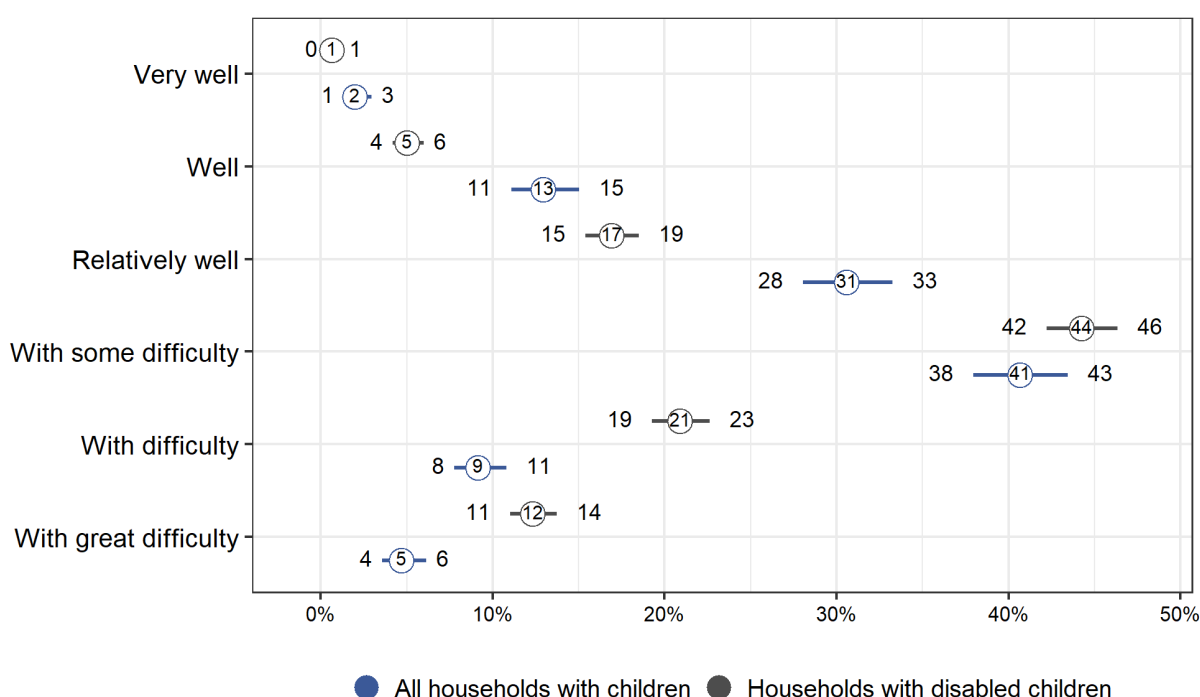
Households with disabled children live on average in the same size accommodation as all other Estonian households with children. The average size of accommodation for families with disabled children is 20.7–24.2 m² per dweller. Based on the Population and Housing Census of 2011⁴, the average area of accommodation per dweller in families with children aged 0–17 years is 22.6 m² in Estonia. 23–28% of households with disabled children have adapted their homes according to the needs of their disabled child

⁴ Statistics Estonia, online database, table RL0807: Average area of inhabited standard accommodation and average number of rooms per dweller, 31 December 2011 (24.10.2017)

and have predominantly financed it themselves. 16–21% of parents of disabled children feel that their home requires more adaptations or needs to be completely readapted. Home adaptation service, i.e. local government support for physical adaptation of homes to meet the requirements of disabled children, has been used by less than 7% of all families with disabled children.

The households with disabled children give their standard of living a lower rating than all Estonian households with children on average. Only 20–26% of all households with disabled children feel that they manage well (incl. responses “relatively well”, “well”, “very well”). Among all households with children this percentage was 40–51 (Figure 4). More households with disabled children struggled to pay utility bills at least once during the previous year compared to the Estonian average. Out of all the Estonian households with children who paid their utility bills, 8–13% struggled with payments, whereas among the families with disabled children the figure was 28–34%.

Figure 4. How does the household manage financially? (% of all households with children and % of households with disabled children)

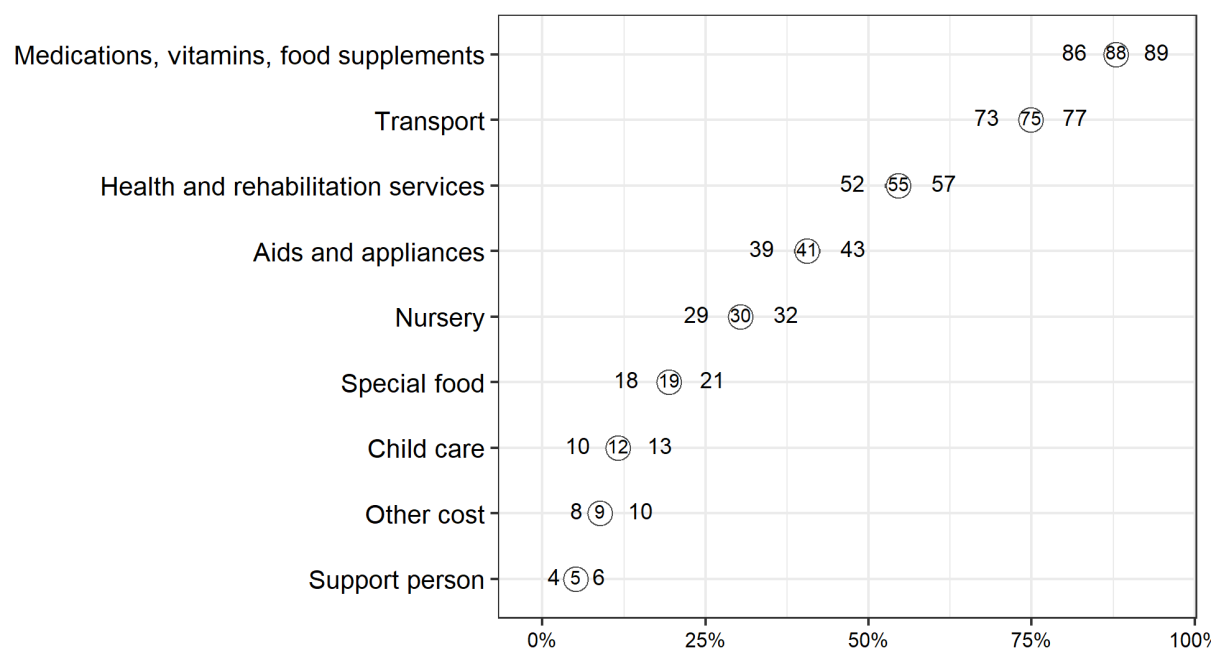


Sources: Households with disabled children: Survey of Families with Disabled Children 2017; All households with children: Statistics Estonia, Estonian Social Survey 2016

Note: Circles denote point estimates of the mean, numbers beside them denote the lower and upper bounds of the 95% confidence interval

Nearly all the parents of disabled children reported incurring expenses on items listed in the questionnaire, only 2–3% of households with disabled children had not experienced any of these types of expenses. Most frequent costs were medications, vitamins and food supplements (86–89% of disabled children) (Figure 5Joonis 175), whereas more than a half of households with disabled children had also incurred expenses on transport (73–77%) or on treatment and rehabilitation services (52–57%). 39–43% of households with disabled children spent money on disability aids.

Figure 5. Expenditure on disabled children in households with disabled children (% of disabled children)



Note: Circles denote point estimates of the mean, numbers beside them denote the lower and upper bounds of the 95% confidence interval

The costliest item is special food, the median spend on which is 80 euros per month in families that use it. At the same time, this cost varies greatly, as in half the households that spend money on special food, the cost fluctuates from 40 to 120 euros per month. The median spend on a support person is not as high (61 euros per month) but it also varies greatly and for half the households that use a support person it ranged from 25 to 153 euros per month. The median spend on both transport and child care was 50 euros per month and both costs varied from about 20 euros to 100 euros per month in households with such spending. The median spend per month on nursery was higher (at 70 euros) and the cost was less variable (ranging from 50 to 90 euros per month for half the households). Median costs are lower on health and rehabilitation services (30 euros per month), medication, vitamins, food supplements (25 euros per month) and disability aids (20 euros per month).

Higher expenditure arises from disabilities that are severe or profound. Expenditure of 50% of households with profoundly disabled children range from 119 to 339 euros per month but may rise to as much as 600 euros. Half the households with severely disabled children spend 60–219 euros on the child's special needs and in case of a moderate disability, 48–159 euros per month.

According to many parents, the extra spending has not been sufficient to meet all the child's needs. This situation occurs most often with the support person service: 29–48% of households with disabled children who have incurred this expense believe that the spending has not been sufficient. At the same time, only a few households (4–6% of households with disabled children) had spent money on support persons. From a quarter to a third (25–35%) of households that spend money on special food (18–21% of all households with disabled children) felt that the spending was not enough to cover the child's needs. 25–37% of households that spent money on child care (10–13%) felt that the spending was not enough. Half the households with disabled children (52–57%) spent money on health and rehabilitation services, whereas 28–33% of them felt that the spending was not enough to cover the child's needs.

In the majority of cases, the disabled child allowance, which in 2017 was 69.04 euros per month for a moderate disability and 80.55 euros per month for a severe or profound disability, was not enough to cover families' extra costs arising from the child's disability. Over half (53–60%) of the disabled children had a

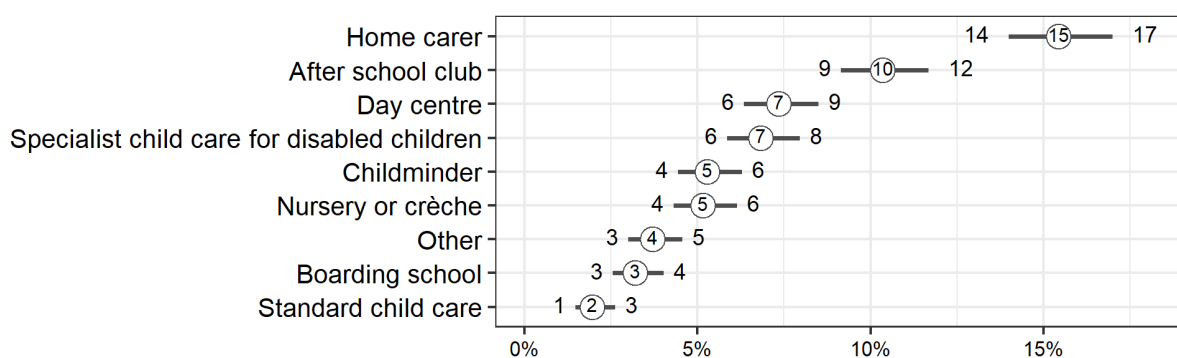
disability which only qualified them for a small degree of support to meet the extra costs or for no support at all. Extra costs arising from disability are met in full or to a great degree by allowances aimed at disabled children for a third (30–36%) of disabled children.

Care load

More than half of the parents (53–57%) of disabled children have used some kind of childcare service for their disabled child during the last 12 months. Most frequently used services are nursery or creche (29–33% of disabled children) and after-school club (13–16%). The use of child care services is primarily linked to the child's age – significantly less child care services are used for older children than for younger children. During the last 12 months, 73–86% of families with disabled children aged 16–17 years had not used any form of child care service, whereas in the age group 0–6 years, the percentage of families not using any child care services was only 10–15.

35–42% of families with disabled children feel the need for increased or additional child care possibilities. The most frequent need is for a home carer in the child's home (14–17% of disabled children, see Figure 6). 9–12% of families with disabled children need an after-school club and less than a tenth of parents of disabled children have an additional need for each of the other child care services.

Figure 6. Need for increased or additional child care for disabled children (% of parents with disabled children)

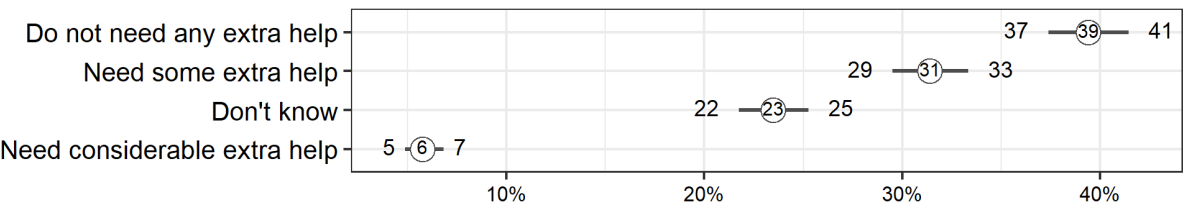


Note: Circles denote point estimates of the mean, numbers beside them denote the lower and upper bounds of the 95% confidence interval

Approximately half (53–57%) of parents of disabled children get help with child care from another member of their household either once a week or more frequently. A quarter (24–27%) of the parents receive help with child care from a member of the family or a relative from outside the household at least once a week. Less than a tenth of parents with disabled children get help with child care from somebody else at least once a week. In case of 11–13% of disabled children, no other person helps their parent with child care.

34–40% of parents with disabled children would need extra help in looking after their disabled child or other people they care for. 29–33% of them would need some extra help and 5–7% would require significant extra help (Figure 7). The degree of how much extra help the parent of the disabled child needs is related to the child's degree of disability. Extra help is required by 47–65% of parents with profoundly disabled children, 40–46% of parents with severely disabled children and 24–30% of parents with moderately disabled children. The need for extra help is also linked to the child's disability type and the parent's level of education. Extra help is required by 45–52% of parents whose child has multiple disabilities and 44–56% of parents whose child has a mental disorder, whereas in the category "other disability" 22–29% of parents require extra help. Parents with higher education level feel the need for extra help more than those with secondary, vocational, basic or lower education.

Figure 7. Need for extra help in looking after or caring for a disabled child or other people (% of parents with disabled children)

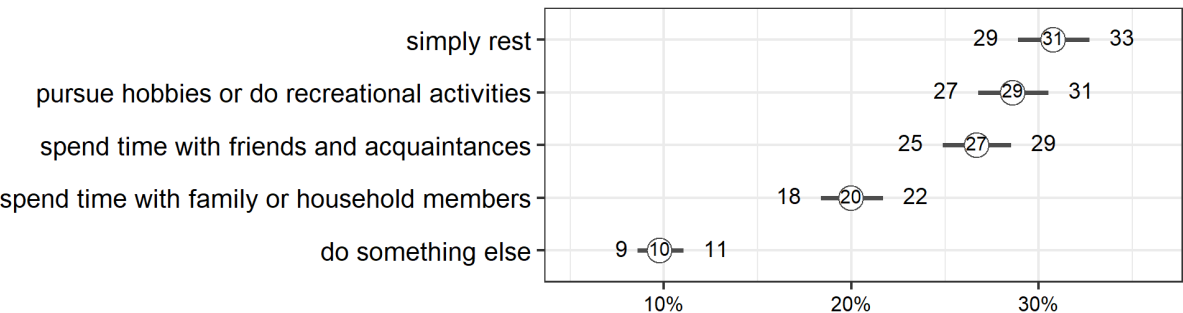


Note: Circles denote point estimates of the mean, numbers beside them denote the lower and upper bounds of the 95% confidence interval

Two thirds of parents with disabled children have had to make concessions in their work or studies during the last 12 months due to their care responsibilities. The most frequent are work related concessions: 33–37% of parents with disabled children have had to take time off work more than once during the last 12 months, 24–27% have frequently had to ask for a care leave, 14–17% have frequently had to reduce their work load. 15–20% of parents with disabled children have had to give up working at least once during the last 12 months.

Approximately 80% of parents with disabled children have performed some activity less than they would have wished to during the last 12 months. About a third (29–33%) of parents with disabled children have frequently had less time than they would have wanted to simply rest (Figure 8), 27–31% have frequently had less chance to pursue hobbies or enjoy recreational activities and 25–29% have frequently had less time to spend with their friends and acquaintances than they wanted.

Figure 8. Due to looking after or caring for a disabled child/children have, during the last 12 months, frequently had less chance than they wished to... (% of parents with disabled children)

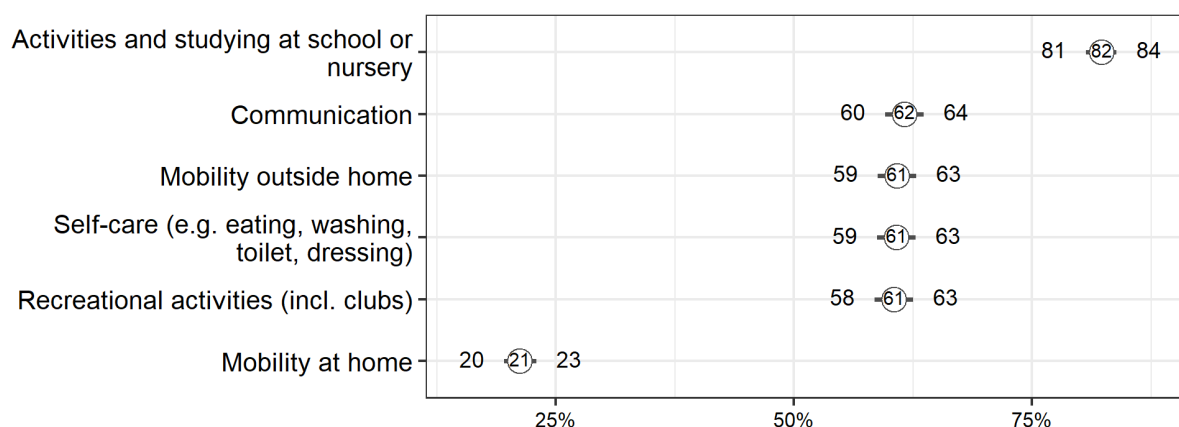


Note: Circles denote point estimates of the mean, numbers beside them denote the lower and upper bounds of the 95% confidence interval

Need for external help

The parents of the majority of disabled children feel that their child needs external help due to their disability (Figure 9) at school or nursery (81–84%), for communication (59–64%), for mobility outside home (59–63%), for recreational activities (58–63%), or for self-care (59–63%). Only about 8% of disabled children do not need any disability-related external help for any of the activities included in the survey.

Figure 9. Need for external help due to disability (% of disabled children)



Note: Circles denote point estimates of the mean, numbers beside them denote the lower and upper bounds of the 95% confidence interval

By background identifier, the need for external help was only analysed among those participants who actively participated in the activities included in the survey. The need for external help varied by type of disability and the assistance required followed a logical pattern, e.g. most children requiring external help for mobility at home had a mobility disability, most of those requiring external help with communication had a mental disorder, speech and language impairment or multiple disabilities. However, in all the activities included in the survey, the need for external help was never limited to one type of disability only – in each one of the activities, there were children from every type of disability who required external help.

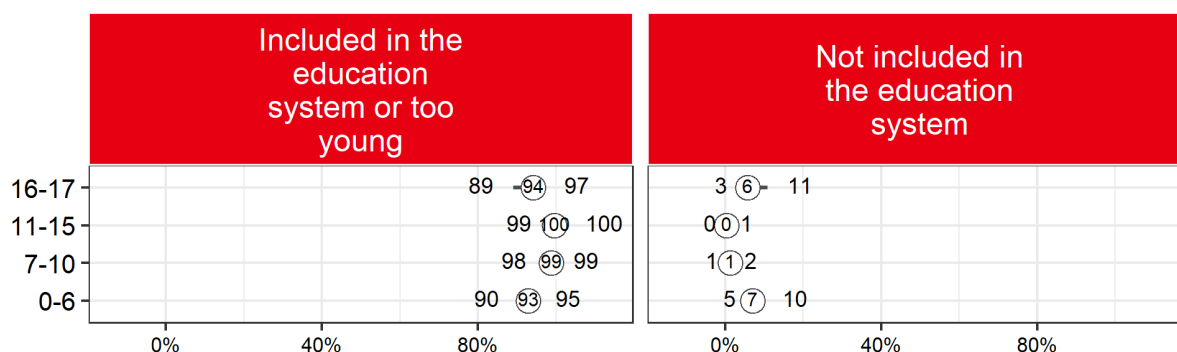
In case of nearly all the activities included in the survey (excl. communication), profoundly disabled children needed more disability-related external help than children with a moderate or severe disability. 90–99% of profoundly disabled children needed external help for recreational activities, which is significantly higher than in case of severely (71–76%) and moderately (58–66%) disabled children. In regards to self-care, 85–96% of profoundly disabled children needed external help, compared to 62–68% of severely disabled children and 50–57% of moderately disabled children. External help for mobility outside of home was required by 86–96% of profoundly disabled children, 64–69% of severely disabled children and 51–58% of moderately disabled children. External help for mobility at home was required by 52–70% of profoundly disabled children, 19–24% of severely disabled children and 14–19% of moderately disabled children. At school or nursery, external help was needed by 92–99% of profoundly disabled children, 89–93% of severely disabled children and 75–81% of moderately disabled children.

Education services

62–66% of disabled children aged 0–17 years went to school (incl. home schooling and hospital schooling) in school year 2016/2017. Nursery or crèche was attended by 28–32% of disabled children. 3–4% of children did not attend any nursery, crèche or school as their parents considered them too young. In conclusion, 2–4% of disabled children did not participate in any pre-school or primary education for other reasons than age.

Pre-school aged children and those aged 16–17 years were more likely to be in the group that did not participate in any kind of schooling (Figure 10). 1–2% of 7–10-year olds did not attend any school or nursery as well as 0.1–1% of 11–15-year olds.

Figure 10. Disabled children not participating in the education system for reasons other than age (% of disabled children in age group)



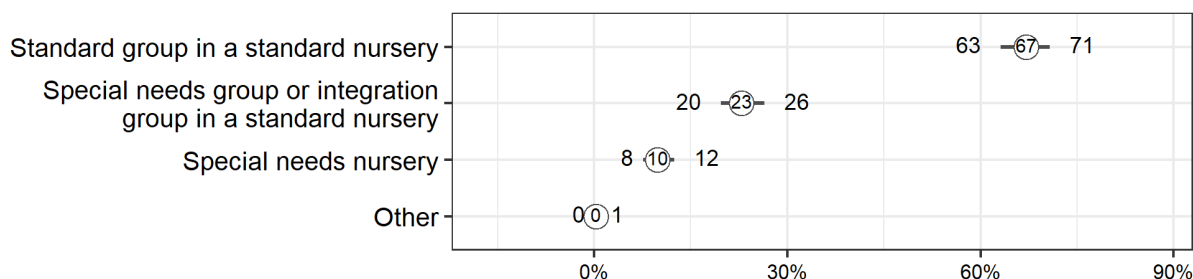
Note: Circles denote point estimates of the mean, numbers beside them denote the lower and upper bounds of the 95% confidence interval

If we look at the children who were old enough but still did not attend a nursery or a crèche, we can see a link with the degree of their disability. 10–24% of profoundly disabled children were not part of the education system, compared to 2–4% of severely disabled children and 1–3% of moderately disabled children.

Comparison between 2017 and 2009 shows that the proportional share of disabled children not participating in the education system has largely remained the same. According to the research report from 2009, the total share of disabled children outside the education system was 8% (GfK 2009:34)⁵.

The majority of disabled children attend a standard school or nursery as part of a standard class or group. 53–59% of disabled children who go to school study in a standard class (Figure 12), 63–71% of disabled children who go to nursery are part of a standard group (Figure 11). 8–12% of disabled children who go to nursery attend a special needs nursery and 20–26% attend a special needs group or integration group in a standard nursery.

Figure 11. What kind of nursery or group did the child attend in school year 2016/2017? (% of disabled children attending nursery)

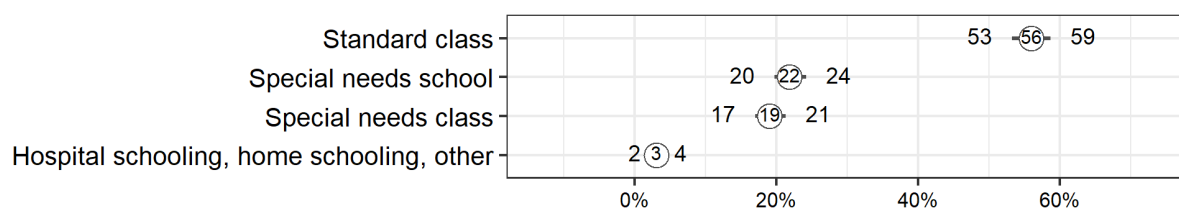


Note: Circles denote point estimates of the mean, numbers beside them denote the lower and upper bounds of the 95% confidence interval

Out of the disabled children attending school, 20–24% go to a special needs school and 17–21% to a special needs class.

⁵ GfK (2009) Survey of Needs and Living Standards of Families with Disabled Children 2009, Quantitative Survey Report in Estonian. https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/Puudega_laps/puudega_laste_perede_toimetulek_2009.pdf

Figure 12. What kind of school and class did the child attend in school year 2016/2017? (% of disabled children attending school)



Note: Circles denote point estimates of the mean, numbers beside them denote the lower and upper bounds of the 95% confidence interval

Children with a profound or severe disability are more likely to study in a special needs nursery or school. Out of all the disabled children attending nurseries, 12–48% of children with a profound disability, 10–17% with a severe disability and 2–7% with a moderate disability go to a special needs nursery. Out of all the disabled children at school, 68–88% of all profoundly disabled children, 24–30% of severely disabled children and 4–9% of moderately disabled children attended a special needs school.

The main problem the disabled children face both at school and nursery is the availability of support measures within educational establishments. 40–48% of disabled nursery children and 31–36% of disabled school children had problems accessing rehabilitation services within educational establishments. Other support services were more readily available.

Disabled children who studied in special needs nurseries and schools experienced less problems in accessing support services and with the learning standards meeting their needs and ability than disabled children studying in standard schools. For example, 30–62% of children attending special needs nurseries had issues with accessing the services of a psychologist, compared to 59–78% of those attending an integration group in a standard nursery or 48–60% of those in a standard group. For the physiotherapy service the numbers were 29–59% in special needs nursery, 61–79% in an integration group and 49–61% in a standard group. At school, for instance, there were less issues with teachers' knowledge and skills in special needs school (11–20%) than in a special needs class in a standard school (37–50%) or standard class (22–29%). The suitability of the curriculum was also more likely an issue for students in standard classes of standard schools (18–24%) and in special needs classes (23–35%) than in special needs schools (8–16%). At the same time, children studying in special needs schools and nurseries were more likely to be confronted with the problem of the school or nursery being a long distance from home and the cost of transport. Out of all the children attending special needs nurseries and integration groups, the physical distance of the nursery was a problem for 24–51% of children in special needs nurseries and 15–30% of children in integration groups, compared to 6–12% of children in standard nurseries. For those children studying in special needs school, the distance to the school was a problem in 21–32% of cases and for those studying in a standard class of a standard school, only in 10–15% of cases.

Health care services

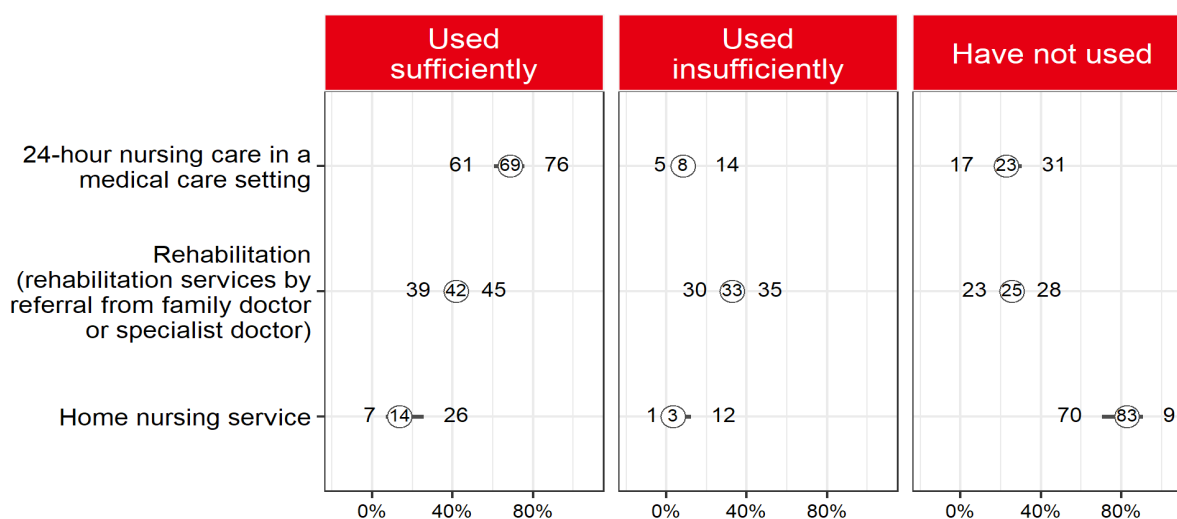
Out of various health care services, during the last 12 months, the majority of disabled children needed a general practitioner (90–93%), specialist doctor (90–93%) or a dentist (80–83%). There was less need for emergency medical care and hospitalisations, 33–37% and 30–33% of disabled children respectively.

There were only a very few cases where children did not receive the service they required. 0.2–0.9% of disabled children who needed to see a general practitioner did not get an appointment during the last 12 months. 0.9–2.1% of disabled children who needed a specialist doctor and 2–5% of those needing emergency medical care or a dentist did not use the service at all and neither did 5–8% of those requiring hospitalisation. In conclusion, children who needed a service were mostly able to access it.

About a half (50–54%) of disabled children who saw a specialist doctor had issues with using the service. About a third of disabled children who needed the services of a general practitioner, dentist, hospitalisation or emergency medical care experienced accessing issues (in case of general practitioner 29–32%, dental care 27–31%, hospitalisation 26–34% and emergency medical care 33–40% of). Most frequent problems experienced in using the services of a general practitioner, specialist doctor or a dentist were long waiting lists (in case of general practitioner 16–19%, specialist doctor 40–44% and dentist 18–22% of disabled children who used the service) and difficulty in booking appointments (in case of general practitioner 9–12%, specialist doctor 21–24% and dentist 6–8% of disabled children who used the service). Long waiting lists were also the main problem when accessing the services of emergency medical care and hospitalisation (23–30% of disabled children who used emergency medical care and 13–19% in case of hospitalisation). All other problems occur significantly less often (experienced by less than 7% of disabled children who used the particular service). There is no comparative data to assess whether the need for health care services, usage frequency and problems experienced by disabled children differ from those of all other children in Estonia.

More than half the disabled children (57–61%) required a rehabilitation service in the last 12 months, 6–8% required round-the-clock nursing care at a medical establishment and 2–3% needed the home nursing service. Round-the-clock nursing care has been the most widely available service among them, with 61–76% of all disabled children who needed it having sufficient access to it, whereas the rehabilitation service was sufficiently accessible to only 39–45% of disabled children. The situation is more difficult if a child requires the home nursing service – only 7–26% of disabled children who needed it could access it sufficiently and 70–91% of those needing the service had no access to it at all (Figure 13). Since the home nursing service is only required by very few, the children who needed the service but did not receive it constituted only a small percentage of all disabled children (2–3%).

Figure 13. Availability of health care services (% of disabled children who required the particular service)



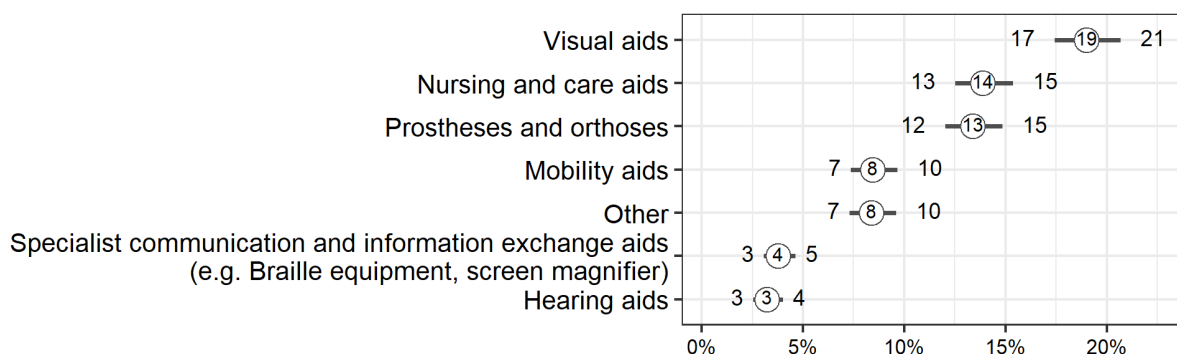
Note: Circles denote point estimates of the mean, numbers beside them denote the lower and upper bounds of the 95% confidence interval

Less than a fifth (15–19%) of parents with disabled children have turned to alternative medicine. Parents with higher education (22–28%) were more likely to turn to alternative medicine. Reasons for using alternative medicine were given in free text answers and mostly said that alternative medicine was used as an additional measure or that parents had had negative experiences with traditional medicine, such as negative attitudes, not receiving any help, disappointment.

Need for and use of disability aids

Most frequently, the disabled children required (Figure 14) visual aids (17–21% of disabled children). Nursing and care aids were needed by 13–15%, prostheses and orthoses by 12–15%, mobility aids by 7–10%, specialist communication aids by 3–5% and hearing aids by 3–4% of disabled children. Nearly half (approx. 49%) of disabled children needed at least one disability aid from the categories included in the survey.

Figure 14. Need for disability aids (% of disabled children)



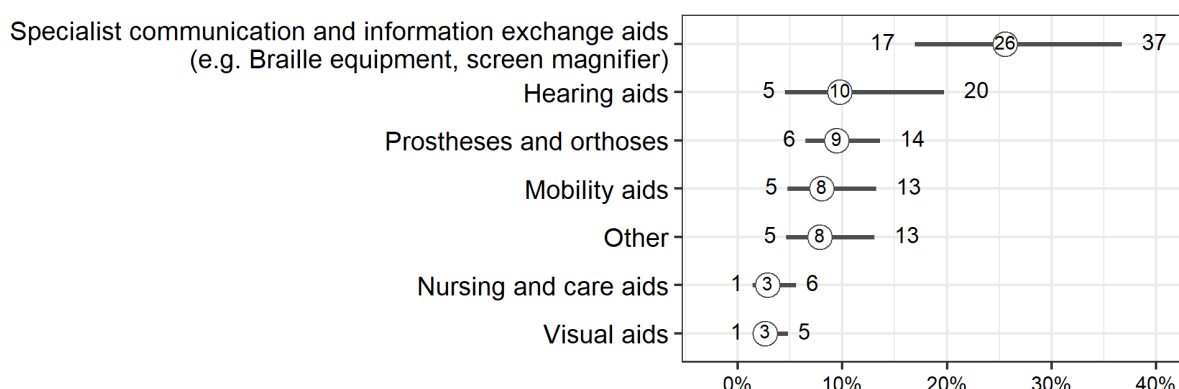
Note: Circles denote point estimates of the mean, numbers beside them denote the lower and upper bounds of the 95% confidence interval

The need for disability aids by background identifier has been analysed only among those parents of disabled children who gave an assessment to the particular need, i.e. the parents who could not answer were excluded. The need for an aid is relatively specific to the disability – thus, the need for visual aids is high (required by 80–99%) among visually impaired children and the need for hearing aids is high (required by 85–99%) among hearing impaired children. Mobility aids are required by 23–39% of children with a mobility disability, followed by children with multiple disabilities as 13–19% of them need a mobility aid. Prostheses and orthoses are most needed by children with a mobility disability (38–55%) and multiple disabilities (19–25%) and in all other disability types the need for these aids is significantly lower.

As a rule, if a child needs a disability aid, they use it. There are, however, situation in all categories of disability aids where the child needing the aid does not use it at all for various reasons (e.g. the aid is not available, not had a chance to acquire it or the existing aid does not meet the requirements) (Figure 15). The most problematic aid category in this respect was specialised communication and information exchange aids, which were only required by 3–5% of disabled children, but were not used by 17–37% of children who needed them.

The reasons for not using necessary aids were described in free text answers as being expensive, no suitable aid existed or it was not available, long waiting lists or lack of information on how to acquire and use them.

Figure 15. Not using required aid for various reasons (% of disabled children who need to use aids from the category)



Note: Circles denote point estimates of the mean, numbers beside them denote the lower and upper bounds of the 95% confidence interval

Usually, the disability aid that is used meets the requirements of the disabled child. Children who had to use disability aids used the aids that met their requirements, depending on the aid, from 91–96% for visual aids to 48–70% for specialised communication and information aids. At the same time, there were situations in all aid categories where the disability aid did not suit the child's requirements. The aids did not suit the requirements of about a tenth of disabled children who needed to use them. Most problematic are mobility aids, as 8–18% of users have a mobility aid that, according to their parent, does not suit the child's requirements. In case of other disability aids, the share of children that used an aid that did not suit their requirements was less than a tenth of all those who needed to use the particular aid.

Reasons for using an aid that did not suit the child's needs were given as free text answers and were mostly very aid specific. Some of the more generic reasons given were that the aid was uncomfortable, the child was growing fast and constantly required new aids, and the family was unable to afford a suitable aid for the child.

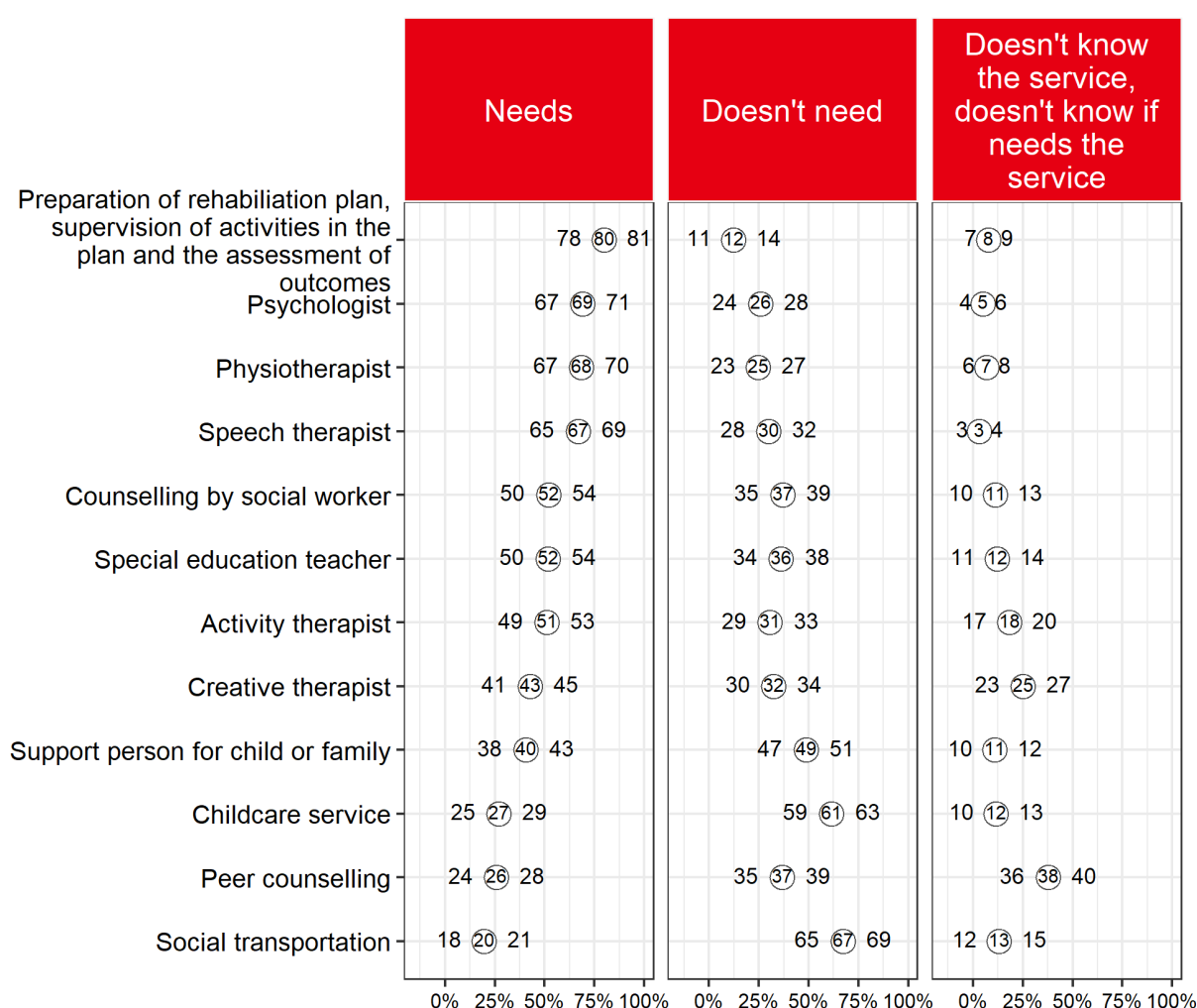
Social services

Need for social services

Almost all disabled children need at least one social service (96-97% of disabled children). The most frequently needed social service among disabled children is the rehabilitation service, which includes preparation of a rehabilitation plan, supervision of activities described in the plan and the assessment of outcomes⁶ (Figure 16). During the last year, 78-81% of disabled children have needed this service. The parents of two thirds, or more, of disabled children felt their child needed the services of a psychologist (67-71%), a physiotherapist (67-70%) or a speech therapist (65-69%). The parents of about half of disabled children felt their child needed a consultation with a social worker (50-54%) or the services of a special education teacher (50-54%) or an activity therapist (49-53%). The services of a creative therapist and a support person were needed by about 40% of disabled children (41-45% and 38-43%, respectively). About a quarter of the children needed childcare services (25-29%) and peer counselling (24-28%) and about a fifth (18-21%) needed social transportation services.

⁶ The service of rehabilitation plan preparation, supervision of activities in it and the assessment of outcome is different from all other services discussed as this is a prerequisite to receiving the rehabilitation services. In 2016, rehabilitation programme and activity plan were introduced as alternatives to the rehabilitation plan. Since the rehabilitation plan was previously a prerequisite to receiving any rehabilitation services, the perceived need for this service may be essentially different from the perceived need for other services.

Figure 16. The need for social services during the last 12 months (% of disabled children)



Note: Circles denote point estimates of the mean, numbers beside them denote the lower and upper bounds of the 95% confidence interval

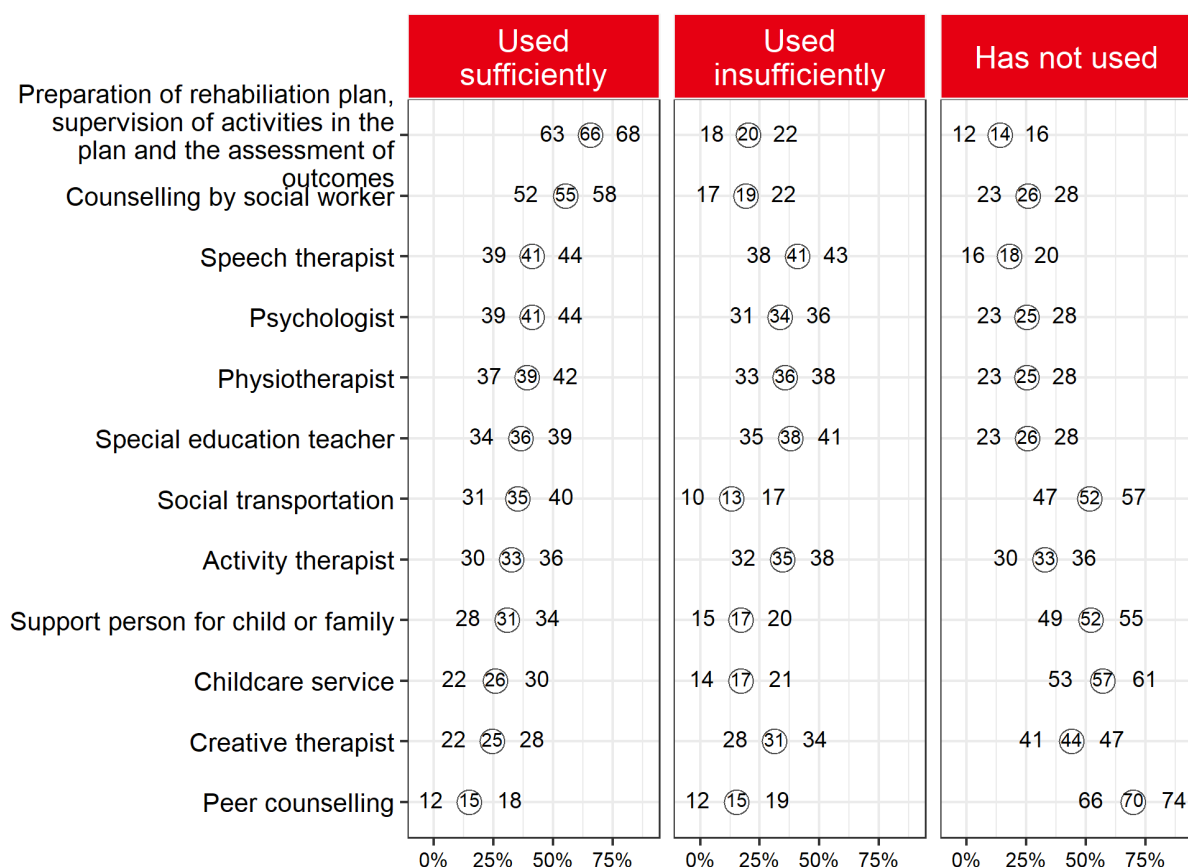
Many parents were unsure about the service of activity therapists, creative therapists and, especially, peer counselling. 3-8% of parents were unsure about the service of psychologists, physiotherapists and speech therapists, whereas 17-20% were unsure about the work of therapists, 23-27% creative therapists and 36-40% peer counselling. This result indicates that the service of activity therapists, creative therapists and, especially, peer counselling are so new that people are unaware of their existence and, therefore, many parents are unable to form opinions about the need for such services. Compared to the results of the 2009 survey, the share of disabled children who need social services has increased by about 5 to 10 percentage points across all services.

Availability of social services

Two thirds of children whose parents perceived the need for a social service during the last 12 months did not have most of these services sufficiently available to them or were completely unavailable (Figure 17). The service with the best availability was that of preparing a rehabilitation plan and supervising the activities in the plan, as well as counselling by a social worker, to which half of the children (63-68% and 52-58%, respectively) who needed those services had sufficient access. All other services were sufficiently available to less than a half of the disabled children who needed them. The availability of peer counselling was particularly bad: 66-74% of those who needed this service didn't receive it at all. Also problematic are the services of social transportation, support persons and childcare, which are provided by local

governments. About half of the disabled children who needed those services didn't receive them at all (47-57% in case of social transportation, 49-55% in case of support person, and 53-61% in case of childcare).

Figure 17. Use of social services by disabled children during the last 12 months (% of disabled children who needed the service)



Note: Circles denote point estimates of the mean, numbers beside them denote the lower and upper bounds of the 95% confidence interval

About one fifth (21-24%) of disabled children have had no problems with requesting or receiving social services. Most common problems faced in receiving and requesting social services are insufficient availability of services offered (27-31% of disabled children), too long waiting lists (25-29%) and administrative complexity (22-25%). The problem that the services on offer are too far away was mentioned by the parents of 14-17% of disabled children. All of the other remaining problems asked about were experienced by less than 15% of disabled children.

Compared to 2009, the share of people experiencing problems with social services is not significantly higher.

Information

The lack of information about assistance and allowances available for disabled children is a great problem. The families of half (46-50%) the disabled children find that information about allowances, services and assistance for disabled children is difficult or very difficult to access. In addition, 22-26% are unable to evaluate the availability of information. Thus, the information is easily or very easily accessible to 26-30% of households with disabled children.

Leaving aside those unable to evaluate the accessibility of information, the accessibility is more often a problem for Russian-speaking families than for Estonian speakers. Information has been difficult or very

difficult to access for 57-63% of families speaking Estonian and 65-74% of Russian-speaking families. In the focus group with parents of disabled children, the situation was described as being behind a double wall. First, obtaining information about allowances and services is very difficult in general since the systems are fragmented and there is nobody who could give an overview of the support system for disabled children across different domains. Second, little information is available in Russian and for someone speaking Estonian as a second language, information in Estonian may not be fully understandable. Even for a non-native speaker with some Estonian skills, the information on allowances and services for disabled children is difficult to comprehend due to specialised vocabulary.

Since the support and assistance of disabled children is fragmented between the central and local governments as well as across social, education and health care systems, there is no single channel for families of disabled children to obtain information from about allowances, services and assistance. To obtain information, one must turn to several different sources, official as well as unofficial. Most often used information channels are rehabilitation institutions (mentioned by parents of 30-34% of disabled children), other parents (30-34%), topical websites (28-32%) and the Social Insurance Board (28-31%). Families of a quarter to a third of disabled children have obtained information through each of these channels. The next group of sources by prevalence is made up of local governments (22-26%) and specialist doctors (21-24%), through whom a fifth to a quarter of parents have obtained information. The third group, through which 10-20% of families of disabled children have obtained information, is made up of friends and acquaintances, Internet forums and general practitioners. Other channels were of minor importance with less than 10% of families of disabled children using them to obtain information.

In free text answers, parents of disabled children offered a number of suggestions on how to improve the dissemination of information. The responses can be summarised into three broad recommendations:

- 1) to use email to inform all families of disabled children of available allowances, services, benefits and any changes to existing regulations;
- 2) to create a specific website, which would pool together comprehensive information from central and local governments as well as from different domains (health care, education and social protection);
- 3) to provide one contact person in every local government with a comprehensive knowledge of all available services, allowances and assistance, and who would be responsible for providing this information to families with disabled children.

It was mentioned in the focus group that the creation of all three channels above would be necessary in order to improve access to information for the families with disabled children.

Sissejuhatus

Puue, mida õigekeelsussõnaraamat määratleb kui inimese keha- või vaimuviga, viga või puudust, mõistetakse erinevates kontekstides ja erinevate inimeste poolt erinevalt. Puude määramisel vastandatakse sageli kahte erinevat mudelit: meditsiinilist mudelit, mille kohaselt puue tuleneb inimese tervislikust olukorrast ja on seega lähtuv inimesest endast, ning sotsiaalselt mudelit, mille kohaselt on puue pigem ühiskonna poolt kirjeldatud, mitte inimesest lähtuv. Maailma Terviseorganisatsioon toob välja, et puude määramisel ei tohiks neid kahte lähenemist vastandada, vaid arvesse tuleb võtta nii inimese tervist kui keskkonda. Uuemaks lähenemiseks on puude määramisel biopsühhosotsiaalne mudel, mille kohaselt kujuneb puue inimese tervise, isiku ja keskkonna omavaheliste vastastikuste suhete mõjul⁷. Seetõttu on ka puudega inimeste toimetuleku hindamisel vaja arvestada nii tervist kui ühiskonnaelus osalemist ja seda takistavaid ning soodustavaid tegureid.

Eesti seadusandja defineerib puuet puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 järgi kui inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotust või kõrvalekallet, mis koostoides erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega takistab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel. Käesolevas uuringus on puudega lapsed määratletud lastena, kel on ametlikult sotsiaalkindlustusametis tuvastatud puue.

Ametlikult tuvastatud puudega lapsi oli uuringu läbiviimise hetkel Eestis 13 143. Aastate lõikes on puudega laste arv järjepidevalt kasvanud. Puude määramisel tuvastatakse puude raskusaste ja puudeliik. Eristatakse kolme raskusastet: keskmine, raske ja sügav. Eristatakse kaheksat puudeliiki: kuulmis-, nägemis-, liikumis-, kõne- või kuulmispuue, vaimupuue, psüühikahäire, muu puue ja liitpuue. Puudega lastest 57% on raske puudega, 38% keskmise puudega ja 6% sügava puudega. Võrreldes 2009. aastaga on kasvanud keskmise ja raske puudega laste arv, samas kui sügava puudega laste arv on veidi vähenenud.

Kaheksast puudeliigist on suurima esinemissagedusega liit- ja muu puue, mis moodustavad vastavalt 31% ja 32% puudega laste arvust. Ülejäänud kuus puudeliiki jagunevad 37% puudega laste vahel. Puude raskusastmete esinemissagedus puudeliikide lõikes ei ole ühtlane. On puudeliike, mille alla koonduvad enam raske või sügava puude raskusastmega lapsed nagu psüühikahäire ja liitpuue, ning puudeliike, mille all on enam keskmise puude raskusastmega lapsi (muu puue). Ka vanuse ja soo lõikes ei ole puudega laste jagunemine puudeliikide vahel ühtlane.

Käesolev uuring on 2009. aasta puudega laste ja perede toimetuleku kordusuuring, mille eesmärk on kaardistada puudega lastega perede toimetulek ja vajadused 2017. aastal. Küsitlusankeedi lähtepunktiks võeti 2009. aastal kasutatud ankeet. Küsitluse ettevalmistuse käigus muudeti ankeeti ladususe ja mõistetavuse parandamiseks ja tulenevalt teenuste ja toetuste süsteemi vahepealsetest muudatustest (uuringu ankeet on toodud uuringu lisas). Võrreldavus 2009. ja 2017. aasta tulemuste vahel on seetõttu võimalik vaid piiratud ulatuses.

Küsitlustööd viidi läbi 2017. aasta augustis-septembris. Küsitlusele vastas kokku 1904 inimest. Valdavalt vastati veebiküsitlusele, väiksem osa vastajaid eelistasid silmast-silma küsitlust. Vastused kaaluti analüüsi teostamiseks üldkogumi (puudega laste) sotsiaal-demograafilistele tunnustele vastavalt. Küsitlusele vastas inimene, kes puudega lapse eest hoolitsemisega kõige rohkem tegeleb. Vastanutest 95% olid puudega lapse vanemad. Uuringu raportis kasutatakse väljendit „puudega lapse vanem“ kõigi uuringu küsimustikule vastajate kohta.

⁷ WHO (2011) World Report on Disability.

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf?ua=1

Analüüsis kasutatakse valimipõhise küsitluse andmeid, millest tehakse järeldusi puudega laste kohta Eestis tervikuna (üldkogum). Kuna küsitluse andmetest ei ole võimalik teha üldkogumi kohta täpseid järeldusi, esitatakse hinnangud üldkogumi väärtustele 95%-liste usaldusvahemikena. Vahemikud näitavad, milline on 95%-lise tõenäosusega nähtuse levik puudega laste seas Eestis.

Analüüsides nähtuste seoseid taustatunnustega nagu nt teenuse vajaduse seos puude liigi, puude raskusastme jt tunnustega, kasutatakse kahte lähenemist:

- Esmalt vaadatakse lihtsalt ühe taustatunnuse lõikes nähtuse levikut (nt teenuse vajadus sügava puudega, raske puudega ja keskmiste puudega laste seas).
- Lisaks vaadatakse seoseid, võttes samaaegselt arvesse erinevaid taustatunnuseid. Selleks kasutatakse logistilist regressiooni, mis võimaldab hinnata vaadeldava taustatunnuse seost nähtusega nii, et teiste taustatunnuste mõju on elimineeritud. Näiteks saab selliselt teada, kas puude raskusaste on seotud teenuse vajadusega ka juhul, kui arvesse võtta puudeliik, lapse vanus ja lapse elukoht. Sisuliselt võimaldab erinevate taustatunnuste samaaegne arvesse võtmine välja tuua puhta(ma) seose tunnuse ja analüüsitava nähtuse vahel.

Analüüsi meetodika täpse kirjelduse leiab uuringu esimesest peatükist, kust asjast huvitatud lugeja saab teada, kuidas küsitlus korraldati ja ellu viidi (ptk 1.1), kuidas on arvutatud usalduspiirid ning leitud regressioonanalüüsi tulemused (ptk 1.3). Lugejal, kellele tehnilised üksikasjad ei paku huvi, soovitame liikuda otse huvipakkuva uuringu tulemusi esitavate sisuliste peatükkide juurde (alates ptk 2). Kui siiski tekib küsimusi jooniste tõlgendamisel, soovitame vaadata üle näited ptk 1.3.5, kuidas jooniseid lugeda.

Küsitlustulemused on esitatud uuringu peatükkides 2-10 ja need käsitlevad küsitluses kaetud teemasid järgmiselt:

- Peatükk 2 annab ülevaate puudega laste arvust, jagunemisest puudeliikide ja puude raskusastmete lõikes, puudega laste leibkondade suurusest ja puudega laste vanemate sotsiaaldemograafilisest profiilist.
- Peatükk 3 käsitleb puudega laste puudest tulenevat kõrvalabi vajadust ning abivahendite vajadust, kättesaadavust ja vastavust vajadustele.
- Peatükk 4 käsitleb puudega laste poolt kasutatud tervishoiuteenuseid (perearst, eriarst, hambaravi, haiglaravi, taastusravi, koduõendus ja statsionaarse ööpäevaringse õendusteenus), nende kasutamise seost taustatunnustega ja tervishoiuteenuste kasutamisel ilmnenud probleeme.
- Peatükk 5 annab ülevaate sellest, kui paljud puudega lapsed vajavad sotsiaalteenuseid (tugiisik, sotsiaaltransport, lapsehoiuteenus, sotsiaaltöötaja poolne nõustamine, rehabilitatsiooniplaani koostamine, täitmise juhendamine ja tulemuste täiendamine, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, loovterapeudi, logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi ja kogemusnõustaja teenus), kui paljud on neid teenuseid saanud kasutada vastavalt vajadustele, kui paljud on teenuseid saanud vähem kui neil vaja oli ja milliseid probleeme on sotsiaalteenuste kasutamisel sagedamini esinenud.
- Peatükk 6 annab ülevaate puudega laste kaasamisest haridussüsteemi: kui paljud lapsed õpivad tavalasteaegades ja -koolides ning kui paljud erikoolides ja -lasteaegades.
- Peatükk 7 kirjeldab puudega lastega kaasnevat hoolduskoormust ning lapsehoiu võimaluste kasutamist ja täiendavat vajadust. Samuti käsitletakse hoolduskoormusega kaasnevaid probleeme puudega lapse hoolitsemisega kõige enam tegelevale pereliikmele.
- Peatükk 8 võtab kokku puudega lastega perede kulutused ja hinnangud enda sotsiaalmajanduslikule toimetulekule. Lisaks käsitletakse puudega lastega perede eluruumi suurust ja vastavust laste vajadustele.
- Peatükk 9 käsitleb puudega lastele mõeldud teenuste ja toetuste teabe kättesaadavust ning kanaleid, mille kaudu teavet saadakse.

- Peatükk 10 toob välja üldisemad puudega laste vanemate hoiakud puudega laste kuvandi kohta avalikkuses ja puudega lapsi puudutavad arvamused üldisemalt.
- Raport lõppeb tulemused ja järelduste peatükiga.

1 Uuringu metoodika

1.1 Küsitluse metoodika

Käesolevas raportis on esitatud uuringu metoodika lühiülevaade. Pikem ülevaade uuringu metoodikast on leitav metoodikaraportist.

1.1.1 Küsitluse taust

Kogu Eestit hõlmava puudega lastega perede küsitluse, mille eesmärgiks oli saada ülevaade puudega lastega perede toimetulekust ja vajadustest (toetuste ja teenuste osas), viis läbi Turu-uuringute AS perioodil 29. august – 28. september 2017. Eelmine (ning samas ka esimene) samalaadne küsitlus viidi läbi aastal 2009.

Andmed koguti veebi- ning silmast-silma küsitluse teel. Sihtrühmaga kontaktivõtuks kasutati Sotsiaalkindlustusameti registriandmeid puudega laste eest sotsiaaltoetusi saavate inimeste kohta, mida oli täiendatud Rahvastikuregistrist päritud kontaktandmetega.

1.1.2 Küsitluse sihtrühm

Sotsiaalkindlustusameti andmetel elas Eestis seisuga 28.06.2017 kokku 13 143 puudega last. Küsitluse sihtrühmaks olid pered, kuhu kuulus vähemalt üks 0–17-aastane puudega laps. Puudega last/lapsi kasvatavate perede täpset arvu pole võimalik määratleda, kuna Sotsiaalkindlustusameti registriandmed pole perepõhised.

Peresiseselt oli küsitlusankeet suunatud inimesele, kes puudega lapse eest hoolitsemisega kõige rohkem tegeleb. See võis olla puudega lapse vanem, aga ka vanavanem, täiskasvanud vend või õde, muu sugulane või mitesugulane.

Valdav osa ankeedi küsimustest puudutas puudega last, kuid oli ka üldisemaid (kogu pere toimetulekut) puudutavaid küsimusi. Juhul, kui peres oli mitu puudega last, paluti vastajal ankeet täita sellest lapsest lähtuvalt, kelle sünniaastale viidati uuringust teavitavas kirjas (laps, kellest lähtuvalt pere juhuvalikuga valimisse sattus).

Küsitlustööst jäeti kõrvale pered, kes elavad väljaspool Eestit (seisuga 01.01.2017 elas väljaspool Eestit 43 puudega last) ja lapsed, kes elavad alaliselt hooldekandenasutuses (täpset arvu pole SKA registriandmete põhjal võimalik määratleda). Kuna uuring keskendus peredele, polnud suur osa ankeedi küsimustest alaliselt hooldekandenasutuses viibivate laste kohta asjakohased. Hooldekandenasutuses viibivaid lapsi püüti valimist välja võtta juba enne küsitlustööga alustamist, kontrollides lapse eest toetuste saajaks märgitud isiku kontaktandmeid – juhul, kui need viitasid institutsioonile või sotsiaaltöötajale, võeti isik valimist välja. Siiski ei õnnestunud sellise eelkontrolli põhjal välistada valimist kõiki juhtumeid, kus laps elas hooldekandenasutuses, mistõttu langes isikuid sel põhjusel valimist välja ka edasise küsitlustöö käigus.

1.1.3 Valimibaas

Kuna tegu on kitsa sihtrühmaga, kelle leidmine elanikkonnast lihtsa juhuvalikuga on keeruline, päriti valimi kontaktid Sotsiaalkindlustusameti hallatavast sotsiaalkaitse infosüsteemist puudega laste eest sotsiaaltoetusi saavate inimeste andmetest. Valimi moodustamisel kasutati süstemaatilist juhuvalikut domineeriva puude liigi alusel moodustatud kihtidest, mis oli sorditud lähtuvalt järgmistest tunnustest: lapse sugu, vanuserühm (0-6 a, 7-15 a, 16-17 a), puude raskusaste, asulatüüp (linnaline või maaline) ja maakond.

Lisaks teostati valimisse sattunud isikute kohta täiendav kontaktandmete päring Rahvastikuregistrisse, et kontaktinfo oleks võimalikult värske ning tõenäosus isikuga ühendust saada (mitme telefoninumbri või e-

maili aadressi olemasolu korral) oleks suurem. Andmete väljastamiseks ning töötlemiseks saadi luba Andmekaitse Inspeksioonilt.

Kokku päriti sotsiaalkaitse infosüsteemist 8 000 isiku kontaktandmed. SKA väljastas andmed 7 997 isiku kohta (3 isikut langes valimist välja lapse vahepealse surma tõttu). Valimibaasist sorteeriti välja isikud, kelle puhul kontaktandmed viitasid lapse viibimisele institutsioonis ning korduvad kontaktid (juhul, kui sama isik oli märgitud sotsiaaltoetuste saajaks mitme puudega lapse eest, jäeti valimibaasi vaid ühest lapsest lähtuv kirje, et välistada topelt-kontaktivõttu sama isikuga). Kokku võeti puhastamise käigus valimibaasist välja 470 isikut. Seejärel teostati põhivalimisse kaasatavate isikute valik: kindla sammu alusel kaasati puude liigi alusel määratletud valimikihtidest põhivalimisse 5403 isikut. Valikust kõrvale jäänud isikud (kokku 2124) jäid lisavalimina reservi. Reservi jäänud valimist võeti küsitlustöö käigus kasutusele 24 isiku kontaktid (Lõuna-Eesti vaimupuudega laste rühmas). Ülevaade valimibaasist on toodud järgnevas tabelis (Tabel 1).

Tabel 1. Ülevaade valimibaasist

Kirjeldus	Isikute arv
Isikuid Sotsiaalkindlustusametist päritud valimibaasis	8 000
Valimist välja võetud lapse surma tõttu	3
Isikuid Sotsiaalkindlustusametist saadud valimibaasis	7 997
Valimibaasist enne küsitlustöö algust välja praagitud - institutsioonis viibiv laps või korduvad kontaktid (sama isik on märgitud toetuste saajaks mitme lapse puhul)	470
Kasutuskõlblikke kontakte valimibaasis peale puhastamist	7 527
Põhivalimisse kaasatud isikuid	5 403
Lisavalimisse jäetud isikuid	2 124
Lisavalimist küsitlustöö käigus kasutusele võetud isikuid (Lõuna-Eesti vaimupuudega laste rühm)	24
Küsitlusse kaasatud isikuid kokku	5 427

Juhul, kui valim oleks moodustatud puudeliikide lõikes proportsionaalsena, oleksid kontaktibaasis kuulmispuudega, nägemispuudega või vaimupuudega laste pered esindatud liiga vähesel arvul, et nende rühmade kohta statistiliselt usaldusväärseid järeldusi teha. Seetõttu suurendati nendes rühmades põhivalimit selliselt, et 30%lise vastamisaktiivsuse puhul oleksid need puude liigid lõppvalimis esindatud vähemalt 60 vastajaga (iga puudeliik eraldi võetuna). Selle arvelt vähendati põhivalimit suuremate puudeliikide, nagu muu puue ja liitpuue, osas. Hilisemas andmetöötlemises kaaluti valim puudeliikide lõikes proportsiooni üldkogumiga (kaalumise kohta vt järgmine ptk).

1.1.4 Valim ja kaalumine

Planeeritud lõppvalimi suurus oli 1 600 vastajat. Eeldades 30-protsendilist vastamisaktiivsust, kaasati põhivalimisse 5 403 isikut. Kasutusse läks ka 24 vastajaga lisavalim Lõuna-Eesti vaimupuudega laste rühmas. Tegelikult lõppvalimi suuruseks kujunes 1 904 vastajat, seega oli vastamisaktiivsus 35% (vastamisaktiivsuse arvutamisel pole välja jäetud isikuid, kes keeldusid küsitlusest osalemisest põhjusel, et ei kuulnud sihtgruppi – veebiküsitluse puhul pole keeldumise põhjused tuvastatavad).

Tulemuste laiendamisel üldkogumile tekkida võiva maksimaalse valimivea suurus jääb valimi sellise suuruse (1 904 vastajat) puhul 95%lisel usaldusnivool 2,1% piiresse (väiksemate rühmade, nt puudeliikide eraldi vaatlemisel võib viga olla suurem).

Küsitlustöös seati eesmärgiks saavutada puude liigist ja regioonist lähtuvatele kvootidele vastav valim. Jagunemist asulatüübi, puude raskusastme ja puudega lapse vanuse alusel jälgiti n-ö pehme kvoodina. Kvootide järgmine tagas valimi vastavuse mudelile kvootide aluseks võetud tunnuste lõikes. Mudeli ja

lõppvalimi vaheliste erinevuste täiendavaks tasandamiseks teostati andmete kaalumise lähtuvalt (valimisse sattunud lapse) domineeriva puude liigi, puude raskusastme ja elukoha tunnustest.

1. Puudeliik (8 gruppi):
 - keele- ja kõnepuue
 - kuulmispuue
 - nägemispuue
 - liikumispuue
 - vaimupuue
 - psüühikahäire
 - muu puue
 - liitpuue
 - Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja keelepuue
 - Liikumispuue
 - Vaimupuue ja psüühikahäire
 - Muu puue
 - Liitpuue
2. Regiooni ja puudeliikide grupid (6 x 5 = 30 gruppi):
 - Tallinn
 - Põhja-Eesti
 - Lääne-Eesti
 - Kesk-Eesti
 - Kirde-Eesti
 - Lõuna-Eesti
3. Puude raskusaste (3 gruppi):
 - Keskmine puue
 - Raske puue
 - Sügav puue
4. Asulatüüp (3 gruppi):
 - Tallinn
 - Muud linnalised asulad
 - Maalised asulad

Kaalumise aluseks võeti valimisse sattunud lapse kohta sotsiaalkaitse infosüsteemis sisalduvad andmed, mitte vastaja poolt antud ütlused (v.a juhul, kui vastaja poolt antud ütlustest selgus, et ta on ankeedi täitnud mõne teise lapse kohta, mida esines 29 juhul).

Üldkogumi, kaalumata valimi ja kaalutud valimi profiilide võrdlus on toodud järgnevas tabelis (Tabel 2).

Tabel 2. Üldkogumi, kaalumata ja kaalutud valimi profiilide võrdlus

	Üldkogum (Sotsiaalkaitse infosüsteemi andmed seisuga 28.06.2017)	Kaalumata valim	Kaalutud valim
PUUDEGA LAPSE SUGU			
Poiss	64,2%	66,2%	66,5%
Tüdruk	35,8%	33,8%	33,5%
PUUDEGA LAPSE VANUS			
0-6 a.	27,3%	29,0%	28,3%
7-15 a.	65,5%	64,3%	64,2%
16-17 a.	7,3%	6,7%	7,4%
ELUKOHT (REGIOON)			
Tallinn	20,0%	19,2%	20,0%
Põhja-Eesti	9,3%	9,6%	9,3%
Lääne-Eesti	8,6%	9,3%	8,6%
Kesk-Eesti	10,2%	10,0%	10,2%
Kirde-Eesti	17,8%	20,0%	17,8%
Lõuna-Eesti	34,1%	32,0%	34,1%
ELUKOHT (ASULATÜÜP)			
Tallinn	20,0%	19,2%	20,0%
Muud linnalised asulad	47,2%	47,7%	47,2%
Maa-asulad	32,7%	33,0%	32,7%

	Üldkogum (Sotsiaalkaitse infosüsteemi andmed seisuga 28.06.2017)	Kaalumata valim	Kaalutud valim
LAPSE PUUDE LIIK			
Keele- ja kõnepuue	10,1%	10,0%	10,1%
Kuulmispuue	2,0%	3,7%	2,0%
Nägemispuue	1,2%	3,2%	1,2%
Liikumispuue	7,1%	7,9%	7,1%
Vaimupuue	3,6%	2,6%	3,6%
Psüühikahäire	14,4%	15,0%	14,4%
Muu	30,6%	28,7%	30,6%
Liitpuue	30,9%	29,1%	30,9%
LAPSE PUUDE RASKUSASTE			
Keskmine	37,6%	34,6%	37,6%
Raske	56,6%	58,8%	56,6%
Sügav	5,8%	6,6%	5,8%

1.1.5 Küsitlusmeetodite kirjeldus

Andmekogumine viidi läbi kombineeritud meetodil. Põhiline osa ankeetidest (1 828 tk) koguti veebiküsitluse, väiksem osa (76 tk) silmast-silma küsitluse teel.

Kontaktivõtu viis sõltus sellest, millised andmed isiku kohta registriandmetes olemas olid. Isikutele, kelle kohta oli teada e-maili aadress, saadeti uuringut tutvustav kiri koos küsitlusankeedile suunava lingiga välja e-maili teel (põhivalimis 4 818 isikut).

Juhul, kui e-maili aadress puudus, kuid isiku kohta oli teada tema telefoninumber, võeti isikuga ühendust telefoni teel (põhivalimis 389 isikut). Telefonivärbamisse suunati ka isikud, kelle puhul e-mail n-ö tagasi põrkus (st registrites toodud e-maili aadressid olid kehtetud) (196 isikut). Juhul, kui isik andis telefonitsi nõusoleku küsitluses osalemiseks, märgiti üles tema e-maili aadress, kuhu saadeti uuringut tutvustav kiri koos lingiga veebiankeedile (algsel kontaktivõtul 298 isikut). Alternatiivina pakuti võimalust, et isikut külastab küsitaja, kelle juuresolekul saab ankeedi täita kas küsitaja tahvelarvutis või silmast-silma intervjuu vormis (vastamise hõlbustamiseks kasutati ka paberkanalil kaarte). Nõusoleku küsitaja külastuseks andis telefonivärbamise käigus 85 isikut. Lisaks kontakteerus 5 isikut uuringufirmaga ise, et anda teada soovist küsitaja külastuseks.

Juhul, kui kontaktibaasis olid olemas vaid aadressiandmed (põhivalimis 196 isikut), saadeti teavitus uuringu läbiviimise kohta välja tavaposti teel. Teavituskirjas sisaldus lisaks üldisele uuringut puudutavale infole ka link küsitluskeskkonda, vastaja unikaalne kood, mis tuli sisestada ankeedile pääsemiseks ning küsitlusjuhtide kontaktandmed, kuhu helistades või kirjutades oli võimalik anda teada oma soovist uuringus mitte osaleda või vastata küsitlusele silmast-silma.

Juhul, kui täidetud ankeeti määratud tähtajaks ei laekunud, saadeti valimisse sattunud isikutele (kes polnud andnud teada keeldumisest) välja meeldetuletuskiri. Peale seda tehti sihtrühmades, kus vastamisaktiivsus osutus oodatust madalamaks (põhiliselt Ida-Virumaa elanikud), meeldetuletuskõned telefoni teel. Kokkuvõtte kontaktivõttudest on toodud allolevas tabelis (Tabel 3).

Tabel 3. Ülevaade kontaktivõttudest

Kirjeldus	Isikute arv
Registriandmetes oli e-maili aadress: saadeti välja e-mail – põhivalim	4818
Registriandmetes oli e-maili aadress: saadeti välja e-mail – lisavalim	24
Registriandmetes puudus e-mail, kuid oli telefoninumber: suunati telefonivärbamisse	389
Registriandmetes puudus nii e-mail kui telefoninumber: saadeti välja paberkandjal kiri	196
E-mail põrkus tagasi, suunati telefonivärbamisse	196
Telefonivärbamise valim kokku	585
Meeldetuletuskõnede valim	632
Andis e-maili telefoni teel (peale telefoni teel kontaktivõttu või meeldetuletusi)	357
Veebis välja saadetud ankeete kokku	5199
Andis teada soovist vastata silmast-silma	90

Iga küsitlusmeetodi puhul oli võimalik ankeedile vastata kas eesti või vene keeles. Nii elektrooniline kui ka paberkandjal teavituskiri saadeti igale isikule välja kahes keeles (eesti ja vene). Enne ankeedile vastamise alustamist teavitati vastajaid sellest, et uuring hõlmab vastaja enda, puudega lapse ning teiste leibkonnaliikmete delikaatsete isikuandmete töötlemist ning küsiti selleks vastaja kirjalikku nõusolekut. Intervjuud jätkati vaid sel juhul, kui vastav nõusolek oli saadud. Kokkuvõtted veebi- ja silmast-silma küsitluse tulemustest on toodud järgnevates tabelites (Tabel 4 ja Tabel 5).

Tabel 4. Veebiküsitluse tulem

Kirjeldus	Isikute arv
E-mail oli andmebaasis olemas (saadeti välja e-mail ilma eelneva teavituskõneta)	4 818
Andis e-maili telefoni teel (peale telefoni teel kontaktivõttu või meeldetuletusi)	381
Välja saadetud e-maile kokku	5 199
Kasutuskõlbmatuid e-maili aadresse (e-mail põrkus tagasi)	369
Märkis keeldumise	484
Saadeti e-mail ja täitis ankeedi veebis	1 794
Saadeti paberkandjal kiri ja täitis ankeedi veebis	34
Veebis laekunud ankeete kokku	1 828

Tabel 5. Silmast-silma küsitluse tulem

Kirjeldus	Isikute arv
Silmast-silma küsitluse valim	90
Kedagi pole kodus	1
Sihtrühma kuuluv inimene pole kodus	3
Keelduti kontaktist	3
Muu intervjuu mittetoimumise põhjus	7
Silmast-silma täidetud ankeete kokku	76

Valdav osa kontaktivõttudest ja küsitlusest viidi läbi veebis, mistõttu pole võimalik täielikult kaardistada põhjusi, miks küsitluses osalemisest keelduti. Telefoni teel tehtud kontaktivõttude põhjal võib siiski järeldada, et valimist väljalangemise peamiseks põhjuseks olid puudulikud või aegunud kontaktandmed. Harvem oli põhjuseks see, et vastaja ei kuulu sihtrühma (laps ei ela perekonnas, pere on kolinud väljaspoole Eestit või laps on vahepeal saanud 18-aastaseks). Keeldumine ilma täpsustuseta on tavaliselt põhjendatav üldise vastumeelsusega uuringutes osalemise vastu, samuti ka aja- ja motivatsioonipuudusega. Vastajatelt saadud tagasisidele tuginedes võib öelda, et kohati tekitas vastumeelsust ka asjaolu, et vastajat (ning puudega last) puudutavad isikuandmed on uuringu läbiviijale väljastatud. Siiski oli puudega lastega perede küsitluse vastamisaktiivsus sarnane tavalistele elanikkonnaküsitlustele. Arvestades ankeedi pikkust (millele

vastamine võttis keskmiselt 50-60 minutit) ning seda, et suurem osa vastajaist täitis ankeedi veebis (kus pikkade ankeetide puhul üldjuhul vastamisaktiivsus oluliselt langeb), võib vastamisaktiivsust lugeda heaks.

1.2 Fookusgrupp

Analüüsi autorite poolt valitud uuringu tulemuste arutamiseks viidi 8. novembril 2017. aastal läbi fookusgrupi intervjuu puuetega laste peresid ühendavate organisatsioonide esindajatega. Fookusgrupis arutamiseks valiti olulisemad või vastuolulised analüüsi tulemused, millele võis lapsevanematelt oodata täiendavat kvalitatiivset sisendit. Teemad, millele keskenduti olid: puudega laste arv ja profiil, hoolduskoormus, millest tuleneb sotsiaalteenuste halb kättesaadavus ja kuidas selliste sotsiaalteenuste kättesaadavust parandada, mille kättesaadavus on halvim, kuidas lahendada teabepuuduse probleemi. Intervjuul osales kuus puudega laste peresid ühendavate organisatsioonide esindajat, kes ühtlasi olid ise ka puudega lapse vanemaks. Fookusgrupi intervjuu tulemused on põimitud peatükki 11

1.3 Analüüsi metoodika

1.3.1 Tulemuste analüüs

Küsitluse ankeet koosnes valdavalt Likerti-tüüpi skaaladega küsimustest, mille puhul hinnatakse küsimusega nõustumise määra etteantud kategooriatest lähtuvalt (näiteks: „Kas laps vajab puude tõttu kodus liikumise juures kõrvalabi?“, mille vastusevariandid on: „Vajab pidevalt kõrvalabi“, „Vajab aeg-ajalt kõrvalabi“, „Ei vaja üldse kõrvalabi“, „Laps ei tegele sellega/ on liiga noor“, „Ei oska öelda“), mitme vastusevariandiga küsimustest, mille puhul vastajal paluti märkida kõik tema jaoks kehtivad vastused (näiteks: „Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul puudega lastele suunatud sotsiaalteenuste saamisel või taotlemisel kogunud järgnevaid probleeme?“, kus küsimusele järgneb probleemide loetelu) ning dihhotoomse skaalaga küsimustest (näiteks: „Kas olete kunagi puudega lapse tervisega seoses pöördunud mittetraditsioonilise ehk alternatiivse meditsiini poole?“, mille vastusevariandid on: „Jah“ ja „Ei“). Likerti-tüüpi skaalaga küsimuste analüüsimisel hinnati vastajate osakaalu kategooriate lõikes. Juhul kui kategooriad olid piisavalt samatähenduslikud ja oli võimalik neid ühendada, hinnati ühe või teise kategooria osakaalu korruga (näiteks respondentide osakaal, kes hindasid kõrvalabi vajalikkust vastusevariantidega: „Vajab pidevalt kõrvalabi“ VÕI „Vajab aeg-ajalt kõrvalabi“). Juhul kui kategooriad on ühendatud ja neid kasutatakse osakaalude arvutamisel, on ühendamise loogika tekstis välja toodud.

Uuritavate tunnuste osakaale analüüsiti erinevate uurimisküsimuste suhtes oluliste taustatunnuste lõikes. Peamised kasutatavad taustatunnused olid:

1) Domineeriva puude liik

- a) keele- ja kõnepuue
- b) kuulmispuue
- c) nägemispuue
- d) liikumispuue
- e) vaimupuue
- f) psüühikahäire
- g) liitpuue
- h) muu puue

Puude liigi määratlemisel lähtutakse registriandmetest.

2) Puude raskusaste

- a) keskmine puue
- b) raske puue

c) sügav puue

Raskusastme määratlemisel lähtutakse registriandmetest.

3) Elukoha regioon

- a) Põhja-Eesti
- b) Lääne-Eesti
- c) Kesk-Eesti
- d) Kirde-Eesti
- e) Lõuna-Eesti

Elukoha regiooni määramisel lähtutakse küsitluses antud vastustest.

4) Elukoha asula tüüp

- a) Tallinn

- b) muud linnalised asulad
- c) maa-asulad

Asula tüübi määramisel määratakse lähtutakse küsitluses antud vastustest

5) Lapse sugu

- a) Poiss
- b) Tüdruk

6) Lapse vanusegrupp

- a) 0–6-aastased
- b) 7–10-aastased
- c) 11–15-aastased
- d) 16–17-aastased

Vanuse määramisel lähtutakse registriandmetest.

7) Leibkonna peamine kodune keel

- a) eesti keel
- b) vene keel

Lähtutakse vastaja määratlusest.

8) Vastaja haridustase

- a) põhiharidus või madalam
- b) keskharidus või kutseharidus
- c) kõrgharidus

Lähtutakse küsitluses antud vastustest

Sõltuvalt uuritava tunnuse või uurimisküsimuse spetsiifikast on kasutatud ka muid taustatunnuseid. Kõik konkreetsetes analüüsis kasutatud taustatunnused on iga analüüsi juures eraldi välja toodud.

Vastavalt uurimisküsimusele ja uuritavale tunnusele kasutatakse analüüsiks ja järelduste tegemiseks valdavalt kahte moodust:

- uuritava tunnuse osakaalude hindamine ja nende võrdlemine ühe taustatunnuse lõikes (vt p. 1.3.2)
- uuritava tunnuse esinemise tõenäosuse hindamine mitme taustatunnuse lõikes lähtuvalt regressioonimudeliga prognoositud hinnangutest. Seeläbi leitud osakaalud võtavad samaaegselt arvesse teiste taustatunnuste võimalikku seost uuritava tunnusega (nt puude liigi, puude raskusastme, elukoha samaaegsel arvesse võtmisel saame eristada, milline on neist igaühe puhasseos uuritava tunnusega, kui teiste tunnuste mõju on elimineeritud) (vt p. 1.3.3).

1.3.2 Osakaalude hinnangud ja usalduspiirid

Tavapäraste osakaalude hinnangud esitatakse joonistena, kus tulemused on kajastatud koos usalduspiiridega⁸ usaldusnivool 95%. Küsitluse valimi põhjal leitud punkthinnangud (keskmine, osakaal vms) ei peegelda üldkogumi tegelikku väärtust kunagi täpselt. Kui teeksite uue küsitluse uue valimiga (mis oleks moodustatud täpselt samadel alustel), siis saaksime sama küsimuse kohta mõnevõrra erineva punkt-hinnangu. Seetõttu konstrueeritakse valimi põhjal saadud tulemustest lähtuvalt usaldusvahemik, mille sisse teatud tõenäosusega kõikide järgnevate küsitluste tulemused (meie vaadeldava küsimuse jaoks) jäävad. Kasutades usaldusnivood 95%, hõlmavad usalduspiirid vahemikku, kuhu üldkogumi hinnang jääb 95%lise tõenäosusega. Usalduspiiride ulatus sõltub eelkõige tunnuse loomulikust varieeruvusest (mida suurem on varieeruvus valimis, seda suurem on eelduslik varieeruvus ka üldkogumis ja seda laiemad on usalduspiirid) ja küsitlusele vastajate arvust valimis (mida suurem on valim, seda tõenäolisem on selle sarnasus üldkogumiga ja seda kitsamad on usalduspiirid). Joonistel esitatud osakaalude ja keskväärtuste tõlgendamisel tuleks seetõttu lähtuda hinnangute usaldusvahemikest, mitte osakaalude või keskväärtuste punkthinnangutest. Punkthinnangud kehtivad vaid konkreetse valimi korral, usalduspiiride põhjal saame aga teha järeldusi üldkogumi ehk kõigi puuetega laste kohta Eestis.

Vastuste ja gruppide vahelisi erinevusi üldkogumis tuleb samuti hinnata lähtuvalt usaldusintervallidest. Kui kahe tunnuse või grupi hinnangute usalduspiirid ei kattu, siis võib järeldada, et tunnused või grupid erinevad olulisel määral ka üldkogumis. Kui ühe grupi või tunnuse usalduspiirid kattuvad teise grupi või

⁸ Usalduspiiride leidmiseks kasutatakse Wilsoni meetodit (Wilson score interval) Singletoni korrigeerimisega.

tunnuse punkthinnanguga, siis erinevust gruppide või tunnuste vahel üldkogumis järeldada ei saa ja valimi põhjal nähtuv erinevus võib olla tingitud puhtalt hinnangute loomulikust varieeruvusest või mõõtmisveast. Kui usalduspiirid kattuvad vähesel määral (kuni ühe kolmandiku ulatuses), siis võib suure tõenäosusega eeldada, et üldkogumis on tunnuste või gruppide vahel erinevusi. Kui kattuvus on suurem, siis seda eeldada ei saa.

Kõik analüüsitavad ja joonistel esitatud osakaalud on kaalutud lähtuvalt üldkogumi proportsioonidest.

1.3.3 Logistiline regressioon

Paljud nähtused on mõjutatud enam kui ühest taustatunnusest samal ajal. Näiteks võib mingi nähtuse levik konkreetse puude liigiga laste hulgas olla mõjutatud nende laste puude raskusastmetest. Seetõttu ei pruugi võrdlus ühe taustatunnuse, näiteks puude liigi, lõikes näidata seost selle taustatunnusega, vaid võib sisaldada mõne teise tunnuse mõju samaaegselt.

Et võtta arvesse erinevate taustatunnuste mõju korruga, hinnatakse gruppide vahelisi erinevusi logistilise regressiooni mudelitega (logit-mudel). Logistilise regressiooniga saab hinnata sõltumatute tunnuste (taustatunnuste) mõju binaarse sõltuva tunnuse (uuritava tunnuse) tõenäosusele, võttes samaaegselt arvesse kõikide teiste mudelisse kaasatud taustatunnuste mõju. Seega võimaldab logistilise regressiooni mudel hinnata mingi uuritava hinnangu tõenäosust lähtuvalt mitmete taustatunnuste üheaegsest mõjust.

Eeldusel, et hinnang on taandatud jah/ei valikule, hinnatakse „jah“ esinemise tõenäosust lähtuvalt erinevate taustatunnuste tasemetest (näiteks tugiteenuste vajaduse tõenäosust lähtuvalt lapse puudeliigist ja tema puude raskusastmest). Mudel leiab igale taustatunnusele regressioonikoefitsiendi, mille abil on võimalik iga taustatunnuse mõju uuritavale tunnusele mudeli seisukohast (kõikide taustatunnuste mõju samaaegselt arvestades) kõige optimaalsemal moel kirjeldada⁹. Lähtuvalt taustatunnuste tasemetest ja neile taustatunnustele leitud regressioonikoefitsientidest on võimalik igale respondendile prognoosida mudelipõhine hinnang uuritava tunnuse esinemise tõenäosusele.

Kõikide analüüsis kasutatavad mudelite ja osakaalude hindamisel kasutatakse lõppvalimi ja üldkogumi proportsioonide erinevust arvestavaid kaale.

1.3.4 Kohandatud keskmised prognoosid

Logistilise regressiooni mudelite tulemused esitatakse kohandatud keskmiste prognoosidena (*adjusted average predictions*) graafiliselt. Seeläbi leitakse kõikide taustatunnuste kategooriate jaoks vastajate keskmine prognoositud uuritava tunnuse esinemise („jah“ esinemise) tõenäosus, kontrollides samal ajal teiste taustatunnuste mõju. Selleks prognoositakse logistilise regressioonimudeli alusel kõikide vaatluste jaoks uuritava tunnuse esinemise tõenäosus juhul, kus kõik vaatlused kuulusid antud taustatunnuse kategooriasse (näiteks hinnates kuulmispuudest tulenevat mõju tugiteenuste vajadusele, määratletakse kõik vastajad kuulmispuudega laste vanemate gruppi kuuluvatena) ning ülejäänud mudelisse kaasatud taustatunnused jäetakse nende tegelikele tasemetele (puude raskusastmete määratlused jäetakse iga vastaja puhul tegelikeks). Seejärel leitakse prognoositud tõenäosuste kõikide vastajate ülene keskmine. Saadud keskmist tõenäosust saab käsitleda kui antud taustatunnuse kategooria puhasmõjust tulenevat uuritava

⁹ Logit ehk logistilise regressiooni mudel on esitatav kujul $\text{logit}(\pi) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 \dots + \beta_k x_k$, kus π on uuritava tunnuse toimumise tõenäosus, $\text{logit}(\pi)$ on logaritm uuritava tunnuse šanssidest ($\text{logit}(\pi) = \ln\left(\frac{\pi}{1-\pi}\right)$), β_0 on mudeli vabaliige (logiti väärtus, kui kõik taustatunnused on nullid) ja β_k on regressioonikoefitsient taustatunnuse x_k jaoks. Seega uuritava tunnuse esinemise tõenäosus on esitatav läbi taustatunnuste lineaarse suhte kui $\pi = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 \dots + \beta_k x_k)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 \dots + \beta_k x_k)}$

tunnuse tõenäosust, mis võtab samal ajal arvesse kõikide teiste taustatunnuste erinevatest tegelikest jagunemistest tulenevaid mõjusid (näiteks tugiteenuste vajaduse tõenäosust kuulmispuudega laste seas, võttes samal ajal arvesse puude raskusastmest tulenevat mõju tugiteenuste vajadusele).

Kohandatud keskmised prognoosid esitatakse sarnaselt osakaalude hinnangutega koos usalduspiiridega. Usalduspiirid hõlmavad jällegi vahemikku, kuhu prognoositud üldkogumi hinnang 95% tõenäosusega jääb. Prognooside tõlgendamisel ja taustatunnuste kategooriatele prognoositud tõenäosuste omavahelisel võrdlemisel tuleks samuti lähtuda usaldusintervallide vahemikest.

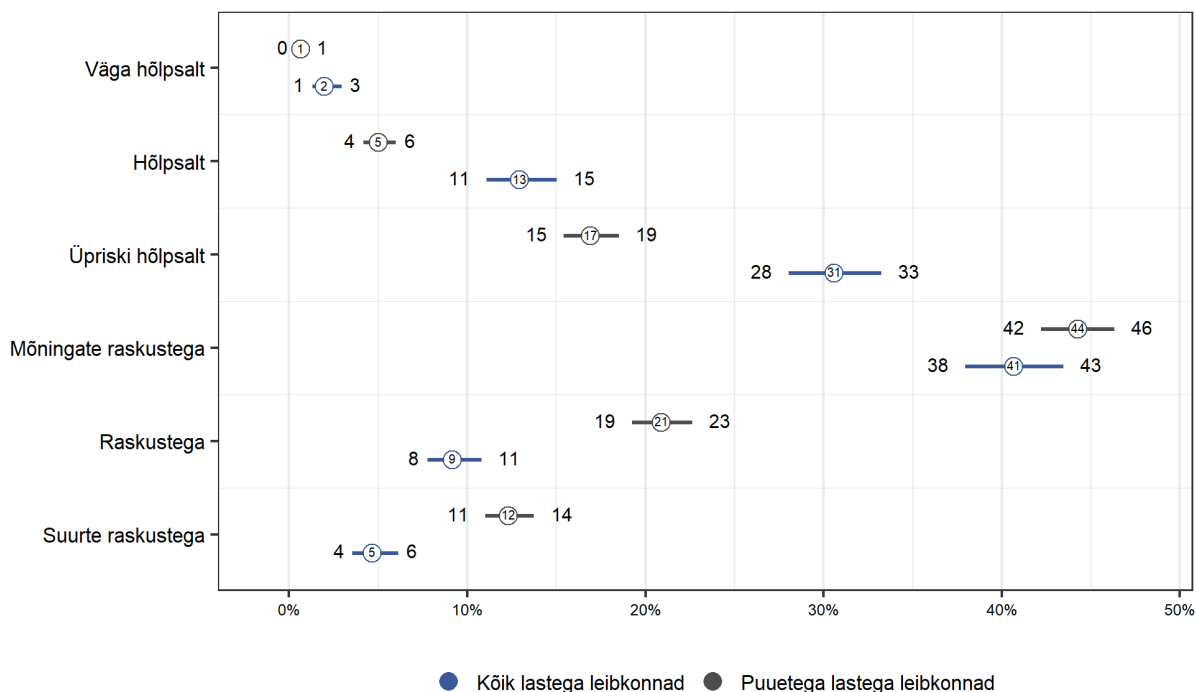
1.3.5 Tulemuste tõlgendamise näide

1.3.5.1 Osakaalude hinnangute näide

Joonis 18 illustreerib osakaalude graafilist esitust. Hinnatakse rahalist toimetulekut kõikide lastega leibkondade ja puudega lastega leibkondade seas. Üpriski hõlpsasti saavad hakkama 15–19% puudega lastega leibkondadest. Kõikide lastega leibkondade seas on vastav vahemik 28–33%. Kuna usalduspiirid ei kattu (19% ehk puudega laste leibkondade ülemine usalduspiir on väiksem kui 28% ehk kõigi lastega leibkondade alumine usalduspiir), siis võib järeldada, et puudega laste leibkondade seas on oluliselt vähem leibkondi, kus saadakse hakkama üpris hõlpsasti, kui Eestis tervikuna. Usalduspiiride kattuvust on joonisel lihtne visuaalselt jälgida – kui suur on kahe joone ühisosa. Kui kahel joonel ühisosa puudub või on väga väike, siis on tulemused statistiliselt oluliselt erinevad; kui ühisosa on suur, siis ei saa erinevust tuvastada.

Mõningate raskustega saab hakkama ca 42–46% puudega laste leibkondadest. Tavaleibkondade seas on vastav hinnang 38–43%.

Joonis 18. Kas leibkond tuleb vajalike kulutuste tegemisel ots otsaga kokku? (% kõigist lastega leibkondadest ja % puudega lastega leibkondadest)



Allikad: Lastega leibkonnad Eestis – Eesti Sotsiaaluuring 2016, puudega lastega leibkonnad – puudega lastega perede toimetuleku uuring 2017.

Kuna usaldusintervallid kattuvad küllaltki suurel määral, siis võib järeldada, et puudega lastega leibkondade osakaal, kes saavad hakkama mõningate raskustega, ei erine oluliselt lastega leibkondade osakaalust Eestis tervikuna, kes on oma hakkamasaamist samaväärselt hinnanud. Kuigi esimesel juhul on

valimi keskväärtus 44% ja teisel juhul 41%, siis üldkogumi kohta järeldusi tehes peame arvestama valimipõhiste tulemuste võimaliku ebamäärasusega (võimalusega, et puudega lastega leibkondade üldkogumi tegelik keskväärtus võib ekstreemsemal juhul olla hoopis usaldusvahemiku alumise piiri lähedal, ehk ca 42% ja kõikide lastega perede korral usaldusvahemiku ülemise piiri lähedal ehk ca 43%, seega tegelikud üldkogumi väärtused võivad valimi tulemustele vastupidised olla), mis ei võimalda antud juhul gruppide vahelist erinevust järeldada.

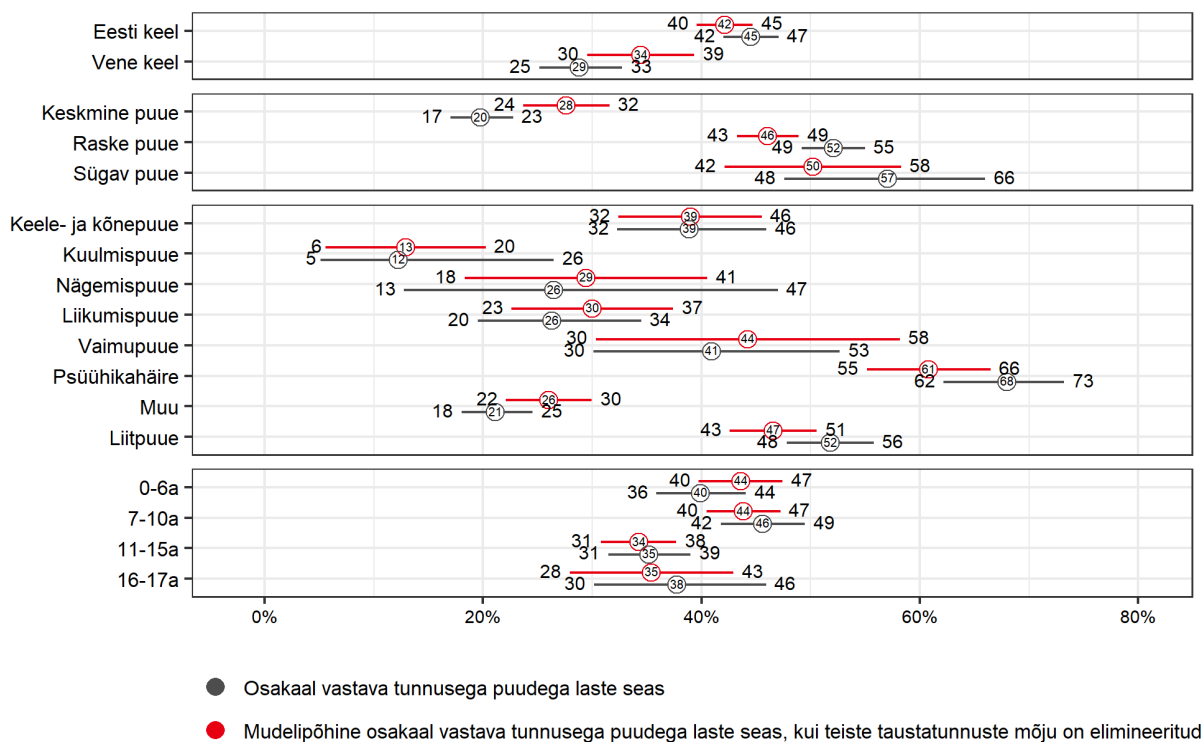
1.3.5.2 Kohandatud keskmiste prognooside näide

Joonis 19 illustreerib kohandatud keskmiste prognooside graafilisest esitust. Hinnatakse tugiisiku vajadust lähtuvalt erinevatest taustatunnustest. Graafikul on välja toodud ainult olulised taustatunnused (mille kategooriate lõikes on olulisi erinevusi). Mudelisse kaasatud, aga joonisel esitamata taustatunnused (mille kategooriate lõikes olulisi erinevusi ei ole, kuid mille suhtes tulemused kontrollitud on) on ära toodud joonisealuses märkuses.

Joonisel on esitatud iga taustatunnuse kõikide kategooriate lõikes nii logistilise regressioonimudeliga prognoositud ja kõiki teisi taustatunnuseid arvesse võttev hinnang tugiisiku vajaduse tõenäosusele kui ka lihtne (teisi taustatunnuseid mittearvestav) vajaduse osakaal. Arvestamata teiste taustatunnuste mõju, on näiteks puude raskusastmete lõikes tugiisikut vajavate laste osakaal (vanemate poolt antud hinnangutest lähtudes) keskmise puudega laste hulgas ca 17–23% ja raske puudega laste hulgas ca 49–55%. Võttes arvesse ka teisi taustatunnuseid, on mudeli prognoositud tugiisiku vajadus keskmise puudega laste seas märksa suurem (tugiisikut vajab 24–32%) kui raske puudega laste seas (vastavalt 43–49%). Tugiisiku vajadus sõltub lisaks puude raskusastmest ka mitmetest teistest teguritest, nagu kodune keel, puudeliik või lapse vanus. Mudelipõhine prognoos võimaldab kõiki muid tegureid arvesse võttes hinnata puude raskusastmest tulenevat otsest mõju, see tähendab mõju, mis tuleneb ainult puude raskusastmete erinevusest ja mitte näiteks sellest, et raske puudega on enam teatud puudeliikidega lastest ja keskmise puudega teistsuguste puudeliikidega lastest.

Prognoositud tõenäosus tugiisiku vajaduseks erineb lapse vanuse lõikes. 0–6 aastaste laste hulgas on antud vajaduse tõenäosus 40–47%, 7–10 aastaste laste hulgas samuti 40–47%. Kuna nende kahe grupi usaldusintervallid kattuvad, siis võib järeldada, et need kaks vanusegruppi tugiisiku vajaduse poolest ei erine. 11–15-aastaste laste hulgas on aga antud vajaduse tõenäosus 31–38%. Kuna usaldusintervallid nooremate vanusegruppidega ei kattu, võib järeldada, et 11–15 aastased vajavad oluliselt väiksema tõenäosusega tugiisikut kui nooremad lapsed. Usaldusintervallid 16–17 aastaste laste gruppidele on suhteliselt laiad (28–43%), kattes täielikult 11–15 aastaste grupi usaldusvahemiku ja kattudes suurel määral ka nooremate vanusegruppide usaldusvahemikega. Seega ei saa järeldada, et kõige vanem vanusegrupp noorematest tugiisiku vajaduse poolest erineks.

Joonis 19. Puudega laste seas tugiisikuteenuse vajadus viimase 12 kuu jooksul (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvaartuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab teenust = 1, ei vaja teenust, ei tea teenust, ei oska öelda = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: puude raskusaste, puudeliik, lapse vanus, kodune keel, elukoha regioon, elukoha liik, elukoha asula tüüp, lapsevanema haridustase.

2 Puudega lapsed ja nende pered

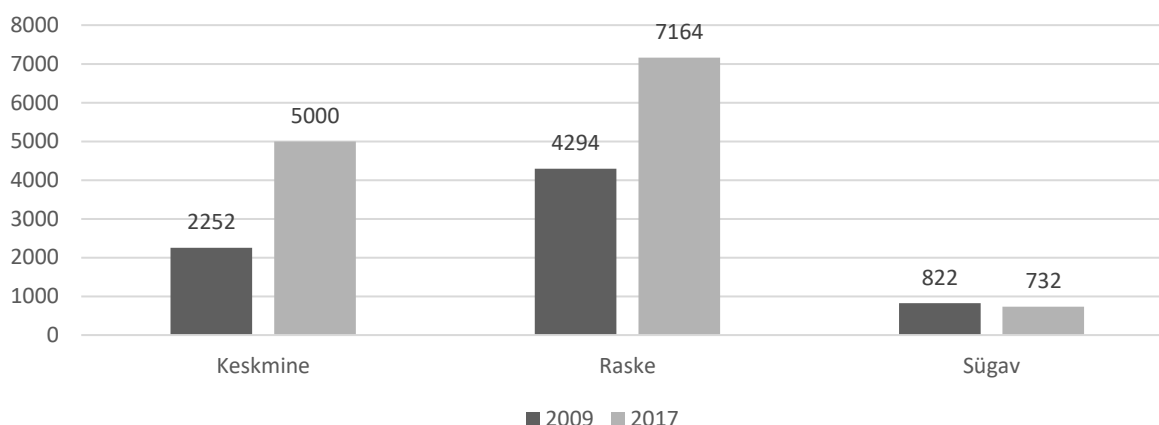
2.1 Puudega laste arv ja profiil

Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli Eestis 2017. aasta 1. jaanuari seisuga 12 896 puudega 0–17-aastast last. Eesti kõikidest lastest on see ca 5,1%¹⁰. Puudega lastest 56% ehk 7 164 olid raske puudega, 39% ehk 5000 keskmise ja 732 ehk 6% olid raske puudega (vt Tabel 6). Enamik puudega lastest on kas liitpuudega või puudeliigiga „muu puue“. 2017. aastal oli selliseid lapsi puudega lastest 63%.

Registriandmete põhjal on võrreldes 2009. aastaga puudega laste arv oluliselt kasvanud (vt Joonis 20). 2009. aasta 1. jaanuari seisuga oli puudega lapsi 7368 ning 0–17-aastasest elanikkonnast moodustasid puudega lapsed 2,9%. Eelkõige on kasvanud keskmise ja raske puudega laste arv ning sellest tulenevalt on sügava puudega laste osakaal puudega laste seas oluliselt langenud (11%lt 6%le). Veidi on langenud ka raske puudega laste osakaal ning keskmise puudega laste osakaal on kasvanud.

Sotsiaalkindlustusameti andmetel jätkas puudega laste arv kasvu ka 2017. aastal. 2017. aasta II kvartali lõpuks oli Eestis puudega laste arv kasvanud 13 143 lapseni (seisuga 28.06.2017).

Joonis 20. 0-17-aastaste puudega laste arv puude raskusastmete järgi 1. jaanuari seisuga

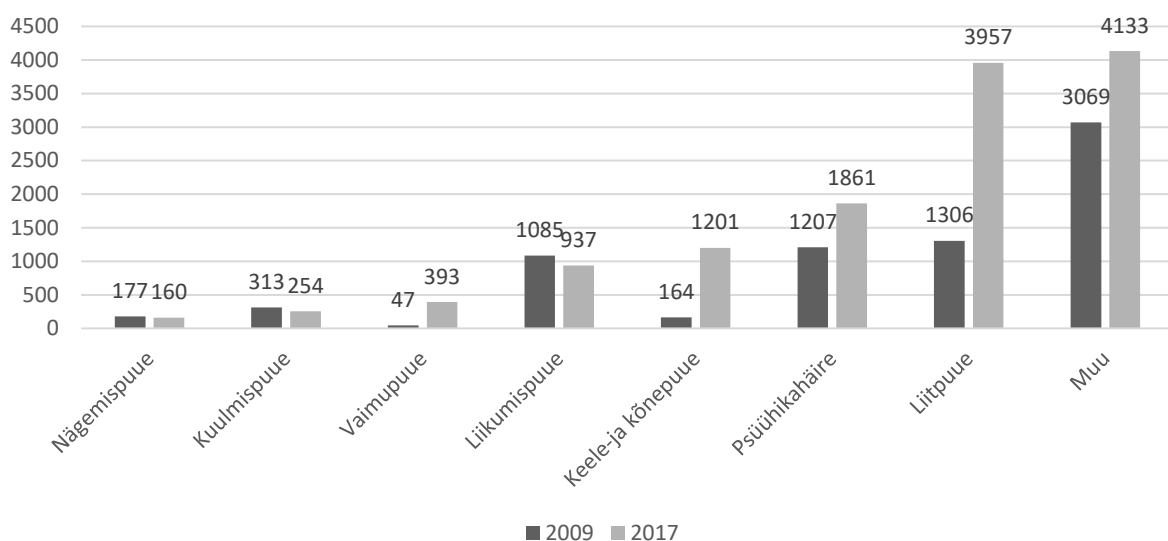


Allikas: Sotsiaalkindlustusameti andmed 1. jaanuari 2017 seisuga

Puudeliikide lõikes on samuti toimunud olulised muutused (vt Joonis 21). 2009. aastal oli liitpuude tähtsus vaid 17,7% võrrelduna 30,7%ga 2017. aastal (1. jaanuari seisuga). Liitpuudega laste arv ongi kahe aasta võrdluses kõige enam kasvanud. Puudeliiki „muu puue“ kuuluvate laste arv on küll kasvanud, kuid osakaal langenud 41,7%lt 32,0%ni. Keele- ja kõnepuudega ning vaimupuudega laste osakaal on oluliselt kasvanud, samas kui kuulmis-, liikumis- ja nägemispuudega laste osakaalud ja absoluutarvud on langenud. Psüühikahäirega laste arv on absoluutarvuna kasvanud, kuid osakaaluna veidi langenud.

¹⁰ 0-17-aastaste laste arv 2017. aasta 1. jaanuari seisuga oli 249 780 (Statistikaameti veebiandmebaas tabel RV0212: Rahvastik aasta alguses ja aastakeskmise rahvaarv soo ja vanuse järgi (01.11.2017)).

Joonis 21. 0-17-aastaste puudega laste arv domineeriva puude liigi järgi 1. jaanuari seisuga



Allikas: Sotsiaalkindlustusameti andmed 1. jaanuari 2017 seisuga

Kokkuvõttes on toimunud olulised muutused puudega laste arvus ja jaotuses puude liigiti ning raskusastmeti. Kuna uuringus on vaatluse all ametlikult tuvastatud puue, siis tekib küsimus, kas ühiskonnas on toimunud puudega laste arvu kasv, mis tuleneb meditsiinilisest määratletava puude esinemise sageduse kasvust ühiskonnas, või sotsiaalsest mudelist lähtuva puude kasvust. Viimasel juhul ei ole meditsiiniliste diagnooside osatähtsus kasvanud, vaid ka varasemalt sarnaste diagnoosidega lastele on ametlikult taotletud ja tuvastatud puue. Kolmandaks võimaluseks on lihtsalt funktsioonihäire või terviseprobleemiga laste vanemate teadlikkuse kasv. Praegusest uuringust ei ole võimalik saada vastuseid, mis on põhjustanud puudega laste osakaalu kasvu, kuid tegemist on olulise küsimusega, mis vääriks eraldi tähelepanu ja põhjalikumat analüüsimist.

Tabel 6. Puudega laste arv puudeliigiti ja puude raskusastmeti 1. jaanuari seisuga

Puudeliik	Keskmine puue	Raske puue	Sügav puue	Kokku 2017		Kokku 2009*	
Keele- ja kõnepuue	561	640	0	1201	9%	164	2%
Kuulmispuue	125	128	1	254	2%	313	4%
Liikumispuue	568	330	39	937	7%	1085	15%
Liitpuue	562	2795	600	3957	31%	1306	18%
Muu	2869	1224	40	4133	32%	3069	42%
Nägemispuue	102	44	14	160	1%	177	2%
Psüühikahäire	142	1689	30	1861	14%	1207	16%
Vaimupuue	71	314	8	393	3%	47	1%
Kokku 2017	5000	7164	732	12 896	100%		
	38%	57%	59%				
Kokku 2009*	2252	4294	822			7368	100%
	31%	58%	11%				

2017. aasta andmete allikas: SKA registriandmed 1. jaanuari 2017 seisuga, autorite arvutused.

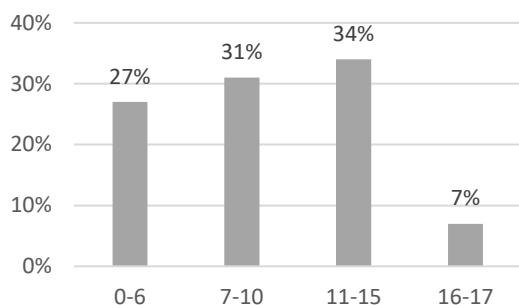
* Allikas: SKA registriandmed 1. jaanuari 2009 seisuga

** Allikas: GfK 2009: 5

Puudega lapsi on enim vanusegruppides 7–10 ja 11-15 (Joonis 22). See ei ole tingitud laste üldarvu erinevusest vanusegrupiti: ka puudega laste osakaal kõigist lastest on vastavates vanusegruppides kõrgem

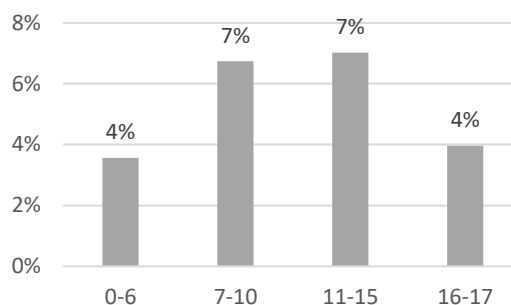
(Joonis 23). Puudega laste seas on vanusegrupi 16-17 osakaal võrreldes 2009. aastaga kahanenud 13%lt 7%ni. Suurenenud on vanusegrupi 7-10 osakaal, mis on võrreldes 2009. aastaga kasvanud 26%lt 31%ni.

Joonis 22. Puudega laste jaotus vanuse järgi (% puudega lastest)



Allikas: SKA registriandmed 1. jaanuari 2017 seisuga, autorite arvutused

Joonis 23. Puudega laste osakaal vastavas vanuses lastest kogu rahvastikus (% vanuserühmast)



Allikas: SKA registriandmed 1. jaanuari 2017 seisuga, autorite arvutused

Puudeliikide esinemissagedus eri vanuserühma laste hulgas on erinev (Joonis 24).

Keele- ja kõnepuude esinemissagedus kahaneb vanuse kasvades: kui vanusegrupis 0-6 on seda liiki puude esinemissagedus 69 juhtu 10 000 lapse kohta, siis vanusegrupis 16–17 leidub vaid üksikuid juhte.

Kuulmispuude esinemissagedus vanusega kasvab. Seda liiki puudega lapsi on väga vähe, vanusegrupiti varieerub esinemissagedus 7-14 lapse vahel 10 000 lapse kohta.

Liitpuude ja muu puude esinemissagedus on kõrgeim vanusegrupis 7-15: selles vanusegrupis on kumbagi liiki puudega lapsi enam kui 200 iga 10 000 lapse kohta ehk 2%, vanemates ja nooremates vanusegruppides vähem.¹¹

Nägemispuuet esineb sagedamini vanusegrupis 7-15 võrreldes nooremate ja vanemate vanusegruppidega. Kuna tegu on kõige harvem esineva puudeliigiga, on raske öelda, kas erinevused vanusegruppide vahel on sisulised või juhuslikku laadi.

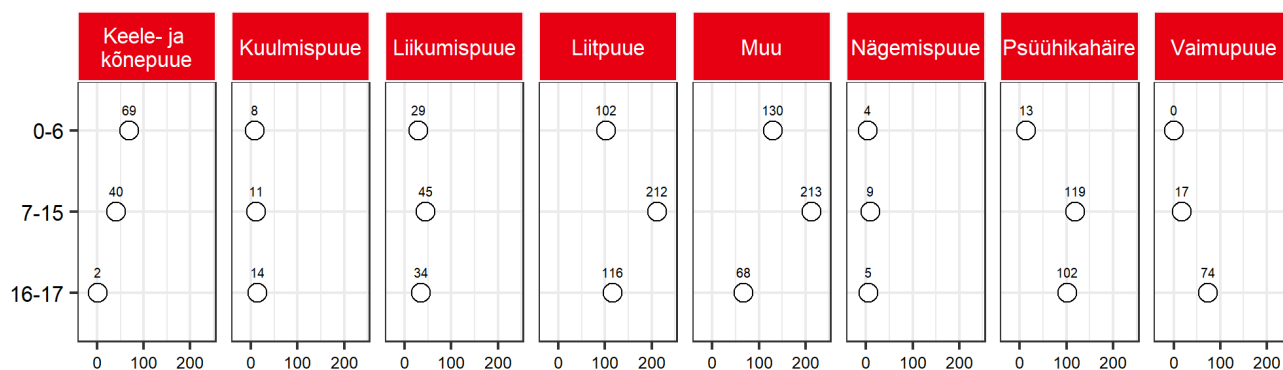
Psüühikahäiret esineb oluliselt harvem vanusegrupis 0-6 võrreldes vanemate vanusegruppidega, kus esinemissagedus ületab 100 juhtu 10 000 lapse kohta ehk 1% vastavas vanuses rahvastikust.

Vaimupuude esinemissagedus on seda suurem, mida vanema vanusegrupiga on tegu – kui 0-6 aastaste laste hulgas on seda tuvastatud vaid üksikutel juhtudel, siis 7-15-aastatel on esinemissagedus 17 juhtu 10 000 lapse kohta.¹²

¹¹ Puude liik „muu“ sisaldab liitpuuet kuni 2007 tehtud otsustes, edaspidi on liitpuue näidatud eraldi puude liigina.

¹² Psüühikahäire ja vaimupuude andmete tõlgendamist raskendab asjaolu, et psüühikahäire sisaldab vaimupuuet kuni 2008 oktoober tehtud otsustes, edaspidi on vaimupuue näidatud eraldi puude liigina.

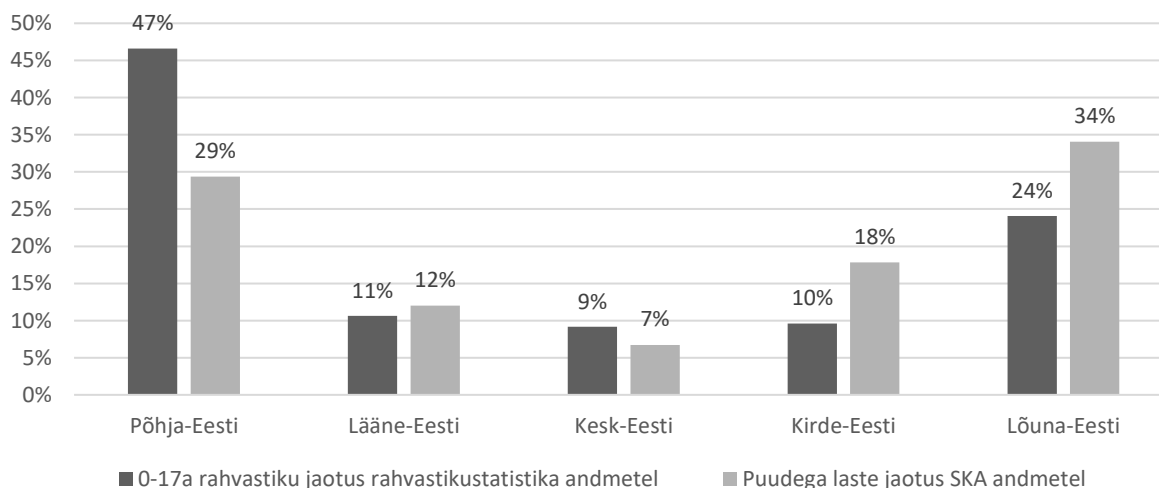
Joonis 24. Eri liiki puuete tõenäosus vanuserühmiti (puudega laste arv 10 000 vastava vanuserühma laste kohta)



Allikas: Sotsiaalministeeriumi andmed 1. jaanuari 2017. a seisuga, Statistikaameti rahvastikuandmed 1. jaanuari 2017 seisuga, autorite arvutused.

Regionaalselt elab 34% puudega lastest Lõuna-Eestis, pisut vähem Põhja-Eestis. Teiste piirkondade osakaalud on väiksemad, varieerudes 7%st Kesk-Eestis 18%ni Kirde-Eestis (Joonis 25). Puudega laste jagunemises elukoha piirkondade alusel ei ole võrrelduna 2009. aastaga toimunud statistiliselt olulisi muutusi (vt GfK 2009: 26).

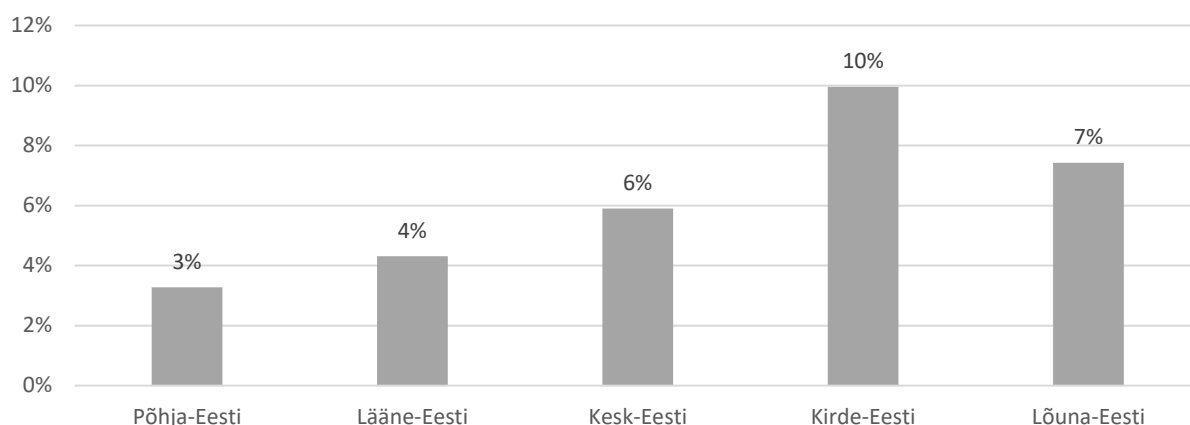
Joonis 25. Puudega laste ja kõigi kuni 17-aastaste laste jaotus regiooniti (% puudega lastest ja kõigist kuni 17-aastastest lastest)



Allikas: Sotsiaalministeeriumi poolt 5. detsembril 2017. a edastatud Sotsiaalkindlustusameti andmed, Statistikaameti rahvastikustatistika andmed, autorite arvutused.

Puudega laste osakaal kuni 17-aastaste laste hulgas on kõige kõrgem Kirde-Eestis, kus ligi kümnendik lastest on puudega, ning madalaim Põhja-Eestis, kus see on ligi kolm korda madalam (vt Joonis 26).

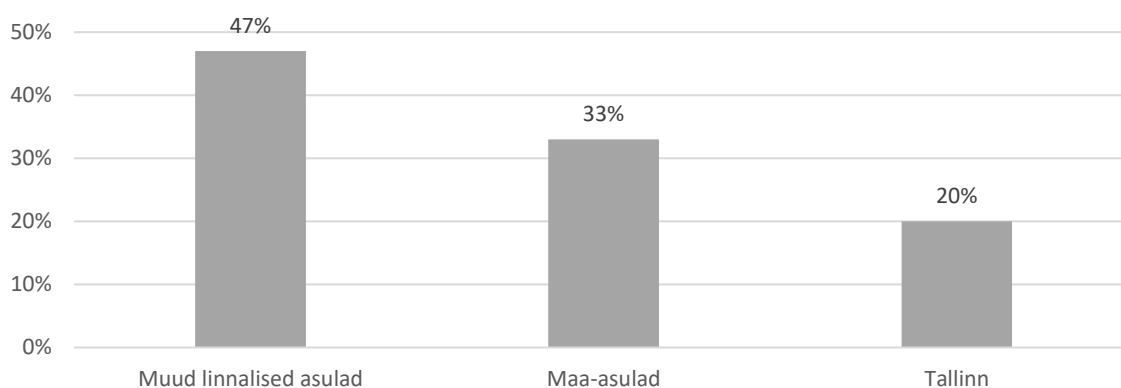
Joonis 26. Puudega laste osakaal kuni 17-aastastest lastest kogu rahvastikus regiooniti (% regioonis elavatest inimestest vanuses 0-17)



Allikas: Sotsiaalministeeriumi poolt 5. detsembril 2017. a edastatud Sotsiaalkindlustusameti andmed, Statistikaamet (0-17a rahvastik maakonniti 2017. a 1. jaanuari seisuga), autorite arvutused

Asulaliigiti (Joonis 27) elab 20% puudega lastest Tallinnas, 47% muudes linnalistes asulates ja 33% maa-asulates. Võrreldes 2009. aastaga, mil Tallinnas elas 15% puudega lastest, on Tallinnas elavate laste osakaal kõigist puudega lastest veidi suurenenud.

Joonis 27. Puudega laste elukoht asulatüüpide lõikes (% puudega lastest)



Allikas: Sotsiaalministeeriumi poolt 5. detsembril 2017. a edastatud Sotsiaalkindlustusameti andmed, autorite arvutused.

2017. aasta küsitluse andmetel on puudega laste leibkondade jagunemine koduse keele alusel sarnane 2009. aasta küsitlusele. 2017. aasta küsitluse andmetel on puudega laste leibkondade peamiseks koduseks keeleks kõige sagedamini eesti keel (70–73% puuetega lastest), järgneb vene keel, mille osakaal jääb vahemikku 26–30%. Kas eesti või vene keelt võrdsel määral või mõnda muud keelt kasutab peamise koduse keelena 0,5-1% puudega laste leibkondadest. See tulemus on vastavuses Eesti elanikkonna etnilise jaotusega.

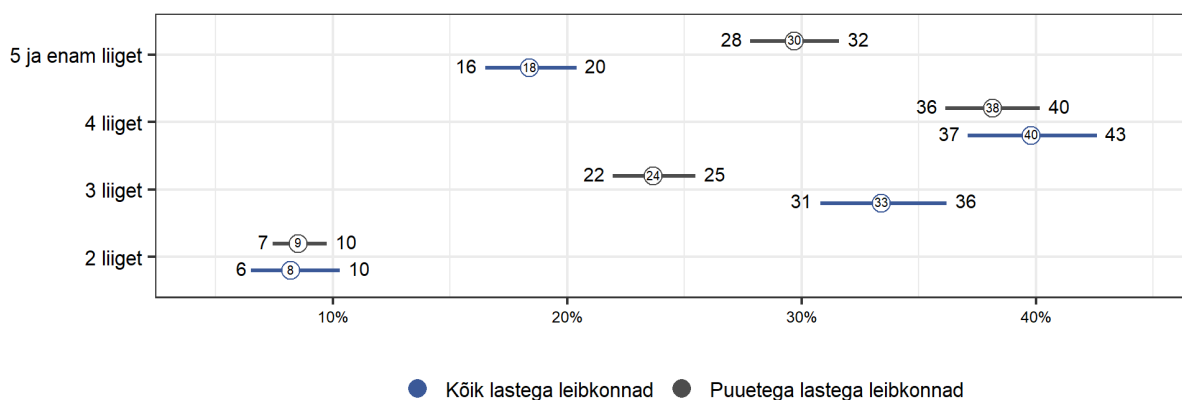
Kokkuvõttes on puudega laste arv 2009. aastaga võrreldes oluliselt kasvanud ning puudega laste jagunemine nii puudeliikide kui puude raskusastmete alusel märkimisväärselt muutunud. Võrreldes 2009. aastaga on vanusegrupi 16-17 osatähtsus on kahanenud ja vanusegrupi 7-10 osatähtsus on suurenenud, samuti on kasvanud Tallinna osatähtsus.

2.2 Puudega laste leibkonnad

Enamikus Eesti puudega lastega leibkondadest on vähemalt kolm liiget (kõige arvukamalt on esindatud 4 liikmega leibkonnad). Leibkondade jaotus leibkonnaliikmete arvu järgi on toodud Joonis 28, kus võrdluseks

on esitatud ka lastega leibkondade jaotus leibkonnaliikmete arvu järgi Eestis üldiselt Eesti Sotsiaaluuringu andmetel. Võrreldes kõigi Eesti leibkondadega, kus on alaealisi lapsi, on puudega lastega leibkondade hulgas 5 või enama liikmega leibkondade osakaal kõrgem ning 3 liikmega leibkondade osakaal madalam.

Joonis 28. Puudega lastega leibkonnad ja kõik lastega leibkonnad Eestis leibkonna suuruse järgi (% leibkondadest)



Allikad: Puudega lastega leibkonnad: Puudega lastega perede küsitlus 2017; Kõik lastega leibkonnad: Statistikaamet, Eesti Sotsiaaluuring 2016

Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Puudega lastega leibkondadest 61-65%l on kaks täiskasvanut (Tabel 7). 16-20%l leibkondadest on täiskasvanuid kolm või enam. Vaid ühe täiskasvanuga leibkonnas elab 17-21% puudega lastest. Täiskasvanutena on siinjuures arvestatud kõiki vähemalt 18-aastaseid isikuid leibkonnas, sh vastajat ennast (puudega lapse eest peamiselt hoolitsev isik, üldjuhul lapsevanem).

Tabel 7. Leibkondade jaotus täiskasvanute ja laste arvu järgi (% puudega lastest)

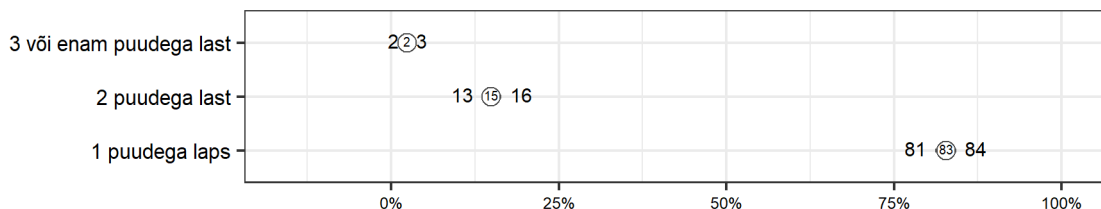
Täiskasvanute arv leibkonnas		Laste arv leibkonnas		Puudega laste arv leibkonnas	
1	19% (17-21%)	1	9% (7-10%)	1	15% (14-16%)
		2	17% (15-19%)	2	53% (51-55%)
		3 või enam	9% (8-10%)	3 või enam	15% (14-17%)
2	63% (61-65%)	1	7% (6-8%)	1	3% (3-4%)
		2	29% (27-31%)	2	10% (8-11%)
		3 või enam	6% (5-7%)	3 või enam	2% (2-3%)
3 või enam	18% (16-20%)	1	4% (3-4%)	1	1% (1-1%)
		2	18% (16-19%)	2	1% (1-2%)
		3 või enam	3% (3-4%)	3 või enam	0% (0-1%)
KOKKU	100%	KOKKU	100%	KOKKU	100%

Allikas: Puudega lastega perede küsitlus 2017, autorite arvutused

Märkus: Tabelis on esitatud keskväärtuse punkthinnangud ning nende järel sulgudes olevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Valdav osa (81-84%) puudega lastest elab leibkondades, kus on üks puudega laps, 13-16% elab kahe puudega lapsega leibkondades, 2-3% kolme või enama puudega lapsega leibkondades (Joonis 29 ja Tabel 7).

Joonis 29. Puudega laste arv leibkonnas (% puudega lastest)



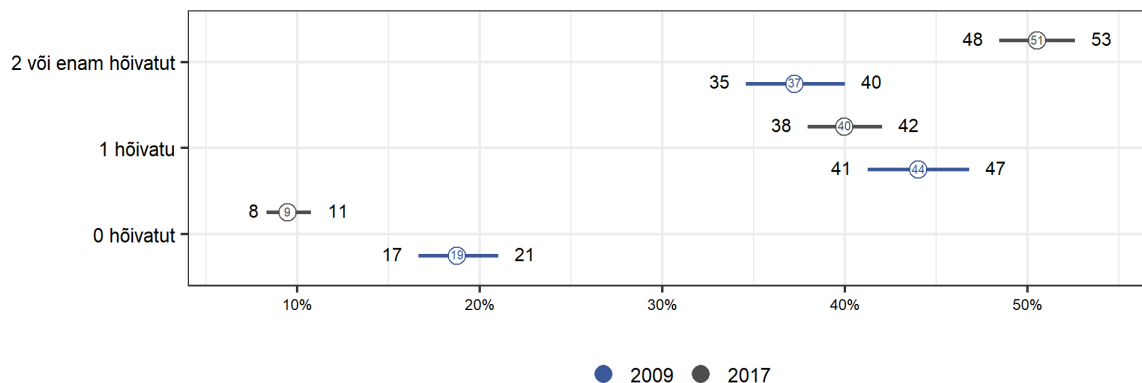
Allikas: Puudega lastega perede küsitlus 2017, autorite arvutused

Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Puudega lastest 44% elab leibkonnas, kus on vaid puudega laps(ed) (valdavalt on need siiski ühe lapsega leibkonnad). Vastav osakaal ühe täiskasvanuga leibkondades elavate puudega laste hulgas on 58%, vähemalt kahe täiskasvanuga leibkondades elavate puudega laste hulgas 40%.

Pooled (48-53%) puudega lastest elavad leibkondades, kus on kaks või enam tööga hõivatud täiskasvanut ja 38-42% ühe hõivatuga leibkondades. Ligi 10% puudega laste leibkondadest pole aga ühtegi hõivatud täiskasvanut (Joonis 30). Võrreldes 2009. aastaga on oluliselt väiksem nende laste osakaal, kes kasvavad ühegi hõivatuta leibkondades (toona 17-21%), ning suurem nende laste osakaal, kes kasvavad ühe hõivatuga või vähemalt kahe hõivatuga leibkondades (2009. aastal osakaalud vastavalt 41-47% ja 35-40%).

Joonis 30. Puuetega laste jaotus tööga hõivatute arvu järgi leibkonnas, 2009 ja 2017 (% puudega lastest)



Allikas: Puudega lastega perede küsitlused 2009 ja 2017, autorite arvutused

Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

2.3 Puudega lapse eest peamiselt hoolitsev inimene

Puudega lapse eest peamiselt hoolitsev inimene on enamikul juhtudest tema vanem (95-97% juhtudest), enamasti ema (90-92%). Vaid vähestel juhtudel oli peamiseks lapse eest hoolitsejaks keegi teine kui vanem (õde, vend, muu sugulane vm). Seetõttu kasutatakse raportis puudega lapse eest peamiselt hoolitsevast isikust rääkides mõistet „vanem“.

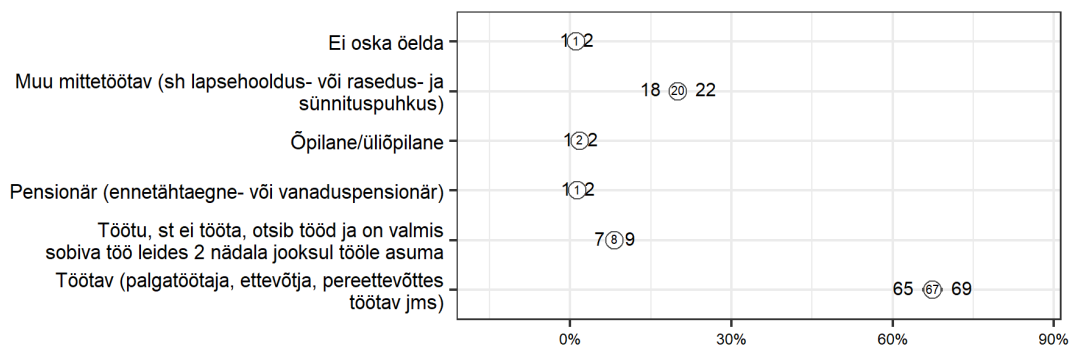
Valdavalt (95-97%) jääb vanema vanus vahemikku 25–54 aastat. Enam kui kahel kolmandikul juhtudest on puudega laste vanemad töötavad – ligikaudu 65–69% (Joonis 31), mis on väiksem kui 25–54-aastaste Eesti

naiste tööhõive määr keskmiselt (2017. aasta II kvartalis 77%). Samas on puudega laste vanemate tööhõive määr märkimisväärselt kõrgem kui 2009. aastal, mil see jäi vahemikku 54-60%.

Leibkonna peamine kodune keel on 70-73% protsendil puudega laste leibkondadest eesti ning 26-30% protsendil vene keel. Puudega laste vanematest, kelle leibkonna kodune keel on vene keel, saab 23-31% enda sõnul igapäevasuhtluses eesti keelega hakkama raskusteta, ligikaudu pooled (43-51%) saavad hakkama raskustega ja 18-25% ei saa eesti keeles üldse hakkama.

Vanemate töötuse määr (7–9%) ületab 25–54-aastaste Eesti naiste Eesti keskmist, mis samal ajaperioodil oli 6,4%. Aastal 2009 oli puudega laste vanemate töötuse määr küsitluse andmetel 9,6-14%.

Joonis 31. Puudega lapsed vanema sotsiaal-majanduslik staatuse järgi (% puudega lastest)

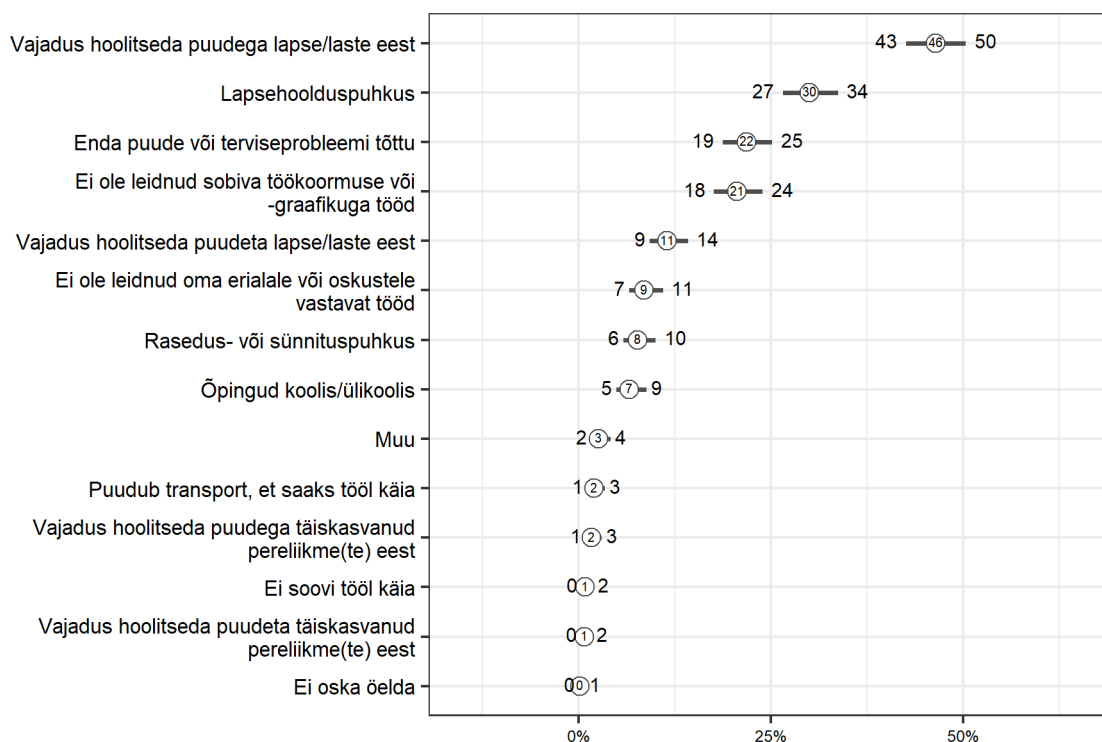


Allikas: Puudega lastega perede küsitlus 2017, autorite arvutused

Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Hõivest kõrvale jäämise põhjuste hulgas (Joonis 32) ei domineeri erinevalt 2009. aasta uuringust töömitteleidmine – enim nimetati 2017. a vajadust hoolitseda puudega lapse eest (43–50%), lapsehoolduspuhkest (27–34%) ning enda puuet või terviseprobleemi (19–25%). Ametlikult tuvastatud, kehtiv puue on 9–12 protsendil puudega laste vanematest (vastav osakaal oli sarnane ka 2009. aastal).

Joonis 32. Puudega lapsed vanema hõives mitteolemise põhjuste järgi (% mittetöötavatest puudega laste vanematest)

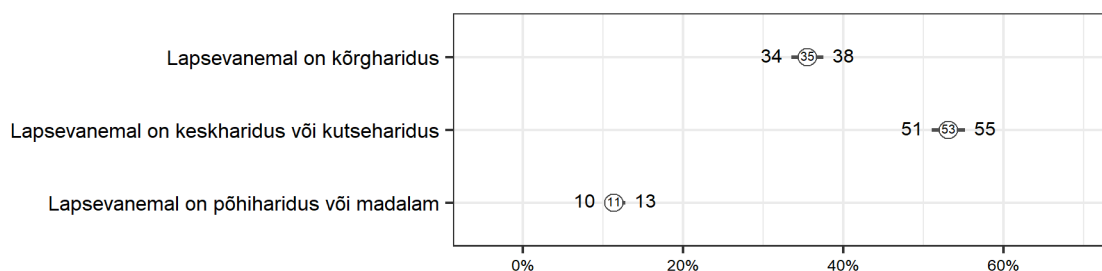


Allikas: Puudega lastega perede küsitlus 2017, autorite arvutused

Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Puudega laste eest peamiselt hoolitsevad isikud on enamasti kesk- või kutseharidusega (51–55%). Kõrgharidusega on 34–38% ning põhihariduse või sellest madalama haridusega on ligikaudu 10–13% (Joonis 33).

Joonis 33. Puudega lapsed vanema hariduse järgi (% puudega lastest)¹³



Allikas: Puudega lastega perede küsitlus 2017, autorite arvutused

Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

¹³ Osakaalude hinnangute ja usalduspiiride arvutamisel on kõrvale jäetud isikud, kes ei soovinud oma andmeid avaldada (u 2% vastajatest).

3 Puudega laste toimetulek

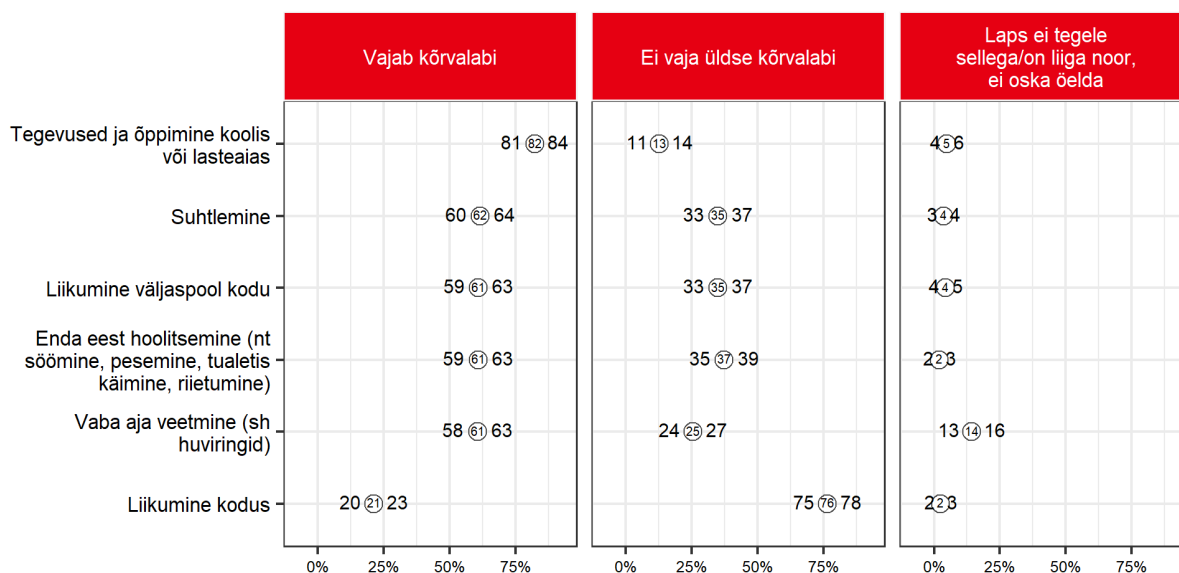
Puudega laste toimetuleku hindamiseks vaadatakse esmalt puudega lapse kõrvalabi vajadust erinevate tegevuste juures ning seejärel abivahendite vajadust ja kasutamist.

3.1 Puudest tuleneva kõrvalabi vajadus

Puudega laste kõrvalabi vajaduse kaardistamiseks paluti nende vanematel hinnata lapse kõrvalabi vajadust erinevate tegevuste juures. Seega pole tegemist objektiivselt mõõdetud kõrvalabi vajadusega vaid puudega laste vanemate hinnangutega selles osas, kas laps vajab käsitletud tegevuste juures puude tõttu kõrvalabi. Küsimustikus oli vastajatel võimalik lapse kõrvalabi vajadust märkida kahe vastusevariandiga: „vajab aeg-ajalt kõrvalabi“ ja „vajab pidevalt kõrvalabi“. Analüüsis kõrvalabi vajaduse määra ei eristata, kuna käsitletud tegevused on sõnastatud mitmeid erinevaid tegevusi hõlmavate kategooriatena, mille puhul on kõrvalabi vajaduse mahtu üheselt raske hinnata. Nt õppimisel ja muudel tegevustel koolis võib laps vajada koolis liikumisel pidevalt kõrvalabi, kuid õppimisel vaid aeg-ajalt.

Puudega laste vanemad tunnetavad lapse puudest tingitud kõrvalabi vajadust enim õppimisel ning muudel tegevustel koolis või lasteaias, mille puhul valdav osa (81–84%) leiab, et laps vajab kõrvalabi (Joonis 34). Üle poole lapsevanematest leiavad, et laps vajab kõrvalabi suhtlemisel (60–64%), väljaspool kodu liikumisel (59–63%), enda eest hoolitsemisel (59–63%) või vaba aja veetmisel (58–63%). Kõrvalabi vajadus on märkimisväärselt väiksem kodus liikumisel, mille puhul vaid ca viiendiku (20–23%) puudega laste vanemate hinnangul vajab laps tegevusel kõrvalabi. Kuna 2009. aasta uuringus käsitleti kõrvalabi vajaduse hindamiseks üldisemaid tegevuste kategooriaid (õppimine, kodused ja koduvälised eakohased igapäevatoimingud, töötamine) ning käesolevas uuringus on uuritavate tegevuste loetelu täielikult muudetud, ei ole võimalik tulemusi võrrelda.

Joonis 34. Puudest tingitud kõrvalabi vajadus erinevate tegevuste juures (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

Pea kõik vastajad (ca 91-93%) tunnetavad, et puudega laps vajab vähemalt ühe eelpool nimetatud tegevuse juures puude tõttu kõrvalabi. Sealjuures veidi üle poole puudega lastest vajavad nende vanemate hinnangul puude tõttu kõrvalabi kolme kuni viie eelpool nimetatud tegevuse juures. Iga kümnes puudega laps vajab puude tõttu kõrvalabi kõigi eelpool nimetatud tegevuste juures. Järgnevalt vaatame iga tegevuse puhul eraldi, kuidas kõrvalabi vajadus erineb sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes.

Taustatunnuste lõikes vaadati kõrvalabi vajadust vaid nende seas, kes käsitletud tegevustega tegelevad. Analüüsist on välja jäetud vastajad, kes ei osanud kõrvalabi vajadust hinnata või märkisid vastusena, et laps ei tegele sellega/on liiga noor.

Õppimisel ja muudel tegevustel koolis või lasteaias esineb puudest tingitud kõrvalabi vajadusel erisusi koduse keele, puude raskusastme, lapse vanuse ning puudeliikide lõikes (Joonis 35). Eesti keelt koduse keelena kõnelevate laste seas on kõrvalabi vajajaid (87–90%) mõnevõrra enam kui venekeelsete laste seas (78–85%).

Puude raskusastmete lõikes on sügava puudega laste seas koolis või lasteaias kõrvalabi vajavate osakaal 92-99%, raske puudega laste seas 89-93% ning keskmise puudega laste seas oluliselt väiksem (75-81%). Kui aga elimineerida teiste taustatunnuste mõju, siis keskmise ning raske puudega lapsed kõrvalabi vajaduse poolest ei erine.

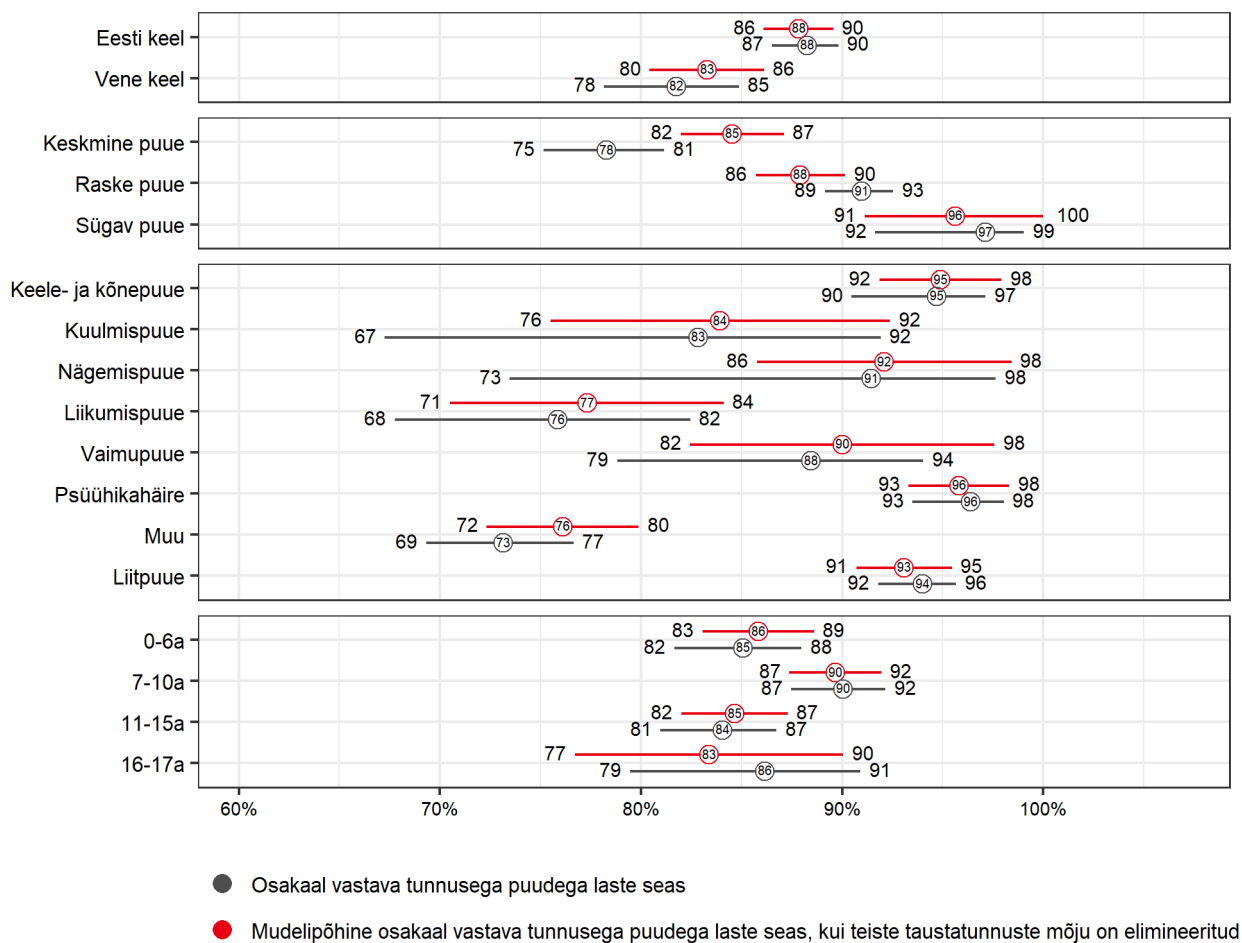
Puudeliikide lõikes ilmneb, et liitpuudega (92–96%), keele- ja kõnepuudega (90–97%) ning psüühikahäirega (93–98%) laste puhul tunnetatakse enam kui liikumispuudega (68–82%) ja muu puudega (69–77%) laste puhul, et laps vajab kõrvalabi õppimisel ja muudel tegevustel koolis või lasteaias.

Puudega lapse vanuse põhjal erineb statistiliselt oluliselt vaid 7–10-aastaste laste vanusegrupp, kus kõrvalabi vajajate osakaal (87–92%) on suurem kui 0–6-aastaste (82–88%) ja 11–15-aastaste (81–88%) seas.

Vaadates õppimisel ja muudel tegevustel koolis kõrvalabi vajajaid eriõppe korralduse järgi, ilmneb ootuspäraselt, et tavakooli tavaklassis õppivate puudega laste seas on õppimisel ja muudel tegevustel koolis kõrvalabi vajavaid mõnevõrra vähem. Tavakooli tavaklassis õppivatest puudega lastest vajavad õppimisel ja muudel tegevustel koolis kõrvalabi 76-82%, seevastu tavakooli eriklassis õppivatest puudega lastest vajab kõrvalabi 94-98% ning erikoolis õppivatest puudega lastest vajab kõrvalabi 92-97%.

Lasteaia käivate puudega laste puhul erineb vajadus kõrvalabi järele õppimisel ja muudel lasteaia toimuvatel tegevustel mõnevõrra lasteaia ja rühma lõikes. Tavalasteaia tavarühmas käivatest puudega lastest vajab õppimisel ja muudel tegevustel kõrvalabi 76-84%, tavalasteaia erirühmas või sobitusrühmas õppivatest puudega lastest vajab kõrvalabi 93-99% ning erilasteaia käivatest lastest, kes valimisse sattusid, vajab õppimisel ja muudel tegevustel lasteaia kõrvalabi kõik.

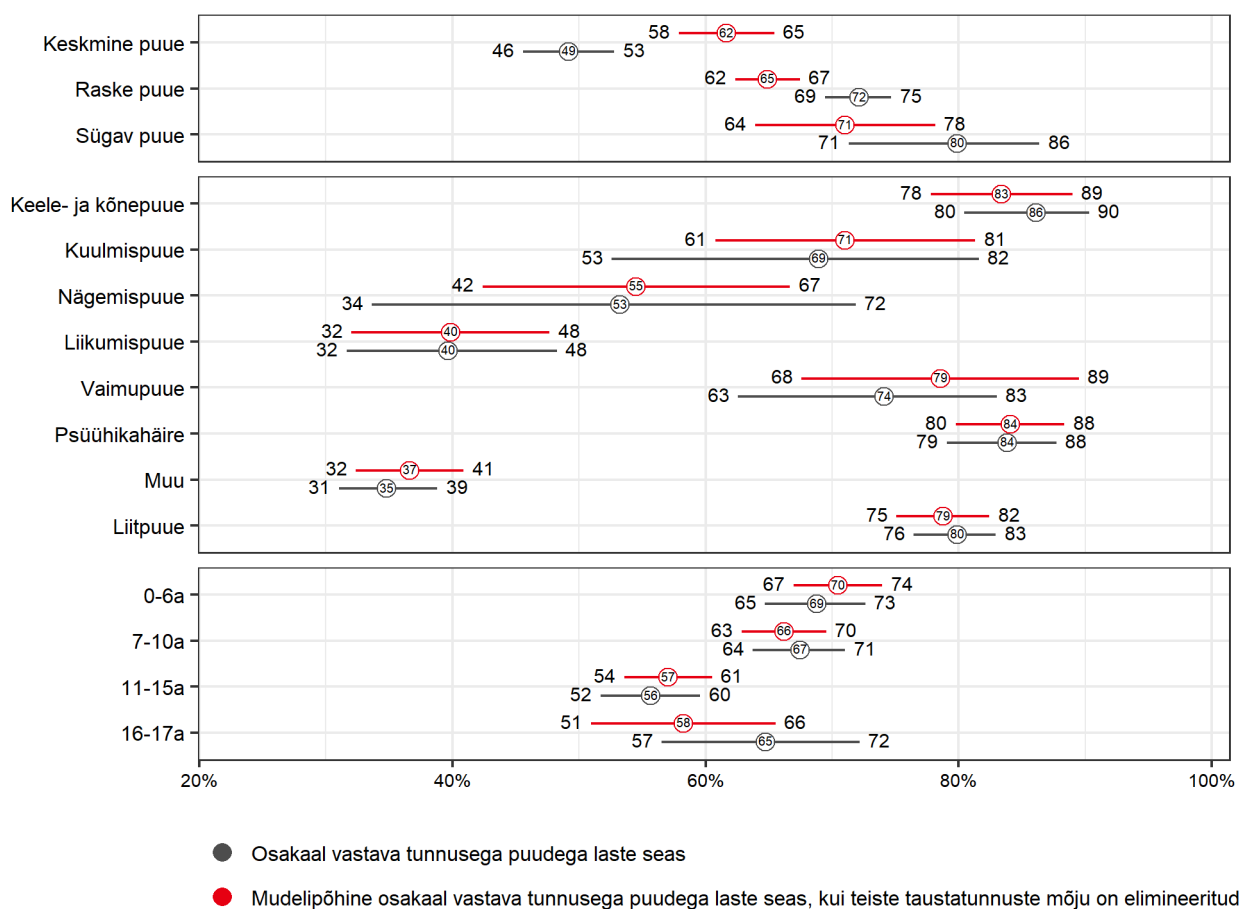
Joonis 35. Puudest tingitud kõrvalabi vajadus õppimisel ja muudel tegevustel koolis või lasteaias (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad ning vastajad, kes ei osanud kõrvalabi vajadust hinnata või märkisid vastusena, et laps ei tegele sellega/on liiga noor. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab aeg-ajalt või pidevalt kõrvalabi õppimisel ja muudel tegevustel koolis või lasteaias = 1, ei vaja üldse kõrvalabi õppimisel ja muudel tegevustel koolis või lasteaias = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: sugu, vanus, puudeliik, puude raskusaste, kodune keel

Puudest tingitud kõrvalabi vajadus **suhtlemisel** on 11–15-aastaste puudega laste seas (52-60%) väiksem kui 0–6-aastaste (65-73%) ja 7-10-aastaste (64-71%) seas (Joonis 36). Suhtlemisel kõrvalabi vajavaid on liikumispuudega (32–48%) ja muu puudega (31–39%) laste seas märkimisväärselt vähem kui teiste puudeliikidega (v.a nägemispuudega) laste seas. Puude raskusastmeti ilmneb, et keskmise puudega laste seas (46-53%) on suhtlemisel kõrvalabi vajavate osakaal oluliselt väiksem kui raske (69-75%) ja sügava puudega (71-86%) laste seas, kuid elimineerides teiste taustatunnuste mõju, ilmneb, et suhtlemisel kõrvalabi vajadus lapse puude raskusastmete lõikes statistiliselt oluliselt ei erine.

Joonis 36. Puudest tingitud kõrvalabi vajadus suhtlemisel (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad ning vastajad, kes ei osanud kõrvalabi vajadust hinnata või märkisid vastusena, et laps ei tegele sellega/on liiga noor. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab aeg-ajalt või pidevalt kõrvalabi suhtlemisel=1, ei vaja üldse kõrvalabi suhtlemisel = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: sugu, vanus, puudeliik, puude raskusaste, kodune keel

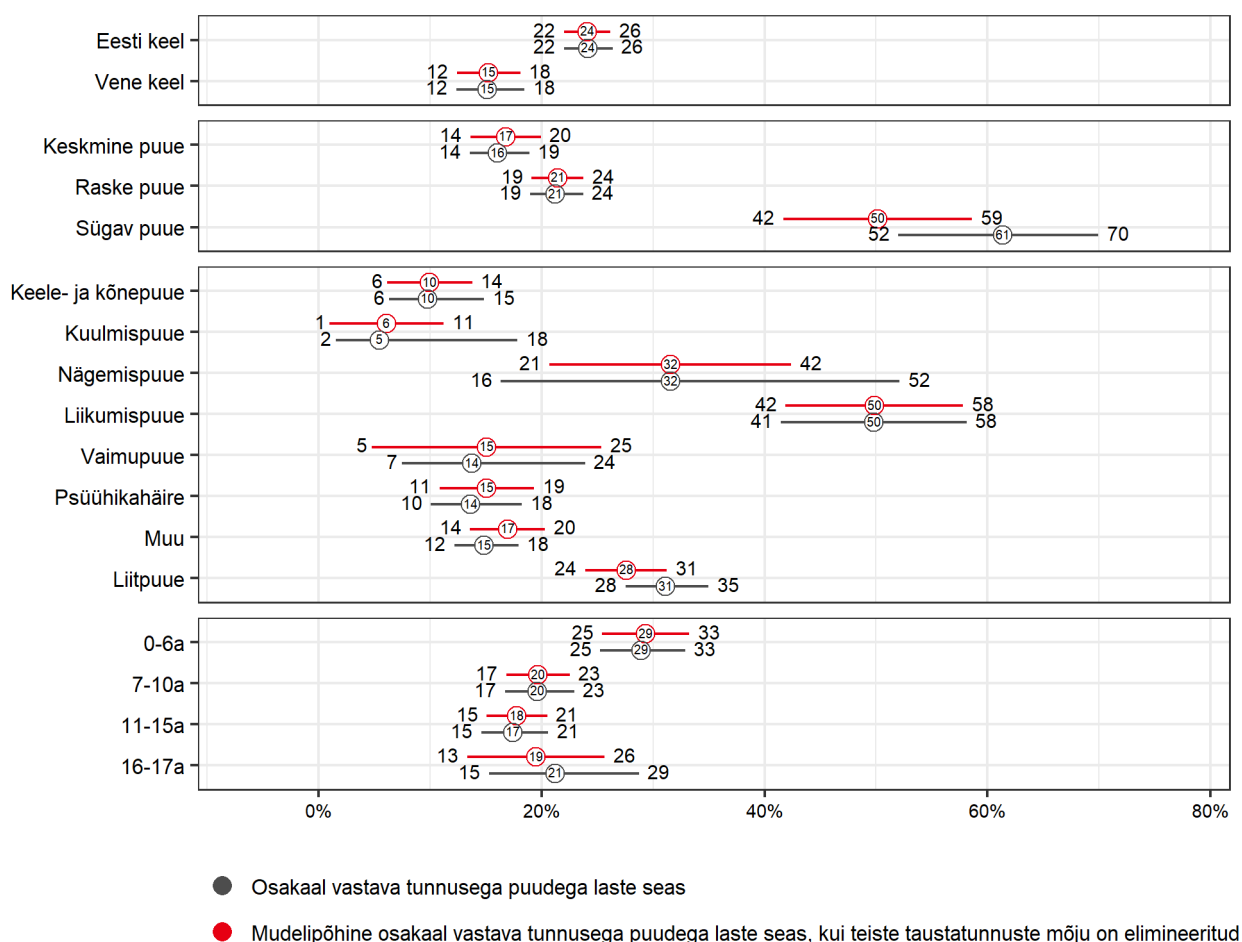
Lapse puudest tingitud kõrvalabi vajadust **kodus liikumisel** tunnetavad vene keelt koduse keelena kõnelevad lapsevanemad (12-18%) vähem kui kodus eesti keelt kõnelevad vanemad (22-26%) (Joonis 37).

Puudeliigiti on kodus liikumisel kõrvalabi vajajate osakaal suurim liikumispuudega laste (41-58%) ja suuruselt järgmine liitpuudega (28-35%) laste seas, teiste puudeliikide seas on kõrvalabi vajavate osakaal väiksem (v.a nägemispuue, mille puhul on usalduspiirid liiga laiad, et oleks võimalik erisust tuvastada).

Puude raskusastmeti eristub enim sügav puue – kodus liikumisel kõrvalabi vajavaid on sügava puudega laste seas 52-70%, raske puudega laste seas aga 19-24% ning keskmise puudega laste seas 14-19%.

Vanusegrupiti kerkib esile noorim, 0–6-aastaste vanusegrupp, mille puhul on kodus liikumisel kõrvalabi vajadus suurem kui 7-15-aastastel lastel: 0–6-aastaste seas on kõrvalabi vajavate osakaal 25–33%, 7-15-aastaste seas jääb see osakaal aga vahemikku 15–23%.

Joonis 37. Puudest tingitud kõrvalabi vajadus kodus liikumisel (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad ning vastajad, kes ei osanud kõrvalabi vajadust hinnata või märkisid vastusena, et laps ei tegele sellega/on liiga noor. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab aeg-ajalt või pidevalt kõrvalabi kodus liikumisel=1, ei vaja üldse kõrvalabi kodus liikumisel= 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: sugu, vanus, puudeliik, puude raskusaste, kodune keel

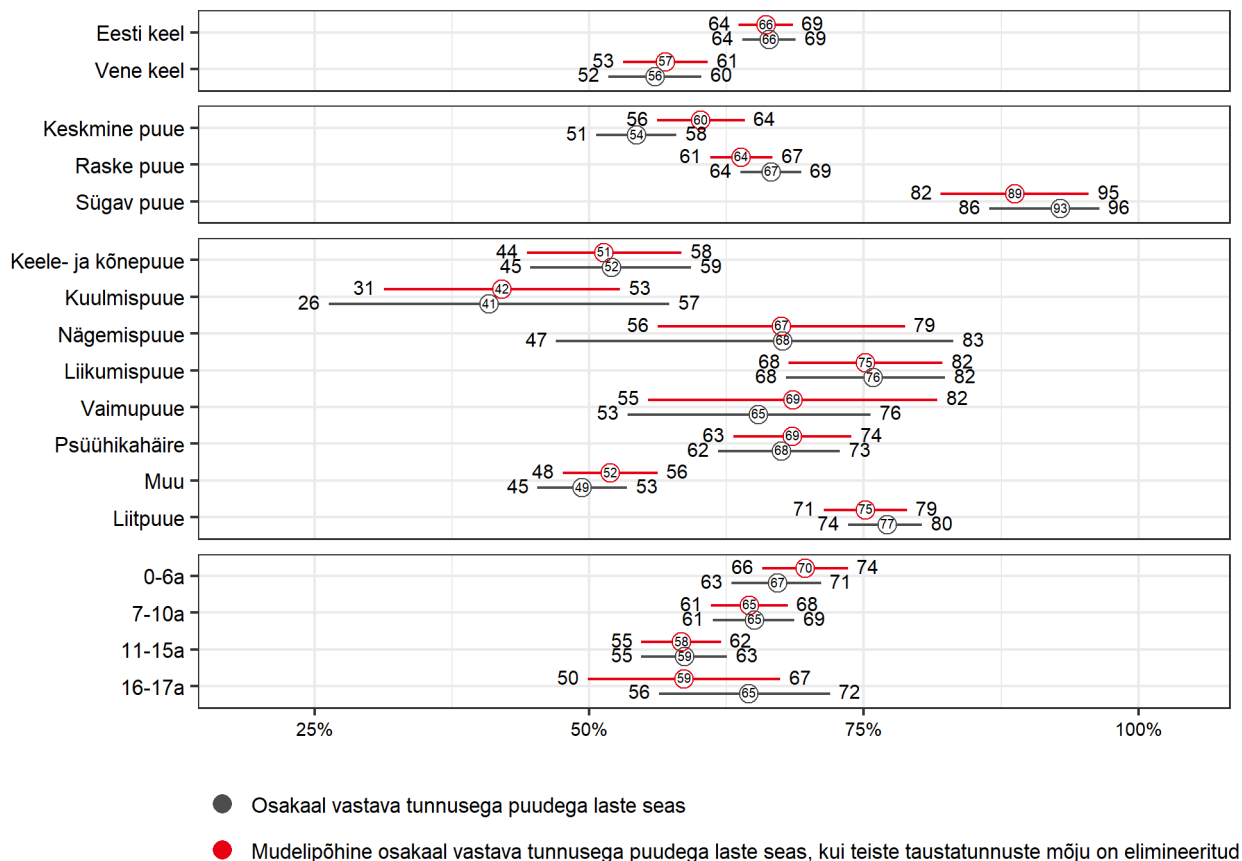
Väljaspool kodu liikumisel eristuvad vanuse lõikes statistiliselt oluliselt 11–15-aastased puudega lapsed, kelle seas on puude tõttu kõrvalabi vajavate osakaal väiksem kui nooremate seas. 11–15-aastaste seas on väljaspool kodu liikumisel kõrvalabi vajavaid 55–63%, nooremate vanusegruppide seas jääb see osakaal vahemikku 61–71%. Vanimasse vanusegruppi kuuluvad lapsed teistest vanusegruppidest statistiliselt oluliselt ei erine (Joonis 38).

Puudeliikide lõikes ilmneb, et liitpuudega (74–80%), liikumispuudega (68–82%) ja psüühikahäirega (62–73%) laste seas on väljaspool kodu liikumisel kõrvalabi vajavate osakaal suurem kui muu puudega (45–53%), kuulmispuudega (26–57%) ning keele- ja kõnepuudega (45–59%) laste seas.

Väljaspool kodu liikumisel kõrvalabi vajajaid on puude raskusastmete lõikes enim sügava puudega (86–96%) laste seas, raske puudega laste seas on see osakaal 64–69% ja keskmise puudega laste seas 51–58%. Elimineerides aga teiste taustatunnuste mõju, ei ilmne keskmise ning raske puudega laste vahel erinevusi kõrvalabi vajamises väljaspool kodu liikumisel.

Vaadates erisusi koduse keele lõikes ilmneb, et vene keelt koduse keelena kõnelevad lapsevanemad tajuvad lapse puudest tingitud kõrvalabi vajadust väljaspool kodu liikumisel mõnevõrra vähem (52-60%) kui eesti keelt kõnelevad (64-69%).

Joonis 38. Puudest tingitud kõrvalabi vajadus väljaspool kodu liikumisel (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad ning vastajad, kes ei osanud kõrvalabi vajadust hinnata või märkisid vastusena, et laps ei tegele sellega/on liiga noor. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab aeg-ajalt või pidevalt kõrvalabi väljaspool kodu liikumisel=1, ei vaja üldse kõrvalabi väljaspool kodu liikumisel= 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: sugu, vanus, puudeliik, puude raskusaste, kodune keel

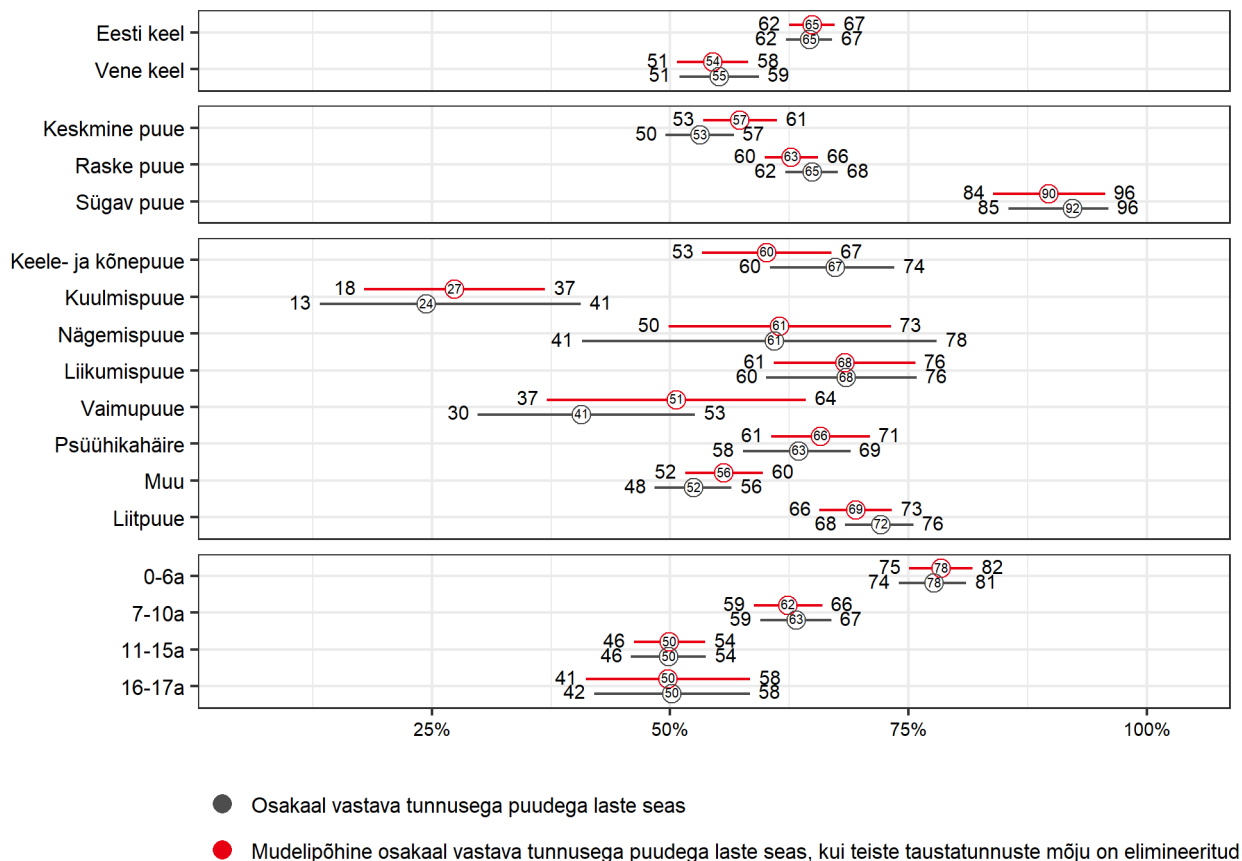
Enda eest hoolitsemise all mõistetakse nt söömist, pesemist, tualetis käimist, riietumist jms. Lapse vanuse kasvades enda eest hoolitsemisel kõrvalabi vajajate osakaal väheneb, 16-17-aastaste vanusegrupp siiski teistest statistiliselt oluliselt ei erine (Joonis 39).

Puudeliigiti on enda eest hoolitsemisel kõrvalabi vajadus küllaltki varieeruv. Küll aga eristuvad kuulmispuudega lapsed, kelle seas on enda eest hoolitsemisel kõrvalabi vajajate osakaal (13–42%) väiksem kui teiste puudeliikidega laste seas.

Võrreldes kõrvalabi vajadust enda eest hoolitsemisel puude raskusastmete lõikes, eristuvad sügava puudega lapsed, kelle seas on kõrvalabi vajajate osakaal tunduvalt suurem kui teiste puudeliikide seas – sügava puudega laste seas 85-96%, raske puudega laste seas 62-68% ning keskmise puudega laste seas 50-57%.

Kodus vene keelt kõnelevad lapsevanemad tajuvad lapse kõrvalabi vajadust enda eest hoolitsemisel vähem kui eesti keelt kõnelevad lapsevanemad (eesti keelt kõnelevatest tajub kõrvalabi vajadust 62-67%, vene keelt kõnelevatest 51-59%).

Joonis 39. Puudes tingitud kõrvalabi vajadus enda eest hoolitsemisel (% puudega lastest)



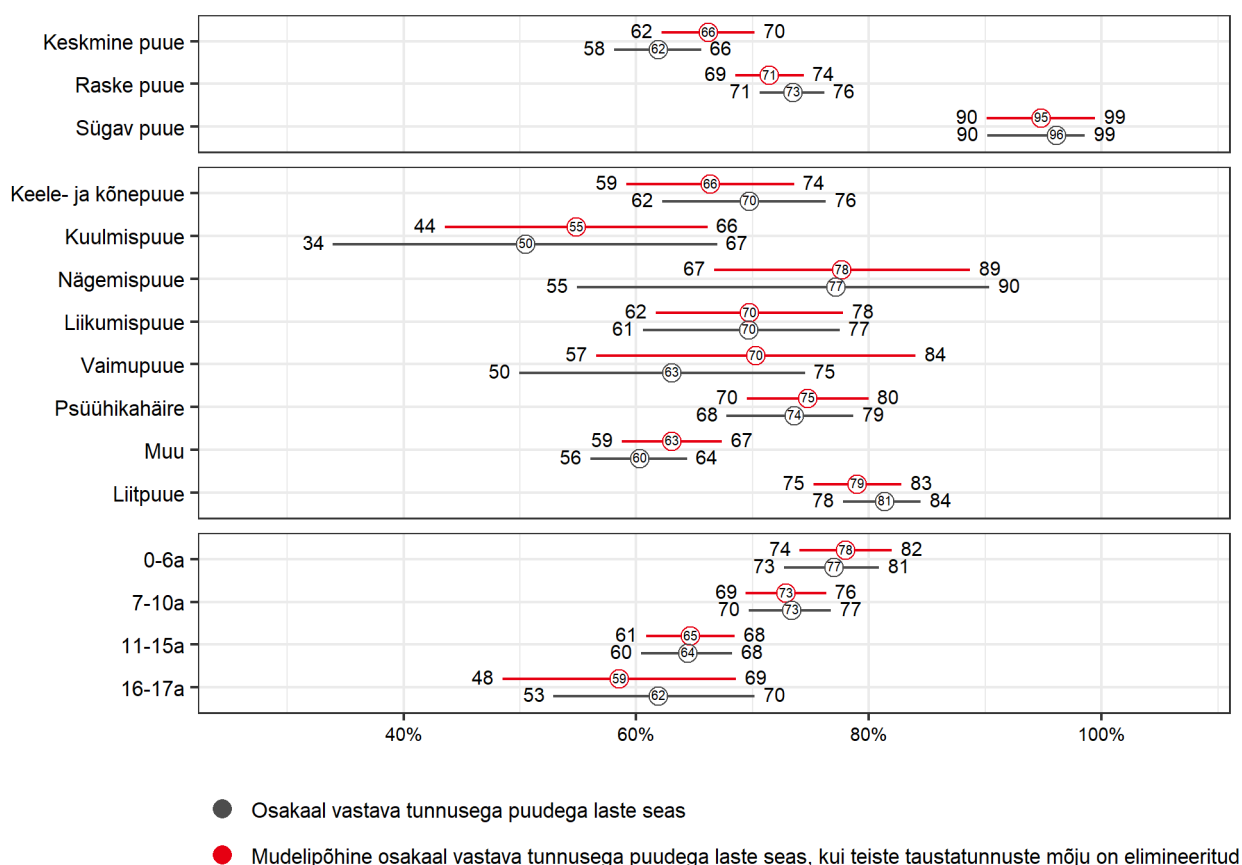
Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad ning vastajad, kes ei osanud kõrvalabi vajadust hinnata või märkisid vastusena, et laps ei tegele sellega/on liiga noor. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab aeg-ajalt või pidevalt kõrvalabi enda eest hoolitsemisel=1, ei vaja üldse kõrvalabi enda eest hoolitsemisel= 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: sugu, vanus, puudeliik, puude raskusaste, kodune keel

Kõrvalabi vajadus **vaba aja veetmisel** lapse vanuse kasvades väheneb: 0–6-aastaste seas on vaba aja veetmisel kõrvalabi vajavaid 73–81%, kuid 11–15-aastaste seas 60–68% (Joonis 40).

Puude raskusastmeid võrreldes ilmneb, et sügava puudega laste seas on vaba aja veetmisel kõrvalabi vajavaid kõige enam – sügava puudega lastest vajab vaba aja veetmisel kõrvalabi 90–99%, raske puudega lastest vastavalt 71–76% ning keskmise puudega lastest vastavalt 58–66%. Kui elimineerime teiste taustatunnuste mõju, siis keskmise ning raske puudega lapsed oma kõrvalabi vajaduselt vaba aja veetmisel oluliselt ei erine.

Puudeliikide lõikes ilmneb, et kõrvalabi vajadus vaba aja veetmisel on liitpuudega (78-84%) ning psüühika-häirega (69-79%) laste seas suurem kui kuulmispuudega (34-67%) ning muu puudega laste (56-64%) seas.

Joonis 40. Puudest tingitud kõrvalabi vajadus vaba aja veetmisel (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvaartuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad ning vastajad, kes ei osanud kõrvalabi vajadust hinnata või märkisid vastusena, et laps ei tegele sellega/on liiga noor. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab aeg-ajalt või pidevalt kõrvalabi vaba aja veetmisel=1, ei vaja üldse kõrvalabi vaba aja veetmisel= 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: sugu, vanus, puudeliik, puude raskusaste, kodune keel

3.2 Abivahendite vajadus ja kasutamine

3.2.1 Abivahendite tagamise korraldus ja abivahendite vajadus

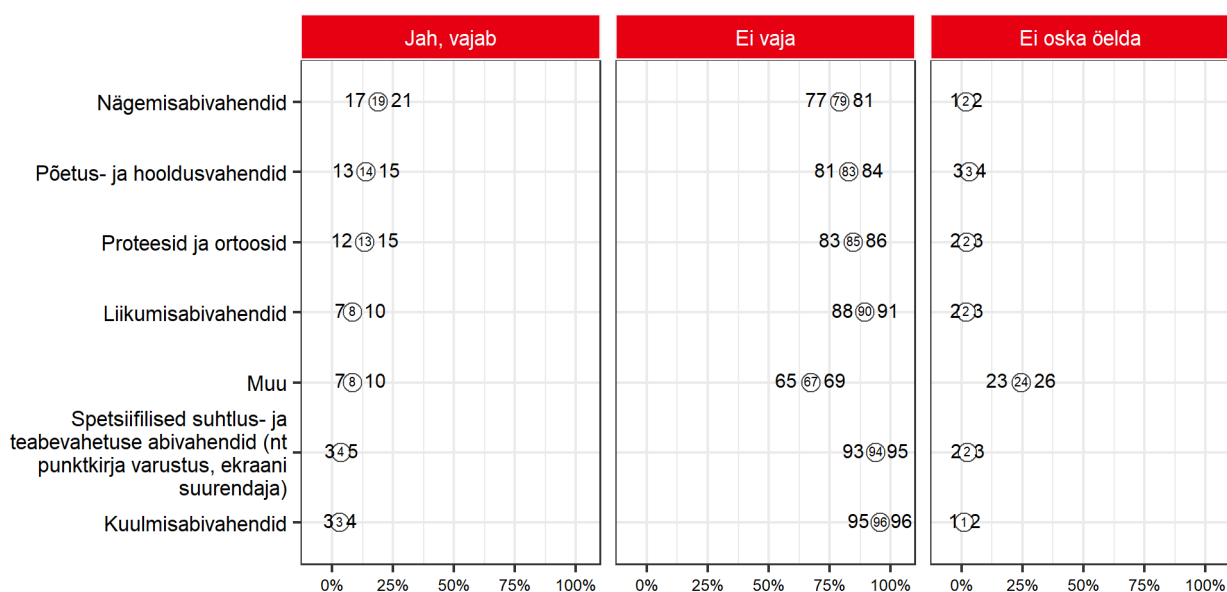
Abivahenditeenus ehk abivahendite tagamine on üks riiklikest hoolekandeteenustest. Sotsiaalhoolekande seaduse § 48 lg 1 alusel on abivahend toode või vahend, mille abil on võimalik ennetada tekkinud või kaasasündinud kahjustuse või puude süvenemist, kompenseerida kahjustusest või puudest tingitud funktsioonihäiret, parandada või säilitada füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet. Abivahenditeenus on mõeldud erivajadustega inimestele, kellel on puudest tingitud takistused igapäevaelus osalemiseks. Teenuse raames kompenseerib riik erivajadustega inimestele osa abivahendi ostu- või üürihinnast¹⁴. Sotsiaalhoolekande seaduses § 50 lg 9 on määratud, et isiku omaosalus on vähemalt 7 eurot, kuid erandjuhul on võimalik abivahendi ostmisel isiku omaosalust vähendada 5 protsendini abivahendi maksumusest, kui isiku majanduslik olukord ei võimalda omaosalust tasuda, kui abivahendi soetamine tekitab isikule suures ulatuses lisakulutusi või kui isik ei ole muudel põhjendatud juhtudel

¹⁴ Sotsiaalministeerium. Riigi korraldatavad teenused. <https://www.sm.ee/et/riigi-korraldatavad-teenused>

võimeline omaosalust täies ulatuses tasuma. Kui riigieelarves ei ole abivahendi ostmise või üürimise tasu maksmise kohustuse ülevõtmiseks piisavalt rahalisi vahendeid, paneb Sotsiaalkindlustusamet õigustatud isiku tasu maksmise kohustuse ülevõtmiseks järjekorda. Abivahendite võimaldamise korralduses on viimastel aastatel toimunud oluline muudatus. 2009. aastal korraldati abivahendite kompenseerimist inimestele maavalitsuste kaudu, 2016. aastal viidi see aga Sotsiaalkindlustusameti haldusalasse.

Järgnevalt vaatame, millistesse kategooriatesse kuuluvaid abivahendeid puudega lapsed toimetulekuks vajavad (Joonis 41). Kõige enam vajatakse nägemisabivahendeid – ligi viiendik (17–21%) puudega lastest vajab neid toimetulekuks. Põetus- ja hooldusvahendeid vajab 13-15% puudega lastest, proteese ja ortoose 12-15% ja liikumisabivahendeid 7-10% puudega lastest. Kõige vähem on puudega laste seas neid, kes vajavad toimetulekuks spetsiifilisi suhtlus- ja teabevahetuse abivahendeid (3-5%) või kuulmisabivahendeid (3–4%).

Joonis 41. Kas laps vajab toimetulekuks järgnevaid abivahendeid? (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkt hinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

Lisaks etteantud abivahendite kategooriate loetelule oli vastajatel võimalik märkida, milliseid muid abivahendeid laps toimetulekuks vajab. Muid abivahendeid vajab toimetulekuks 7–10% kõigist puudega lastest. Sealhulgas märgiti kõige sagedamini meditsiinilisi abivahendeid nagu inhalaator, insuliinipump ja glükomeeter. Küll aga tuleb arvestada, et kuna neid abivahendeid ei olnud etteantud loetelus, on võimalik, et kõik vastajad neid ise ei märkinud ning seega võib inhalaatorit, insuliinipumpa, glükomeetrit vm meditsiinilisi abivahendeid vajavate osakaal puudega laste seas olla tegelikult suurem.

Kuna 2009. aastaga võrreldes on käesolevas uuringus abivahendite vajaduse ja kasutamise küsimus struktureeritud erinevalt, ei ole tulemused otseselt võrreldavad. Käesolevas uuringus kaardistati esmalt kõik lapsed, kes kategooria abivahendeid vajavad, ning seejärel uuriti nende abivahendite kasutamise kohta. Seevastu 2009. aastal kaardistati abivahendeid vajavad ainult kolmes kategoorias: vajab ja kasutab; vajab, kuid ei kasuta, sest ei saa seda majanduslikult lubada; vajab, kuid ei kasuta, sest ei pakuta sobivat. Seetõttu võisid eelmises uuringus abivahendeid vajavate hulgast jääda välja need lapsed, kes küll abivahendeid vajavad, kuid seda ei kasuta muudel põhjustel. 2009. aastal läbiviidud uuringus ei antud vastajatele ette vastusevarianti „ei oska öelda“ ning see võib samuti põhjustada erisusi käesoleva ning eelneva uuringu tulemustes. Üldistatult võib aga tuua välja, et ka 2009. aasta uuringu tulemustes ilmneb, et enim on

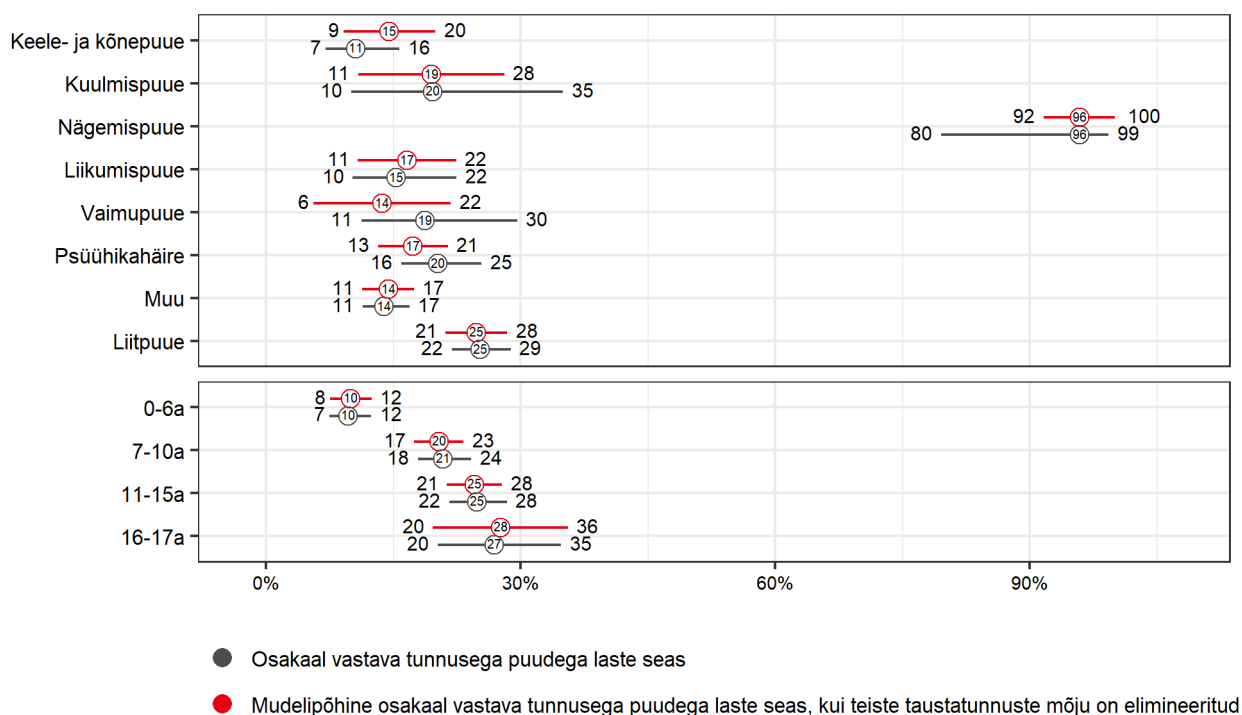
puudega laste seas nägemisabivahendeid, hooldus- ja kaitsevahendeid ning proteese ja ortoose vajavaid lapsi.

Kui vaadata, kui paljude erinevate kategooriate abivahendeid puudega lapsed vajavad, selgub, et ligi pooled (45-49%) puudega lapsed vajab vähemalt ühte loetletud kategooriatesse kuuluvat abivahendit. Kolmandik (ca 33%) puudega lastest vajavad ainult ühte kategooriasse kuuluvaid abivahendeid ja ca 16% puudega lastest vajab kahte või enamasse kategooriasse kuuluvaid abivahendeid.

Kuna mitmed uuringus käsitletud abivahendite kategooriad (nägemis-, kuulmis- ja liikumisabivahendid) on puudespetsiifilised, on neid abivahendeid vajatavate laste jaotus tugevalt seotud puudeliikide jaotusega puudega laste seas. Erandiks on siinkohal nägemisabivahendid. Kuigi nägemispuudega lapsi on puudega laste seas kõige vähem, siis antud kategooriasse kuuluvaid abivahendeid, näiteks prille, vajavad lapsed olenemata puude liigist. Järgnevalt kirjeldame abivahendi vajadust erinevate gruppide lõikes iga abivahendi kategooria puhul eraldi. Analüüsist on välja jäetud vastajad, kes ei osanud abivahendite vajadust hinnata.

Nägemisabivahendeid vajab valdav osa (80-99%) nägemispuudega lastest. Teiste puudeliikidega laste seas on nägemisabivahendeid vajavaid lapsi tunduvalt vähem. Vanuseti ilmneb, et teistest vähem vajavad toimetulekuks nägemisabivahendeid 0–6-aastased lapsed. Kui 0–6-aastastest vajab nägemisabivahendeid 7–12%, siis vanemates vanuserühmades jääb neid abivahendeid vajavate laste osakaal vahemikku 18–35%. Puude raskusastmete lõikes nägemisabivahendite vajadus statistiliselt oluliselt ei erine (Joonis 42).

Joonis 42. Nägemisabivahendite vajadus (% puudega lastest)

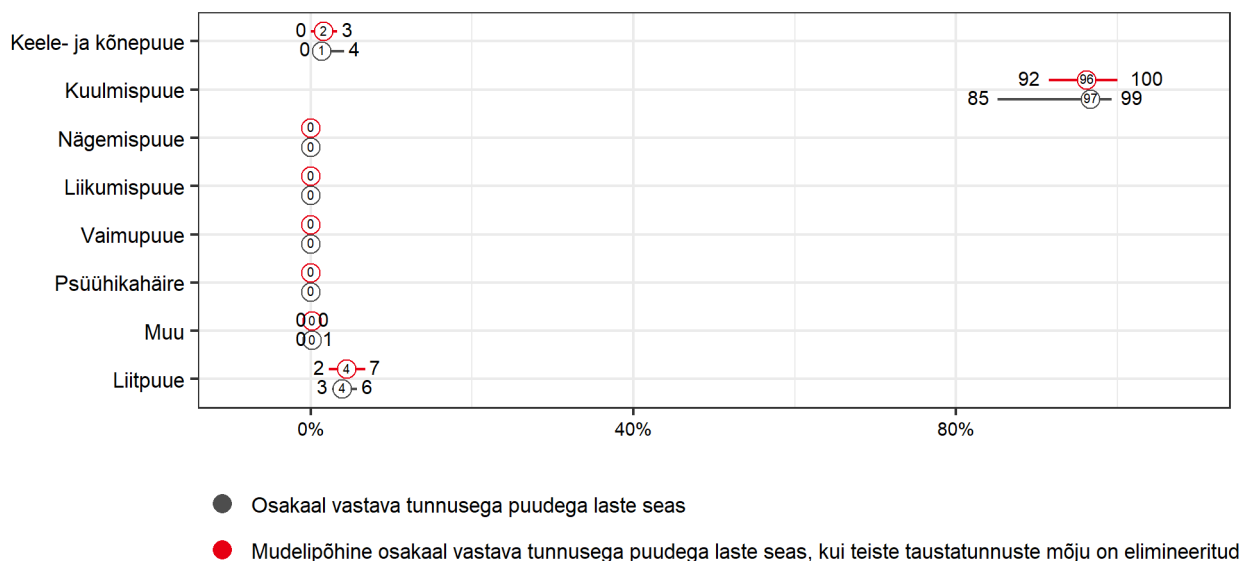


Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud vastajad, kes ei osanud nägemisabivahendite vajadust hinnata. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab toimetulekuks nägemisabivahendeid=1, ei vaja toimetulekuks nägemisabivahendeid= 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: vanus, puudeliik, puude raskusaste

Kuulmisabivahendeid vajavad toimetulekuks pea kõik (85-99%) kuulmispuudega lapsed. Toimetulekuks kuulmisabivahendeid vajavaid lapsi esineb ka liitpuudega (ca 3–6%) ning keele- ja kõnepuudega laste seas

(kuni 4%). Puude raskusastme ning vanuse lõikes kuulmisabivahendite vajadus statistiliselt oluliselt ei erine (Joonis 43).

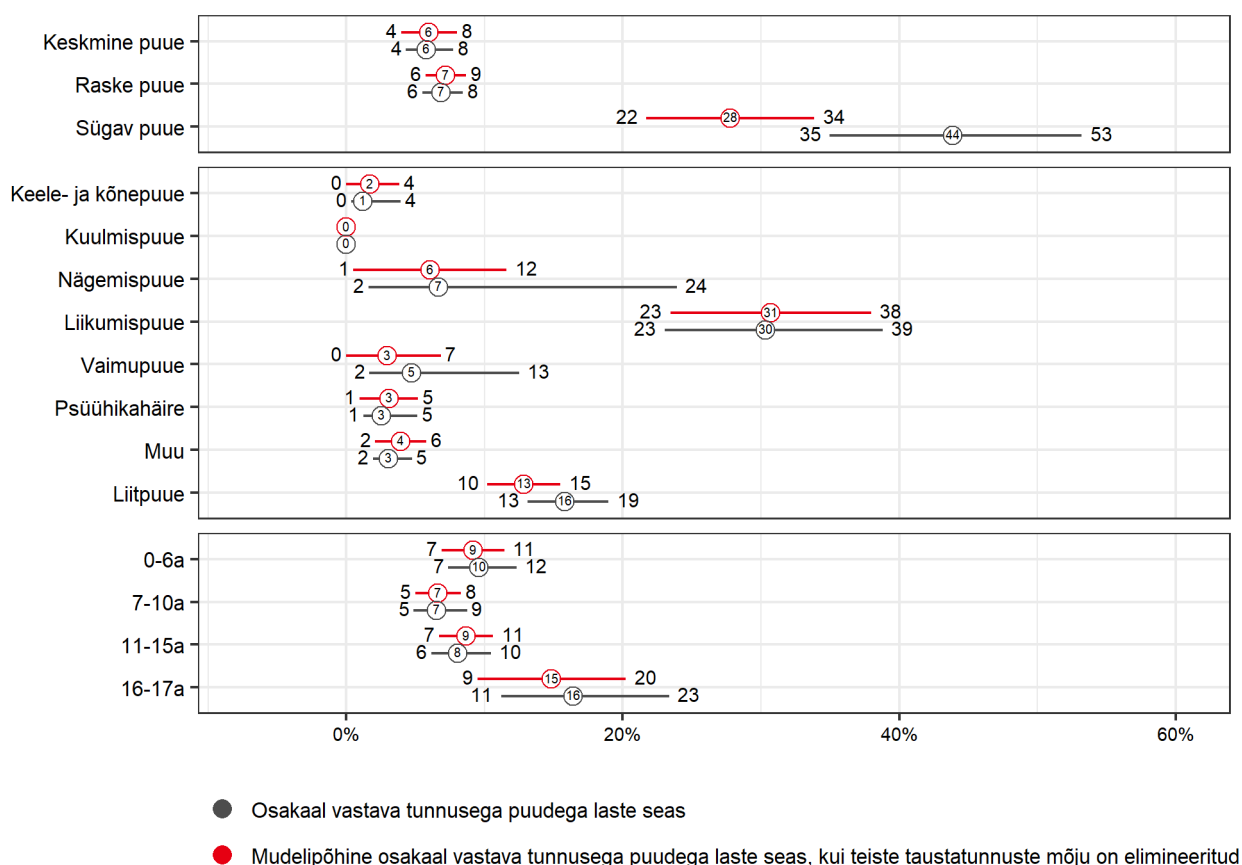
Joonis 43. Kuulmisabivahendite vajadus (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Juhul, kui joonisel pole esitatud usalduspiire, siis tähendab see, et käesoleva uuringu valimis ei esinenud ühtegi vastava puude liigiga kuulmisabivahendeid vajavat last. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud vastajad, kes ei osanud kuulmisabivahendite vajadust hinnata. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab toimetulekuks kuulmisabivahendeid=1, ei vaja toimetulekuks kuulmisabivahendeid= 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: vanus, puudeliik, puude raskusaste

Liikumisabivahendeid vajab 23–39% liikumispuudega lastest. Liitpuudega lastest vajab toimetulekuks liikumisabivahendit 13-19%. Vanusegrupiti on liikumisabivahendite vajadus küllaltki sarnane, kuid teistest mõnevõrra enam on liikumisabivahendeid vajavaid lapsi 16-17-aastaste seas (11-23%). Sügava puudega laste seas on liikumisabivahendite vajadus oluliselt suurem kui raske ning keskmise puudega laste seas – sügava puudega lastest vajab liikumisabivahendit 35-53%, raske puudega lastest 6-8% ning keskmise puudega lastest 4-8%. Kui aga elimineerime puude liigi ning vanuse mõju, on liikumisabivahendeid vajavate laste prognoositud osakaal (22-34%) sügava puudega laste seas oluliselt väiksem. See tähendab, et liikumisabivahendite vajadust sügava puudega laste seas mõjutavad oluliselt lapse puude liik ning vanus (Joonis 44).

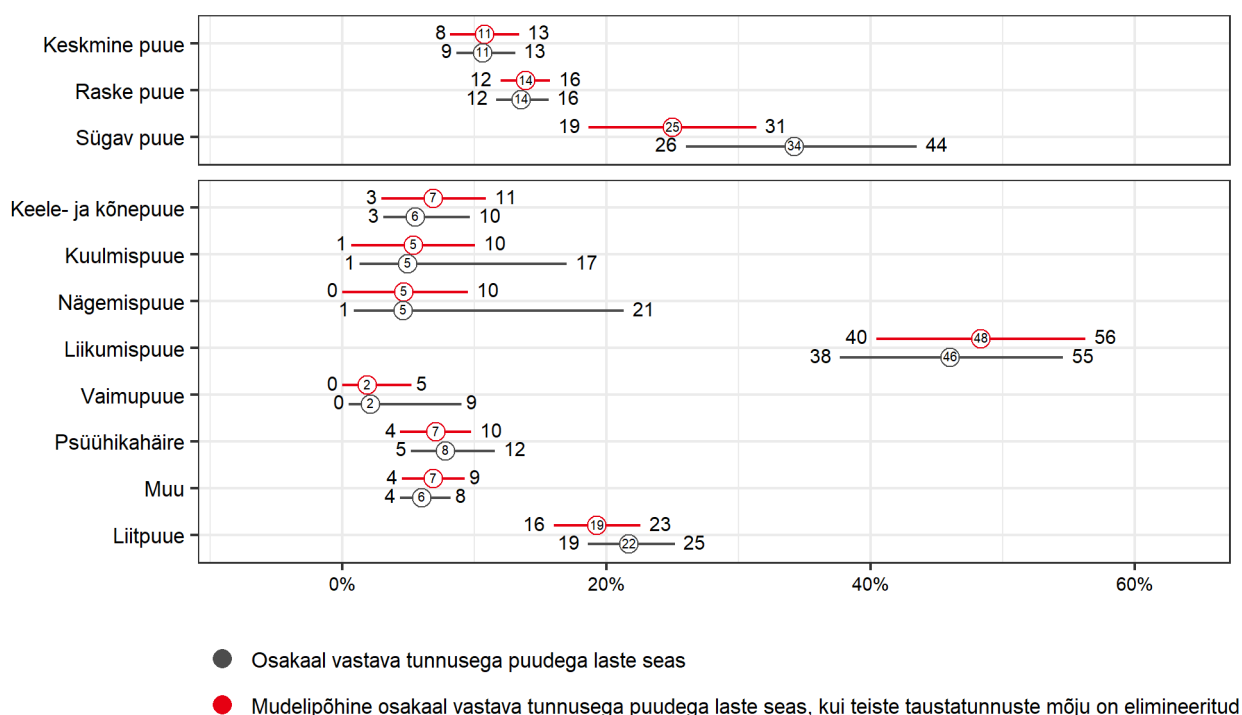
Joonis 44. Liikumisabivahendite vajadus (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Juhul, kui joonisel pole esitatud usalduspiire, siis tähendab see, et käesoleva uuringu valimis ei esinenud ühtegi vastava puude liigiga liikumisabivahendeid vajavat last. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud vastajad, kes ei osanud liikumisabivahendite vajadust hinnata. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab toimetulekuks liikumisabivahendeid=1, ei vaja toimetulekuks liikumisabivahendeid= 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: vanus, puudeliik, puude raskusaste

Proteese ja ortoosse vajavaid lapsi on enim liikumispuudega laste seas (38-55%) ning teistest mõnevõrra enam ka liitpuudega laste seas (19-25%). Puude raskusastmeti eristub sügav puue – proteese ja ortoosse vajab toimetulekuks 26-44% sügava puudega lastest, 12-16% raske puudega lastest ning 9-13% keskmise puudega lastest. Küll aga ilmneb, et lapse puude liigi ning vanuse mõju elimineerides on sügava puudega laste seas proteese ja ortoosse vajavate laste prognoositud osakaal mõnevõrra väiksem. Lapse vanuse lõikes proteeside ja ortooside vajadus oluliselt ei erine (Joonis 45).

Joonis 45. Proteeside ja ortooside vajadus (% puudega lastest)

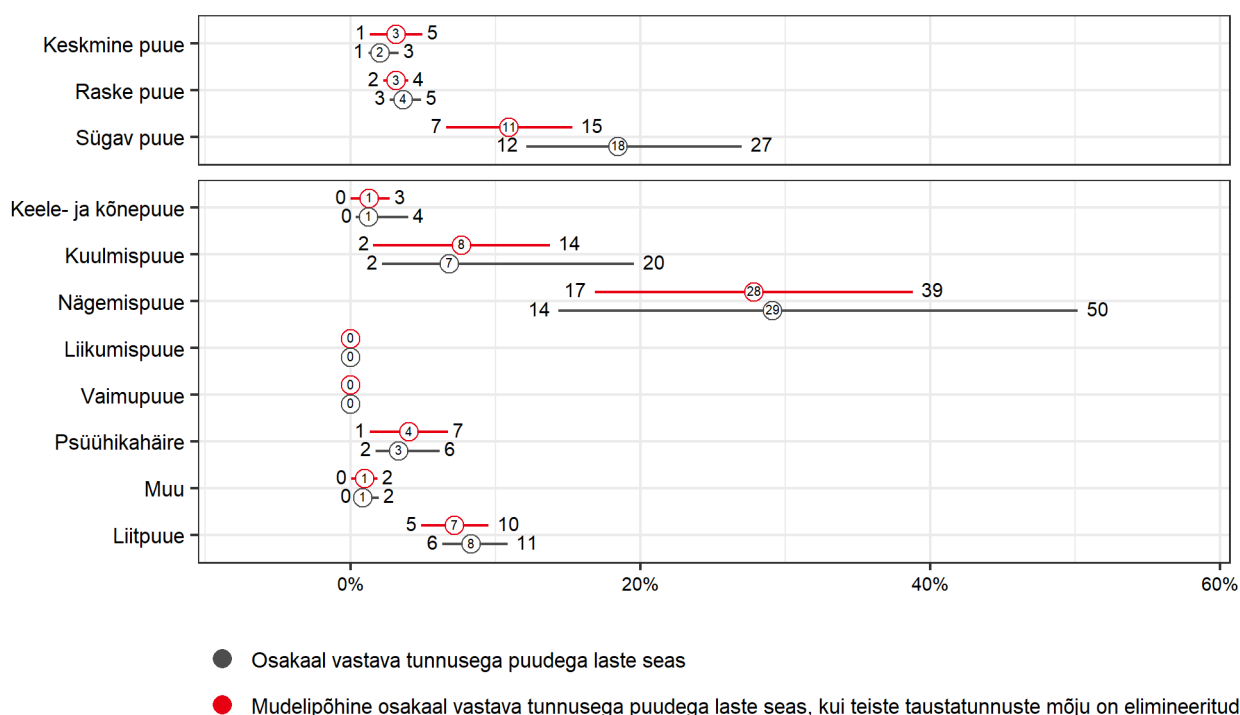


Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud vastajad, kes ei osanud proteeside ja ortooside vajadust hinnata. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab toimetulekuks proteese või ortoose=1, ei vaja toimetulekuks proteese või ortoose=0. Mudelis kasutatud taustatunnused: vanus, puudeliik, puude raskusaste

Spetsiifilisi suhtlus- ja teabevahetuse abivahendeid vajavaid on enim nägemispuudega laste seas (14-50%). Nende abivahendite vajadust esineb ka kuulmispuudega (2-20%), psüühikahäirega (2-6%), liitpuudega (6-11%), keele- ja kõnepuudega (kuni 4%) ning muu puudega laste seas (kuni 2%) (Joonis 46).

Erinevusi esineb ka puude raskusastmeti – sügava puudega lastest vajab seda tüüpi abivahendeid 12-27%, kuid raske ja keskmise puudega laste seas jääb nende abivahendite vajajate osakaal 1-5% piiresse. Elimineerides teiste taustatunnuste mõju, ilmneb, et sügava puudega laste seas on spetsiifilisi suhtlus- ja teabevahetuse abivahendeid vajavate laste prognoositud osakaal mõnevõrra väiksem. Vanusegrupiti statistiliselt olulisi erinevusi ei esine.

Joonis 46. Spetsiifiliste suhtlus- ja teabevahetuse abivahendite vajadus (% puudega lastest)

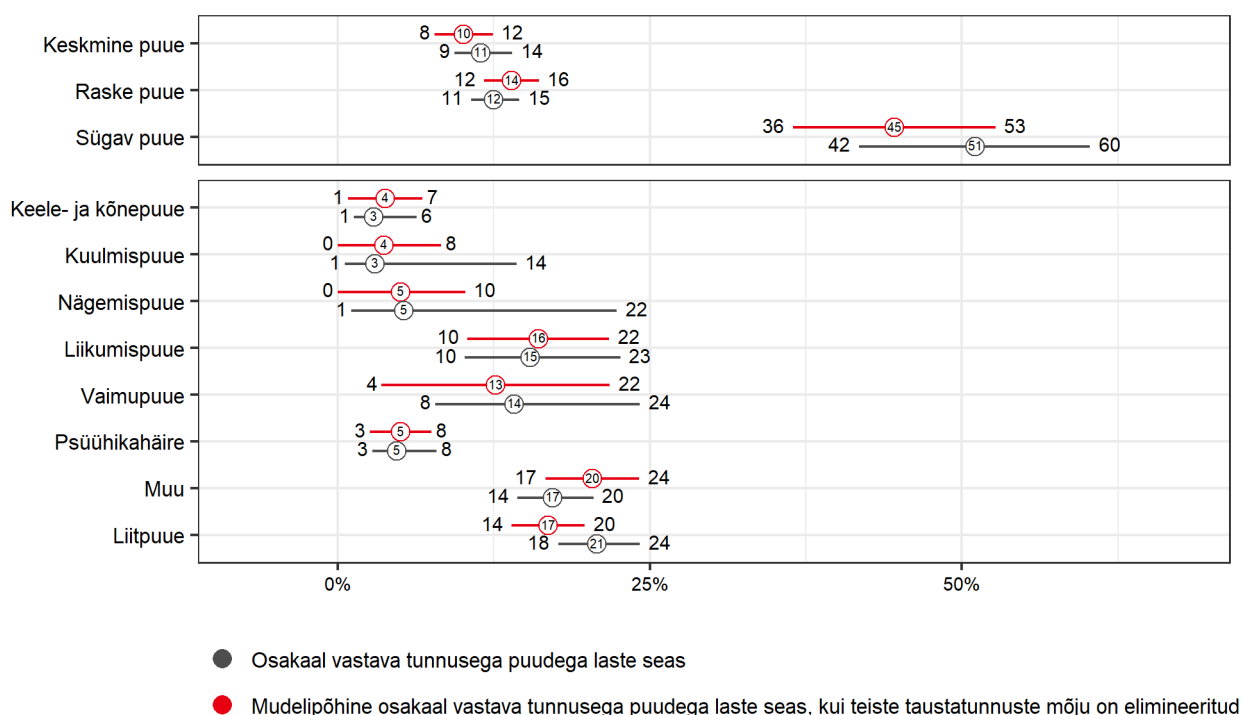


Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Juhul, kui joonisel pole esitatud usalduspiire, siis tähendab see, et käesoleva uuringu valimis ei esinenud ühtegi vastava puude liigiga spetsiifilisi suhtlus- ja teabevahetuse abivahendeid vajavat last. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud vastajad, kes ei osanud spetsiifilisi suhtlus- ja teabevahetuse abivahendite vajadust hinnata. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab toimetulekuks spetsiifilisi suhtlus- ja teabevahetuse abivahendeid=1, ei vaja toimetulekuks spetsiifilisi suhtlus- ja teabevahetuse abivahendeid=0. Mudelis kasutatud taustatunnused: vanus, puudeliik, puude raskusaste

Põetus- ja hooldusvahendeid vajavate laste osakaalud jaotuvad puudeliigiti suhteliselt sarnaselt. Teiste puudeliikidega võrreldes on põetus- ja hooldusvahendeid vajavaid lapsi mõnevõrra enam liitpuudega (18-24%), liikumispuudega (10-23%), vaimupuudega (8-24%) ning muu puudega laste (14-20%) seas (Joonis 47).

Puude raskusastmeti eristub selgelt sügav puue, milliste laste seas on neid abivahendeid vajavate osakaal 32–60%, teiste taustatunnuste mõju elimineerides on aga põetus- ja hooldusvahendeid vajavate laste prognoositav osakaal sügava puudega laste seas mõnevõrra väiksem. Raske ning keskmise puudega laste seas jääb neid abivahendeid vajavate laste osakaal vahemikku 9-15%. Vanusegrupiti statistiliselt olulisi erinevusi ei esine.

Joonis 47. Põetus- ja hooldusvahendite vajadus (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud vastajad, kes ei osanud põetus- ja hooldusvahendite vajadust hinnata. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab toimetulekuks põetus- ja hooldusvahendeid=1, ei vaja toimetulekuks põetus- ja hooldusvahendeid=0. Mudelis kasutatud taustatunnused: vanus, puudeliik, puude raskusaste

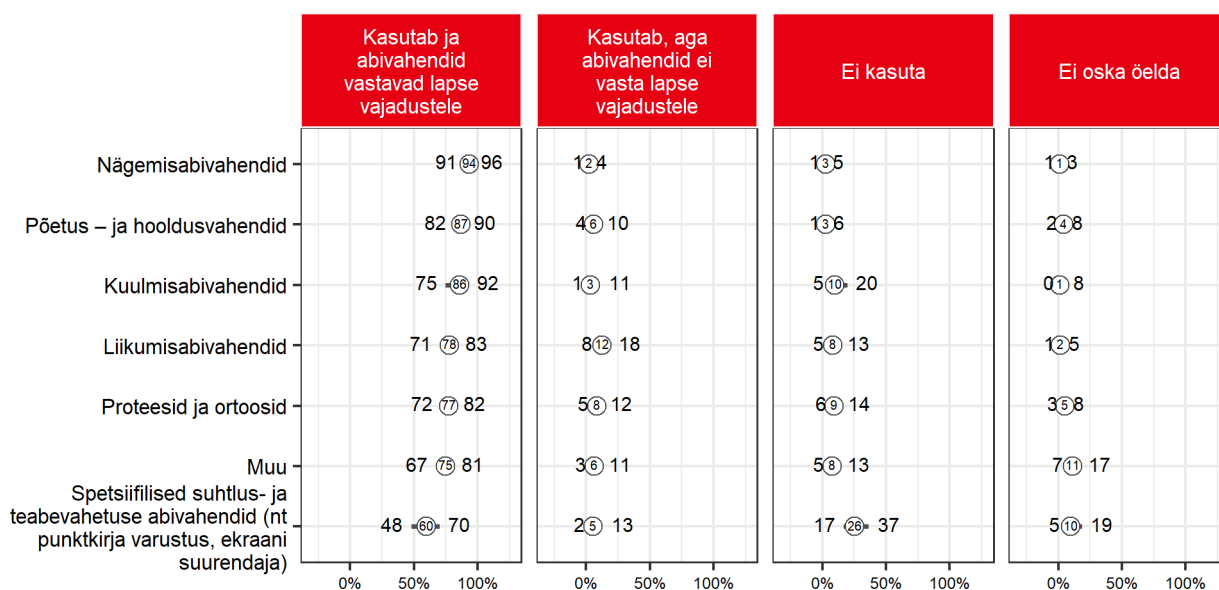
3.2.2 Abivahendite kasutamine ja nende vastavus vajadustele

Järgnevalt küsiti vajatavate abivahendite kohta, kas laps neid abivahendeid ka kasutab ja kas need abivahendid vastavad lapse vajadustele (Joonis 48). Valdav osa abivahendeid vajavatest lastest neid ka kasutab ning valdaval osal abivahendit kasutavatest lastest vastab abivahend vajadustele.

Küll aga on oluline välja tuua, et kõigi abivahendite kategooriate puhul on puudega laste seas ka neid, kellel esineb abivahendi kasutamisega probleeme ehk kes vajatavat abivahendit üldse ei kasuta või kes kasutavad abivahendit, mis nende vajadustele ei vasta. Vajatava abivahendi mittekasutamist esineb kõige enam spetsiifiliste suhtlus- ja teabevahetuse abivahendite ning kuulmisabivahendite puhul. Spetsiifilisi suhtlus- ja teabevahetuse abivahendeid vajavatest puudega lastest ei kasuta neid 17-37%, kuulmisabivahendeid vajavatest lastest vastavalt 5-20%. Olukordi, mil laps kasutab tema vajadustele mitte vastavat abivahendit, esineb enim liikumisabivahendite puhul – 8-18% neid abivahendeid vajavatest lastest kasutavad abivahendeid, mis ei vasta nende vajadustele. Teiste abivahendite kategooriate puhul jääb nende laste osakaal, kes abivahendit vajavad, kuid kasutavad vajadustele mittevastavat abivahendit, alla 10%. Vajatava abivahendi mittekasutamist ning vajadustele mittevastava abivahendi kasutamist ei ole aga võimalik taustatunnuste lõikes täpsemalt kirjeldada, sest neid olukordi esines uuringus osalenute seas liiga vähe, et taustatunnuste lõikes oleks võimalik tuvastada statistiliselt olulisi erinevusi.

Käesoleva uuringu tulemusi ei ole siinkohal võimalik võrrelda 2009. aasta tulemustega, kuna eelnevas uuringus ei küsitud abivahendite vastavust lapse vajadustele. Üldisemalt aga leiti nii 2009. aasta uuringus kui käesolevas uuringus, et valdav osa neist, kes abivahendeid vajavad, neid ka kasutavad.

Joonis 48. Kas laps kasutab järgnevaid abivahendeid? Kui jah, kas need vastavad lapse vajadustele? (% puudega lastest, kes vastava kategooria abivahendeid vajavad)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

3.2.3 Põhjused, miks abivahendit ei kasutata või miks abivahend ei vasta lapse vajadustele

Vastajatel, kes märkisid vajitava abivahendi kategooria puhul, et laps abivahendeid ei kasuta või et kasutatav abivahend ei vasta lapse vajadusele, paluti neid asjaolusid ka põhjendada.

3.2.3.1 Vajitava abivahendi mitte kasutamine

Kuna iga abivahendi kategooria puhul eraldi võetuna oli valimis liiga vähe lapsi, kes abivahendit vajasisid, kuid seda ei kasutanud, ning sisulisi põhjendusi andsid samuti vähesed, ei ole otstarbekas abivahendi mittekasutamise põhjuste osas esitada sagedusjaotusi. Läbivalt töid lapsevanemad välja järgnevaid põhjendusi:

1. Vajalik abivahend on liiga kallis ning pere majanduslik olukord ei võimalda abivahendit osta.

„Pole olnud võimalik soetada.“ (liikumisabivahendid)

„Sest eriarst keeldus seda välja kirjutamast, et saada erisoodustust selle abivahendi ostmiseks /.../ Tavahinnaga osta oli liiga kallis.“ (muud abivahendid)

„Ei suuda hetkel finantsiliselt neid soetada.“ (proteesid ja ortoosid)

„Suure hinna tõttu pole ostanud.“ (spetsiaalsed suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid)

2. Lapse kasvamise tõttu on vaja osta uus abivahend küllaltki tihti ning see pole majanduslikult võimalik.

„Uute tellimine on liiga kallis ja liiga kaua valmistatakse. Kui kätte saab, on juba väikesed ja ei saa kasutada.“ (proteesid ja ortoosid)

„Ei ole võimalik nii tihti neid osta, kuna jalg kasvab kiiresti.“ (proteesid ja ortoosid)

3. Olemasolevad abivahendid last ei aita ning sobivat abivahendit ei ole olemas või ei pakuta.

„Laps ei kuule ja aparaat ei aita teda“ (kuulmisabivahendid)
 „Pole leidnud vastavat ja päris sobivat hüppeliigese toetajat“ (proteesid ja ortoosid)
 „Arstid ja ortoosimeister ei suutnud leida varianti, mis meie lapsele oleks reaalset abi pakkunud.“
 (proteesid ja ortoosid)
 „Laps on kõnetu, ei ole veel leidnud sobivat tehnilist abivahendit, mille kaudu laps end väljendada suudaks.“ (spetsiaalsed suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid)

4. Lapsevanemal puudub vajalik info abivahendite saamise ja kasutamise kohta.

„Sest pole saanud kusagilt infot nende kasutamise ja saamise kohta.“ (spetsiaalsed suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid)
 „Ta võiks kasutada spetsiaalseid toetavaid jalanõusid. Pole teavet.“ (proteesid ja ortoosid)

5. Pikad ooteajad ja järjekorrad abivahendi tellimisel, valmistamisel ning rahastuse saamisel.

„Ootame tellitud kommunikaatorit juba 5 kuud.“ (spetsiaalsed suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid)
 „Pole tellimus kohale jõudnud. Pikk ooteaeg.“ (muud abivahendid)
 „Ortoosid ei ole veel valmis, ilma ei saa.“ (proteesid ja ortoosid)

6. Küsitluse toimumise hetkeks ei olnud veel jõutud lapsele abivahendit osta või on laps abivahendi kasutamiseks veel liiga noor.

„Laps on liiga noor veel.“ (nägemisabivahendid)
 „Pole veel jõudnud soetada, sest rehabilitatsiooni plaan sai alles paika“ (muud abivahendid)
 „Vajadus on määratud hiljuti, ei ole veel jõudnud ortoose muretseda“ (proteesid ja ortoosid)

3.2.3.2 Kasutatava abivahendi mittevastavus lapse vajadustele

Vastajate põhjendused, miks kasutatav abivahend lapse vajadustele ei vasta, on küllaltki abivahendispet-siifilised. Järgnevalt on käsitletud neid põhjendusi iga abivahendite kategooria puhul eraldi. Ka siin oli vastajate arv väike, mistõttu pole otstarbekas abivahendi mittevastavuse kohta toodud selgitusi sagedusjaotustest lähtuvalt võrrelda.

Nägemisabivahendid

Nägemisabivahendite kategoorias esineb põhjusena asjaolu, et lapse nägemine on halvenenud, kuid kuna silmaarstile on pikad järjekorrad, ei olnud laps veel uusi abivahendeid saanud. Samuti tuuakse välja, et kasutatav abivahend on lapsele ebamugav või ei ole piisavalt vastupidav.

„Silmaarstile on raske aega saada. Väga pikad järjekorrad. Hetkel vajaksid prillid uuendamist.“

„Silmaarstile saamise järjekorrad on pikad, silmanägemine muutub kiiresti (lühinägelikkuse süvenemine) ja laps on sunnitud kuni arstile jõudmiseni kasutama vanu prille.“

„Prilliraamid on nõrgad, ei pea vastu“

Kuulmisabivahendid

Kuulmisabivahendeid, mis lapse vajadustele ei vasta, kasutas käesolevas uuringus vaid 3 last. Sealjuures põhjused, miks abivahend ei vasta lapse vajadustele, sõltuvad konkreetsest lapsest. Põhjustena toodi välja, et kuuldeaparaat ei aita last piisavalt ning lapsele vajalikud kuuldeaparaadid on liiga kallid.

Liikumisabivahendid

Üheks läbivaks probleemiks on see, et abivahend, mis lapse vajadustele vastaks, on liiga kallis ning majanduslikel põhjustel kasutatakse seetõttu odavamalt, kuid lapsele mitte sobivat abivahendit.

„Ratastool, mida laps kasutab, ei vasta nõuetele ja uut ratastooli osta me kahjuks ei ole suutelised.“

„Rulaatorit, mis sobiks meie kodustesse ja õue tingimustesse kruusateel käimiseks aga Eestis ei müüda ega rendita. Tellides Euroopast aga on parimal juhul ka omaosalus mitme kuu söögiraha hind“

„Liikumispuudega laste spetsiaalsed vankrid on kallimad kui autod ja sellepärast ei suuda muretseda lapsele korralikku ja tema vajadustele spetsiaalset vankrit.“

Sealjuures on abivahendi mittevastavus lapse vajadustele seotud ka sellega, et majanduslikult ei ole võimalik osta uut abivahendit nii tihti, kui laps kasvamise tõttu vajaks.

„Sest käru on väikseks jäänud, sobiva käru muretsemine keeruline ja ülikallis.“

„Laps on liiga suur selle käru jaoks, uut hetkel veel pole saanud.“

„Tavalastele mõeldud kärudesse enam väga hästi enam ära ei mahu. Spetsiaalsed kärud on aga väga kallid isegi kui omaosalus on 10%.“

Samuti tuuakse välja, et individuaalse abivahendi tellimine on aeganõudev protsess, mille tõttu peab laps abivahendit oodates kasutama tema vajadustele mitte vastavaid vahendeid.

„Seda liikumisvahendit saab eri-tellimisel sellega läheb kaua aega (valmimisega) laps võib ka sellest välja kasvada kuni ootab eristat.“

Proteesid ja ortoosid

Sarnaselt liikumisabivahenditele tuuakse ka proteeside ja ortooside puhul peamiselt esile põhjuseid, mis on tingitud mitme asjaolu koosmõjust nagu lapse kasvamine, abivahendi kallidus, sage vajadus uus abivahend soetada, pikad järjekorrad ja aeganõudev abivahendi valmistamise protsess.

„Järjekorrad on nii pikad, et selleks ajaks, kui valmis saavad, on asi juba väga hull ja ortoosid on väikseks jäänud.“

„Ortooside ja erijalatsite tellimine on keeruline, aeganõudev ja laps kasvab pidevalt, seda pole süsteemis arvesse võetud.“

„Ortooside saamine, rahastamine on väga piiratud, sest aastas 1 paar ortoost on liiga vähe kasvavale lapsele ja ka liikuv laps 1 paari ortoost kannab läbi 6 kuuga. /.../ Koolikäival lapsel on vaja sisejalatseid nii sportimiseks kui õpperuumis viibimiseks, lisaks talvesaapaid, kevad-sügis jalatseid pluss suvejalatseid ehk miinimum on 5 paari ortoosidega seondult. Ortoosid on väga kallid, et erimenetlusega oma osalus jääb ikka mitme saja euroni.“

Spetsiaalsed suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid

Kasutatavate spetsiaalsete suhtlus- ja teabevahetuse abivahendite puhul märkisid 5 vastajat, et abivahend ei vasta lapse vajadustele. Selle olukorra selgituseks on esitatud vaid kaks sisulist vastust. Põhjendusena toodi välja, et laps ning vanemad ei oska abivahendit kasutada ning et lapsel ei ole ekraanisuurendajat ja selle asemel kasutatakse luupi.

Põetus- ja hooldusvahendid

Kasutatavate põetus- ja hooldusvahendite mittevastavus lapse vajadustele on vastajate sõnul osalt tingitud sellest, et abivahendi kvaliteet ei vasta alati abivahendi kasutamise eesmärgile.

„Ei ole vastavaid mähkmeid ja voodi kiled on haprad ja lähevad kergelt katki“

„Mähkmed ei pea alati.“

„Mulle tundub, et kanüülid on muutunud aja jooksul ebakvaliteetsemaks. Kui idee poolest peaks neid vahetama iga kolme päeva tagant, siis tegelikkuses need üle kahe päeva ei toimi.“

Samuti tuuakse välja, et pakutavate abivahendite valik on kesine, lapsele individuaalselt sobivad abivahendid pole ning abivahendi ostmist ei kompenseerita lapsele vajaliku koguse ulatuses.

„Abivahendikaardiga on valik piiratud ja enamuse tuleb osta apteegist.“

„Püksmähkmed on kas päris pisikestele, millesse 10-aastane sisse ei mahu või täiskasvanutele, mis jäävad liiga suureks.“

„Vajab pidevalt ja suuremas koguses kui praegu kompenseeritakse.“

Muud abivahendid

Kategoriseerimata abivahendite osas on toodud välja mitmeid probleeme insuliinipumbaga. Sealhulgas tuuakse välja, et lapse kasutatav insuliinipump ei võimalda lapse veresuhkru taset jälgida, ning samuti oleks lapse vajadusele vastavalt vaja suuremas koguses insuliinipumba tarvikuid nagu näiteks kanüülid.

„Laps vajaks sensoriga insuliinipumpa, aga see on liiga kallis ja ma ei jõua seda osta. Tavalise pumba ostsime, aga sellest on vähe kasu, vaja oleks ikkagi sensoriga, mis jälgiks ka pidevalt veresuhkru taset ja suhtleks pumbaga.“

„Insuliinipumba kanüüle peaks olema rohkem iga lapse kohta arvestatud, kuna kanüülide otsad lähevad vahel pannes kõveraks või ei lähe insuliin hästi enam läbi. Siis tuleb kanüül vahel kiiremini ära vahetada kui 3 päeva tagant, mis on nende kasutusajaks arvestatud. Neid kokku hoida on väga keeruline ja kanüül on hädavajalik.“

3.3 Kokkuvõtte

Valdav osa (ca 91-93%) puudega laste vanematest tunnetab, et puudega laps vajab oma puudest tingituna kõrvalabi vähemalt ühe uuringus käsitletud tegevuse juures (tegevused ja õppimine koolis või lasteaias, suhtlemine, liikumine kodus ja väljaspool kodu, enda eest hoolitsemine, vaba aja veetmine). Puudega laste vanemate hinnangutele tuginedes vajavad puudega lapsed enim abi õppimisel ning muudel tegevustel koolis või lasteaias – valdav osa lapsevanematest (81-74%) leiab, et laps vajab nende tegevuste juures kõrvalabi. Üle poolte lastevanemate hinnangul vajab puudega laps kõrvalabi suhtlemisel (60–64%), väljaspool kodu liikumisel (59–63%), enda eest hoolitsemisel (59–63%) või vaba aja veetmisel (58–63%). Kõige vähem on neid puudega lapsi, kes vajavad kõrvalabi kodus liikumisel – ligi viiendik (20-23%) puudega lastest vajab nende vanemate hinnangul selle tegevuse juures kõrvalabi.

Lapsevanemate hinnangud puudega lapse kõrvalabi vajadusele erinevate tegevuste juures on seotud lapse puude liigi, puude raskusastme, vanuse ning koduse keelega. Kõigi uuringus käsitletud tegevuste (tegevused ja õppimine koolis või lasteaias, suhtlemine, liikumine kodus ja väljaspool kodu, enda eest hoolitsemine, vaba aja veetmine) puhul on kõrvalabi vajadus nooremate laste seas võrreldes vanemate lastega suurem ka siis, kui teiste taustatunnuste mõju on elimineeritud. Seetõttu võib eeldada, et kõigile vastajatele polnud üheselt selge, et hinnata tuleb puudest tingitud kõrvalabi vajadust. Kuna uuringus käsitletud tegevused on sellised, mille puhul kõik noored lapsed, olenemata sellest, kas neil on puue, vajavad suuremal või vähemal määral kõrvalabi, siis ilmselt oli lapsevanematel keeruline eristada lapsel just puudest tuleneva abi vajadust.

Puude raskusastmeti eristused kõigi uuringus käsitletud tegevuste puhul sügava puudega lapsed, kelle hulgas on erinevate tegevuste juures kõrvalabi vajavaid tunduvalt enam kui keskmise ning raske puudega laste seas. Lapse puude liiki arvestades ei kerkinud esile sellist puudeliiki, mille puhul esineks suurem kõrvalabi vajadus kõigi käsitletud tegevuste puhul. Küll aga on mitmete tegevuste puhul liitpuudega laste seas kõrvalabi vajavate osakaal teiste puudeliikidega võrreldes mõnevõrra suurem. Koduse keele puhul ilmnes, et vene keelt koduse keelena kõnelevad vanemad tajuvad eesti keelt kõnelevatest vanematest vähem lapse kõrvalabi vajadust kodus ja väljaspool kodu liikumisel, enda eest hoolitsemisel ning õppimisel ja muudel tegevustel koolis või lasteaias. Siinkohal võib olla tegemist kultuurilise erinevusega. Antud asjaolu toodi välja puudega lastega peresid ühendavate organisatsioonide esindajatega läbiviidud fookusgrupi-intervjuus, kus selgus, et vene keelt kõnelevad lapsevanemad kardavad enam stigmatiseerimist, mis omakorda viib selleni, et lapse abivajadust tunnistatakse vähem.

Ligi pooled (45-49%) puudega lastest vajavad nende vanemate hinnangul toimetulekuks vähemalt ühte uuringus käsitletud abivahendite kategooriatesse kuuluvat abivahendit. Kõige enam on puudega laste seas nägemisabivahendite vajajaid (ca 17-21% puudega lastest vajab neid). Põetus- ja hooldusvahendeid vajab 13-15%, proteese ja ortoose 12-15% ja liikumisabivahendeid 7-10% puudega lastest. Kõige vähem on puudega laste seas neid, kes vajavad toimetulekuks spetsiifilisi suhtlus- ja teabevahetuse abivahendeid (3-5%) või kuulmisabivahendeid (3-4%). Abivahendite vajadus on tugevalt seotud lapse puude liigiga. Kuulmisabivahendeid vajab 85-99% kuulmispuudega ja 2-7% liitpuudega lastest. Liikumisabivahendeid vajab 23-39% liikumispuudega lastest ja sageduselt järgmised on liitpuudega lapsed, kelle seas on liikumisabivahendi vajajaid 13-19%. Proteese ja ortoose vajavaid lapsi esineb kõige enam liikumispuudega (38-55%) ja liitpuudega laste seas (19-25%), teiste puudeliikidega laste seas on proteeside ja ortooside vajajaid oluliselt vähem. Nägemisabivahendeid vajab toimetulekuks valdav osa (80-99%) nägemispuudega lastest. Nägemisabivahendite vajajaid esineb ka kõigi teiste puudeliikidega laste seas, kuid siiski märkimisväärselt vähem kui nägemispuudega laste seas.

Kui laps abivahendit vajab, siis üldjuhul ta seda ka kasutab ning valdavalt vastavad kasutatavad abivahendid lapse vajadustele. Samas esineb kõigi uuringus käsitletud abivahendite kategooriate puhul olukordi, mil vajavat abivahendit ei kasutata või ei vasta kasutatav abivahend lapse vajadustele. Kõige enam esineb vajatava abivahendi mittekasutamist spetsiifiliste suhtlus- ja teabevahetuse abivahendite puhul – neid abivahendeid vajavatest lastest 17-37% ei kasuta neid. Kuulmisabivahendeid ei kasuta 5-20% neid vajavatest, proteese ja ortoose ei kasuta 6-14% neid vajavatest, liikumisabivahendeid ei kasuta 5-13% neid vajavatest, põetus- ja hooldusvahendeid ei kasuta 1-6% neid vajavatest ning nägemisabivahendeid ei kasuta 1-5% neid vajavatest puudega lastest. Olukordi, mil kasutatav abivahend ei vasta lapse vajadustele, esineb enim liikumisabivahendeid vajavate laste puhul – nende abivahendite vajajatest 8-18% kasutavad sellist abivahendit, mis lapse vajadustele ei vasta. Teiste abivahendite kategooriate puhul jääb nende laste osakaal, kes abivahendit vajavad, kuid kasutavad oma vajadustele mitte vastavat abivahendit, alla 10%.

4 Tervishoiuteenused

Tervishoiuteenuste peatükis antakse ülevaade puudega lastest, kes vajasisid ja kasutasid küsitlusele eelnenud 12 kuu jooksul erinevaid tervishoiuteenuseid. Tervishoiuteenustega seonduvate probleemide puhul vaadatakse esmalt üldiselt, kellel teenusega probleeme esines ja seejärel analüüsitakse enamlevinud probleeme iga teenusega seoses.

4.1 Õigus tervishoiuteenustele

Arstiabi on Eestis kolmetasandiline¹⁵:

- esmatasand ehk perearstiabi,
- eriarstiabi ja
- õendusabi.

Üldjuhul peab arstiabi saamiseks esmalt pöörduma perearsti poole, kes nõustab, teostab vajalikud uuringud ja ravi ning vajadusel suunab järgmise tasandi arstiabile ehk eriarsti vastuvõtule. Erakorralise arstiabi vajadusel saab inimene pöörduda otse haigla erakorralise meditsiini osakonda või kutsuda välja kiirabi. Ka hambaravi jaoks ei ole vaja perearsti suunamist.

Tervishoiuteenuste, ravimite meditsiiniseadmete ning rahaliste hüvitiste kättesaadavust ja ravikindlustussüsteemi jätkusuutlikkust korraldab ja tagab Eesti Haigekassa. Haigekassa poolt ravikulude hüvitamiseks on vajalik, et inimesel oleks ravikindlustus. Riik tagab õiguse ravikindlustusele alla 19-aastastele lastele, õpilastele ja üliõpilastele, ajateenijatele, rasedatele, töötutele, osalise või puuduva töövõimega isikutele, lapsehoolduspuhkusel olijatele, ülalpeetavatele abikaasadele, pensionäridele, puudega inimeste hooldajatele ja haigekassaga vabatahtliku kindlustuslepingu sõlminutele (Ravikindlustuse seadus § 5 lg 4). Alla 19-aastaste laste eest tasub haigekassa ka hambaraviteenuste maksumuse kalendriaastaks kehtestatud piirmäära ulatuses.

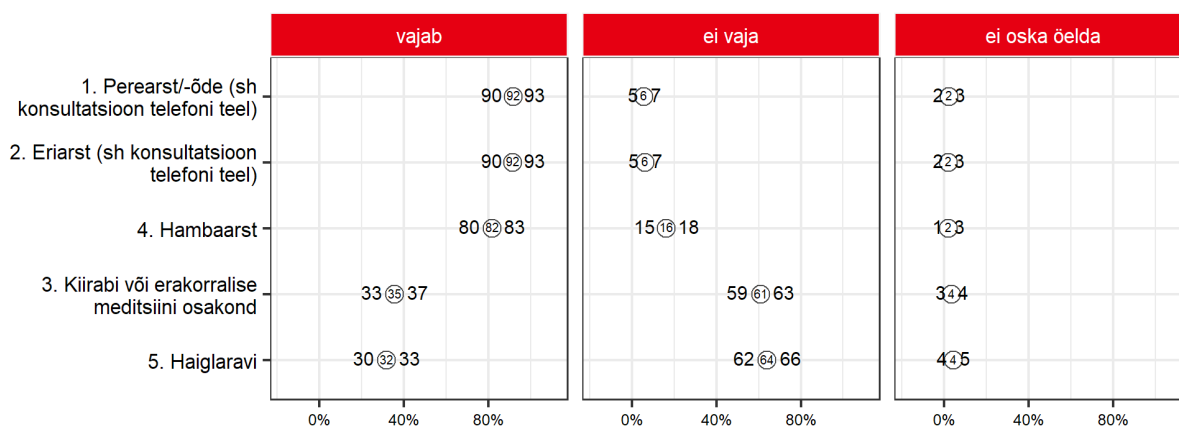
4.2 Tervishoiuteenuseid vajanud ja kasutanud puudega lapsed

Käesolevas uuringus määratleme perearsti, eriarsti, hambaarsti, erakorralise meditsiini ja haiglaravi vajanud puudega laste osakaalu liites kokku need, kes kasutasid nimetatud teenuseid või vastasid, et nad küll vajasisid teenust, kuid ei saanud kasutada. Tervishoiuteenustest vajavad puudega lapsed kõige enam perearstiteenust: 90–93% puudega lastest kasutasid või oleksid soovinud kasutada viimase 12 kuu jooksul perearstiteenust (Joonis 49). Järgmisel kohal on eriarstiteenus (või eriarsti konsultatsioon telefoni teel), mida puudega lastest on vajanud pea samasugune osakaal (90–93%). Järgneb hambaarstiteenus (80–83% puudega lastest on kas kasutanud või vajasisid, aga ei saanud kasutada). Kiirabi või erakorralise meditsiini teenuseid on kas kasutanud või vajanud, aga mitte kasutanud 33–37% puudega lastest. Kõige vähem on loetletud tervishoiuteenustest aasta jooksul kasutatud või vajatud haiglaravi: 30–33% puudega lastest.

Kuna 2009. a puudega laste uuringus oli tervishoiuteenuseid puudutav küsimus struktureeritud käesolevast uuringust erinevalt, siis pole tulemused otseselt võrreldavad. Eelmises uuringus on küsitud külastuskordade arvu vaba vastusena ning polnud võimalust vastata „ei oska öelda“, „ei vaja“, „ei saanud, kuigi vajaks“.

¹⁵ Eesti Haigekassa. Arsti- ja õendusabi. <https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/arsti-ja-oendusabi/>

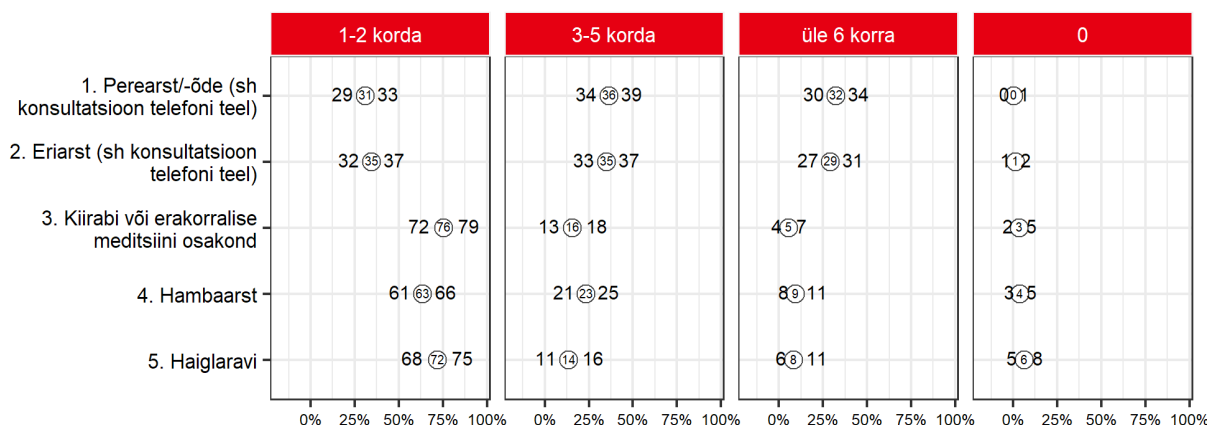
Joonis 49. Puudega lapsed, kes on viimase 12 kuu jooksul tervishoiuteenuseid kasutanud või vajanud, kuid mitte kasutanud (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Kategooria „vajab“ koondab need lapsed, kes kasutasid teenust ja kes vajasid, kuid ei kasutanud.

Analüüsides olukorra esinemist, kus puudega laps on teenust vajanud, kuid pole seda kordagi saanud, ilmneb, et sellist probleemi on vähem pere- ja eriarstiteenuse puhul ja ülejäänud teenuste puhul ilmneb olukorda mõnevõrra sagedamini (Joonis 50).

Joonis 50. Mitmel korral viimase 12 kuu jooksul on puudega laps kasutanud järgnevaid tervishoiuteenuseid? (% teenust vajavatest puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Teenust vajavad lapsed on need, kes kasutasid teenust ja kes vajasid, kuid ei kasutanud.

Perearstiteenust vajanutest on neid, kellel pole olnud võimalik seda aasta jooksul kordagi saada, vähem kui 1% (Joonis 50). Eriarsti juurde pole üldse saanud 1–2% eriarstiabi vajanud puudega lastest. Haiglaravi vajanud laste osakaal on küll väiksem kui teisi tervishoiuteenuseid vajanud (Joonis 49), kuid nende hulgas on selliste osakaal, kes ravile pole üldse saanud, kõige suurem (5–8%). Hambaarstiabi ja erakorralise meditsiini teenuseid vajanud, kuid üldse mitte saanud puudega laste osakaal on väiksem, jäädes 2-5% vahele.

Külastuskordade osas ei erine pere- ja eriarsti kasutus statistiliselt oluliselt (hinnates usalduspiiride kattuvuse alusel). Mõlema teenuse puhul jagunevad teenust vajanud lapsed enam-vähem võrdselt kasutamiskordade vahel. Kiirabi ja erakorralise meditsiini teenust kasutatakse oluliselt vähem kordi aastas kui arstiteenuseid: enamik, kes on teenust vajanud, on erakorralise meditsiini teenuseid kasutanud üks-kaks korda viimase 12 kuu jooksul (72–79%). Üle kuue korra aastas on tervishoiuteenustest kõige harvem kasutatud kiirabi, 4–7% vajajatest. Haiglaravi kasutatakse sarnaselt erakorralise meditsiini teenustega

enamasti 1-2 korda aastas (68–75%) ja üle 6 korra kasutanuid on 6–11%. Ka hambaarsti külastavad puudega lapsed enamasti ühel korral 12 kuu jooksul.

4.2.1 Probleemid tervishoiuteenustega

Viimase 12 kuu jooksul tervishoiuteenuseid kasutanud laste vanematelt küsiti, kas ja milliseid probleeme on etteantud loetelust teenuste kasutamisel esinenud. Samuti oli inimestel võimalik vaba vastusena kirjeldada loetelust puudunud probleeme. Kuna eelmises, 2009. aasta puudega laste perede uuringus ei olnud ette antud probleemide loetelu, vaid probleeme võis loetleda vabade vastustena, ei ole tulemused võrreldavad käesoleva uuringuga.

Tulemustest (Tabel 8) ilmneb, et kõige enam esines inimestel erinevaid probleeme eriarstiteenusega - ca pooltel vähemalt ühe korra vastuvõtul käinutest. Probleemide esinemise sageduselt järgmine oli erakorraline arstiabi, millega probleeme koges veidi üle kolmandiku teenust kasutanutest. Perearst, hambaravi ja haiglaravi ei eristunud üksteisest probleemide esinemise sageduse poolest, nende teenustega oli probleeme veidi vähem kui kolmandikul teenust kasutanutest.

Tabel 8. Tervishoiuteenuste probleemide esinemine

	Perearst/-õde (sh telefoni teel)	Eriarst (sh telefoni teel)	Kiirabi	Hambaravi	Haiglaravi
12 kuu jooksul tervishoiuteenust kasutanuid (% puudega lastest)	90–93%	89–92%	32–36%	76–80%	28–32%
Probleemide esinemine (% teenust kasutanud puudega laste arvust)	29–32%	50–55%	33–40%	27–31%	26–34%

4.3 Perearsti vajanud laste osakaal, teenuse kasutamise sagedus ja seonduvad probleemid

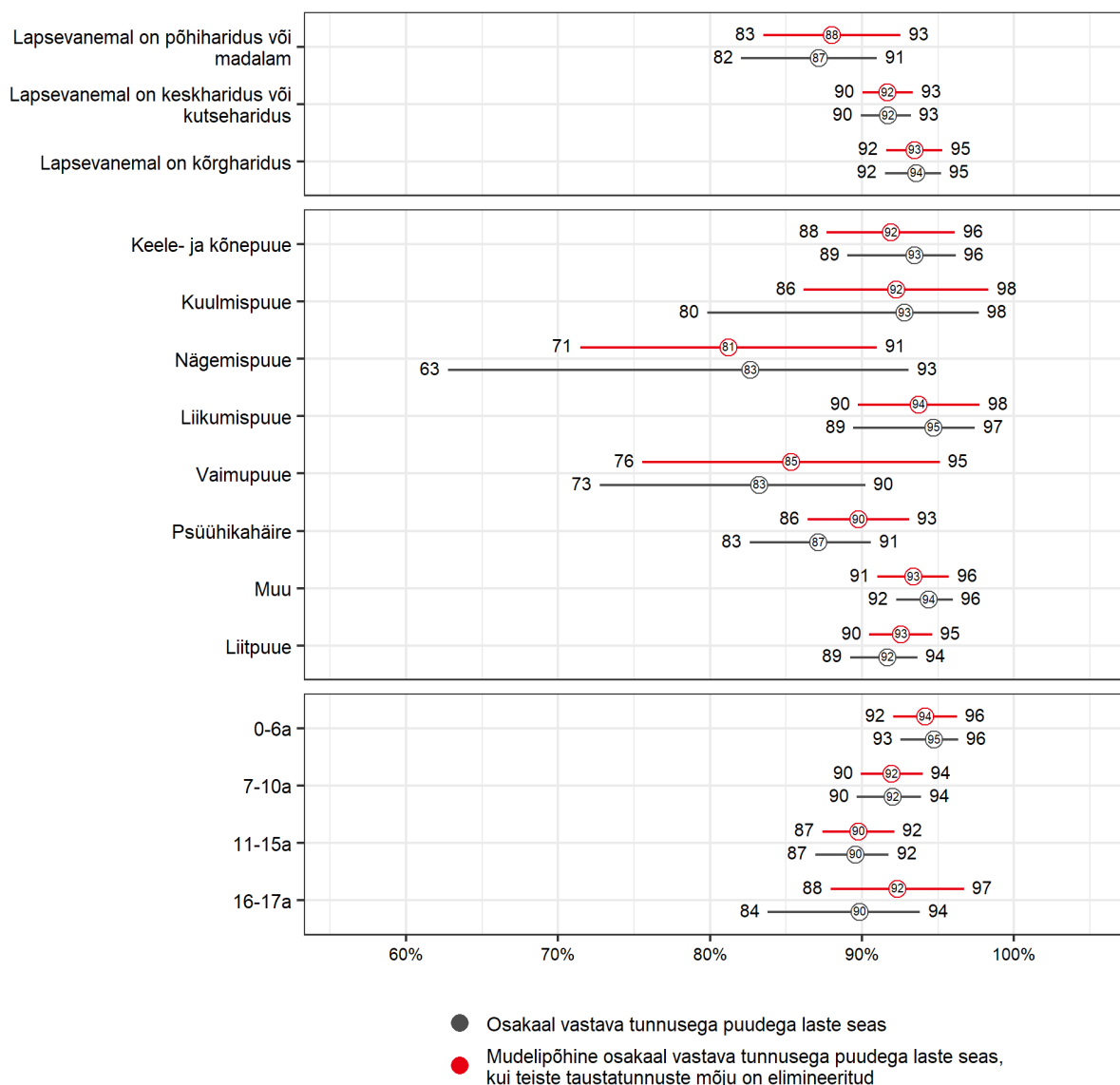
On mõned tunnused, mille lõikes esineb statistiliselt olulisi, kuid sisuliselt väikesi erinevusi perearsti vajavate laste osakaaludes. Sellised tunnused on puudeliik, lapse vanus ja vastaja haridustase (Joonis 51).

Puudeliikidest on perearsti vajanud laste osakaal statistiliselt oluliselt väiksem vaimupuudega (73–90%) ja psüühikahäirega (83–91%) lastel võrreldes muu puudega (92–96%) lastega.

Lapse vanuse kasvades perearstiteenust vajavate laste osakaal kahaneb: teenust vajab kõige suurem osakaal 0–6-aastaste vanusegrupist (93–96%), järgmistes gruppides on keskmine teenusevajajate osakaal väiksem. Statistiliselt oluline erinevus on noorima ja 11–15-aastaste vanusegrupi (87–92%) vahel. Vanuses 16–17 aastat on grupi väiksuse tõttu usalduspiirid laiad ja seetõttu ei eristu nad oluliselt muudest gruppidest.

Perearsti vajadust tajuvad kõrgharidusega vastanutest suurem osakaal (92–95%) kui põhi- või madalama haridusega vastanutest (82–91%).

Joonis 51. Puudega lapsed, kes on küsitlusele eelneval 12 kuul perearsti teenust kasutanud või ei ole kasutanud, kuigi oleks vajanud (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud; pole mitte kordagi viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, kuigi oleks teenust vajanud = 1, ei ole viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, sest pole teenust vajanud; ei oska öelda = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapsevanema haridustase, lapse puudeliik, lapse puude raskusaste, lapse sugu, lapse vanus, maakond, elukoha asula tüüp, kodune keel.

Vastajatel, kes märkisid, et laps ei kasutanud perearsti teenust viimase 12 kuu jooksul mitte kordagi (0,2 – 0,9% teenust vajanutest), kuigi oleks seda teenust vajanud, paluti seda põhjendada. Põhjused toodi välja kolme tüüpi probleeme (vabu vastuseid andis 7 inimest):

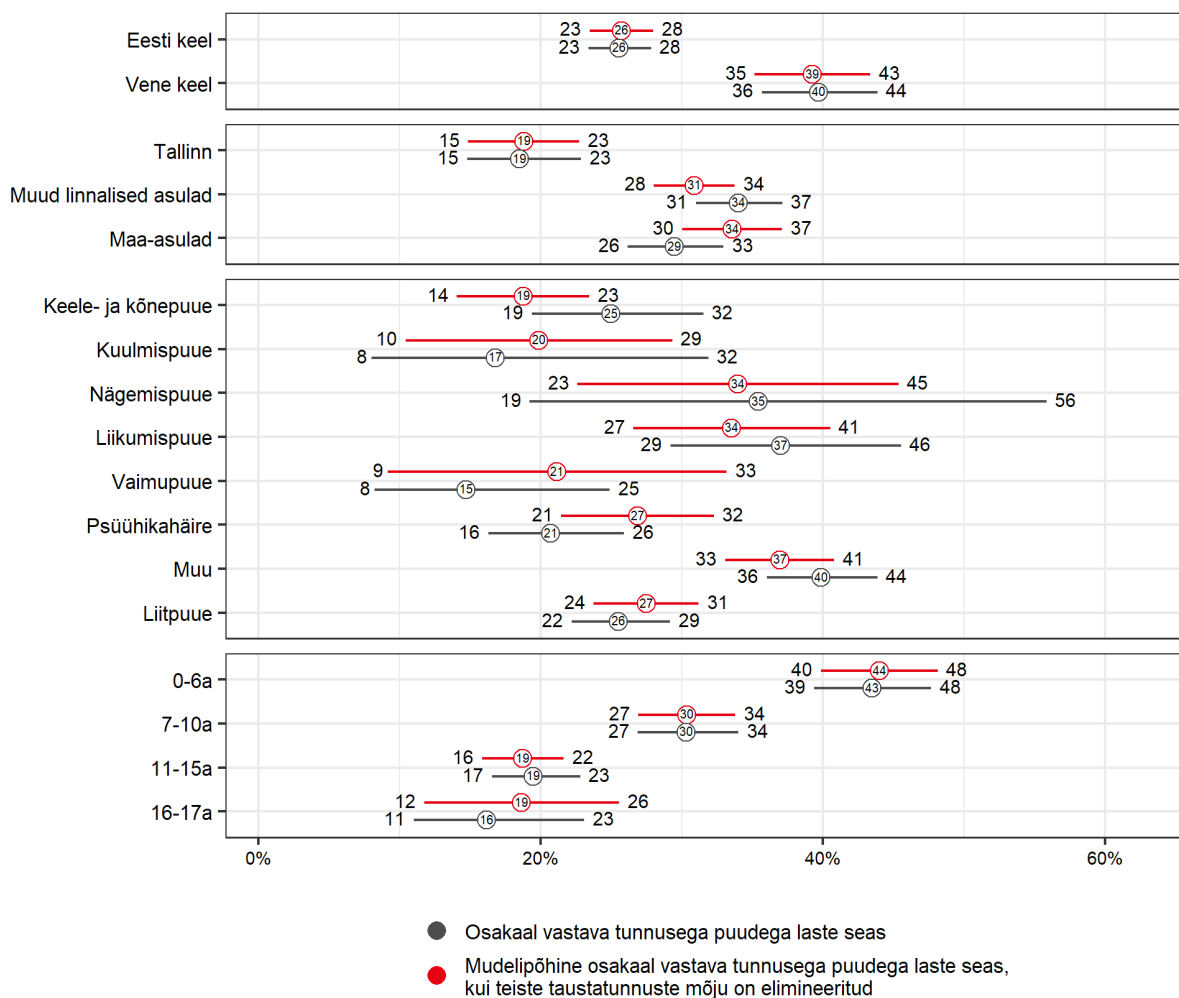
1. Raskused perearstiga kontakteerumisel,
2. Perearsti ei peeta pädevaks lapse probleemiga tegelema,
3. Lapsel on hirm arsti ees.

Tuvastamaks eriti sagedaste perearstikülastustega seonduvaid tegureid, võrreldi omavahel 6 ja enam korda perearsti külastanud nendega, kes kasutasid perearstiteenust harvem või üldse mitte, aga oleksid vajanud

perearsti teenust. Enam kui kuus korda külastas perearsti 28–32% kõikidest puudega lastest. Sagedase perearstiabi külastamisega seonduvad tunnused on lapse puude liik, lapse vanus, asulatüüp, maakond ja kodune keel (Joonis 52).

Perearsti külastavad kuus või enam korda aasta jooksul enamad muu puudeliigiga (36–44%) ja liikumispuudega (29–46%) lastest. Muu puudeliigiga lastest oluliselt harvem külastavad perearsti pea kõik ülejäänud grupid, v.a nägemispuudega (19–56%) lapsed, kelle puhul on usalduspiirid väga laiad ja seetõttu ei ole võimalik otsustada. Liikumispuudega lastest harvem külastavad perearsti psüühikahäirega (16–26%), vaimu- (8–25%) ja liitpuudega (22–29%) lapsed.

Joonis 52. Perearsti teenuse sageli (6 või rohkem kordi) kasutamine viimasel 12 kuul tasutatunnuste lõikes (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud 6 ja enam korda = 1; on viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud 5 ja vähem kordi; pole mitte kordagi viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, kuigi oleks teenust vajanud; ei vajanud teenust; ei oska öelda = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapsevanema haridustase, lapse puude liik, lapse puude raskusaste, lapse sugu, lapse vanus, elukoha maakond, elukoha asula tüüp, kodune keel.

Perearsti külastab 0–6-aastastest puudega lastest suurem osakaal (39–48%) kui vanematest (7-10-aastastest 27-34%, 11-15-aastastest 17-23% ja 16-17-aastastest 11-23%). Nooremate puudega laste seas on perearsti külastanutel suurem osakaal - tõenäoliselt samadel põhjustel, miks üldiselt nooremad lapsed käivad sagedamini perearsti juures. Seda nii sagedasema viirusnakkustesse haigestumise kui ka esimesel

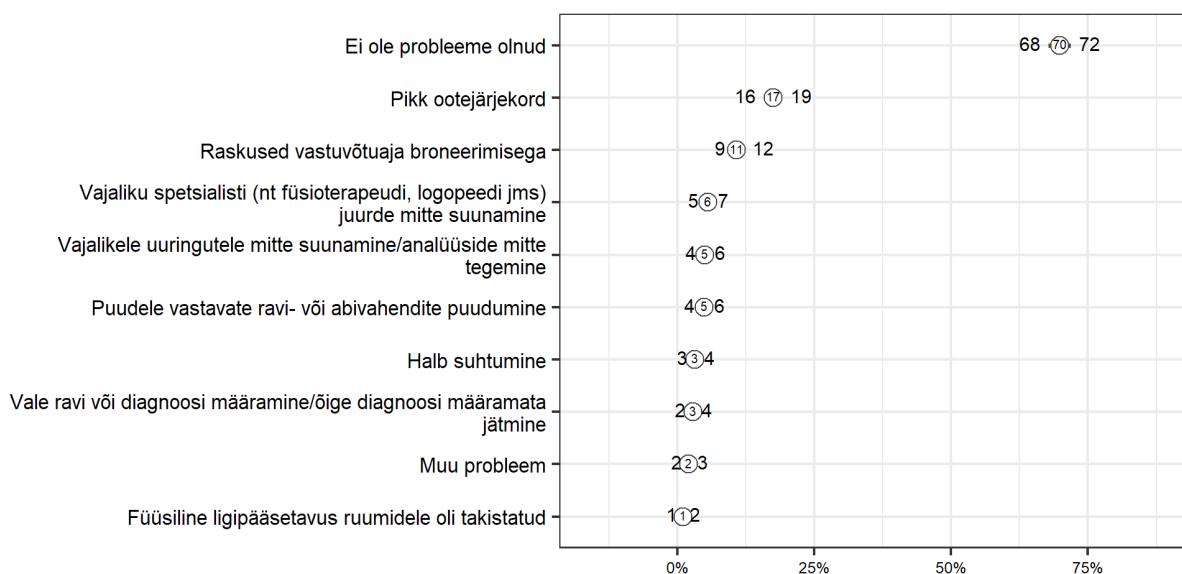
kolmel eluaastal toimuva tihedama lapse arengu korralise jälgimise ja vaktsineerimise külastuste²² tõttu. Sage perearsti külastamine väheneb lapse vanuse kasvades.

Tallinnas (15–23%) on perearsti kuus või enam korda aastas külastanud puudega laste osakaal suhteliselt väiksem kui muudes linnalistes asulates (31–37%) või maa-asulates (26–33%).

Venekeelsetest kodudest (36–44%) pärit puudega laste seas on perearsti kuus ja enam kordi aastas külastanud enam kui eestikeelsete kodude (23–28%) puudega laste seas.

Probleeme küsiti ainult nende käest, kes olid tervishoiuteenuseid kasutanud. Perearsti külastanutest 29–32%l esines teenusega seoses probleeme. Kõige sagedamini raporteeriti probleeme järjekorraga (16–19%) ja vastuvõtuaaja broneerimisega (9–12%), iga ülejäänud probleemi esines vähem kui 7%l külastanutest (Joonis 53).

Joonis 53. Perearstiteenusega seotud probleemide esinemine (% perearsti teenust viimasel 12 kuul kasutanud puudega lastest)



Ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

Lisaks etteantud loetelule oli vastajatel võimalik tuua välja ka muid probleeme, mis perearsti teenuse kasutamisel esines. Muid probleeme esines perearsti külastanutest 2–3%l. Probleeme kirjeldas 39 inimest, sealhulgas toodi korduvalt välja:

1. Vastuvõtuaeg on liiga lühike/arst on liiga hõivatud

“Liiga lühike vastuvõtuaeg. Arst tundus olevat ülekoormatud, kuigi ma ei saa öelda, et ta ise oleks olnud hoolimatu vms, aga oleksin soovinud rahulikumas õhkkonnas esitada küsimusi ja saada nõuannet.”

2. Perearstil puuduvad teadmised puudega lapse spetsiifilistel teemadel

“Tuginedes konsultatsioonidele erialaarstidega tundub, et perearst ei hinda ise tulenevalt erialaarstide poolt pakutavast lapse terviseinformatsioonist lapse üldist tervislikku seisundit adekvaatselt. Peame tihti ise küsima ravimeid ning täpsustama üle koguseid, ravimitüüpe, kuigi erialaarsti poolt on tihti vastav informatsioon perearstile kättesaadav. Vajalikud uuringud ja analüüsid ning muude spetsialistide poole suunamised oleme saanud erialaarstide kaudu, kus tihti imestatakse, et miks perearst ei ole seda juba varem teinud.”

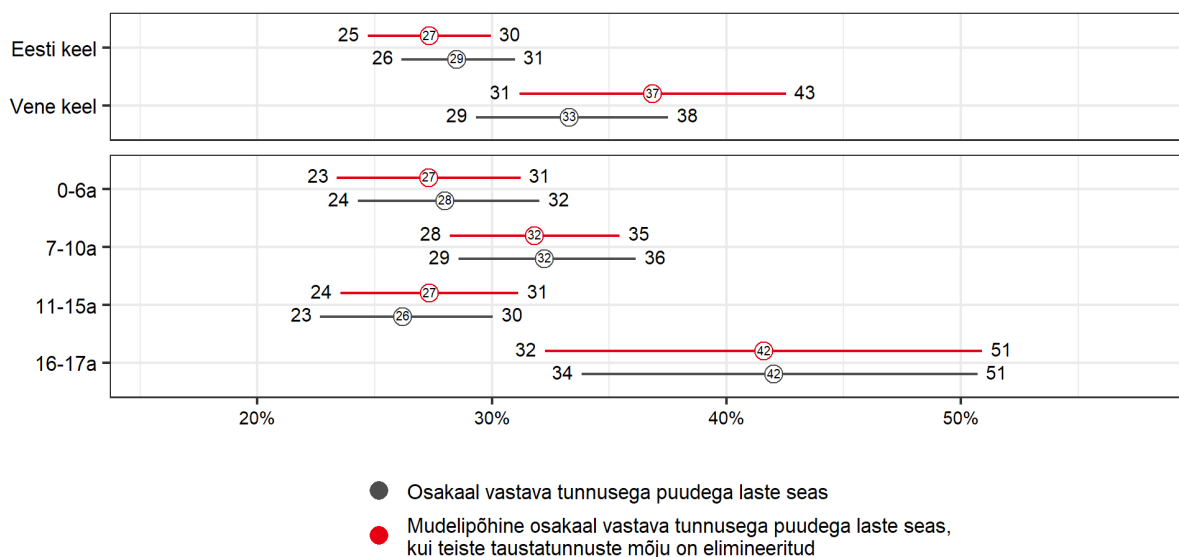
3. Analüüside vastuste teada saamine võtab kaua aega/vereproove saab teha harva/arsti enda teenus liiga harva

„Vereanalüüsi ei ole võimalik kiiresti anda, peab ootama mõned päevad, aga ka kuni nädal on olnud järjekord [...]. Arst peab (muude) sümptomite alusel alustama antibiootikumiravi[...]“

Lisaks mainiti veel järgmisi probleeme: probleemid auto parkimisega, viipekeele tõlgi leidmisega, probleem töölt ära saamisega, et arsti juurde minna, perearsti ja eriarsti vahelise infovahetusega.

Probleemide olemasolus esines statistiliselt olulisi erinevusi lapse vanusegrupi ja koduse keele lõikes (Joonis 54). Vanusegruppidest 16–17-aastastel (34–51% perearsti külastanutest) on oluliselt sagedamini probleeme kui 0–6 (24–32%) ja 11–15-aastastel (23–30%). Vene keelt koduse keelena kõnelevate laste seas on enam kui eesti keelt kõnelevate seas neid, kellel on perearstiteenusega probleeme esinenud. Erinevus ei paista välja, kui võrrelda lihtsalt osakaalusid vene ja eesti keelt koduse keelena kõnelevatest lastest (vastavalt 29-38% ja 26-31%). Statistiliselt oluline erinevus ilmneb, kui muude taustatunnuste mõju on elimineeritud.

Joonis 54. Perearstiteenusega seotud probleemide esinemine tasutatunnuste lõikes (% perearsti teenust viimasel 12 kuul kasutanud puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvaartuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud; teenusega on esinenud probleeme = 1, teenusega ei ole esinenud probleeme = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapsevanema haridustase, lapse puude liik, lapse puude raskusaste, lapse sugu, lapse vanus, elukoha maakond, elukoha asula tüüp, kodune keel.

Järgnevalt analüüsimine enim esinenud probleeme erinevate taustatunnuste lõikes. **Pikka ootejärjekorda** nimetasid probleemina 16–19% perearsti külastanutest. Olulisteks tunnusteks¹⁶, mille lõikes oli pika ootejärjekorraga erinevusi, olid puudeliik, lapse vanus, elukoha maakond ja kodune keel.

Eri puudeliikidega laste vahel küll väga suuri erinevusi probleemide esinemises ei olnud, kuid liikumispuudega lastel oli statistiliselt oluliselt vähem probleeme kui keele- ja kõnepuudega lastel.

¹⁶ Regressioonimudeli sõltuv muutuja: on olnud probleeme perearsti pika ootejärjekorraga = 1, ei ole olnud ootejärjekorraga probleeme = 0. Analüüsi on kaasatud vaid kõik need, kes on kasutanud perearstiteenust 12 kuu jooksul. Tulemuste kirjelduses kajastamata statistiliselt olulisi erinevusi mitte sisaldavad mudelisse lülitatud muutujad: lapse sugu, puude raskusaste, vastaja haridus, asula tüüp.

Vanuse puhul ühtset trendi probleemi esinemises ei ole, kuid 7–10-aastastel lastel esineb probleemi statistiliselt oluliselt sagedamini kui vanematel ja noorematel.

Kodus vene keelt kõnelevatel lastel on ootejärjekorraga statistiliselt oluliselt sagedamini probleeme, kuid erinevus ei ole väga suur.

Perearsti vastuvõtuaaja broneerimisega on probleeme 9–12% perearsti külastanutest. Probleemi esinemist kirjeldavatest taustatunnustest¹⁷ on statistiliselt olulised lapse vanus ja elukoha maakond. Nagu ka ootejärjekorra puhul, ei ole perearsti vastuvõtu broneerimisega probleemid seotud lapse vanusega lineaarselt, vaid probleemi esineb veidi rohkem lastel vanuses 7-10 ja 16-17. Erinevused on küll statistiliselt olulised, kuid sisuliselt väikesed. Ka maakonniti esineb broneerimisprobleemide osas varieeruvust, kuid usalduspiirid on gruppide väiksuse tõttu laiad, mistõttu on raske probleemsemaid maakondi esile tõsta.

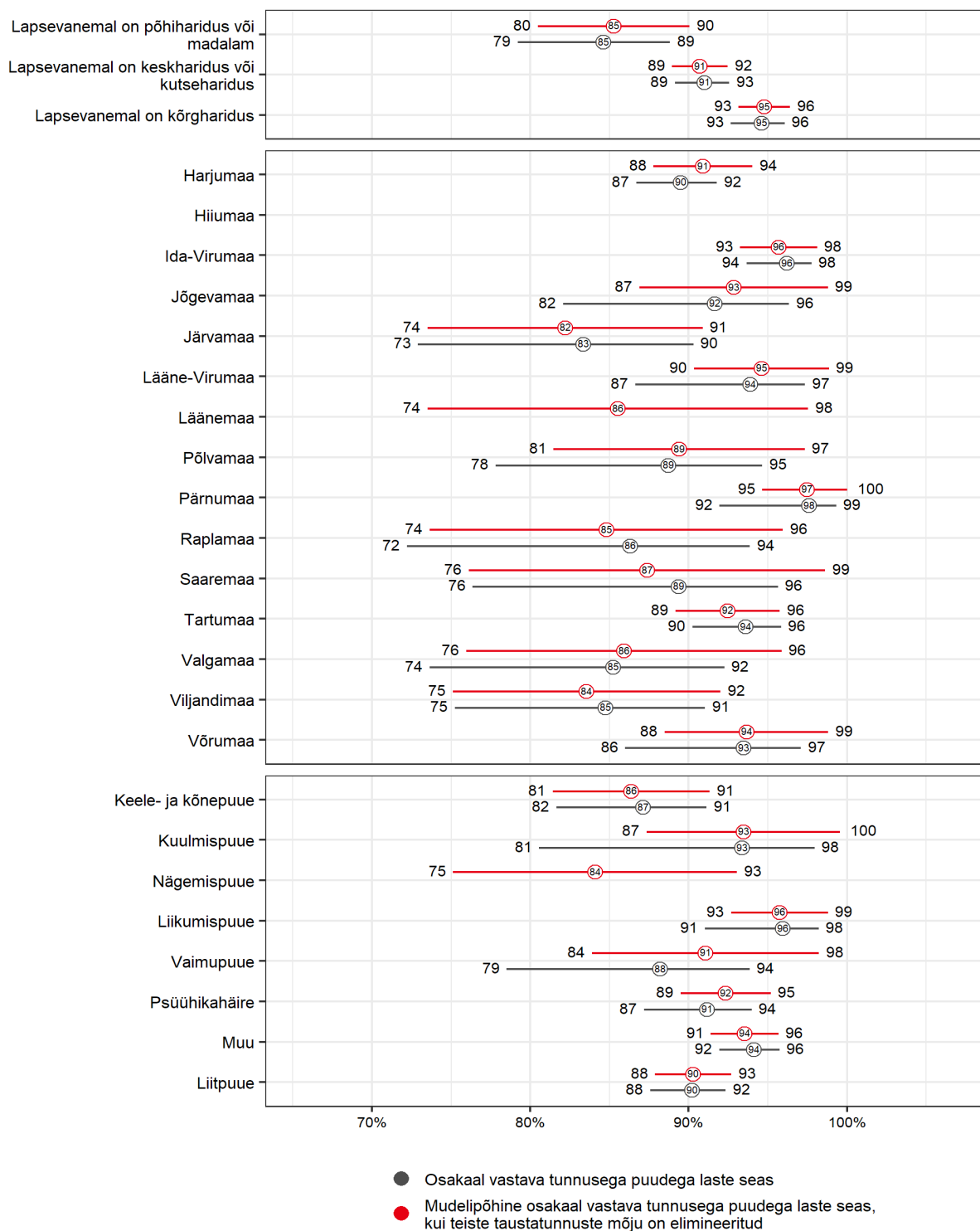
4.4 Eriarsti teenust vajanud laste osakaal, kasutamise sagedus ja teenusega seonduvad probleemid

Eriarstiabi teenust on puudega lastest kasutanud või vajanud, aga mitte saanud kasutada, viimase 12 kuu jooksul sama paljud kui perearsti, s.o 90–93% (Joonis 49). Ka eriarsti külastamise sagedus on sarnane perearstiga (Joonis 50). Neid, kes vastasid, et ei ole eriarstiabi vajanud, on väga vähe: vaid 5–7% puudega lastest. Olulised taustatunnused, mille lõikes esines statistiliselt olulisi erinevusi eriarstiabi vajanud laste osakaalus, on puudeliik, lapsevanema haridustase ja elukoha maakond (Joonis 55).

Puudeliikidest oli eriarsti vajanud laste osakaal liikumispuudega ja muu puudega laste seas (vastavalt 91–98% ja 92–96%) veidi suurem kui keele- ja kõnepuudega ja liitpuudega laste hulgas (vastavalt 82–91% ja 88–92%). Kõrgema haridustasemega vanemate seas on eriarsti vajanuid enam kui madalama haridustasemega vanemate seas, vastavad osakaalud haridustasemete gruppides kõrgemast madalamini on 93–96%, 89–93% ja 79–89% (Joonis 55). Oluline erinevus on maakondade vahel: Ida-Virumaal ja Pärnumaal on eriarstiabi vajajaid rohkem (vastavalt 94–98% ja 92–99%) kui Harju-, Järva- ja Viljandimaal (vastavalt 87–92%, 73–90% ja 75–91%), ülejäänud maakondade puhul on usalduspiirid sedavõrd laiad, et ei võimalda olulisi erisusi tuvastada.

¹⁷ Regressioonimudeli sõltuv muutuja: on olnud probleeme perearstile vastuvõtuaaja broneerimisega = 1, ei ole olnud probleemi = 0. Analüüsi on kaasatud vaid kõik need, kes on kasutanud perearstiteenust 12 kuu jooksul. Tulemuste kirjelduses kajastamata statistiliselt olulisi erinevusi mitte sisaldavad mudelisse lülitatud muutujad: lapse sugu, puude liik ja raskusaste, vastaja haridus, asula tüüp, kodune keel.

Joonis 55. Puudega lapsed, kes on küsitlusele eelneval 12 kuul eriarsti teenust kasutanud või ei ole kasutanud, kuigi oleks vajanud (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud; pole mitte kordagi viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, kuigi oleks teenust vajanud = 1, ei ole viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, sest pole teenust vajanud; ei oska öelda = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapsevanema haridustase, lapse puude liik, lapse puude raskusaste, lapse sugu, lapse vanus, elukoha maakond, elukoha asula tüüp, kodune keel.

Vaid 0,9–2% puudega lastest pole üldse saanud eriarsti teenust kasutada, kuigi vajasis seda. Põhjusena, miks eriarsti teenust ei saadud kasutatud, toodi välja järgnevaid asjaolusid (20 vastajat):

1. Pikk ootejärjekord

“Saime ühe aja 4 kuu pärast, laps oli sellel päeval haige.”

2. Ei saanud perearstilt suunamist eriarstile

“Perearst pole suunanud, pole aidanud vajaduse korral.”

3. Arst ei ole saanud lapsega head kontakti

“Lapsel väga negatiivne kogemus.”

“Arstid ei oska leida lapsega ühist keelt.”

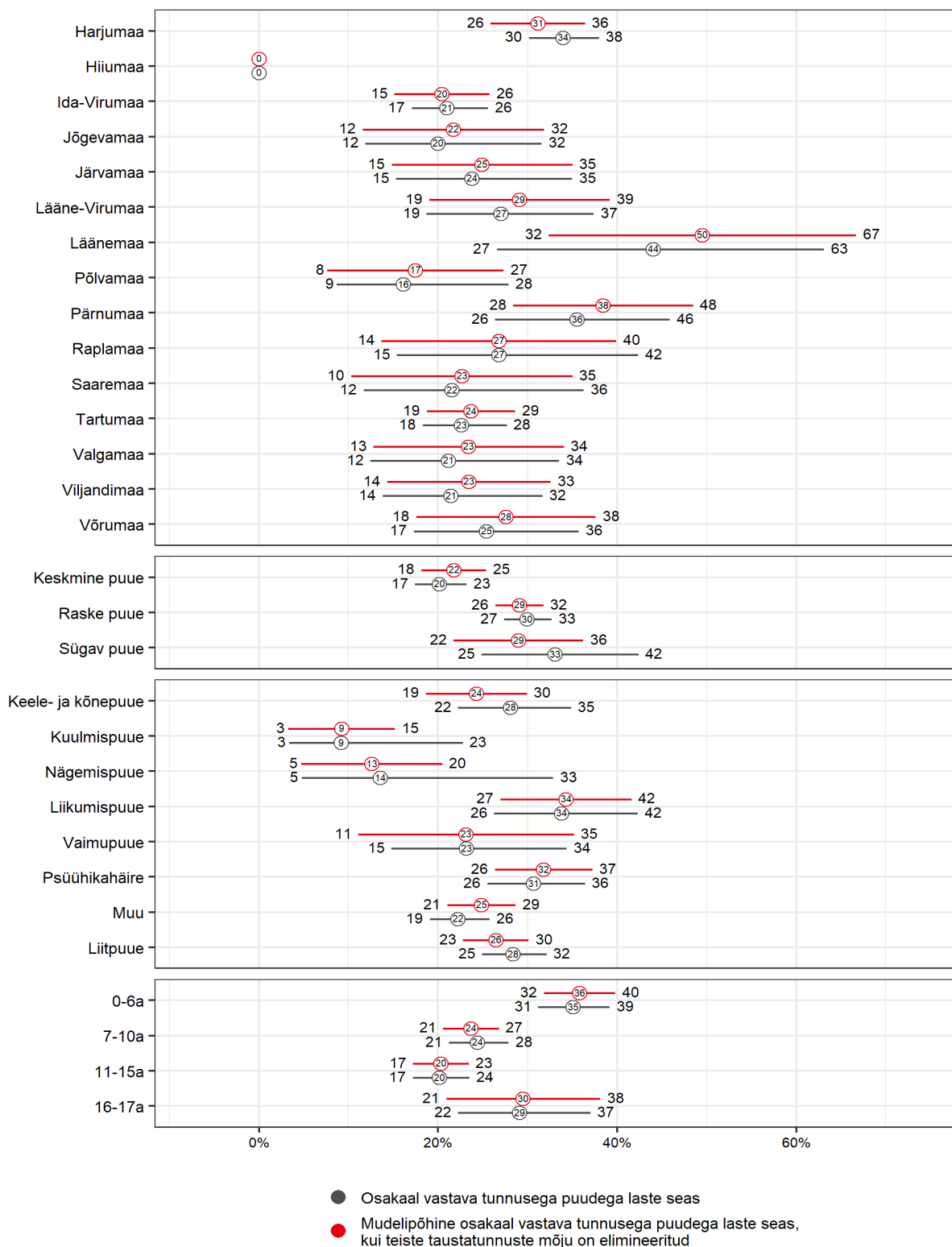
Eriarsti külastab sagedamini kui kuus korda aastas üle kolmandiku kõikidest puudega lastest (sh need, kellel polnud vaja teenust kasutada). Siinkohal tuleb küll silmas pidada, et vabades vastustes eriarstiga seotud probleemide kohta välja toodu põhjal võib järeldada, et osad vastajatest on mõelnud eriarstiabi all ka teatud rehabilitatsiooniteenuseid, nt logopeedi, mille kasutamise sagedus ongi tavaliselt suurem. Statistiliselt olulised eriarsti külastamise sagedust kirjeldavad taustatunnused on puudeliik, raskusaste ning lapse vanus (Joonis 56).

Eriarsti külastab sügava ja raske puudega lastest sageli suurem osa kui keskmise puudega lastest (vastavalt 25–42% ja 27–33% vs 17–23%). Kui võrrelda samade taustatunnustega lapsi, siis ei saa andmete põhjal kinnitada, et sügava puudega lastest vajavad eriarstiabi teenust sageli enamad kui raske või keskmise puudega lapsed. Siiski jääb alles sisuliselt väike erinevus keskmise ja raske puudega laste vahel. Ühesuguste taustatunnustega keskmise puudega laps kasutab eriarsti teenust kuus või enam korda aastas tõenäosusega 17–23% ja raske puudega laps 27–33%.

Puudeliikidest eristuvad kuulmispuudega lapsed, kellest 3–23% külastavad eriarsti rohkem kui kuus korda aastas. Nendega võrreldes on suurem osakaal liikumispuudega, psüühikahäirega ja liitpuudega lastel, kellest on eriarsti sageli külastanud vastavalt 26–42%, 26–36% ja 25–32%.

Eriarsti külastamise sagedus on seotud vanusega: noorimas vanuserühmas on eriarsti sageli külastavaid kõige enam (31–39%), 16–17-aastased ei eristu teistest vanusegruppidest laiate usalduspiiride tõttu (22–37%).

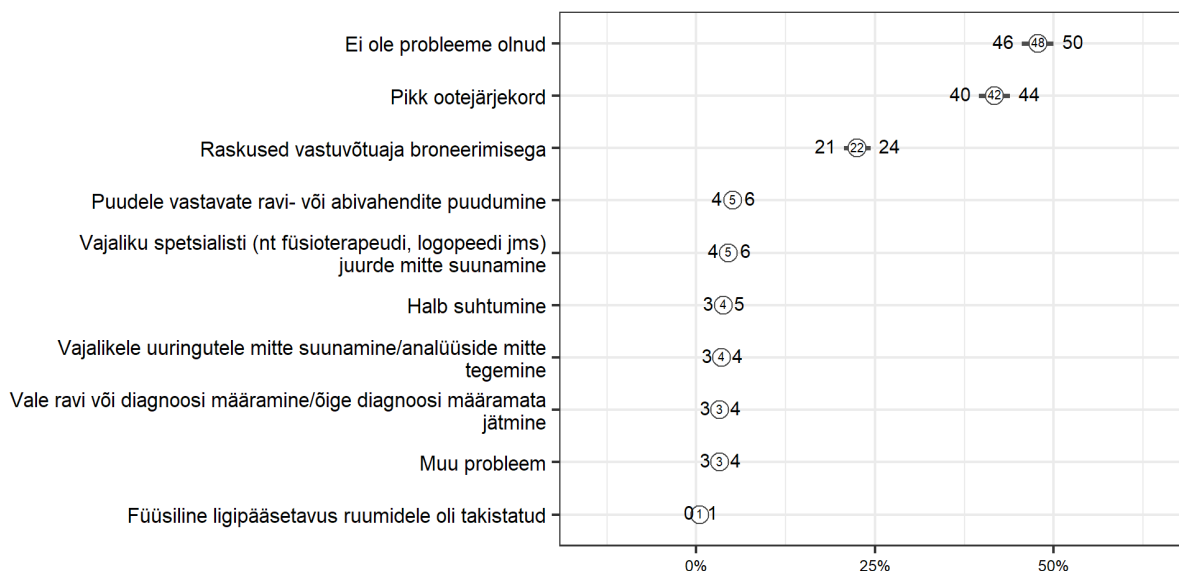
Joonis 56. Eriarsti teenuse sageli (6 või rohkem kordi) kasutamine (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud 6 ja enam korda = 1; on viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud 5 ja vähem kordi; pole mitte kordagi viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, kuigi oleks teenust vajanud, ei ole teenust kasutanud, sest ei vajanud ja ei oska öelda, kas vajas teenust = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapsevanema haridustase, lapse puude liik, lapse puude raskusaste, lapse sugu, lapse vanus, maakond, elukoha asula tüüp, kodune keel.

Ligi poolel eriarsti külastanud puudega lastest pole teenusega probleeme olnud (Joonis 57). Sarnaselt perearstiteenusega on probleemid seotud pigem vastuvõtule saamisega kui teenuse endaga. Kõige sagedamini nimetatud probleem on pikk ootejärjekord (40–44%), sageduselt teine on raskused vastuvõtutaja broneerimisega (21–24%). Iga ülejäänud probleemi nimetatakse juba palju harvem, alla 7% juhtudest. Kõige harvem oli probleemiks füüsiline juurdepääsetavus, alla 1%.

Joonis 57. Eriarsti teenusega seotud probleemide esinemine (% viimase eriarsti teenust kasutanud puudega lastest)



Ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

Muid probleeme nimetati viimase 12 kuu jooksul eriarsti vastuvõtul käinute poolt 56 korral (3–4%). Tuleb küll mainida, et neist 8 olid rehabilitatsiooniteenuste kohta. Sealhulgas töid vastajad välja:

1. Eriarst asub kaugel, kõik võtab palju aega ja raha

“Tartu Kliinikum ei ole spetsialiste, sellest lähtuvalt peab raviteenuseid saama 250km kauguselt.”

“Eriarstid on Tartus. Perel puudub isiklik transport, liikumine toimub ühistranspordiga.”

“Eriarst Tallinnas, tihti vaja käia, peame abikaasaga mõlemad vaba päeva võtma lisaks sõidukulu.”

2. Eriarstilt pole saadud abi – kas on haigus haruldane ja arstil pole selle osas piisavalt informatsiooni või ei olda veendunud arsti valitud ravimeetodi õigsuses.

“On ebanormaalne, et emad peavad oma harvikaigustega lapse ravimiseks leidma ise variante (arstid panevad lapsele diagnoosi ja siis sisuliselt jätavad su üksi) - jah suunatakse füsioterapeudi/logopeedi jne juurde, kuid sageli Eestis olemasolevatest meetoditest ei piisa, kuid keegi uusi meetodeid sulle pakkuma ei tule, ikka tuleb ise neid leida, kuid samas nende teenuste maksumust keegi ei korva (Haigekassa küll korvab, kui arstide konsilium nii otsustab, kuid tõden ausalt, minu jaoks pole olnud ebaneeldivat hetke, kui arstide konsilium ja rohkem ma sinna ei pöördu).”

“Ei ole kindel, kas valitud teraapiameetod oli lapse jaoks sobivaim”

3. Arst on liiga hõivatud, temalt ei saa vajadusel täiendavat infot. Näiteks:

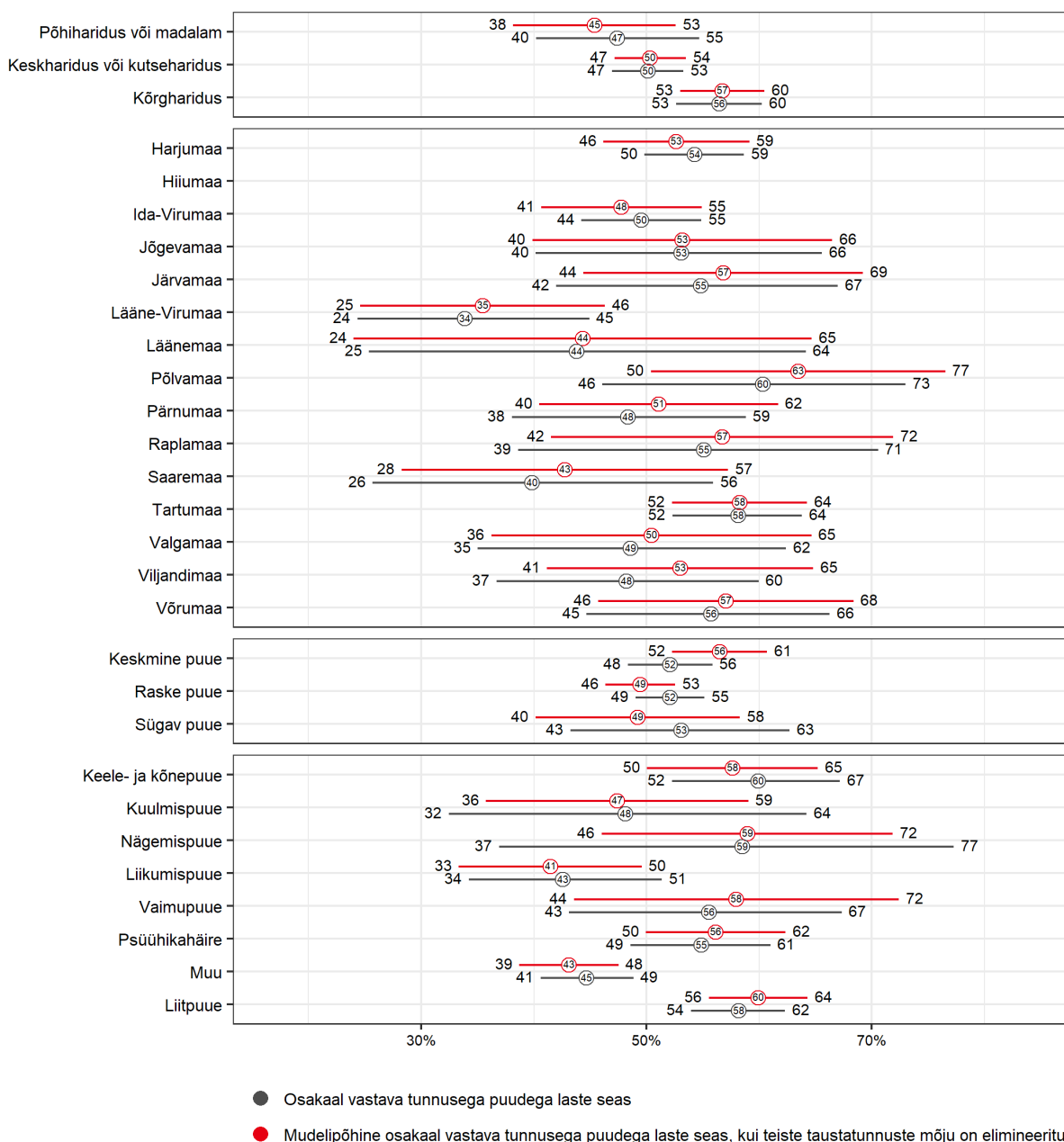
“Vahel, kui oleks vaja arstiga kiirelt kontakteeruda ja nõu küsida, pole see võimalik”,

“Eriarst tegeleb diagnoosimisega, aga ei anna suuniseid puudega toimetulekuks. Käime perioodiliselt lihtsalt oma käekäigust rääkimas, arst tagasisidet ja nõu tegelikult ei saa”.

Veel mainiti, et tervisest tulenevalt on lapsel raskusi arsti ukse taga järjekorras ootamisega, eriarsti vastuvõttu on raske klapiatada tõlgiga samale päevale (kuulmispuudega lapsel), analüüside tegemisel on pikad järjekorrad, puudub õige spetsialist, arst loobus lapse ravimisest, suunati vale spetsialisti jutule (täiskasvanutele spetsialiseerunud logopeedi).

Analüüsides, kelle seas oli rohkem neid, kellel esines probleeme, ilmnes olulisi erinevusi puude liigi ja raskusastme (mudelipõhiste osakaalude puhul), elukoha maakonna ja haridustaseme lõikes (Joonis 58).

Joonis 58. Eriarsti teenusega seotud probleemide esinemine taustatunnuste lõikes (% eriarsti teenust kasutanud puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud; teenusega on esinenud probleeme = 1, teenusega ei ole esinenud probleeme = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapsevanema haridustase, lapse puude liik, lapse puude raskusaste, lapse sugu, lapse vanus, elukoha maakond, elukoha asula tüüp, kodune keel.

Probleemidega kokku puutunud laste osakaalude vahel ei olnud olulist erinevust puude raskusastmete aspektist, kui vaadata lihtsalt erineva puude raskusastmega laste seas neid, kellel probleeme oli. Kui võrrelda ühesuguste taustatunnustega lapsi ja seeläbi elimineerida mudelisse kaasatud teiste taustatunnuste mõju, ilmneb, et keskmise puude korral on probleeme kohanud lastel suurem osakaal võrreldes raske puudega (vastavalt 52–61% ja 46–53%), sügava puude puhul ei ole laiade usalduspiiride tõttu erinevus endiselt oluline. Puudeliikidest oli probleemidega laste osakaal keele- ja kõnepuudega ja liitpuudega laste puhul (vastavalt 52–67% ja 54–62%) suurem kui liikumispuudega ja muu puudega laste puhul (vastavalt 34–51% ja 41–49%). Maakondade lõikes esineb statistiliselt olulisi erinevusi vähe. Välja saab tuua Lääne-Virumaa, kus eriarsti teenusega on probleeme esinenud oluliselt vähem (24–45%) kui Harjumaal, Põlvamaal, Tartumaal ja Võrumaal (vastavalt 50–59%, 46–73%, 52–64% ja 45–66%). Kõrgharidusega vastajad raporteerisid probleemide olemasolust oluliselt sagedamini (53–60%) kui kesk- või kutseharidusega (47–53%) ja põhi- või madalama haridusega (40–55%) vastajad.

Pikka ootejärjekorda pidas probleemiks 31–44% eriarsti külastanutest. Olulisi erinevusi probleemi¹⁸ esinemises esines puude liigi ja raskusastme, maakonna ja haridustaseme lõikes.

Puude raskusastmetest oli ootejärjekorraprobleemi esinenud keskmise puudega lastel enamatel võrreldes raske puudega lastega.

Puudeliikidest esines ootejärjekorraprobleemi keele- ja kõnepuudega, liitpuudega ja psüühikahäirega lastel enamatel kui muu ja liikumispuudega lastel.

Kõrgharidusega vastanud nendivad põhi- ja madalama haridustasemega vastanutest oluliselt sagedamini, et neil oli probleeme ootejärjekordade pikkusega.

Pea veerandil viimase 12 kuu jooksul eriarsti vastuvõtul käinutest oli probleeme **vastuvõtuaaja broneerimisega**. Erinevused ilmnesid¹⁹ puude liigi ja raskusastme, vanuse, elukoha maakonna, koduse keele ja vastanute haridustaseme lõikes.

Mida kergem puudeaste, seda keerulisem on vastuvõtuaega broneerida, puudeliikidest aga on broneerimisega probleeme muu, liikumis- ja kuulmispuude puhul harvem kui liitpuude, psüühikahäire ja keele- ja kõnepuude puhul.

Vanusegruppidest eristub 16–17-aastaste grupp, kelle seas on kõige suurem osakaal neid, kellel oli probleeme eriarstile aja broneerimisega. Võimalik, et tegemist on vanusega, mille puhul pole selget piiri, kas pöörduda laste või täiskasvanute spetsialisti poole.

Broneerimisprobleemide esinemine erineb ka vastaja haridustasemeti: mida kõrgem haridus, seda sagedamini on vastaja raporteerinud probleemi. Suhteliselt suur on ka erinevus probleemi esinemise sageduses eesti- (17–22%) ja venekeelsetest (25–36%) kodudest pärinevate laste vahel.

¹⁸ Regressioonimudeli sõltuv muutuja: on olnud probleeme eriarsti pika ootejärjekorraga = 1, ei ole olnud probleemi = 0. Analüüsi on kaasatud vaid kõik need, kes on kasutanud eriarstiteenust 12 kuu jooksul. Tekstis kajastamata statistiliselt olulisi erinevusi mitte sisaldavad mudelisse lülitatud muutujad: lapse sugu ja vanus, kodune keel, asula tüüp, maakond.

¹⁹ Regressioonimudeli sõltuv muutuja: on olnud probleeme eriarsti vastuvõtuaaja broneerimisega = 1, ei ole olnud probleemi = 0. Analüüsi on kaasatud vaid kõik need, kes on kasutanud eriarstiteenust 12 kuu jooksul. Tekstis kajastamata statistiliselt olulisi erinevusi mitte sisaldavad mudelisse lülitatud muutujad: lapse sugu, asula tüüp, maakond.

4.5 Erakorralise meditsiini teenuseid vajanud laste osakaal, kasutamise sagedus ja teenusega seonduvad probleemid

Erakorralise meditsiini teenuseid (kiirabi ja erakorralise meditsiini osakonna – EMO - teenust) on 12 kuu jooksul kasutanud või tajunud selle vajadust, aga mitte saanud kasutada 30–37% puudega lastest (Joonis 49)

Erakorralist abi vajanud laste osakaal on sügava puudega laste seas mõnevõrra suurem võrreldes keskmise ja raske puudega lastega (Joonis 59). Erinevus ei ole nii nähtav, kui vaadata erakorralise meditsiini teenust vajanud laste osakaalu lihtsalt puude raskusastmete lõikes (vastavalt 32-39% keskmise puude, 32-37% raske puude ja 35-54% sügava puudega lastest). Erinevus ilmneb selgemini, kui võrrelda muude samasuguste taustatunnustega lapsi. Sellisel juhul on samade tunnustega lastest, kellel on sügav puue, tõenäosus vajada erakorralise meditsiini teenuseid 36-53%, samas keskmise puudega lastest 30-37% ja raske puudega lastest 33-39%.

Puudeliikidest on erakorralist abi vajanud liikumis- (32–49%) ja muu puude liigiga (37–45%) laste seas teistest oluliselt rohkem kui keele- ja kõnepuudega (22-35%) laste seas.

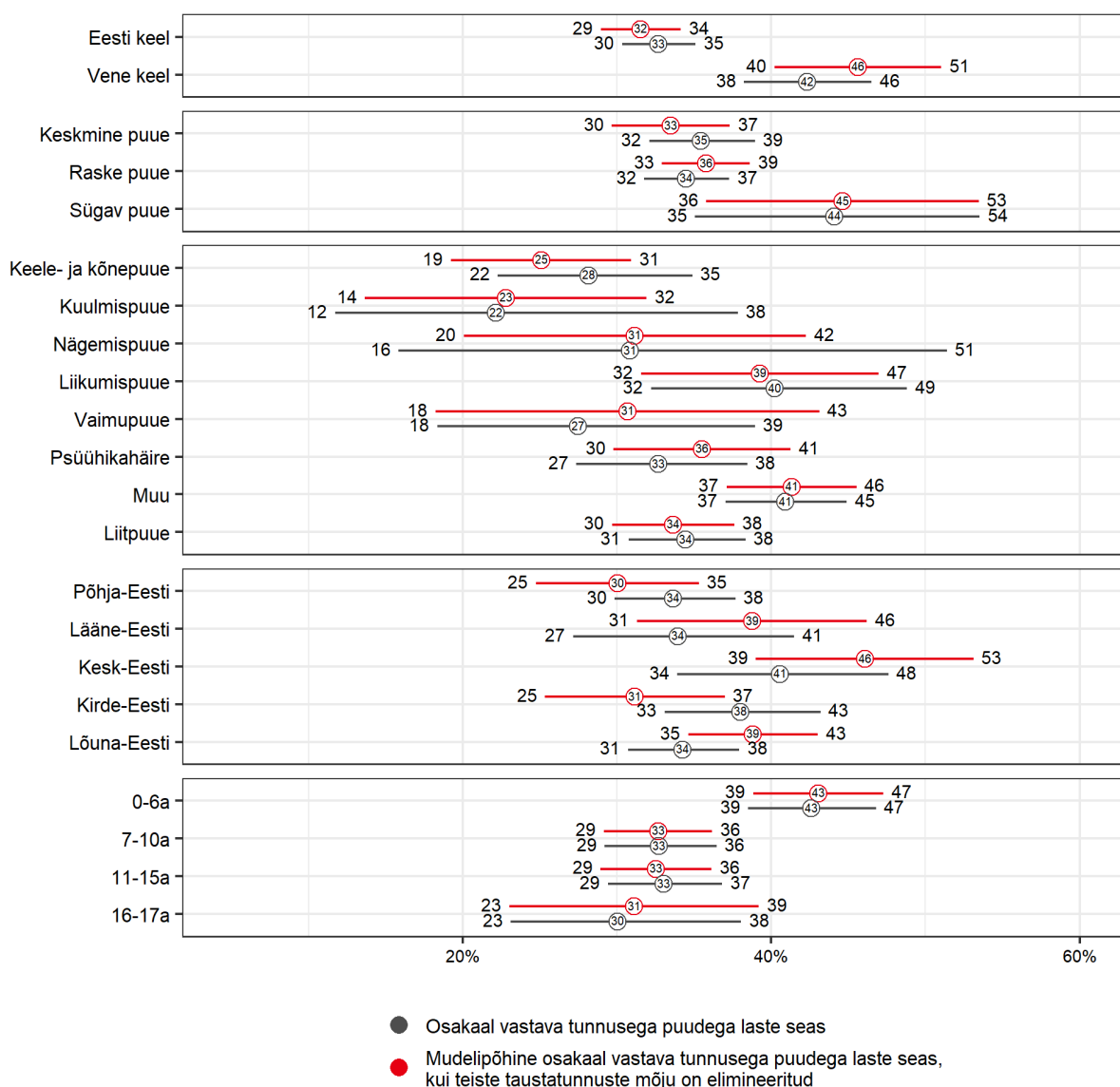
Vanuserühmadest on kõige suurem osakaal erakorralise meditsiini teenust vajanud lastel 0–6-aastaste grupis, kellest koguni 39– 47% on viimase aasta jooksul vähemalt ühe korra vajanud erakorralist meditsiinilist abi.

Huvitaval kombel on oluline erinevus ka eesti- ja venekeelsetes kodudes kasvavate laste vahel: viimaste seas on kiirabi või erakorralise meditsiini teenust vajanud oluliselt rohkem (38–46%, vrdl eestikeelsete seas 30-35%).

Regiooniti²⁰ ei erine erakorralise meditsiini teenust vajanud laste osakaal statistiliselt oluliselt. Siiski ilmnevad erinevused, kui võrrelda ühesuguste taustatunnustega lapsi. Mudelisse kaasatud taustatunnuste mõju elimineerides ilmneb, et oluliselt erinevad üksteisest Kesk-Eesti, kus on vajadus kõrgem, Põhja- ja Kirde-Eestist, kus vajadus teenuse järele on madalam.

²⁰ Erakorralise meditsiini teenuseid analüüsid kasutati taustatunnusena maakonna asemel suuremaid piirkondi (Tallinn, Harjumaa, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti) — kuna kiirabi teeninduspiirkonnad ei kattu maakonna piiridega, on kohasem kasutada suuremaid piirkondi.

Joonis 59. Puudega lapsed, kes on küsitlusele eelneval 12 kuul erakorralise meditsiini teenust kasutanud või ei ole kasutanud, kuigi oleks vajanud (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud; pole mitte kordagi viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, kuigi oleks teenust vajanud = 1, ei ole viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, sest pole teenust vajanud; ei oska öelda = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapsevanema haridustase, lapse puude liik, lapse puude raskusaste, lapse sugu, lapse vanus, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, kodune keel.

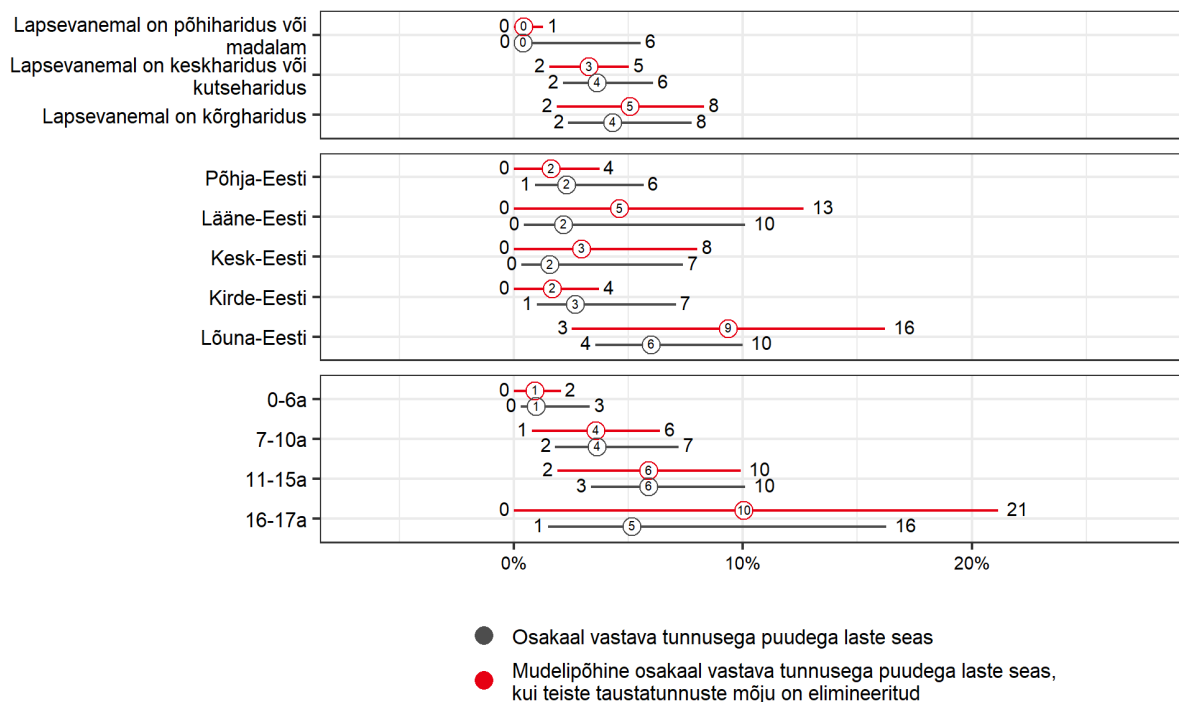
Vaid 2–5% erakorralise meditsiini teenuse vajadust tajunutest (nii teenust kasutanud kui ka vajadust tajunud, kuid mitte kasutanud) ei saanud teenust viimase 12 kuu jooksul mitte ühtegi korda kasutada (Joonis 50). Taustatunnustest on lapsevanema haridustaseme, elukoha maakonna ja lapse vanusegrupi lõikes statistilised erinevused, kuid erinevused on väikesed (Joonis 60).

Vanema haridustaseme lõikes esines olulisi erinevusi vaid siis, kui teiste taustatunnuste mõju on elimineeritud. Vanemaid, kes tunnetasid vajadust erakorralise meditsiini teenuste järele, aga ei saanud neid kasutada, oli põhi- või madalama haridusega vanemate seas 0-6%, kesk- või kutseharidusega vanemate seas 2-6% ja kõrgharidusega vanemate seas 2-8% - seega statistiliselt olulisi erinevusi ei ole. Ühesuguste

taustatunnustega lapsi võrreldes aga on neid, kes tajusid vajadust erakorralise meditsiini teenuste järele, kuid seda kordagi aasta jooksul ei kasutanud, vähem põhi- ja madalama haridustasemega vanemate hulgas (0-1% vrdl kesk- või kutseharidus 2-5% ja kõrgharidus 2-8%).

Vanusegruppidest eristusid oluliselt 0-6-aastased lapsed, kellest 0-3%. vajasisid erakorralist med abi, kuid ei olnud seda kordagi aasta jooksul saanud. 11-15-aastaste seas oli see osakaal mõnevõrra suurem: 3-10%.

Joonis 60. Erakorralise meditsiini mitte kasutanud puudega lapsed (% teenust vajanud puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: pole mitte kordagi viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, kuigi oleks teenust vajanud = 1, viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapsevanema haridustase, lapse puude liik, lapse puude raskusaste, lapse sugu, lapse vanus, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, kodune keel.

Põhjastena, miks erakorralise meditsiini teenust ei kasutatud, kuigi seda vajati, toodi välja (17 vastajat):

1. Saadi hakkama kas ise või telefonitsi saadud juhiste järgi

“Saime ise olukorra kontrolli alla”

“Üks kord olukord muutus tõsisemaks, kuid saime inhalaatori ja muude koduste vahendite abil hakkama”

“Transpordi puudumise tõttu saime juhiseid ja abi telefoni teel.....”.

2. Kuigi puudega lapse vanem pidas erakorralist abi hädavajalikuks, suunati laps siiski pere- või eriarsti juurde

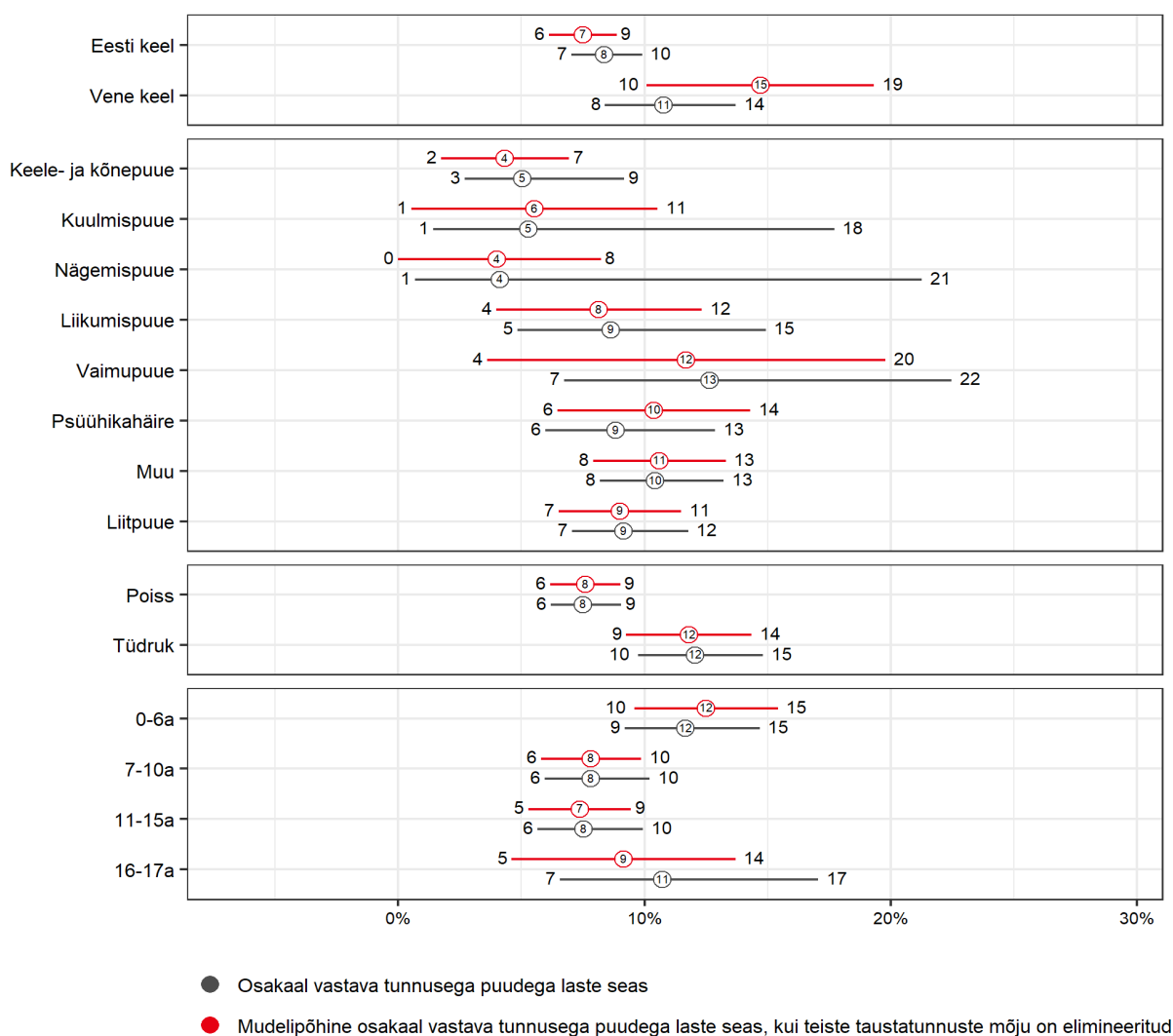
“Vaimse puude tõttu oleks vahel vajalik saata ta kiiremas korras haiglasse nt. lasteosakonda, eriti siis, kui laps hakkas rääkima enesetapumõtetest. Selle asemel suunati aga mitteohtlikuna näiv laps koju ja soovitati psühhiaatri aeg panna (lähim aeg 2+ kuud. erakliinikus sai 1 kuulise ooteajaga)”

“Kiirabisse helistasin kui lapsel tuli jälle kõrge palavik aga väga kiiresti jõudis üle 39 ja püsis. Palusin abi, aga soovitati anda rohtu ja pöörduda perearstile, kuna tegemist ilmselt kroonilise põletikuga. Järgmisel päeval läksime lapsega linna ja perearst andis saatekirja haiglasse.”

Küsitlusele eelnenud 12 kuu jooksul kolm ja enam korda erakorralist meditsiiniabi vajanud laste osakaal on suurem tüdrukute seas (10-15% puudega tüdrukutest) võrreldes poistega (6-9%), noorimas vanusegrupis (9-15%) võrreldes ülejäänutega (6-10% vanuses 7-10, 6-10% vanuses 11-15), venekeelsetes peredest võrreldes eestikeelsetega (vastavalt 8-14% ja 7-10%). Keele järgi ei ole suurt erinevust, kui ei võrdle ühesuguste taustatunnustega lapsi. Samade taustatunnustega on kolm või enam korda olnud vaja erakorralise meditsiini teenust kasutada eestikeelsetest peredest pärit puudega lastest 6-9% ja venekeelsetest 10-19%.

Puudeliikidest on sageli olnud vaja erakorralise meditsiini teenust kasutada psüühikahäirega (6-13%), liit- (7-12%) või muu puudega (8-13%) lastel enam võrreldes kuulmis- (1-18%), nägemis- (1-21%) ja keele- ja kõnepuudega (3-9%) lastega. Erinevused puudeliikide vahel ei paista välja, kui ei võrdle ühesuguste taustatunnustega lapsi (Joonis 61).

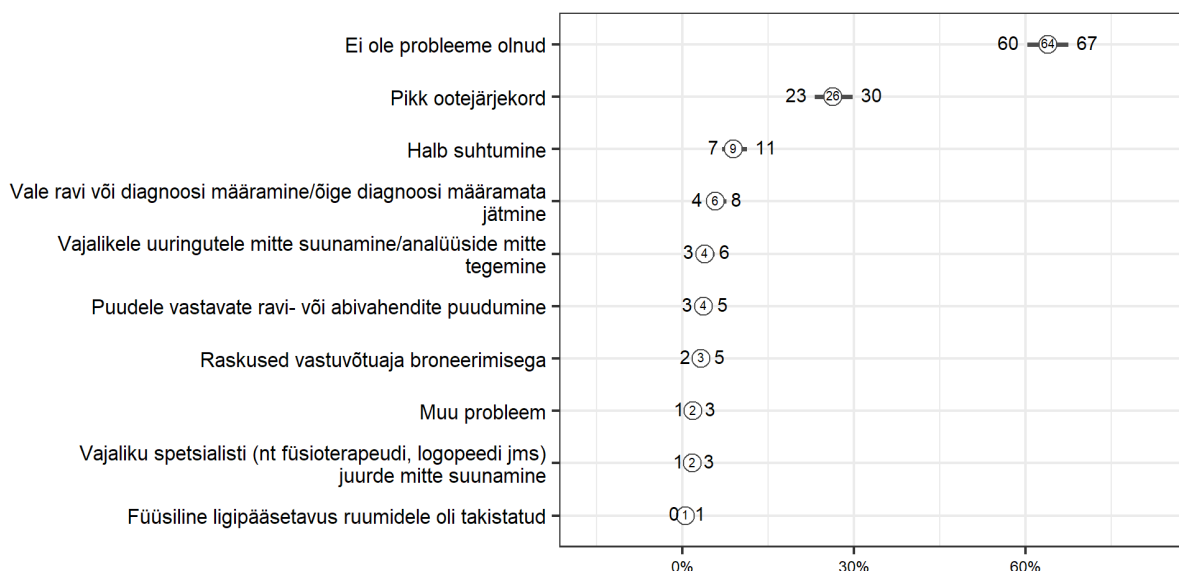
Joonis 61. Erakorraliste meditsiini teenuse sageli (3 või enam kordi) kasutamine (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud 3 ja enam korda = 1; on viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud 2 ja vähem kordi; pole mitte kordagi viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, kuigi oleks teenust vajanud = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapsevanema haridustase, lapse puude liik, lapse puude raskusaste, lapse sugu, lapse vanus, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, kodune keel.

Vastajatel, kelle puudega laps oli kasutanud viimase 12 kuu jooksul erakorralist meditsiiniabi (32–36%), paluti märkida, kas neil esines teenust kasutades probleeme (Joonis 62). Kõige enam oli selliseid, kellel ei esinenud ühtki probleemi (60-67%), pea kolmandikul oli ootejärjekord pikk (23-30%). Sageduselt järgmisena märgiti halba suhtumist, küll vaid 7–11 protsendil juhtudest; muude probleemide sagedus oli veelgi madalam. Probleemide esinemist ei saa seostada ühegi taustatunnusega, sest ükski uuritud teguritest ei olnud statistiliselt oluliselt probleemide olemasoluga seotud.

Joonis 62. Erakorralise meditsiini teenusega seotud probleemide esinemine (% viimase 12 kuu jooksul erakorralise meditsiini teenust kasutanud puudega lastest)



Ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Kõige sagedamini nimetati erakorraliste tervishoiuteenuste puhul probleemina **pikka ootejärjekorda**. Ainus tunnus, millega probleemi esinemine on seotud, on kodune keel. Nimelt esines venekeelsetest kodudest pärit laste seas probleemi 29–42%, eestikeelsetest kodudest pärit laste seas on see osakaal 18–26%.

Halba suhtumist esineb suhteliselt vähe ja grupi väiksuse tõttu ei ilmnenud enamuse taustatunnuste lõikes olulisi erinevusi. Ainus tunnus, mille lõikes erinevusi ilmses, kui vaadata samasuguste taustatunnustega lapsi, oli piirkond: Lääne-Eestis esines seda probleemi harvem kui Põhja-Eestis.

Lisaks ette antud loetelus olevatele probleemidele tõi vaid 1,1–3,1% teenust kasutanud puudega laste vanematest (14 vastanut) välja mõne muu probleemi, sealhulgas:

1. Erakorralise meditsiini töötajate oskamatus tegeleda puudega lastega

„Kiirabitöötajad ei oska pimedaga lapsega suhelda“

„Ei osata käituda vaimupuudega lapsega. Tal ei ole väliselt midagi aru saada ja selle tõttu on suhtumine olnud halb.“

2. Erakorralise meditsiiniabi haigustunnustega töötajaid peetakse nakkushaiguste levitajaks

„Suur nakkuste oht (sh ka meditsiinitöötajatelt). Kirurgi osakonnas või vaheintensiivis võis näha kõhivaid, aevastavaid töötajaid. Poolte haiglasolekute ajal laps haigestus mõnda viirushaigusesse.“

3. Kiirabi aeglus

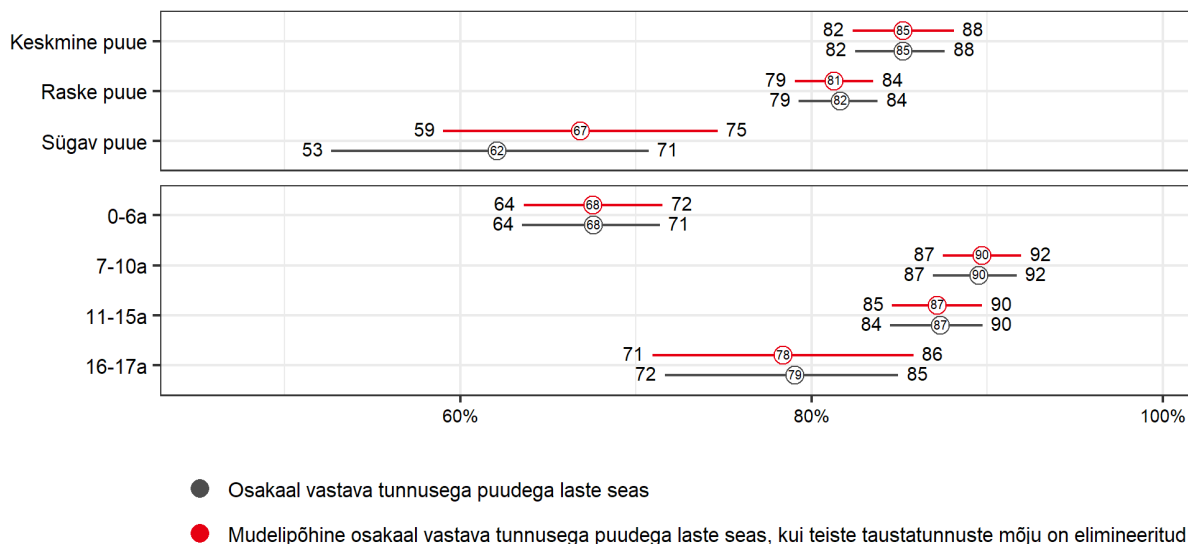
„Väga kaua võtab väljakutsele reageerimine aega. Ootasime 30 minutit. Kiirem on oma autoga sõita haiglasse kui midagi juhtub.“

4.6 Hambaravi vajanud laste osakaal, kasutamise sagedus ja teenusega seonduvad probleemid

Hambaraviteenust on aasta jooksul vajanud 80-83% puudega lastest (vt Joonis 49). Hambaravi vajadusega seonduvateks olulisteks tunnusteks on puude raskusaste ja laste vanus. Viimase lõikes esinevad erinevused on suured.

Hambaravi vajanud laste osakaal on tihedalt seotud puude raskusastmega: mida raskem puue, seda väiksem on laste osakaal, kelle vanem tajub, et lapsel oleks olnud vaja hambaravi. Kui keskmise puudega laste puhul vajas hambaraviteenust 82–88% lastest, siis sügava puude puhul tajus vajadust vaid 53–71% puudega laste vanematest. (Joonis 63).

Joonis 63. Puudega lapsed, kes on küsitlusele eelneval 12 kuul hambaravi teenust kasutanud või ei ole kasutanud, kuigi oleks vajanud (% puudega lastest)



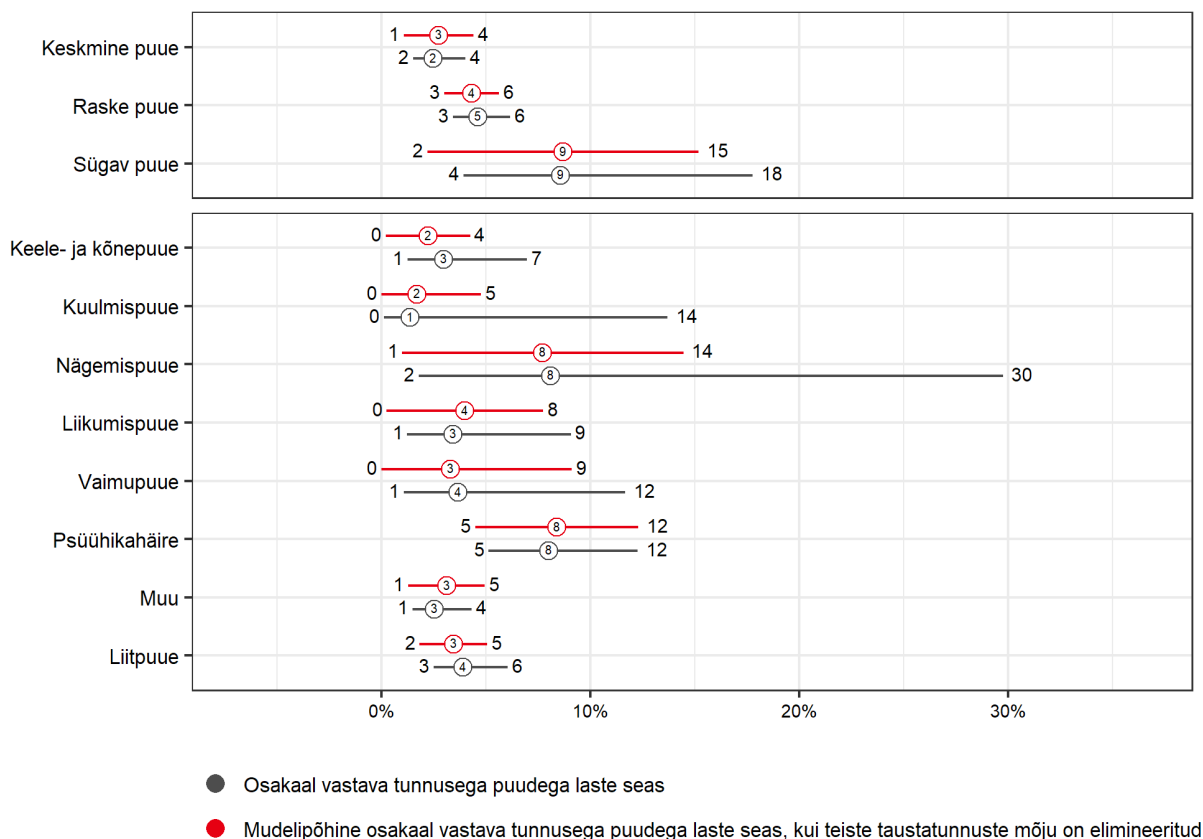
Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelpõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud; pole mitte kordagi viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, kuigi oleks teenust vajanud = 1, ei ole viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, sest pole teenust vajanud; ei oska öelda = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapsevanema haridustase, lapse puude liik, lapse puude raskusaste, lapse sugu, lapse vanus, elukoha maakond, elukoha asula tüüp, kodune keel.

Hambaravi vajadus sõltub lapse vanusest: kõige noorema vanusegrupi puhul tajub väiksem osakaal puudega laste vanematest, et lapsel oleks olnud vaja hambaravi (64–71%) kui vanemate vanusegruppide puhul (7-10-aastastest 87-92% 11-15-aastastest 84-90% ja 16-17-aastastest 72-85%). Väiksem osakaal vanematest, kes tajuvad noorima vanusegrupi puudega laste hambaravi vajadust, on sarnane kõigi Eesti laste hambaravi teenuse kasutamise näitajaga. Haigekassa statistikast kõigi Eesti laste kohta ilmneb, et 3-

aastaste laste seas oli 2016. aastal hambaarsti külastanud kõigest 40%, osakaal tõuseb edaspidistel aastatel²¹ ja järgmises vanusegrupis 7–10-aastaste seas on see üle 70%.²²

Vaid 3–5% lastest, kes hambaravi teenust kasutasid või ei kasutanud, kuigi oleks vajanud, ei ole saanud teenust mitte ühtegi korda viimase 12 kuu jooksul. Neid, kellel teenust oleks vaja, aga mingil põhjusel seda ei saanud, on statistiliselt oluliselt rohkem puudeliikidest psüühikahäirega (5–12%) võrreldes muu puude liigiga (1–4%) laste seas (Joonis 64), ülejäänud puude liigid ei erinenud laiade usalduspiiride tõttu. Samuti on teenust mitte saanud enam sügava (4–18%) võrreldes keskmise puudega (2–4%) laste seas.

Joonis 64. Hambaraviteenuse mitte saamine (% teenust vajanud puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: pole mitte kordagi viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, kuigi oleks teenust vajanud = 1, viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapsevanema haridustase, lapse puude liik, lapse puude raskusaste, lapse sugu, lapse vanus, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, kodune keel.

Vanematelt küsiti ka, mis põhjustel lapsed teenust ei saanud, kuigi nad oleksid seda vajanud. Põhjustena, miks hambaravi teenust ei saadud, kuigi seda vajati, toodi välja (61 vastajat):

²¹ Eesti Haigekassa majandusaasta aruanne 2016 (Joonis 13, lk 77) -

http://www.haigekassa.ee/sites/default/files/uuringud_aruanded/haigekassa_aruanne_2017_web.pdf

²² Perearstidel ja -õdedel on kohustus suunata hambaarsti profülaktilisele vastuvõtule lapsed vanuses 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15 aastat. (Sotsiaalministri määruse nr 2 «Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend» lisa. RT I, 26.01.2016, 7 <https://www.riigiteataja.ee/akt/126012016007>)

1. Hambaarsti juurde (sellise, kelle juurde saaks minna puudega lapsega/tasuta) on ressursi vähesuse (asub kaugel, võtab palju aega, kallis) tõttu raske minna

„Hiiumaal ei ole võimalik hambaarstile aegu saada, kõigil on juba omad patsiendid, juurde ei võeta. Puudega lapsega hambaarstil käimine ei ole väga lihtne protsess, lisaks mandrile sõit on ka raskendatud ja kulukas.“

„Elukoha lähedal pole sobivat teenusepakkujat ja peale tööaega on raske kaugemal linnas sobivat aega ja arsti leida. ...“

2. Puudest tulenevalt ei nõustu laps hambaraviga

„Johtuvalt puudest. Ideaalne oleks, kui intellekti- ja vaimsepuudega lastel/täiskasvanutel oleks kasvõi üks hambaravi kabinet linnas.“

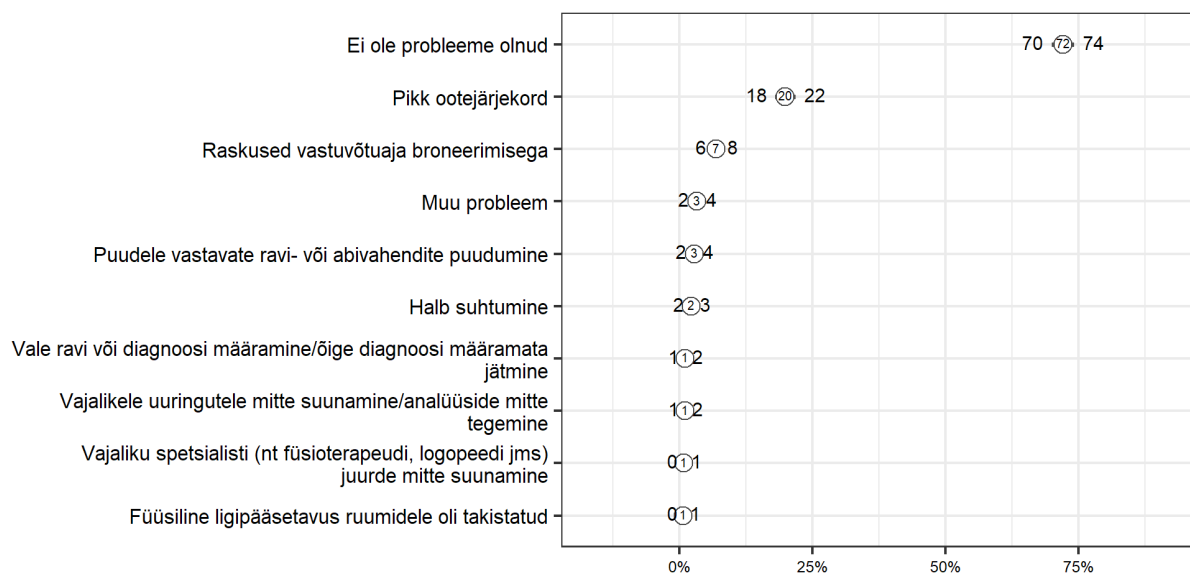
„Keeruline leida hambaarsti, kes suudaks töötada autistliku lapsega“; „Laps ei suuda paigal püsida ja seega igasugune koostöö on välistatud“

3. Lapsele saab hambaravi teha vaid narkoosi all, kuid sellele teenusele on pikad ootejärjekorrad

„Lapsel on vaja parandada hambaid narkoosi all, sellel teenusel on pikad ootejärjekorrad“

Enamikul puudega lastest, kes on hambaraviteenust kasutanud, pole sellega probleeme esinenud (70-74%) (Joonis 65). Probleemidest on kõige suurem osa puudega lapse vanematest kokku puutunud pika ootejärjekorraga (18-22%) ja raskustega vastuvõtutaja broneerimisel (6-8%). Ülejäänud probleeme esines vähem kui 5%l lastest, kes hambaravi teenust kasutasid.

Joonis 65. Hambaraviga seotud probleemide esinemine (% hambaravi teenust kasutanud puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Vähesel määral töid vastajad välja ka probleeme, mis polnud etteantud loetelus. Sealhulgas nimetati järgnevaid:

1. Hambaravi on liiga kallis, haigekassa finantseeritaval teenusel on liiga pikk järjekord, hambaravi visiiditasu on liiga suur

„Haiguse ja tema lõualuu erinevusega on vaja teha hambakaare laiendamine + breketid, haigekassa järjekord on nii pikk ning endal pole võimalik 6000 eurot selle eest maksta, et eraarsti juures seda läbi teha!”

2. Lapse hirm arsti ees, arst ei oska puudega lapsega suhelda, vähene teave probleemide lahendamise võimalustest

„Psühholoogiline abi hambaarstile minemiseks puudub, korra saadeti, aga sellest polnud mingit kasu, kuna see, mida psühholoog rääkis, see nulliti arsti juures taas ära.”

“Laps ei tee koostööd. Mitmeid kordi ei avanud suudki. Auke palju, kuid ravitud ei saa. Vajalik oleks kuidagi kõik korruga korda teha aga suunatud pole kuhugi.”

3. Puudub võimalus üldnarkoosis hambaraviks või selle järjekorrad on liiga pikad.

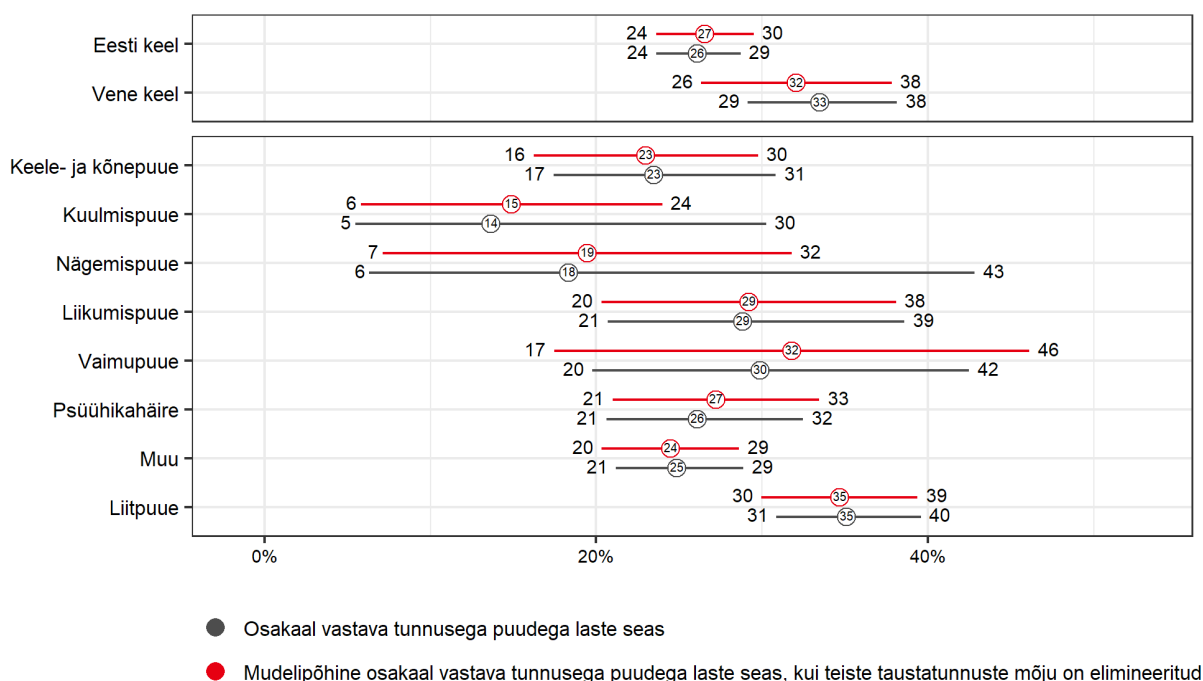
“Erivajadusega lastele on tihti vaja üldnarkoosis hambaravi teha. Tartus oli ooteaeg üldnarkoosis hambaravile aasta, pidime sõitma Tartust Tallinna ravile, seal oli ooteaeg 2 kuud. See oli kiirekorraline hambaravi järjekord.”

„Kõik on olnud enam-vähem, aga puudega lapsel, kel on selleks hädavajadus, peaks olema võimalus kiiremini pääseda narkoosis hamba kontrolli ja hambaravile. Kõnetu lapse puhul võib olla raske aru saada, et tal hammas teeb valu. Ei kujuta ette, kui selline laps peaks 2 kuud ootama, et tal suus probleemi uurima ja lahendama hakatakse.”

Üldnarkoosis hambaravi kättesaadavuse parandamine võiks olla lahenduseks ka muude lapse (puudest tingitud) psühholoogiliste hambaraviprobleemide puhul. Samuti oleks vaja teavitada vanemaid selle võimaluse olemasolust, kuna vastustest, nt “...vajalik oleks kuidagi kõik korruga korda teha aga suunatud pole kuhugi” ja „Laps keeldub suud avamast” paistab, et mõnikord ei osata seda võimalust soovida.

Peresid, kelle puudega lapsel pole olnud 12 kuu jooksul probleemi hambaraviga, on 70–74% (Joonis 65). Olulised erinevused probleemide olemasolus on seotud koduse keele ja puude liigiga (Joonis 66).

Joonis 66. Hambaravi teenusega seotud probleemide esinemine (% hambaravi teenust kasutanud puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvaartuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud; teenusega on esinenud probleeme = 1, teenusega ei ole esinenud probleeme = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapsevanema haridustase, lapse puude liik, lapse puude raskusaste, lapse sugu, lapse vanus, elukoha maakond, elukoha asula tüüp, kodune keel.

Venekeelsetest kodudest pärit lastel on olnud mõnevõrra enam probleeme hambaraviga (29–38%) võrreldes eestikeelsetest kodudest pärit lastega (24–29%). Seda erinevust selgitavad aga vene- ja eestikeelsete puudega laste erinevad taustatunnused. Kui võrrelda samasuguste taustatunnustega eesti- ja venekeelseid leibkondi, siis statistiliselt olulist erinevust pole. Puudeliikidest esines probleeme liitpuudega lastel oluliselt enam (31–40%) võrreldes keele- ja kõne-, kuulmis- ja muu puudega lastega (17–31%, 5–30% ja 21–29%).

Pikka ootejärjekorda nimetatakse hambaravi puhul probleemseks 18–22% hambaravi kasutanud puudega laste puhul. Ainsaks taustatunnuseks²³, mille lõikes esineb olulist varieeruvust ootejärjekorra probleemiga, on elukoha maakond. Võrumaal esineb probleemi sagedamini kui Harjumaal, Pärnumaal ja Saaremaal.

Vastuvõtuaia broneerimisega esines viimase aasta jooksul enne küsitlust raskusi keskmiselt 6–8% hambaraviteenust kasutanud lastest. Ainsate oluliste tunnustena²⁴ mõjutasid broneerimise probleeme

²³ Regressioonimudeli sõltuv muutuja: on olnud probleeme hambaarsti pika ootejärjekorraga = 1, ei ole olnud probleemi = 0. Analüüsi on kaasatud vaid kõik need, kes on kasutanud hambaarstiteenust 12 kuu jooksul. Tekstis kajastamata statistiliselt olulisi erinevusi mitte sisaldavad mudelisse lülitatud muutujad: lapse sugu ja vanus, puude liik ja raskusaste, vastaja haridus, asula tüüp, kodune keel.

²⁴ Regressioonimudeli sõltuv muutuja: on olnud probleeme hambaarsti vastuvõtuaia broneerimisega = 1, ei ole olnud probleemi = 0. Analüüsi on kaasatud vaid kõik need, kes on kasutanud hambaarstiteenust 12 kuu jooksul. Tekstis kajastamata statistiliselt olulisi erinevusi mitte sisaldavad mudelisse lülitatud muutujad: lapse sugu ja vanus, puude liik ja raskusaste, vastaja haridus, asula tüüp.

kodune keel ja elukoht. Nimelt esines probleeme Võrumaal ja Tartumaal vähem kui Harjumaal. Venekeelsetel peredel esines broneerimisega enam probleeme kui eestikeelsetel.

4.7 Haiglaravi vajanud laste osakaal, kasutamise sagedus ja teenusega seonduvad probleemid

Haiglaravi vajas viimase 12 kuu jooksul 30–33% puudega lastest (Joonis 49). Haiglaravi puhul esineb tervisteenustest kõige sagedamini olukorda, kus tajuti teenuse vajadust, kuid seda ei saadud üldse: 5–8% teenuse vajajatest. Haiglaravi vajaduses on kõige enam varieeruvust puude liigiti ja raskusastmeti, kuid ka kodune keel ja vanusegrupp on seotud haiglaravi vajadusega (Joonis 67).

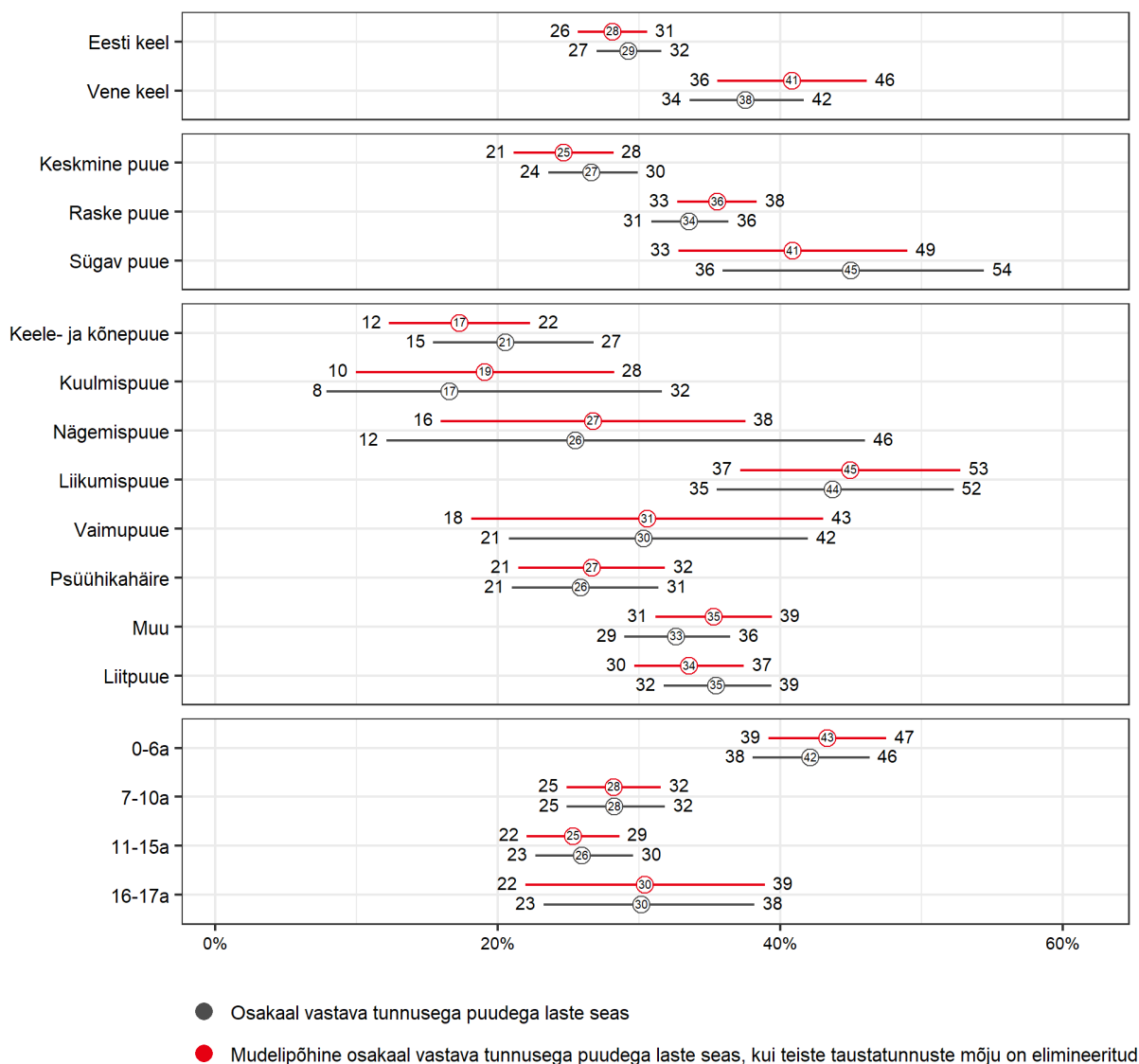
Haiglaravi vajab suurim osakaal liikumispuudega lastest (35–52%). Samuti on lastel, kes vajasisid haiglaravi, muu ja liitpuudega laste seas (29–36% ja 32–39%) mõnevõrra suurem osakaal kui keele- ja kõnepuudega (15–27%), kuulmispuudega (8–32%) ja psüühikahäirega (21–31%) lastel. Nägemispuudega (12–46%) ja vaimupuudega (21–42%) lapsed ei eristu eelnimetatud puudeliikidega lastest laiate usalduspiiride tõttu.

Puude raskusastme seos haiglaravi vajanud laste osakaaluga on samuti loogiline: sügava puude puhul on haiglaravi vajajate osakaal suurem (36–54%) kui keskmise puude puhul (24–30%). Raske puue ei eristu kummastki ülejäänust, kuid samasuguste taustatunnustega lapsi võrreldes on selle grupi haiglaravi vajadus oluliselt suurem keskmise puudega laste omast ja ei erine oluliselt sügavast.

Ootuspärane on, et noorima vanusegrupi lastest vajab suurem osakaal haiglaravi (38–46%) kui 7-aastastest ja vanematest (vastavalt 7–10-aastastest 25–32%, 11–15-aastastest 23–30% ja 16–17-aastastest 23–38%) (Joonis 67). Sarnane muster esineb vaadates kõigi Eesti laste haiglaravil viibimiste statistikat²⁵: 0–4-aastaste seas 24%, 5 – 9-aastaste seas 8%, 10 – 14-aastaste seas 7,5%. Kuigi tegemist on ravil viibimiste statistikaga, st mõni laps võib olla loetud mitu korda, samuti ei ole siin, erinevalt puuetega laste näitajast, neid, kes vajasisid haiglaravi, aga seda mingil põhjusel ei saanud, on osakaalud märkimisväärselt väiksemad kui ainult puudega laste puhul.

²⁵Haiglaravil viibinute osakaal kõigist Eesti lastest vanusegruppide lõikes on arvatud TAI tabeli PH01: Haiglast lahkunud ravi põhjuse, ravitüübi, soo ja vanuserühma järgi (http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/pxweb/et/03Tervishoiuteenused/03Tervishoiuteenused__02Paevaravi/PH01.px) ja Statistikaameti tabeli RV021: Rahvastik soo ja vanuserühma järgi, 1. jaanuar põhjal (<http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=RV0211#>). Haiglast lahkunute statistikas võib mõni laps olla topelt, kui ta on viibinud haiglaravil mitu korda..

Joonis 67. Puudega lapsed, kes on küsitlusele eelneval 12 kuul hambaravi teenust kasutanud või ei ole kasutanud, kuigi oleks vajanud (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud; pole mitte kordagi viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, kuigi oleks teenust vajanud = 1, ei ole viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, sest pole teenust vajanud; ei oska öelda = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapsevanema haridustase, lapse puude liik, lapse puude raskusaste, lapse sugu, lapse vanus, elukoha maakond, elukoha asula tüüp, kodune keel.

Venekeelsetes peredes vajas küsitlusele eelnenud 12 kuu jooksul haiglaravi oluliselt enam puudega lapsi kui eestikeelsetes peredes, vastavad osakaalud on 34–42% ja 27–32% (Joonis 67).

Haiglaravi vajadust tajunud puudega lastest oli 5-8% selliseid, kes ei saanud küsitlusele eelneva aasta jooksul kordagi teenust kasutada (Joonis 50). Taustatunnuste lõikes olulisi erisusi ei saa tuvastada, kuna vaatluste vähesuse tõttu olid usalduspiirid kas väga laiad või puudusid vaatlused üldse.

Vanematelt küsiti, mis põhjustel lapsed teenust ei saanud, kuigi nad oleksid seda vajanud. Põhjustena, miks haiglaravi ei saadud, kuigi seda vajati, toodi välja (26 vastajat):

1. Haiglakohtadele on pikad ootejärjekorrad

„Pikad ooteajad“

2. Raviti ambulatoorselt (vanemate poolt nii positiivset kui negatiivset seisukohta selle otsuse õigsuse kohta)

„Leiti, et on võimalik ka ambulatoorselt ravida.“

„Laps saadeti tagasi, st. haigla ei võtnud vastu, kuna valvearsti hinnangul laps ei vajanud haiglaravi ja räägib tühja.“

3. Laps ei soovi haiglasse minna

„Laps oleks pidanud vaimse tervise seisundi tõttu Seewaldisse - haiglasse sisse minema kuid , laps ei olnud nõus seal olema.“

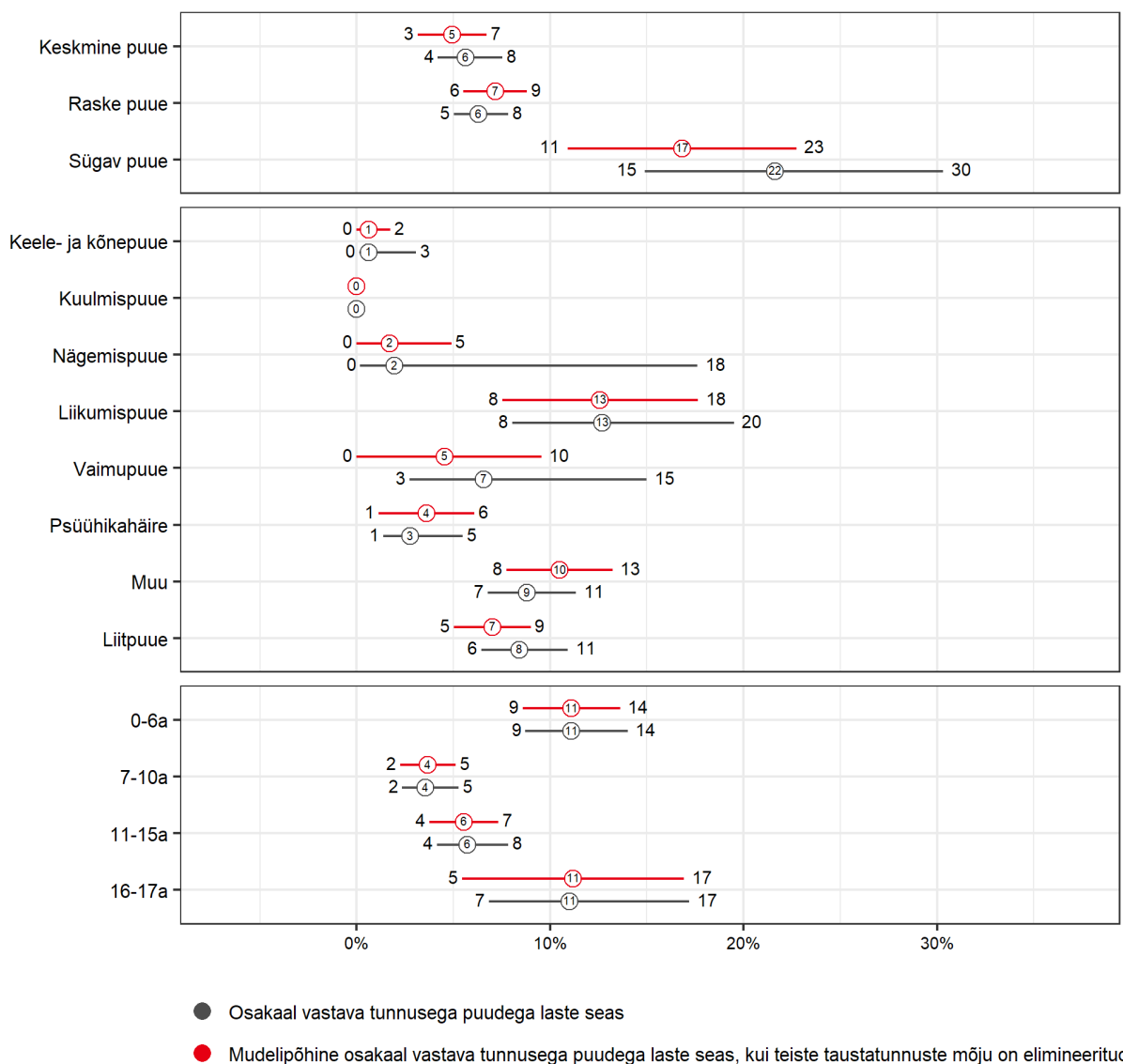
„laps ei soovi haiglasse minna ja sundida ma ei taha teda ka.“

Analüüsides sageli haiglaravil olemisega seotud taustatunnuseid, võrreldi viimase aasta jooksul 3 ja enam korda haiglaravil olnuid kõigi puudega lastega. Oluliselt eristuvad sageli haiglaravil olijad puude liigi, raskusastme ja vanuse lõikes (Joonis 68). Enam vajasid sageli haiglaravi sügava puudega lapsed (15–30%) võrreldes muude raskusastmetega (vastavalt keskmise puudega lastest 4-8% ja raske puudega lastest 5-8%).

Puude liikidest vajasid haiglaravi sageli liikumis-, liit- ja muu puudega lastest vastavalt 8–20%, 7–11% ja 8–11%. Neist harvem vajasid enam kui kolm korda aasta jooksul haiglaravi keele- ja kõnepuudega ning psüühikahäirega lapsed, vastavalt 0–3% ja 1–5%.

Vanusegruppidest on haiglaravi sageli vajavaid 0–6-aastaste seas oluliselt enam kui 7–15-aastaste seas (vastavalt 0-6-aastaste seas 9–14% vs 7-10-aastaste seas 2–5% ja 11-15-aastaste seas 4–8%).

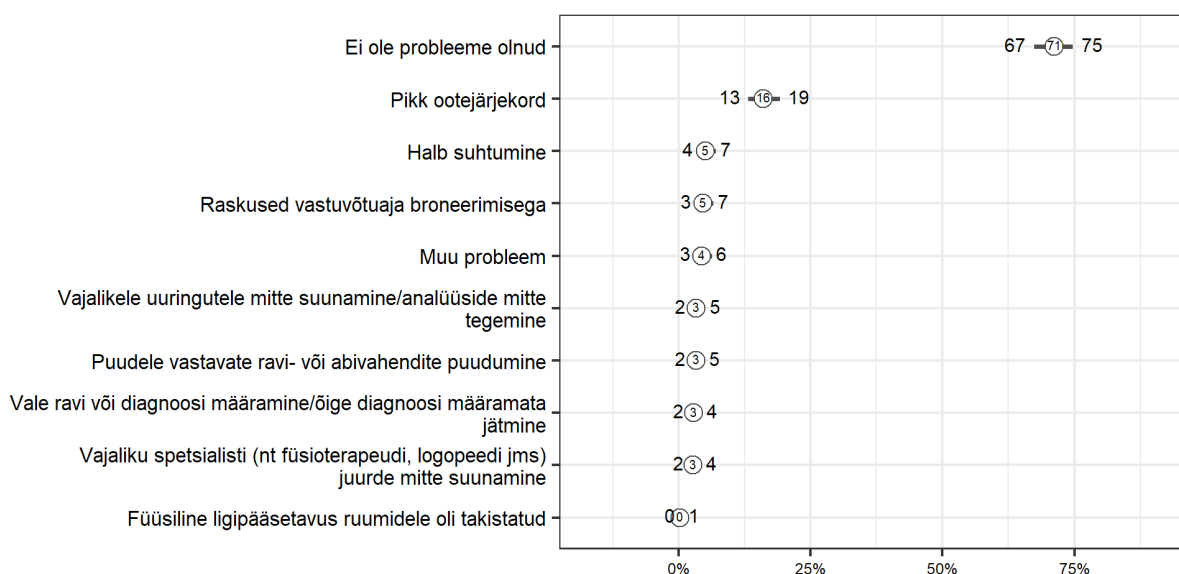
Joonis 68. Haiglaravil sageli (3 või enam kordi) viibimine (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud 3 ja enam korda = 1; on viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud 2 ja vähem kordi; pole mitte kordagi viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, kuigi oleks teenust vajanud = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapsevanema haridustase, lapse puude liik, lapse puude raskusaste, lapse sugu, lapse vanus, maakond, elukoha asula tüüp, kodune keel.

Enamikul haiglaravil olnud lastest pole teenusega probleeme olnud (67–75%). Probleemidest esines kõige enamatel lastel pikk ootejärjekord (13–19%). Ülejäänud muresid esineb palju vähematel (Joonis 69). Kuna haiglaravi kasutanud lapsi oli suhteliselt vähe ja neist omakorda väike osakaal täheldas probleemi, ei ole võimalik taustatunnuste lõikes probleemide esinemist analüüsida.

Joonis 69. Haiglaraviga seotud probleemide esinemine (% viimase 12 kuu jooksul haiglaravil viibinud puudega lastest)



Ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Lisaks etteantud loetelus olevatele probleemidele toodi välja ka järgnevad:

- 1. Puudega lapse vanemal peaks olema võimalus tasuta koos lapsega haiglas olla ka siis, kui laps on vanem kui 10, voodipäeva tasu on liiga kallis.**

„Puudega lapse haiglaravil viibides, saatjal kallis vooditasu“

- 2. Haiglas või lasteosakonnas on liiga vähe kohti, haigla asub liiga kaugel**

„Lastepalatid on täis, vahe on vabu kohti. Osad lapsed koos vanematega saadeti teise linna ravile. Lasteosakonda pole edasi arendatud, kuigi seda vajavad paljud lapsed.“

„Haiglas ei olnud kohti, magasime lapsega öösel mängutoas“.

- 3. Sattudes haiglasse muu terviseprobleemiga ei täideta (kohe) puudega seonduvaid vajadusi**

„Kuna laps sööb püreestatud toitu, siis tavaliselt haiglasoleku esimesel päeval sellist toitu ei saa.“

„Käies puudega lapsega haiglaravil peaks mõtlema, et kas ikka saab panna ühte väiksesse palatisse kokku 4 inimest: 2 ema ja nende puudega lapsed, kes sageli on erinevate puuete, harjumuste, vajaduste jms. Samuti tuleb haiglaravile minnes võtta kaasa kõik vajalikud abivahendid (vankrid, käimisraamid, potitoolid jne), sest haiglates reeglina neid ole ja kui on siis kõigile kindlasti ei jätku. Samuti on probleemiks see, et nt haiglate palatite wcd/dushiruumid ei ole sageli kohandatud liikumispuudega patsientidele.“

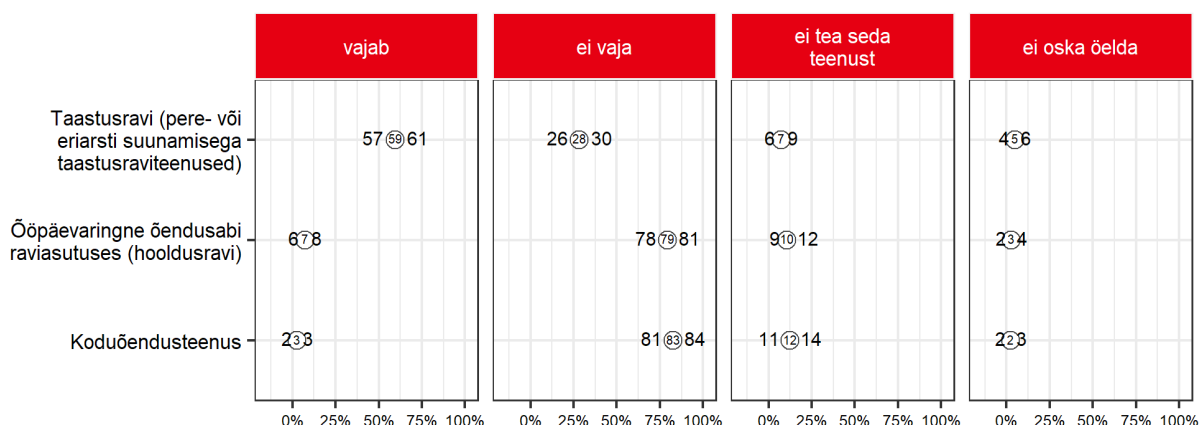
4.8 Taastusravi, raviarutuses ööpäevaringse õendusabi ja koduõendusteenuse vajadus ja kasutamine

Lisaks eelkirjeldatud tervishoiuteenustele analüüsiti eraldi spetsiifilisemaid tervishoiuteenuseid: taastusravi, ööpäevaringset õendusabi raviarutuses (varasemalt nimetati hooldusraviks) ja koduõendusteenust. Eraldi analüüsiti loetletud teenuseid seetõttu, et sooviti teada ka vastajate teadlikkust nendest. Kuigi ka 2009. aasta uuringus küsiti puudega laste peredelt samade teenuste kohta, ei ole võrdlus käesoleva uuringuga võimalik. Seda seetõttu, et eelmise uuringu näost-näkku vastamise puhul ei antud

vastajale vastusevariante “ei tea seda teenust” ja „ ei oska öelda“, mistõttu ka teiste, praegusega sarnaste, vastusevariantide sisu ja sagedus ei ole käesoleva küsitluse tulemustega võrreldav.

Analüüsidest taastusravi, raviastutuses pakutava ööpäevaringse õendusabi ja koduõendusteenuse vajadust 12 kuu jooksul küsitlusele eelneval ajal näeme, et see varieerub teenuseti oluliselt (Joonis 70). Kõige suurem osakaal puudega lastest vajavad taastusraviteenust, 57–61%. Ööpäevaringse õendusabi vajadus on 6-8% lastest. Koduõendusteenust vajavate puudega laste osakaal jääb vahemikku 2-3%. Väike hulk vastajatest ei tea nimetatud teenuseid. Õendusteenustest oluliselt paremini teatakse taastusravi, vaid 6–9% on selliseid, kes seda teenust ei tea. Õendusteenuseid ei tea ca 10% vastanutest (vastavalt ööpäevaringset õendusabi 9-12% ja koduõendusteenust 11-14%.

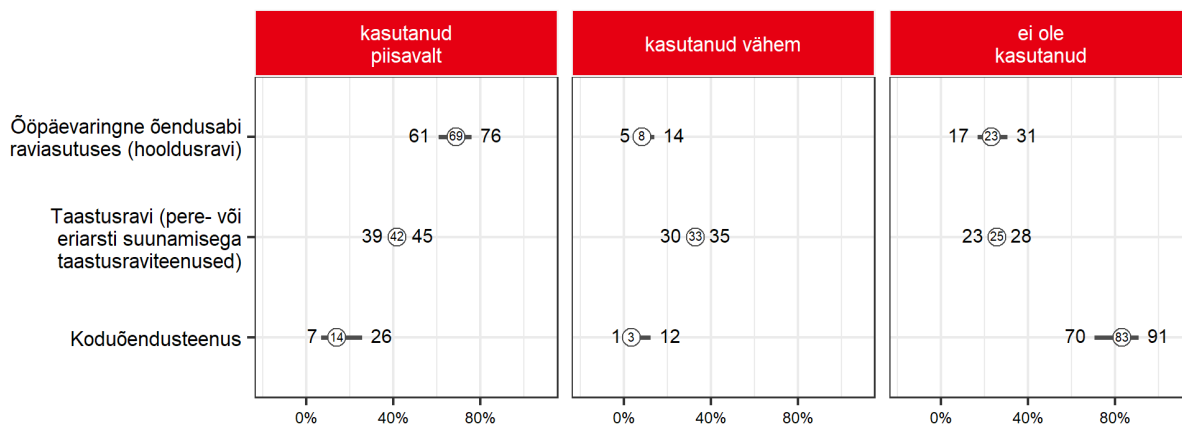
Joonis 70. Puudega lastest taastusravi, ööpäevaringset õendusabi ja koduõendusteenust uuringule eelneva 12 kuu jooksul vajanud (% puudega lastest)



Märkus: teenust vajavateks loetakse siin kõiki, kes kasutasid teenust või ei kasutanud, kuigi oleks vajanud. Ringid tähistavad keskvaartuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Vaadeldavatest teenustest on neile, kes teenust vajavad, kõige paremini olnud kättesaadav ööpäevaringne õendusabi. Piisavas mahus on seda viimase 12 kuu jooksul saanud 61–76% ööpäevaringset õendusabi vajanud puudega lastest (Joonis 71). Oluliselt halvemini kättesaadavad on olnud taastusravi ja koduõendusteenus. Esimest on saanud piisavalt 39–45% taastusravi vajanud puudega lastest ning vähem kui vaja on seda kasutanud kolmandik (30-35%) vajajatest. Koduõendusteenust ei ole üldse kasutanud 70–91% neist, kes selle vajadust tunnetasid.

Joonis 71. Tervishoiuteenuste kättesaadavus puudega laste seas uuringule eelneva 12 kuu jooksul (% teenust vajavatest puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvaartuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

4.8.1 Ööpäevaringse õendusabi vajaduse ja saamisega seotud taustatunnused

Õendusabi²⁶ on teenus, millega säilitatakse ja võimalusel ka parandatakse patsiendi tervislikku seisundit ja toimetulekut, ravitakse ja toetatakse stabiilses seisundis patsienti ning vajaduse korral leevendatakse tema vaevusi. Õendusabi teenuse saamiseks on vajalik arsti saatekiri, milles kajastub määratud ravi ning hinnang õendusabi vajaduse sagedusele. Õendusabi teenus jaguneb vastavalt selle osutamise kohale iseseisvaks statsionaarseks õendusabiks ehk hooldusraviks ehk ööpäevaringseks õendusabiks raviasutuses ja ambulatoorseks ehk koduõenduseks.

Käesolevas peatükis käsitletav ööpäevaringne õendusabi raviasutuses²⁶ (sünonüümideks kasutame hooldusravi ja iseseisev statsionaarne õendusabi) on mõeldud patsientidele, kes ei vaja pidevat arstiabi, kuid vajavad pärast traumasid, rasket haigust, kroonilise haiguse ägenedes või raskest haigusest tingitud vaevuste leevendamisel abi. Statsionaarsele õendusabi teenusele suunab perearst või eriarst ning vastavalt patsiendi tervislikule seisundile ja õendusabi teenuse vajadusele otsustatakse õendushaiglas viibimise aeg. Patsient suunatakse õendusabi saama õendushaiglasse, kui vajaliku abi ja raviprotseduuride maht ületab koduõenduse võimalused. Statsionaarse õendusabi teenuse kasutamisel tuleb patsiendil tasuda ka omaosalus – 2017. aastal peab patsient tasuma 10,16 eurot ühe haiglapäeva eest ning samuti on õendushaiglas õigus patsiendilt küsida lisaks täiendavalt 25 eurot esimese 10 haiglapäeva eest. 2009. aasta uuringu ajal nimetati analoogset teenust hooldusraviks haiglas ning sellele teenusele ei kehtinud veel omaosalust²⁷, esimese 10 päeva ravi eest oli voodipäevatasu haigusjuhtumi kohta 25 krooni päevas ehk 1,6 eurot.

Hooldusravi vajab küsitlusele eelneva 12 kuu jooksul 6–9% puudega lastest. Hooldusravi vajadus on statistiliselt oluliselt seotud lapse puude raskusastmega ja liigiga ning koduse keelega (Joonis 72). Ootuspäraselt vajavad sügava puudega lastest hooldusravi (18-36%) suurem osa kui teiste puude raskusastmetega lastest (vastavalt keskmise puudega 5-9% ja raske puudega 6-10%) ja erinevus on ka sisuliselt suur.

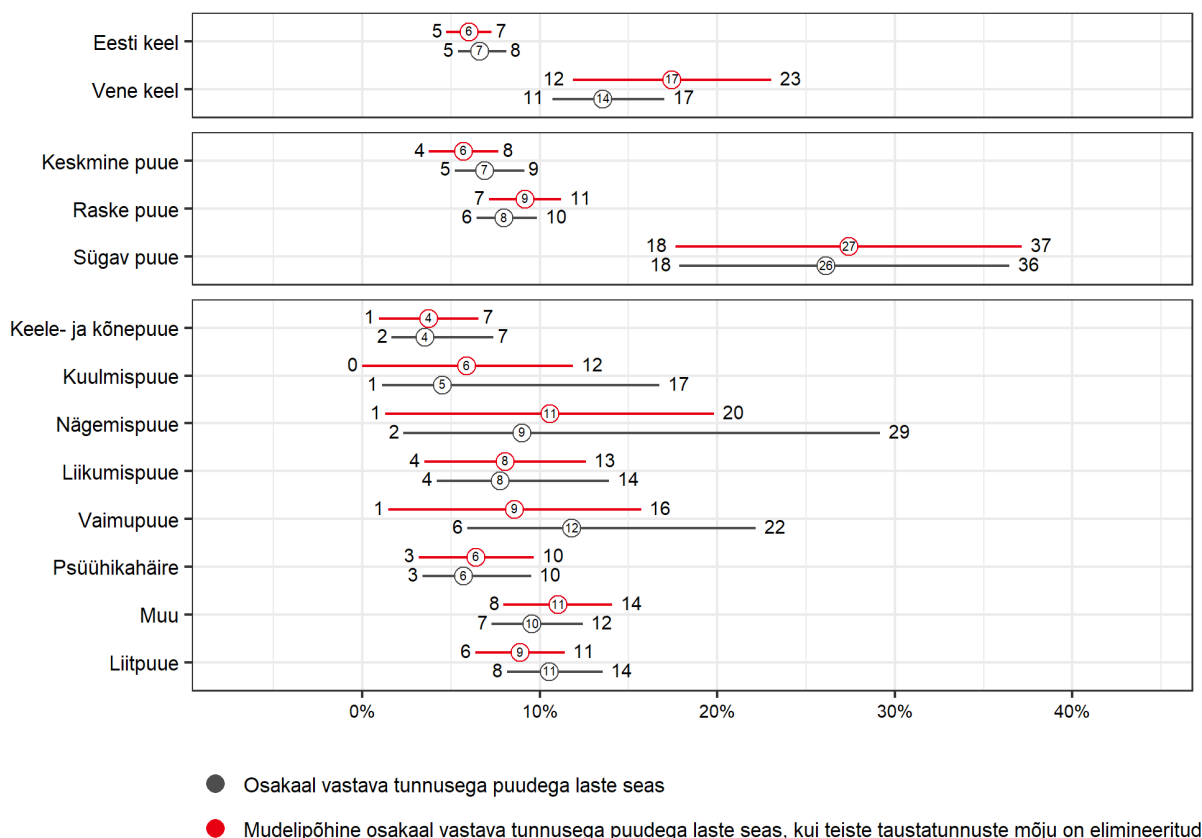
Puudeliikide lõikes vajab hooldusravi teenust liitpuudega (8-14%) ja muu funktsiooni häirega (7-12%) lastest suurem osal kui keele- ja kõnepuudega (2-7%) lastest. Teiste puudeliikide vahel ei ole võimalik statistiliselt olulisi erinevusi tuvastada.

Hooldusravi vajaduses on erinevused ka koduse keele lõikes, nimelt tajutakse enamates kodus vene keelt kõnelevates peredes puudega laste hooldusravi vajadust (5-8%) kui eestikeelsetes peredes (11-17%) (Joonis 72).

²⁶ Eesti Haigekassa. Õendusabi. <https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/arsti-ja-oendusabi/oendusabi/>

²⁷ Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu (RTI 2008, 2, 19; viimane red. RTI 2009, 16, 99, jõust 6.03.2009) <https://www.riigiteataja.ee/akt/13154310>

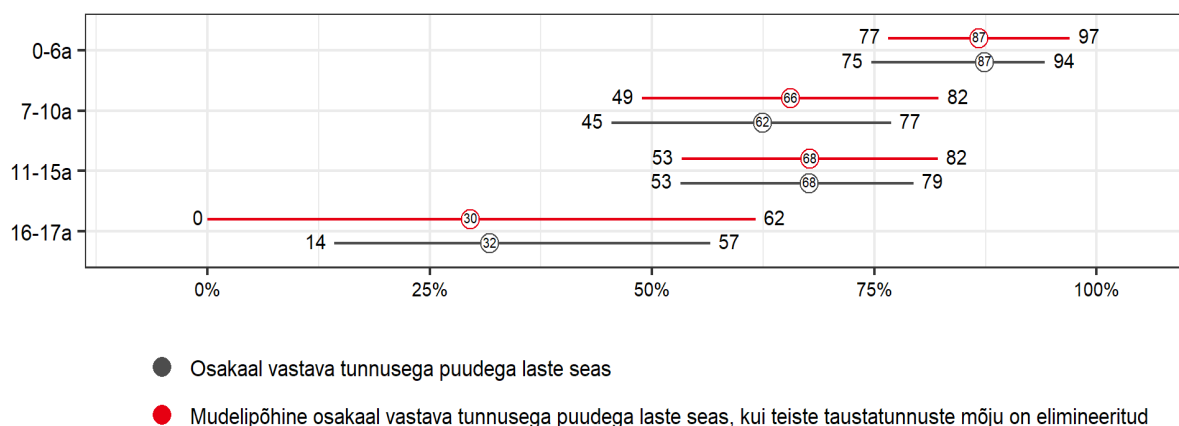
Joonis 72. Ööpäevaringset õendusabi vajanud puudega lapsed uuringule eelneva 12 kuu jooksul (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud; pole mitte kordagi viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, kuigi oleks teenust vajanud = 1, ei ole viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, sest pole teenust vajanud; ei tea seda teenust; ei oska öelda = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapsevanema haridustase, lapse puude liik, lapse puude raskusaste, lapse sugu, lapse vanus, elukoha maakond, elukoha asula tüüp, kodune keel.

Hooldusravi vajanud puudega lastest ca 31% ei ole teenust saanud või on saanud seda ebapiisavas mahus (Joonis 71). Hooldusravi kättesaadavuses esinevad statistiliselt olulised erinevused vaid vanusegrupiti (Joonis 73). Muude taustatunnuste lõikes pole võimalik erisusi tuvastada, kuna antud teenuse vajajate grupp on valimis väga väike. Teenuse kättesaadavust hinnatakse 0–6-aastaste vanuserühmas paremini kui vanemates vanuserühmades. Ööpäevaringset õendusabi vajanud 0–6-aastastest puudega lastest, said seda kasutada nii palju kui vaja 75–94%, 16–17-aastastest lastest vaid 14–57% (Joonis 73).

Joonis 73. Laps on kasutanud uuringule eelneva 12 kuu jooksul hooldusravi teenust nii palju kui vaja (% teenust vajavatest puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvaartuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud nii palju kui vaja = 1, on teenust kasutanud, aga vähem kui tegelikult vajaks; ei ole viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, kuigi oleks teenust vajanud = 0. Modelis kasutatud taustatunnused: lapse puude liik, lapse puude raskusaste, lapse vanus.

4.8.2 Koduõendusteenuse vajadust ja saamist mõjutavad tegurid

Ambulatoorne õendusabi ehk koduõendusteenus²⁶ on suunatud inimestele, kes vajavad meditsiinilist abi, kuid mitte haiglas viibimist. Teenus hõlmab õendusplaani koostamist, õendusala nõustamist, patsiendi põetamist ning raviprotseduuride ja teatud laboriuuringute tegemist. Sarnaselt statsionaarse õendusabiga suunab patsiendi koduõendusteenusele tema perearst või eriarst saatekirjaga, kus on märgitud vajalik arstiabi ning kirjeldatud õendusabi vajadus. Küll aga rahastab koduõendusteenust haigekassa täies mahus ning seetõttu patsient omaosalust tasuma ei pea.

Koduõenduse vajadus on väga väikesel osal puudega lastest (vt Joonis 70). Vajadust mõjutavaid tunnuseid analüüsiti järgmiste taustatunnuste lõikes: puudeliik ja raskusaste, lapse vanus, elukoha maakond, kodune keel. Joonistus välja vaid üks statistiliselt oluline tunnus: kodune keel. Venekeelsetest kodudest vajab teenust suurem osakaal puudega lapsi (3–9%) võrreldes eestikeelsetega (1–3%), mis on suhteliselt väike sisuline erinevus. Kuna teenuse vajajaid on väga vähe, siis ka kättesaadavusega statistiliselt oluliselt seotud tegureid ei ole võimalik välja tuua.

4.8.3 Taastusravi vajadust ja kättesaadavust mõjutavad tegurid

Taastusravi kuulub sisuliselt eriarstiabi alla. Taastusravi²⁸ on töövõimet või toimetulekut taastav ravi, mis on suunatud funktsioonide taastamisele, säilitamisele või puudega kohanemisele. Taastusravi osutatakse patsiendile nii ambulatoorselt kui ka statsionaarselt. Taastusravi teenuse saamiseks on vajalik arsti saatekiri taastusravi vastuvõtule. Seejärel hindab taastusravi, millist taastusravi patsient vajab ning milliseid protseduure teostatakse. Eesti Haigekassa tasub nende taastusravi teenuste maksumuse, mis on kantud haigekassa tervishoiuteenuste loetellu²⁹.

²⁸ Eesti Haigekassa. Taastusravi. <https://www.haigekassa.ee/et/taastusravi-4/>

²⁹ Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu. RT I, 29.04.2017, 7. <https://www.riigiteataja.ee/akt/129042017007>

Ambulatoorne taastusravi hõlmab järgnevaid teenuseid²⁸:

- füsioteraapia (sh basseinis)
- tegevusteraapia
- massaaž (mööduka või tugeva halvatusesega haigele)
- raviujumine (liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele)
- mudaravi (reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele)
- külmvõimlemiskambri ravi ja speleoteraapia (kroonilise bronhiidi või bronhiaalastmaga haigele)
- isiksuse uuring
- kognitiivse funktsiooni uuring
- psühhoteraapia
- logopeediline uuring

Statsionaarne taastusravi²⁸ on mõeldud patsientidele raske haiguse, operatsiooni, trauma ning ka krooniliste haigusseisundite ja nende ägenemise järgselt taastumiseks. Statsionaarne taastusravi liigitub neljaks:

- intensiivne funktsioone taastav taastusravi
- funktsioone taastav taastusravi
- funktsioone toetav taastusravi alla 19-aastastele isikutele
- funktsioone toetav taastusravi vähemalt 19-aastastele isikutele

Uuringu sihtrühma ehk alla 18-aastaste inimeste jaoks on relevantesid esimesed kolm taastusravi liiki. Nende puhul tasub haigekassa voodipäeva maksumuse 100% ulatuses²⁹. Lisaks protseduuridele ja uuringutele tasub haigekassa statsionaarse taastusravi puhul ka alla 8-aastase lapsega ja alla 16-aastase sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimise päevade eest²⁸.

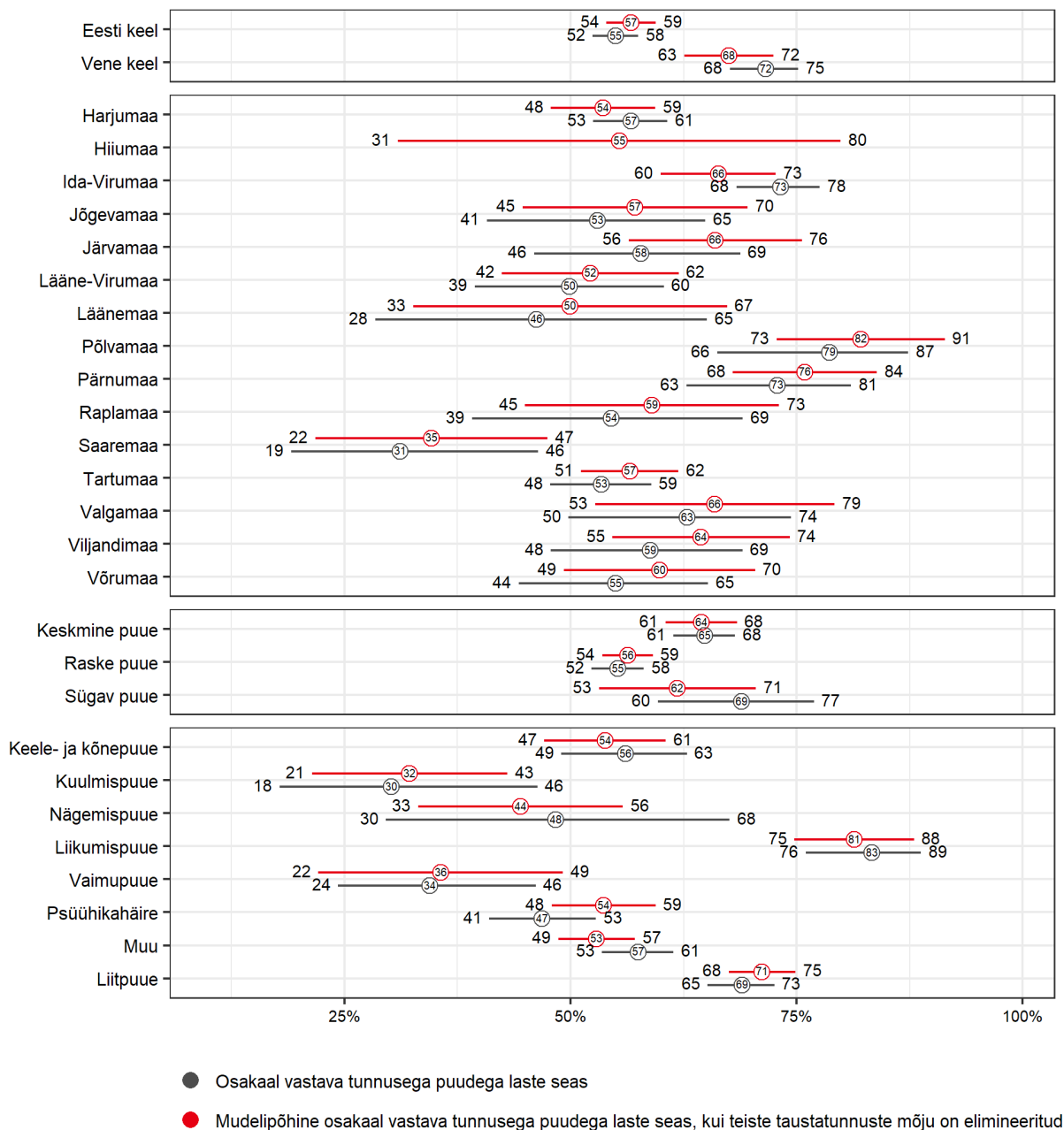
Puudega lastest vajavad taastusravi märksa enamad kui õendusteenuseid (vt Joonis 70). Taastusravi vajavate laste osakaal erineb olulisel määral järgmiste taustatunnuste lõikes: puude raskusaste ja liik, elukoha maakond ja kodune keel (Joonis 74). Statistiliselt oluline, aga sisuliselt väike erinevus on puude raskusaste lõikes taastusravi vajavate laste osakaalus nii, et keskmise puudega lastest vajavad enamad taastusravi kui raske puudega lastest (vastavalt 61–68% ja 52–58%). Sügava puudega laste seas on vajadus taas kõrgem (60–77% sügava puudega lastest vajavad taastusravi). Samas, kui vaadata ühesuguste taustatunnustega lapsi, siis sügava puudega laste osakaal, kes vajavad taastusravi, ei erine raske ja keskmise puudega laste osakaalust.

Puudeliikidest on kõige suurem osakaal lapsi, kes vajavad taastusravi, liikumispuudega laste seas, koguni 76–89%. Samuti vajavad teistest gruppidest enamad taastusravi liitpuudega laste seas (65–73%), mis võib tuleneda sellest, et liitpuude üheks komponendiks võib olla ka liikumispuue. Keskmisel määral vajavad taastusravi keele- ja kõnepuudega (49–63%) ning muu puudega (53–61%) lapsed – neil jääb vajadus 50–60% ringi. Kõige väiksem taastusravi vajavate laste osakaal on vaimu- ja kuulmispuudega laste seas, vastavalt 21–46% ja 18–46%. Nägemispuudega lapsed (30–68% neist vajavad taastusravi) ei eristu laiade usalduspiiride tõttu oluliselt keskmise (50–60% vajavad taastusravi) ja väikese vajadusega (vähem kui pooled vajavad taastusravi) puude liikidega lastest, küll aga on nende seas vajadus oluliselt madalam kui liikumis- ja liitpuudega laste seas.

Taastusravi vajaduse poolest eristuvad lapsed statistiliselt oluliselt ka koduse keele alusel, nimelt vajab venekeelsetest kodudest pärit lastest taastusravi suurem osakaal (68–75%) kui eestikeelsetest (52–58%). Ka maakondade vahel esineb suur varieeruvus taastusravi vajavate puudega laste osakaaludes, ulatudes Põlvamaast, kus 66–87% puudega lastest vajavad taastusravi, Saaremaani, kus vajadus on vaid 19–46% puudega lastest. Kuna maakondade vahel püsivad ka erinevused juhul, kui vaatame ühesuguste taustatunnustega lapsi, siis on maakonniti mingi struktuurne erinevus, mis sellist olukorda põhjustab.

Taolist erinevust võib põhjustada näiteks eriarstide poolt taastusravile suunamise varieeruvus. Võimalik, et taastusravi võimaluste olemasolu piirkonnas mõjutab arstide taastusravile suunamise praktikat ja seega tajuvad puudega laste vanemad osades maakondades suuremat vajadust teenuse järele. Paraku ei võimalda käesoleva uuringu andmestik seda täpsemalt analüüsida.

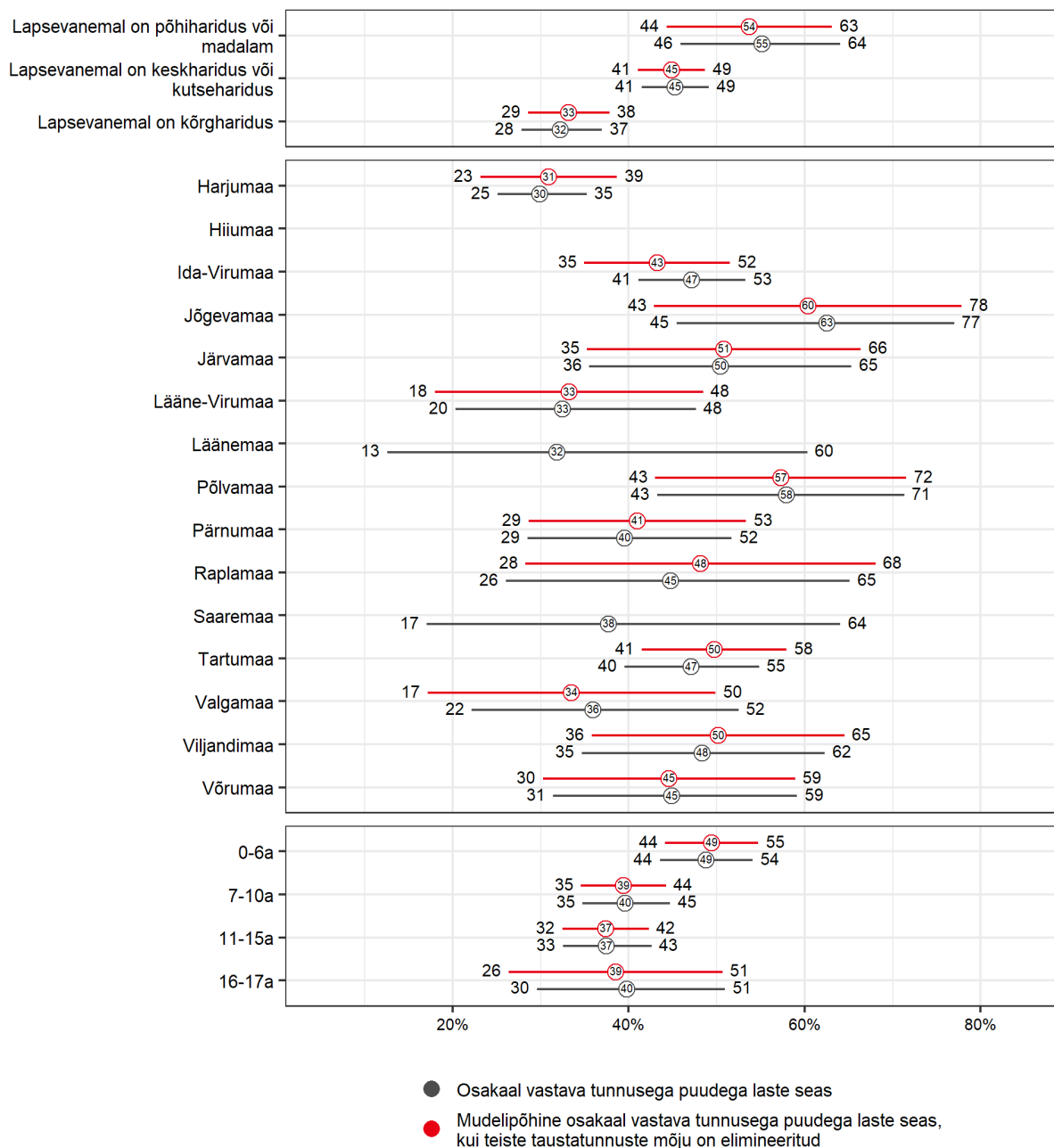
Joonis 74. Taastusravi vajanud puudega lapsed uuringule eelneva 12 kuu jooksul(% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud; pole mitte kordagi viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, kuigi oleks teenust vajanud = 1, ei ole viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, sest pole teenust vajanud; ei tea seda teenust; ei oska öelda = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapsevanema haridustase, lapse puude liik, lapse puude raskusaste, lapse sugu, lapse vanus, elukoha maakond, elukoha asula tüüp, kodune keel.

Taastusravi vajajatest on piisavas mahus teenust saanud 39–45%, ülejäänud pole kas üldse teenust saanud, kuigi on olnud vaja, või on saanud ebapiisavas mahus. Taastusravi kättesaadavusega on statistiliselt oluliselt seotud lapse vanus, elukoha maakond ja vastaja haridustase (Joonis 75). Taastusravi kättesaadavus väheneb lapse vanusega: kõige enam on piisavalt taastusraviteenust saanud kasutada 0–6-aastased (44–54% teenuse vajajatest), neist vähem on selliseid lapsi 7-10-aastaste seas (35-45%) ja 11-15-aastaste seas (33-43%). Küsitlusandmetel baseeruv kättesaadavuse hinnang on ilmselgelt subjektiivne ja hinnang sellele, kas laps on saanud teenust piisaval määral, sõltub vastaja hinnangust. Taastusravi kättesaadavuse hinnangu seos vastaja haridustasemega tulenebki tõenäoliselt sellest, et kõrgharidusega vastajad (28-37% neist, kes teenust vajasisid, leiavad, et teenus oli piisavalt kättesaadav) on kriitilisemad kui kesk- ja kutseharidusega (41-49%) või põhi- ja madalama (46-64%) haridustasemega vastajad.

Joonis 75. Laps on taastusravi teenust kasutanud nii palju kui vaja uuringule eelneva 12 kuu jooksul (% teenust vajanud puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud nii palju kui vaja= 1, on teenust kasutanud, aga vähem kui tegelikult vajaks; ei ole viimase 12 kuu jooksul teenust kasutanud, kuigi oleks teenust vajanud = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapsevanema haridustase, lapse puude liik, lapse puude raskusaste, lapse sugu, lapse vanus, elukoha maakond, elukoha asula tüüp, kodune keel.

Maakonniti esineb taastusravi kättesaadavuses rohkelt varieeruvust. Kõige madalam on hinnang Harjumaal, kus taastusravi on piisaval määral saanud vaid 25–35% puudega lastest, oluliselt parem on olukord aga Ida-Virumaal (41-53%), Jõgevamaal (45-77%), Järvamaal (36-65%), Põlvamaal (43-71%) ja Tartumaal (40-55%), kus suurem osakaal puudega laste vaenmatest hindavad teenuste kättesaadavust piisavaks. Ülejäänud maakonnad ei erine oluliselt kummastki grupist.

4.9 Alternatiivmeditsiini poole pöördumine

Lisaks tervishoiuteenuste vajamisele ja kasutamisele uuriti puudega lapse tervisega seoses alternatiivmeditsiini poole pöördumist. Küsimustikus ei defineeritu lapsevanema jaoks alternatiivmeditsiini tähendust, mistõttu jäi selle sisustamine iga vastaja enda otsustada. Alternatiivmeditsiinist on abi otsitud 15–19% puudega laste puhul. Tuleb tähele panna, et erinevalt tervishoiuteenustest pole selle küsimuse puhul 12 kuu ajalist piirangut, seega ei ole see võrreldav tervishoiuteenuste kasutamise osakaaluga.

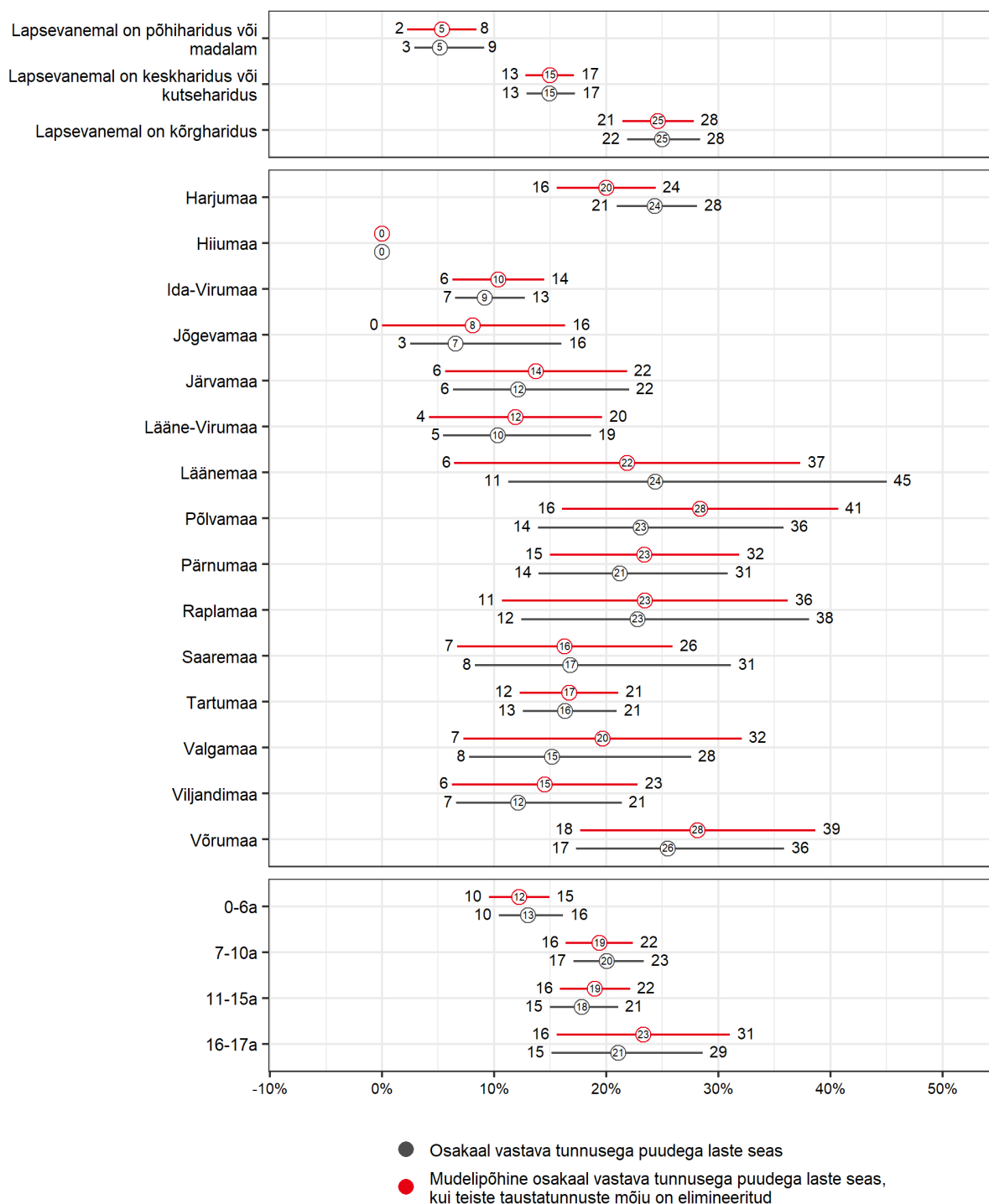
Võrdlust eelmise küsitluse tulemustega ei ole võimalik korrektselt teha, kuna näitajad pole paraku otseselt võrreldavad – 2017. aasta küsitluses küsiti ühe konkreetse lapse kohta, eelmisel korral aga pere kõigi laste kohta.

Analüüsi kaasatud taustatunnustest on alternatiivmeditsiini poole pöördumine seotud lapse vanuse, vastaja haridustaseme ja elukoha maakonnaga (Joonis 76). Väiksem on lapsevanemate osakaal, kes on pöördunud puudega lapse tervisemuredega alternatiivse meditsiini poole, kõige noorema vanusegrupi puudega laste seas, vaid 10–16%. Vanemate laste vanusgruppide vanematest on pöördunud alternatiivmeditsiini poole vastavalt 7-10-aastaste laste vanematest 17-23%, 11-15-aastaste laste vanematest 15-21% ja 16-17-aastaste laste vanematest 15-29%. Selline tulemus on loogiline: kuna küsimus on püstitatud ilma ajalise piiranguta (kogu lapse eluea kohta), siis väikelaste puhul on see aeg lühem.

Vastaja haridustaseme tõustes alternatiivse abi poole pöördujate osakaal suureneb, olles 3–9% põhi- või madalama haridustasemega vastajate puhul, kuid koguni 22–28% kõrgharidusega vastajate puhul. Ka kesk- või kutseharidusega vastajad eristuvad oma vahepealse tulemusega (13-17%) teistest gruppidest. Taoline seos võib tuleneda kahest tegurist: 1) kõrgema haridustasemega vanemad klassifitseerivad ravimeetodeid kriitilisemalt, ka madalama haridustasemega lapsevanemad võivad küll olla neid meetodeid kasutanud, kuid peavad neid tavameditsiiniks (alternatiivmeditsiiniks peetakse vabades vastustes ka raviteedega ja aroomiõlidega ravimist, soolakambrit, eri tüüpi massaaže jne) ja/või 2) kõrgharidusega vanemad on paremini informeeritud erinevatest ravivõimalustest, sealhulgas ka alternatiivmeditsiini võimalustest.

Ka maakonniti esineb rohkelt varieeruvust alternatiivmeditsiini kasutamises, kuid olulised erinevused ilmnevad vaid üksikute maakondade vahel, Harjumaal (21-26%) ja Võrumaal (17-36%) on suurema osa puudega laste vanematest pöördunud alternatiivse meditsiini poole võrreldes Ida-Virumaaga (7-13%) ka Jõgevamaaga (3-16%).

Joonis 76. Mittetraditsioonilise ehk alternatiivse meditsiini poole pöördumine (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on puudega lapse tervisega seoses pöördunud alternatiivmeditsiini poole = 1, ei ole pöördunud = 0. Analüüsist välja jäetud vastajad, kes ei osanud öelda, kas on alternatiivmeditsiini poole pöördunud. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapsevanema haridustase, lapse puude liik, lapse puude raskusaste, lapse sugu, lapse vanus, elukoha maakond, elukoha asula tüüp, kodune keel.

Lisaks alternatiivse meditsiini kasutamisele paluti vastajatel kirjeldada, mis põhjusel nad puudega lapse tervisega seoses alternatiivse meditsiini poole pöördusid. Vastuse andis 286 inimest, sealhulgas toodi välja:

1. Ei saanud abi tavameditsiinist

„Sest traditsiooniline meditsiin ei suuda piisavalt aidata (isegi väikest lootusekübet ei anta meditsiinis, sest sellega võib kaasneda kahjunõue). Siinkohal peaks lahti kirjutama ka selle, et mida mõeldakse alternatiivse meditsiini all - kui lähtuda sellest, et kogu teenus, mida ei osuta Eesti perekeskustesse/haiglate personal (arstid, õed, füsioterapeudid), on alternatiivne meditsiin, siis jah oleme kasutanud: 1) kasutame üht Rootsi terapeuti, kes tegeleb ajukahjustusega lastega, kelle meetodid on väga hästi arendanud last (kuid kulu kuni 3000 eurot aastas tuleb endal kanda); 2) jooga - aitab keskendumist, tasakaalu arendada; 3) kiropraktik 4) raviteed - kuigi ametlikku tõestust ei ole, on ravimteedest siiski kasu kasvõi immuunsuse tõstmisel“

2. Pettumus tavameditsiinist, halvad kogemused tavameditsiiniga

„liigeste raviks, kuna ei kannatanud meditsiinilisi ravimeid“,

„Sest laps peab igapäevaselt võtma ravimeid ja see ei saa kuidagi hea olla tema organismile.“

3. Katsetatakse alternatiivmeditsiini kui lisavõimalust tavameditsiinile.

„Kasutasime delfiiniteraapiat jm teenuseid kuna soovime lapsele parimat“,

„Kuna tegemist on kasvajaga, mida täielikult Eestis kahjuks ei ole võimalik eemaldada, siis oleme proovinud ka alternatiivmeditsiinist abi leida.“

4. Tavameditsiinis kokkupuude halva suhtumisega

„Esimene kokkupuude kohaliku haigla töötajatega oli väga "karune". Keegi ei tahtnud meiega rääkida. Alternatiivmeditsiinis ei anna keegi lubadusi ega suru midagi peale. Kui on vaja rääkida, siis keegi ei keera pead ka kõrvale nagu minu lapse esimene raviarst haigla koridoris. Arstiteaduskonnas peaks olema kohustuslik kursus, kuidas klientidega suheldakse ja mis on tänapäevane klienditeeninduskultuur.“

5. Pikad eriarsti ootejärjekorrad

„Kuna laps oli suitsiidne ja pidime psühhiaatri aega ootama üle 2 kuu siis konsulteerisin .“

4.10 Kokkuvõte

Enamikul puudega lastest on küsitlusele eelnenud 12 kuu jooksul olnud vaja perearsti (90–93%), eriarsti (90–93%) ja hambaarsti (80–83%) teenuseid. Kiirabi ja haiglaravi on vajanud ca kolmandik puudega lastest. Taastusraviteenuse vajadus on enam kui pooltel puudega lastest (57–61%), ööpäevaringse õendusabi vajadus 6–8% ja koduõendusteenuse vajadus 2–3% puudega lastest. Tervishoiuteenuste vajadust mõjutavate taustatunnuste osas võib välja tuua üksikud levinumad mustrid: kõiki vähemkasutatavaid tervishoiuteenuseid (st muid kui pere-, eri- ja hambaarst) vajavad venekeelsetest peredest pärit puudega lapsed oluliselt sagedamini. Erinevuse suurus võrreldes eestikeelsest perest pärit lastega varieerub ca 5 protsendipunkti koduõenduse vajaduses kuni ca 20 protsendipunkti ööpäevaringse õendusteenuse vajaduses.

Eri- ja perearsti külastanute seas on enam-vähem võrdselt neid, kes külastasid arsti 1–2 korda, 3–5 korda ja 6 või enam korda küsitlusele eelnenud 12 kuu jooksul. Neid, kes pole üldse saanud perearsti või eriarsti teenust, on kuni paar protsenti vajajatest. Puudega lastest, kellel oli vaja erakorralise meditsiini teenust või haiglaravi, ca 70% kasutas neid teenuseid 1–2 korda küsitlusele eelnenud aasta jooksul, vähem kui viiendik 3–5 korda ja vähem kui kümnendik enam kui kuus korda. Erakorralise meditsiini ja hambaarsti teenust pole

üldse saanud 3–5% ja haiglaravi 5–8% neist puudega lastest, kelle puhul tajuti nende teenuste järele vajadust.

Tervishoiuteenuste kasutamise sagedusega seotud taustatunnustest võib esile tõsta kahte: lapse vanus ja puude liik. Nimelt võis enamiku teenuste puhul näha, et noorimas vanusegruppis kasutatakse teenuseid sagedamini võrreldes ülejäänutega (v.a vanusegrupp 16–17, mis laiaade usalduspiiride tõttu mõnikord ei eristunud). Erandiks on hambaarsti teenus, mida noorim vanusegrupp külastab oluliselt harvemini kui vanemad lapsed. Samuti ilmnes, et sagedamini kasutavad tervishoiuteenuseid liitpuudega ja muu puudega lapsed, oluline erinevus on enamasti võrreldes keele- ja kõnepuudega lastega, kes kasutasid teenuseid eelnevatest harvem (v.a eriarstiteenus, mille puhul nad sarnanesid külastamise sageduselt muu ja liitpuudega lastega).

Eriarstiabiga on olnud probleeme ca pooltel teenust kasutanutest. Perearsti, hambaravi ja haiglaravi teenusega on probleeme olnud ca kolmandikul teenust kasutanutest ja erakorralise meditsiiniabi teenusega 33–40%. Probleemid tervishoiuteenustega on eeskätt seotud mitte teenusega, vaid neile juurdepääsuga: pikk ootejärjekord oli läbivalt kõige sagedamini esinev probleem. Perearsti, eriarsti, hambaravi teenuse puhul oli sageduselt järgmine probleem vastuvõtuaja broneerimine. Kõiki muid probleeme esineb oluliselt vähem.

Spetsiifiliste tervishoiuteenuste (taastusravi ja õendusteenused) kättesaadavuse osas ilmnes, et vaid 6–28% koduõendusteenuse vajajatest on saanud kasutada teenust piisaval määral, ülejäänud kas pole saanud teenust piisavalt või üldse mitte. Taastusravi ja ööpäevaringse õendusteenusega ei ole olukord nii halb, neid ei ole saanud kasutada 20 ja 30% vahel neist, kes seda vajasisid.

Alternatiivmeditsiini poole pöördunuid on alla viiendiku kõikidest puudega laste vanematest.

5 Sotsiaalteenused

5.1 Üldine vajadus ja kättesaadavus

Sotsiaalteenuste puhul saame hinnata inimeste tunnetatud vajadust teenuste järele, kuna objektiivseid vajaduse kriteeriume ei ole võimalik küsitluses kaardistada. Tunnetatud vajadus võib lisaks objektiivse vajaduse puudumisele puududa ka siis, kui inimene ei tea teenust või ei oska teenuse vajadust hinnata. Juhul, kui inimesel puudub tunnetatud vajadus teenuse järele ükskõik kummal põhjusel, siis ei ole tal selget puudust just sellest teenusest. Seepärast ei ole mõistlik eeldada, et need, kes vastavad „ei tea“ või „ei oska öelda“, on samasuguse jaotusega, kui need, kes vastavad, et nad vajavad või ei vaja seda teenust. Seetõttu käsitletakse neid, kes ei tea teenust või ei oska öelda, kas nad teenust vajavad, eraldi grupina või mitmemõõtmelises analüüsis koos nendega, kellel tunnetatud teenuse vajadus puudub.

Pea kõigil puudega lastel on vajadus vähemalt ühe sotsiaalteenuse järele. Lapsi, kellel ei olnud vajadust ühegi sotsiaalteenuse järele, on puudega laste seas vähe (ca 3%). Selliseid vaatluseid oli küsitluses nii vähe, et nende põhjal ei ole võimalik välja tuua seoseid taustatunnustega.

Kõigi küsitluses nimetatud sotsiaalteenuste järele on vähemalt osal puudega lastest tunnetatud vajadus (Joonis 77). Kõige levinum on vajadus rehabilitatsiooniplaani koostamise ja täitmise juhendamise teenuse³⁰ järele. Viimase aasta jooksul on seda vaja olnud neljal viiendikul puudega lastest (78-81%).

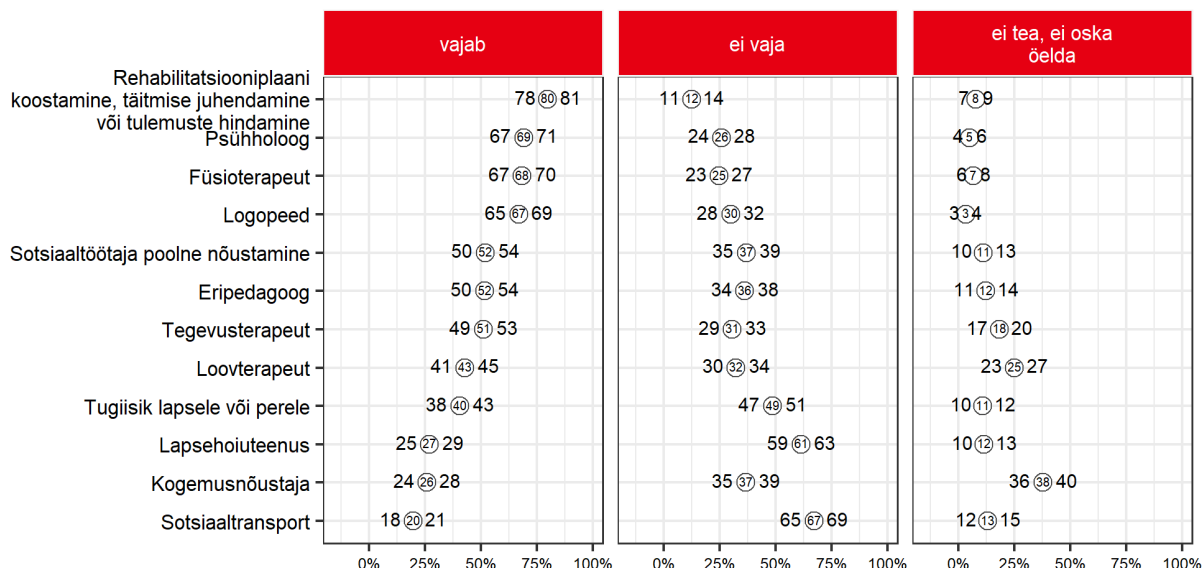
Rehabilitatsiooniplaani raames pakutakse järgmisi teenuseid: psühholoogi, füsioterapeudi, logopeedi, eripedagoogi, loovterapeudi, kogemusnõustaja, tegevusterapeudi ja sotsiaaltöötaja teenust. Lisaks nimetatutele pakutakse ka nõustavat arsti ja õe teenust, mida siinkohal eraldi ei käsitleta. Psühholoogi, füsioterapeudi, logopeedi ja eripedagoogi teenust pakutakse lastele ka haridussüsteemi kaudu haridusasutustes ja tervishoiusüsteemi kaudu taastusravina. Neid teenuseid käsitletakse ühtsena sotsiaalteenuste plokis ja ei käsitleta eraldi tervishoiu- ja haridusteenuste plokis. Seda seetõttu, et teenuseid tarbivad inimesed ei ole tõenäoliselt teadlikud täpsetest piiridest sotsiaal-, tervishoiu- ja haridussüsteemi vahel. Lisaks teenuste jagunemisele haridus-, tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi vahel jagunevad sotsiaalteenused veel riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel. Peale riiklikult korraldatava rehabilitatsiooni on kohalikel omavalitsustel kohustus tagada inimeste toimetulek ning selleks vajalik abi. Kohaliku omavalitsuse (KOV) korraldatavad sotsiaalteenused on nõustamine, sotsiaaltransport, tugiisik ja lapsehoiu, mis raske ja sügava puudega laste jaoks on olnud riiklikult finantsiliselt toetatud ning muu vajalik abi vastavalt inimeste vajadustele. Eristamata riiklikku ja kohalikku tasandit ning erinevaid riiklikke süsteeme, hinnati küsitluses üldisemalt teenuste vajadust ja kättesaadavust.

Kahel kolmandikul või enamatelgi puudega lastest on nende vanemate hinnangul vaja psühholoogi (67-71%, Joonis 77), füsioterapeudi (67-70%) või logopeedi (65-69%) teenust (Joonis 77). Umbes pooltel puudega lastest on vaja sotsiaaltöötaja nõustamist (50-54%), eripedagoogi (50-54%) või tegevusterapeudi (49-53%) teenust. Loovterapeudi ja tugiisikuteenuseid on vaja veidi vähemal, vastavalt 41-45% ja 38-43% puudega lastest. Veerandil on vaja lapsehoiu (25-29%) või kogemusnõustaja (24-28%) teenust ja viiendikul sotsiaaltranspordi (18-21%) teenust.

³⁰ Rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise juhendamise või tulemuste hindamise teenus on teistest käsitletud teenustest erinev, kuna see on eeldus rehabilitatsiooniteenuste saamiseks. 2016. aastal lisandusid rehabilitatsiooniplaanile alternatiividena rehabilitatsiooniprogramm ja tegevuskava. Kuna rehabilitatsiooniplaan on varasemalt olnud eeldus rehabilitatsiooniteenuste saamiseks, siis võib olla tunnetatud vajadus selle teenuse järele sisuliselt erinev teiste teenuste tunnetatud vajadusest.

Märkimisväärne hulk, enam kui kolmandik (36-40%), puudega laste vanematest ei tea kogemusnõustaja teenust või ei oska selle teenuse vajadust hinnata. See viitab vajadusele teenuse olemust võimalikele tarbijatele enam tutvustada.

Joonis 77. Puudega laste sotsiaalteenuste vajadus viimase 12 kuu jooksul (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid. Teenust vajavate hulgas on nii need, kes vajavad ja on kasutanud kui ka need, kes ei ole kasutanud, aga vajavad teenust.

Võrreldes 2009. a raporteeritud tulemustega on kõikide sotsiaalteenuste vajaduse hinnangud praeguse uuringu andmetel veidi kõrgemad³¹. Nt füsioterapeudi teenust vajas 2009. a 62% puudega lastest, praeguse uuringu järgi aga 67-70%, logopeedi 2009. aastal 56% ja 2017. aastal 65-69%, psühholoogi 2009. aastal 52% ja 2017. aastal 67-71% puudega lastest (GfK 2009: 43). Siiski on 2017. aastal kuus enim vajavat teenust samad, mis olid 2009. aastal, kuid veidi teises järjestuses (2009. aastal oli esimene füsioterapeudi teenus ja sellele järgnesid rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamise, logopeedi, psühholoogi, sotsiaalnõustamise ja eripedagoogi teenused. Teenust vajavate laste osakaal on kasvanud sõltuvalt teenusest ca 5–10 protsendipunkti, ainult sotsiaaltransporditeenuse vajadus on käesolevas uuringus väiksem (2009. aastal vajas sotsiaaltransporti 22–27%, praeguse uuringu kohaselt 18–22% puudega lastest).

Inimeste osakaal, kes „ei tea seda teenust“ või „ei oska öelda“, on käesolevas uuringus süstemaatiliselt suurem kui 2009. aastal. 2009. aastal oli „ei oska öelda“ osakaal vaid 0,2–1,2%, käesolevas uuringus 2–9% ja lisaks „ei tea seda teenust“ kuni 13% puudega laste vanematest (loovterapeudi teenuse osas lausa 18–19% ja kogemusnõustaja teenuse osas 28–32%). Kahe uuringu tulemused ei ole võrreldavad, kuna erinev on nii küsitlemise meetodika ja vastuste variandid kui ka ühiskondlik kontekst, milles on vahepeal aset leidnud muutused. Näiteks võib sotsiaaltranspordi vajadus olla vähenenud seetõttu, et ühistransport on võrreldes 2009. aastaga paremini kättesaadav, aga ka „ei tea seda teenust“ valiku lisamine vastusevariantide hulka võib olla vähendanud nende osakaale, kes kindlalt vajavad või ei vaja teenust.

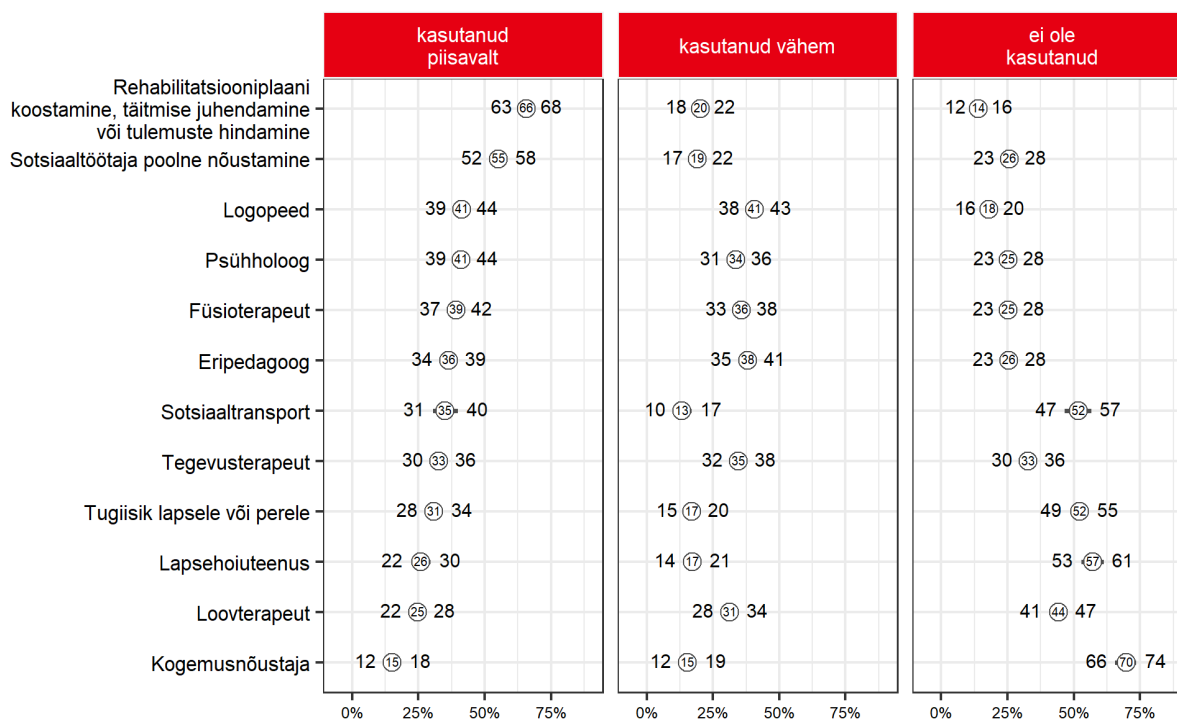
5–7% puudega lastest vajavad muid täiendavaid ankeedi loetelus nimetatavaid teenuseid. Valdav osa lapsevanematest piirdus teenuste vajaduse hindamisel ankeedis loetletud teenustega ning täiendavaid teenuseid ei nimetanud, mis siiski ei välista võimalust, et vajadus täiendavate teenuste järele võib olla

³¹ Kuna 2009. aastal oli teenuste loetelu praegusest veidi erinev ja ei olnud vastusevarianti „ei tea seda teenust“, siis ei ole küsitluste tulemused otseselt võrreldavad.

laiem. Täiendavate teenustena tuuakse välja vajadust järgmiste teenuste järele: soolakamber, kliiniline või lastepsühhiaater, neuroloog, massaaž, ujumine, hipoteraapia, ratsutamine, perenõustamine, tugigrupp, eraõpetaja või tugiõpe, võimlemine (lisaks füsioteraapiale), laagrid ja tegevused koolivaheajal, tugiisikuteenus koos transpordiga, paindlik treeningute võimalus rehabilitatsiooniplaani alusel (praegu saab ainult ujumist, mis lapsele ei sobi ja seetõttu oleks vaja asendada mõne teise treeninguga, mida aga ei finantseerita), tõlk.

Sotsiaalteenuste kättesaadavust hinnati käesolevas uuringus lähtuvalt sellest, kas laps, kes teenust vajab, on saanud vajatud teenust piisavalt kasutada, on kasutanud vajadust vähem või pole üldse kasutanud. Enamiku teenuste puhul on piisavas mahus saanud teenust kasutada vaid üks kolmandik neist puudega lastest, kes teenust vajaksid (Joonis 78). Seega on kaks kolmandikku teenuseid vajanud puudega lastest saanud enamikku teenuseid vähem kui vaja või üldse mitte. Paremini on kättesaadav rehabilitatsiooniplaani koostamise ja täitmise juhendamise teenus ning sotsiaaltöötaja poolne nõustamine, mida on saanud piisavas mahus enam kui pooled lastest, kellel seda vaja on olnud. Rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise ja juhendamise teenust on piisavalt saanud kasutada 63-68% teenuse vajajatest ja sotsiaaltöötaja nõustamist 52-58%. Kõige suurem suhteline puudujääk on sotsiaaltranspordi, tugiisiku ja lapsehoiuteenuse osas, mis on Sotsiaalhoolekandeseaduse alusel KOV korraldatava abina käsitletavad. Sotsiaaltranspordi, tugiisiku ja lapsehoiuteenust ei ole saanud üldse ligi pooled vajajatest. Täpsemalt pole 47-57% sotsiaaltranspordi teenust vajanud puudega lastest, 49-55% tugiisikuteenust vajanutest ja 53-61% lapsehoiuteenust vajanutest saanud neid teenuseid üldse kasutada. Nimetatud kolm teenust on sellised, mille üldine vajadus on suhteliselt väiksem. Siiski viitavad tulemused sellele, et laste jaoks, kellel on vaja sotsiaaltranspordi, tugiisikut või lapsehoiuteenust, on teenuste kättesaadavus eriti halb. Lisaks neile teenustele on suured probleemid ka kogemusnõustaja teenuse kättesaadavusega – neist, kes kogemusnõustaja teenust vajavad, pole 66-74% saanud teenust üldse kasutada.

Joonis 78. Puudega laste sotsiaalteenuste kasutamine viimasel 12 kuul (% puudega lastest, kellel oli teenust vaja)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

2009. aastal määratleti probleemseks need teenused, mille kättesaadavusega oli probleeme enam kui viiendikul puuetega lastest. Halva (probleemse) kättesaadavusena mõistetakse siinkohal olukorda, kus laps teenust vajab, kuid on saanud teenust kasutada vajatust vähem või üldse mitte. 2017. a oli probleemse kättesaadavusega teenuste nimistu sama mis 2009. aastal, kuid laste osakaal, kellele teenuste kättesaadavus probleeme valmistas, oli oluliselt suurem:

Tabel 9. Probleemsed teenused 2009. ja 2017. aastal

2009. a uuringus teenused, millega oli probleeme enam kui viiendikul puudega lastest (vajavad teenust, kuid on saanud seda kasutada vähem kui vaja või üldse mitte):	2017. a uuringus teenused, millega on probleeme enam kui 30%l puudega lastest (vajavad teenust, kuid on saanud seda kasutada vähem kui vaja või üldse mitte):
• füsioterapeut (32% puudega lastest oli kasutanud vähem kui vajaks või ei olnud kasutanud üldse)	• füsioterapeut (41-46%)
• sotsiaalnõustamine (22%)	
• psühholoog (23%)	• psühholoog (40-44% puudega lastest)
• tegevus- või loovterapeut (21%)	• tegevusterapeut (35-39%), loovterapeut (33-37%)
• logopeed (23%)	• logopeed (38-42%),
	• eripedagoog (33-37%)

2009. a probleemseks liigitatud sotsiaalnõustamine on teenus, mille kättesaadavust probleemseks hinnanute osakaal polnud 2009. aastal oluliselt suurem võrreldes sotsiaaltöötaja nõustamise teenust probleemseks hinnanute osakaaluga käesolevas uuringus (2017. a oli kättesaadavus piiratud 23-26% puudega laste jaoks).

Samuti liigitati 2009. a uuringus probleemseks rehabilitatsiooniplaani (19%), sotsiaaltranspordi (16%), eripedagoogi (16%), lapsehoiu (13%) ja hooldusraviteenused (13%), mille kättesaadavus oli probleemiks 10-20%le peredest, kus kasvas puudega laps (GfK 2009:43). Kõigi nende teenustega on 2017. aasta uuringu järgi analoogselt arvestades probleeme 20-30%l puudega lastest. Rehabilitatsiooniplaani kättesaadavusega on probleeme 27-31%l puudega lastest, sotsiaaltöötaja nõustamisega 23-26%l, tugiisikuteenusega 27-31%l, lapsehoiuteenusega 19-22%l ja kogemusraviteenusega 22-25%l puudega lastest. Vaid sotsiaaltranspordi kättesaadavus on probleeme valmistanud väiksemale osakaalule puudega lastest – 12-15%, mis ei erine oluliselt 2009. aasta tulemusest. Seega on erinevate sotsiaalteenuste kättesaadavust probleemseks hinnanute osatähtsus 2017. aastal ligikaudu 10 protsendipunkti võrra suurem kui 2009. aastal. Sotsiaaltranspordiga paistab sellises vaates olevat olukord parem. Samas on siin kirjeldatud tulemuste puhul tähelepanuta jäetud see, et erinevaid teenuseid vajab erineval hulgal lapsi. Kui vaadata teenuse kättesaadavust arvatuna mitte kõikidest puudega lastest, vaid ainult nendest, kellel on seda teenust vaja olnud, siis on halvem just nende teenuste kättesaadavus, mille tunnetatud vajadus on väiksem (Joonis 78).

Kokkuvõttes on suhteliselt halvemini kättesaadavad (st teenuse vajajate seas on seda piisavas mahus kasutanute osakaal väiksem) väiksema tunnetatud vajadusega teenused nagu tugiisiku- ja lapsehoiuteenus ja sotsiaaltransport. See tähendab, et olukorras, kus lapsel on vaja just sellist teenust, mida vajavad vähesed puudega lapsed, siis sellise teenuse saamisega satutakse suurema tõenäosusega hätta. Osakaaluna kõikidest puudega lastest on aga enam probleeme laiemalt vajatavate teenustega, mida pakutakse rehabilitatsiooniteenuste raames. Samasugune oli olukord ka 2009. aastal. Võrreldes 2009. aastaga võib teenuste kättesaadavus olla halvenenud, kuna nende osakaal, kes leiavad, et vajavad teenust, kuid ei saanud teenust kas üldse kasutada või kasutasid teenust vajatust vähem, on kasvanud 10 protsendipunkti

võrra. Samas on ka erinevate teenuste puhul 5-10 protsendipunkti võrra suurenenud nende lapsevanemate osatähtsus, kes tunnetavad lapse vajadust teenuse järele.

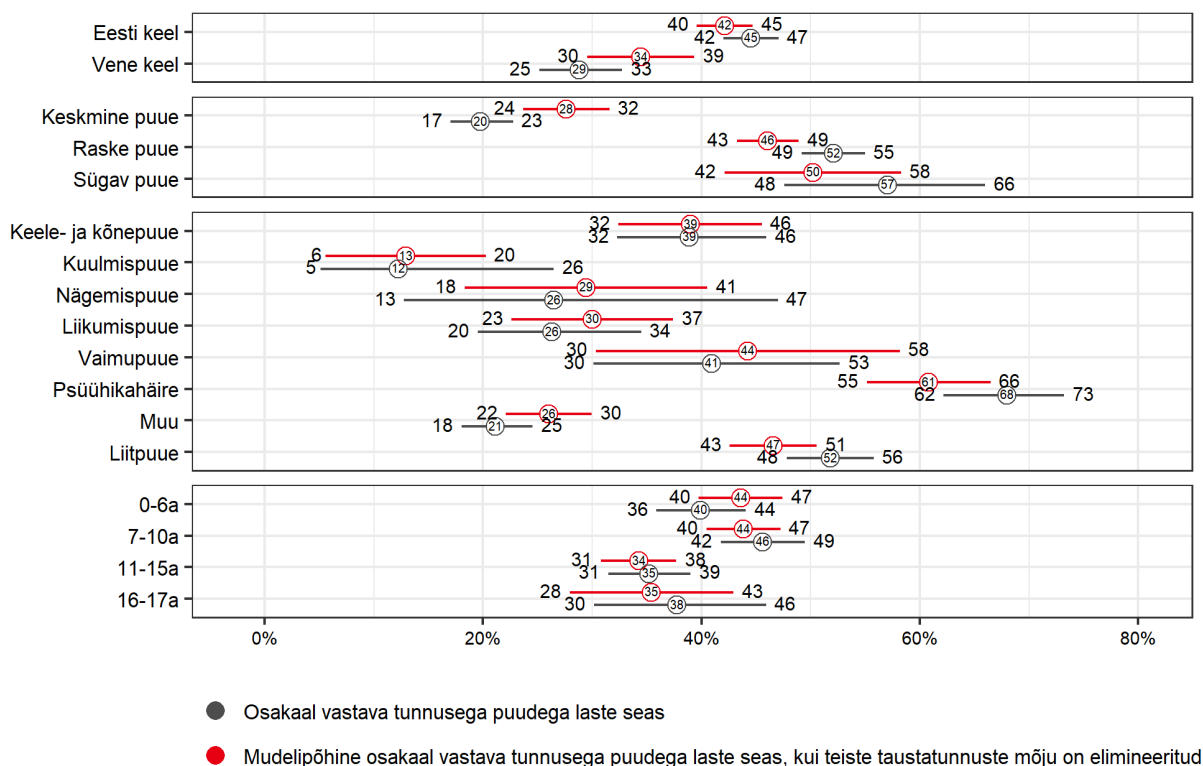
5.2 Sotsiaalteenuste vajadus ja kasutamine teenuste kaupa gruppide lõikes

5.2.1 Tugiisik

Keskmiselt on tugiisikuteenust vaja 38–43% puudega lastest, kellest omakorda on teenust viimase 12 kuu jooksul piisavalt kasutanud 28–34%.

Tugiisiku vajadus sõltub puude liigist. Psüühikahäirega lastest vajavad tugiisikut 62-73%, liitpuudega lastest 48-56%, vaimupuudega lastest 30-53% ning keele- ja kõnepuudega lastest 32-46% (Joonis 79). Väiksem on tugiisikut vajavate laste osakaal kuulmispuudega (5-26%), liikumispuudega (20-34%) ja muu puudega (18-25%) laste seas. Nägemispuudega laste kohta ei saa küsitluse põhjal kindlat järeldust teha, kuna usalduspiirid on laiad (13-47%).

Joonis 79. Tugiisikuteenuse vajadus viimase 12 kuu jooksul (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab teenust = 1, ei vaja teenust, ei tea teenust, ei oska öelda = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: puude raskusaste, puudeliik, lapse vanus, kodune keel, elukoha regioon, elukoha liik, elukoha asula tüüp, lapsevanema haridustase.

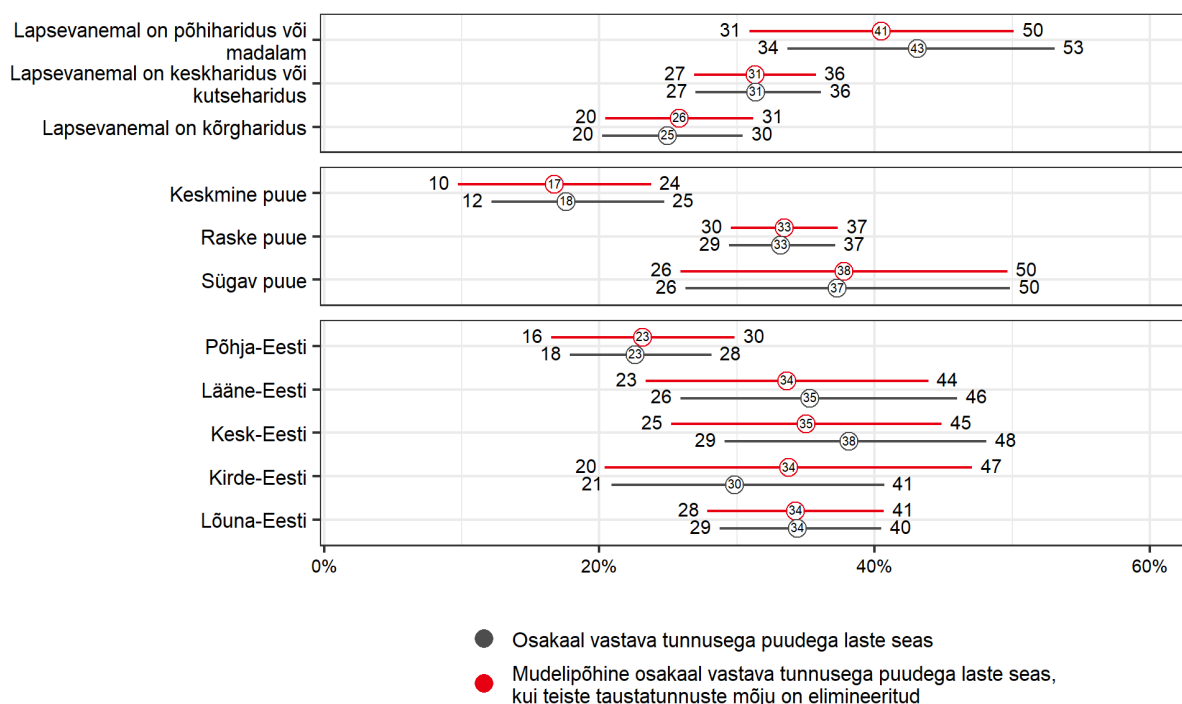
Samuti kasvab tugiisiku vajadus lapse puude raskusastmega. Keskmise puudega lastest vajab tugiisikut 17-23%, raske puudega lastest 49-55% ja sügava puudega lastest 48-66%. Need erinevused vähenevad, kui laste teised taustatunnused arvesse võtta. Võrreldes samade taustatunnustega (sama puudeliigi, koduse keele, vanuse, elukoha ja vanema haridustasemega) puudega lapsi on tugiisiku vajamise tõenäosus 24-32% keskmise puudega lapsel, 43-49% raske ja 42-58% sügava puudega lapsel.

Vanemate vanusegruppide seas on tugiisikut vaja veidi vähemal kui nooremate vanusegruppide seas. Alla 6-aastaste laste seas on tugiisiku vajadus 36-44%l puudega lastest, 7-10-aastaste seas 42-49% ja vanemates vanusegruppides 11-15-aastastel 31-39% ning 16-17-aastastel 30-46% puudega lastest. Teisi taustatunnuseid arvesse võttes joonistub selgemalt välja, et nooremates vanusegruppides on tugiisiku vajadus suurem. Muude samade taustatunnustega 0-6-aastastest ja 7-10-aastastest lastest vajab tugiisikut 40-47%, 11-15-aastastest aga 31-38%.

Vene keelt koduse keelena kõnelevad lapsevanemad tunnetavad oma puudega lapse puhul vajadust tugiisiku järele harvemini (25-33%) kui eesti keelt koduse keelena kõnelevad lapsevanemad (42-47%). Kui võrrelda võrreldavaid gruppe, kus muud taustatunnused on samasugused, on tugiisiku vajaduse erinevus pere koduse keele järgi väiksem. Muude samade taustatunnuste korral on vene keelt koduse keelena kõnelevatel lastel tõenäosus vajada tugiisikut 30-39% ja eesti keelt kõnelevatel 40-45%.

Tugiisiku kasutamine on seotud lapse puude liigi ja lapsevanema haridustasemega, väikesed erinevused on ka elukoha regiooni lõikes (Joonis 80). Raske puudega lastest on tugiisikuteenust vajanutest saanud teenust piisavalt kasutada 29-37% ja sügava puudega lastest 26-50%. Keskmise puudega lastest on tugiisikuteenust saanud piisavalt kasutada vaid 12-25% vajajatest. Erinevused jäävad enam-vähem sama suureks ka juhul, kui arvesse on võetud teiste taustatunnuste mõju ja võrreldud samade taustatunnustega lapsi. Seega on tugiisiku kättesaadavus suhteliselt halb, piisavas mahu on tugiisikut saanud kasutada vähesed ning eriti halb on tugiisiku kättesaadavus keskmise puudega laste jaoks.

Joonis 80. Tugiisikuteenust viimase 12 kuu jooksul piisavalt kasutanud (% teenust vajanud puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: kasutab teenust piisavalt = 1, kasutab teenust vähem kui vaja või ei kasuta üldse, aga vajab = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanuserühm, asula tüüp, kodune keel, vastaja haridustase, elukoha regioon.

Kõrgharidusega lapsevanemad peavad tugiisikuteenuse mahtu sagedamini ebapiisavaks kui põhiharidusega vanemad. Vanematest, kes on kõrgharidusega ja kelle lastel on olnud vaja tugiisikuteenust, leiab 20-30%, et nad on saanud tugiisikuteenust kasutada piisavalt; kesk- või kutseharidusega vanematest

27-36% ja põhihariduse või madalama haridusega vanematest 34-53%. Põhjuseks võivad olla kõrgharidusega lapsevanemate kõrgemad ootused teenuse suhtes, mistõttu on nad teenuse suhtes nõudlikumad ja sellest lähtuvalt ka sagedamini kriitilised kui madalama haridusega lapsevanemad.

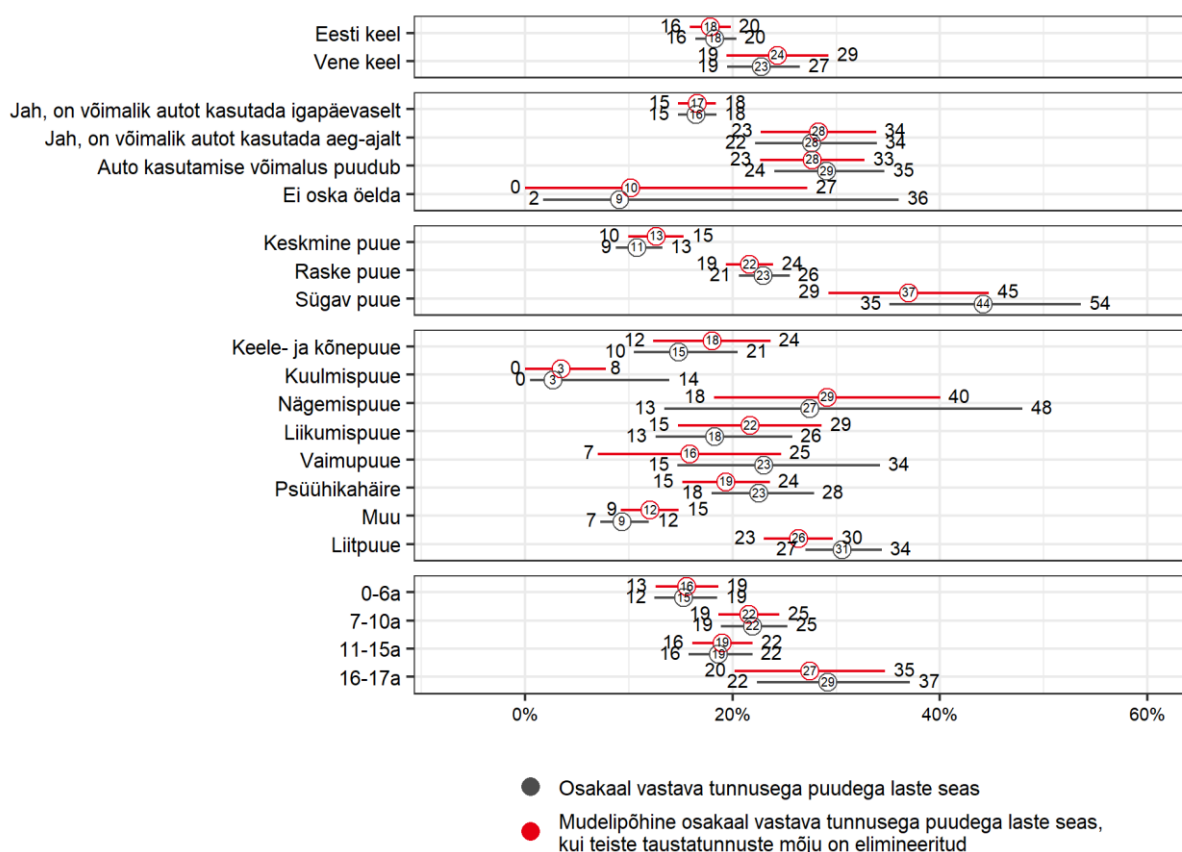
Peale teiste taustatunnuste mõju elimineerimist on Põhja-Eesti puudega laste jaoks tõenäosus tugisikuteenust piisavas mahus saada veidi väiksem (18-28%) kui Lõuna-Eesti puudega lastel (29-40%). Samas ei ole regioonidevahelised erinevused väga selgepiirilised ega suured.

5.2.2 Sotsiaaltransport

Sotsiaaltransporti vajab 18–21% puudega lastest, piisaval määral on seda kasutada saanud 31–40% vajajatest.

Vajadus sotsiaaltranspordi järele on seotud lapse puude raskusastmega, puude liigiga ja pere võimalusega kasutada autot. Väikesed erinevused on sotsiaaltranspordi tunnetatud vajaduses ka laste koduse keele ja vanuse lõikes. Kõige kõrgem on sotsiaaltransporti vajavate laste osakaal liitpuudega laste seas (27-34%), kõige väiksem kuulmispuudega (0-14%) ja muu puudega laste seas (7-12%) (loonis 81).

Joonis 81. Sotsiaaltranspordi teenuse vajadus viimase 12 kuu jooksul (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lise usalduspiiri. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab teenust = 1, ei vaja teenust, ei tea teenust, ei oska öelda = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanus, elukoha regioon, elukoha liik, elukoha asula tüüp, vastaja haridustase, auto kasutamise võimalus, kodune keel.

Sügava puudega laste seas on oluliselt enam sotsiaaltransporti vajavaid lapsi (35-54%) kui raske puudega (21-26%) ja keskmise puudega laste seas (9-13%). Kui võtta arvesse teiste taustatunnuste mõju, on puude raskusastmete lõikes erinevused veidi väiksemad, kuid siiski statistiliselt olulised.

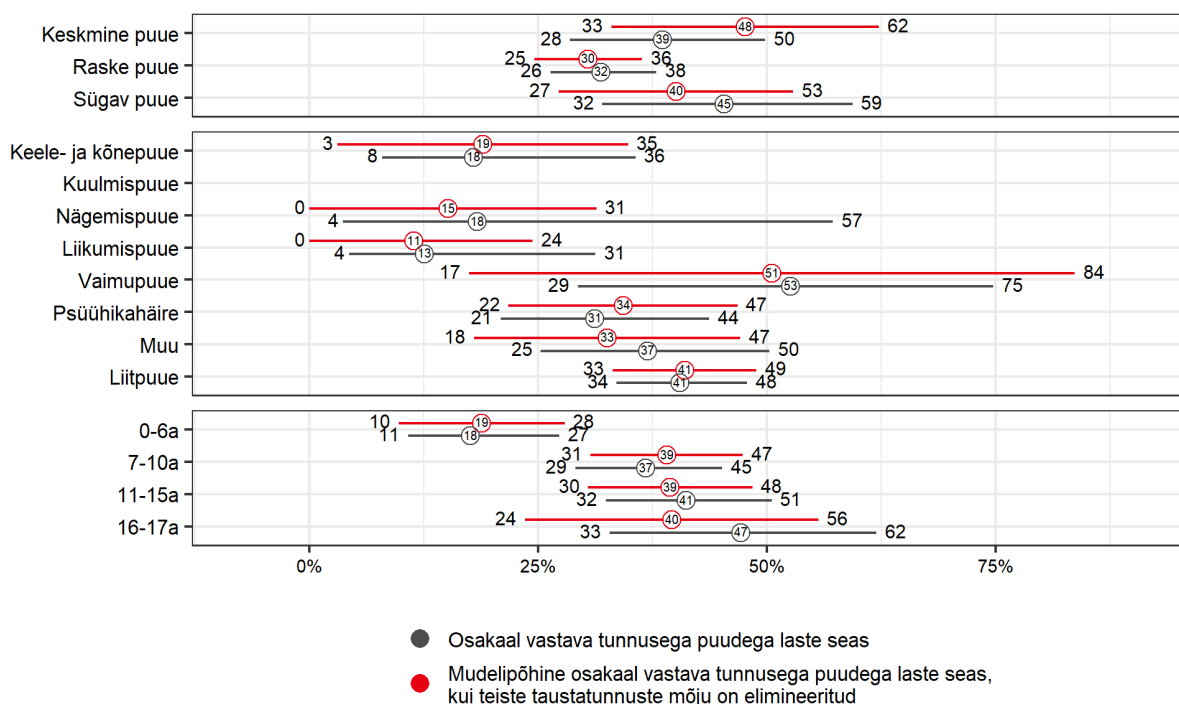
Nende seas, kellel on võimalik igapäevaselt autot kasutada, on vajadus sotsiaaltranspordi järele väiksem (15-18%) kui neil, kellel autokasutamisevõimalus puudub (24-35%) või kes omavad autokasutamise võimalust aeg-ajalt (22-34%).

Vanemate vanusegruppide seas on vajadus sotsiaaltranspordi teenuse järele veidi suurem kui nooremates vanusegruppides. Kuni 6-aastastest puudega lastest vajavad sotsiaaltranspordi 12-19%, 7-10-aastastest 19-25%, 11-15-aastastest 16-22% ja 16-17-aastastest 22-37%.

Vene keelt koduse keelena rääkivate laste vanemate seas on nende osakaal, kes tunnetavad vajadust sotsiaaltranspordi järele, veidi suurem (19-27%) kui kodus eesti keelt rääkivate laste vanemate seas (16-20%).

Sotsiaaltranspordi kättesaadavuse osas ei ole sotsiaaldemograafiliste gruppide vahel olulisi erinevusi. Ainukesena ilmnevad erinevused vanusegruppide võrdluses. Võrreldes alla 7-aastaste lastega on vanemate laste seas veidi enam neid, kes on saanud teenust piisavalt kasutada. Alla 7-aastastest, kes sotsiaaltranspordi vajasisid, on seda piisavalt saanud kasutada 11-27%, vanemates vanusegruppides aga enam kui 30% (7-10-aastastest 29-45%, 11-15-aastastest 32-51% ja 16-17-aastastest 33-62%) (Joonis 82).

Joonis 82. Sotsiaaltranspordi teenust viimase 12 kuu jooksul piisavalt kasutanud (% teenust vajanud puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Jooniselt on välja jäetud näitajad, mille usalduspiiride vahemik on suurem kui 70pp. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: kasutab teenust piisavalt = 1, kasutab teenust vähem kui vaja või ei kasuta üldse, aga vajab = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanuserühm, asula tüüp, kodune keel, vastaja haridustase, elukoha regioon, auto olemasolu peres.

Lisaks sellele, et sotsiaaltranspordi vajajatest saavad seda piisaval määral kasutada vähesed, on väiksematel lastel sotsiaaltranspordi kasutamine piiratum kui vanematel lastel. Alla 7-aastased lapsed küll vajavad sotsiaaltranspordi harvem kui vanemad lapsed, kuid nende laste jaoks, kellel seda on vaja, on see oluliselt halvemini kättesaadav kui vanemate vanuserühmade laste jaoks. Selline tulemus viitab vajadusele vaadata üle ka alla 7-aastastele lastele sotsiaaltranspordi pakkumise tingimused.

5.2.3 Lapsehoiuteenus

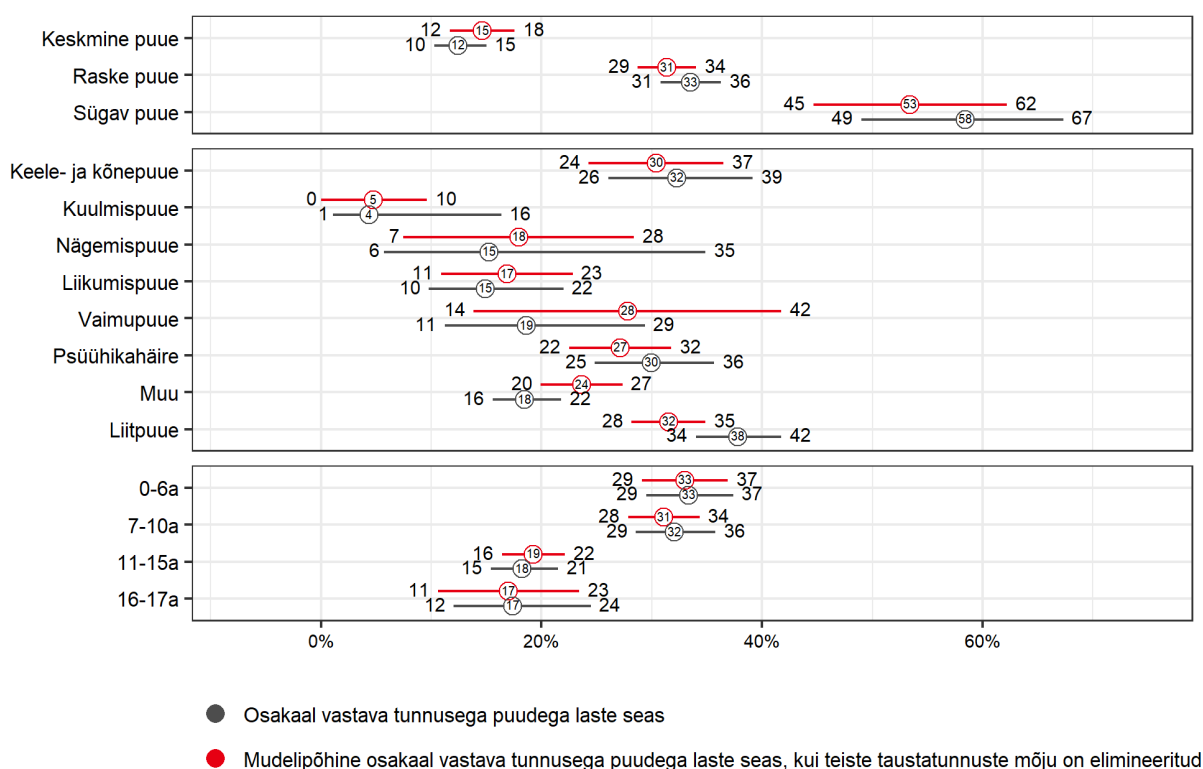
Lapsehoiuteenust on vaja 25–29 protsendil puudega lastest ja vaid ligi veerand (22-30%) teenuse vajajatest on saanud seda piisavas mahus kasutada. Enam kui pooltele (70-78%) puudega lastest, kellel on lapsehoiuteenust vaja olnud, pole see olnud piisavas mahus kättesaadav.

Lapsehoiuteenuse vajadus on seotud puude raskusastme, puude liigi ja lapse vanusega. Lapsehoiuteenuse vajadus on alla 11-aastastel lastel (teenust vajab 29-37% alla 6-aastastest ja 29-36% 7-10-aastastest puudega lastest) sagedasem kui vanematel lastel (11-15-aastastest vajavad lapsehoiuteenust 15-21% ja 16-17-aastastest 12-24%) (Joonis 83)

Raskema puude raskusastme korral on lapsehoiuteenuse vajadus suurem kui kergema puude raskusastme korral. Sügava puudega lastest vajavad lapsehoiuteenust 49-67%, raske puudega lastest 31-36% ja keskmise puudega lastest 10-15%. Puude raskusastme lõikes säilib erinevus ka siis, kui võrrelda samade taustatunnustega puudega lapsi.

Puudeliikidest on kuulmis- (1-16%), liikumis- (10-22%) ja muu puudega (16-22%) laste seas lapsehoiuteenuse vajadus harvem kui liitpuude (34-42%), keele- ja kõnepuude (26-39%) ning psüühikahäirega (25-36%) laste seas. Nägemis- ja vaimupuudega laste seas on lapsehoiuteenuse vajajate osakaal väga laias vahemikus, mistõttu ei saa selle kohta, kui paljudel nägemis- või vaimupuudega lastest on lapsehoiuteenust vaja, kuigi täpseid järeldusi teha.

Joonis 83. Lapsehoiuteenuse vajadus viimase 12 kuu jooksul (% puudega lastest)

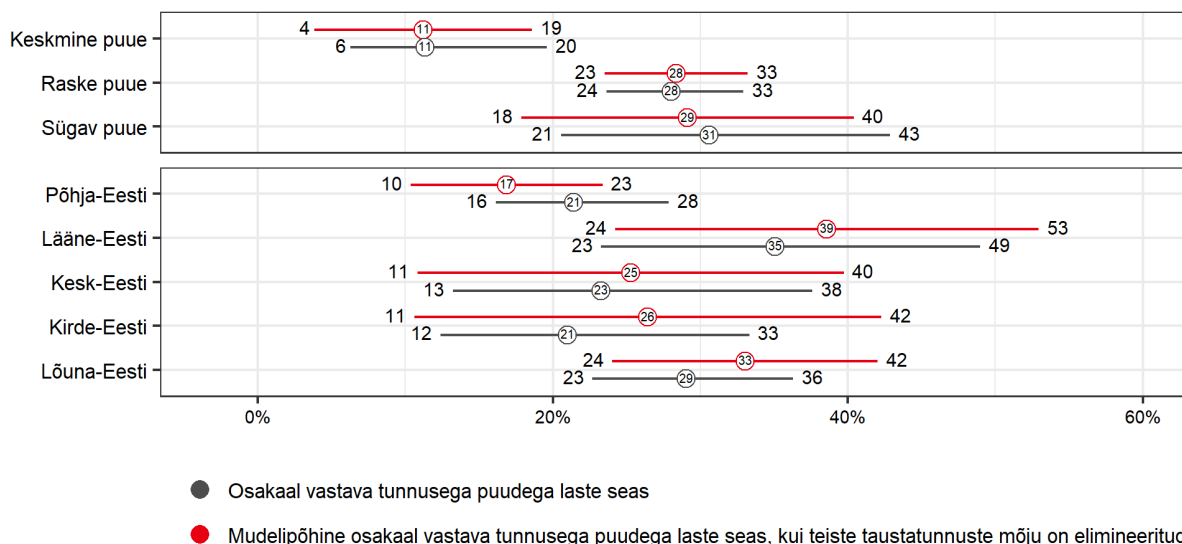


Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab teenust = 1, ei vaja teenust, ei tea teenust, ei oska öelda = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanus, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, vastaja haridustase, kodune keel.

Enamike taustatunnuste lõikes ei ole lapsehoiuteenuse kättesaadavuses statistiliselt olulisi erinevusi. Väikesed erinevused ilmnevad puude raskusastme ja elukoha regiooni lõikes (Joonis 84). Keskmise puudega

laste jaoks on lapsehoiuteenus halvemini kättesaadav kui raske või sügava puude raskusastmega lastele. Keskmise puudega lastest on lapsehoiuteenust saanud piisavalt kasutada 6-20%, raske puudega lastest 24-33% ja sügava puudega lastest 21-43% teenust vajanud puudega lastest. Sellised tulemused tunduvad kinnitavat, et riiklikult toetatud raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse olemasolu on võimaldanud nendele gruppidele ka parema teenuse kättesaadavuse kui muude tunnuste poolest sarnastel keskmise puudega lastel, kellel on samuti lapsehoiuteenust vaja. Siiski ei ole ühegi puudega laste grupi jaoks teenuse kättesaadavus kuigi hea.

Joonis 84. Lapsehoiuteenust teenust viimase 12 kuu jooksul piisavalt kasutanud (% teenust vajanud puudega lastest)



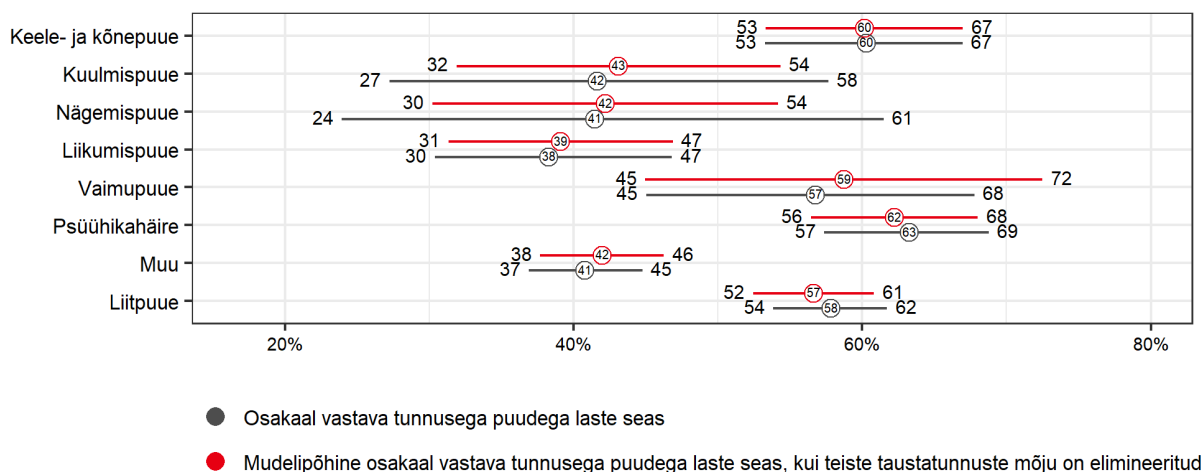
Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: kasutab teenust piisavalt=1, kasutab teenust vähem kui vaja või ei kasuta üldse, aga vajab = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanuserühm, asula tüüp, kodune keel, vastaja haridustase, elukoha regioon.

5.2.4 Sotsiaaltöötaja poolne nõustamine

Sotsiaaltöötaja poolset nõustamist tajuvad oma puudega lapsest lähtuvalt vajalikuna ca pooled (50-54%) puudega laste vanemad, selle teenuse vajajatest omakorda pooled (52-58%) on saanud nõustamist sellises mahus, nagu nad vajalikuks pidasid. Kättesaadavuse tasemelt on sotsiaaltöötaja poolne nõustamine pärast rehabilitatsiooniplaani koostamist sotsiaalteenuste seas teisel kohal, st antud teenuse kättesaadavus on parem kui enamiku teiste sotsiaalteenuste kättesaadavus.

Sotsiaaltöötaja poolse nõustamise vajadust ei tunnetata erinevad grupid sellisel määral erinevalt, et oleks võimalik välja tuua statistiliselt olulisi erinevusi. Ainult puudeliikide lõikes on liikumis- ja muu puudega laste vanemate seas tunnetatud vajadus sotsiaaltöötaja nõustamise järele veidi väiksem kui psüühikahäire, liitpuude ning keele- ja kõnepuudega laste vanemate seas (Joonis 85). Liikumispuudega laste vanematest tunnetab vajadust sotsiaaltöötaja nõustamise järele 30-47%, muu puudega laste vanematest 37-45%, samas kui liitpuudega laste vanematest 54-62%, psüühikahäirega laste vanematest 57-69% ja keele- ja kõnepuudega laste vanematest 53-67%.

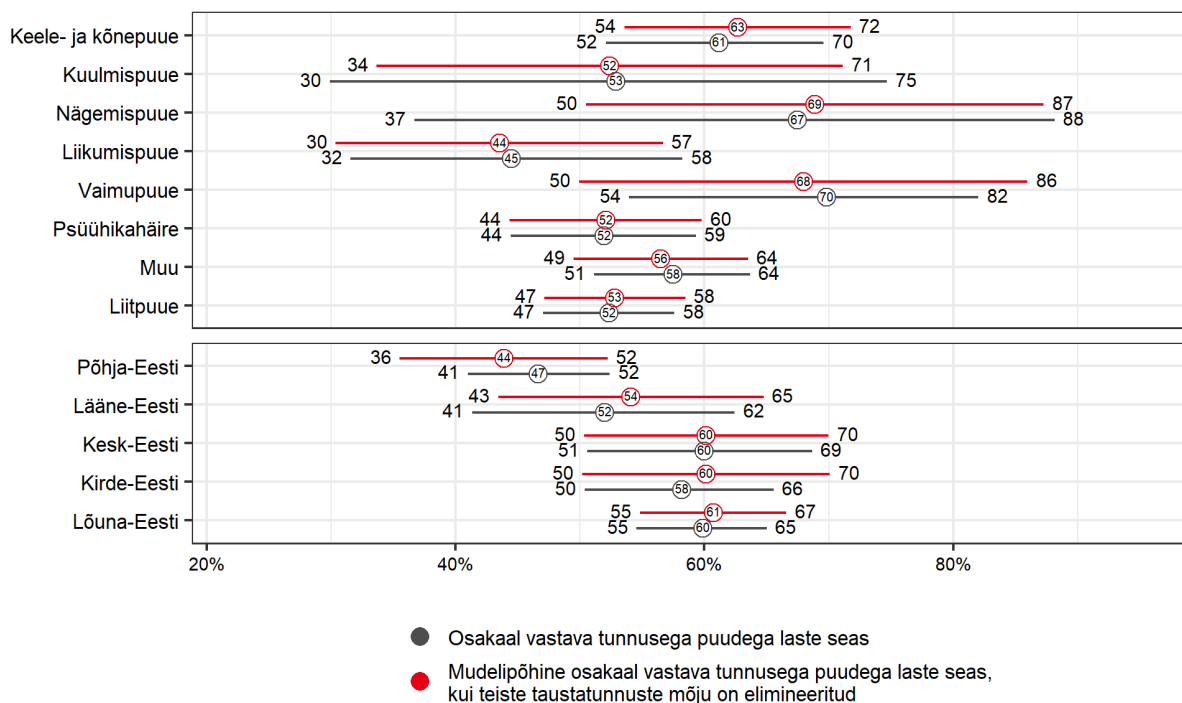
Joonis 85. Sotsiaaltöötaja nõustamise vajadus viimase 12 kuu jooksul (% puudega lastest) (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab teenust = 1, ei vaja teenust, ei tea teenust, ei oska öelda = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, elukoha regioon, elukoha liik, elukoha asula tüüp, vastaja haridustase, kodune keel, lapse vanus.

Samuti ei ole andmetest võimalik tuvastada märkimisväärsed erinevusi sotsiaaltöötaja poolse nõustamise kättesaadavuses taustatunnuste lõikes. Vaid regioonide ja puudeliikide lõikes on tuvastatavad väikesed erinevused. (Joonis 86)

Joonis 86. Sotsiaaltöötaja nõustamist viimase 12 kuu jooksul piisavalt saanud (% teenust vajanud puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: kasutab teenust piisavalt = 1, kasutab teenust vähem kui vaja või ei kasuta üldse, aga vajab = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanuserühm, asula tüüp, kodune keel, vastaja haridustase, elukoha regioon.

Põhja-Eestis on sotsiaaltöötaja nõustamise teenust piisaval määral kasutada saanud väiksem osakaal teenust vajanud puudega lastest (41-52% neist, kes teenust vajasisid) kui Kesk- (51-69%), Kirde- (50-66%) ja Lõuna-Eestis (55-65%). Liikumispuudega lastest, kes teenust vajasisid, on piisaval määral teenust kasutada saanud vähemad (32-58%) kui vaimu- (54-82%) ning keele- ja kõnepuudega (52-70%) lastest, kes teenust vajasisid. Samas on puudeliikide kohta eraldi võetuna võimalik saada vaid väga laiade usalduspiiridega hinnanguid, mistõttu jäävad erinevused enamasti statistilise vea piiridesse.

5.2.5 Rehabilitatsiooniplaani koostamine, täitmise juhendamine või tulemuste hindamine

Rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise juhendamise või tulemuste hindamise teenus on lapsevanemate poolt tunnetatud vajalikuna kõigist sotsiaalteenustest kõige enam ning samuti on see kõige paremini kättesaadav teenus. Teenuse vajadust tunnetatakse enamiku puudega laste jaoks (78–82%) ja neist, kellel on teenust vaja, on seda piisavalt kasutanud ligi kaks kolmandikku (63-68%). Rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise juhendamise ja tulemuste hindamise teenus on möödapääsmatu puudega lapse rehabilitatsiooniteenuste saamiseks. Ilma rehabilitatsiooniplaani koostamiseta ei saanud varemalt lapsele ka rehabilitatsiooniteenuseid määrata³², mistõttu on teenuse vajadus selle teenuse korral veidi teistsuguse tähendusega. Võib olla olukordi, kus lapsevanem tajub teenust vajalikuna, kuna seda on vaja teenusele saamiseks, kuid kui teenuseid oleks võimalik ilma plaanita saada, siis ei peetaks seda teenust ka vajalikuks.

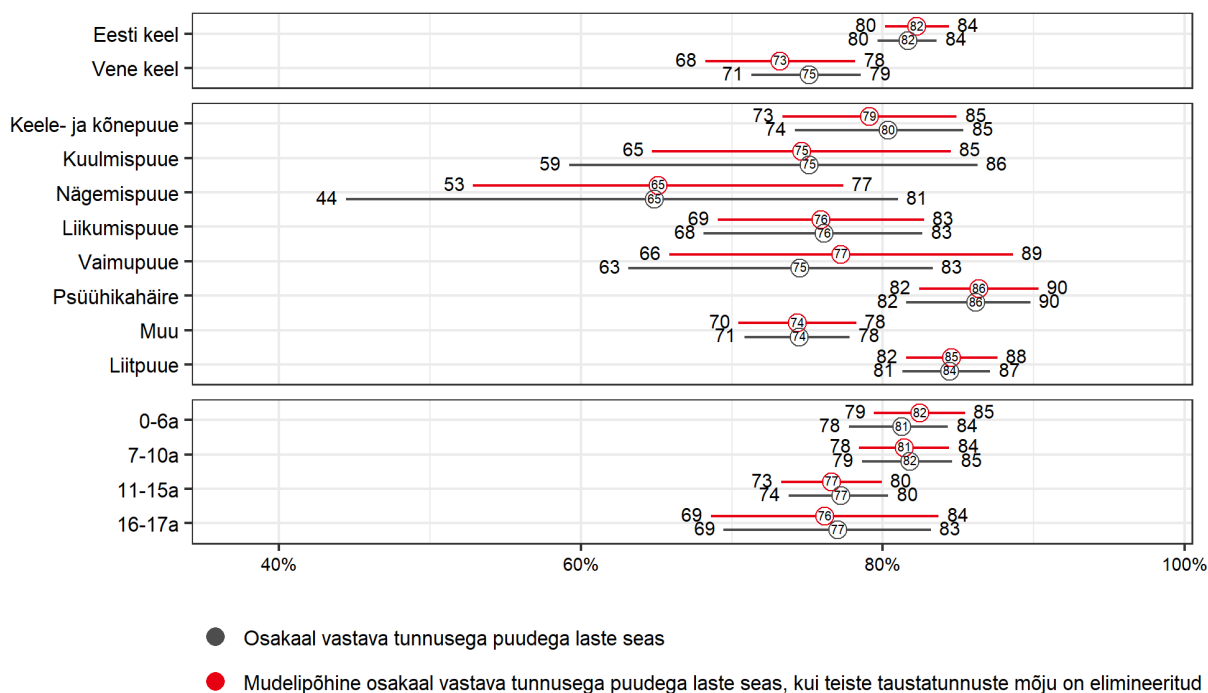
Vene keelt koduse keelena kõnelevatest vanematest hindavad rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise juhendamise või tulemuste hindamise teenust vajalikuna vähemad (71-79%) kui eesti keelt kõnelevatest vanematest (80-84%) (loonis 87). See erinevus jääb kehtima ka juhul, kui arvesse on võetud teiste taustatunnuste mõju.

Nooremate vanusegruppide laste seas on tunnetatud vajadus rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise juhendamise või tulemuste hindamise teenuse järele sagedasem kui 11-15 aastaste laste seas. 0-6-aastaste puudega laste vanematest 79-84% leiavad, et lapsel on teenust vaja. 7-10-aastaste puudega laste vanematest tunnetab vajadust teenuse järele 79-85% ja 11-15-aastaste laste vanematest 74-80%. 16-17-aastaste puudega laste kohta pole võimalik teha kuigi täpseid üldistusi, kuna hinnangu usalduspiirid on laiad ja seega ei eristu selle vanuserühma tulemus statistiliselt olulisel määral teiste vanusegruppide tulemustest.

Puudeliikidest eristuvad psüühikahäire (82-90% psüühikahäirega lastest vajavad rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise juhendamise või tulemuste hindamise teenust) ja liitpuue (81-87%), mille korral on rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise juhendamise või tulemuste hindamise teenuse vajajaid rohkem kui muu puude (71-78%), liikumispuude (68-83%) ja nägemispuude (44-81%) korral.

³² Praegu võib rehabilitatsiooniplaani asemel kasutada ka rehabilitatsiooniprogrammi.

Joonis 87. Rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise juhendamise või tulemuste hindamise teenuse vajadus viimase 12 kuu jooksul (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab teenust = 1, ei vaja teenust, ei tea teenust, ei oska öelda = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, elukoha regioon, elukoha liik, elukoha asula tüüp, vastaja haridustase, puude raskusaste, kodune keel, lapse vanus.

Taustatunnuste lõikes ei saa grupiti välja tuua selgeid ja suuri erinevusi, kelle jaoks rehabilitatsiooniplaani koostamise, juhendamise või tulemuste hindamise teenuse kättesaadavus on olnud parem ja kelle jaoks halvem (Joonis 88). Väikesed erinevused esinevad puude raskusastme, puude liigi ja regiooni lõikes.

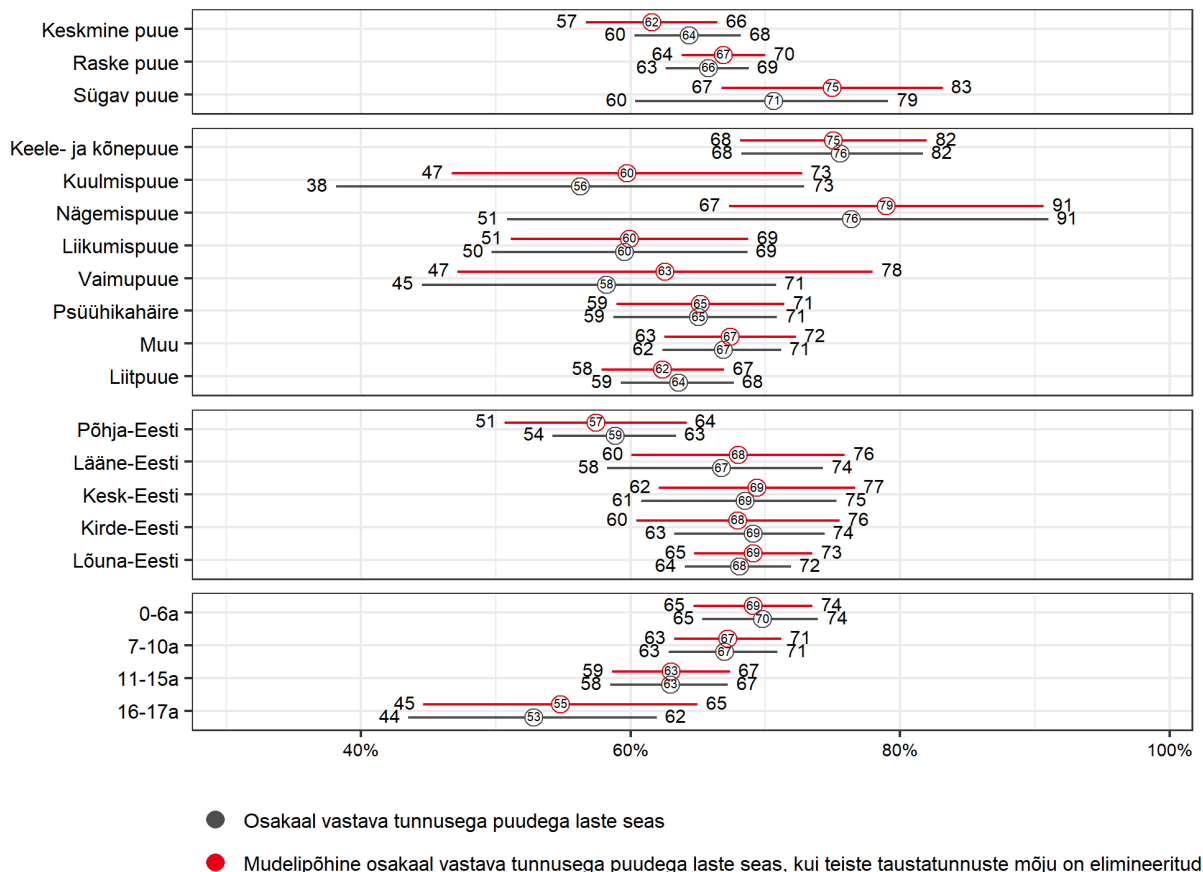
Liikumispuudega (51-69%), psüühikahäirega (59-71%) ja liitpuudega (59-68%) laste seas on rehabilitatsiooniplaani koostamise, juhendamise või tulemuste hindamise teenust piisavas mahus saanud lapsi veidi vähem kui keele- ja kõne- (68-82%) ning nägemispuudega (51-91%) laste hulgas. Nägemispuudega laste seas ei saa teisi taustatunnuseid arvesse võtmata erinevust teistest puudeliikidest välja tuua, aga kui võrrelda samade taustatunnustega lapsi, on nägemispuudega laste seas tõenäosus saada teenust piisavas mahus 67-91%, samas kui liitpuude korral on see 58-67%.

Rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise juhendamise või tulemuste hindamise teenust vajanud sügava puudega lastest 60-79% on saanud teenust piisavas mahus, raske puudega lastest vastavalt 63-69% ja keskmise puudega lastest vastavalt 60-68%. Puude raskusastmete vahelised erinevused ei ole statistiliselt olulised. Kui aga võrrelda samasuguste taustatunnustega lapsi, siis ilmneb, et sügava puudega lapsel on tõenäosus saada teenust piisavas mahus 67-83% ja keskmise puudega lapsel 57-66%. Seega muude samade taustatunnuste korral on sügava puudega laste vanemad suurema tõenäosusega seisukohal, et teenust on saadud piisavas mahus võrrelduna keskmise puudega laste vanematega.

Põhja-Eestis hinnatakse teenuste kättesaadavust harvem piisavaks kui Lõuna-Eestis. Põhja-Eesti puudega laste vanematest, kelle hinnangul on nende puudega laps antud teenust vajanud, leiab 54-63%, et teenust on saadud piisavalt, Lõuna-Eesti puudega laste vanematest vastavalt 64-72%. Kesk- ja Kirde-Eestis on rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise juhendamise või tulemuste hindamise teenust saanud piisavalt

vastavalt 63-74% ja 61-75% teenuse vajajatest, mida on samuti veidi enam kui Põhja-Eestis. Samas ei ole peale muude taustatunnuste mõju arvesse võtmist Põhja-Eesti ja Kesk- ning Kirde-Eesti vahelised erinevused statistiliselt olulised.

Joonis 88. Rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise juhendamise või tulemuste hindamise teenust viimase 12 kuu jooksul piisavalt kasutanud (% teenust vajanud puudega lastest)

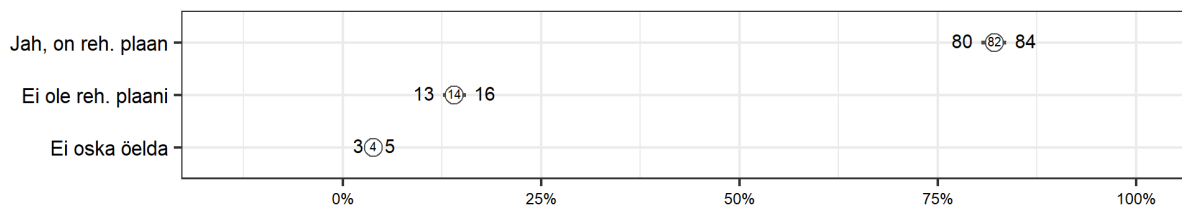


Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: kasutab teenust piisavalt = 1, kasutab teenust vähem kui vaja või ei kasuta üldse, aga vajab = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanuserühm, asula tüüp, kodune keel, vastaja haridustase, elukoha regioon.

5.2.6 Rehabilitatsiooniplaan

Rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise juhendamise ja tulemuste hindamise teenus on tihedalt seotud rehabilitatsiooniplaani olemasoluga. Kehtiv rehabilitatsiooniplaan oli viimase 12 kuu jooksul vähemalt mõnda aega neljal viiendikul (80–84%) puudega lastest (Joonis 89).

Joonis 89. Kehtiva rehabilitatsiooniplaani olemasolu viimase 12 kuu jooksul, sh ka lühema aja vältel (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

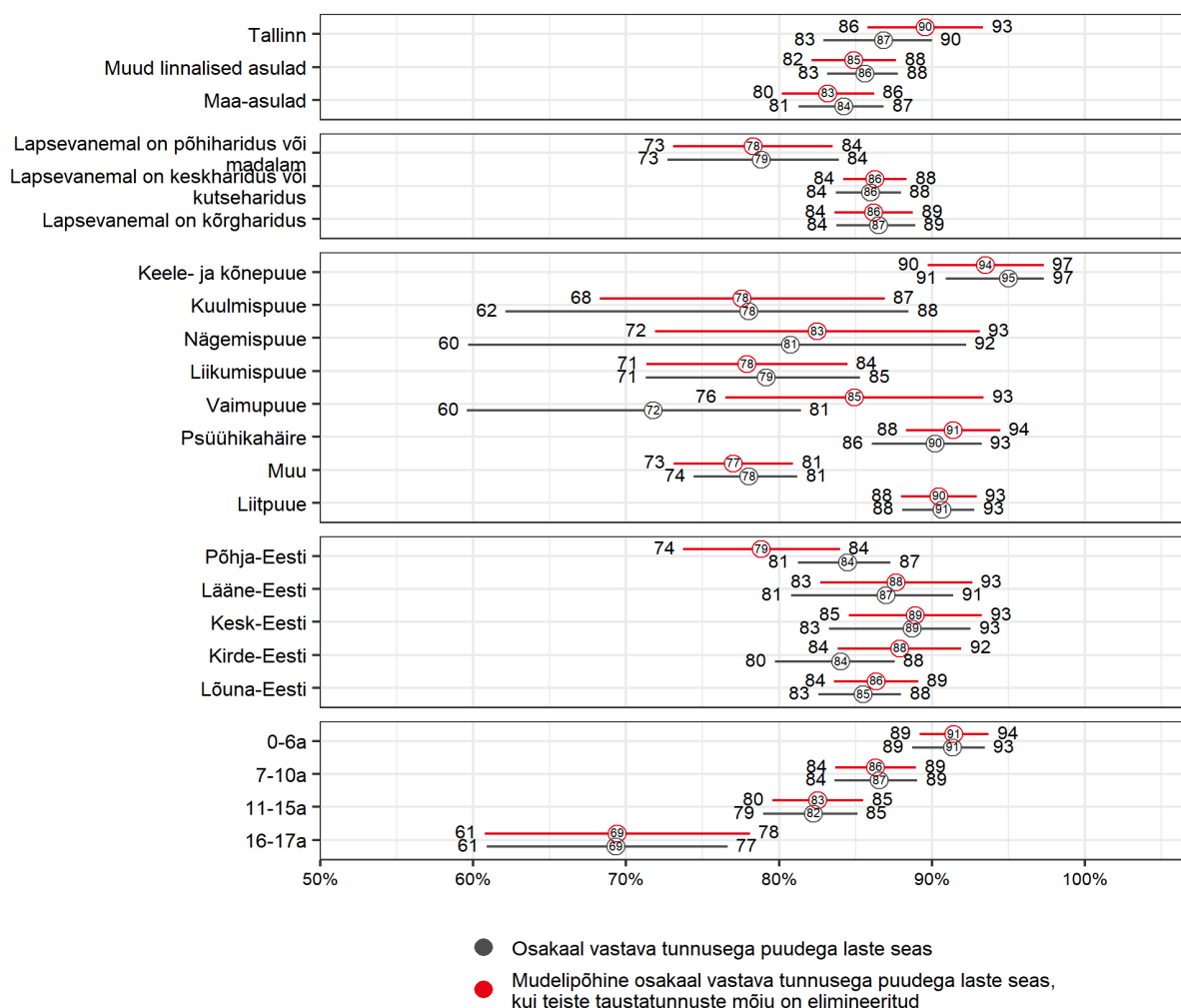
Nooremate vanuserühmade puudega lastest oli neid, kellel oli kehtiv rehabilitatsiooniplaan olemas, rohkem kui vanemate vanuserühmade lastest (Joonis 90). Alla 7-aastastest puudega lastest oli rehabilitatsiooniplaan viimase 12 kuu jooksul 89-93%, 7-10-aastastest 84-89%, 11-15-aastastest 79-85% ja 16-17-aastastest 61-77%. Võrreldes alla 7-aastaste puudega lastega on 16-17-aastaste puudega laste seas kehtiva rehabilitatsiooniplaaniga lapsed 12-30 protsendipunkti võrra vähem. Sarnased erinevused ilmnevad vanuserühmade vahel ka juhul, kui teiste taustatunnuste mõju elimineerida.

Keele- ja kõnepuudega, psüühikahäirega ning liitpuudega lastest ligi 90% on kehtiv rehabilitatsiooniplaan. Teistesse puudeliikidesse kuuluvatest lastest on rehabilitatsiooniplaan veidi vähemal. Keele- ja kõnepuudega lastest on rehabilitatsiooniplaan 91-97%, psüühikahäirega lastest 86-93% ja liitpuudega lastest 88-93%. Muu puudega lastest on rehabilitatsiooniplaan 74-81%, liikumispuudega lastest 71-85%, vaimupuudega lastest 60-81% ja kuulmispuudega lastest 62-88%. Nägemispuudega laste puhul ei saa rehabilitatsiooniplaani olemasolu esinemissagedust kuigi täpselt hinnata, kuna hinnangu usalduspiirid on väga laiad.

Puudega lastest, kellel on vanem põhiharidusega, on rehabilitatsiooniplaan väiksemal osal kui kõrgema haridusega lapsevanemate lastel. Vastavalt on põhihariduse või madalama haridustasemega vanematega puudega lastest rehabilitatsiooniplaan 73-84% ja kõrgema haridustasemega vanematega puudega lastest 84-89%. Ka teiste taustatunnuste mõju arvesse võttes jäävad lapsevanema haridustasemest lähtuvad erinevused kehtima.

Vaadates rehabilitatsiooniplaani omavate laste osakaalu erinevates regioonides ja asulatüüpides, ei erine asulatüübid ja regioonid üksteisest statistiliselt oluliselt. Tallinnas on rehabilitatsiooniplaan 83-90%, muudes linnades 83-88% ja maa-asulates 81-87% puudega lastest. Kui aga võrrelda samade taustatunnustega lapsi, on Tallinnas elaval puudega lapsel rehabilitatsiooniplaani olemasolu tõenäosus 86-93% ja maa-asulates vastavalt 80-86% ehk maa-asulates on rehabilitatsiooniplaan tõenäoliselt olemas väiksemal osal puudega lastest. Samasugune erinevus ilmneb Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti vahel: keskmiselt on Põhja-Eestis rehabilitatsiooniplaan olemas 81-87% puudega lastest ja Lõuna-Eestis 84-89% puudega lastest ja erinevust regioonide vahel ei ole. Kui aga võrrelda samasuguste taustatunnustega lapsi Põhja- ja Lõuna Eestis, siis on rehabilitatsiooniplaani omamise tõenäosus 74-84% Põhja-Eesti ja 84-49% Lõuna-Eesti puudega laste seas.

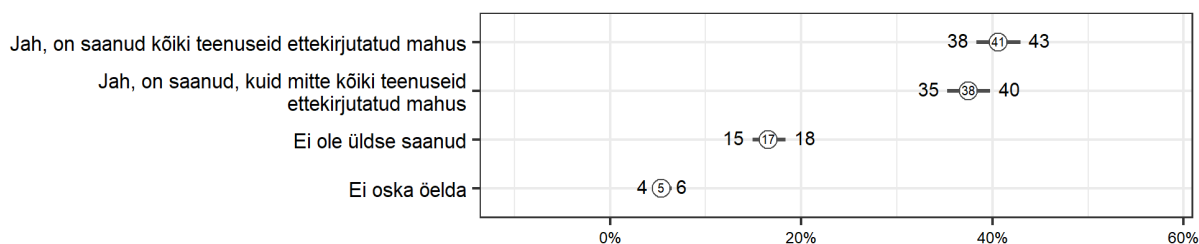
Joonis 90. Kehtiva rehabilitatsiooniplaani olemasolu viimase 12 kuu jooksul, sh ka lühema aja vältel (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on rehabilitatsiooniplaan viimase 12 kuu jooksul = 1, ei olnud rehabilitatsiooniplaani = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, vastaja haridustase, kodune keel, lapse vanus.

Neist puudega lastest, kellel oli viimase 12 kuu või lühema aja vältel kehtiv rehabilitatsiooniplaan olemas, said 38–43% kõiki rehabilitatsiooniplaanis olnud teenuseid ettekirjutatud mahus (Joonis 91). Vaid osasid teenuseid sai pea sama osakaal (35–40%) ja üldse ei saanud rehabilitatsiooniteenuseid 15-18% rehabilitatsiooniplaaniga puudega lastest.

Joonis 91. Kas laps on saanud kõiki rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud teenuseid ette kirjutatud mahus? (% puudega lastest, kellel oli viimase 12 kuu (sh ka lühema aja) vältel olemas kehtiv rehabilitatsiooniplaan)

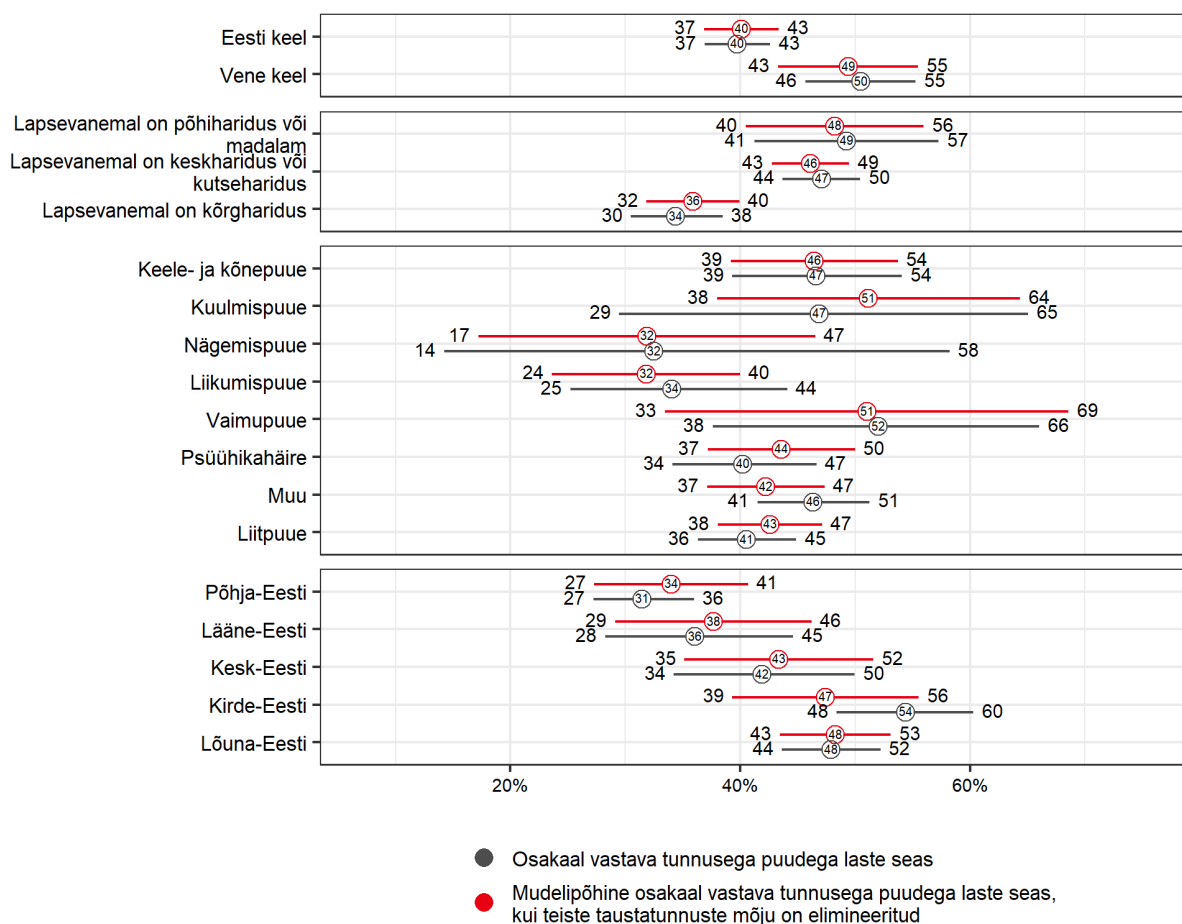


Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

Taustatunnuste kaupa võrdlusest on välja jäetud vastajad, kes ei osanud küsimusele, kas laps on rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud teenuseid plaanis ettekirjutatud mahus saanud, vastust anda.

Võrreldes lapsevanematega, kelle kodune keel on vene keel, arvasid koduse keelena eesti keelt kõnelevad lapsevanemad harvemini, et laps sai kõiki rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud rehabilitatsiooniteenuseid ettekirjutatud mahus (Joonis 92). Vastavalt hindas 37-43% koduse keelena eesti keelt ja 46-55% vene keelt kõnelevatest lapsevanematest, kelle puudega lapsel oli kehtiv rehabilitatsiooniplaan, et laps on saanud kõiki rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud teenuseid ettekirjutatud mahus.

Joonis 92. Puudega lapsed, kes on viimase 12 kuu jooksul saanud kõiki rehabilitatsiooniplaanis olevaid rehabilitatsiooniteenuseid ettekirjutatud mahus (% puudega lastest, kellel oli viimase 12 kuu (sh ka lühema aja) vältel kehtiv rehabilitatsiooniplaan)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on saanud kõiki rehabilitatsiooniplaanis olnud teenuseid viimase 12 kuu jooksul = 1, ei ole saanud ühtegi või osasid teenuseid = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, elukoha regiooni, elukoha asula tüüp, vastaja haridustase, kodune keel, lapse vanus.

Kõrgharidusega vastajad on saanud rehabilitatsiooniteenuste mahu suhtes kriitilisemad kui madalama haridusega lapsevanemad ning nende seas on oluliselt vähem neid, kelle hinnangul sai laps kõiki rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud rehabilitatsiooniteenuseid ettekirjutatud mahus (30-38%). Kesk- või kutseharidusega lapsevanematest ütles 44-50%, et laps sai kõiki ette nähtud rehabilitatsiooniteenuseid ettekirjutatud mahus, põhihariduse või madalama haridustasemega lapsevanematest vastavalt 41-57%.

Erinevused puudega lapse vanema hariduse lõikes jäävad püsima ka siis, kui on arvestatud teiste taustatunnuste mõjuga.

Põhja-Eesti puudega lastest on 27-36% saanud kõiki rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud teenuseid ettekirjutatud mahus. Kirde- ja Lõuna-Eestis on ettekirjutatud mahus teenuseid saanud laste protsent suurem, vastavalt 48-60% ja 44-52%. Lääne- ja Kesk-Eesti näitajad enamikust regioonidest statistiliselt oluliselt ei erine (vastavalt 28-45% ja 34-50%). Kui aga võtta arvesse ka teiste taustatunnuste mõju, erinevad üksteisest vaid Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti: Põhja-Eestis on tõenäosus saada kõiki rehabilitatsiooniplaani teenuseid väiksem ja Lõuna-Eestis suurem (vastavalt 27-41% ja 43-53%).

5.2.7 Füsioterapeut

Füsioterapeudi teenust vajab 67–70% puudega lastest, neist piisavalt saab füsioterapeudi teenust kasutada 37–42%.

Erinevused tunnetatud vajaduses füsioterapeudi teenuse järele esinevad rehabilitatsiooniplaani olemasolu, puude raskusastme, puude liigi ja lapsevanema haridustaseme lõikes (Joonis 93).

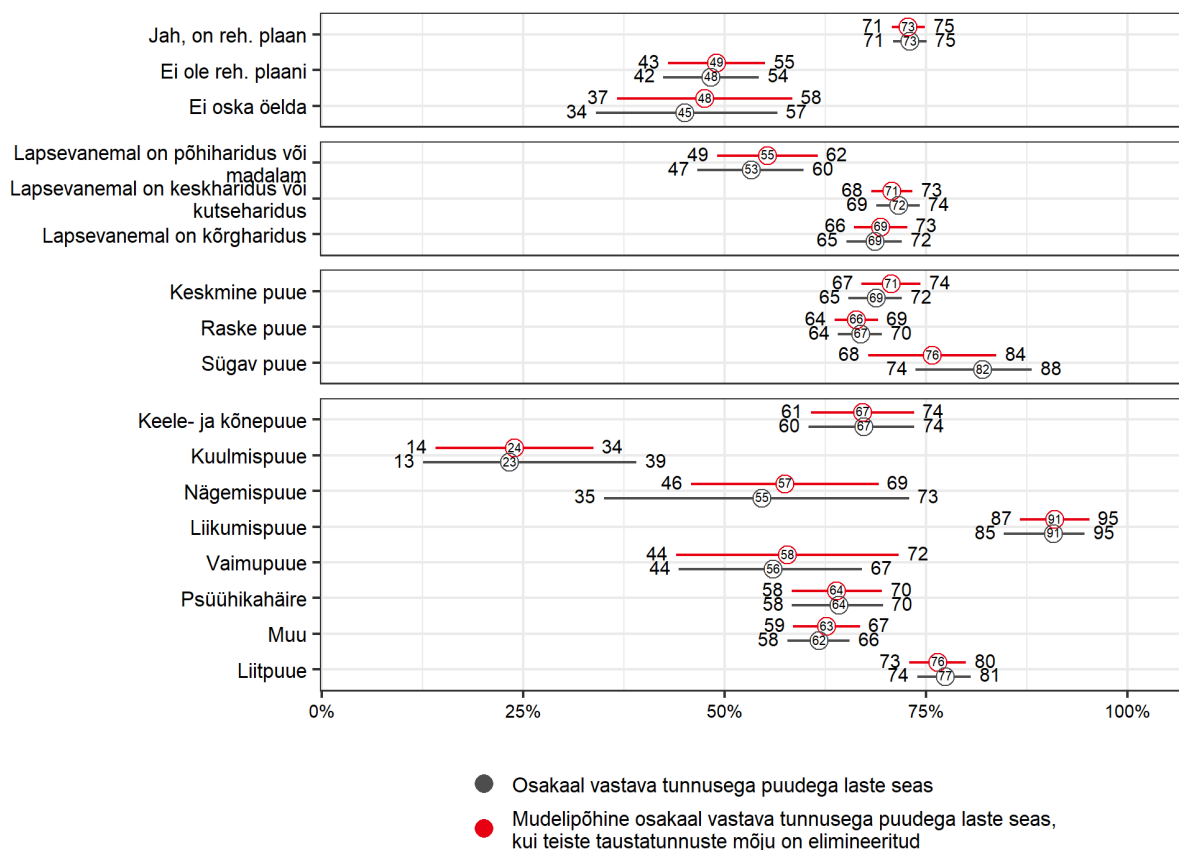
Rehabilitatsiooniplaaniga puudega lastest on vajadus füsioterapeudi järele 71-75 protsendil. Neist, kellel rehabilitatsiooniplaani pole, on füsioterapeudi järele vajadus 42-54%. Selline erinevus püsib ka siis, kui võtta arvesse ka teiste taustatunnuste mõju.

Sügava puudega lastest on vajadus füsioterapeudi järele 74-88%, raske ja keskmise puudega lastest väiksemal osal (vastavalt 64-70% ja 65-72%). Samas kui arvesse on võetud ka teiste taustatunnuste mõju, siis jääb alles väga väike erinevus vaid sügava ja raske puudega laste vahel ning statistiliselt oluline erinevus keskmise puudega lastega puudub.

Pea kõik liikumispuudega laste vanemad tunnetavad oma lapse puhul vajadust füsioterapeudi järele (85-95% liikumispuudega lastest vajavad nende vanemate hinnangul füsioterapeudi teenust). Ka liitpuudega lastest vajavad füsioterapeudi teenust enam kui kolm neljandikku (74-81%). Teiste puudeliikidega lastest vajab füsioterapeuti väiksem osa. Kõige harvem tunnetati vajadust füsioterapeudi järele kuulmispuudega laste puhul, kellest on füsioterapeuti vaja 13-39%.

Põhihariduse või madalama haridustasemega lapsevanematest tajub lapse vajadust füsioterapeudi teenuse järele väiksem osa kui kõrgema haridustasemega lapsevanematest. Põhiharidusega vanematest 47-60% leiavad, et nende puudega lapsel on vaja füsioterapeudi teenust, keskharidusega vanematest vastavalt 69-74% ja kõrgharidusega vanematest vastavalt 65-72%.

Joonis 93. Füsioterapeudi teenuse vajadus viimase 12 kuu jooksul (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsis on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab teenust = 1, ei vaja teenust, ei tea teenust, ei oska öelda = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, vastaja haridustase, kodune keel, lapse vanus, rehabilitatsiooniplaani olemasolu lapsel.

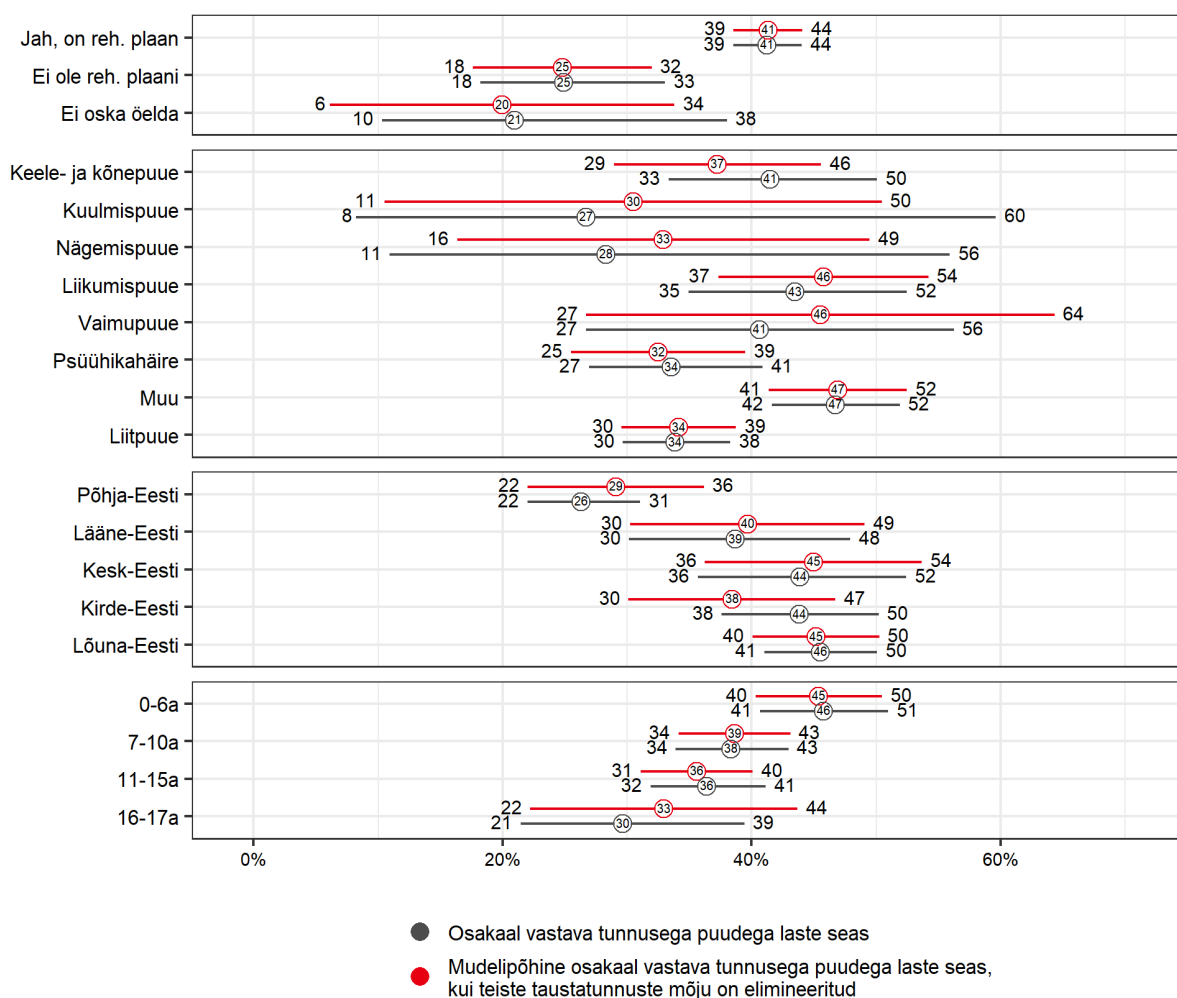
Lisaks sellele, et lapse kehtiva rehabilitatsiooniplaani olemasolul on vanemate poolt tunnetatud vajadus füsioterapeudi teenuse järele suurem, saavad rehabilitatsiooniplaaniga lapsed ka suurema tõenäosusega füsioterapeudi teenust lapse vajadustele vastavas mahus (Joonis 94). Rehabilitatsiooniplaaniga lastest, kes füsioterapeudi teenust vajavad, on 39-44% antud teenust saanud nii palju kui vaja, kuid lastest, kellel pole rehabilitatsiooniplaani, on saanud teenust piisavas mahus 18-33%.

Põhja-Eestis on füsioterapeudi teenust piisavas mahus saanud laste osakaal kõigist teenust vajavatest puudega lastest väiksem (22-31%) kui teistes Eesti regioonides (kus see on ligikaudu 30-50%). Kui võtta arvesse teiste taustatunnuste mõju, jääb erinevus Põhja-Eesti ja Kesk- ning Lõuna-Eestis elavate puudega laste vahel statistiliselt oluliseks: Põhja-Eestis on füsioterapeudi kättesaadavus suhteliselt halvem ja Kesk- ning Lõuna-Eestis suhteliselt parem.

Alla 7-aastastest puudega lastest, kes füsioterapeudi teenust vajavad, on teenust vajadustele vastavas mahus saanud suurem osa lapsi (41-51%) kui vanemate vanusgruppide lastest. 7-10-aastastest on piisavas mahus füsioterapeudi teenust saanud 34-43%, 11-15-aastastest 32-41% ja 16-17-aastastest 21-39%.

Puudeliikide lõikes ei ole väga selgeid ja suuri erinevusi füsioterapeudi teenuse saamisel lapse vajadustele vastavas mahus.

Joonis 94. Füsioterapeudi teenust viimase 12 kuu jooksul piisavalt kasutanud (% teenust vajanud puudega lastest)



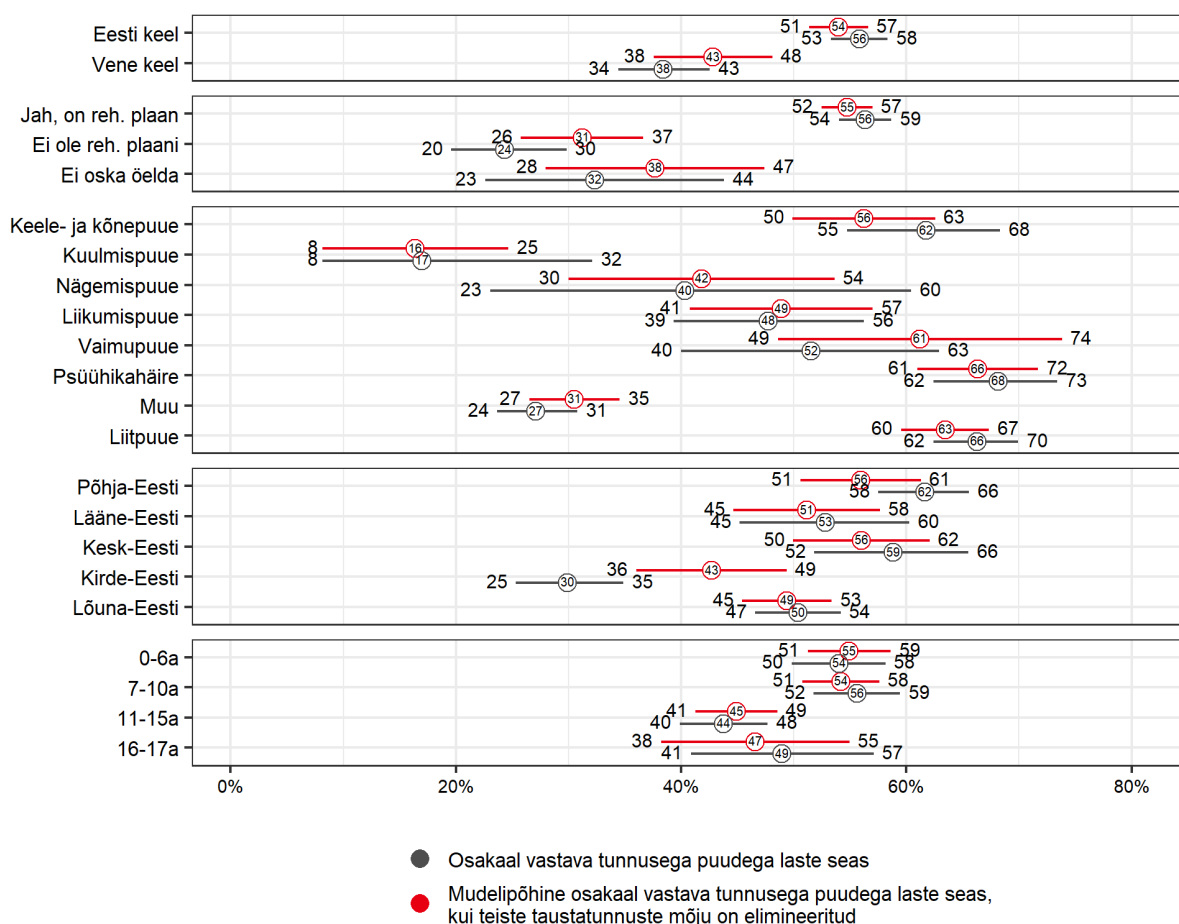
Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: kasutab teenust piisavalt = 1, kasutab teenust vähem kui vaja või ei kasuta üldse, aga vajab = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanuserühm, asula tüüp, kodune keel, vastaja haridustase, elukoha regioon, rehabilitatsiooniplaani olemasolu.

5.2.8 Tegevusterapeut

Tegevusterapeuti on vaja 49–53%l puudega lastest ja piisavalt on tegevusterapeudi teenust saanud kasutada ca kolmandik neist (30–36%), kes seda vajavad.

Nii nagu füsioterapeudi teenust, hinnatakse ka tegevusterapeudi teenust vajalikuks sagedamini nende vanemate poolt, kelle lapsel on rehabilitatsiooniplaan olemas. 54–59% (Joonis 95) rehabilitatsiooniplaaniga puudega laste vanematest leiavad, et tegevusterapeudi teenus on nende lapse jaoks vajalik. Ilma rehabilitatsiooniplaanita puudega laste vanematest peab tegevusterapeudi teenust oma lapse jaoks vajalikuks 20–30%. Kui võtta arvesse ka teiste taustatunnuste mõju, siis vähenevad erinevused rehabilitatsiooniplaaniga ja ilma rehabilitatsiooniplaanita laste vanemate hinnangutes veidi, kuid hinnangute erinevus jääb siiski suhteliselt suureks ja statistiliselt oluliseks.

Joonis 95. Tegevusterapeudi teenuse vajadus viimase 12 kuu jooksul (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab teenust = 1, ei vaja teenust, ei tea teenust, ei oska öelda = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, vastaja haridustase, puude raskusaste, kodune keel, lapse vanus, rehabilitatsiooniplaani olemasolu.

Suured erinevused tegevusterapeudi vajaduses on ka puudeliikide lõikes. Teistest puudeliikidest vähem on tegevusterapeuti vaja kuulmis- ja muu puudega lastel. Kuulmispuudega lastest on tegevusterapeudi vajadus 8-32% ja muu puudega lastest 24-31%. Liikumis- ja vaimupuudega lastest on viimase 12 kuu jooksul tegevusterapeuti vajanud vastavalt 39-56% ja 40-63%. Teistest enam on tegevusterapeuti vajanud keele- ja kõnepuudega lapsed (55-68%), psüühikahäirega (62-73%) ja liitpuudega (62-70%) lapsed. Nägemispuudega lastest on tegevusterapeuti vajanute osakaal nii laiade usalduspiiridega, et selle grupi tegevusterapeudi vajaduse kohta on väga keeruline midagi täpselt öelda (tegevusterapeuti vajab neist 23-60%). Kui võrrelda samasuguste taustatunnustega lapsi, on tegevusterapeudi vajamise tõenäosus kõrgem vaimupuudega, liitpuude ja psüühikahäirega laste seas.

Väikesed erinevused tegevusterapeudi tunnetatud vajaduses ilmnevad ka puudega lapse koduse keele, vanuserühma ja elukoha regiooni alusel. Eesti keelt koduse keelena kõnelevate puudega laste vanematest 53-58% leidis, et lapsel on vaja tegevusterapeuti, vene keelt kõnelevatest aga 34-43%. Kui eesti ja vene keelt kõnelevate laste taustatunnuste erinevused arvesse võtta ja võrrelda samade taustatunnustega lapsi, on erinevus väga väike (ca 10 protsendipunkti), aga siiski olemas.

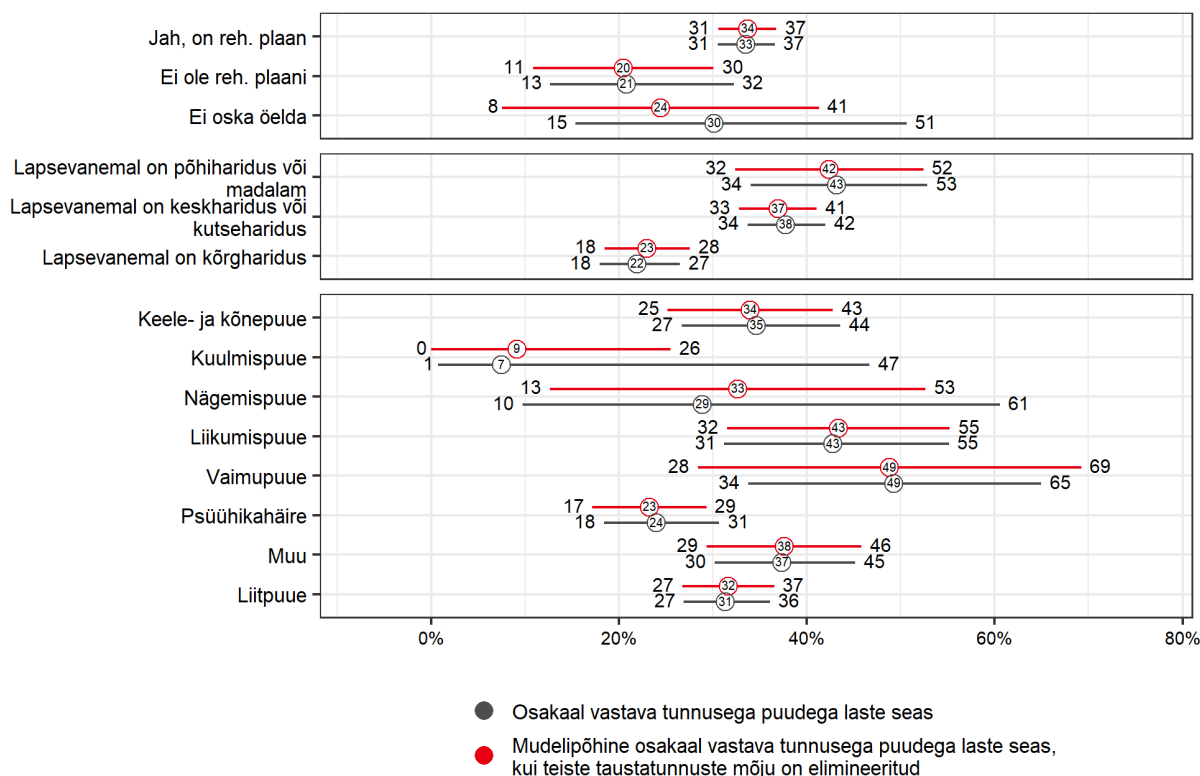
Kirde-Eestis elavate puudega laste vanematest leidis 25-35%, et lapsel on vaja tegevusterapeuti. Kõigis teistes Eesti regioonides oli tegevusterapeudi tunnetatud vajadus suurem (Põhja-Eestis 56-66%, Lääne-

Eestis 45-60%, Kesk-Eestis 52-66% ja Lõuna-Eestis 47-54%). Kirde-Eestis on tunnetatud vajadus tegevusterapeudi järele väga madal, kuid see ei tulene peamiselt mitte regionaalsest erinevusest vaid sellest, et piirkonnas elavad suures osas vene keelt koduse keelena rääkivad lapsed ja kodune keel selgitab erinevusi. Kui võrrelda ühesuguste taustatunnustega lapsi, siis ei erine Kirde-Eesti tulemus statistiliselt olulisel määral Lääne- ja Lõuna-Eestist, väike erinevus jääb Põhja- ja Kesk-Eestiga.

Alla 11-aastaste puudega laste puhul oli tunnetatud vajadus tegevusterapeudi järele veidi suurem (50-58% 0-6-aastaste ja 52-59% 7-10-aastaste seas) kui 11-15-aastaste puudega laste puhul (40-48%). 16-17-aastaste erinevust teistest vanuserühmadest ei saa antud vanuserühma laiade usalduspiiride tõttu kindlalt väita.

Küsitluse andmete põhjal saame tuvastada, et tegevusterapeudi teenust piisavalt kasutada saanud laste osas esinevad erinevused rehabilitatsiooniplaani olemasolu, puudeliikide ja lapsevanema haridustaseme lõikes (Joonis 96). Neist puudega lastest, kellel on rehabilitatsiooniplaan, on vajadustele vastavalt tegevusterapeudi teenust saanud kasutada suurem osa (31-37%) võrreldes nendega, kellel pole viimase 12 kuu jooksul rehabilitatsiooniplaani olnud (13-32%). Väga väike erinevus rehabilitatsiooniplaaniga ja ilma rehabilitatsiooniplaanita laste tegevusterapeudi vajaduses säilib ka sel juhul, kui teiste taustatunnuste mõju on arvesse võetud.

Joonis 96. Tegevusterapeudi teenust viimase 12 kuu jooksul piisavalt kasutanud (% teenust vajanud puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: kasutab teenust piisavalt = 1, kasutab teenust vähem kui vaja või ei kasuta üldse, aga vajab = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanuserühm, asula tüüp, kodune keel, vastaja haridustase, elukoha regioon, rehabilitatsiooniplaani olemasolu.

Muude samasuguste taustatunnustega laste võrdlemisel on kuulmispuudega ning psüühikahäirega laste seas võrrelduna liikumispuudega ning muu puudega lastega oluliselt vähem neid, kes on tegevusterapeudi teenust piisavas mahus kasutanud.

Tegevusterapeudi teenuse kättesaadavust hindab ebapiisavaks kõrgharidusega lapsevanematest suurem osakaal kui madalama haridusega lapsevanematest. Kõrgharidusega puudega laste vanematest leidis 18-27%, et laps sai teenust kasutada oma vajadustele vastavas mahus, kesk- või kutseharidusega vanematest arvas nii vastavalt 34-42% ja põhi- või madalama haridusega vanematest vastavalt 34-53%. Puudega lapse vanema hariduse lõikes ilmnunud erinevused on samas suurusjärgus ka siis, kui arvesse on võetud teiste taustatunnuste mõju.

5.2.9 Loovterapeut

Loovterapeudi teenust vajab 41–45% puudega lastest, kellest omakorda on saanud piisavas mahus seda teenust kasutada 22–28%. Loovterapeudi teenus on suhteliselt vähetuntud teenus: 23–27% puudega laste vanematest ei teadnud loovterapeudi teenust või ei osanud hinnata, kas lapsel on seda vaja.

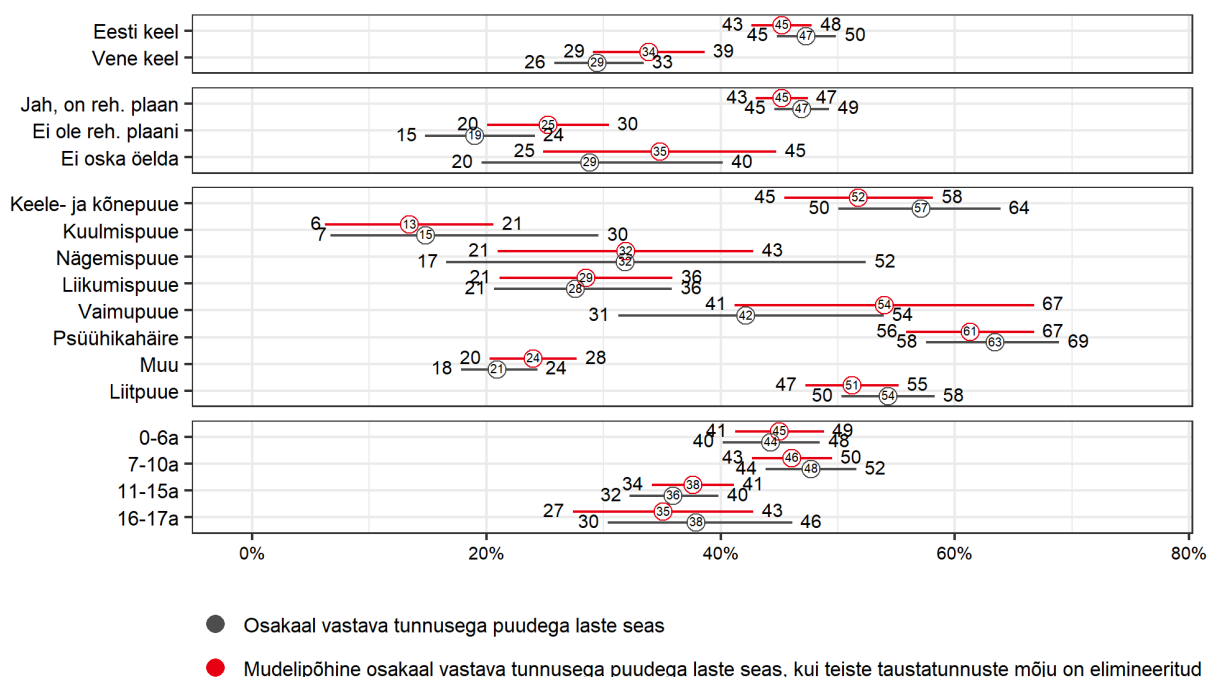
Nagu teistegi rehabilitatsiooniplaani teenuste puhul, on ka loovterapeudi puhul tunnetatud vajadus teenuse järele tõenäolisem, kui lapsel on rehabilitatsiooniplaan. Rehabilitatsiooniplaaniga puudega lastest vajas nende vanemate sõnul viimase 12 kuu jooksul loovterapeudi teenust 45-49%; samas kui neist, kellel rehabilitatsiooniplaani polnud, vajas loovterapeudi teenust nende vanemate sõnul 15-24%. Kui võtta arvesse teiste taustatunnuste mõju, on erinevus rehabilitatsiooniplaaniga ja ilma rehabilitatsiooniplaanita laste vanemate hinnangutes veidi väiksem, kuid siiski statistiliselt oluline. Muude taustatunnuste mõju arvesse võtmisel on loovterapeudi tunnetatud vajamise tõenäosus 43-47%, kui lapsel on rehabilitatsiooniplaan, ja 20-30%, kui rehabilitatsiooniplaani pole (Joonis 97).

Puudeliikidest on loovterapeudi teenuse tunnetatud vajadus olnud viimase 12 kuu jooksul suurem keele- ja kõnepuudega (50-64%), psüühikahäire (58-69%) ja liitpuudega (50-58%) laste puhul. Selgelt väiksem on olnud vajadus loovterapeudi teenuse järele kuulmispuudega (7-30%), liikumispuudega (21-36%) ja muu puudega (18-24%) laste puhul. Vaimupuudega ja nägemispuudega laste seas on loovterapeudi vajanud laste osakaalu hinnang väga suurte usalduspiiridega (vastavalt 31-54% ja 17-52%), mistõttu ei saa neid liigitada ei suurema ega väiksema loovterapeudi vajadusega puudeliikidega laste rühma. Kui võrrelda samade taustatunnustega lapsi, paigutuvad nägemispuudega lapsed pigem sellesse gruppi, kus loovterapeudi teenuse vajadus on väiksem (21-43%), ja vaimupuudega lapsed gruppi, kus loovterapeudi vajadus on suurem (41-67%).

Alla 11-aastastest puudega lastest on viimase 12 kuu jooksul loovterapeudi vajanud suurem osa kui 11-15-aastastest puudega lastest. Kuni 6-aastastest vajas loovterapeudi teenust 40-48%, 7-10-aastastest 44-52% ja 11-15-aastastest 32-40%.

Vene keelt koduse keelena kõnelevatest peredest on loovterapeudi vajanud suhteliselt väiksem osa lastest: eesti keelt kõnelevatest lastest vajas loovterapeudi 45-50% ja vene keelt kõnelevatest 26-33%. Kui võrrelda samade taustatunnustega lapsi, on koduse keele seos loovterapeudi tunnetatud vajadusega veidi väiksem, aga siiski statistiliselt oluline.

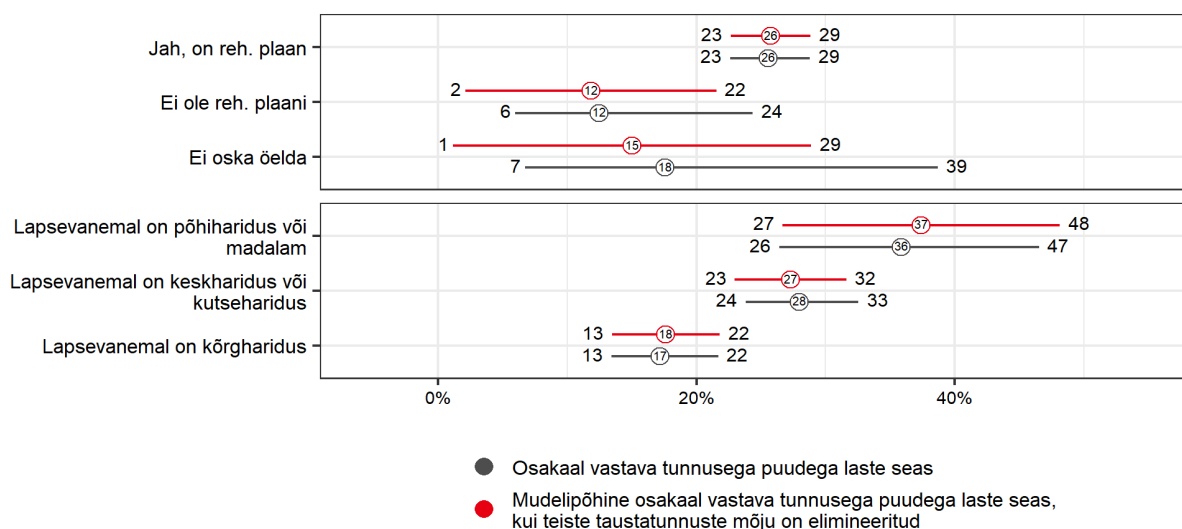
Joonis 97. Loovterapeudi teenuse vajadus viimase 12 kuu jooksul (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab teenust = 1, ei vaja teenust, ei tea teenust, ei oska öelda = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, vastaja haridustase, puude raskusaste, kodune keel, lapse vanus, rehabilitatsiooniplaani olemasolu.

Laste osakaal, kes on saanud loovterapeudi teenust kasutada nii palju kui vaja, on kõikides alamrühmades väga väike (Joonis 98).

Joonis 98. Loovterapeudi teenust viimase 12 kuu jooksul piisavalt kasutanud (% teenust vajanud puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: kasutab teenust piisavalt = 1, kasutab teenust vähem kui vaja või ei kasuta üldse, aga vajab = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanuserühm, asula tüüp, kodune keel, vastaja haridustase, elukoha regioon, rehabilitatsiooniplaani olemasolu.

Üksikuid erinevusi on võimalik tuvastada rehabilitatsiooniplaani olemasolu järgi ja lapsevanemate haridustasemete võrdluses. Loovterapeudi teenuse kättesaadavust hindasid puudega laste vanemad veidi paremaks juhul, kui lapsel oli rehabilitatsiooniplaan. 23-29% rehabilitatsiooniplaaniga laste ja 6-24% rehabilitatsiooniplaanita laste vanematest leidis, et laps sai loovterapeudi teenust kasutada piisavas mahu. Kõrgharidusega lapsevanemad hindavad loovterapeudi kättesaadavust halvemaks kui madalama haridustasemega lapsevanemad (kõrgharidusega vanematest 13-22% leiab, et laps sai teenust nii palju kui vaja, kesk- või kutseharidusega vanematest vastavalt 24-33%).

5.2.10 Logopeed

Logopeedi teenust vajab ca kaks kolmandikku puudega lastest (65-69%), kellest omakorda on saanud seda piisavas mahu kasutada 39-44%.

Alamrühmade võrdluses esinevad erinevused logopeedi tunnetatud vajaduses lapse puude liigi, vanuse, rehabilitatsiooniplaani olemasolu, lapse koduse keele ja elukoha regiooni järgi.

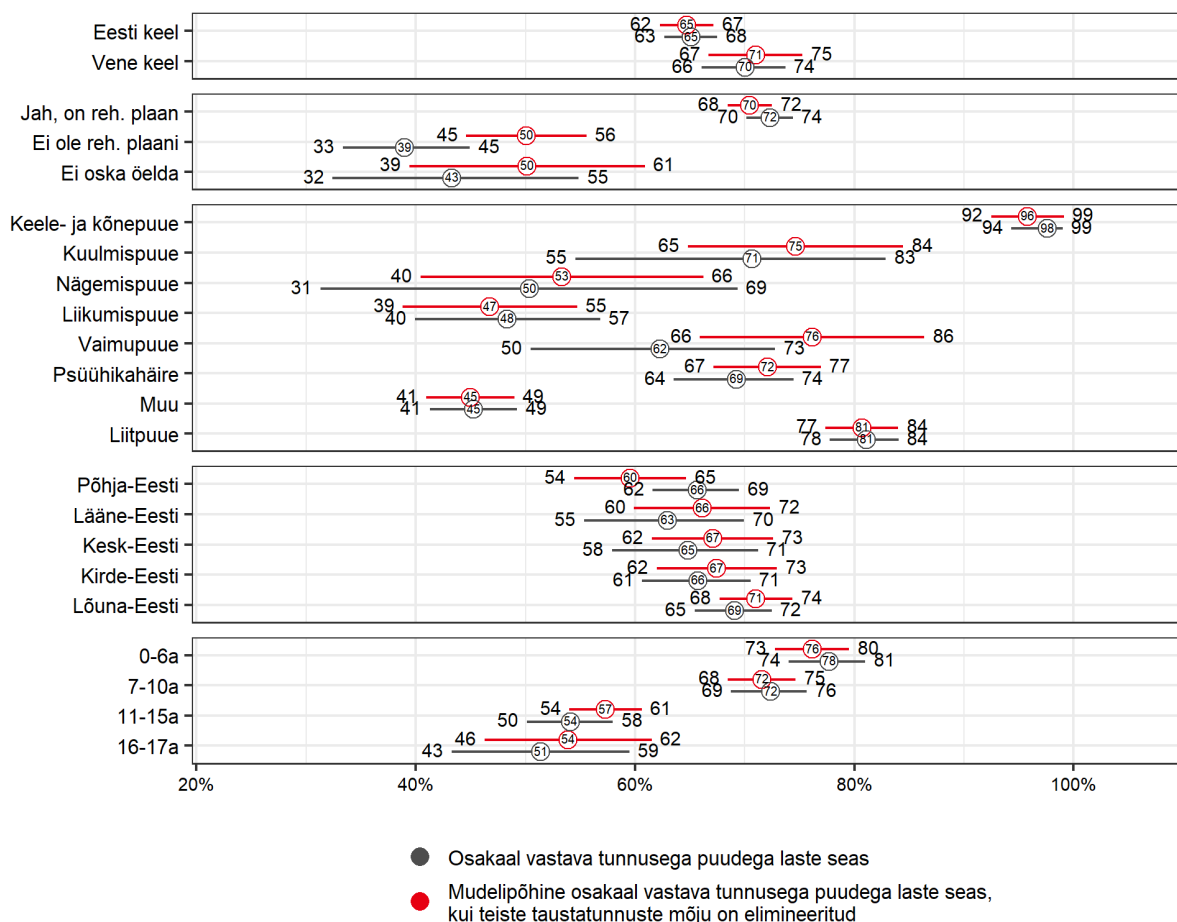
Keele- ja kõnepuudega lastest vajavad logopeedi teenust pea kõik (94-99%, vt Joonis 99). Liitpuudega ja psüühikahäirega laste seas on vajadus logopeedi teenuse järele samuti väga suur (vastavalt 78-84% ja 64-74%). Veidi väiksem on logopeedi teenuse vajajate osakaal muu puudega laste (41-49%) ja liikumispuudega laste hulgas (40-57%). Väga laiade usalduspiiridega on logopeedi teenuse vajajate osakaalu hinnang kuulmispuudega, nägemispuudega ja vaimupuudega laste hulgas. Kui võrrelda samade taustatunnustega lapsi, siis on logopeedi teenust tõenäoliselt vaja kahel kolmandikul või enamatel keele- ja kõnepuude, kuulmispuude, vaimupuude, psüühikahäire ja liitpuudega lastel ning alla kahel kolmandikul nägemispuude, liikumispuude ja muu puudega lastel.

Viimase 12 kuu jooksul esines tunnetatud vajadus logopeedi teenuse järele 70-74% rehabilitatsiooniplaaniga lastest ja 33-45% ilma rehabilitatsiooniplaanita lastest. Kui võtta arvesse ka teiste taustatunnuste mõju, on see erinevus veidi väiksem, kuid siiski statistiliselt oluline.

Nooremate laste puhul tunnetatakse vajadust logopeedi teenuse järele selgelt sagedamini kui vanemate laste puhul: 0-6-aastastest puudega lastest on viimasel 12 kuul logopeedi teenust vaja olnud kolmel neljandikul või rohkematelgi (74-81%), 7-10-aastastest puudega lastest vastavalt 69-76% ja 11-15-aastastest puudega lastest vastavalt 50-58%.

Koduse keele ja elukoha regiooni järgi ei ole erinevused gruppide vahel suured. Eesti keelt koduse keelena kõnelevatest puudega lastest vajab logopeedi teenust 63-68% ja vene keelt kõnelevatest puudega lastest 66-74%. Regioonide vahel on logopeedi järele tunnetatud vajaduses erinevus ainult juhul, kui teiste taustatunnuste mõju on arvesse võetud. Sellisel juhul on Põhja-Eestis vajadus logopeedi teenuse järele veidi väiksemal osal puudega lastest (54-65%) kui Lõuna-Eesti puudega lastest (68-74%).

Joonis 99. Logopeedi teenuse vajadus viimase 12 kuu jooksul (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab teenust = 1, ei vaja teenust, ei tea teenust, ei oska öelda = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, vastaja haridustase, puude raskusaste, kodune keel, lapse vanus, rehabilitatsiooniplaani olemasolu.

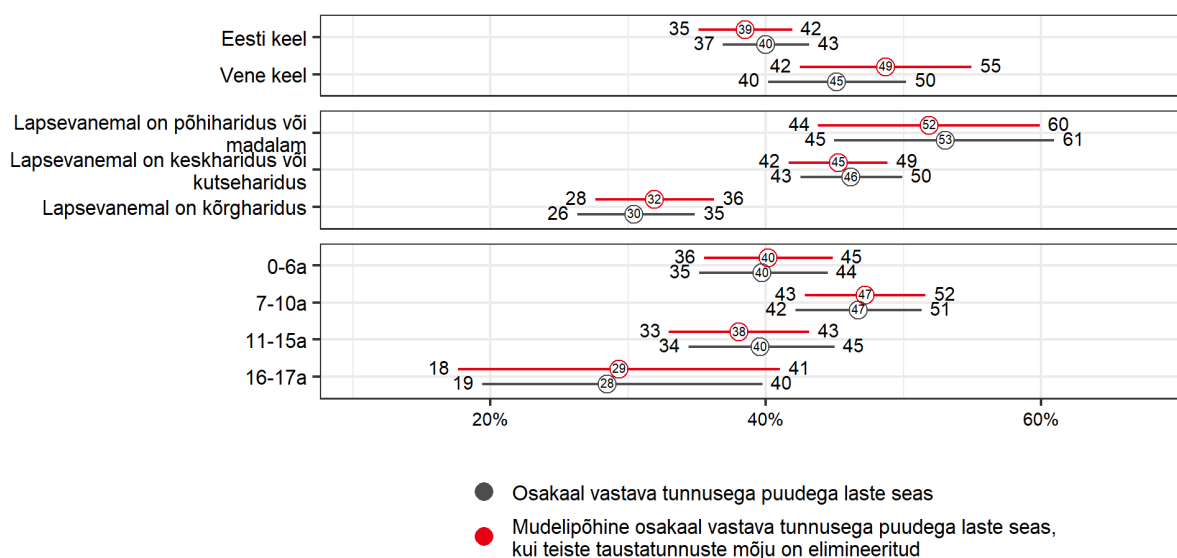
Logopeedi teenuse kasutamist piisavaks hinnanud vastajate osakaal taustatunnuste lõikes oluliselt ei erine, v.a puudega laste vanemate haridustasemetega võrlduses (Joonis 100). Logopeedi teenuse mahtu hindavad sagedamini ebapiisavaks kõrgharidusega lapsevanemad (28-35% leiab, et laps on saanud logopeedi teenust piisavalt kasutada) võrreldes madalama haridustasemega lapsevanematega (vastavalt 43-50% kesk- ja kutseharidusega vastajatest ning 45-61% põhi- või madalama haridusega vastajatest).

Vanuserühmadest on logopeedi teenus olnud piisavas mahus kättesaadav pisut sagedamini 7-10-aastastele puudega lastele (42-51% vajajatest sai kasutada piisavalt), samas kui noorematele (0-6-aastastest 35-44%) ja vanematele (11-15-aastastest 34-45%) vanuserühmadele on teenuse kättesaadavus olnud halvem. Kuigi statistiliselt olulised, on vanuserühmade vahelised erinevused siiski väga väikesed.

Koduse keele lõikes on erinevus puudega laste vahel olemas vaid siis, kui võrrelda samasuguste taustatunnustega lapsi. Sellisel juhul on vene keelt koduse keelena kõnelevate laste jaoks tõenäosus saada logopeedi teenuseid piisavas mahus suurem kui koduse keelena eesti keelt kõnelevate laste jaoks (42-55% koduse keelena vene keelt kõnelevatest lastest ja 35-42% eesti keelt kõnelevatest lastest).

Erinevalt teistest rehabilitatsiooniteenustest ei ole logopeedi teenuse kättesaadavusele antud hinnangud statistiliselt oluliselt seotud rehabilitatsiooniplaani olemasoluga.

Joonis 100. Logopeedi teenust viimase 12 kuu jooksul piisavalt kasutanud (% teenust vajanud puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhise osakaalu leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: kasutab teenust piisavalt = 1, kasutab teenust vähem kui vaja või ei kasuta üldse, aga vajab = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanuserühm, asula tüüp, kodune keel, vastaja haridustase, elukoha regioon, rehabilitatsiooniplaani olemasolu.

5.2.11 Eripedagoog

Eripedagoogi on vaja ca pooltel puudega lastest (50-54%), kellest omakorda on saanud teenust piisavas mahus kasutada ca kolmandik (34-39%).

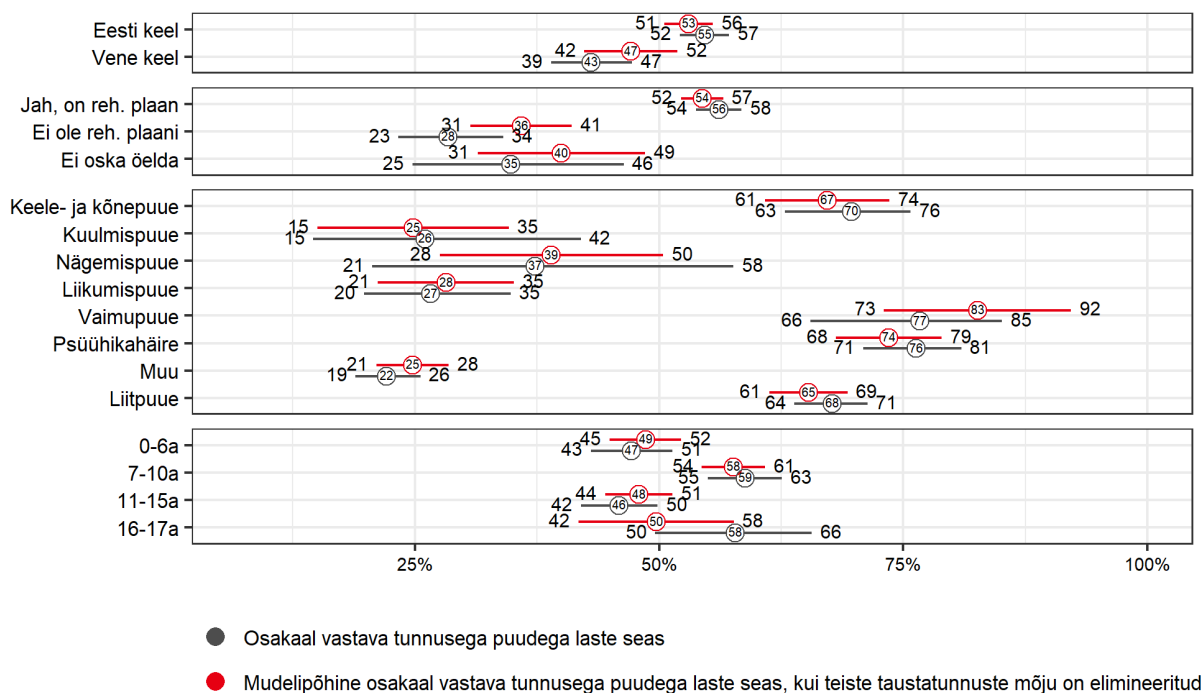
Küsitluse andmetest saame tuvastada seose eripedagoogi teenuse vajaduse ja lapse puude liigi, lapse vanuse, rehabilitatsiooniplaani olemasolu ning lapse koduse keele vahel (Joonis 101). Domineeriva puude liigi järgi eristub kaks gruppi puudega lapsi. Esimeses grupis on vajadus eripedagoogi teenuse järele enam levinud. Sellesse gruppi kuuluvad keele- ja kõnepuudega (kellest vajab eripedagoogi teenust 63-76%), vaimupuudega (66-85%), psüühikahäirega (71-81%) ja liitpuudega (64-71%) lapsed. Teise grupi moodustavad lapsed, kelle hulgas on vajadus eripedagoogi teenuse järele väiksem. Sinna kuuluvad kuulmispuudega lapsed (kellest vajab eripedagoogi teenust 15-42%), liikumispuudega (20-35%), muu puudega (19-28%) ja nägemispuudega (21-58%) lapsed.

Rehabilitatsiooniplaaniga laste puhul tunnetatakse vajadust eripedagoogi teenuse järele sagedamini (54-58%) kui nende puhul, kellel rehabilitatsiooniplaani pole (23-34%). Kui võrrelda muus osas samade taustatunnustega lapsi rehabilitatsiooniplaani olemasolu järgi, siis on erinevus veidi väiksem, aga siiski olemas.

Koduse keele järgi on eesti keelt kõnelevatest puudega lastest 52-57% selliseid, kellel on vaja eripedagoogi teenust, ja vene keelt koduse keelena kõnelevatest vastavalt 39-47%. Koduse keele lõikes puuduvad aga statistiliselt olulised erinevused juhul, kui võtta arvesse ka teiste taustatunnuste mõju – sel juhul on vene keelt kõnelevate puudega laste seas tõenäosus vajada eripedagoogi 42-52% ja eesti keelt kõnelevate puudega laste seas 51-56%.

Vanuse järgi on 7-10-aastaste puudega laste seas võrrelduna nooremate ja vanemate vanusrühmadega veidi enam neid, kellel on eripedagoogi teenust vaja. 7-10-aastaste puudega laste seas on eripedagoogi teenust vajavaid lapsi 55-63%, 0-6-aastaste seas 43-51% ja 11-15-aastaste seas 42-50%. 16-17-aastaste grupi ei saa laiade usalduspiiride tõttu teistest gruppidest eristada.

Joonis 101. Eripedagoogi teenuse vajadus viimase 12 kuu jooksul (% puudega lastest)

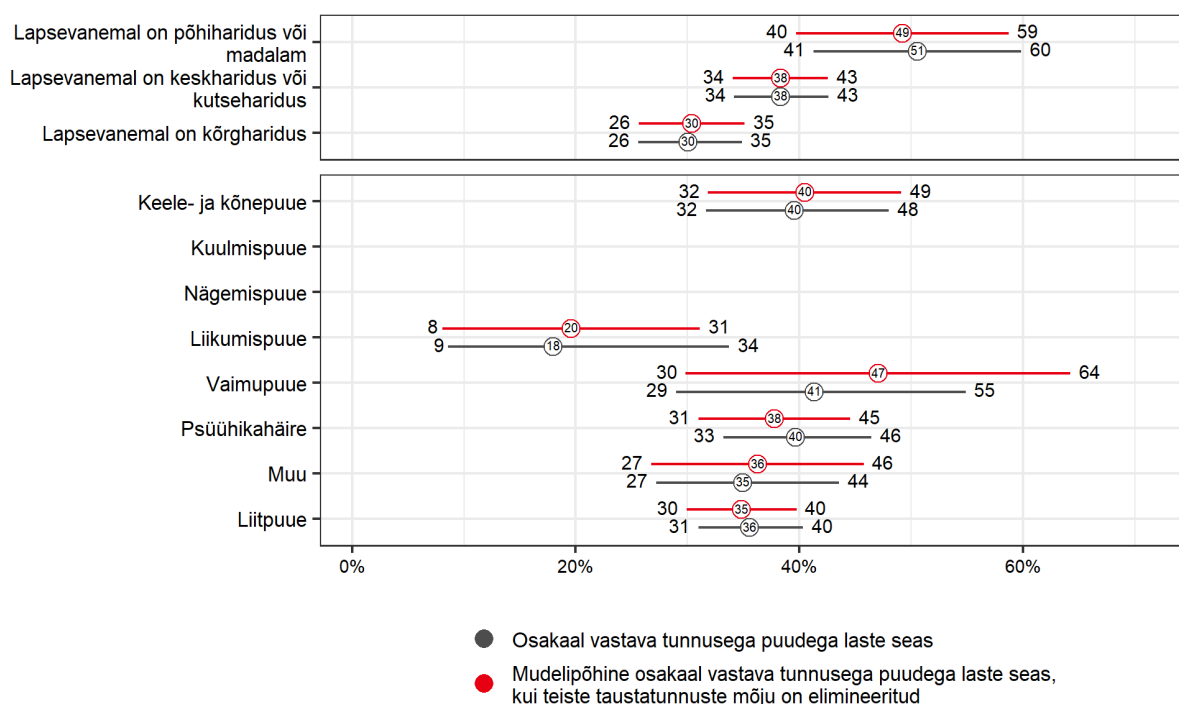


Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab teenust = 1, ei vaja teenust, ei tea teenust, ei oska öelda = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, elukoha regioon, elukoha liik, elukoha asula tüüp, vastaja haridustase, puude raskusaste, kodune keel, lapse vanus, rehabilitatsiooniplaani olemasolu.

Eripedagoogi teenuse kättesaadavus taustatunnuste lõikes oluliselt ei erine. Statistiliselt oluline seos esineb jällegi lapsevanema haridustaseme ja teenuse kättesaadavusele antud hinnanguga (Joonis 102). Tõenäolisemalt hindavad eripedagoogi teenuse kasutamist piisavaks madalamate haridustasemetega lapsevanemad. Kõrgharidusega lapsevanematest, kelle lapsel oli eripedagoogi teenust vaja, leiab 26-35%, et laps on saanud eripedagoogi teenust piisavas mahu, kesk- või kutseharidusega lapsevanematest arvab nii 34-43% ja põhi- või madalama haridustasemega lapsevanematest vastavalt 41-60%.

Eripedagoogi teenust vajanud liikumispuudega laste hulgas on teenust piisavas mahu saanute osakaal väiksem (9-34%) võrrelduna keele- ja kõnepuude (32-48%), vaimupuude (29-55%), psüühikahäire (33-46%), muu puude (27-44%) ja liitpuudega (31-40%) lastega. Kuulmis- ja nägemispuudega laste osakaalul on enam kui 39 protsendipunkti laiused usalduspiirid (vaatluste arv andmetes vastavalt 6 ja 9), mistõttu ei saa nende kohta teha selgeid järeldusi, samuti pole neid näidatud joonisel.

Joonis 102. Eripedagoogi teenust viimase 12 kuu jooksul piisavalt kasutanud (% teenust vajanud puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Jooniselt on välja jäetud väärtused, mille usalduspiirid on laiemad, kui 39pp. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: kasutab teenust piisavalt = 1, kasutab teenust vähem kui vaja või ei kasuta üldse, aga vajab = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanuserühm, asula tüüp, kodune keel, vastaja haridustase, elukoha regioon, rehabilitatsiooniplaani olemasolu.

5.2.12 Psühholoogia

Vajadus psühholoogi järgi on tunnetatud 67–71%l puudega lastest, kellest omakorda on psühholoogi teenust piisavas mahus saanud 39-44%.

Tunnetatud vajadus psühholoogi järele seostub lapse puude liigi, vanuse ja rehabilitatsiooniplaani olemasoluga.

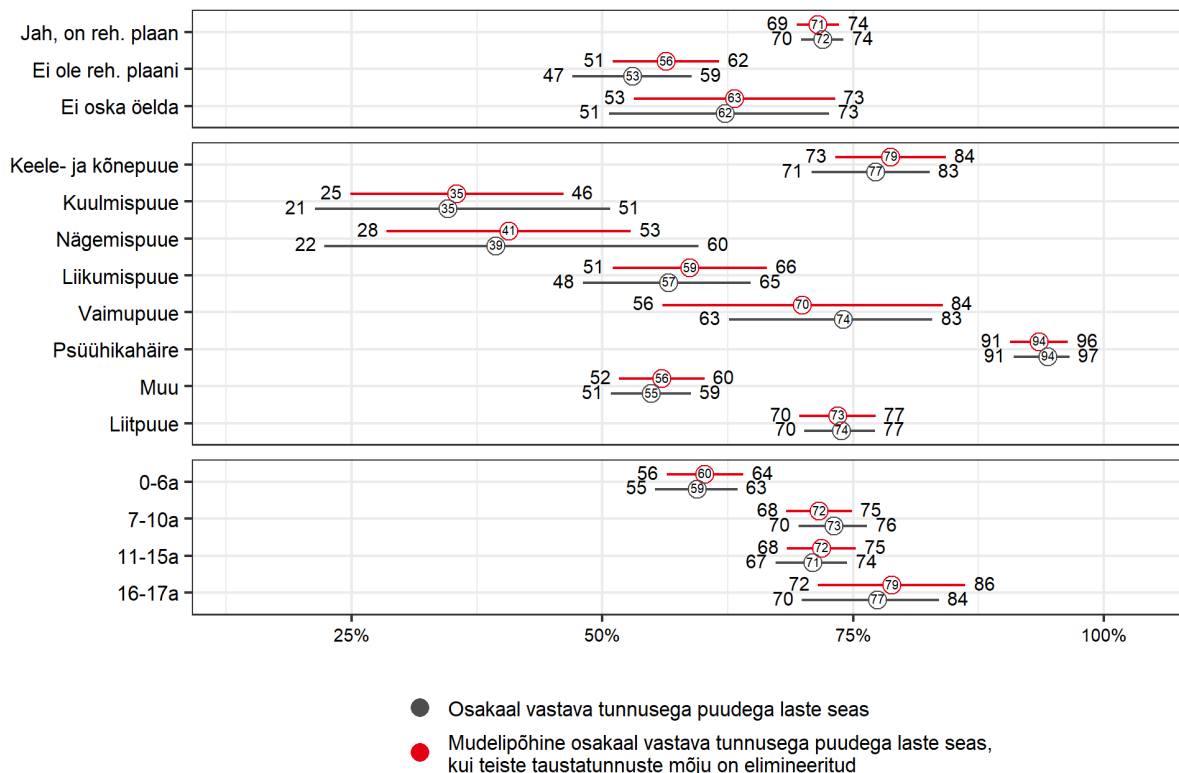
Rehabilitatsiooniplaaniga puudega laste seas on neid, kelle puhul lapsevanem tunnetab vajadust psühholoogi teenuse järele rohkem (70-74%) võrrelduna lastega, kellel ei ole rehabilitatsiooniplaani (47-59%). Võrreldes samade taustatunnustega lapsi, on erinevused rehabilitatsiooniplaaniga ja ilma rehabilitatsiooniplaanita laste puhul tunnetatud vajaduses psühholoogi järele veidi väiksemad, kuid siiski ületab rühmade vaheline erinevus kümnet protsendipunkti (Joonis 103).

Vanuserühmade võrdluses on tunnetatud psühholoogi vajadus suurem üle 6-aastaste laste puhul, aga erinevus noorima vanuserühmaga on väike. Lähtuvalt lapsevanemate hinnangutest vajab psühholoogi teenust 55-63% 0-6-aastastest, 70-76% 7-10-aastastest, 67-74% 11-15-aastastest ja 70-84% 16-17-aastastest puudega lastest. Vanuserühmade vahelised erinevused säilivad ka sel juhul, kui teiste taustatunnuste mõju elimineerida.

Puudeliikide võrdluses on psühholoogi vaja pea kõigil psüühikahäirega lastel (91-97%). Teistest puudeliikidest on vajadus psühholoogi järele sagedasem ka keele- ja kõnepuudega (71-83%) ning liitpuudega (70-77%) laste seas. Vaimupuudega laste kohta ei saa väga täpset hinnangut anda, kuna see grupp on väga väike ja selle tõttu on hinnangu usalduspiirid laiad (psühholoogi teenust on vajanud 63-83%

vaimupuudega lastest). Liikumis- ja muu puudega lastest on psühholoogi teenust vajanud umbes pooled (vastavalt 48-65% ja 51-59%) ning nägemis- ja kuulmispuudega lastest viiendik kuni pooled (vastavalt 21-51% ja 22-60%).

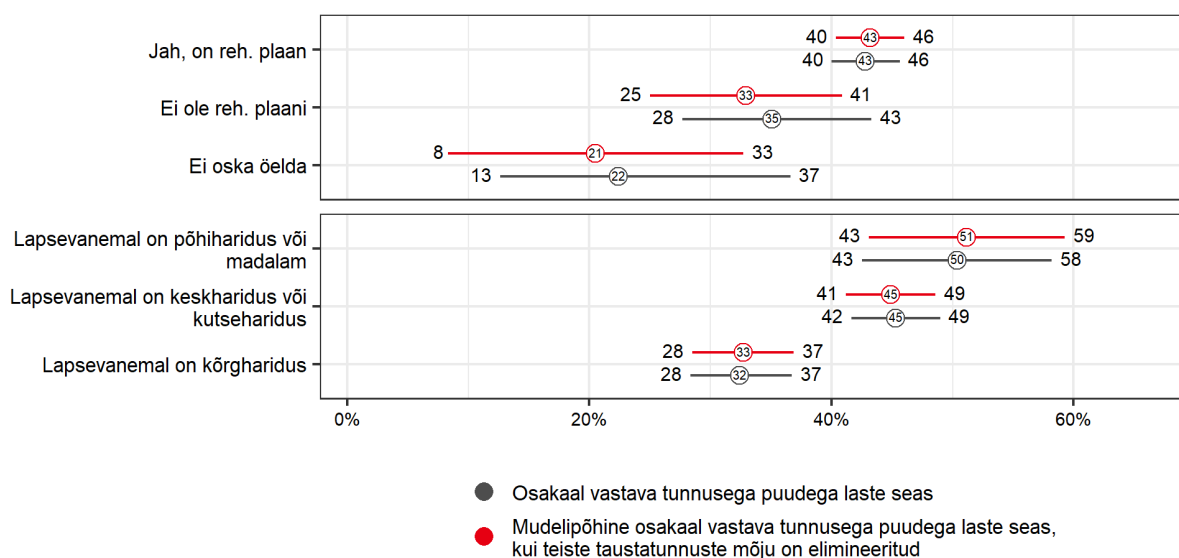
Joonis 103. Psühholoogi teenuse vajadus viimase 12 kuu jooksul (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab teenust = 1, ei vaja teenust, ei tea teenust, ei oska öelda = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, rehabilitatsiooniplaani olemasolu, elukoha regioon, elukoha liik, elukoha asula tüüp, vastaja haridustase, puude raskusaste, kodune keel, lapse vanus.

Psühholoogi teenuse kättesaadavus ei ole taustatunnuste lõikes sellisel määral erinev, et oleks võimalik olulisi suuri erinevusi välja tuua. Väikesed erinevused ilmnevad rehabilitatsiooniplaani olemasolu ja lapsevanema haridustaseme lõikes (Joonis 104). Rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral on juurdepääs psühholoogi teenusele parem (psühholoogi teenust on piisavas mahus kasutanud 40-46% rehabilitatsiooniplaaniga lastest, kes on teenust vajanud, ja 28-43% ilma rehabilitatsiooniplaanita lastest, kes on teenust vajanud). Rehabilitatsiooniplaaniga ja ilma rehabilitatsiooniplaanita laste vaheline erinevus jääb statistiliselt oluliseks ka siis, kui teiste taustatunnuste mõju on arvesse võetud. Kõrgharidusega lapsevanematest hindab psühholoogi teenuse mahtu piisavaks väiksem osa (28-37%) võrreldes kutse- või keskharidusega lapsevanematega (42-49%) ja põhi- või madalama haridusega lapsevanematega (43-58%).

Joonis 104. Psühholoogi teenust viimase 12 kuu jooksul piisavalt kasutanud (% teenust vajanud puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: kasutab teenust piisavalt = 1, kasutab teenust vähem kui vaja või ei kasuta üldse, aga vajab = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanuserühm, asula tüüp, kodune keel, vastaja haridustase, elukoha regioon, rehabilitatsiooniplaani olemasolu.

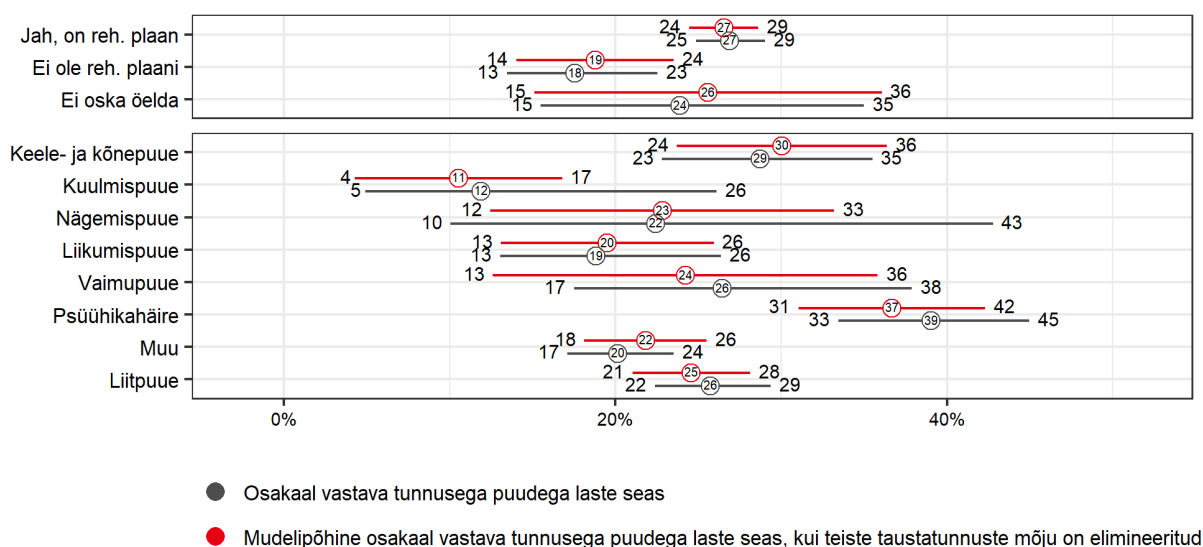
5.2.13 Kogemusnõustaja

Teadlikkus kogemusnõustaja teenusest on küllaltki madal: 28–32% puudega laste vanematest ei tea seda teenust ja 6–9% ei oska öelda, kas nende puudega lapsel on seda teenust vaja. Vajadust kogemusnõustaja teenuse järele tunnetatakse ligi veerandi puudega laste puhul (24–28%), mis on madalam tulemus kui kõigi teiste uuritud rehabilitatsiooniteenuste osas. Neist lastest, kellel on kogemusnõustaja teenust vaja, on seda piisaval määral kasutanud vaid 12–18%.

Tunnetatud vajadus kogemusnõustaja järele on seotud rehabilitatsiooniplaani olemasolu ja lapse puude liigiga. Statistiliselt olulisi seoseid teiste taustatunnustega ei ilmnenud.

Rehabilitatsiooniplaaniga lastest vajas kogemusnõustaja teenust 25–29% ja ilma rehabilitatsiooniplaanita lastest vastavalt 13–23% (Joonis 105). Ka teiste taustatunnuste mõju arvesse võttes säilivad rehabilitatsiooniplaaniga ja ilma rehabilitatsiooniplaanita laste vahel kogemusnõustaja vajaduse osas erinevused. Puudeliikidest on tunnetatud vajadus kogemusnõustaja järele suurem psüühikahäirega laste hulgas (33–45%), võrrelduna liitpuude (22–29%), muu puude (17–24%), liikumispuude (13–26%) ja kuulmispuudega (5–26%) lastega. Nägemispuudega laste kohta saame teha väga laiade usalduspiiridega järelduse (10–43 protsendil nägemispuudega lastest on vaja kogemusnõustaja teenust), mistõttu ei erine selle puudeliigiga laste näitaja statistiliselt olulisel määral teistesse puudeliikidesse kuuluvate laste näitajatest.

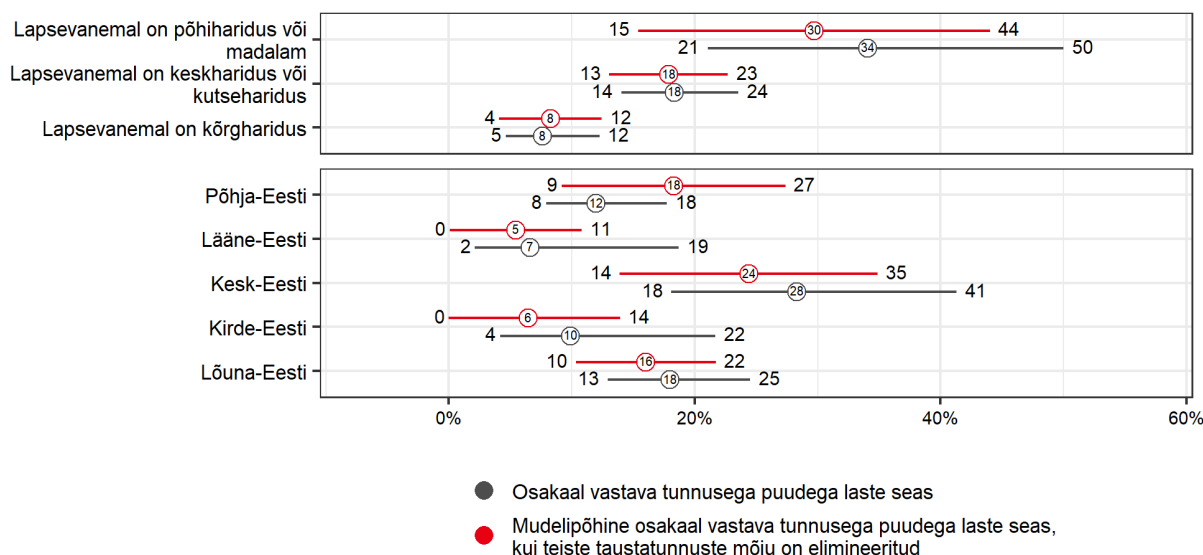
Joonis 105. Kogemusnõustaja teenuse vajadus viimase 12 kuu jooksul (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajab teenust = 1, ei vaja teenust, ei tea teenust, ei oska öelda = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, elukoha regioon, elukoha liik, elukoha asula tüüp, vastaja haridustase, puude raskusaste, kodune keel, lapse vanus, rehabilitatsiooniplaani olemasolu.

Kogemusnõustaja teenust on saanud piisavas mahus kasutada väga vähesed puudega lastest ning järeldusi selle kohta, milliste taustatunnustega lapsed saavad teenust kasutada suurema tõenäosusega ja milliste taustatunnustega lapsed väiksema tõenäosusega, on keeruline välja tuua. Statistiliselt olulisi seoseid ilmneb vähe (Joonis 106).

Joonis 106. Kogemusnõustaja teenust viimase 12 kuu jooksul piisavalt kasutanud (% teenust vajanud puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: kasutab teenust piisavalt = 1, kasutab teenust vähem kui vaja või ei kasuta üldse, aga vajab = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanuserühm, asula tüüp, kodune keel, vastaja haridustase, elukoha regioon, rehabilitatsiooniplaani olemasolu.

Kõrgharidusega lapsevanemad hindavad kogemusnõustaja kättesaadavust kriitilisemalt. Kõrgharidusega lapsevanematest, kelle lapsel oli vaja kogemusnõustaja teenust, leiab 5-12%, et teenust on saadud piisavas mahu, kutse- või keskharidusega lapsevanematest vastavalt 14-24% ja põhi- või madalama haridustasemega lapsevanematest vastavalt 21-50%.

Lääne- ja Kirde-Eestis hinnatakse kogemusnõustaja teenuse kättesaadavust kriitilisemalt kui Kesk-Eestis. Kogemusnõustaja teenust vajanud lastest on Lääne-Eestis 2-19% ja Kirde-Eestis 4-22% saanud seda kasutada nii palju, kui vaja. Kesk-Eestis on vastav osakaal 18-41%. Põhja-Eestis hindab teenuse saamist piisavaks 8-18% teenust vajanutest, mis on veidi vähem kui Kesk-Eestis. Kui aga võrrelda samasuguste taustatunnustega lapsi, siis Põhja- ja Kesk-Eesti näitajad statistiliselt olulisel määral ei erine ning saab öelda vaid, et erinevus on olemas Lääne-, Kirde- ja Kesk-Eesti vahel.

5.2.14 Kokkuvõte

Tunnetatud vajadus sotsiaalteenuste järele on sõltuvalt teenusest erinev. Teenuse vajajate osakaal varieerub sõltuvalt teenusest viiendikust puudega lastest (sotsiaaltranspordi teenuse puhul) kuni nelja viiendikuni (rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise juhendamise või tulemuste hindamise teenuse puhul³³). Sotsiaalteenuste tunnetatud vajadus sõltub lapse puude liigist ja raskusastmest, lapsevanema teadlikkusest, lapse vanusest, kodusest keelest ning mõningatel juhtudel ka pere majanduslikest võimalustest. Viimase näiteks on sotsiaaltransport, mille järele on vajadus väiksem peredes, kus on olemas igapäevane auto kasutamise võimalus.

On ilmne, et mõned sotsiaalteenused on vajalikumad just teatud puudeliikidega lastele ning vajadus on seda suurem, mida raskema puude raskusastmega on tegu. Psüühikahäire ja liitpuue on puudeliigid, millega kaasneb teiste puudeliikidega võrreldes suurem vajadus paljude teenuste järele (nt psühholoog, tugiisik). Samas vajadus füsioterapeudi järele on teiste puudeliikidega võrreldes suurem liikumispuudega laste seas, vajadus logopeedi järele aga keele- ja kõnepuudega laste seas. Siiski pole vajadus ühegi teenuse järele piiritletav vaid ühe puudeliigiga – kõigi puudeliikide puhul esines vajadust erinevate sotsiaalteenuste järele suuremal või vähemal määral.

Lisaks puude liigile ja raskusastmele sõltub vajadus teenuse järele lapse vanusest. On teenuseid, mille järele kasvab vajadus lapse vanuse kasvades, nagu nt sotsiaaltransport ja psühholoog, kuid enamiku uuringus käsitletud teenuste puhul tunnetatud vajadus teenuse järele lapse vanuse kasvades väheneb (nt tugiisik, lapsehoiuteenus, tegevusterapeut, loovterapeut, logopeed). Lisaks on mõned teenused sellised, mille järele on suurem vajadus just teatud vanuses lastel: näiteks eripedagoogi vajadust tunnetatakse teistest vanusegruppidest sagedamini 7-10-aastaste laste puhul.

Vajadus rehabilitatsiooniteenustena pakutavate teenuste järele on märgatavalt sagedasem laste hulgas, kellel on olemas rehabilitatsiooniplaan. Nt füsioterapeudi vajajate osakaal on rehabilitatsiooniplaaniga laste hulgas ligi 20 protsendipunkti kõrgem kui nende laste hulgas, kel rehabilitatsiooniplaani pole. Tõenäoliselt on selle seose taga rehabilitatsiooniplaani omavate laste vanemate parem teadlikkus lapse teenuste vajadusest, mis kaasneb rehabilitatsiooniplaani koostamisega, tutvumisega selles seatavate eesmärkidega ning seonduvate teenuste vajadustega.

³³ Rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise juhendamise või tulemuste hindamise teenus on teistest käsitletud teenustest erinev, kuna see on eeldus rehabilitatsiooniteenuste saamiseks. 2016. aastal lisandusid rehabilitatsiooniplaanile alternatiividena rehabilitatsiooniprogramm ja tegevuskava. Kuna rehabilitatsiooniplaan on varasemalt olnud eeldus rehabilitatsiooniteenuste saamiseks, siis võib olla tunnetatud vajadus selle teenuse järele sisuliselt erinev teiste teenuste tunnetatud vajadusest.

Küsitluse andmete põhjal tundub koduse keelena eesti keelt rääkivate perede ja vene keelt rääkivate perede vahel olevat kultuuriline erinevus. Koduse keelena vene keelt rääkivate perede tunnetatud vajadus sotsiaalteenuste järele on paljude teenuste puhul väiksem kui eesti keelt rääkivatel peredel. Sellised teenused on nt tugiisikuteenus, rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise juhendamise ja tulemuste hindamise teenus ning tegevusterapeudi, loovterapeudi ja eripedagoogi teenused. Eranditeks on sotsiaaltranspordi ja logopeedi teenused, mille tunnetatud vajadus on vene keelt kõnelevatel peredel eesti keelt kõnelevate peredega võrreldes veidi suurem.

Sotsiaalteenuste kättesaadavust hinnati lähtuvalt sellest, kas laps, kes teenust vajab, on vajatud teenust kasutanud piisavalt, vajatust vähem või pole üldse kasutanud. Sotsiaalteenuste kättesaadavus on teenuseti erinev. Kõige paremini on kättesaadavad rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise juhendamise ja tulemuste hindamise ning sotsiaaltöötaja nõustamise teenus. Uuringus käsitletud sotsiaalteenuste võrdluses on nende puudega laste osakaal, kes pole vajatud teenust üldse saanud, üldjuhul kõrgeim Sotsiaalhoolekande seaduse alusel KOVi poolt pakutava abi (lapsehoid, tugiisikuteenus ja sotsiaaltransport) osas, madalaim aga rehabilitatsiooniteenustena pakutavate teenuste osas. Rehabilitatsiooniteenustena pakutavate teenuste (v.a loovterapeut) osas pole teenuseid saanud ca veerand puudega lastest, kes antud teenuseid vajaksid. Lapsehoiu, tugiisikuteenuse ja sotsiaaltranspordi teenust pole üldse saanud ligi pool teenust vajanutest. Paremaks hindavad rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavust lapsevanemad, kelle lapsel on rehabilitatsiooniplaan.

Mõne teenuse näol on teatud puudeliigiga laste jaoks tegemist kriitilise tähtsusega teenusega, mistõttu võivad probleemid teenuse kättesaadavusega puudega lapse toimetulekut oluliselt mõjutada (nt sotsiaaltranspordi teenust hindavad oluliselt sagedamini ebapiisavaks liikumispuudega laste vanemad).

Teenuste kättesaadavust hindavad kõrgharidusega lapsevanemad piisavaks teistest harvem järgnevate teenuste osas: tugiisik, tegevusterapeut, loovterapeut, logopeed, eripedagoog, psühholoog, kogemusnõustaja.

Mõned teenused on tõenäoliselt kavandatud eelkõige mõnda kindlat vanusgruppi silmas pidades ja seetõttu on teiste vanusegruppide jaoks teenuse kättesaadavus halvem. Nt on sotsiaaltransport koolieelikutest puudega lastele halvemini kättesaadav kui kooliealistele puudega lastele. Rehabilitatsiooniplaani koostamise ja täitmise juhendamise teenuse kättesaadavust hindavad halvemaks 16–17-aastaste laste vanemad võrrelduna alla 7-aastaste laste vanematega. Füsioterapeudi kättesaadavus on halvem 11–15-aastaste vanuserühmale võrrelduna koolieelikutega. Logopeedi teenuse kättesaadavus on veidi parem 7–10-aastastel võrreldes teiste vanuserühmadega.

Ilmnevad ka mõned regionaalsed erinevused teenuste kättesaadavusel, nt lapsehoiuteenuse kättesaadavusega on Lääne- ja Lõuna-Eestis vähem probleeme kui Põhja-Eestis. Samuti on hinnangud sotsiaaltöötaja poolse nõustamise, rehabilitatsiooniplaani koostamise ja täitmise juhendamise ning füsioterapeudi kättesaadavusele regioonide võrdluses kõige kriitilisemad just Põhja-Eestis. Samas on hinnangud kogemusnõustaja teenuse kättesaadavusele Põhja- ja Kesk-Eestis paremad võrrelduna Lääne- ja Kirde-Eestiga.

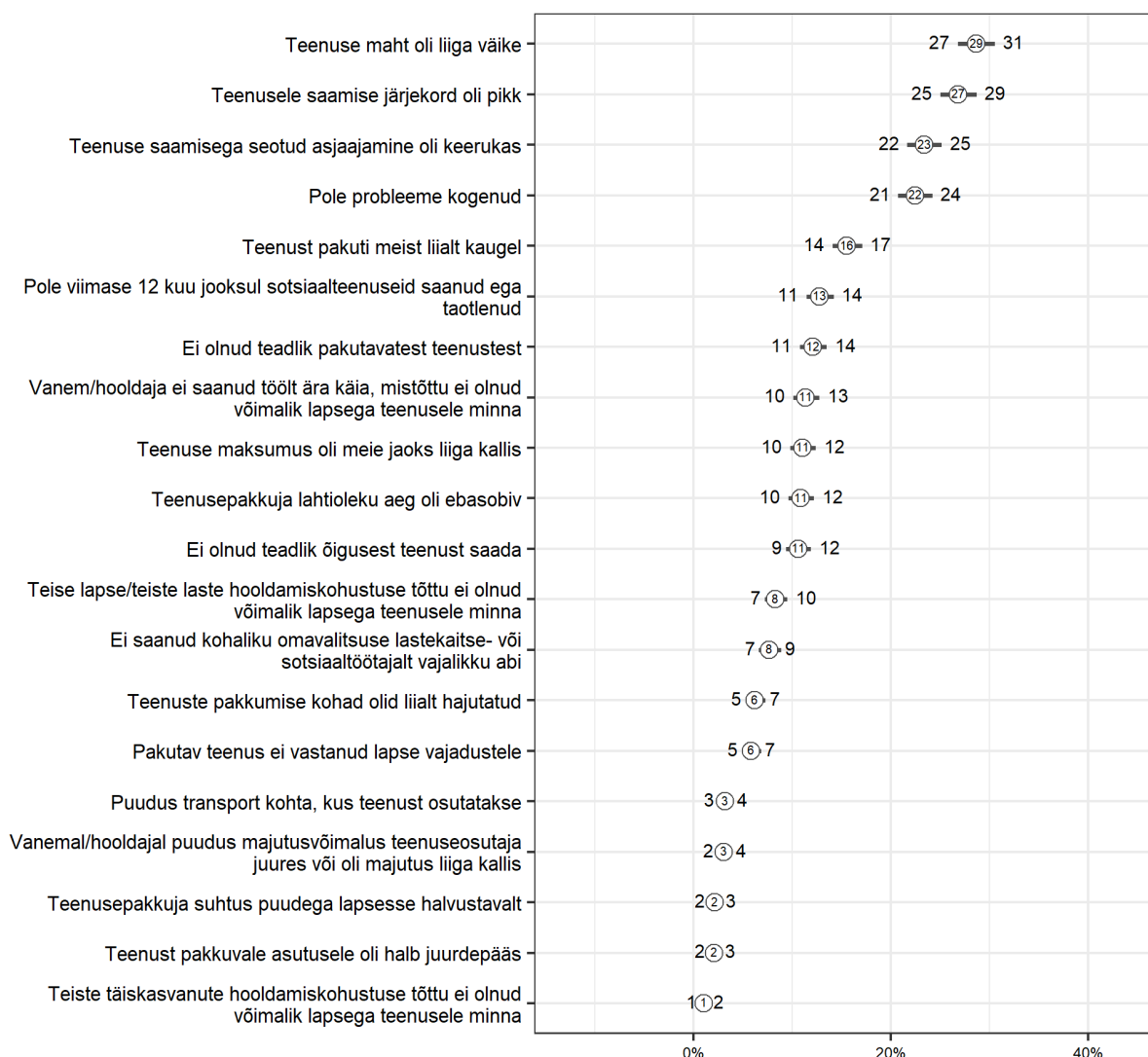
Kokkuvõttes on sotsiaalteenuste tunnetatud vajadus oluliselt suurem kui teenuste kättesaadavus. Suhteliselt suurem on kättesaadavuse probleem teenuste osas, mida käsitletakse SHS alusel KOV korraldatava abina (sotsiaaltransport, tugiisikuteenus, lapsehoiuteenus). Absoluutmahult on nende teenuste kättesaadavus probleemiks väiksemale hulgale puudega lastest kui nendel, mida SHS alusel käsitletakse riigi korraldatava abina (rehabilitatsiooniteenused), sest KOV teenuseid vajavaid puudega lapsi on vähem kui riiklikult korraldatud teenuseid vajavaid puudega lapsi.

5.3 Probleemid sotsiaalteenuste saamisel

5.3.1 Probleemide üldine levik

Veidi enam kui viiendikul (21-24%) puudega laste vanematest pole lapsele suunatud sotsiaalteenuste saamisel probleeme olnud, 11-14% pole viimase 12 kuu jooksul puudega lastele suunatud sotsiaalteenuseid taotlenud ning laps pole teenuseid ka saanud (Joonis 107). Samas võis laps osadel juhtudel, kus vanem pole lapsele sotsiaalteenuseid taotlenud ja laps pole teenuseid saanud, laps neid teenuseid siiski vajada (vt eelmine ptk).

Joonis 107. Sotsiaalteenuste saamisel või taotlemisel viimase 12 kuu jooksul lapsevanematel esinenud probleemid (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

Puudega laste sotsiaalteenuste saamisel eristuvad kolm suurema levikuga probleemi: teenuste maht oli liiga väike (27-31%), teenusele saamise järjekord oli liiga pikk (25-29%) ja teenuse saamisega seotud asjaajamine oli liialt keerukas (22-25%). Neid probleeme nimetas enam kui veerand puudega laste vanematest. Ka 2009. aasta uuringus olid kaks enim nimetatud probleemi teenuste saamisega seotud

keerukas asjaajamine ja liialt väike teenuste maht³⁴. Kolmandaks sagedamini mainitud probleemiks oli 2017. aastal teenuste pakkumise kaugus (14-17%). Iga ülejäänud küsimustikus toodud probleemi esines vähem kui 15 protsendil puudega laste vanematest.

Teenuste maht oli liialt väike³⁵ – on tunnetatud oluliselt suurema tõenäosusega juhul, kui lapsel on rehabilitatsiooniplaan olemas (30-34%, vrld 9-17% rehabilitatsiooniplaani puudumisel); kui lapse vanem on kõrgharidusega (32-39%, vrld 24-29%, kui on kesk- või kutseharidusega ja 11-21%, kui põhi- või madalama haridusega) ja kui lapsel on psüühikahäire (28-39%), liitpuue (34-41%) või keele- ja kõnepuue (28-42%) võrrelduna muu puudega (15-21%) lastega.

Teenuse saamise järjekord oli pikk – hindavad probleemina suurema tõenäosusega kõrgharidusega vanemad (30-37%, vrld kutse- või keskharidusega 22-28% ja põhi- või madalama haridusega 12-22%). Kui võrrelda lihtsalt puude raskusastme järgi lapsi, kelle vanemate hinnangul olid pikad järjekorrad olid probleemiks, siis statistilist olulist erinevust ei ilmne (sügava puudega lastest oli selliseid 14-30%, raske puudega lastest 27-32% ja keskmise puudega lastest 21-27%). Kui teiste taustatunnuste mõju elimineerida, siis on pikkade järjekordadega väiksema tõenäosusega probleem sügava puudega laste vanematel (12-23%, vrld raske puudega lastega 24-29% ja keskmise puudega lastega 25-33%).

Teenusega seotud asjaajamine oli keerukas – hindavad samuti sagedamini probleemseks kõrgharidusega lapsevanemad (26-33%, vrld põhi- või madalama haridusega vanemad 8-16%). Alla 7-aastaste laste vanemad hindavad asjaajamise keerukust probleemiks suurema tõenäosusega (24-32%, vrld 7-10-aastaste laste vanemad 21-27%, 11-15-aastaste laste vanemad 16-22%), mis viitab tõenäoliselt sellele, et selliste vanemate seas on rohkem neid, kes alles peavad süsteemiga tutvuma ja sellest arusaamine on keeruline. Vaimupuudega laste vanemate seas on neid, kes hindavad asjaajamise keerukust probleemseks veidi vähem (6-22%) kui enamiku teiste puudeliikidega laste vanemate seas (nt keele- ja kõnepuudega lastel 20-32%, liikumispuudega lastel 17-32%, psüühikahäirega lastel 26-37%, liitpuudega lastel 22-29%).

Probleeme pole – selliseid, kes hindavad, et probleeme pole, on muude taustatunnuste mõju arvesse võttes vähem nende lapsevanemate seas, kes on kõrgharidusega (15-20%, vrld kesk- ja kutseharidusega lapsevanemad 22-27% ja põhi- või madalama haridusega 23-35%) või kes elavad Põhja-Eestis (11-16%, vrld Kesk-Eesti 22-35%, Lõuna-Eesti 24-31%).

Teenuse pakkumise koht oli liialt kaugel – on vähematele probleemiks Tallinnas (8-14% puuetega lastest) ja sagedamini probleemiks maa-asulates (muus linnalises asulas 12-16% ja maa asulas 17-23%) elavatele inimestele.

Ei olnud teadlik pakutavatest teenustest – kõrgharidusega lapsevanemad hindavad seda sagedamini probleemiks (30-37%) võrrelduna põhi- või madalama haridustasemega lapsevanematega (12-22%). Puude raskusastmete lõikes ilmnevad erinevused antud probleemi mainimissageduses ainult siis, kui arvesse on võetud ka teiste taustatunnuste mõju.. Sellisel juhul on sügava puudega laste vanemate seas madal teadlikkus pakutavatest teenustest probleemiks väiksema tõenäosusega (tõenäosus, et samasuguste

³⁴ Kuna 2009. aasta küsitluses ei olnud küsimuses probleemide kogemisele ajalist piirangut, pole probleemide esinemissageduse protsentuaalsed väärtused võrreldavad. 2009. aasta uuringus oli teenuste saamise keerukas asjaajamine olnud probleemiks 62%le puudega lastest ja teenustele saamise järjekord 57%le.

³⁵ Siinkohal toodud seosed põhinevad kõik logit-mudelil, mille sõltuv muutuja on 1 juhul, kui probleemi esines ja 0, kui probleemi ei esinenud. Mudelis arvesse võetud sõltumatud muutujad on lapse puude liik, puude raskusaste, lapse vanus, kodune keel, elukoha regioon, asula tüüp, rehabilitatsiooniplaani olemasolu, vastaja haridustase.

taustatunnustega lastel esineb probleem, kui laps on sügava puudega, on 12-23%) kui raske (24-29%) ja keskmise (25-33%) puudega laste vanematel.

Vanem ei saanud töölt ära käia – kõrgharidusega lapsevanemate seas esines seda probleemi rohkem (13-18%) kui madalamate haridustasemetega lapsevanemate seas (8-12% kesk- või kutseharidusega ja 4-11% põhi- või madalama haridusega vastajatest).

Teenuse maksumus oli meie jaoks liiga kallis – laiate usalduspiiride tõttu ei ilmnunud gruppide lõikes statistiliselt olulisi erinevusi.

Teenusepakkuja lahtiolekuaeg oli ebasobiv – teistest sagedamini toovad seda probleemi välja kõrgharidusega lapsevanemad (12-17%, vrdl põhi- või madalama haridusega lapsevanemad 3-10%).

Pole teenuseid saanud ega taotlenud – selliseid vastuseid andsid oluliselt sagedamini lapsevanemad, kelle puudega lapsel pole rehabilitatsiooniplaani (22-33%, vrdl kellel on rehabilitatsiooniplaan 8-11%). Sügava puudega lastest 4-15% jaoks pole sotsiaalteenuseid taotletud ega neid saadud, raske puudega laste seas on selliseid 13-18% ja keskmise puudega laste seas 11-16% (kui võrrelda samade taustatunnustega lapsi, siis eristuvad keskmise ja raske puudega lapsed selliselt, et keskmise puudega laste seas on neid, kelle jaoks pole teenuseid taotletud, vähem kui raske puudega laste seas – teiste taustatunnuste mõju elimineerides on tõenäosus, et teenuseid pole taotletud ega saadud, keskmise puudega lapsel 8-12% ja raske puudega lapsel 13-18%). Psüühikahäirega (5-11%), liitpuudega (7-11%) ja keele- ja kõnepuudega (4-10%) laste seas on selliseid lapsi vähem kui teiste puudeliikidega laste seas (muu puudega 17-23%, vaimupuudega 8-25%, liikumispuudega 10-22%, nägemispuudega 9-40% ja kuulmispuudega lastest 16-44%).

Pole teadlik õigusest teenust saada – juhul, kui arvesse on võetud ka teiste taustatunnuste mõju, esineb seda probleemi vähem nende lapsevanemate seas, kelle lapsel on rehabilitatsiooniplaan (8-11%) võrrelduna lapsevanematega, kelle lapsel ei ole rehabilitatsiooniplaani (12-21%).

Teise lapse hooldamiskohustuse tõttu polnud võimalik puudega lapsega teenusele minna – mida rohkem on peres lapsi, seda tõenäolisem on selle probleemi esinemine (kolme lapsega peredes, kus pole ühtegi hõivatut: 12-32%, ühe hõivatuga kolme või enama lapsega peredes: 15-25%, kahe või enama hõivatuga kolme või enama lapsega peredes: 11-22%, kahe lapsega peredes vastavalt 3-18%, 8-15%, 5-10% ja ühe lapsega peres 0-9%, 0-2% ja 0-2%). Ka nendel vanematel, kelle puudega lapsel on rehabilitatsiooniplaan olemas, on sellise probleemi esinemine veidi sagedasem (8-11%) kui neil, kelle lapsel rehabilitatsiooniplaani pole (1-6%).

Ei saanud KOV sotsiaaltöötajalt või lastekaitsetöötajalt vajalikku abi – vene keelt koduse keelena kõnelevate perede seas (8-14%) on see sagedasem probleem kui eesti keelt kõnelevate perede seas (5-8%). Puudeliikidest on seda probleemi vähem esinenud keele- ja kõnepuude (2-8%) ja muu puude (3-6%) korral võrrelduna liitpuude (8-13%), psüühikahäire (8-15%) ja liikumispuudega (7-17%).

Teenus ei vastanud lapse vajadustele – vene keelt koduse keelena kõnelevatel peredel on sellist probleemi esinenud veidi sagedamini (6-10%) kui eesti keelt kõnelevatel (4-6%).

Ülejäänud probleeme on esinenud liialt vähestel inimestel, et oleks võimalik tuua välja statistiliselt olulisi seoseid, mis kirjeldaksid probleemi esinemist sõltuvalt taustatunnustest.

5.3.2 Täiendavad probleemid ja põhjendused, miks teenus ei vastanud vajadustele

Muid probleeme tõid välja 47 vastajat, kirjeldades olukordi, kus laps erinevatel põhjustel teenust ei saanud või kus teenuse saamine oli raskendatud. Sagedamini esile toodud probleemid olid järgmised:

1. Teenusepakkumiseks ei ole piisavat mahtu, teenus on aeguv või teenusele on lihtsalt pikk järjekord

„Teenusepakkujal on liiga palju kliente võetud, mistõttu ei ole kõigile soovijatele piisavalt teenuste saamiseks aegu pakkuda. Meil jäi seetõttu nt. 2016. aastal osa reh. plaani rahast kasutamata.“

2. Kahe teenusepakkuja juures ei saa rehabilitatsiooniplaani teenuseid võtta ja ühel ei ole kõiki neid teenuseid, mida oleks vaja. Seepärast jääb osa teenuseid saamata.

„... seda ei jõua ise kinni maksta, kuna minu teada ei saa kahes kohas rehaplaani täitmas käia, st riigi poolt kompenseeritakse vaid ühes asutuses saadud teenused.“

3. Rehabilitatsiooniasutus on tegelenud pettusega

„Rehabilitatsiooniasutus saab sotsiaalkindlustusametilt rohkem raha, kui meile teenust pakutakse. Ehk siis sotsametile esitatakse rohkemate teenuste eest aruanne, kuid meie nii palju teenuseid ei osutata. Oleme võrrelnud esitatud aruandeid (saime sotsametist) reaalselt saadud teenustega.“

4. Mingi konkreetse teenuse pakkujaid pole

„No tugiisikut [saada] tundub võimatu missioon.“

„... olime saanud peale 4 kuud ootamist logopeedile, siis uue aja saime taas alles 3 kuu pärast, aegu lihtsalt pole võtta.“

„Meie lapsele vajaminevat massööri, kes tegeleks spetsiaalse massaažiga X-jalguse ja lihaslõtvuse leevendamiseks, oli raske leida.“

„Teisel katsel oli psühholoog töölt lahkunud, pidi uus tulema ja siis minuga ühendust võetama. Kolmandal helistamisel sain teada, et uus psühholoog on osalise tööajaga ja vabad ajad on määramata kaugusel.“

5. Teenusepakkujate kaugus ja erinevate teenuste kombineerimise keerukus

„Taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenuse saamise kohad on kodust kaugel, mistõttu on 1-2 nädalased kodust ja töölt eemal viibimised emotsionaalselt väsitavad (nii lapsele kui vanemale); seni oleme kasutanud taastusraviteenust 4-5 korda aastas, aga vajadus oleks suurem. Senisest sagedasem hoolduslehel viibimine (ravil oleku ajal) on keeruline kahel põhjusel - perekonna lahusolek ja ka rahaline kaotus.“

„Teenused peaksid lapsele asuma võimalikult lähedal ja koos, et ei peaks töölt ära käima mitu korda nädalas. N.ö komplekti kokku saada riigi, valla ja erateenuste pakkumiste alusel on VÄGA keeruline.“

6. Teenuste rahastamise skeem

„Kuigi rehabilitatsiooniplaanis on loetletud palju teenuseid, mida laps veel vajaks, ei saa neid, sest maht on ületatud. Seega sai riigi poolt ainult eripedagoogi teenuse 1x nädalas. Seega on ainuke võimalus vanematel ise otsida juurde tasulised teenused (logopeed).“

„Kui reh. plaan kinnitati detsembris ja soovisin veebruaris teenusele aega reserveerida, siis oli reh. plaanil märgitud teenused tühistatud. Kui küsisin miks siis, öeldi et ei tea, neile tuli käsk, et riigil ei ole raha ja esitage uus avaldus...“

7. Asjaajamise keerukus ja bürokraatia

„Dokumentide korda ajamisega läks aega, kuna aasta alguses pandi ootejärjekorda ja info olukorra kohta oli puudulik.“

„Suhtlus käib ainult läbi administraatori, kes mitte kunagi ei tea mitte midagi!“

„Internetis esitatud rehabilitatsiooni taotlus jäi vastuseta, n.ö jäi süsteemi rippuma märkega esitatud, ise ka midagi ette ei võtnud aja puudusel.“

Lisaks paluti puudega laste vanematel, kes märkisid, et teenus ei vastanud lapse vajadustele, seda ka põhjendada. 71 vastajat kirjeldasid, miks teenus lapse vajadustele ei vastanud. Suures osas kirjeldatakse samu probleeme, mida juba eelnevalt sotsiaalteenuste saamise või taotlemise probleeme puudutavas küsimuses nimetati:

- Nimetatud on kas teenuse saamata jäämist või saamist väiksemas mahus, kui oleks vaja, kuna teenusepakkujal pole vastavat teenust vajalikus mahus pakkuda, puuduvad vastava ala spetsialistid või spetsiifilise kvalifikatsiooniga spetsialistid.
- Teine osa probleemidest keskendub teenuse sisule, selle korraldusele ja teenuse konkreetsele läbiviijale, mis ei vasta lapse vajadustele.
- Kolmas osa probleemide kirjeldustest lähtub lastest: teenuste pakkumisel ei arvestata lapse puude spetsiifikaga ning puudujääke esineb ka teenusepakkuja kvalifikatsioonis ning oskustes (sh keeleoskus), mille tõttu ei arvestata piisavalt lapse eripäradega.

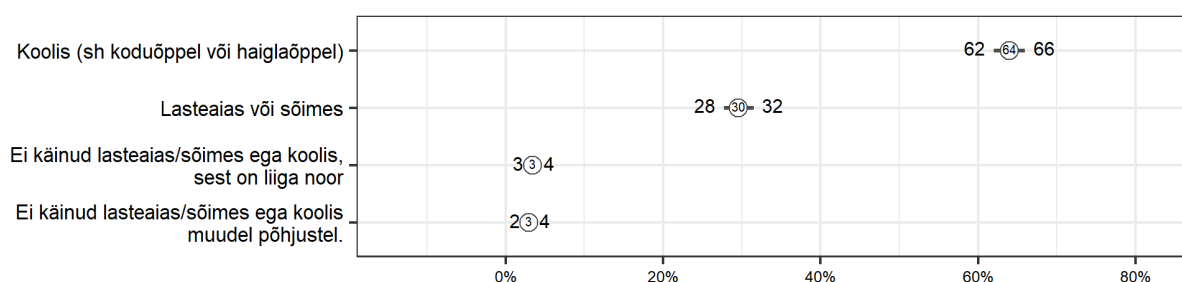
Kokkuvõttes on probleemid teenustega sagedamini seotud piiratud ligipääsuga teenustele, mitte teenuste sisulise kvaliteediga. Probleeme tunnetavad sagedamini kõrgharidusega lapsevanemad ja need, kelle lapsel on olemas rehabilitatsiooniplaan. Mõned probleemid on seotud spetsiifiliste taustatunnustega, nagu nt teenuste pakkumise koht kaugus on sagedamini probleemiks maa-asulates, teiste laste hooldamise probleem suuremates peredes. Sotsiaaltöötajalt nõu saamine on olnud suuremaks probleemiks venekeelsetele peredele.

6 Haridus

6.1 Koolieelses haridusasutuses ja koolis käimine

2016/2017 õppeaastal käis 62-66% puudega lastest koolis (sh koduõppe või haiglaõppe vormis) (Joonis 108). Lasteaias või sõimes käis ligi 28-32% puudega lastest ning 3-4% lastest ei käinud ei lasteaias, lastesõimes ega koolis, sest olid lapsevanema hinnangul liiga noored. Seega vaid 2-4% puudega lastest on jäänud üldharidus- või alusharidussüsteemist kõrvale mingitel muudel põhjustel kui vanus. 2009. aasta uuringuraportis leiti, et haridussüsteemist on kõrvale jäänud 8% puudega lastest (GfK 2009: 34). Sellest lähtudes on koolist ja lasteaiast kõrvale jäänud puudega laste arv ja osakaal selle ajaga võrreldes vähenenud, kuid tulemus ei ole otseselt võrreldav, sest 2009. aastal puudus koolis õppimise valiku juurest täiend „(sh kodu- või haiglaõppe)“.

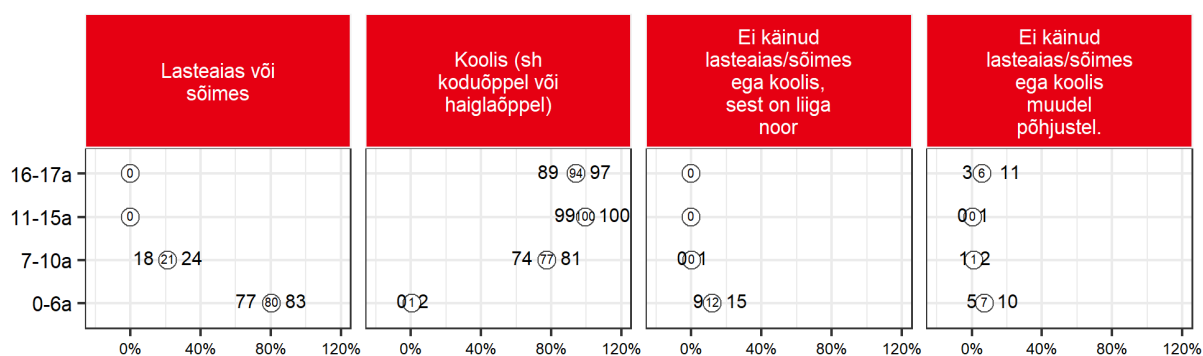
Joonis 108. Puudega laste osalemine haridussüsteemis 2016/2017. õppeaastal (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

0-6-aastastest lastest käivad lasteaias või sõimes 77-83% (Joonis 109), aga 3-7-aastaste laste seas on see osakaal ligi 86%. Valdav osa hariduse omandamisest kõrvalejääjatest on lasteaiaealised, kelle kõrvale jäämise põhjused vastavalt küsitluses antud vabadele vastustele on enamjaolt seotud sobiva lasteaiakoha või vajaliku tugiisiku puudumisega. Lisaks on olukordi, kus vanemad hindavad oma suutlikkust last hooldada ning tema erivajadusi täita kohati suuremaks kui lasteaias personalil.

Joonis 109. Haridussüsteemis osalemine lapse vanuse lõikes 2016/2017. õppeaastal (% vanuserühma kuuluvatest puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

7-aastastest ja vanematest puudega lastest käib kas lasteaias või koolis 96-98%. Vastajate selgitused, miks laps koolis ei käi, seonduvad tervise, ravi ja pikaajalise haiglas viibimisega. Näiteks on lapse kõrvalejäämist vabades vastustes selgitatud järgmiselt:

„Koolikohustus oli koduõppe vormis, kuid tervisliku seisundi tõttu ei olnud võimaline ka selles õppevormis õppima.“

„Viibis haiglas, uuringutel ja operatsioonidel.“

„Oli haiglas ja kodus nii öelda akadeemilisel, õnnetus juhtus 2016. a. juunis.“

16–17-aastaste puudega laste seas on haridussüsteemist kõrvalejääjate osakaal suurem kui 7-15-aastaste puudega laste seas: 16-17-aastastest ei käi koolis 2–14%. Viimased tegelevad pärast kooli lõppemist töö või edasiõppimise võimaluste või muude lahenduste otsimisega.

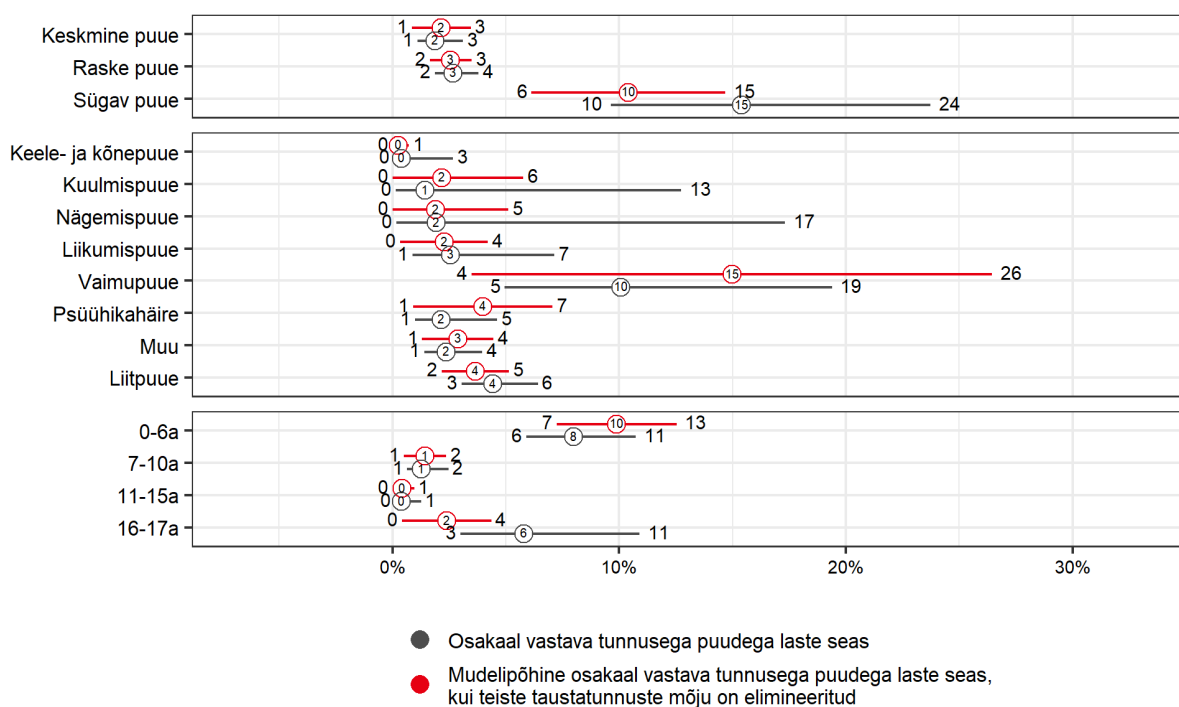
„Ei sobinud eriala, kuhu algul astus kooli.“

„9. klassi sai lõpetatud, kuna käis haiglakoolis ca viimane kuu. Edasi õppima minna ei olnud vaimse seisundi tõttu võimalik.“

„Lõpetas kutsehariduskeskuse ja otsib tööd.“

Kokkuvõttes osaleb enamik puudega lastest haridussüsteemis, õppides kas koolis või lasteaias. Mitteamine on seotud lapse vanusega, aga ka puude raskusastmega (Joonis 110). Jättes vaatluse alt välja need lapsed, kes ei õpi koolis või käi lasteaias, kuna on vanema hinnangul liiga noored, on sügava puudega lastest haridussüsteemist kõrvale jäänud 10-24%, raske puudega lastest 2-4% ja keskmise puudega lastest 1-3%. Puudeliikide lõikes on laiade usalduspiiride tõttu keeruline selgeid järeldusi teha.

Joonis 110. 2016/2017. õppeaastal haridussüsteemis mitteamine puudega lapsed taustatunnuste lõikes (% puudega lastest, kelle puhul pole haridussüsteemis mitteamine põhjendatud nende vanusega)



Märkus: ringid tähistavad keskvaartuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Analüüsist välja jäetud, kes on liiga noored, et käia lasteaias või sõimes ning muud keelt koduse keelena rääkivad lapsed. Sõltuv muutuja: ei käi koolis või lasteaias muudel põhjustel = 1, käib koolis, käib lasteaias või sõimes = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, kodune keel, lapse sugu, lapse vanus.

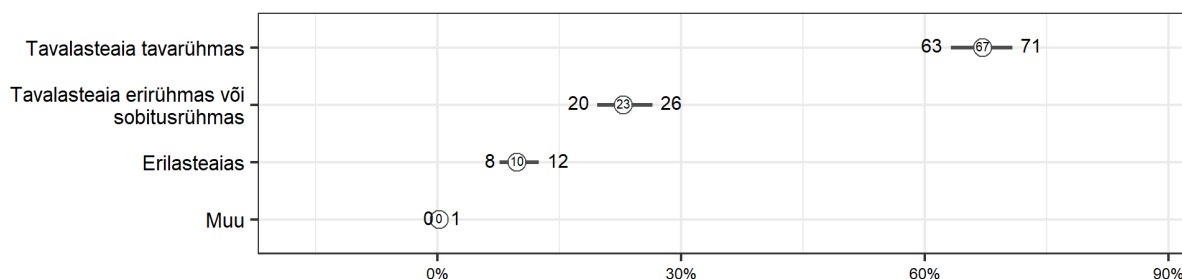
6.2 Koolieelne haridusasutus

6.2.1 Lasteaia ja rühma liik

Lasteaed on Eestis koolieelne lastehoidu ja alusharidust pakkuv asutus, kus moodustatakse söime- ja lasteaiarühmad. Söimerühmad on kuni kolmeaastastele ja lasteaiarühmad 3–7 aastastele lastele. Erivajadustega lastele võib teha spetsiaalse erilasteaia või ka erirühmi või sobitusrühmi tavalasteaias. Erirühm on selline erivajadustega laste rühm, kuhu kuuluvad vaid erivajadusega lapsed (erirühma liigid on: kehapuudega laste rühm, tasandusrühm kõnepuude ja spetsiifilise arenguhäirega lastele, meelepuudega laste rühm, arendusrühm, pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm – autismispektrihäiretega lastele, liitpuudega laste rühm). Sobitusrühma kuuluvad nii erivajadusega kui erivajaduseta lapsed. Nii eri- kui sobitusrühmas on laste arv väiksem kui tavarühmas. Sobitusrühmas arvestatakse, et üks erivajadustega laps täidab kolme lapse koha. Lapse erivajaduse tuvastamiseks ja suunamiseks erivajadustega laste rühma on vajalik nõustamiskomisjoni soovitus. Järgnevas tekstis vaadatakse tavalasteaia erirühma ja sobitusrühma koos ning nimetatakse ühiselt erirühmaks.

Valdav osa lasteaias käivatest puudega lastest, ligikaudu 63–71%, käib tavarühmas, 20–26% käib erirühmas ja umbes kümnendik (8-12%) käib erilasteaias (Joonis 111).

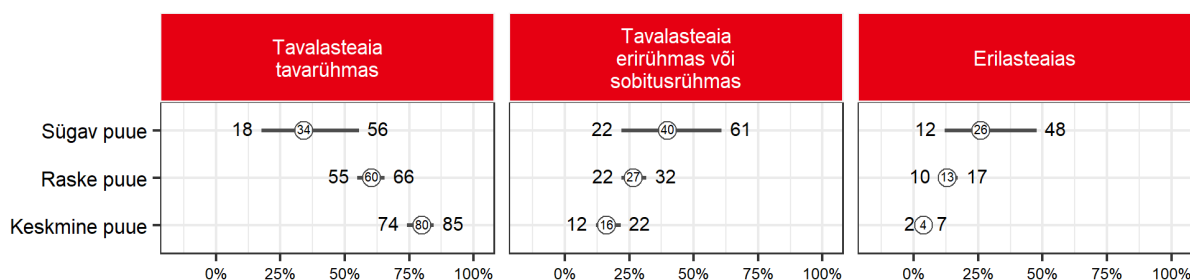
Joonis 111: Millises lasteaias ja rühmas laps 2016/2017. õppeaastal käis? (% lasteaias käivatest puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

Järgnevast analüüsist on kõrvale jäetud lapsed, kelle vanemad vastasid, et laps käib muus lasteaias kui tavalasteaia või erilasteaia. Keskmise puudega lapsed käivad enamjaolt tavalasteaia tavarühmas (74-85%), vähesed lapsed ka tavalasteaia eri- või sobitusrühmas (12-22%) (Joonis 112). Erilasteaia käimine on selle grupi puhul küllaltki vähe (2-7%). Raske puudega lastest käivad tavalasteaia tavarühmas ligi 60% (55-66%) ja eri- või sobitusrühmas ca 22-32%. Erilasteaia käijate osakaal on raske puudega lastest ligi 10-17%. Sügava puudega lasteaias käijate osakaal on küllaltki vähe, seega ei ole võimalik väga ühest ja täpset hinnangut anda, sest osakaalude usalduspiirid on laiad. Siiski võib järeldada, et tavalasteaia tavarühmas käib sügava puudega lapsi oluliselt vähem (tavalasteaia tavarühmas käib 18-56% sügava puudega lastest, keda on ka arvuliselt vähem kui keskmise või raske puude raskusastmega lapsi) kui raske või keskmise puudega lapsi ning seega on sellest grupist enam lapsi koondunud kas tavalasteaia eri- või sobitusrühmadesse (22-61%) või erilasteaia (12-48%).

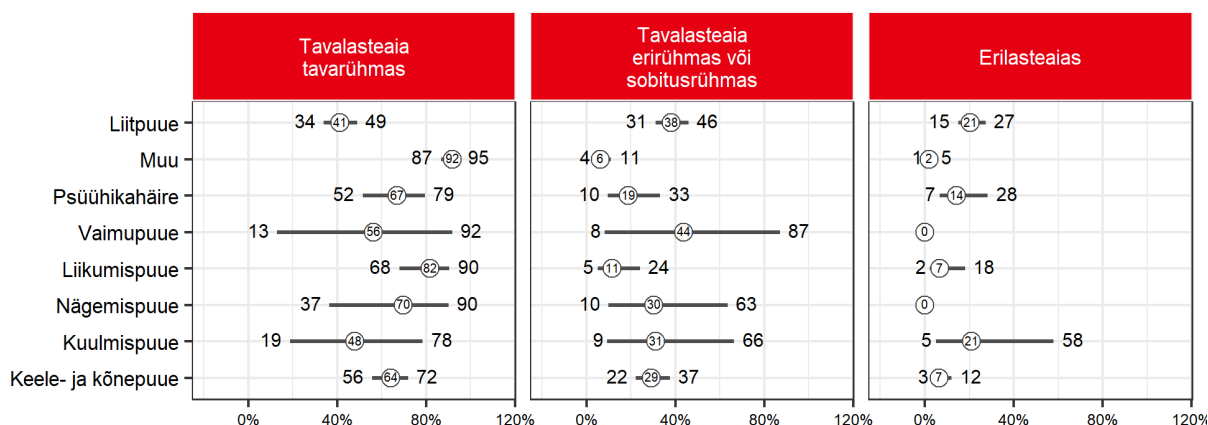
Joonis 112: Millises lasteaia ja rühmas laps 2016/2017. õppeaastal käis? Jagunemine puude raskusastme lõikes (% vastava puude raskusastmega lasteaia või lastesõimes käivatest lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid. Arvestustest on kõrvale jäetud muus lasteaia ja sõimes kui tavalasteaia või erilasteaia käinud lapsed, (2 vaatlust).

Puudeliikide lõikes eristuvad eelkõige muu puudega lapsed, kellest valdav enamus käib tavalasteaia tavarühmas (87-95%), ja liitpuudega lapsed, kellest üle poole käib kas tavalasteaia eri- või sobitusrühmas (31-46%) või erilasteaia (15-27%) (Joonis 113). Teiste puudeliikide omavahelised erisused ei ole niivõrd märkimisväärsed. Siinkohal tuleb jällegi arvestada, et mõnede puudeliikide puhul on uuringus osalenud laste arv väike, mis tingib küllaltki laiad usalduspiirid.

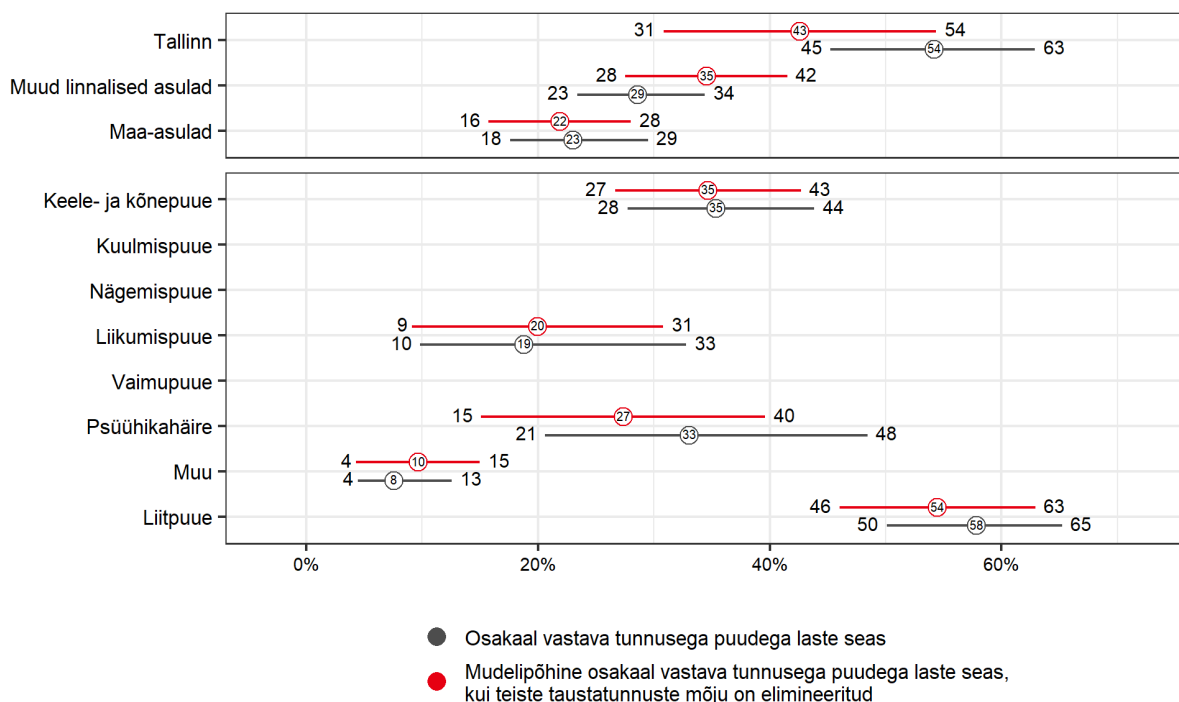
Joonis 113: Millises lasteaia ja rühmas laps 2016/2017. õppeaastal käis? Jagunemine puude liigi lõikes (% vastava puude liigiga lasteaia käivatest lastest)



Märkus: arvestustest on kõrvale jäetud muus lasteaia ja sõimes käinud lapsed, kui tavalasteaia või erilasteaia (2 vaatlust)

Maa-asulates elavad lapsed käivad erilasteaia või erirühmas (18-29%) väiksema tõenäosusega kui Tallinnas (45-63%) elavad lapsed (Joonis 114). Juhul, kui võrrelda samasuguste taustatunnustega lapsi, siis on erinevus Tallinna ja maa-asulate vahel väiksem, kuid siiski olemas.

Joonis 114. 2016/2017. õppeaastal erilasteaias või erirühmas käivad puudega lapsed taustatunnuste lõikes (% puudega lastest, kes käivad lasteaias)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Jooniselt on välja jäetud väärtused, mille usalduspiirid on laiemad, kui 44 pp. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad ja lapsed, kelle vanemad märkisid muu lasteaia tüübi kui eri- või tavalasteaia. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: käib erilasteaias, käib tavalasteaia erirühmas = 1, tavalasteaia tavarühm = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, kodune keel, lapse sugu.

6.2.2 Lasteaia või sõimes käimisega seonduvad probleemid

6.2.2.1 Sissejuhatus

Lasteaia esinenud probleeme saab teema ja leviku järgi grupeerida järgmiselt:

1. Tugimeetmete kättesaadavus (kõige levinum probleem)
2. Õppe vastavus vajadustele
3. Sotsiaalne keskkond
4. Füüsiline kaugus ja ruumid
5. Muud probleemid

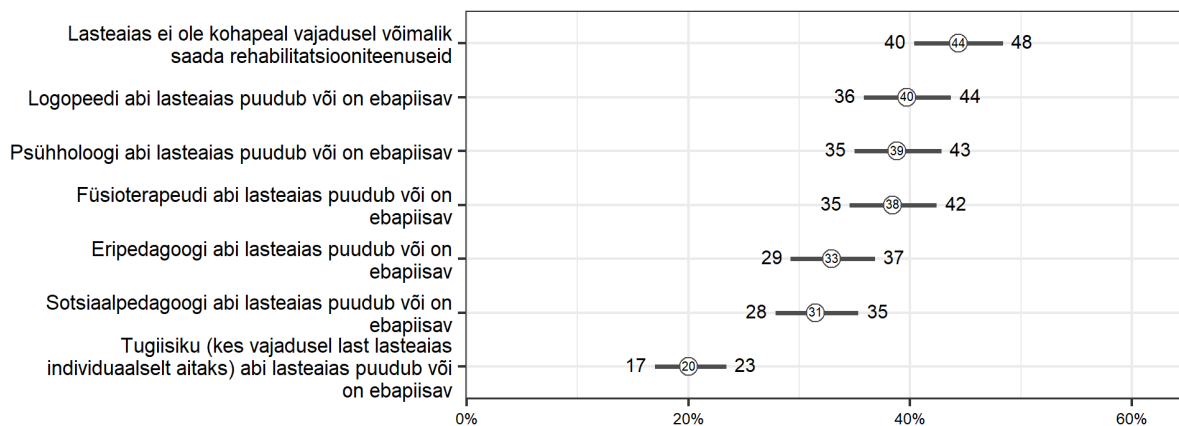
Sellises järjestuses käsitletakse järgnevalt probleeme lähemalt.

6.2.2.2 Tugimeetmete kättesaadavus ja olemasolu haridusasutuses

Rehabilitatsiooniteenuste piiratud kättesaadavus lasteaia on teistest sagedamini esinev probleem (40-48%) (Joonis 115). Samuti on probleeme kõikide teenustega, mida pakutakse muuhulgas rehabilitatsiooni raames: logopeed (36-44%), psühholoog (35-43%), füsioterapeut (35-42%), sotsiaalpedagoog (28-35%) ja eripedagoog (29-37%). Nende teenustega seonduvatest probleemidest vaid veidi vähem levinud probleem on tugiisikuteenuse puudumine või ebapiisavus (17-23%), mis teenusena ei liigitu rehabilitatsiooniteenuste alla. Tugiisikuga seonduvate probleemide vähesem mainimine tuleneb asjaolust, et tugiisikuteenuse üldine vajadus on väiksem kui eelpool nimetatud teenustel. Samas on tugiisikuteenuse suhteline kättesaadavus

oluliselt halvem kui rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus (ptk 5.1). Seega ei näita probleemi väiksem levik, et tegemist oleks kindlasti väiksema probleemiga.

Joonis 115. Tugimeetmetega esinenud probleemid lasteaias 2016/2017. õppeaastal puudega lastel (% lasteaias käivatest puudega lastest)

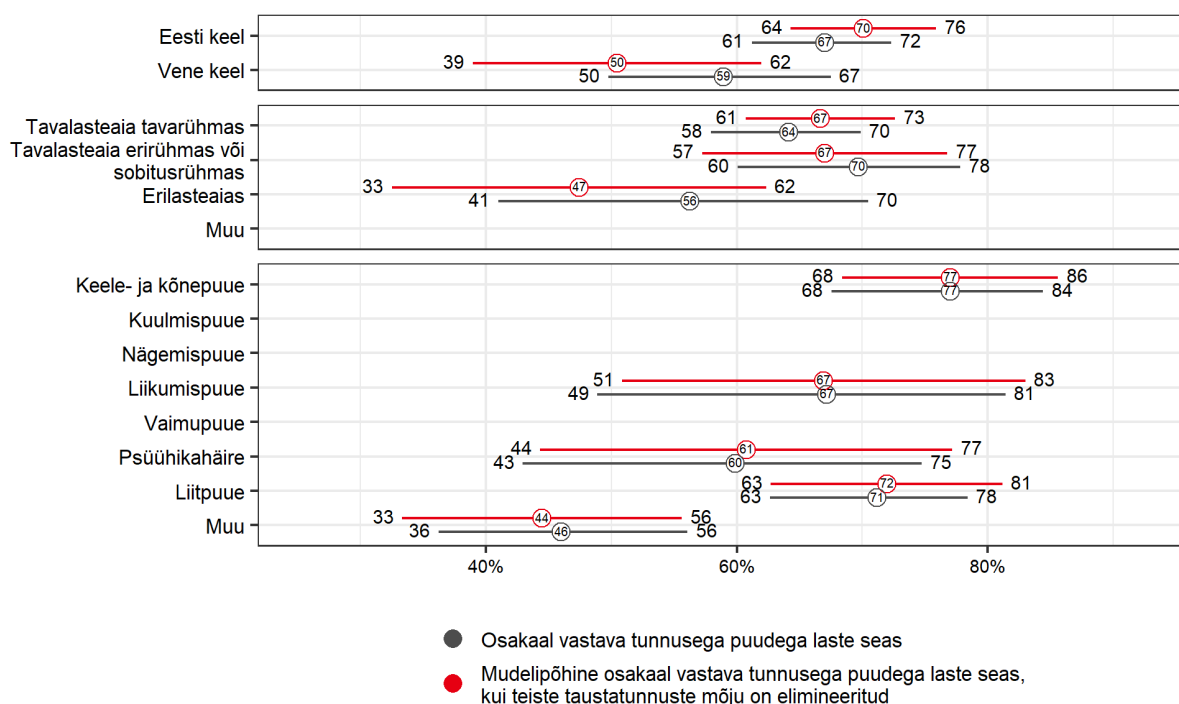


Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

Taustarühmade võrdluses kaasati analüüsi vaid need vastajad, kelle hinnangul antud teema last puudutab. Analüüsist jäeti kõrvale vastajad, kes ütlesid, et teema last ei puuduta või kes jätsid vastuse andmata.

Rehabilitatsiooniteenuste lasteaias kohapeal mittesaamise või teenuste ebapiisavuse probleemi esineb erilasteaedades käivatest puudega lastest 41-70%, tavalasteaia erirühmas käivatest puudega lastest 60-78% ja tavarühmas käivatest puudega lastest 58-70%. Kui võrrelda samade taustatunnustega lapsi, siis erilasteaias käival lapsel on väiksema tõenäosusega probleeme rehabilitatsiooniteenuste saamisega lasteaias kohapeal kui tavalasteaia tavarühmas käival puudega lapsel. Puudeliikide lõikes on see sagedasem probleem keele keele- ja kõnepuudega (68-84%) ning liitpuudega lastel (63-78%) ja veidi vähemate poolt tunnetatud muu puudega lastel (36-56%) (Joonis 116).

Joonis 116. Puudega laste osakaal, kelle vanemad peavad probleemiks, et lasteaias ei ole kohapeal võimalik saada rehabilitatsiooniteenuseid (% lasteaias käivatest puudega lastest, keda antud teema puudutab)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Vaatluse alt välja on jäetud „Ei oska öelda“ ja „See teema last ei puuduta (pole meile oluline)“ vastanud. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: probleem esines = 1, probleemi ei esinenud = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, kodune keel, lasteaia ja rühma tüüp.

Psühholoogi, füsioterapeudi, logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja eripedagoogi teenuste ehk kõikide tugiteenuste puhul, mida pakutakse ka rehabilitatsiooniteenustena, esineb erilasteaias käivate lastel vähem probleeme kui tavalasteaias käivate lastel:

- psühholoogi teenuse saamisega oli probleeme erilasteaias käivatest lastest 30-62%, tavalasteaia sobitusrühmas käivatest lastest 59-78% ja tavarühmas käivatest lastest 48-60%;
- füsioterapeudiga oli probleeme erilasteaias 29-59%, sobitusrühmas 61-79%, tavarühmas 49-61%;
- logopeedi teenuse osas ei ole erinevusi, kui vaadata lihtsalt osakaalusid lastest (erilasteaias 27-54%, sobitusrühmas 30-47% ja tavarühmas 41-52%), kuid erinevused ilmnevad, kui vaadata samasuguste taustatunnustega lapsi³⁶ (erilasteaias 19-44% ja tavarühmas 45-56%);
- sotsiaalpedagoogiga on analoogne olukord, kus vaadates laste osakaalu, kellel on probleeme, ei ole lasteaia rühmade lõikes statistiliselt olulisi erinevusi (erilasteaias 26-58%, sobitusrühmas 45-66%, tavarühmas 41-54%), kuid erinevused ilmnevad, kui vaadata samasuguste taustatunnustega lapsi (erilasteaias 11-45%, sobitusrühmas 41-61% ja tavarühmas 45-57%);

³⁶ Taustatunnustega lastena käsitletakse selles peatükis logit-mudelisse lülitatud tunnuseid: puude liik, puude raskusaste, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, kodune keel, lasteaia ja rühma tüüp, pereliikmete arv. Sõltuv muutuja: probleem esines = 1, probleemi ei esinenud = 0. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Vaatluse alt välja on jäetud „Ei oska öelda“ ja „See teema last ei puuduta (pole meile oluline)“ vastanud.

- eripedagoogi teenuse saamisega on probleeme erilasteaias käivatest lastest 18-44%, sobitusrühmas 30-48% ja tavarühmas 43-55%, kuid erinevused on selgemad, kui vaadata samasuguste taustatunnustega lapsi (erilasteaias 10-35%, sobitusrühmas 25-43% ja tavarühmas 48-59%).

See tähendab, et võrrelduna tavalasteaia tava-, eri- või sobitusrühmaga suudetakse erilasteaias kohapeal paremini pakkuda puudega laste vajadustele vastavaid tugiteenuseid. Teenustest enamiku osas ei ole sobitus- või erirühmade lastel vähem probleeme kui tavarühmade lastel, v.a eripedagoogi teenus, millega sobitusrühmades õppivatel puudega lastel on vähem probleeme kui tavarühmades õppivatel puudega lastega.

Eesti keelt koduse keelena rääkivate puudega laste perede seas on enam kui kodus vene keelt rääkivate seas neid, kes tunnetavad probleemina nii üldiselt rehabilitatsiooniteenuste puudust (Joonis 116) kui ka spetsiifiliste teenuste (psühholoog, füsioterapeut, sotsiaalpedagoog) puudust lasteaias. Psühholoogi teenusega oli probleeme eesti keelt koduse keelena kõnelevatest 56-68% ja vene keelt kõnelevatest 40-56%; füsioterapeudiga eestikeelsetest 54-66% ja venekeelsetest 42-60% (erinevus on selgem, kui võrrelda samasuguste taustatunnustega lapsi, sel juhul on eestikeelsetest probleeme 56-70% ja venekeelsetest 34-57%); sotsiaalpedagoogiga on probleeme olnud 47-60% eestikeelsetest puudega laste peredest ja 32-49% venekeelsetel peredel. Logopeedi ja eripedagoogi teenuse osas pole koduse keele järgi statistiliselt olulist erinevust võimalik tuvastada. Logopeediga on probleeme olnud eestikeelsetest peredest 39-50% ja venekeelsetest 35-50%; eripedagoogiga eestikeelsetest peredest 41-52% ja venekeelsetest 31-47%.

Ülejäänud gruppide erisused on teenuste kaupa järgmised:

Psühholoogi³⁷ teenuse puudumist või ebapiisavust lasteaias tunnetavad enam psüühikahäire (58-89%), liitpuude (59-76%) ning keele- ja kõnepuudega (62-80%) laste vanemad võrrelduna liikumis- (14-45%) ja muu puudega (27-45%) laste vanematega. Regiooniti esinevad samuti mõned sisuliselt väikesed statistiliselt olulised erinevused.

Füsioterapeudi teenuse puudumist või ebapiisavust lasteaias tunnetatakse psüühikahäirega (56-89%), liitpuudega (57-74%) ning keele- ja kõnepuudega (59-78%) laste vanemate seas sagedamini kui muu puudega (27-46%) laste vanemate seas.

Logopeedi teenuse puudumist või ebapiisavust lasteaias tunnetavad keele- ja kõnepuudega (49-66%) ning liitpuudega (42-58%) laste vanematest enamad kui nägemis- (4-54%), muu (21-36%) ja liikumispuudega (19-48%) laste vanemad.

Sotsiaalpedagoogi teenuse puudumine või ebapiisavus lasteaias on sagedasem probleem psüühikahäire (45-78%), liitpuude (50-68%) ning keele- ja kõnepuudega (50-71%) lastel võrrelduna liikumispuude (9-36%) ja muu puudega (24-42%) lastega. Tallinnas tunnetatakse probleemi sagedamini (52-72%) kui muudes linnalistes asulates (30-45%) või maa-asulates (44-61%). Maa-asulad erinevad Tallinnast juhul, kui võrrelda samasuguste taustatunnustega lapsi Tallinnas ja maa-asulates - sel juhul on tõenäosus, et Tallinna puudega lastel probleem esineb, 55-83% ja maa-asulate puudega laste puhul 37-57%.

Eripedagoogi teenuse puudumist või ebapiisavust lasteaias on maininud sagedamini psüühikahäirega (34-68%), liitpuudega (37-54%) ning keele- ja kõnepuudega (51-69%) laste vanemad võrrelduna muu puude (22-40%) ja liikumispuudega (8-35%) laste vanematega. Kuulmispuudega laste tulemus teistest

³⁷ Mudeli spetsifikatsioon on selle ja lasteaias probleeme käsitlevate järgnevate tunnuste korral sama, mis kirjeldatud Joonis 116 allmärkuses.

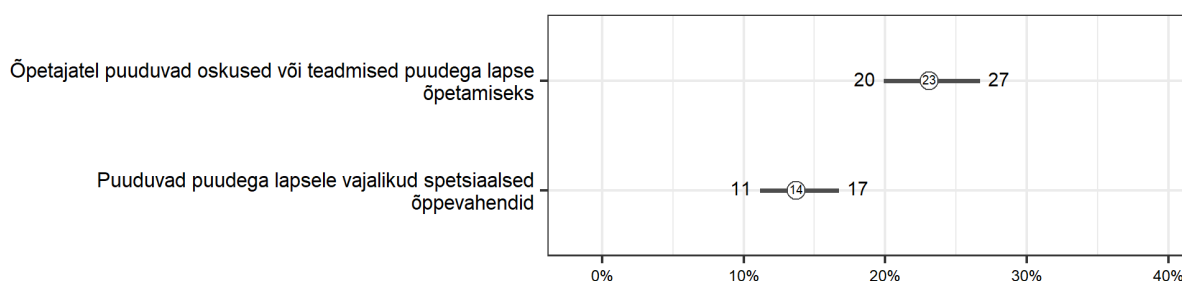
puudeliikidest statistiliselt olulisel määral ei eristu, kuna on laiemate, 50-protsendipunktiliste usalduspiiridega. Muudes linnalistes asulates (25-39%) on eripedagoogi teenuse puudumine või ebapiisavus harvem probleemiks kui maa-asulates (44-60%) ja Tallinnas (45-64%).

Tugiisikuteenus, mis ei ole, erinevalt eelmistest, rehabilitatsiooniteenuste raames pakutav teenus, pakkumisega on olnud Põhja-Eestis (35-52%) enam probleeme kui Kesk-Eestis (5-28%) ja Lõuna-Eestis (20-36%) elavate lasteaia käivate laste seas. Lääne-Eesti ja Kirde-Eesti näitajad statistiliselt oluliselt ei erine, kuna nende regioonide kohta järelduste tegemisel tuleb arvestada laiade usalduspiiridega.

6.2.2.3 Õppe vastavus vajadustele

Lasteaia käivate puudega laste vanematest tunnetas 20–27% probleeme seoses õpetajate puuduvate oskuste või teadmistega puudega laste õpetamiseks. Sellest veidi vähem oli probleeme õppevahendite puudumisega (11-17%) (Joonis 117).

Joonis 117. Lasteaia käivatel puudega lastel esinenud probleemid õppe vastavusega lapse vajadustele (% lasteaia käivatest puudega lastest)



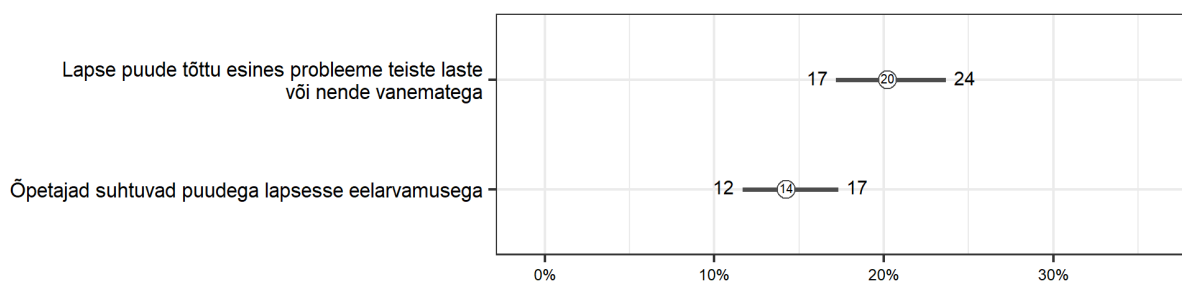
Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

Õpetajate teadmiste ja oskuste probleem on selgelt seotud lasteaia ja rühma tüübiga. Erilasteaia on 2-18%l selline probleem esinenud, tavalasteaia erirühmas 9-23%l, tavalasteaia tavarühmas aga 33-44%l. Need erinevused püsivad ka siis, kui vaadata samade taustatunnustega lapsi.

6.2.2.4 Sotsiaalne keskkond

Ligi viiendik (17-24%) puudega laste vanematest on toonud välja probleemi teiste laste või nende vanematega. Õpetaja eelarvamusliku suhtumisega puudega lapsesse on kokku puutunud 12–18% puudega laste vanematest (Joonis 118).

Joonis 118. Lasteaia käivatel puudega lastel puude tõttu esinenud probleemid teiste laste vanemate ja lastega (% lasteaia käivatest puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

Teisi taustatunnuseid arvesse võttes on selliseid probleeme esinenud erilasteaia vähemal kui tavalasteaia tavarühmas. Probleeme teiste laste või nende vanematega on olnud 6-25%l erilasteaia käivatel puudega lastel ja 20-29%l tavarühma lastel. Erinevus on selgem, kui võrrelda samasuguste taustatunnustega lapsi: sel juhul on tõenäosus, et erilasteaia on probleem, 3-20% ja tavarühmas

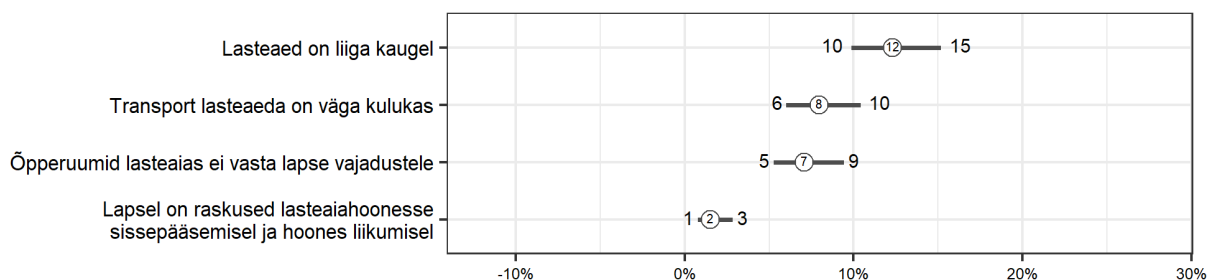
tavalasteaias 22-32%. Nii sobitusrühmas käivatel (5–15%) kui erilasteaias käivatel lastel (3–19%) on õpetajate eelarvamusliku suhtumisega vähem probleeme kui tavarühmades käivatel lastel. (17–26%) .

Probleeme teiste laste või nende vanematega on muu puudega (10-22%) ja liikumispuudega (3-23%) lastel olnud vähem kui psüühikahäire (24-54%), liitpuude (20-34%) ja keele- ja kõnepuudega (20-36%) lastel.

6.2.2.5 Füüsiline kaugus ja ruumidele ligipääs

Lasteaias käivate puudega laste vanemad tunnetavad lasteaia füüsilise keskkonnaga seonduvaid probleeme vähem kui eelpool käsitletud probleeme (Joonis 119). Kõige enam tuuakse esile lasteaedade liigset kaugust (10–15%) ja ka sellega mõneti seonduvat transpordi kulukust (6–10%). Õpperuume peab lapse vajadusi arvestades ebasobivaks 5–9% ja lasteaia konkreetset füüsilist keskkonda vaid 1–3% vastajatest.

Joonis 119: Lasteaia füüsilise keskkonnaga seotud probleemid (% puudega lastest, kes käivad lasteaias)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

Kaugus lasteaiast on mõnevõrra enam tunnetatud probleem maa-asulates. See erinevus pole statistiliselt oluline, kui võrrelda maa-asulates ja linnades elavate laste vanemate osakaale, kes probleemi mainisid (Tallinnas 9-22%, muudes linnalistes asulates 8-16% ja maa-asulates 13-25%); küll aga ilmneb erinevus, kui võtta arvesse ka teiste taustatunnuste mõju. Teisi taustatunnuseid arvestades on 16–31% maa-asulates elavatel puudega lastest probleemiks, et lasteaed on liiga kaugel võrrelduna linnaliste asulatega, kus vastav näitaja on 7–18% ja Tallinnas 3-15%. Lasteaia kaugus on erilasteaias või sobitusrühmas käivate laste jaoks veidi sagedasem probleem (vastavalt 24-51% ja 15–30%) kui tavalasteaias käivate laste jaoks (6-12%). Analoogsed seosed ilmnevad ka transpordi kulukuse probleemi osas.

Õpperuumide vajadustele vastavuse ja ruumides liikumise probleemi esineb nii vähestel, et nende gruppide lõikes analüüsimisel ei saa statistiliselt ja sisuliselt olulisi erinevusi välja tuua.

6.2.2.6 Muud probleemid

Lisaks oli vastajatel võimalik tuua välja muid probleeme, mis seoses puudega lapse käimisega lasteaias või lastesõimes viimasel õppeaastal esinesid. Sealhulgas nimetati järgnevaid probleeme:

1. Lapsega tegelevate õpetajate või spetsialistide ebakompetentsus või liiga vähe töötajaid.

„Tugiisik oli ebakompetentne, mis väljendus selles, et ei vastanud kõikidele lepingus olevatele punktidele, sealhulgas vanemale lühiülevaate andmine lapse päeva kohta ning andis iga päeva lõpus või sageli lapsele kommi, mille osas oli teda palutud seda mitte teha, kuid ta ei reageerinud palvetele. ... Laps hakkas teadmata põhjusel lonkama augusti alguses, kuid tugiisik ei teadnud millest see tingitud oli, ometigi on tema amet isiklik abistamine ja jälgimine.“

„Lasteaia kasvatajad ei ole nõus vastutust võtma ega süvenegi insuliinipumba toimingutesse. Kuna lasteaedades ei ole ka arste, on kogu vastutus kasvatajal ja ka lapsi on ühes rühmas palju.“

„Lasteaias pidev personali puudus, 7 raske liikumispuudega lapse kohta 1 õpetaja ja 1 abiõpetaja korraga tööl on ikka väga vähe. Lastega ei jõuta tegeleda, ainuke variant ongi nad tooli istuma panna, siis ei juhtu õnnetusi. Mis arengust me nii räägime liikumise poole pealt???”

„Kahjuks ei oma võimlemisõpetaja oskusi liikumispuudega lapsega ümberkäimiseks (taunitav oli ka vanema huvi tundi jälgida).“

2. Liiga suured rühmad, et puudega laps saaks käia tavarühmas või kodulähedases lasteaias. Erirühmade puudus.

„Kui diabeetik käib sobitusrühmas, on talle arvestatud nn. kolme lapse koht. Sama peaks olema kindlasti ka tavalasteaias tavarühmas kuna diabeetik vajabki rohkem aega ja tähelepanu. Siis ei oleks ka kasvatajad ehk sellele nii vastu.“

„Lasteaias puudub väikerühm. Laps väsib suures rühmas ja ta ei saa vajalikul määral tähelepanu õppimisel ja tegevustes abi.“

3. Venekeelsete erirühmade puudus

„Väga vähe kohti on venekeelsetes erilasteaedades.“

4. Sobiva komplekti tugiteenuste puudumine

„1. toitumine (kuna üliallergiline ja diabeetik vajab laps eridieeti) – lasteaias puudub oma kokk ja kui laps soovib lasteaias süüa, siis peaks ise söögi kaasa panema 2. diabeet (laps vajab jälgimist, suhkru mõõtmist, vajadusel ka süstimist) ja kindlal ajal söömist kindlates kogustes. Kõiges eelnevas vajab ta abistamist, sest lapsel arenguline mahajäämus (psüühiliste, kõne-ja muude funktsioonide häire). Seetõttu ei saa laps lasteaias olla tervet päeva. Lasteaed soovitas otsida lapsele tugiisik, et laps saaks terve päeva lasteaias olla.“

5. Lasteaias pakutavad tugiteenused, mis on samad rehabilitatsiooniteenustega, ei arvestata rehabilitatsiooniteenustena. Samas oleks vaja, et rehabilitatsiooniteenuseid pakutaks lasteaias. Samuti oleks võimalik erilasteaeda selliselt rahastada.

„Probleem on see, et lasteaed suleti. Samuti sisuliselt järgiti rehabilitatsiooniplaani ja lapsele vajalikud teenused olid kättesaadavad, kuid ametlikult ei läinud lasteaias spetsialistide tegevus rehabilitatsiooniteenuste alla (sh ei saanud lasteaed sealt rahastust). Ma arvan, et see on väga suur lünk süsteemis, sest kui lapsel on võimalik saada teenused (logopeed, eripedagoog, füsioteraapia jms) lasteaiast, parandaks see oluliselt teenuste kättesaadavust ning ehk ei vaevleks ka spetsiaalsed lasteaedad rahapuuduses.“

6. Toitlustuse probleemid

„Lasteaiakokk keeldus lapsele vastavat toitu tegemast, ka juhtkond ei võtnud midagi ette.“

7. Puudega laste erirühm on oluliselt kallim kui tavarühm

„Olen sunnitud mõlemad lapsed meelega puudega laste rühma panema. Rühma kohatasu on 70 eurot lapse kohta. Tavalasteaias oleks kohatasu 35 lapse kohta.“

8. Puudub paindlikkus ja vastutulelikkus lasteaias poolt, mis võimaldaks lapse päeva paremini korraldada

„Kuna laps peaks käima füsioteraapias vähemalt iga nädal ning füsioterapeudid võtavad vastu valdavalt 9-16.00, siis on päris keeruline lapsega teenusel käia nii, et laps saaks õpitud ja söödud. Kahjuks ei võimalda lasteaed mõningasi erinevusi ettenähtud söögiaegadest (nt 30 min varem või hiljem sööma minna).“

6.2.3 Kokkuvõte

Kokkuvõttes käib suurem osa puudega lasteaiaaalistest lastest koolieelses haridusasutuses, vaid ca 14% on selliseid, kes ei käi lasteaias ega -sõimes. Enamik käib lasteaia tavarühmas. Erilasteaeadades ja erirühmades käivate puudega laste osakaal on suhteliselt väike. Samas on erilasteaeadades käivatel puudega lastel parem juurdepääs sotsiaalteenustele ja ka sotsiaalse keskkonnaga on vähem probleeme kui samade taustatunnustega lastel, kes käivad tavarühmades. Erilasteaiad ja sobitusrühmad on aga laste kodudest kaugemal ja seetõttu on nende kasutamisel veidi enamatel probleeme lasteaia kauguse ja transpordi kulukusega.

6.3 Koolid

6.3.1 Kooli, klassi ja õppekava liik

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses on sätestatud erivajadustega laste kaasava hariduskorralduse põhimõte, mille järgi õpib erivajadustega laps üldjuhul kodulähedase kooli tavaklassis koos teiste õpilastega. Seejuures peavad olema tagatud lapsele vajalikud tugimeetmed, et oleks võimalik omandada kvaliteetne haridus. Hariduse tugimeetmetena käsitletakse logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenust. Lisaks nendele on teatud eriklassides ette nähtud ka füsioterapeudi teenus. Õppimist toetava meetmena võib moodustada vajadusel õpiabirühmi. Koolis käimist toetavate teenustena võib teha pikapäevarühmi ja õpilaskodu.

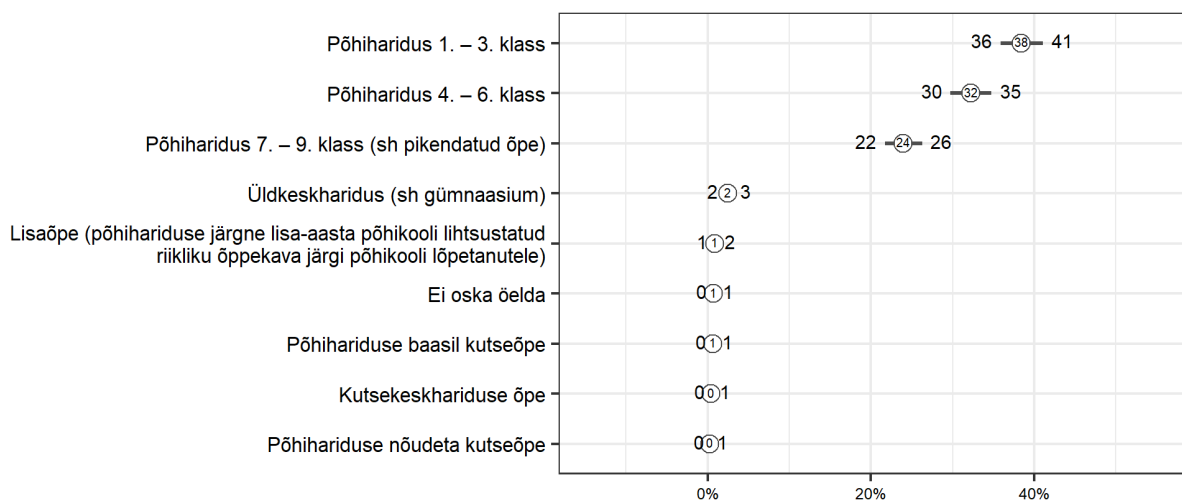
Õppe paremaks korraldamiseks võib moodustada eriklasse ja erikooli. Eriklassi lapse õppima suunamiseks peab olema lapsel tuvastatud hariduslik erivajadus. Hariduslik erivajadus võib, aga ei pruugi olla seotud puudega. Lapse suunamiseks osadesse eriklassidesse piisab arsti tõendist, et selle alusel hariduslik erivajadus tuvastada, teiste jaoks peab lapsel olema maakondliku nõustamiskomisjoni soovitus. Üks-ühele õppe ja väikeklassi tingimustes õppe jaoks peab olema üleriikliku nõustamiskomisjoni soovitus. Lisaks eriklassi ja erikooli tingimustes õppele võib vajadusel korraldada õppe ka kodu- või haiglatiingimustes.

Teine oluline dimensioon erivajadustega õpilaste õppe korraldamisel on õppekava, mille järgi õpilased õpivad. Lisaks põhikooli riiklikule õppekavale võib vajadusel laps õppida lihtsustatud riikliku õppekava järgi, mille all on omakorda kolme liiki õpe: lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpe. Lihtsustatud õppekava võimaldab valida selle õppe taseme, mis vastab lapse võimetele, kuid kõikidel juhtudel, kui õpilane õpib lihtsustatud õppekava järgi, tehakse talle ka individuaalne õppekava. Lapse viimiseks lihtsustatud õppekavale on vajalik nõustamiskomisjoni nõusolek. Individuaalse õppekava võib teha ka riikliku põhikooli õppekava järgi õppivatele lastele, kuid juhul, kui sellega kaasneb mingites õppeainetes õppekavajärgsete tulemuste saavutamise vähendamine, on vaja nõustamiskomisjoni nõusolek. Gümnaasiumi tasemel on üks riiklik õppekava.

Puudega laste jagunemine õppeastmete vahel kajastab 7–17-aastaste koolis käivate puudega laste vanuselist kompositsiooni. Üle 95% kooliealistest puudega lastest õpib põhikoolitasandil (sh pikendatud õppel või lisaõppel³⁸) (Joonis 120).

³⁸ Põhihariduse järgne lisa-aasta põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi põhikooli lõpetanutele.

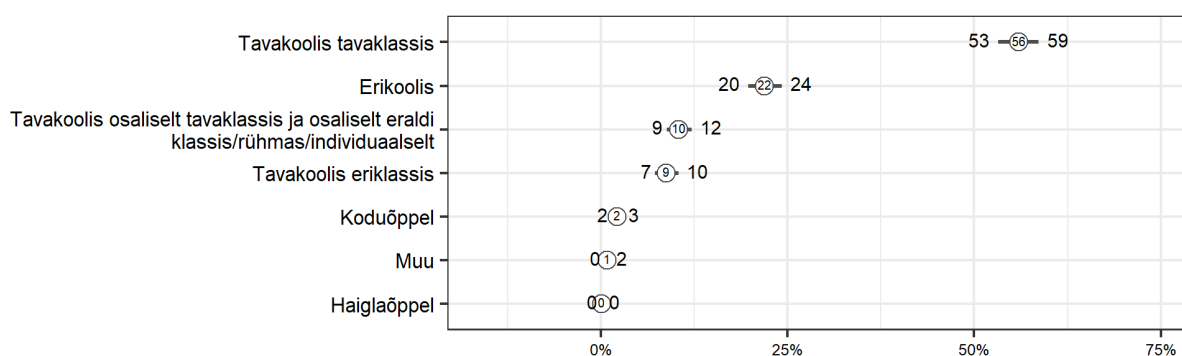
Joonis 120. Koolis käivate puudega laste jagunemine õppeastmete vahel 2016/2017. õppeaastal (% koolis käivatest kuni 17-aastastest puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

Põhikoolis õppivatest puudega lastest õpivad veidi enamad kui pooled (53-59%) tavakooli tavaklassis (Joonis 121). Erikoolis õpib viiendik kuni veerand (20-24%) põhikoolis õppivatest puudega lastest. Tavakooli eriklassis õpib samuti ca viiendik (16-22%) põhikoolis õppivatest puudega lastest, seejuures neist ligi pooled õpivad täielikult eriklassis ja pooltel on osaliselt õpe koos tavaklassiga.

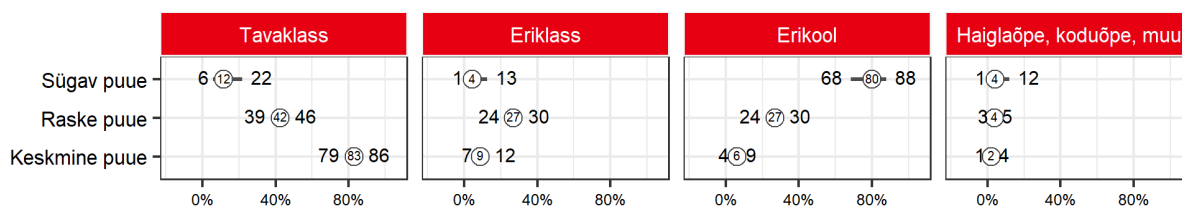
Joonis 121. Põhikoolis õppivate puudega õpilaste jagunemine õppe korralduse järgi 2016/2017. õppeaastal (% põhikoolis õppivatest puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

Erikoolis ja eriklassis õppimise peamiseks määrajaks on lapse puude raskusaste (Joonis 122). Põhikoolis õppivatest sügava puudega lastest õpib valdav osa erikoolides (68–88%). Samas, tavakoolides õppides võivad sügava puudega lapsed olla nii tava- kui eriklassis (vastavalt 6-22% ja 1-13%). Raske puudega lapsed jagunevad enam-vähem võrdselt tavaklassi (39-46%), eriklassi (24-30%) ja erikooli (24-30%) vahel, veidi suurem osa on tavaklassis. Keskmise puudega lapsed õpivad valdavalt tavaklassis (79–86%).

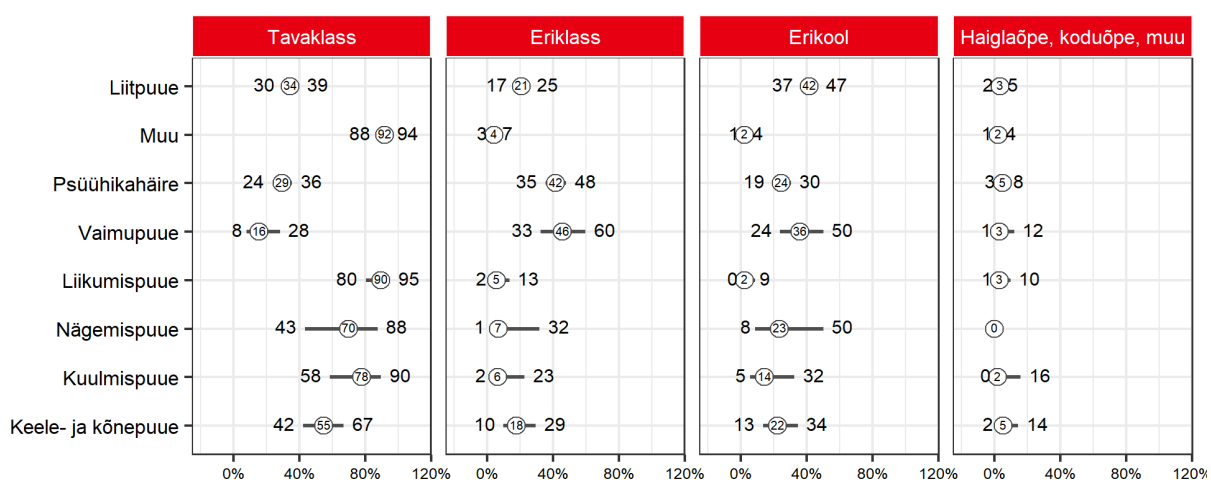
Joonis 122. Põhikoolis õppivate puudega õpilaste jagunemine eriõppe korralduse ja puude raskusastme järgi 2016/2017. õppeaastal (% põhikoolis õppivatest vastava raskusastmega puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

Puudeliikide lõikes on samuti erinevused selles, kas laps õpib tavaklassis, eriklassis või erikoolis, kuid need erinevused ei ole nii selgepiirilised kui puude raskusastmete lõikes. Põhikoolis õppivatest liitpuude, psüühikahäire ja vaimupuudega lastest õpib tavakooli tavaklassides väiksem osa kui teiste puudeliikidega lastest (Joonis 123). Põhikoolis õppivatest puudega lastest õpib tavakooli tavaklassis liitpuudega lastest 30-39%, psüühikahäirega lastest 24-36%, vaimupuudega lastest 8-28%, nägemispuudega lastest 43-88%, kuulmispuudega lastest 58-90%, keele- ja kõnepuudega lastest 42-67%, liikumispuudega lastest 80-95% ja muu puudega lastest 88-94%. Need puudeliigid, mille korral on vähem lapsi tavakooli tavaklassis, on samal ajal ka sagedamini seotud raskemate puude raskusastmetega. Teise grupi moodustavad nägemis-, kuulmis- ja keele ning kõnepuudega õpilased, kellest ca 50-90% õpib tavakooli tavaklassides, ning kolmanda grupi moodustavad muu ja liikumispuudega lapsed, kellest enam kui 80% õpivad tavakooli tavaklassides.

Joonis 123. Põhikoolis õppivate puudega õpilaste jagunemine eriõppe korralduse ja puude liigi järgi 2016/2017. õppeaastal (% põhikoolis õppivatest vastava puude liigiga lastest)

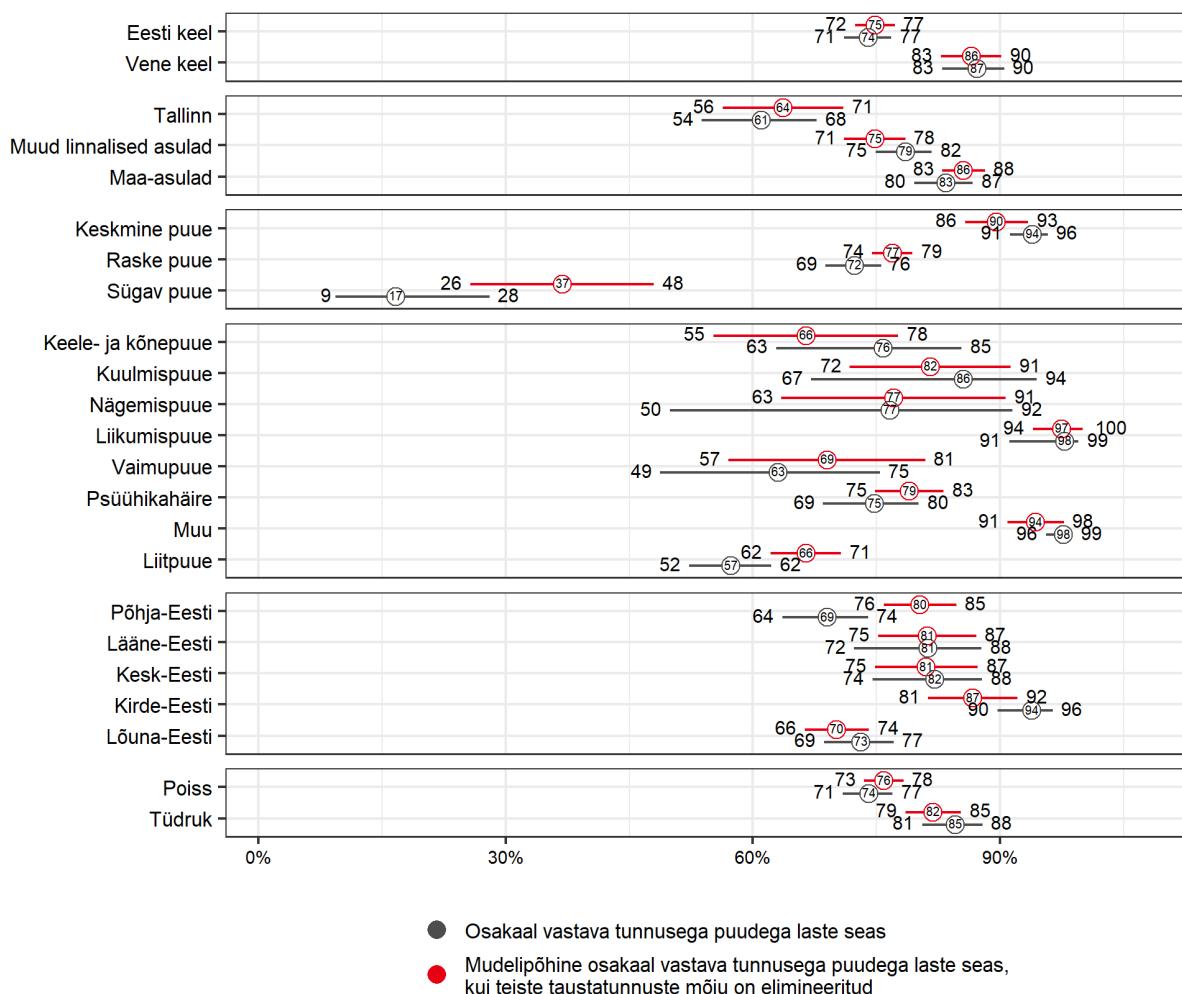


Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

Ka muid taustatunnuseid arvesse võttes õpivad raskema puude raskusastmega lapsed väiksema tõenäosusega ja liikumis- ning muu puudega lapsed suurema tõenäosusega tavakoolis (Joonis 124). Tavakoolis õppimine on seotud elukohaga. Tallinnas õpib erikoolis 54-68% põhikoolis õppivatest puudega lastest, muudes linnalistes asulates vastavalt 75-82% ja maa-asulates 80-87%. Maa ja linnaliste asulate erinevus on selgem, kui teiste taustatunnuste mõju elimineerida. Tavakoolis õppimise tõenäosus on muude samade tingimuste korral maa-asulates elavate laste seas suurem (83-88%) kui linnas elavate laste seas (71-78%). Põhikoolis õppivatest puudega lastest Tallinnas ja Lõuna-Eestis (69-77%) on tavakoolis õppivate laste osakaal väiksem kui teistes Eesti regioonides (Kirde-Eestis 90-96%, Kesk-Eestis 74-88% ja Lääne-Eestis 72-88%). Põhja-Eesti küll ei eristu Lõuna-Eestist, juhul kui võrrelda lihtsalt tavaklassis õppivate laste osakaale põhikoolis õppivatest puudega lastest, kuid erinevus on ilmne, kui elimineerida teiste taustatunnuste mõju. Teistest regioonidest eristub Tallinn, kuid mitte ülejäänud Põhja-Eesti. Lõuna-Eesti ja Tallinna eristumine on tõenäoliselt tulenev sellest, et Tallinnas ja Tartus on juurdepääs erikoolidele võrreldes teiste Eesti piirkondadega parem.

Erikoolis õpib venekeelsetes leibkondades elavatest põhikoolis käivatest lastest väiksem osakaal kui eestikeelsetes leibkondades elavatest põhikoolis käivatest lastest. Vastavalt on tavakoolis õppivate puudega laste osakaal vene keelt koduse keelena kõnelevatest 83-90% ja eesti keelt kõnelevatest 71-77%. Põhikooliastmel õppivatest puudega tüdrukutest õpib tavakoolis (81-88%) suurem osa kui poistest (71-77%).

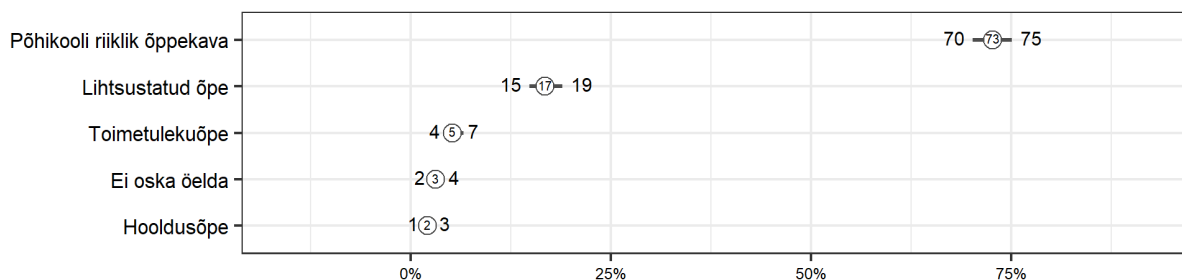
Joonis 124. Tavakoolis õppivate puudega laste osakaalud ja prognoositud osakaalud 2016/2017. õppeaastal (% koolis õppivatest puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: õppis tavakoolis tavaklassis või eriklassis = 1, õppis erikoolis = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, kodune keel, lapse vanuse grupp, lapse sugu.

Enamik põhikoolis õppivaid puudega lapsi õpib põhikooli riikliku õppekava järgi (70–75%) (Joonis 125).

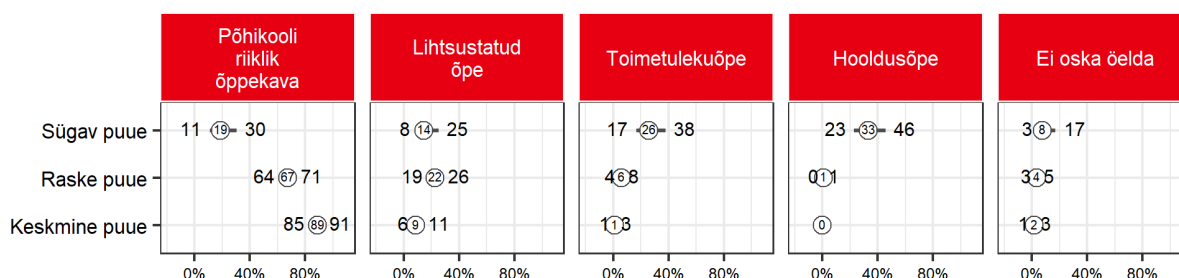
Joonis 125: Põhikoolis õppivate puudega laste jagunemine õppekavast lähtuvalt 2016/2017. õppeaastal (% põhikoolis õppivatest puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

Kuigi enamik põhikoolis õppivatest puudega lastest õpib põhikooli riikliku õppekava järgi, on puude raskusastme kasvades selliste laste arv suhteliselt väiksem (Joonis 126). Põhikoolis õppivad sügava puudega lapsed õpivad valdavalt põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi (53-86%), seejuures kõige suurem osa on hooldusõppel (23-46% sügava puudega lastest). Põhikoolis õppivatest raske puudega lastest õpib valdav osa põhikooli riikliku õppekava järgi (64-71%), aga viiendik kuni veerand on lihtsustatud õppel (19-26%).

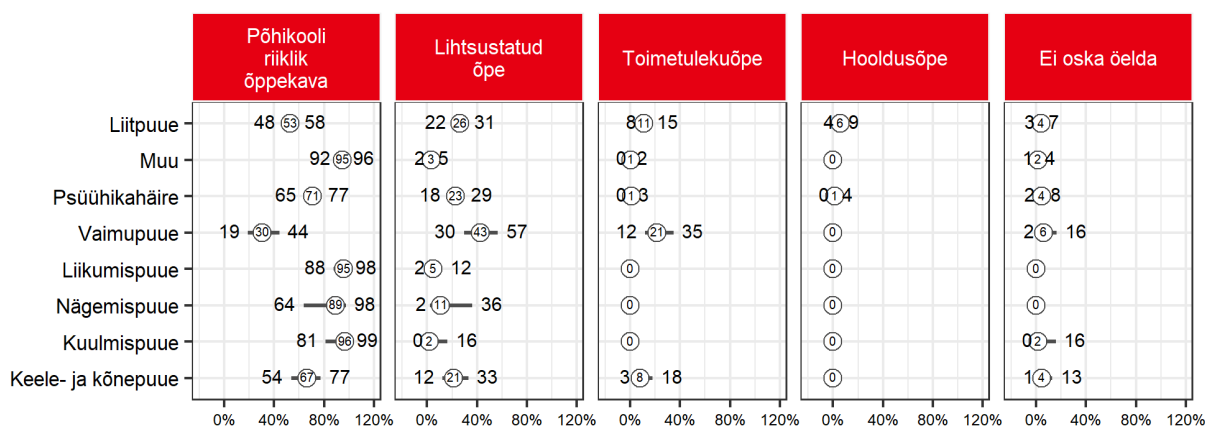
Joonis 126. Põhikoolis õppivate puudega laste jagunemine õppekava järgi 2016/2017. õppeaastal puude raskusastmete lõikes (% põhikoolis õppivatest vastava puude raskusastmega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

Põhikooli riiklikul õppekaval õppivaid on vaimupuude (19-44%), psüühikahäire (65-77%), liitpuude (48-58%) ning keele- ja kõnepuude (54-77%) korral suhteliselt vähem kui teiste puudeliikide korral – muu puue 92-96%, liikumispuue 88-98%, kuulmispuue 81-99% ja nägemispuue 64-98% (Joonis 127).

Joonis 127. Põhikoolis õppivate puudega laste jagunemine õppekava järgi 2016/2017. õppeaastal puudeliikide lõikes (% põhikoolis õppivatest vastava puude liigiga lastest)

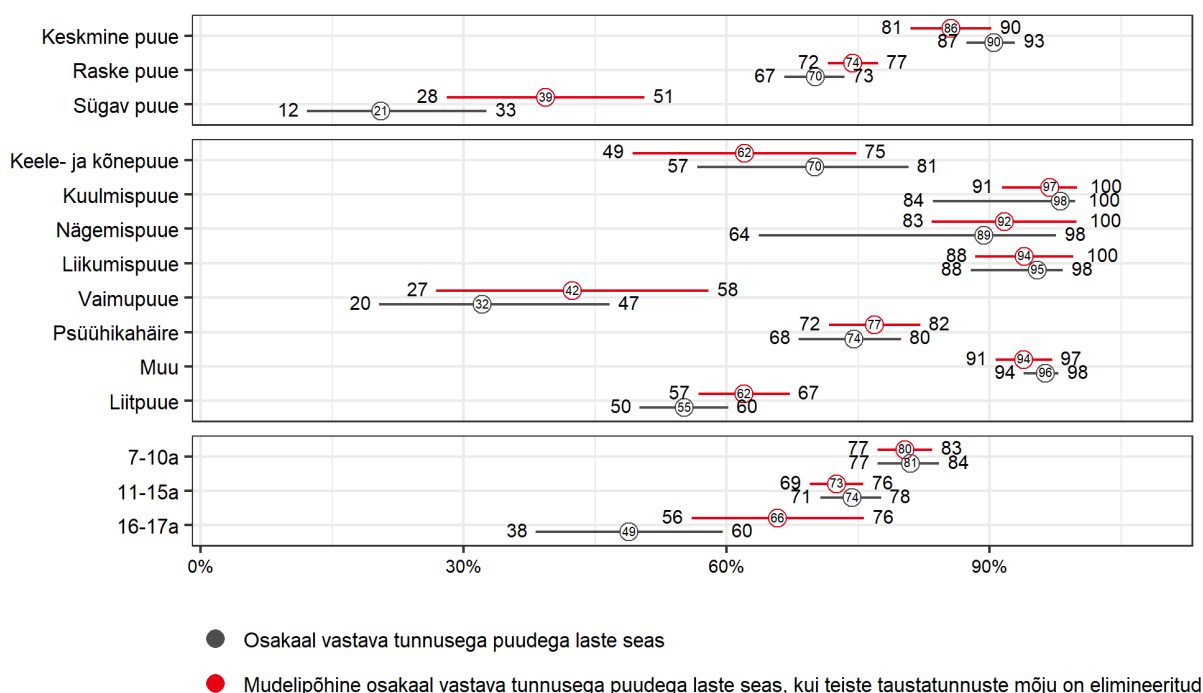


Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

Põhikoolis õppivate liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega laste seas aga ei sattunudki valimisse selliseid, kes õpiksid toimetuleku- või hooldusõppel.

Mida raskem puude raskusaste, seda väiksem on nende laste osakaal, kes õpivad põhikooliastmes riikliku õppekava järgi (keskmise puudega lastest 87-93%, raske puudega lastest 67-73% ja sügava puudega lastest 12-33%). Erinevused puude raskusastmete vahel säilivad ka juhul, kui muud taustatunnused on arvesse võetud (Joonis 128). Kuulmis-, nägemis-, liikumis- ja muu puudega lapsed õpivad suurema tõenäosusega riikliku õppekava järgi, kui võtta arvesse ka muud taustatunnused. Seega on riiklikul õppekaval õppimine samal ajal seotud nii puude liigi kui raskusastmega.

Joonis 128. Põhikooli riiklikul õppekaval õppivate laste osakaalud ja prognoositud osakaalud (% koolis õppivatest puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: õppis põhikooli riikliku õppekava järgi = 1, õppis muu õppekava järgi või ei tea, millise õppekava järgi laps õpib = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, kodune keel, lapse vanuse grupp, lapse sugu.

6.3.2 Kooliga seonduvad probleemid

6.3.2.1 Sissejuhatus

Kooliga seonduvad probleemid saab valdkonna ja leviku järgi grupeerida järgmiselt:

1. Tugimeetmete kättesaadavus on suurima levikuga probleem
2. Õppe vastavus vajadustele (õpetajate oskused ja teadmised, abiõpetaja puudumine, õppekava ja õppevahendid)
3. Sotsiaalne keskkond (õpetajate ja kaasõpilaste suhtumine)
4. Füüsiline keskkond ja ruumides liikumisega seonduv
5. Eriklassi ja koduõppe võimaluste vastavus lapse vajadustele ja pere soovidele

Sellises järjekorras käsitletakse järgnevalt iga teemaplokki põhjalikumalt.

6.3.2.2 Tugimeetmete kättesaadavus ja olemasolu haridusasutuses

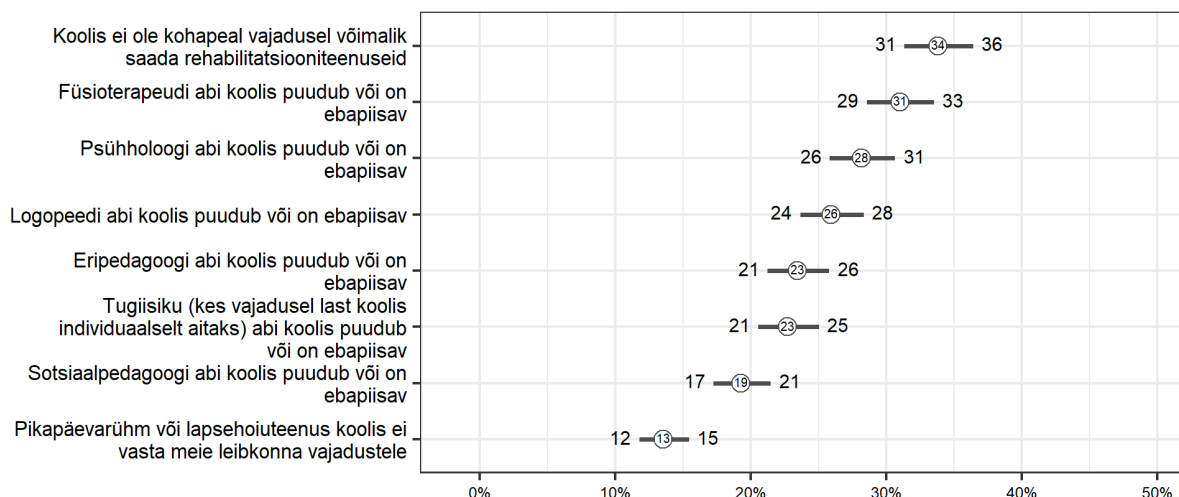
Nii lasteaias kui ka koolis on ette antud probleemide loetelust kõige levinumad probleemid seotud sotsiaal- või haridusvaldkonna tugiteenuste kättesaadavusega. Kolmandik (31-36%) koolis käivate puudega laste vanematest on viimasel õppeaastal tunnetanud probleemi, et laps ei saanud koolis kohapeal rehabilitatsiooniteenuseid või need teenused olid ebapiisavad (Joonis 129). Rehabilitatsiooniteenustena ja haridusvaldkonna tugiteenustena pakutavate füsioterapeudi, psühholoogi, logopeedi ja eripedagoogi teenuste saamisel koolis oli probleeme viiendikul kuni kolmandikul puudega lastest (vastavalt füsioterapeudiga 29-33%, psühholoogiga 26-31%, logopeediga 24-28%, eripedagoogiga 21-26%).

Psühholoogi vajadus on koolis käivatel lastel 70-75%l puudega lastest, füsioterapeudi vajadus 66-71%, logopeedi vajadus 58-63%l ja eripedagoogi vajadus 49-55%l koolis käivatest puudega lastest. Seega pooltel, kellel on neid teenuseid vaja, on probleeme sellega, et teenuseid koolis ei pakuta või need on ebapiisavad.

Tugiisiku abiga koolis on olnud probleeme viiendikul kuni veerandil (21-25%) koolis käivatest puudega lastest. Tugiisiku üldine vajadus oli 37-43%l koolis käivatest puudega lastest, seega enamikul, kellel on tugiisiku abi vaja, on ka probleeme selle saamisel koolis.

Pikapäevarühma või lapsehoiuteenusega oli probleeme 12-15%l koolis käivatest puudega lastest.

Joonis 129. Probleemid hariduse tugiteenustega (% koolis käivatest puudega lastest)

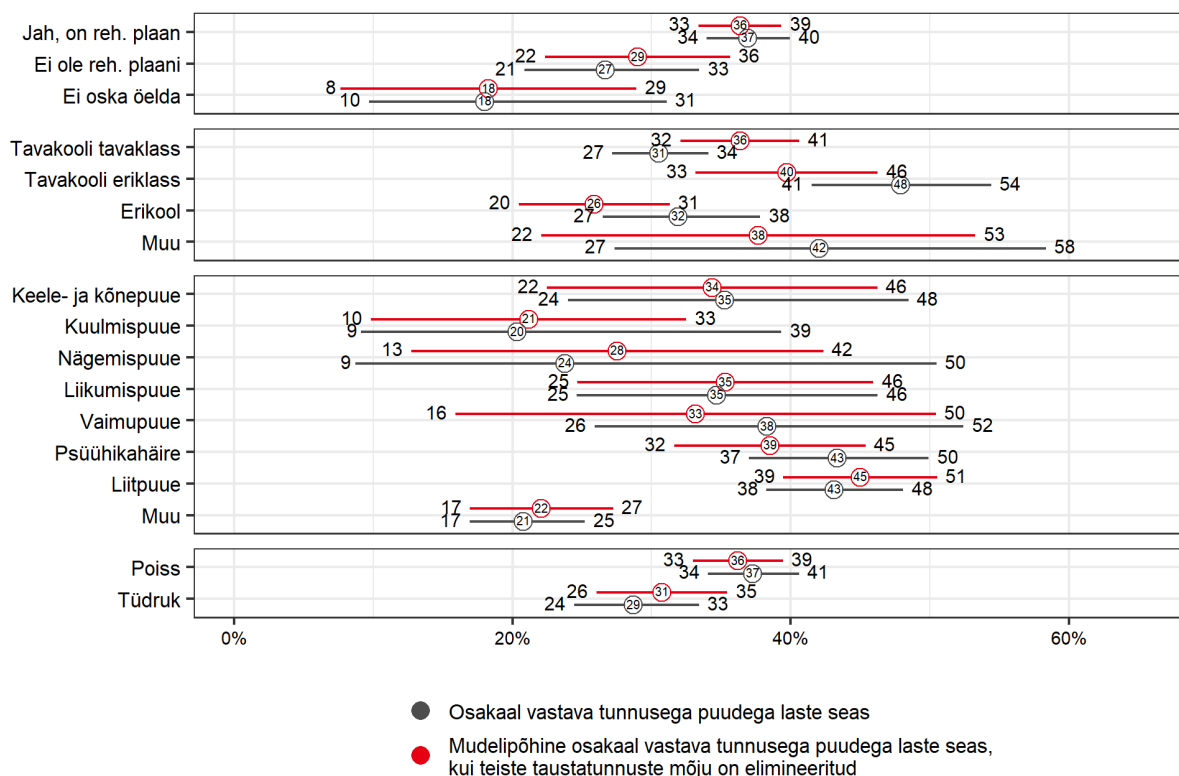


Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

Eeltoodud probleeme analüüsides ei ilmne gruppide vahel statistiliselt olulisi ja sisuliselt märkimisväärsed erinevusi, kui võtta samaaegselt arvesse puudeliik, puude raskusaste, lapse sugu, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, pere kodune keel ja kooli ning klassi liik. Üksikud erinevused ilmnevad lähtuvalt lapse puude liigist.

Erinevused ilmnevad üldistes rehabilitatsiooniteenuse saamise võimalustes (Joonis 130). Ilmneb, et neist puudega laste vanematest, kelle lapsel on rehabilitatsiooniplaan olemas, hindab suurem osakaal rehabilitatsiooniteenuste mitteraamist koolis probleemiks (34-40%, vrdl nendega, kelle lapsel pole rehabilitatsiooniplaani 21-33%). Võrrelduna tavakooli tavaklassis õppivate lastega on erikoolis õppivate laste seas veidi vähem neid, kellele on rehabilitatsiooniteenuste saamine koolis olnud probleemiks. Selline erinevus ilmneb aga vaid juhul, kui võrrelda samade taustatunnustega lapsi (tavakooli tavaklassis on tõenäosus, et rehabilitatsiooniteenuste saamine on probleemiks, 32-41%, tavakooli eriklassis 33-46% ja erikoolis 20-31%). Poiste seas on selle probleemiga lapsi rohkem (34-41%) kui tüdrukute seas (24-33%).

Joonis 130. Puudega laste osakaal, kelle vanemate hinnangul on probleemiks, et koolis ei ole võimalik saada kohapeal rehabilitatsiooniteenuseid (% koolis käivatest lastest)

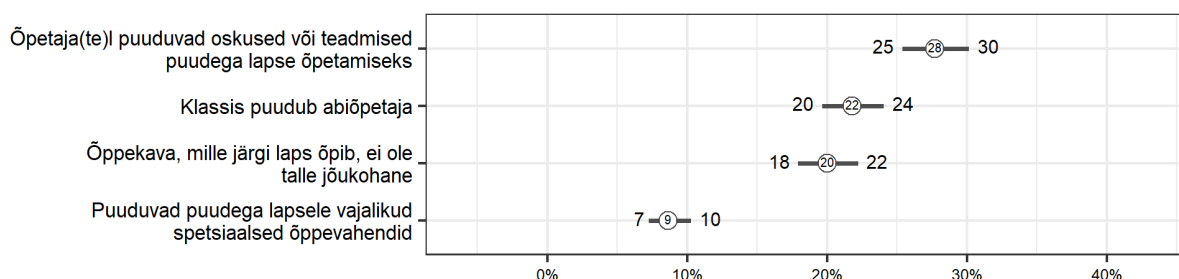


Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Valim piiratud eesti või vene keelt koduse keelena rääkivate lastega. Sõltuv muutuja: probleem esines = 1, probleemi ei esinenud, teema ei puuduta meie last, ei oska öelda = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, kodune keel, lapse sugu, lapse vanus, kooli ja klassi liik, rehabilitatsiooniplaani olemasolu.

6.3.2.3 Õppe vastavus vajadustele

Õpetajate puuduvate oskuste ja teadmiste probleemi märkis veidi enam kui neljandik puudega laste vanematest (25-30%) (Joonis 131). Viiendikule kuni veerandile (20-24%) on probleemiks, et klassis puudub abiõpetaja ja õppekava pole lapsele jõukohane (18-22%). Õppevahendite puudus on probleemiks kümnendikule või veidi vähematele (7-10%) koolis käivatele puudega lastele.

Joonis 131. Probleemid koolis õppe vastavusega õpilase vajadustele (% koolis käivatest puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

Õpetajate teadmiste ja oskuste probleem³⁹ on erikoolis harvem (11-20%) kui tavakooli eriklassis (37-50%) ja tavaklassis (22-29%). Võrreldes samade taustatunnustega lapsi, ei ole probleemi esinemise tõenäosus tavakooli eriklassi ja tavaklassi puhul erinev (vastavalt on tõenäosus probleemi olemasoluks 28-41% eriklassis ja 29-37% tavaklassis, samas kui erikoolis on tõenäosus probleemi esinemiseks 7-14%).

Abiõpetaja puudumise probleemi osas puuduvad statistiliselt olulised erinevused, kui võrrelda lihtsalt tavakooli tavaklassis õppivate puudega laste osakaalu, kelle jaoks see on probleemiks (16-22%), erikoolis õppivate puudega laste vastava osakaaluga (13-22%). Erinevused ilmnevad, kui võtta arvesse, et tavakooli tavaklassis ja erikoolis õpivad erinevad lapsed. Kui võrrelda samade taustatunnustega lapsi erikoolis ja tavakooli tavaklassis, siis on abiõpetaja puudumine suurema tõenäosusega probleemiks tavakoolis (tavaklassis 22-30%, eriklassis 19-30% ja erikoolis 9-16%).

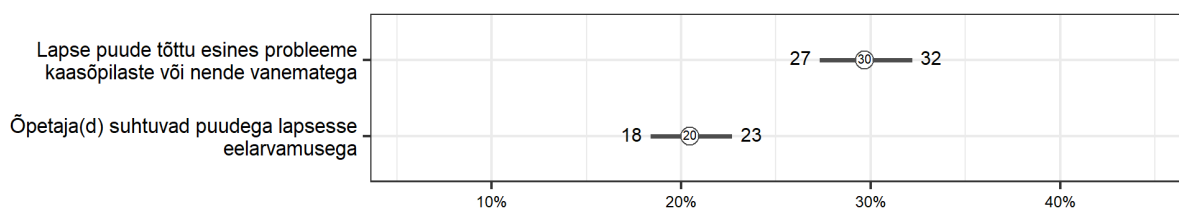
Õppekava jõukohasus on tavakooli tavaklassides (18-24%) ja eriklassides (23-35%) enam probleemiks kui erikoolis (8-16%) õppivatel õpilastel. Kui muud taustatunnused arvesse võtta, siis pole tavaklassides ja tavakooli eriklassides õppivate õpilaste vahel antud probleemi esinemissageduse osas olulisi erinevusi. Vene keelt koduse keelena rääkivate laste vanemad on õppekava jõukohasust probleemina sagedamini välja toonud (22-32% vene keelt koduse keelena kõnelevatest ja 16-21% eesti keelt koduse keelena kõnelevatest). Toimetulekuõppel (3-17%) ja hooldusõppel (1-20%) õppivatest lastest on õppekava jõukohasus probleemiks vähemal kui lihtsustatud (20-32%) ja põhikooli riiklikul õppekaval (18-23%) õppivatel lastel.

Õppevahendite puudumine on puudeliikide võrdluses sagedamini probleemiks nägemispuudega lastele (16-61%). Kõigil teistel puudeliikidel esineb õppevahendite puudumise probleemi vähem kui 19%, v.a kuulmispuudega lapsed, kelle jaoks oli see probleemiks 3-28%. Teiste puudeliikide tulemused omavahel statistiliselt oluliselt ei erine.

6.3.2.4 Sotsiaalne keskkond

Lapse puude tõttu on viimasel õppeaastal tekkinud probleeme kaasõpilaste või nende vanematega veerandil kuni kolmandikul (27-32%) koolis käivatest puudega lastest (Joonis 132). Lasteaias käivatest lastest oli seda probleemi veidi vähemal. Ka õpetaja suhtumise probleemi on koolis käivate laste vanemad toonud välja enam (18-23%) kui lasteaias käivate laste vanemad.

Joonis 132. Probleemid koolis sotsiaalse keskkonnaga (% koolis käivatest puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

Teiste õpilaste või nende vanematega on esinenud teistest puudeliikidest sagedamini probleeme psüühika-häirete (42-55%) ja liitpuudega (30-40%) lastel. Võrdluseks on keele- ja kõnepuudega lastel esinenud seda probleemi 10-30%, liikumispuudega lastest 12-30% ja muu puudega lastest 14-22%. Kuulmis-, nägemis-

³⁹ Alapeatükis toodud taustatunnuste seos probleemi esinemisega on leitud logit-mudeliga. Valim on piiratud eesti või vene keelt koduse keelena rääkivate lastega. Sõltuv muutuja: probleem esines = 1, probleemi ei esinenud, teema ei puuduta meie last, ei oska öelda = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puude liik, puude raskusaste, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, kodune keel, lapse sugu, lapse vanus, kooli ja klassi liik.

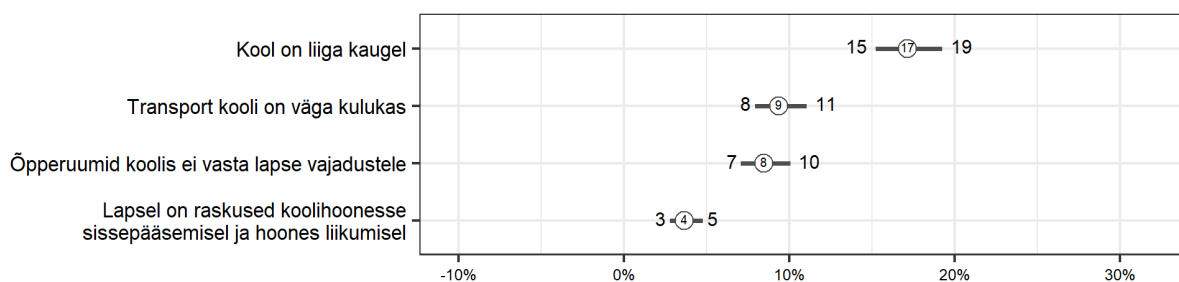
ja vaimupuudega laste seas on teiste halba suhtumist kogenud laste osakaalude hinnangud väga laiade usalduspiiridega, mistõttu nad ei eristu statistiliselt olulisel määral teiste puudeliikidega lastest.

Õpetajate negatiivse suhtumisega on teiste puudeliikidega võrreldes enam kokku puutunud psüühikahäiretega lapsed (28-40%) ja vaimupuudega lapsed (28-55%). Võrdluseks on keele- ja kõnepuudega lastest puutunud õpetajate halva suhtumisega kokku 6-23%, kuulmispuudega lastest 3-28%, liitpuudega lastest 14-22% ja muu puudega lastest 12-19%. Nägemis- ja liikumispuudega laste seas on probleemi olemasolu hinnangud väga laiade usalduspiiridega (vastavalt 4-42% ja 14-33%), mistõttu ei eristu nende rühmade tulemus teiste puudeliikidega laste tulemustest. Tavakooli tavaklassis (16-22%) on eelarvamuslikku suhtumist esinenud vähem kui tavakooli eriklassis (29-42%), aga kõige vähem on seda erikoolis (8-16%). Kui võrrelda samasuguste taustatunnustega lapsi, siis tavakooli tavaklassi ja eriklassi tulemused üksteisest ei erine.

6.3.2.5 Füüsiline kaugus ja ruumidele ligipääs

Kooli kaugus on probleemiks 15–19% puudega lastele, sellega seonduv kulukas transport aga pea poole vähematele (8-11%) (Joonis 133). Õpperuumide mittevastavus lapse vajadustele on probleemiks vähem kui kümnendikule puudega lastest (7-10%) ja ruumides liikumine 3–5%le puudega lastest. Kõik nimetatud probleemid esinevad lasteaias käivate laste puhul harvemini.

Joonis 133. Probleemid kooli kauguse ja füüsilise juurdepääsetavusega (% koolis käivatest puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

Erikoolis õppivatest lastest on kooli kaugus probleemiks enamatele kui tavakooli tavaklassis õppivatele (vastavalt erikoolis õppivatest 21-32%le ja tavakooli tavaklassis 10-15%). Eesti ja vene keelt koduse keelena kõnelevate puudega laste võrdluses puuduvad kooli kaugust probleemiks pidanute osakaaludes olulised erinevused (vastavalt 14-19% eestikeelsetel ja 16-25% venekeelsetel), kui mitte arvestada teiste taustatunnuste mõju. Kui võrrelda aga samade taustatunnustega lapsi, siis on kooli kaugus vene keelt kõnelevatel lastel probleemiks suurema tõenäosusega (19-33%) kui eesti keelt kõnelevatel lastel (12-17%).

Probleem transpordi kulukusega on sagedasem sügava puudega laste peredel (19-41%) võrrelduna keskmise (4-9%) ja raske puudega lastega peredega (7-11%). Transpordi kulukuse probleemi esineb muu puudega lastega perede seas (1-4%) harvem kui teiste puudeliikidega lastega peredel (enam kui 6%, v.a nägemispuudega lapsed, kelle kohta on hinnang väga laiade usalduspiiridega (3-38%)).

Koolihoonesse sissepääsemise ja hoones liikumise takistused on raske (3-6%) või sügava (4-19%) puudega lapsel suurema tõenäosusega kui keskmise (1-4%) puudega lapsel ning samuti liikumispuudega (11-29%) lapsel võrreldes teiste puudeliikidega (keele- ja kõnepuudega ning vaimupuudega laste seas selliseid lapsi polnud, psüühikahäirega laste seas 2-6%, liitpuudega laste seas 3-7%, muu puudega laste seas 0-2%). Kuulmis- ja nägemispuudega laste kohta on hinnangud väga laiade usalduspiiridega, vastavalt 0-17% ja 1-29%, mis ei võimalda neid eristada teistest puudeliikidest).

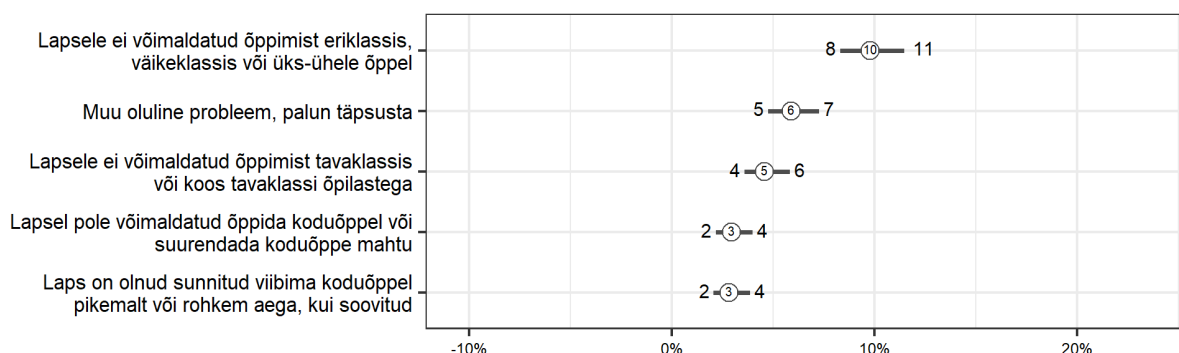
Vajadustele mitte vastavate õpperuumide probleemi esineb sagedamini sügava puudega lastel (12-31%) võrreldes keskmise puudega (3-7%) ja raske puudega (7-12%) lastega. Erikoolides ja tavakoolides õppivate

laste puhul esineb õpperuumide vajadustele vastavuse probleemi võrdselt sageli, kui jätta arvesse võtmata, et nendes koolides õpivad erinevad lapsed (vastavalt on see tavakooli tavaklassis probleemiks 5-9%, eriklassis 8-16% ja erikoolis 5-11%). Kui võrrelda aga samasuguste taustatunnustega lapsi, siis on erikoolis õppivate laste puhul tõenäosus, et õpperuumide vastavus on probleemiks, väiksem kui tavakoolis õppivate laste puhul (vastavalt erikoolis 2-6%, tavakooli eriklassis 7-14% ja tavaklassis 6-12%).

6.3.2.6 Õppevormi vastavus vajadustele ja muud probleemid

Õppevormi vastavuse probleeme on esinenud vähem kui teiste valdkondade probleeme, mida uuringus käsitleti (Joonis 134). Eriklassis õppimist (8-11% puudega lastest) või tavaklassis õppimist (4-6%) või koduõppel õppimise (2-4%) võimaldamist puudutavad probleemid esinesid nii vähestel lastel, et nende analüüsimine taustatunnuste gruppide kaupa ei võimalda teha statistiliselt ja sisuliselt olulisi järeldusi.

Joonis 134. Probleemid õppevormiga (% koolis käivatest puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

6.3.2.7 Muud probleemid

Peale etteantud loetelu võisid vastajad tuua välja ka muid probleeme, mis on seoses puudega lapse käimisega koolis viimasel õppeaastal esinenud. Suures osas näitlikustati vabades vastustes samu probleeme, mida küsiti otseselt küsitluses. Täiendavate probleemidena või veidi teise nurga alt varasemalt küsitud probleemide kohta toodi välja järgnevaid:

1. **Õppekava on liiga lihtne.** Õpilase viimisel lihtsamale õppekavale ei saa laps enam tagasi keerulisemale õppekavale, aga kui uus õppekava osutub tema jaoks liiga lihtsaks, siis on sellega probleem, mida ei saagi hästi lahendada. Samuti võib ka põhikooli riiklik õppekava olla kohati liiga lihtne.

„toimetuleku klassis õppival lapsel on üksluine õppekava ja laps tahaks suuremat koormust ja teadmisi. Kui laps suunatakse toimetuleku klassi siis tema taset keegi ei kontrolli ja laps püüdleb asjata, et saada abiklassi. ta on toimetulekus kuni lõpuni. on suhtelisel arvamus, et toimetuleku saanud laps ei arene edasi ja laps on pettunud ning stressis sellisest suhtumisest. tema tulevik on tume maa ja unistusteta.“

„Lapse edasijõudmine osades ainetes on kiirem kui teistel lastel, kuid liig rangelt hoitakse kinni RÕKist ega arvestata lapse individuaalse eripäraga, mida väikeklassi õpe võimaldaks. Lapsel on igav, mis tekitab ka motivatsiooniprobleeme ja sellest johtuvalt käitumisraskusi.“

2. **Koduõppe maht on liiga väike ja ei võimaldata tugiteenuseid**

„Koduõppe raames on vaid 8 tundi, mis jääb väheseks ning puudus võimalus alustada inglise keele õpingutega, lisaks logopeedi abi ei olnud võimalik saada.“

3. **Eriklassi või väikeklassi puudumine tavakoolis, kus laps tahaks käia. Soovimatus erivajadustega lastele vajalike kohanduste tegemiseks tavakoolis.**

„Laps võiks õppida tavakoolis ehk piikkonna koolis, mis asub kodust 300m kaugusel. Kahjuks pole see võimalik järgnevatel põhjustel: ... koolil puudub võimalus luua väike klass väike klassi õppevormiks ja ka koolil puuduvad eripedagoogid.“

„Kool soovib HEV-lastest vabaneda, nõudes, et laps pandaks erikooli. Ka meid survestati, kuid me ei tahtnud last panna erikooli, mis asub kodust väga kaugel.“

„Ilma nõustamiskomisjoni otsuseta ei taha õpetajad puudega lapsele tavaklassis individuaalselt läheneda kuigi klassis vaid 6 õpilast.“

„Esimene kool keeldus lapsele väikeklassi kohta pakkumast ja pidime minema linna teise kooli väikeklassi koha saamiseks.“

4. Klass on liiga suur, liitklass

„Depressioonis diabeetikul, kes ometi on andekas, ei ole väga lihtne leida sobivat õppekeskkonda - peaks olema rahulikum keskkond, väiksem klass...“

„Lapse klassis on põhianetes liiga palju liit-tunde, kuna kool on väike ja pearaha vähe. Eelmisel õppeaastal 4.-5. klassis oli kokku 4+7 õpilast, sest 4. klass oli väga väike. Minu lapsel on keeruline õppida klassis, kus õpetaja õpetab 2 klassi korraga ja erinevaid teemasid.“

5. Paindlikkuse puudumine

„Probleem oli meil kehalise kasvatus tunniga, kus ei tahetud aru saada, et laps ei saa kõike teistega võrdselt teha.“

„Kool ei tulnud meile vastu, ei soostunud sellega, et laps oleks õppinud kodus ja käinud koolis ainult vastamas/kontrolltööd tegemas, koolipoolseid seisukohti ja arusaamu suruti lihtsalt vägisi peale.“

6. Koolil puuduvad ressursid vajaliku õppe pakkumiseks ja lapsevanem peab ise selle kinni maksma

„Maksis ise abiõpetajale, mis pole normaalne.“

7. Lapsest tulenevad probleemid, pikaajaline haiglas viibimine ja tervisest tulenev koolist puudumine

„Pidevalt läheb välja endast kardab kooli keskkonda minna.“

„Laps on haiguse tõttu väga pikalt koolist puudunud.“

8. Pere pidi kolima mujale, et saada lapsele sobivas koolis koht

„Kolisime kogu oma leibkonnaga Tartusse, et laps saaks käia XXX Koolis. Tallinnas tema haridustee jätkamiseks pärast 2. klassi lahendust ei olnud.“

9. Koolis puudub arst/õde, kelle poole vajadusel saaks pöörduda

„Koolis puudub kooliarst/õde, kuhu pöörduda, kui tekib vajadus arsti abile.“

10. Kooli toitlustus ei vasta lapse vajadustele

„Gluteenivaba toidu kättesaadavus. Ei ole kindel kas toitlustajat saab piisavalt usaldada. Toitlustamisega tegelevate töötajate teadlikkus tsöliaakiast.“

11. Eriklass, mis on komplekteeritud omavahel mittedobivatest lastest. Raskused sobiva õppevormi leidmiseks

„Muret teeb, et ehkki võimalused õppida väikeklassis jm on olemas, ei pruugi väikeklassi erinevate diagnoosidega lapsed omavahel üldse klappida.“

„Erinevate diagnoosidega: ATH ja autismispektrihäirega lapsed on ühes klassis. Aspergeri sündroomiga lapsed ja ATH lapsed ei saa ühes klassis õppida.“

12. Muudatuste sisseviimine võtab väga kaua aega, mis võib olla puudega lapse jaoks probleem (nt üleminek koduõppele, lihtsustatud õppekavale vmt)

„Terve õppeaasta perioodil ei suudetud teha kooli poolt lapsele vastavat õppeprogrammi, et laps saaks hakkama koolis.“

„Ei suudetud võimaldada koheselt lihtsustatud õppekava ja tundeelu klassi ressursside puudulikkuse tõttu.“

„Lapse tervis halvenes just kolmandal veerandil, siis, kui koduõppele ülemineku avaldust ei olnud enam võimalik esitada, ning tavalisel viisil jätkamine käis talle üle jõu. Kool ei tulnud meile vastu, ei soostunud sellega, et laps oleks õppinud kodus ja käinud koolis ainult vastamas/kontrolltöid tegemas.“

6.3.3 Kokkuvõte

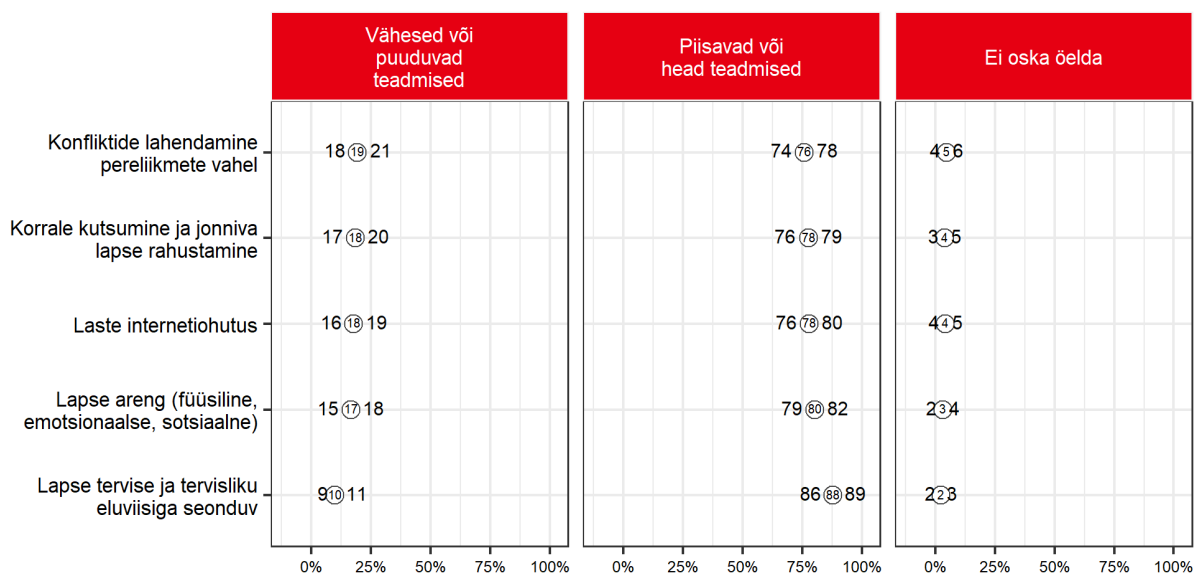
Suurem osa puudega lastest õpib tavakooli tavaklassis ning põhikooli riiklikul õppekaval. Eriklassis ja erikoolis õppimine on tõenäolisem raskema puude raskusastme korral. Sagedasemad probleemid, mis puudega lastel koolis õppimisel esinevad, seonduvad rehabilitatsiooniteenuste saamisega koolis kohapeal. Erinevate teenustega on probleeme viiendikul kuni kolmandikul õpilastest. Erikoolis õppimisel esineb enamikke probleeme harvem kui tavakoolis, sh tugimeetmete kättesaadavusega, õppe vastavusega lapse vajadustele ja sotsiaalse keskkonnaga seonduvaid probleeme. Nii nagu lasteaedade puhul, on ka erikoolides õppimisega sagedamini kaasnevaks probleemiks kooli kaugus võrreldes tavakoolidega.

7 Hoolduskoormus

7.1 Puudega lapse vanema teadmised lapse kasvatamisega seotud valdkondades

Valdaval osal puudega laste vanematest on uuringus käsitletud lapse kasvatamisega seotud valdkondades nende enda hinnangul piisavad või head teadmised (Joonis 135). Kõige enam hinnatakse oma teadmisi piisavateks või headeks lapse tervise ja tervisliku eluviisiga seonduvas valdkonnas (86-89% puudega laste vanematest), teiste valdkondade puhul on oma teadmisi headeks või piisavateks hindavate osakaal samuti kõrge, jäädes vahemikku 74-82%. Vähesteks või puuduvateks hindab oma teadmisi erinevates valdkondades viiendik või vähem (vahemikus 9-21%). Sealjuures esines vastajaid, kes hindasid oma teadmisi puuduvateks, käsitletud valdkondade lõikes märkimisväärselt vähe (paar protsenti või vähem). Tulemusi ei ole võimalik võrrelda 2009. aasta uuringuga, sest tegemist on uue küsimusega, mida eelmises uuringus ei küsitud.

Joonis 135. Milliseks Te hindate oma teadmisi järgnevates lapse kasvatamisega seotud valdkondades? (% puudega laste vanematest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Enam kui pooltel (ca 56%) küsitlusele vastanutel on nende enda hinnangul piisavad või head teadmised kõigis uuringus käsitletud valdkondades. Vaid ca 3% küsitlusele vastanutest märkis kõigi valdkondade puhul, et teadmised on vähesed või puuduvad. Väheste või puudulike teadmiste osas esineb sotsiaaldemograafiliste tunnuste lõikes varieeruvust väga vähe. Lapse arengu ning lapse tervise ja tervisliku eluviisiga seonduvas valdkonnas lapsevanema haridustaseme tõustes väheneb mõnevõrra nende osakaal, kellel on puuduvad või vähesed teadmised. Kõrgharidusega lapsevanematest 5-9%l on vähesed või puuduvad teadmised seoses lapse tervise ja tervisliku eluviisiga, põhihariduse või madalama ning keskhariduse või kutseharidusega lapsevanemate seas jääb see osakaal vahemikku 9-22%. Lapse arenguga seonduvas on vähesed või puuduvad teadmised 12-17% kõrgharidusega lapsevanematest, 15-19% kesk- või kutseharidusega lapsevanematest ning 18-29% põhihariduse või madalama haridustasemega lapsevanematest.

Keskmise puudega laste vanemate seas on mõnevõrra vähem kui raske ja sügava puudega laste vanemate seas neid, kes hindavad oma teadmisi puuduvateks või vähesteks lapse arengu ja lapse tervise ja tervisliku

eluviisiga seonduvas valdkonnas. Lapse arenguga seonduvas hindavad oma teadmisi väheks või puuduvaks 10-15% keskmise puudega laste vanematest, 17-22% raske puudega laste vanematest ning 16-31% sügava puudega laste vanematest. Lapse tervise ja tervisliku eluviisiga seonduvas hindavad oma teadmisi väheks või puuduvateks 5-8% keskmise puudega laste vanematest, 11-14% raske puudega laste vanematest ning 8-22% sügava puudega laste vanematest.

Lapse korrale kutsumise ja jonniva lapse rahustamise valdkonnas on 0-10-aastaste laste vanemate ja kodus eesti keelt kõnelevate seas mõnevõrra enam neid, kes hindavad oma teadmisi vähesteks või puuduvateks – kodus vene keelt kõnelevatest 13-19% ja eesti keelt kõnelevatest 18-22% hindavad oma teadmisi väheks või puuduvaks, 0-10-aastaste laste vanematest hindavad oma teadmisi väheks või puuduvaks 17-24%, 11-15-aastastest aga 12-18%.

Pereliikmete vaheliste konfliktide lahendamise valdkonnas on neid, kes hindavad oma teadmisi vähesteks või puudulikeks, enam kodus eesti keelt kõnelevate lapsevanemate seas (eesti keelt kõnelevatest 20-24%, vene keelt kõnelevatest 11-17%).

Laste internetiohutuse valdkonnas vähesed teadmised või teadmiste puudumine sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes oluliselt ei erine.

Puudega laste vanematel paluti kirjeldada, milliste puudega lapsega seonduvate teemade osas vajaksid nad senisest rohkem infot. Kõigist küsitlusele vastanutest 16% märkis vähemalt ühe teema, mille osas ta tunneb vajadust täiendava info järele. Märgitud teemad on varieeruvad. Välja võib tuua, et enim tunnetatakse vajadust psühholoogiaalaste teadmiste järele. Üldisemalt jagunesid teemad järgnevasse kategooriasse:

- toitumine,
- logopeedia, kõne areng
- seadused, õigused
- toetused, soodustused
- teenused
- internetiohutus, arvutisõltuvusest hoidumine
- psühholoogia, sh käitumisprobleemid, lapse rahustamine, emotsionaalne areng ja toetamine, puberteet, seksuaalkasvatus
- venekeelne info
- lapse hariduse omandamine, toimetulek koolis, huviharidus
- lapse tervis, sh ravimeetodid, ravivõimalused, lapse diagnoosi ja eripärade mõistmine
- vanemakoolitused, tugirühmad, infovahetus teiste vanematega
- abivahendid
- lapse tulevikuväljavaated
- sotsialiseerumine, lapse suhted teiste inimestega

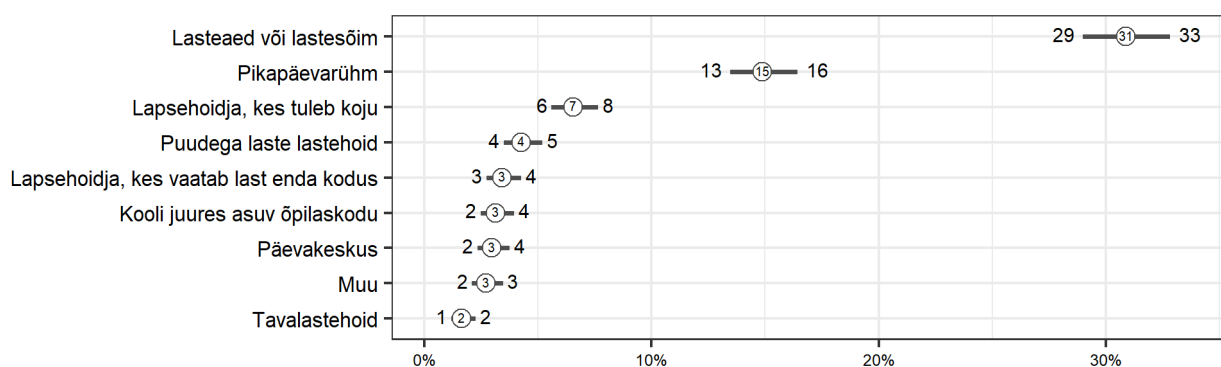
2009. aasta uuringus oli küsimus ülesehituselt erinev. Uuringus paluti vastajatel öelda etteantud loetelust, milliste teemadega seoses nad vajaksid praegusest rohkem infot. Kuna käesolevas uuringus kasutati vaba vastusega küsimust, mille puhul vastajad said ise oma infovajadust kirjeldada, ei saa tulemusi otseselt võrrelda. Samas märgiti ka 2009. aasta uuringus kõige sagedamini puudujääke psühholoogiaalastes teadmistes.

7.2 Puudega lapse lapsehoiuvõimalused

Puudega laste vanematel paluti etteantud loetelust märkida, milliseid konkreetseid lapsehoidmise võimalusi nad on viimase 12 kuu jooksul puudega lapse jaoks kasutanud. Enam kui pooled puudega laste

vanematest (53-57%) on puudega lapse hoidmiseks kasutanud vähemalt ühte lapsehoidmise võimalust. Puudega laste vanemad, kes olid lapse jaoks viimase 12 kuu jooksul kasutanud mõnda lapsehoidmise võimalust, olid valdavalt kasutanud vaid ühte võimalust. Kahte või enamat lapsehoidmise võimalust oli kasutanud 11-14% puudega laste vanematest. Kõige enam on kasutatud lasteaeda või lastesõime ning pikapäevarühma (Joonis 136). Lisaks etteantud loetelule oli lastevanematel võimalik märkida ka mõnda muud lapsehoidmise võimalust, mida nad on viimase 12 kuu jooksul puudega lapse jaoks kasutanud. Sealhulgas toodi välja: erinevad lastelaagrid, tugisik, noortekeskus, huviringid, laste mängumaa. Lapsehoiu võimaluste kasutamist ei saa võrrelda 2009. aasta uuringu tulemustega, kuna eelmises uuringus erinevate lapsehoidmise võimaluste kasutamist ei käsitletud

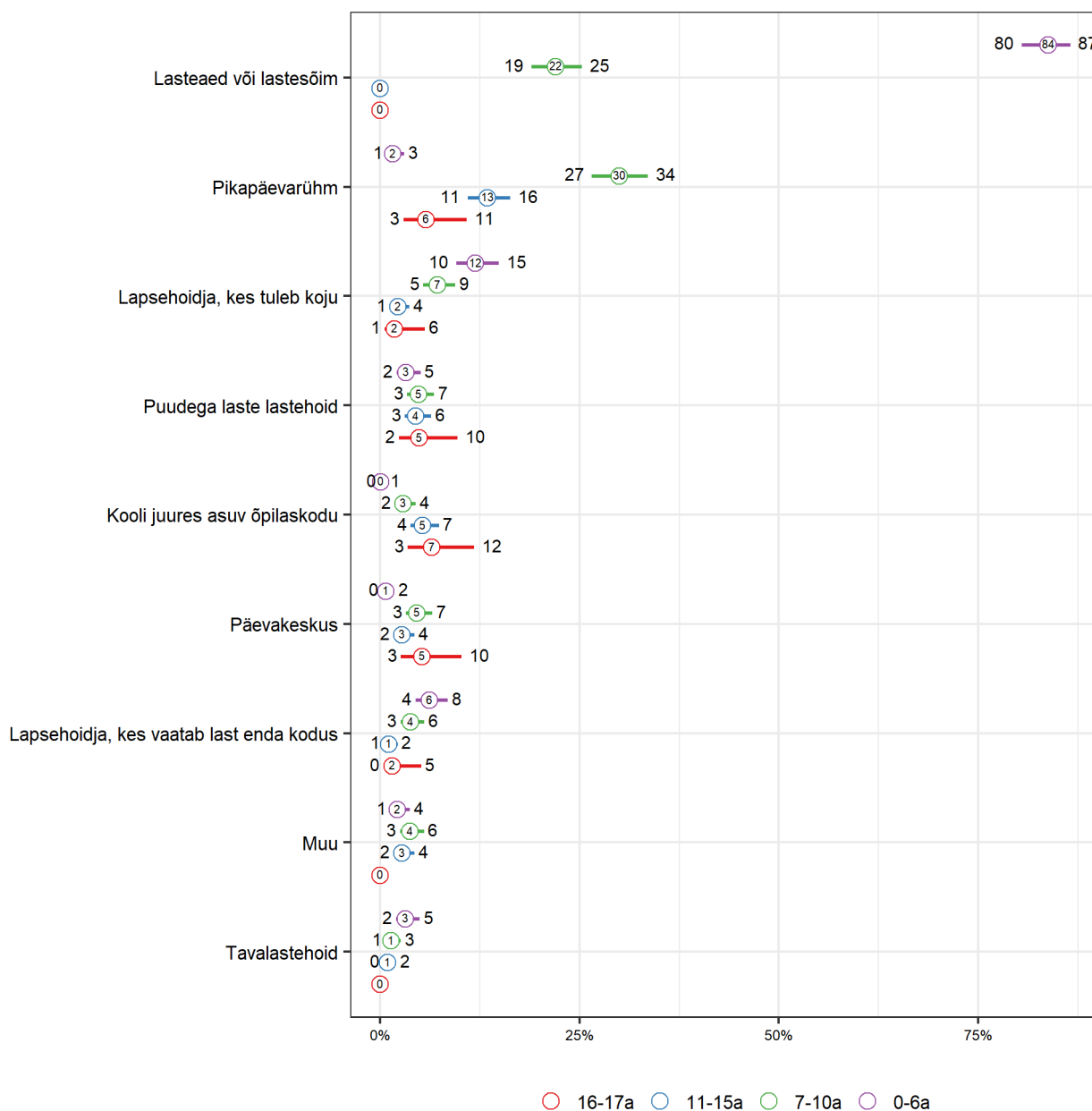
Joonis 136. Puudega lapse jaoks viimase 12 kuu jooksul kasutatud lapsehoidmise võimalused (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Lasteaia või sõime ning pikapäevarühma võimaluse kasutamine viimase 12 kuu jooksul on tugevalt seotud lapse vanusega (Joonis 137). Ootuspäraselt on valdav osa (80–87%) 0–6-aastaste puudega laste vanematest viimase 12 kuu jooksul kasutanud lapse hoidmiseks lasteaia või lastesõime võimalust. Kuna lasteaias käib ka 7-aastaseid lapsi, siis esineb lasteaia võimaluse kasutamist ka 7–10-aastaste vanusegruppis (19-25%). Pikapäevarühma võimalust on kasutatud selgelt enam 7–10-aastaste puudega laste hoidmiseks (27-34%), lapse vanuse kasvades pikapäevarühma kasutamine väheneb. Kuigi küsitlusele vastanute seas esineb ka neid puudega laste vanemaid, kes märkisid, et on 0–6-aastase lapse hoidmiseks kasutanud pikapäevarühma võimalust, mõistsid need lapsevanemad pikapäevarühmana ilmselt midagi muud kui koolides pakutavat tugiteenust. Lapsehoidja (nii see, kes tuleb koju, kui ka see, kes hoiab last enda kodus) võimaluse kasutamine lapse vanuse kasvades väheneb, kuid 16–17-aastaste puhul ei ole lapsehoidja võimaluse kasutamine statistiliselt oluliselt eristatav teistest vanusegruppidest. Kooli juures asuva õpilaskodu ning puudega laste lastehoiu kasutamine vanuse lõikes statistiliselt oluliselt ei erine. Päevakeskuse kasutamise puhul eristuvad 0–6-aastased lapsed, kelle hoidmiseks on päevakeskust kasutatud mõnevõrra vähem, kuid erinevus on siiski väike: 0–6-aastaste laste vanematest on kasutanud kuni 1%, 7-17-aastaste laste vanemate seas jääb päevakeskuse võimalust kasutanute osakaal vahemikku 2-10%.

Joonis 137. Viimase 12 kuu jooksul puudega lapse jaoks kasutatud lapsehoidmise võimalused vanusegruppide lõikes (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

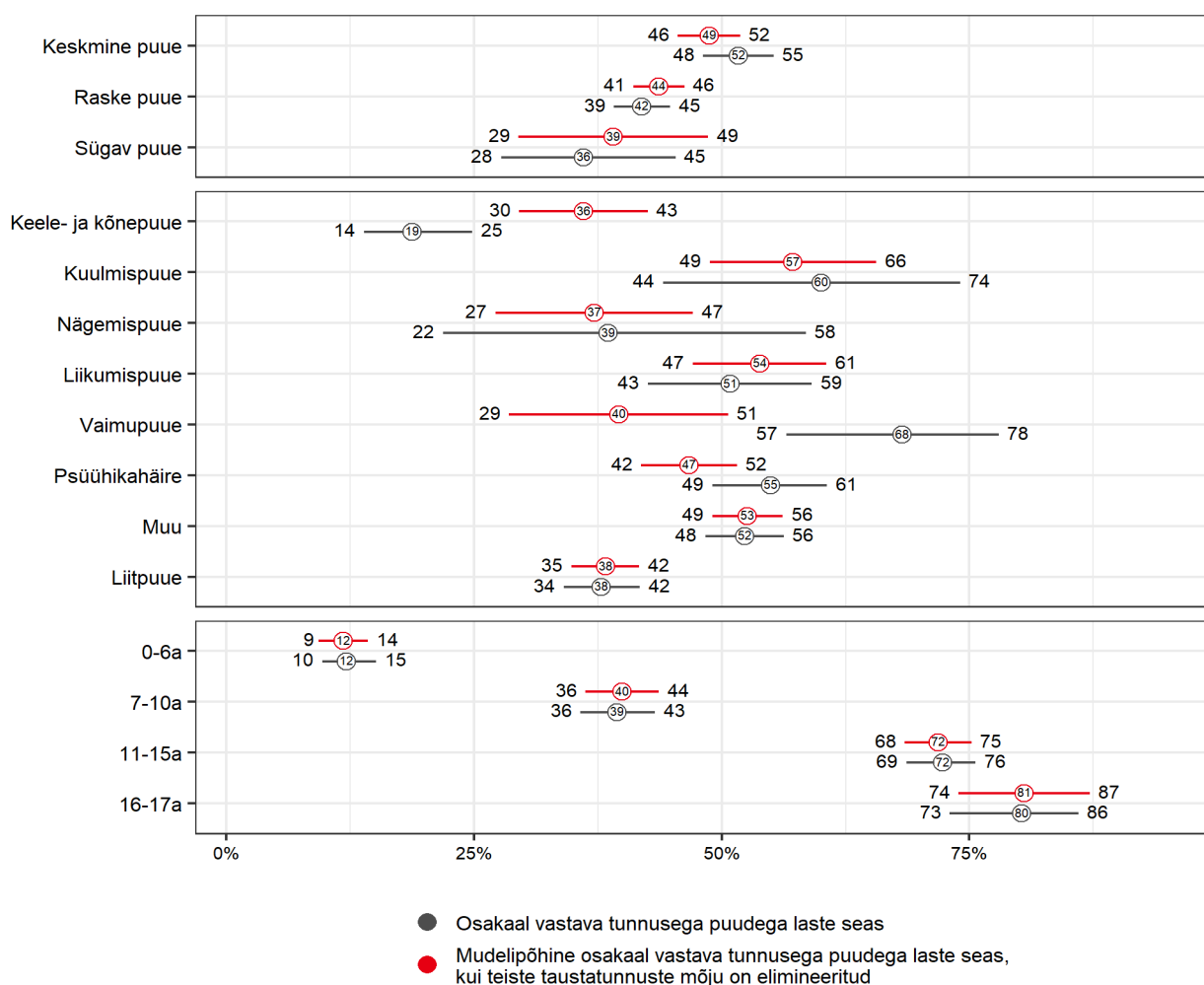
Kõigist puudega laste vanematest ligi pooled (43-47%) ei olnud viimase 12 kuu jooksul **puudega lapse jaoks kasutanud mitte ühtegi lapsehoidmise võimalust**. Lapsed, kelle jaoks ei olnud kasutatud ühtegi laste hoidmise võimalust, erinevad vanuse, puude liigi, puude raskusastme ning vastaja sotsiaalse seisundi lõikes (Joonis 138).

Lapsehoidmise võimaluste mittekasutamine varieerub lapse vanuse lõikes märkimisväärselt – kui valdava osa (73-86%) 16–17-aastaste laste jaoks lapsehoidmise võimalusi ei kasutatud, siis 0–6-aastaste seas on see osakaal vaid 10–15%.

Neid, kes ei olnud puudega lapse jaoks ühtegi lapsehoidmise võimalust viimase 12 kuu jooksul kasutanud, on keskmise puudega laste vanemate seas 48-55% ning mõnevõrra vähem raske puudega (39-45%) ja sügava puudega (28-45%) laste vanemate seas.

Lapse puude liigi lõikes on kõige vähem neid, kelle jaoks pole lapsehoidmise võimalusi kasutatud, keele- ja kõnepuudega laste seas (14-25% keele- ja kõnepuudega lastest), küll aga elimineerides teiste taustatunnuste mõju, ilmneb, et keele- ja kõnepuudega laste seas on see prognoositud osakaal suurem ning ei erine statistiliselt oluliselt nägemispuudega, vaimupuudega ning liitpuudega lastest. Selle põhjuseks on ilmselt nooremate laste suurem osakaal keele- ja kõnepuudega laste seas. Vaimupuudega laste seas on teiste puudeliikidega võrreldes mõnevõrra enam neid, kelle jaoks ei kasutatud viimase 12 kuu jooksul ühtegi lapsehoidmise võimalust (57-78% vaimupuudega lastest), kuid teiste taustatunnuste mõju elimineerides on see osakaal väiksem ning ei erine statistiliselt oluliselt teiste puudeliikidega lastest.

Joonis 138. Lapsevanem ei ole viimase 12 kuu jooksul puudega lapse hoidmiseks kasutanud mitte ühtegi lapsehoidmise võimalust (% puudega lastest)



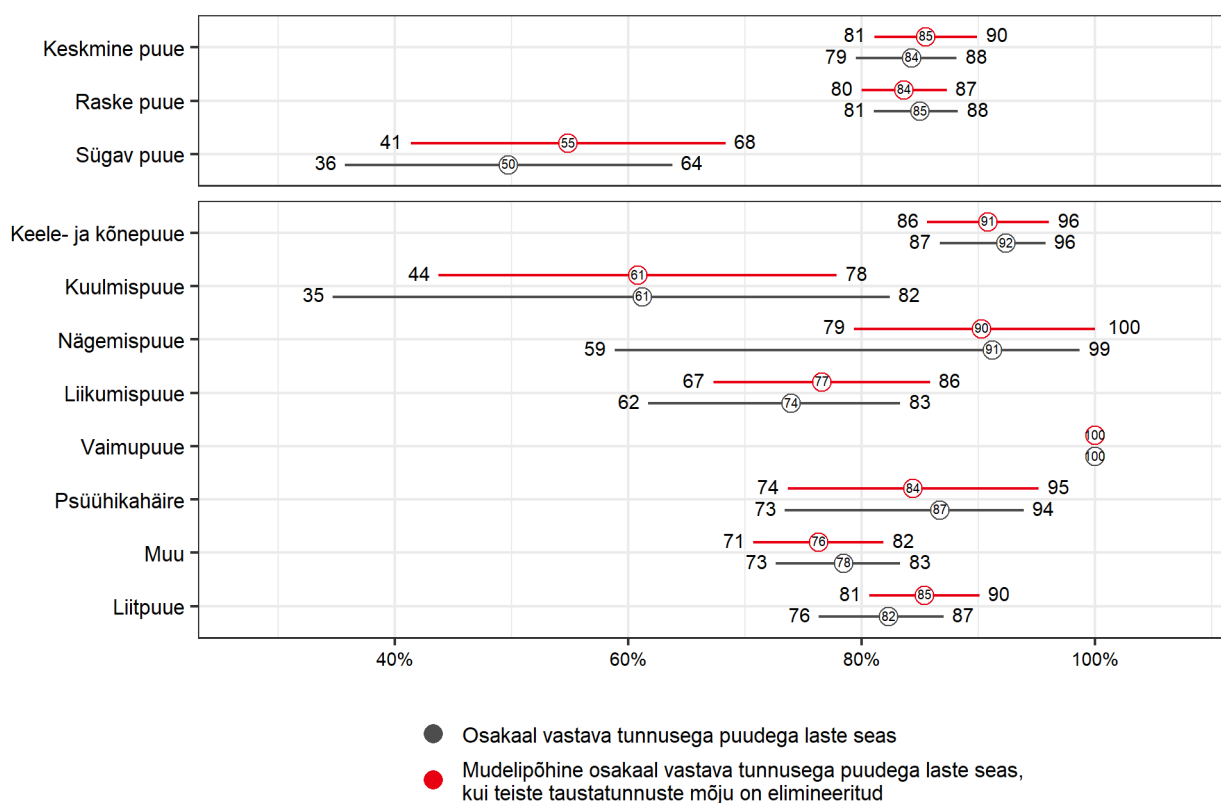
Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: ei ole viimase 12 kuu jooksul puudega lapse hoidmiseks kasutanud ühtegi lapsehoidmise võimalust=1, on viimase 12 kuu jooksul puudega lapse hoidmiseks kasutanud mõnda lapsehoidmise võimalust= 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: puudeliik, puude raskusaste, kodune keel, lapse vanus, lapsevanema peamine sotsiaalne seisund, täiskasvanute arv, laste arv.

Puudega lapse hoidmist **lasteaia** või **lastesõime** vaatame erinevate taustategurite lõikes vaid lasteaia-ealiste (0–7-aastaste) puudega laste seas (Joonis 139).

Sügava puudega laste jaoks on oluliselt vähem kui keskmise ja raske puudega laste jaoks kasutatud hoiuvõimalusena lasteaeda või lastesõime. Lasteaia või -sõime võimalust on kasutatud 36-64% sügava puudega lasteaiaealiste lastehoidmiseks, 81-88% raske puudega lasteaiaealiste laste ning 79-88% keskmise puudega lasteaiaealiste laste hoidmiseks.

Keele- ja kõnepuudega lasteaiaealiste laste hoidmiseks (87-96%) on kasutatud lasteaeda või -sõime enam kui kuulmispuudega (35-82%), liikumispuudega (62-83%), muu puudega (73-83%) ja liitpuudega (76-87%) lasteaiaealiste laste hoidmiseks. Kõigi uuringus osalenud lasteaiaealiste vaimupuudega laste hoidmiseks on kasutatud lasteaeda või -sõime.

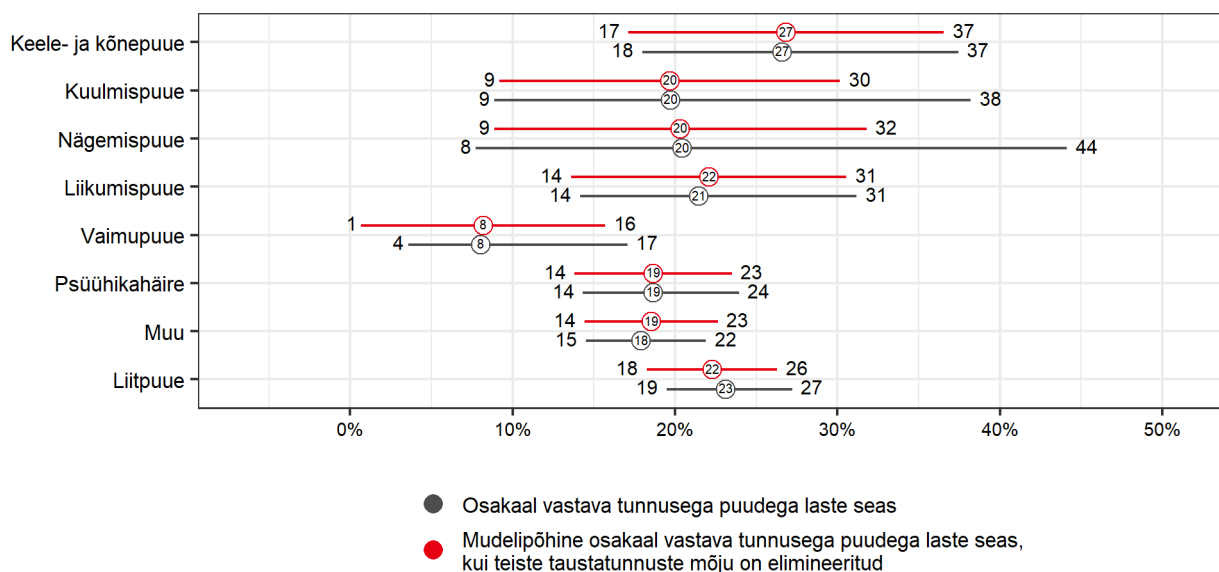
Joonis 139. Lapsevanem on viimase 12 kuu jooksul puudega lapse hoidmiseks kasutanud lasteaia või lastesõime võimalust (% 0–7-aastastest puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega ja üle 7-aastased lapsed. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul puudega lapse hoidmiseks kasutanud lasteaeda või lastesõime=1, ei ole viimase 12 kuu jooksul puudega lapse hoidmiseks kasutanud lasteaeda või lastesõime= 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: puudeliik, puude raskusaste, kodune keel, lapse vanus, lapsevanema peamine sotsiaalne seisund, täiskasvanute arv, laste arv.

Pikapäevarühma kasutamist vaatame vaid kooliealiste (7–17-aastaste) puudega laste seas (Joonis 140). Pikapäevarühma võimaluse kasutamine kooliealiste laste seas erineb statistiliselt oluliselt vaid lapse puude liigi lõikes. Vaimupuudega laste hoidmiseks on pikapäevarühma võimalust kasutatud vähem kui keele- ja kõnepuudega, liitpuudega ja liikumispuudega laste hoidmiseks.

Joonis 140. Lapsevanem on viimase 12 kuu jooksul puudega lapse hoidmiseks kasutanud pikapäevarühma võimalust (% 7-17-aastastest puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega ja alla 7-aastased lapsed. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul puudega lapse hoidmiseks kasutanud pikapäevarühma=1, ei ole viimase 12 kuu jooksul puudega lapse hoidmiseks kasutanud pikapäevarühma= 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: puudeliik, puude raskusaste, kodune keel, lapse vanus, lapsevanema peamine sotsiaalne seisund, täiskasvanute arv, laste arv.

7.3 Puudega lapse hoidmise võimaluste täiendav või senisest suurem vajadus

Järgnevalt paluti puudega laste vanematel märkida, milliseid loetletud lapsehoidmise võimalusi oleks puudega lapse jaoks täiendavalt vaja või mida oleks vaja kasutada senisest rohkem. Üle kolmandiku (35-42%) lastevanematest vajab vähemalt ühte loetletud lapsehoidmise võimalust senisest rohkem või täiendavalt. Puudega laste vanematest 12-15% ei oska aga hinnata, milliseid lapsehoidmise võimalusi neil oleks vaja täiendavalt või senisest rohkem.

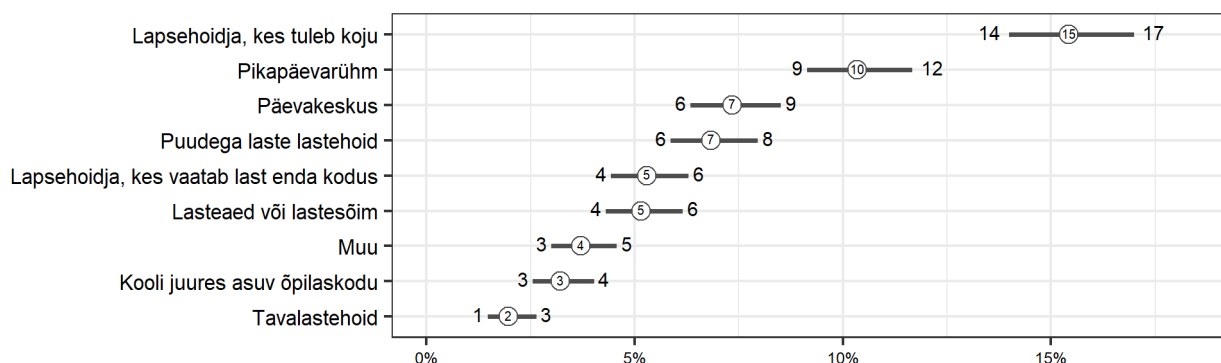
Kõige enam (14-17%) vajatakse puudega lapse hoidmiseks täiendavalt või senisest rohkem võimalust kasutada lapsehoidjat, kes tuleb koju (Joonis 141).

Ligi kümnendiku (9-12%) puudega laste hoidmiseks vajatakse täiendavalt või senisest rohkem võimalust kasutada pikapäevarühma.

Lisaks etteantud loetelule said lapsevanemad märkida ka muid lapsehoidmise võimalusi, mida neil oleks puudega lapse hoidmiseks täiendavalt või senisest rohkem vaja, sealhulgas toodi välja: laagrid, eraõpetaja, tugiisik, lapsehoidja, huviringid/trennid.

Lapsehoidmise võimaluste täiendavat vajadust 2009. aastal läbiviidud uuringus ei käsitletud.

Joonis 141. Lapsehoidmise võimalused, mida vajatakse puudega lapse hoidmiseks täiendavalt või senisest rohkem (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Sarnaselt viimase 12 kuu jooksu lapsehoidmise võimaluste kasutamisega erineb lapsehoidmise võimaluste täiendav või senisest suurem vajadus samuti lapse vanuse lõikes (Joonis 142). Puudega lapse hoidmiseks senisest rohkem või täiendavalt vajab lasteaeda või lastesõime 0–6-aastaste laste vanematest 14–20% ning 7–10-aastaste laste vanematest 1–2%, sest ka 7-aastased lapsed võivad veel käia lasteaia. Vanemate vanuserühmade puhul lasteaia täiendavat vajadust mõistetavalt ei esine.

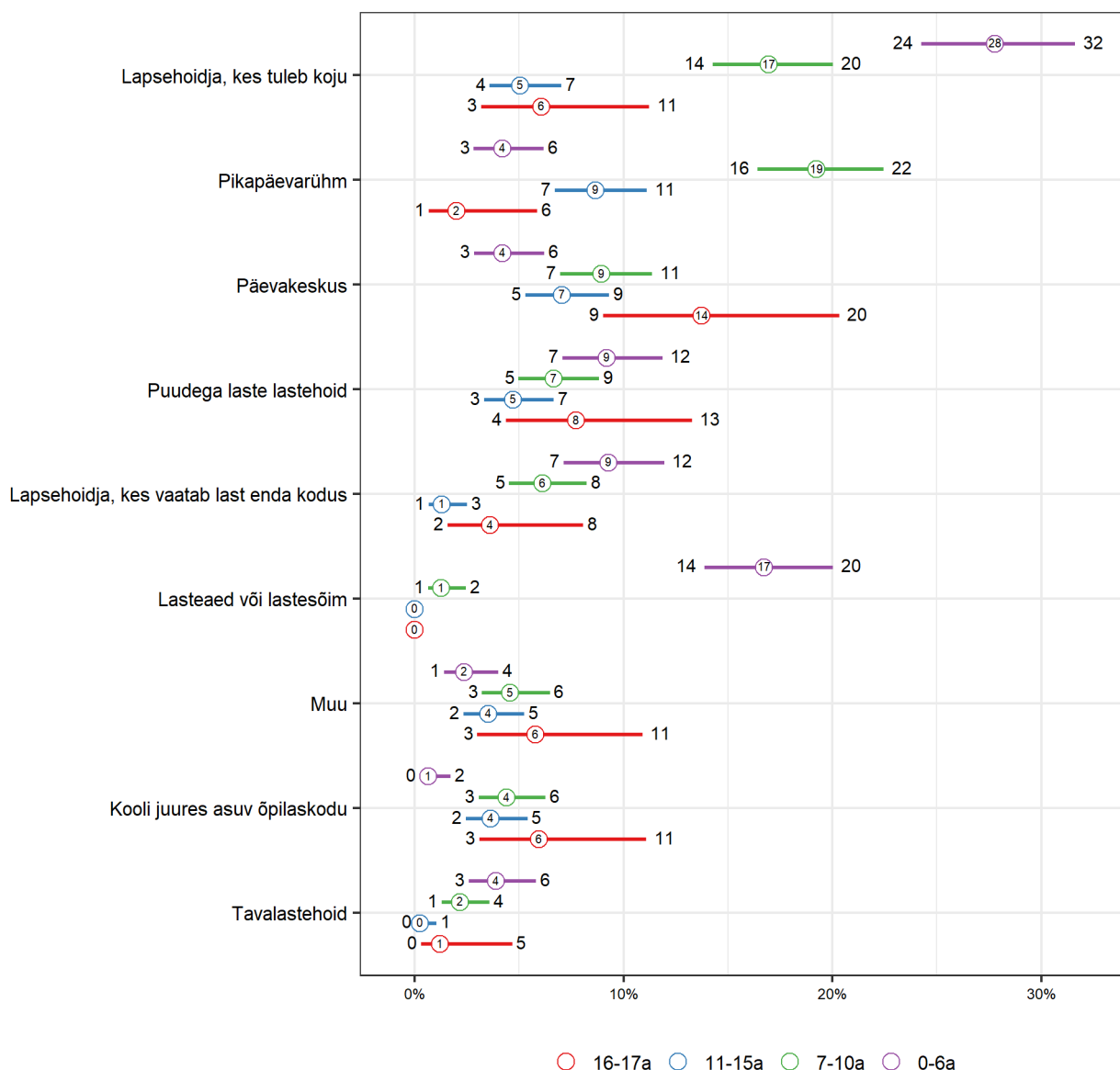
Pikapäevarühma täiendav või senisest suurem kasutamise vajadus on 16–22% 7–10-aastaste laste vanematel, vanemate laste seas esineb vähem pikapäevarühma täiendavat või senisest suurema kasutamise vajadust. Pikapäevarühma ja kooli juures asuva õpilaskodu vajadust on toonud välja ka 0–6-aastaste laste vanemad, kuid siinkohal võisid vastajad mõelda vajadust tuleviku perspektiivis, kui laps läheb kooli, või mõisteti pikapäevarühma all midagi muud, kui koolis pakutavat tugiteenust.

Keskmisest enam vajatakse täiendavalt või senisest rohkem lapsehoidjat, kes tuleb koju, 0–6-aastaste laste hoidmiseks – 24–32%. Lapse vanuse kasvades vajadus lapsehoidja (kes tuleb koju) järele väheneb. Samuti väheneb lapse vanuse kasvades vajadus lapsehoidja järele, kes vaatab last enda kodus. Kui 7–12% 0–6-aastaste laste hoidmiseks vajatakse täiendavalt või senisest rohkem lapsehoidjat (kes vaatab last enda kodus), siis 11–15-aastaste laste seas on see osakaal vaid 1–3%, vanima vanusegrupi puhul statistiliselt olulist erisust ei esine.

Päevakeskuse senisest suuremat või täiendavat vajadust esineb 16–17-aastaste laste vanemate seas (9–20%) enam kui 0–6-aastaste laste vanemate seas (3–6%).

Puudega laste lastehoiu ning tavalastehoiu senisest suurema või täiendava vajaduse osas eristuvad vaid noorim ja 11–15-aastaste vanuserühm: 0–6-aastaste laste vanemate seas on puudega laste lastehoidu vajavaid 7–12% ning 11–15-aastaste laste vanemate seas 3–7%.

Joonis 142. Puudega lapse hoidmiseks senisest enam või täiendavalt vajavad lapsehoidmise võimalused puudega laste vanusegruppide lõikes (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

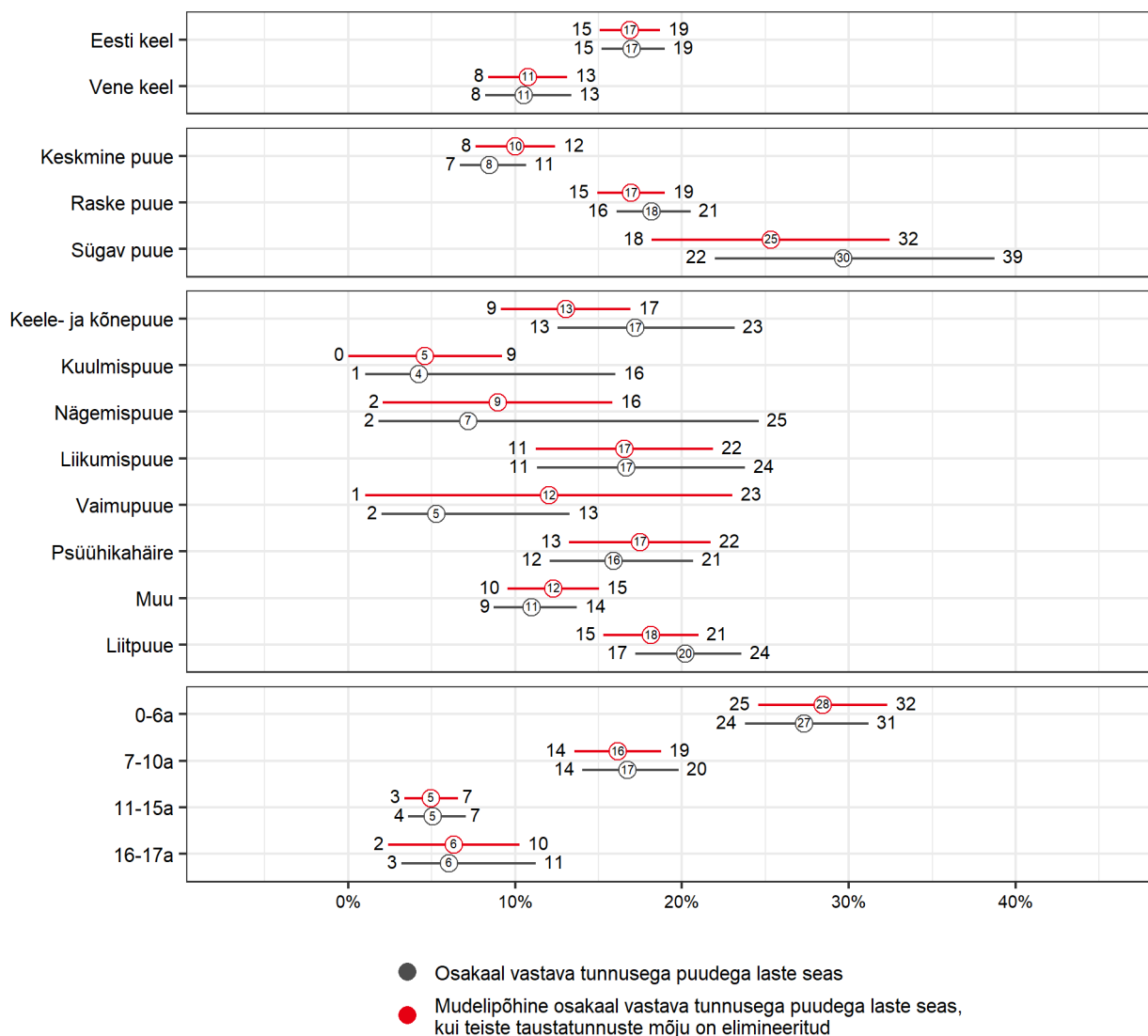
Lapsehoidjat (kes tuleb koju) puudega lapsele rohkem või täiendavalt vajavate osakaal on kodus eesti keelt kõnelevate seas suurem kui vene koduse keelega vastajate seas – eesti keelt kõnelevatest 15-19% ja vene keelt kõnelevatest 8-13% (Joonis 143).

Lapsehoidjat senisest enam või täiendavalt vajavate puudega laste vanemate osakaal suureneb lapse puude raskusastme kasvades. Kui keskmise puudega laste vanematest vajab senisest enam või täiendavalt võimalust kasutada lapsehoidjat (kes tuleb koju) 7-11%, siis sügava puudega laste vanemate seas on see osakaal 22-39%.

Lapse vanuse kasvades lapsehoidja vajadus väheneb, kuid 16–17-aastaste laste puhul statistiliselt olulist erinevust 11-15-aastastest ei esine. Noorimate, 0-6-aastaste laste seas on 24-31% neid, kelle jaoks vajatakse lapsehoidjat senisest enam või täiendavalt, 11-15-aastaste seas on see osakaal 4-7%.

Puudeliigiti erineb lapsehoidja (kes tuleb koju) täiendav või senisest suurem vajadus vähe – liitpuudega laste seas on vajadus mõnevõrra suurem (17-24%) kui muu puudega laste seas (9-14%).

Joonis 143. Lapsehoidja (kes tuleb koju) täiendav või senisest suurem vajadus (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega lapsed. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajaks senisest rohkem või täiendavalt puudega lapse jaoks lapsehoidjat, kes tuleb koju=1, ei vaja täiendavalt ega senisest rohkem puudega lapse jaoks hoidjat, kes tuleb koju või ei oska vajadust hinnata= 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapse puudeliik, puude raskusaste, vanus, kodune keel, lapsevanema peamine sotsiaalne seisund, täiskasvanute arv, laste arv.

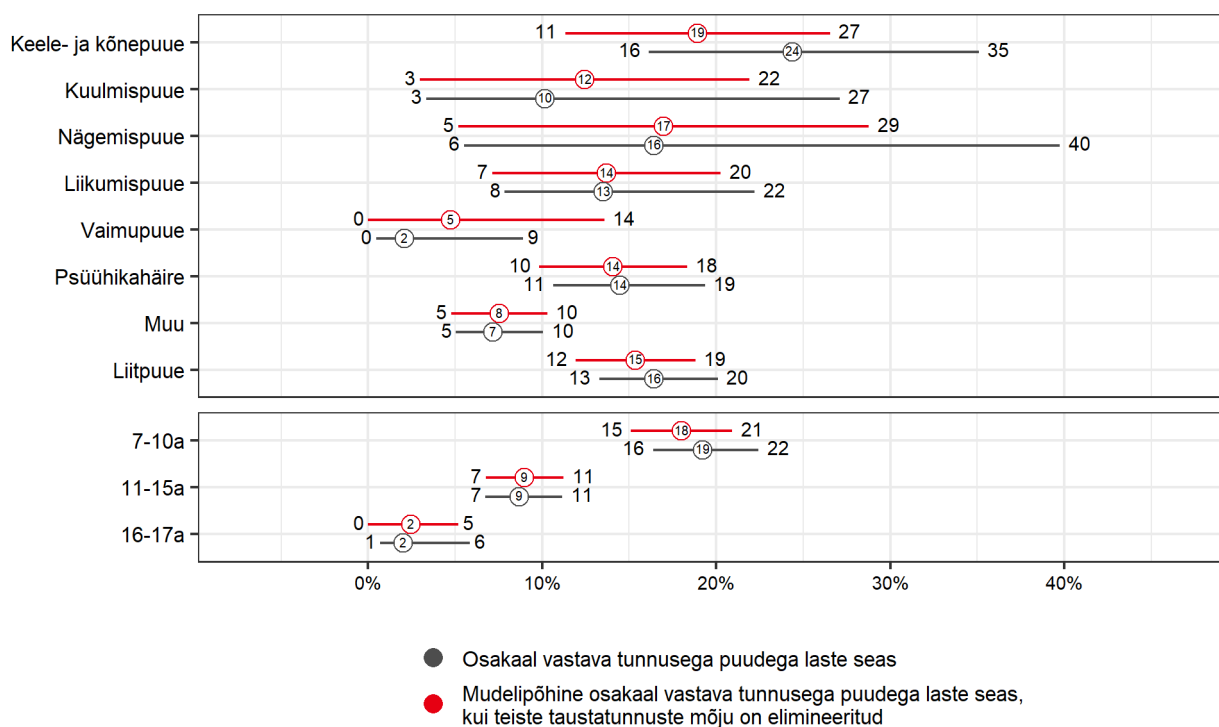
Pikapäevarühma senisest suuremat või täiendavat vajadust vaatame vaid kooliealiste (7–17-aastaste) puudega laste seas.

Täiendavalt või senisest rohkem vajatakse pikapäevarühma võimalust 7–17-aastaste muu puudega laste hoidmiseks vähem (5-10%) kui psüühikahäirega (11-19%), keele- ja kõnepuudega (16-35%) ning liitpuudega (13-20%) laste hoidmiseks (Joonis 144).

Puudega lapse vanuse lõikes ilmneb, et senisest enam või täiendavalt pikapäevarühma vajavate osakaal on väiksem vanemates vanuserühmades. 16-17-aastaste laste vanematest vajavad lapsele pikapäevarühma

võimalust senisest rohkem või täiendavalt 1-6%, samas 7-10-aastaste laste vanematest ligi neljandik (16-22%).

Joonis 144. Pikapäevarühma senisest suurem või täiendav vajadus (% 7–17-aastastest lastest)



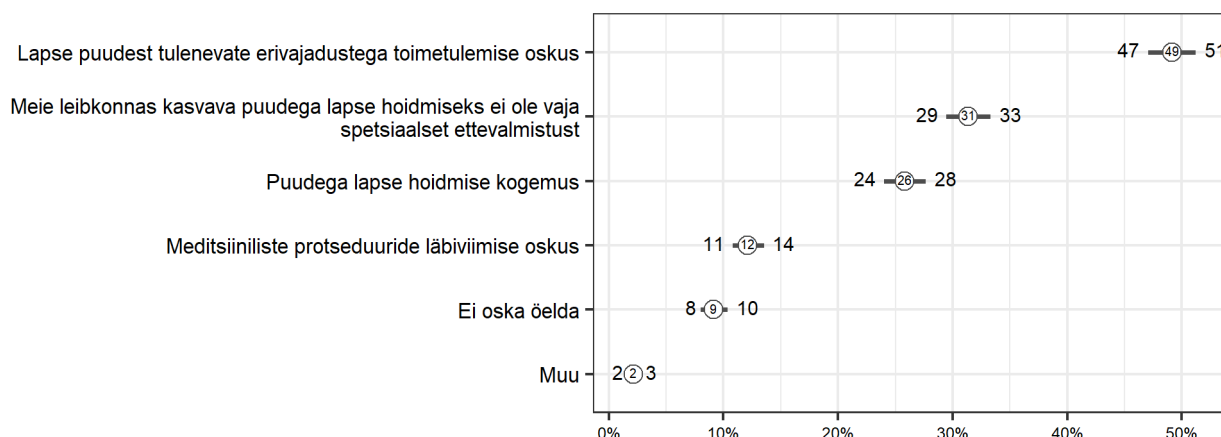
Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega ja alla 7-aastased lapsed. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: vajaks senisest enam või täiendavalt puudega lapse jaoks pikapäevarühma=1, ei vaja täiendavalt ega senisest rohkem puudega lapse jaoks pikapäevarühma või ei oska vajadust hinnata = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapse puudeliik, puude raskusaste, lapse vanus, kodune keel, lapsevanema peamine sotsiaalne seisund, täiskasvanute arv, laste arv.

7.4 Puudega lapse eest hoolitseva isiku spetsiaalne ettevalmistus

Pea kolmandik (29-33%) puudega laste vanematest tõi välja, et nende leibkonnas kasvava puudega lapse hoidmiseks ei ole vaja spetsiaalset ettevalmistust, 8-10% ei osanud hinnata spetsiaalse ettevalmistuse vajadust (Joonis 145). Ligi poolte (47-51%) puudega laste vanemate hinnangul peaks nende leibkonnas kasvava puudega lapse eest hoolitseval isikul või hoidjal olema lapse puudest tulenevate erivajadustega toimetulemise oskus. Ligi viiendik (24-28%) on toonud välja, et vajalik on puudega lapse hoidmise kogemus. 2009. aastal läbiviidud uuringus küsiti küll sarnast küsimust, kuid etteantud vastusevariantide loetelu oli erinev ning seetõttu pole tulemused võrreldavad.

Lisaks etteantud loetelule oli käesolevas uuringus võimalik märkida mõni muu spetsiaalne ettevalmistus, mis lapsevanema hinnangul leibkonnas kasvava puudega lapse eest hoolitseval isikul või hoidjal peaks olema. Mõne muu spetsiaalse ettevalmistuse märkis vaid 2-3% puudega laste vanematest. Sealhulgas toodi välja konkreetseid hariduslike ja teadmiste alaseid nõudeid nagu viipekeeelne oskus, psühholoogiaalane haridus või teadmised, eripedagoogi haridus, logopeedi haridus, toitumisalased teadmised, füsioteraapiaalased teadmised. Samuti toodi välja erinevaid iseloomujooni, mis peaksid isikul olema: tolerantsus, empaatilisus, kannatlikkus, järjekindlus, julgus, südamlikkus, hea suhtlemisoskus.

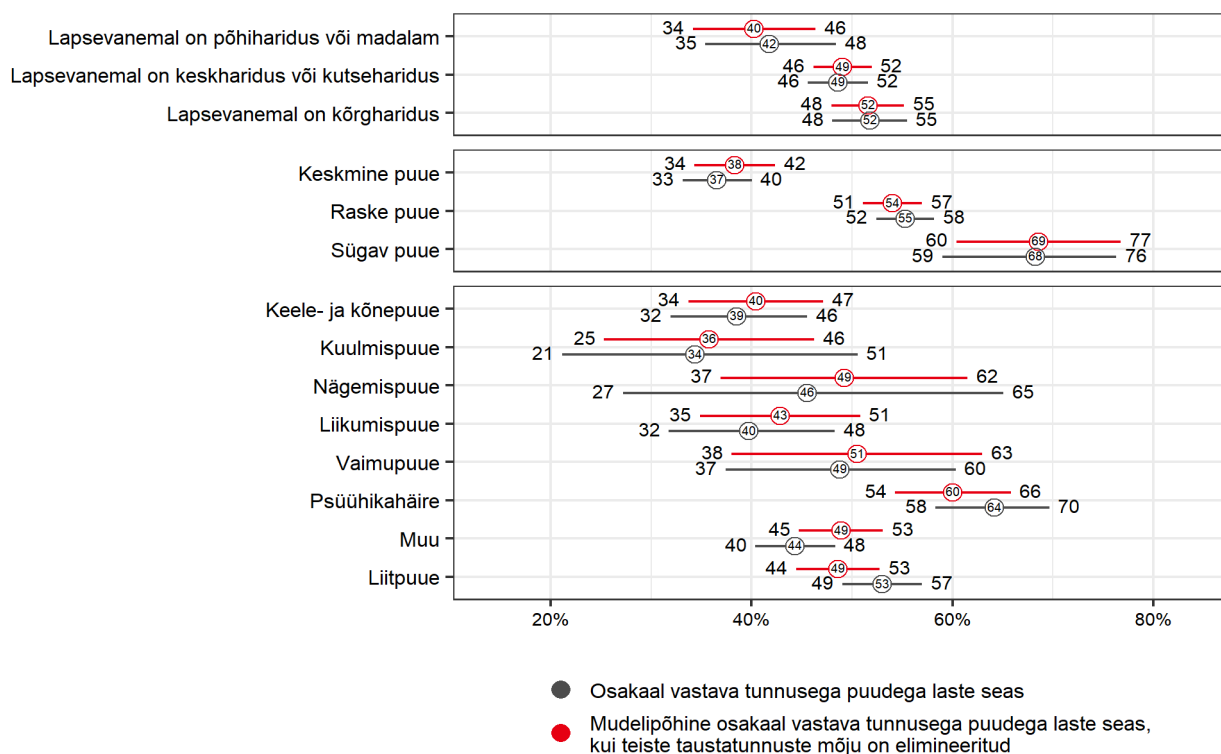
Joonis 145. Milline spetsiaalne ettevalmistus peaks olema leibkonnas kasvava puudega lapse eest hoolitseval isikul või hooldajal? (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Lapse puudest tulenevate erivajadustega toimetulemise oskust vajalikuks pidavaid on kõrgharidusega lapsevanemate seas enam kui põhihariduse või madalala haridustasemega lapsevanemate seas (Joonis 146).

Joonis 146. Leibkonnas kasvava puudega lapse eest hoolitseval isikul või hooldajal peaks olema lapse puudest tulenevate erivajadustega toimetulemise oskus (% puudega lastest)

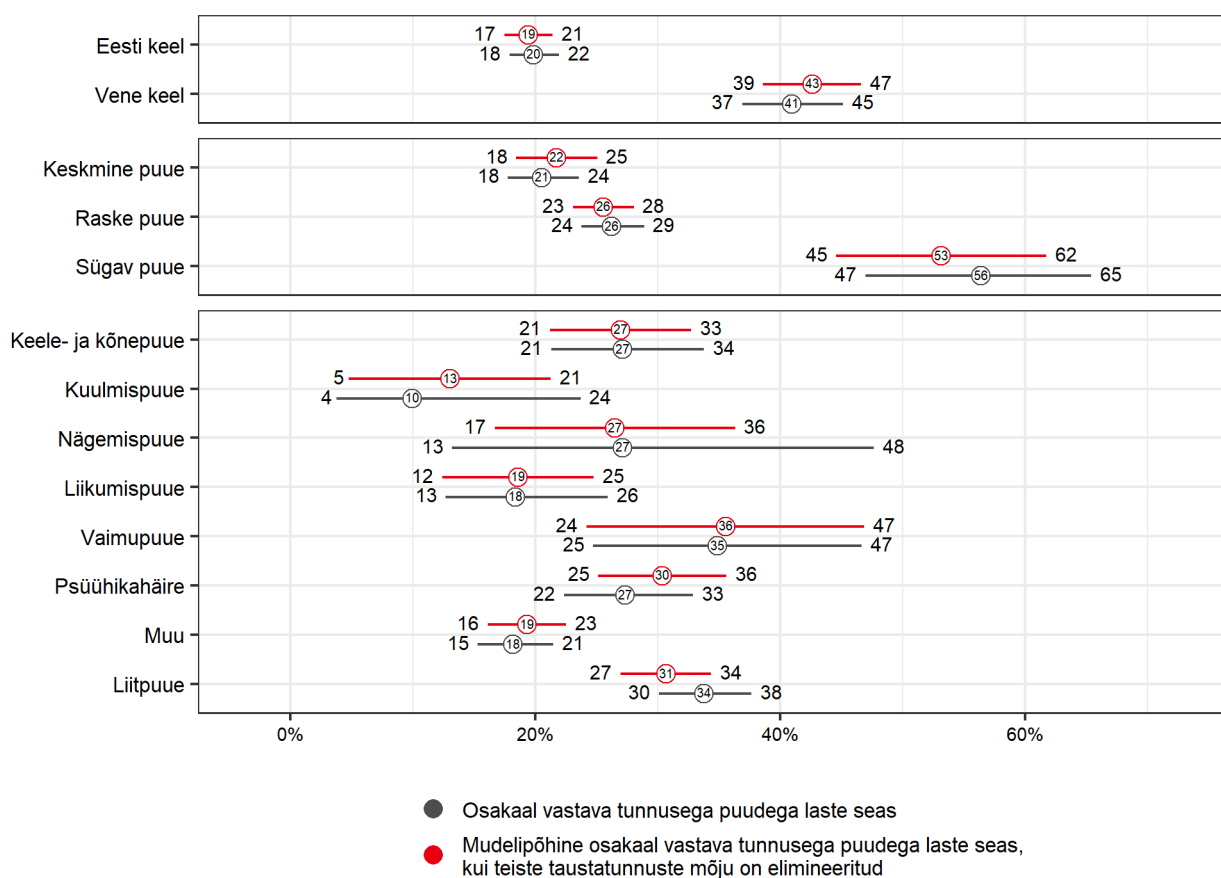


Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega lapsed. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: leibkonnas kasvava puudega lapse eest hoolitseval isikul peaks olema lapse puudest tulenevate erivajadustega toimetulemise oskus=1, leibkonnas kasvava puudega lapse eest hoolitseval isikul ei pea olema lapse puudest tulenevate erivajadustega toimetulemise oskus, või ei oska spetsiaalse ettevalmistuse vajadust hinnata = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: puudeliik, puude raskusaste, kodune keel, lapsevanema haridus

Kõrgharidusega lapsevanematest peab seda vajalikuks 48-55%, põhihariduse või madalama haridustasemega lapsevanematest 35-48%. Lapse puude raskusastme kasvades suureneb nende vastajate osakaal, kes nimetatud oskust vajalikuks peavad. Sügava puudega laste vanematest peab 59-76% vajalikuks lapse puudest tulenevate erivajadustega toimetulemise oskust, keskmise puudega laste vanematest aga 33-40%. Puudeliikide lõikes ilmneb, et psüühikahäirega laste vanemate seas (58-70%) on üldiselt teiste puudeliikidega võrreldes (v.a nägemis- ja vaimupuue) enam neid, kes peavad erivajadustega toimetulemise oskust vajalikuks.

Puudega lapse hoidmise kogemust peavad vajalikuks vene koduse keelega lapsevanemad enam kui koduse eesti keelt kõnelevad lapsevanemad (vene keelt kõnelevatest 37-45%, eesti keelt kõnelevatest 18-22%) (Joonis 147).

Joonis 147. Leibkonnas kasvava puudega lapse eest hoolitseval isikul või hoidjal peaks olema puudega lapse hoidmise kogemus (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvaartuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega lapsed. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: leibkonnas kasvava puudega lapse eest hoolitseval isikul peaks olema puudega lapse hoidmise kogemus=1, leibkonnas kasvava puudega lapse eest hoolitseval isikul ei pea olema puudega lapse hoidmise kogemus või ei oska spetsiaalse ettevalmistuse vajadust hinnata= 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: puudeliik, puude raskusaste, kodune keel, lapsevanema haridus.

Sügava puudega laste vanemad võrreldes keskmise ja raske puudega laste vanematega peavad märkimisväärselt enam vajalikuks puudega lapse hoidmise kogemust. Sügava puudega laste vanematest peab puudega lapse hoidmise kogemust vajalikuks 47-65%, kuid keskmise ning raske puude puhul jääb see osakaal vahemikku 18-29%.

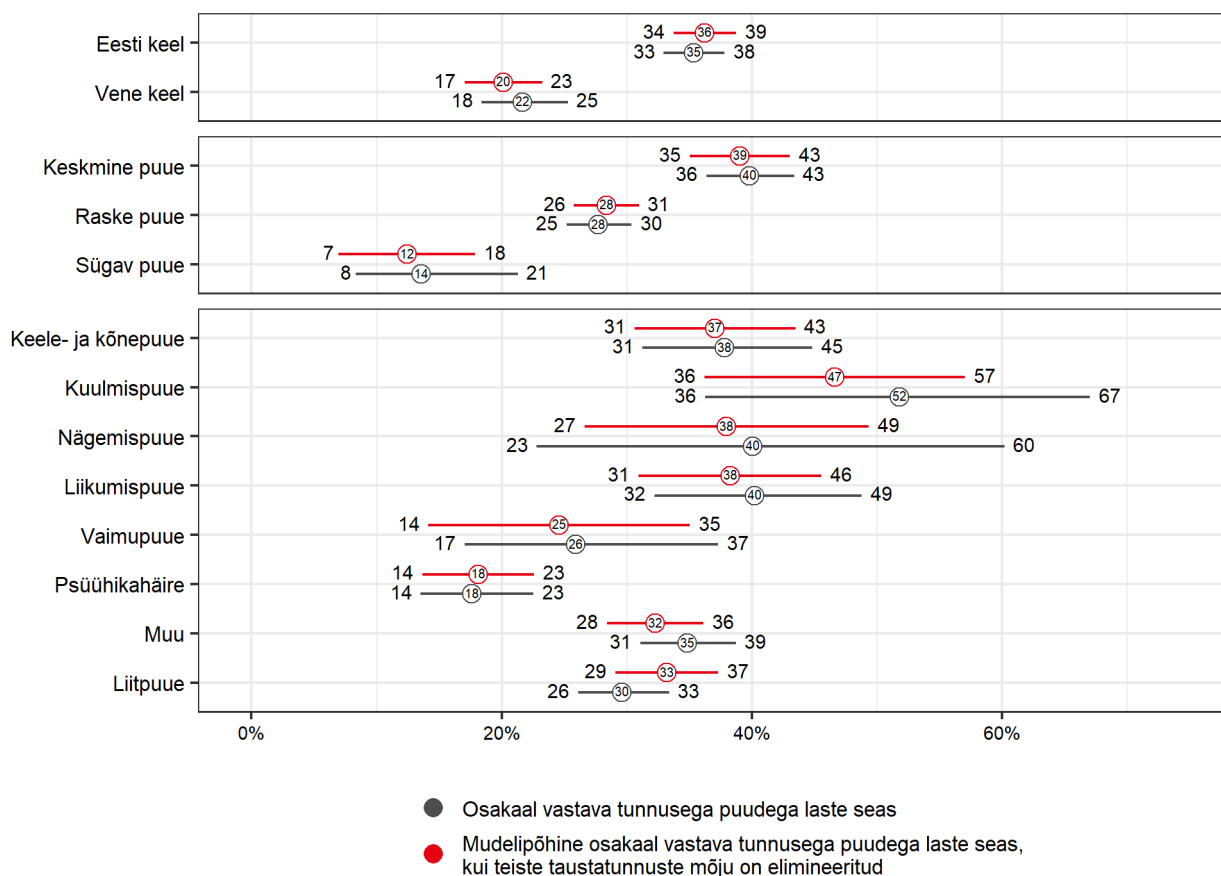
Muu puudega (15-21%), kuulmispuudega (4-24%) ning liikumispuudega (13-26%) laste vanemate seas on vähem kui teiste puudeliikidega (v.a nägemispuudega, mis ei eristu statistiliselt oluliselt) laste seas neid, kes leiavad, et puudega lapse eest hoolitseval isikul või hoidjal peaks olema puudega lapse hoidmise kogemus.

Puudega laste vanemaid, kelle hinnangul nende leibkonnas kasvava puudega lapse hoidmiseks **ei ole vaja mingisugust spetsiaalset ettevalmistust** (Joonis 148), on eesti koduse keelega vastajate seas (33-38%) enam kui kodus vene keelt kõnelevate seas (18-25%).

Mida väiksem on lapse puude raskusaste, seda suurem on nende vastajate osakaal, kelle hinnangul spetsiaalset ettevalmistust ei ole vaja: keskmise puude korral 36-43%, raske puude korral 25-30% ja sügava puude korral 8-21%.

Lapse puude liigi lõikes ilmneb, et psüühikahäirega laste vanemate seas on neid, kelle hinnangul puudega lapse hoidmiseks ei ole vaja spetsiaalset ettevalmistust, vähem kui teiste puudeliikide (v.a vaimupuue) seas.

Joonis 148. Leibkonnas kasvava puudega lapse hoidmiseks ei ole vaja spetsiaalset ettevalmistust (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvaartuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega lapsed. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: leibkonnas kasvava puudega lapse hoidmiseks ei ole vaja spetsiaalset ettevalmistust=1, leibkonnas kasvava puudega lapse eest hoolitseval isikul ei peab olema mingisugune spetsiaalne ettevalmistus või ei oska selle vajalikkust hinnata= 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: puudeliik, puude raskusaste, kodune keel, lapsevanema haridus.

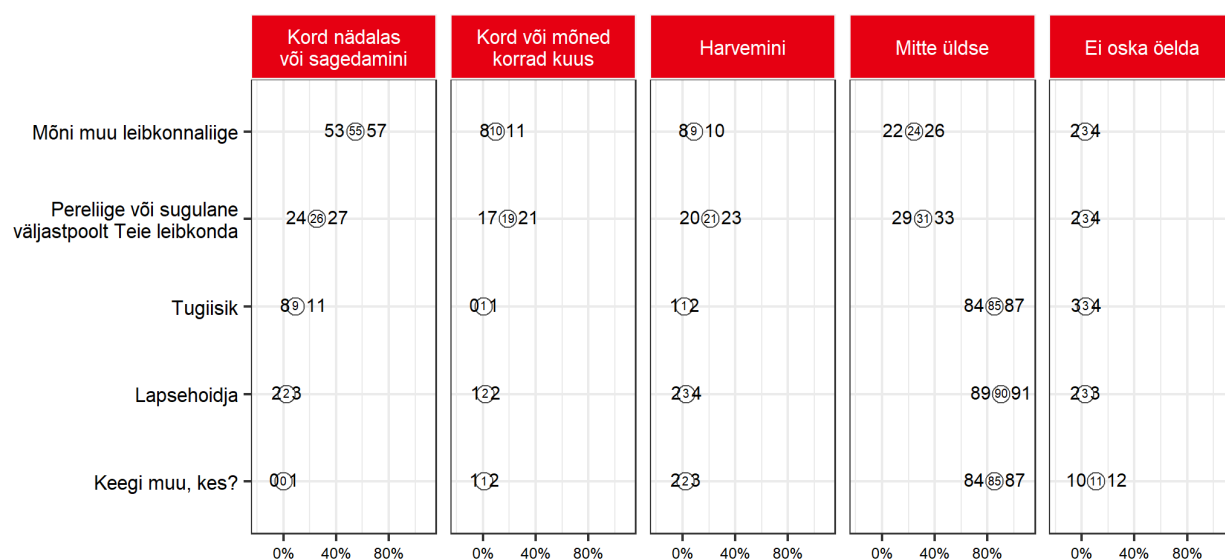
7.5 Puudega lapse vanema hoolduskoormus

Valdav osa puudega lapse hoolduskoormusest langeb lapse leibkonnaliikmetele ning teistele pereliikmetele või sugulastele väljaspool leibkonda (Joonis 149). Ligikaudu pooli (53-57%) puudega lapsi hoiab või hooldab vähemalt kord nädalas mõni muu leibkonnaliige peale uuringus osalenud puudega lapse vanema. Ligikaudu neljandikku (24-27%) puudega lastest hoiab või hooldab vähemalt kord nädalas pereliige või sugulane väljastpoolt leibkonda. Iga kümnnendat (8-11%) puudega last hoiab või hooldab vähemalt kord nädalas lapse tugiisik.

Lisaks loetletule anti puudega laste vanematele võimalus märkida muud isikud, kes last mingil määral hoiavad või hooldavad. Kõigist lapsevanematest vaid 3% märkis mõne muu isiku, kes mingil määral puudega last hoiab või hooldab. Sealhulgas toodi välja peamiselt sõbrad/sõbrannad, tuttavad ja naabrid.

2009. aasta uuringus ei küsitud, kui sageli loetelus nimetatud isikud puudega last hoiavad või hooldavad, vaid paluti öelda, kas nimetatud isikud puudega last/lapsi abistavad või hooldavad. Samuti on loetletud isikud käesolevas ning 2009. aasta uuringus mõnevõrra erinevad. Tulemusi üldiselt võrreldes saab välja tuua, et sarnaselt käesoleva uuringu tulemustega ilmnes ka 2009. aasta uuringust, et valdavat osa puudega laste vanematest aitavad puudega lapse hoidmisel või hooldamisel teised leibkonnaliikmed.

Joonis 149. Kui sageli lisaks Teile hoiab või hooldab puudega last keegi teine? (% puudega laste vanematest)



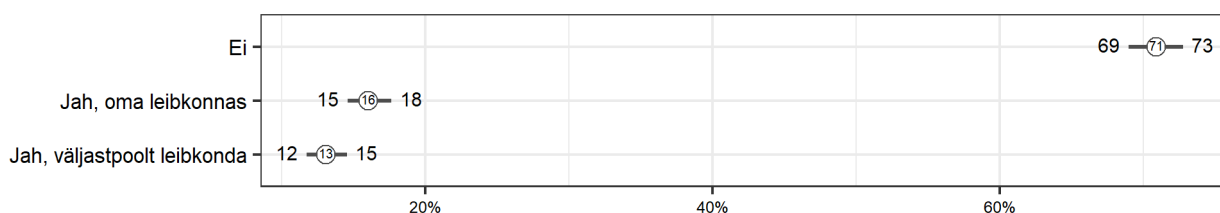
Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Käesoleva uuringu tulemuste põhjal on puudega laste vanemate seas ka neid, kellele langeb puudega lapse hoidmisel ja hooldamisel kogu koormus. 11-13% puudega lastest on sellised, kelle hooldamisel ei abista lapsevanemat mitte ükski teine isik. Vaadates käesoleva uuringu tulemustel puudega lapse ainuisikulist hooldamist sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes, ilmneb, et mida suurem on leibkonnas täiskasvanute arv, seda väiksem on tõenäosus, et lapsevanemat ei abista puudega lapse hooldamisel mitte keegi. Küll aga esineb selliseid olukordi, kui puudega lapse hoidmisel ja hooldamisel ei aita lapsevanemat ükski teine isik, ka nendes leibkondades, kus on enam kui üks täiskasvanu. 9-12% puudega laste vanematest, kes elavad 2 täiskasvanuga leibkondades, ei aita puudega lapse hooldamisel mitte ükski teine isik. 8-14% puudega laste vanematest, kes elavad 3 või enam täiskasvanuga leibkondades, ei aita puudega lapse hooldamisel ükski teine isik. Neid puudega laste vanemaid, keda puudega lapse hooldamisel ükski teine isik ei abista, on põhihariduse või madalama haridustasemega lapsevanemate seas (16-26%) enam kui kõrgharidusega lapsevanemate seas (5-9%).

Puudega lapsi ainuisikuliselt hooldavate osakaalu ei ole võimalik võrrelda 2009. aasta uuringuga, kuna eelnevas uuringus oli vastajatel võimalik valida variant „Ei, ainult mina“ ning käesolevas uuringus on ainuisikuliselt hooldavate osakaal moodustatud neist, kes kõigi loetletud isikute puhul märkisid, et ei hoolda ega hoia puudega last üldse. Samuti on ainuisikuliselt puudega last hooldavate osakaalude erinevus (2009. 16% ja 2017. 12%) küllaltki väike.

Lisaks leibkonnas kasvavate laste hooldamisele on paljudel lapsevanematel täiendavaid hooldatavaid. Peale leibkonnas kasvava(te) lapse/laste abistab või hooldab veel kedagi oma leibkonnast või väljastpoolt leibkonda ca 27–33% puudega laste vanematest. Oma leibkonnas on peale laste veel teisi hooldatavaid 15–18% puudega laste vanematest ning väljaspool leibkonda 12–15% puudega laste vanematest (Joonis 150). 2009. aasta uuringus küsiti vaid hooldatavate kohta, kes on väljaspool vastaja leibkonda, ning tulemustest ilmnes, et kedagi teist hooldas ca 19% vastajatest.

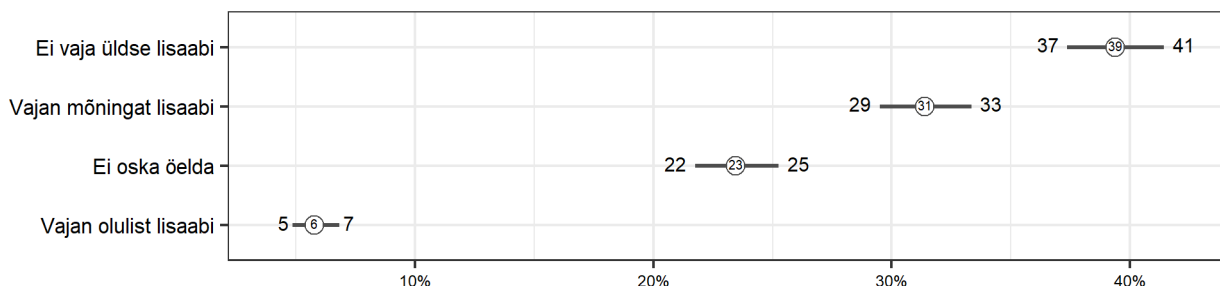
Joonis 150. Kas Te abistate või hooldate peale Teie leibkonnas kasvava(te) lapse/laste veel kedagi oma leibkonnast või väljastpoolt leibkonda? (% puudega laste vanematest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Kõigi hooldatavate (sh lapsed ning teised hooldatavad) abistamisel või hooldamisel vajab olulist või mõningat lisaabi 34–40% kõigist puudega laste vanematest. Sealjuures mõningat lisaabi vajab 29–33% ning olulist lisaabi vajab 5–7% lapsevanematest (Joonis 151). 2009. aastal oli olulist lisaabi vajavate osakaal 8% ning mõningat lisaabi vajavate osakaal 38%. Nende osakaal, kes ei osanud lisaabi vajadust hinnata, on käesolevas uuringus suurem (2009. aastal 2%, 2017. aastal 23%) ning nende osakaal, kes märkisid, et ei vaja üldse lisaabi, on käesolevas uuringus oluliselt väiksem (2009. aastal 52%, 2017. aastal 39%). Küll aga tuleb siinkohal arvestada, et 2009. aastal ei olnud vastajatele küsimustikus ette antud vastusevarianti „ei oska öelda“, mis võis vastuste osakaalusid mõjutada ning tingida ka kahe uuringu tulemuste erinevuse.

Joonis 151. Kuivõrd Teie ise vajate lisaabi puudega lapse või teiste hooldatavate abistamisel või hooldamisel? (% puudega laste vanematest)



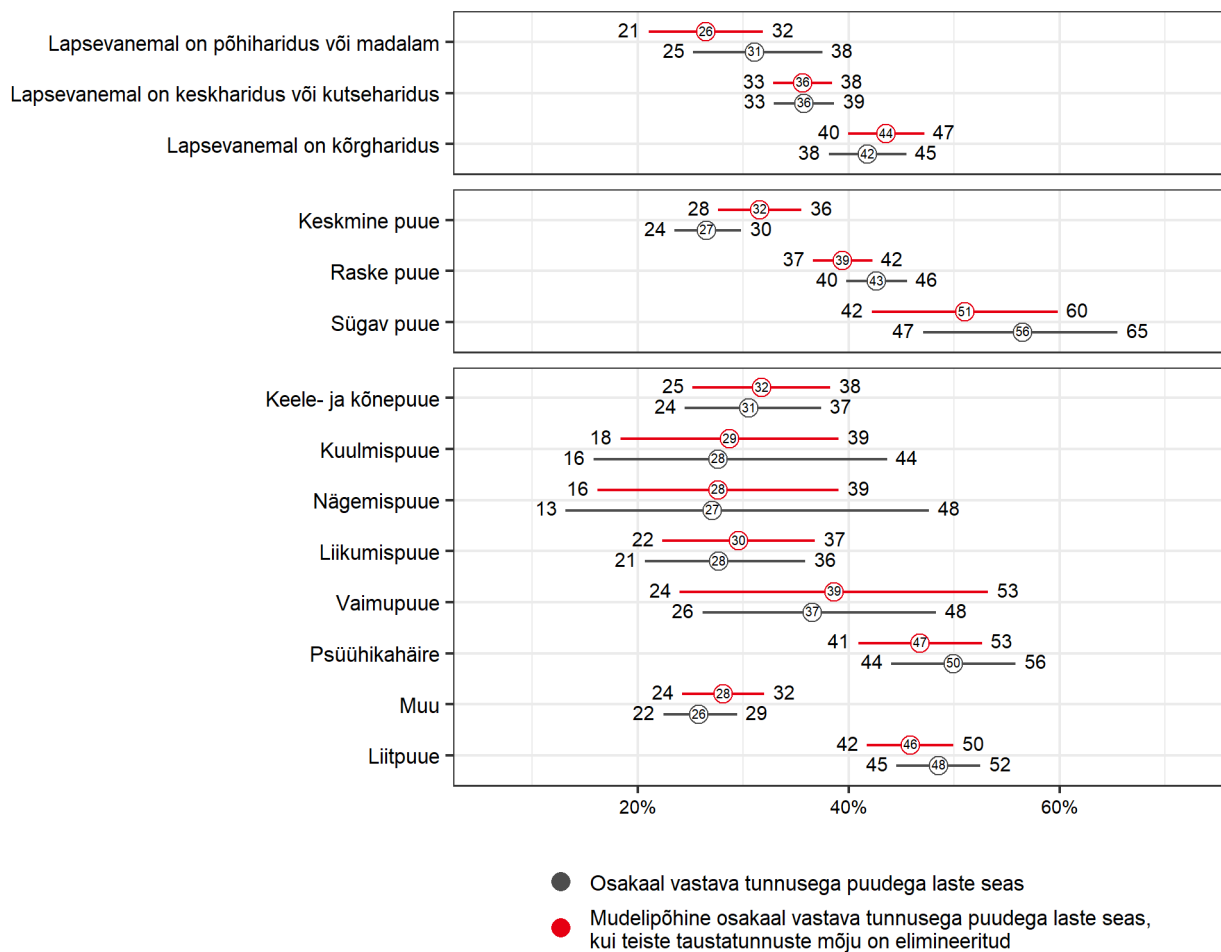
Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Puudega lapse või teiste hooldatavate abistamisel või hooldamisel (mõningat või olulist) lisaabi vajavate osakaal suureneb lapse puude raskusastme kasvades (Joonis 152). Kui sügava puudega laste vanemate seas on lisaabi vajavaid 47–65%, siis keskmise puudega laste vanemate seas on neid 24–30%. Mida kõrgem on lapsevanema haridustase, seda enam tunnetatakse olulise või mõninga lisaabi vajadust. Lapse puude liigi

lõikes eristuvad psüühikahäirega ning liitpuudega laste vanemad, kelle seas on lisaabi vajadus suurem kui teiste puudeliikidega laste vanemate (v.a vaimupuue) seas.

Võrreldes puudega laste vanemaid selle järgi, kas neil endal on samuti puue tuvastatud, ilmneb, et lapsevanematest, kellel on endal puue, vajab lisaabi 46-60%, ning lapsevanematest, kellel puuet ei ole tuvastatud, vajab lisaabi 33-38%.

Joonis 152. Lapsevanem vajab olulist või mõningat lisaabi puudega lapse või teiste hooldatavate abistamisel või hooldamisel (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega lapsed. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni Sõltuv muutuja: vajab puudega lapse või teiste hooldatavate abistamisel või hooldamisel mõningat või olulist lisaabi=1, ei vaja puudega lapse või teiste hooldatavate abistamisel või hooldamisel mõningat või olulist lisaabi või ei oska lisaabi vajadust hinnata = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapse puudeliik, lapse puude raskusaste, kodune keel, vastaja haridus, lapsevanema peamine sotsiaalne seisund, lapse vanus, lapsevanemal puude olemasolu, täiskasvanute arv, laste arv.

Puudega laste vanematel, kes vajavad mõningat või olulist lisaabi puudega lapse või teiste hooldatavate abistamisel või hooldamisel, paluti kirjeldada, millist lisaabi nad kõige enam vajaksid. Peamiselt toodi lisaabi vajadustena välja:

1. **Tugiisikut** (lapsele), sh kooli, koolivälisel ajal

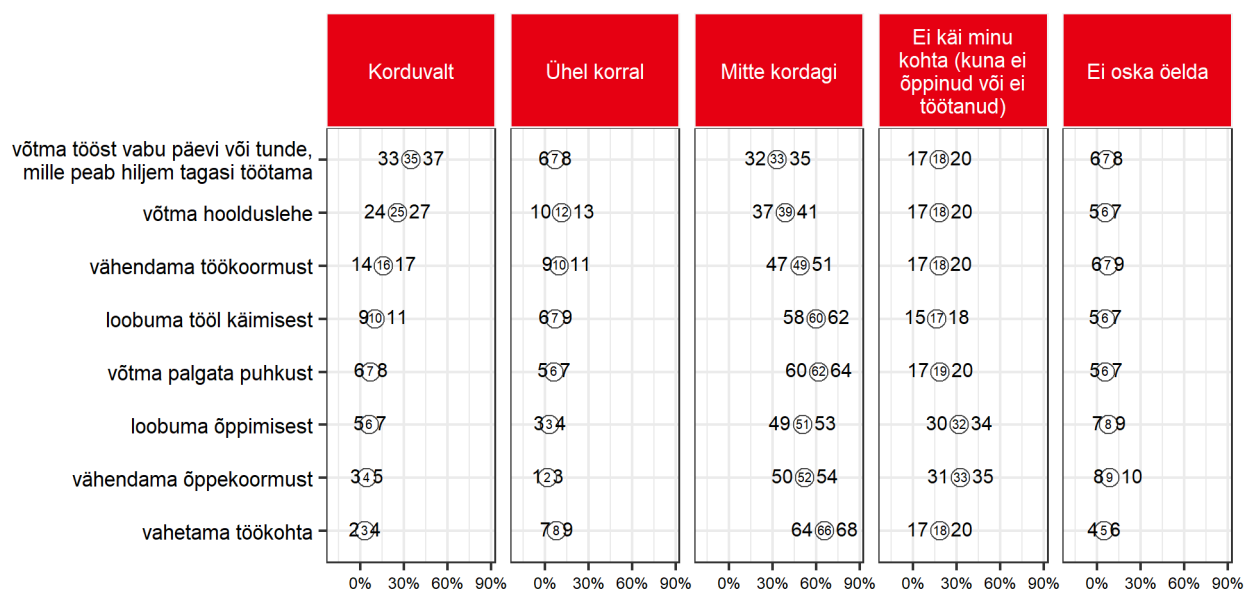
2. **Lapsehoiuteenust**, sh õhtuti, päevasel ajal, nädalavahetustel, koolivaheaegadel, aeg-ajalt, era- korralistel juhtudel ajutiselt
3. **Psühholoogi, nõustamist, vaimset/moraalset tuge**, sh stressiga toimetulek, lapse käitumisraskus- tega toimetulek, motivatsioon, kogemusnõustamine
4. **Informatsiooni/teavet**, sh abivahendite kasutamine, lapse igapäevaelu korraldamine, lapse diag- noos/haigus, lapse haridustee, abivõimalused, puudega seotud eripärad, lapse toitumine, mediti- siiniline teave
5. **Logopeedi/eripedagoogi**
6. **Koduabilist**, sh abi koristamisel, söögi valmistamisel, poes käimisel, abi teiste hooldavate hooldamisel
7. **Koduõpetajat lapsele/ abi lapse õppimisel kodus**
8. **Transpordivõimalusi**, sh kooli/lasteaeda ja tagasi koju, teenusepakkujate juurde, arstile
9. **Puhkust, vaba aega**
10. **Rahalist abi/toetust**
11. **Abilist lapsele**, sh tööpäevadel lapse viimine teenustele/kooli/huviringidesse/arstile, lapsega õues jalutamine
12. **Füüsilist abi lapse tõstmisel**
13. **Abi seoses enda tervisega/haigusega toimetulekuks**

7.6 Hoolduskoormusega kaasnevad probleemid

Hoolduskoormusega kaasnevate probleemide osas kaardistati uuringus esmalt töötamise ning õppimisega seonduvad probleemid. Ligikaudu 64%l puudega laste vanematest on viimase 12 kuu jooksul esinenud vähemalt üks uuringus käsitletud probleem. Kõige enam esineb olukordi, mil puudega lapse vanem on pidanud võtma tööst vabu päevi või tunde, mille peab hiljem tagasi töötama (Joonis 153). Sellist olukorda esines korduvalt viimase 12 kuu jooksul ligi kolmandikul (33-37%) lapsevanematest. Ligi neljandik (24-27%) vastajatest tõi välja, et on viimase 12 kuu jooksul pidanud korduvalt võtma puudega lapse hoidmise või hooldamise jaoks hoolduslehe. Teisi uuringus käsitletud probleeme esines puudega laste vanemate seas vähem kui neljandikul. Sealjuures on õppimisega seotud probleeme esinenud küllaltki vähe, mis on ka mõistetav, kuna uuringus osalenud puudega laste vanemate seas oli vaid ligi 2% neid, kes määratlesid oma peamiseks sotsiaalseks seisundiks õpilane/üliõpilane⁴⁰.

⁴⁰ Õppimisega tegelevaid võib olla tegelikult mõnevõrra rohkem, sest uuringus ei kaardistatud neid, kes tegelevad õppimisega muude tegevuste kõrvalt, ehk neid, kellel pole õppimine peamiseks tegevuseks

Joonis 153. Mitmel korral viimase 12 kuu jooksul olete Teie ise pidanud puudega lapse/laste hoidmise või hooldamise tõttu...? (% puudega laste vanematest)

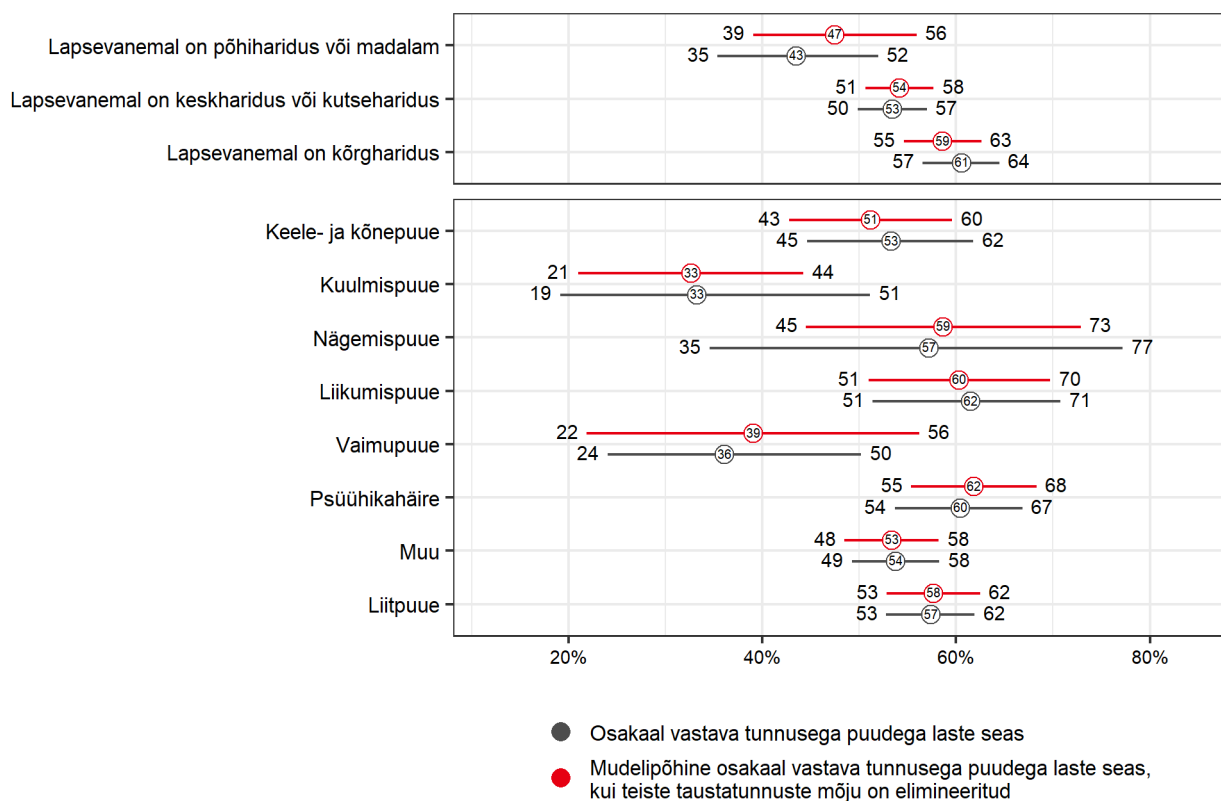


Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Järgnevalt vaatame enim esinenud probleeme taustatunnuste lõikes. Probleemi esinemisena käsitletakse kõiki juhtusid, mil probleem esines korduvalt või vaid ühel korral.

Puudega laste vanematest, kelle peamine sotsiaalne seisund on töötav, on veidi üle poole (56-61%) pidanud viimase 12 kuu jooksul võtma puudega lapse hooldamiseks **vabu päevi või tunde, mille peab hiljem tagasi töötama**. Vabu päevi või tunde võtnuid esineb ka nende seas, kelle peamine sotsiaalne seisund oli küsitluse toimumise hetkel mittetöötav (töötute töötajate seas 40-61% ja muude mittetöötavate seas 31-47%) ja seda ilmselt põhjusel, et küsitlusele eelnenud 12 kuu jooksul osa neist töötasid. Mida suurem on täiskasvanute arv leibkonnas, seda vähem on neid, kes on pidanud töölt vabu päevi või tunde võtma. Kõrgharidusega vastajate seas on mõnevõrra enam kui madalama haridustasemega vastajate seas neid, kes pidid viimase 12 kuu jooksul vähemalt ühe korra võtma töölt vabu päevi või tunde puudega lapse hoidmiseks või hooldamiseks (Joonis 154). Vabu päevi või tunde pidid võtma töölt kõrgharidusega lapsevanematest 57-64% ning põhihariduse või madalama haridustasemega lapsevanematest 35-52%. Kuigi töölt vabu päevi või tunde võtnuid esineb kõige vähem nii kuulmis- kui ka vaimupuudega laste vanemate seas, siis teiste taustatunnuste mõju elimineerides ilmneb, et teiste puudeliikidega laste vanematest erinevad statistiliselt oluliselt vaid kuulmispuudega laste vanemad.

Joonis 154. Lapsevanem on viimase 12 kuu jooksul pidanud ühel korral või korduvalt puudega lapse/laste hoidmise või hooldamise tõttu võtma töölt vabu päevi, mille peab hiljem tagasi töötama (% puudega lastest)



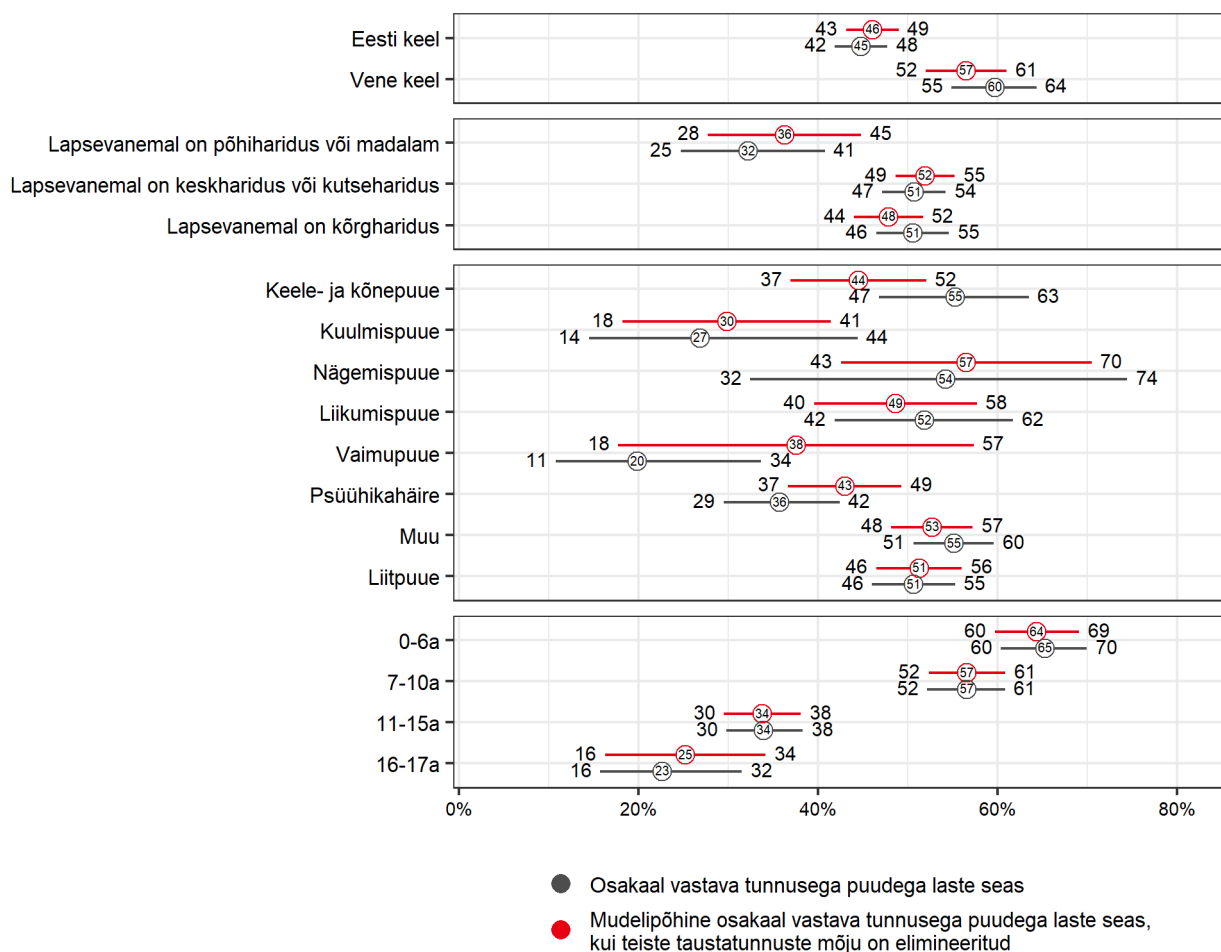
Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist välja jäetud muu koduse keelega vastajad ja need, kes märkisid, et ei õppinud ega töötanud või ei osanud probleemi esinemist hinnata. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on pidanud viimase 12 kuu jooksul korduvalt või ühel korral võtma tööst vabu päevi või tunde, mille peab hiljem tagasi töötama=1, ei ole viimase 12 kuu jooksul mitte kordagi pidanud võtma tööst vabu päevi või tunde, mille peab hiljem tagasi töötama = 0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapse puudeliik, lapse puude raskusaste, kodune keel, vastaja haridus, lapsevanema peamine sotsiaalne seisund, lapse vanus, täiskasvanute arv, laste arv.

Hoolduslehe on viimase 12 kuu jooksul pidanud puudega lapse/laste hooldamiseks võtma ca pooled (47-53%) nendest, kelle peamiseks sotsiaalseks seisundiks on töötav. Hoolduslehe võtnuid on ka mittetöötavate seas (töö otsijatest 46-67% ja muudest mittetöötavatest 35-50%), kuna küsitlusele eelnenud 12 kuu jooksul võisid nad olla töötavad.

Hoolduslehe võtnute osakaal erineb ka koduse keele, lapsevanema hariduse, lapse puude liigi ning vanuse lõikes (Joonis 155). Kodus eesti keelt kõnelevatest on pidanud hoolduslehe võtma 42-48%, vene keelt kõnelevatest aga mõnevõrra enam - 55-64%. Hoolduslehe võtnute osakaal lapse vanuse kasvades väheneb.

Kõrgharidusega ning kesk- või kutseharidusega lapsevanemate seas on enam hoolduslehe võtnuid kui põhihariduse või madalama haridusega lapsevanemate seas – põhihariduse või madalama haridustasemega lapsevanematest 25-41% on pidanud viimase 12 kuu jooksul võtma puudega lapse hoidmise tõttu hoolduslehe, keskkhariduse või kutsehariduse ja kõrgharidusega lapsevanemate seas jääb see osakaal vahemikku 46-55%.

Joonis 155. Lapsevanem on viimase 12 kuu jooksul pidanud ühel korral või korduvalt puudega lapse/laste hoidmise või hooldamise tõttu võtma hoolduslehe (% puudega lastest)



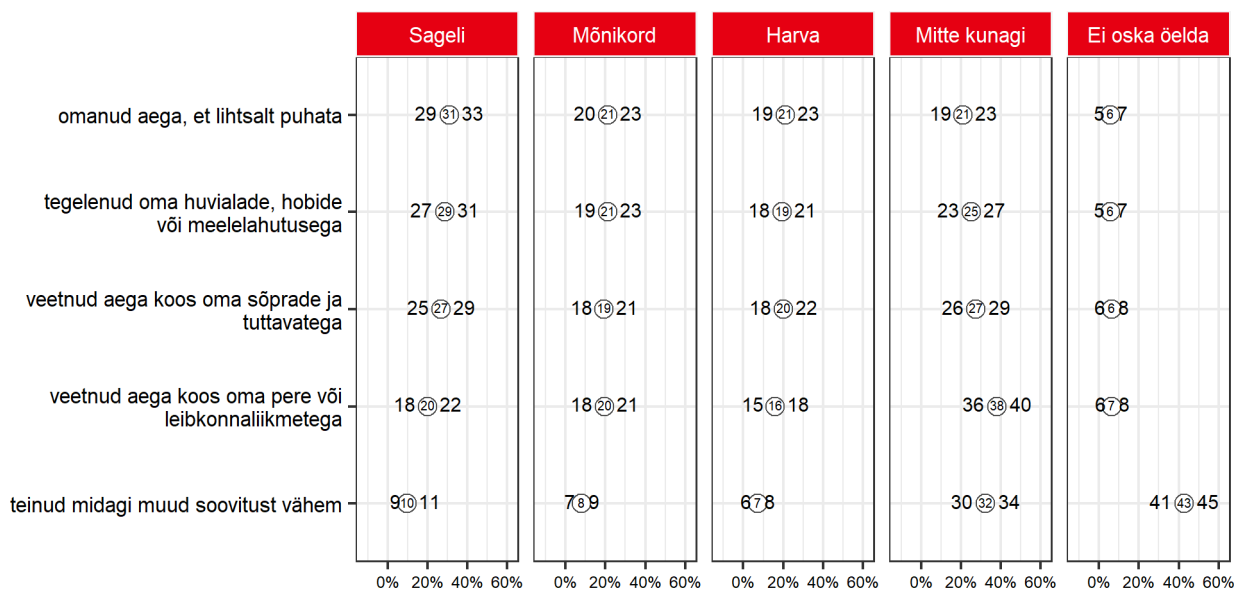
Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist välja jäetud muu koduse keelega vastajad ja need, kes märkisid, et ei õppinud ega töötanud või ei osanud probleemi esinemist hinnata. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on pidanud viimase 12 kuu jooksul korduvalt või ühel korral võtma hoolduslehe=1, ei ole viimase 12 kuu jooksul mitte kordagi pidanud võtma hoolduslehte =0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapse puudeliik, lapse puude raskusaste, kodune keel, vastaja haridus, lapsevanema peamine sotsiaalne seisund, lapse vanus, täiskasvanute arv, laste arv.

Lapse puude liigi lõikes ilmneb, et kõige vähem on hoolduslehe võtnud vaimupuudega (11-34%) ning kuulmispuudega laste (14-44%) vanemate seas. Kui aga elimineerida teiste taustatunnuste mõju, siis vaimupuudega laste vanemad teiste puudeliikidega laste vanematest statistiliselt oluliselt ei erine. Samas kuulmispuudega laste vanemad erinevad teiste taustatunnuste mõju elimineerides pea kõigist (v.a vaimupuudega ning psüühikahäirega laste) teiste puudeliikidega laste vanematest.

Järgnevalt paluti puudega laste vanematel hinnata, milliseid tegevusi ja kui sageli nad on viimase 12 kuu jooksul puudega lapse/laste hoidmise või hooldamise tõttu teinud soovitus vähem. Valdav osa vastajatest (ca 80%) tundis, et on viimase 12 kuu jooksul soovitus vähem teinud vähemalt ühte tegevust. Kuna uuringus käsitletud tegevused on sellised, mille soovitus vähem tegemist võib esineda kõigi inimeste seas, tuleks pöörata rohkem tähelepanu nendele olukordadele, mil tegevusi on puudega laste vanemad teinud soovitus sageli vähem. Kõige probleemsem on puhkamine. Ligi kolmandik (29-33%) puudega laste vanematest on viimase 12 kuu jooksul omanud sageli soovitus vähem aega lihtsalt puhkamiseks (Joonis 156).

Oma huvialade, hobide või meelelahutusega on sageli tegelenud soovitust vähem 27-31% lapsevanematest. Oma sõprade ja tuttavatega on sageli veetnud soovitust vähem aega ligi viiendik (25-29%) ning pere või leibkonnaliikmetega on aega veetnud sageli soovitust vähem ligi neljandik (18-22%) puudega laste vanematest.

Joonis 156. Kui sageli viimase 12 kuu jooksul olete puudega lapse/laste hoidmise või hooldamise tõttu soovitust vähem...? (% puudega laste vanematest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid ning nendest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Lisaks loetletule anti lapsevanematele võimalus nimetada midagi muud, mida nad on viimase 12 kuu jooksul puudega lapse hoidmise või hooldamise tõttu soovitust vähem teinud. Mõnda muud tegevust on sageli soovitust vähem teinud kümnendik (9-11%) puudega laste vanematest. Tegevuste hulgas, mida on viimase 12 kuu jooksul teinud soovitust vähem (sh nii sageli, mõnikord kui ka harva), töid lapsevanemad välja järgnevad:

- Meelelahutuslikud tegevused, sh teater, kino, üritused, väljas söömine, lugemine, matkamine
- Enese arendamine/täiendamine, õpingud
- Enda tervise ja füüsilise vormi eest hoolitsemine
- Majapidamistoimingud
- Magamine
- Iluteenuste kasutamine
- Reisimine
- Hobidega tegelemine
- Töötamine
- Kodu renoveerimine/remont
- Teise/teiste lastega aja veetmine

Järgnevalt vaatame, kuidas erineb uuringus käsitletud tegevuste soovitust vähem tegemine taustatunnuste lõikes. Tegevust soovitust vähem teinute hulka kuuluvad kõik, kellel esines seda kas sageli, mõnikord või harva.

Kõrgharidusega lapsevanemate seas on enam kui kesk- või kutseharidusega ning põhihariduse või madalama haridustasemega lapsevanemate seas neid, kes on puudega lapse hoidmise või hooldamise tõttu

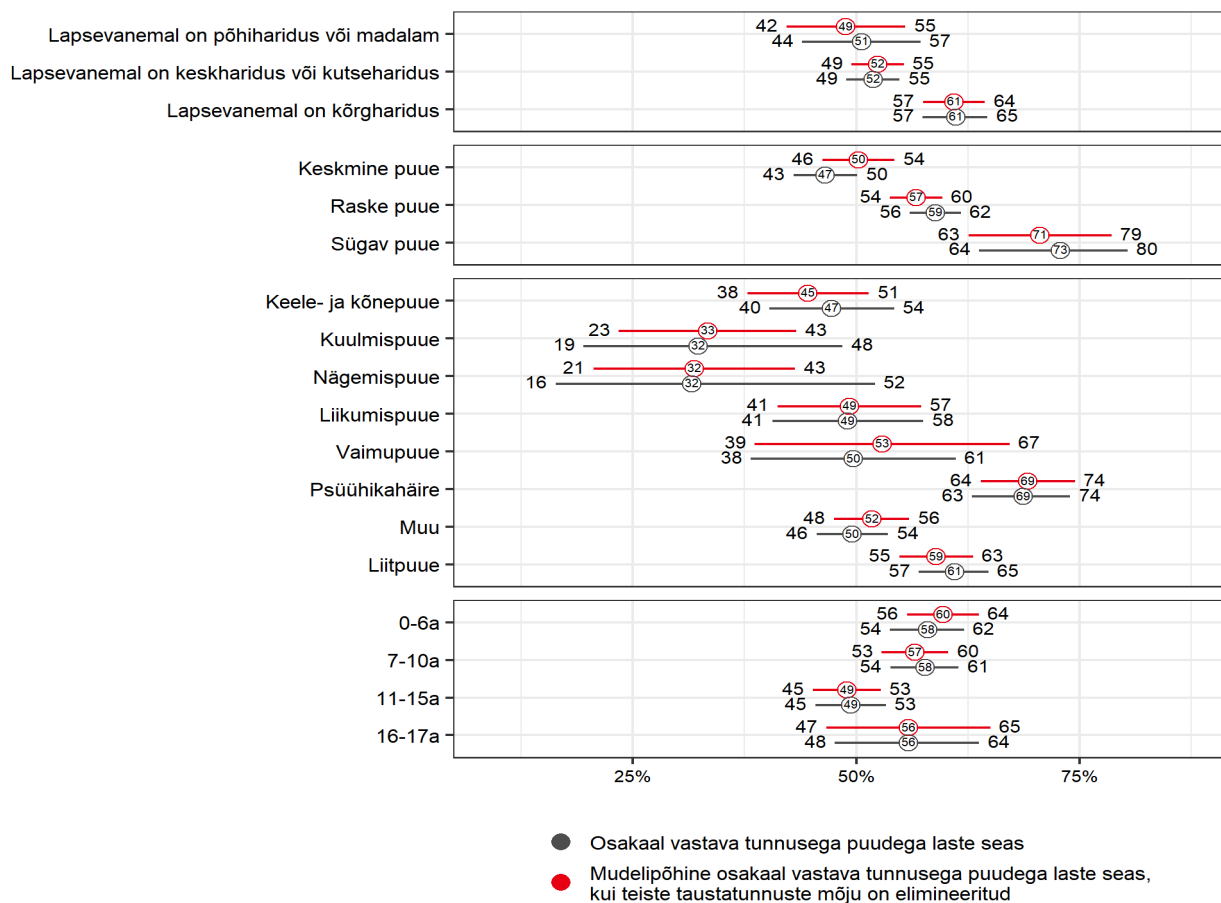
soovitust vähem oma pere või teiste leibkonnaliikmetega aega veetnud (Joonis 157). Kõrgharidusega lapsevanematest 57-65% on soovitus vähem veetnud aega pere või teiste leibkonnaliikmetega, keskmihariduse või kutsehariduse ning põhihariduse või madalama haridustasemega vastajate seas jääb see osakaal vahemikku 44-57%.

Lapse puude raskusastme kasvades nende vastajate osakaal, kes on saanud soovitus vähem oma pereliikmete või teiste leibkonnaliikmetega aega veeta, suureneb.

Üldiselt ilmneb, et mida noorem on puudega laps, keda hooldatakse, seda suurem on nende osakaal, kes on nimetatud tegevust teinud soovitus vähem, küll aga ei ole võimalik teha järeldusi 16–17-aastaste laste vanemate kohta, kuna selles grupis on vastajate arv liiga väike.

Puudeliigi lõikes eristuvad selgelt psüühikahäirega laste vanemad, kelle seas on pere või teiste leibkonnaliikmetega soovitus vähem aega veetnud enam kui teiste puudeliikidega laste vanemate seas.

Joonis 157. Lapsevanem on viimase 12 kuu jooksul puudega lapse/laste hoidmise või hooldamise tõttu soovitus vähem veetnud aega koos oma pere või leibkonnaliikmetega (% puudega lastest)



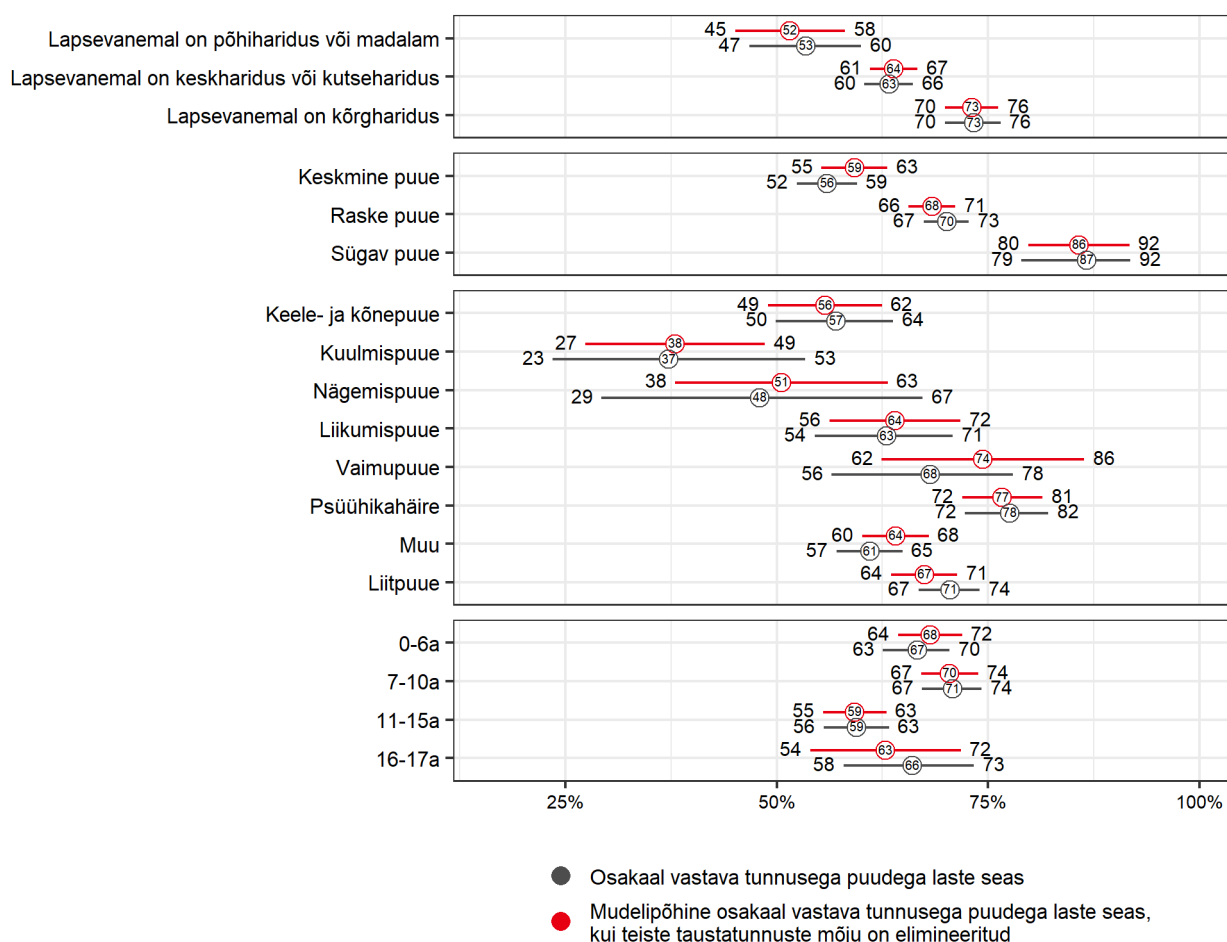
Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist välja jäetud muu koduse keelega lapsed. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul puudega lapse/laste hoidmise või hooldamise tõttu soovitus vähem veetnud aega koos oma pere või leibkonnaliikmetega =1, ei ole viimase 12 kuu jooksul puudega lapse/laste hoidmise või hooldamise tõttu soovitus vähem veetnud aega koos oma pere või leibkonnaliikmetega või ei oska öelda =0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapse puude liik, lapse puude raskusaste, kodune keel, lapsevanema haridus, lapse vanus, täiskasvanute arv, laste arv.

Sõprade ja tuttavatega soovitus vähem aega veetnud on 0–10-aastaste laste vanemate seas rohkem kui 11–15-aastaste laste vanemate seas (Joonis 158). Kui 11–15-aastaste laste vanematest on sõprade ja tuttavatega soovitus vähem aega veetnud 56–63%, siis 0–10-aastaste laste vanemate seas on see osakaal vahemikus 63–74%. 16–17-aastaste laste vanusegrupi kohta ei ole võimalik vastajate väikse arvu tõttu järeldust teha.

Lapse puude raskusastme ning lapsevanema haridustaseme kasvades suureneb nende osakaal, kes on viimase 12 kuu jooksul saanud soovitus vähem sõprade ja tuttavatega aega veeta. Sügava puudega laste vanematest on sõprade ja tuttavatega soovitus vähem aega veetnud valdav osa (79–92%), keskmise puudega laste vanematest aga ligi pooled (52–59%).

Puudeliigiti eristuvad kuulmispuudega laste vanemad, kelle seas on vähem kui teiste puudeliikide seas (v.a nägemispuue) neid, kes on soovitus vähem sõprade ja tuttavatega aega veetnud. Kuulmispuudega laste vanemad eristuvad teiste puudeliikidega laste vanematest ka siis, kui elimineerime teiste taustatunnuste mõju.

Joonis 158. Lapsevanem on viimase 12 kuu jooksul puudega lapse/laste hoidmise või hooldamise tõttu soovitus vähem veetnud aega koos oma sõprade ja tuttavatega (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist välja jäetud muu koduse keelega lapsed. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul puudega lapse/laste hoidmise või hooldamise tõttu soovitus vähem veetnud aega koos oma sõprade ja tuttavatega =1, ei ole viimase 12 kuu jooksul puudega lapse/laste hoidmise või hooldamise tõttu soovitus vähem veetnud aega koos oma sõprade ja tuttavatega või ei oska öelda =0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapse puude liik, lapse puude raskusaste, kodune keel, lapsevanema haridus, lapse vanus, täiskasvanute arv, laste arv.

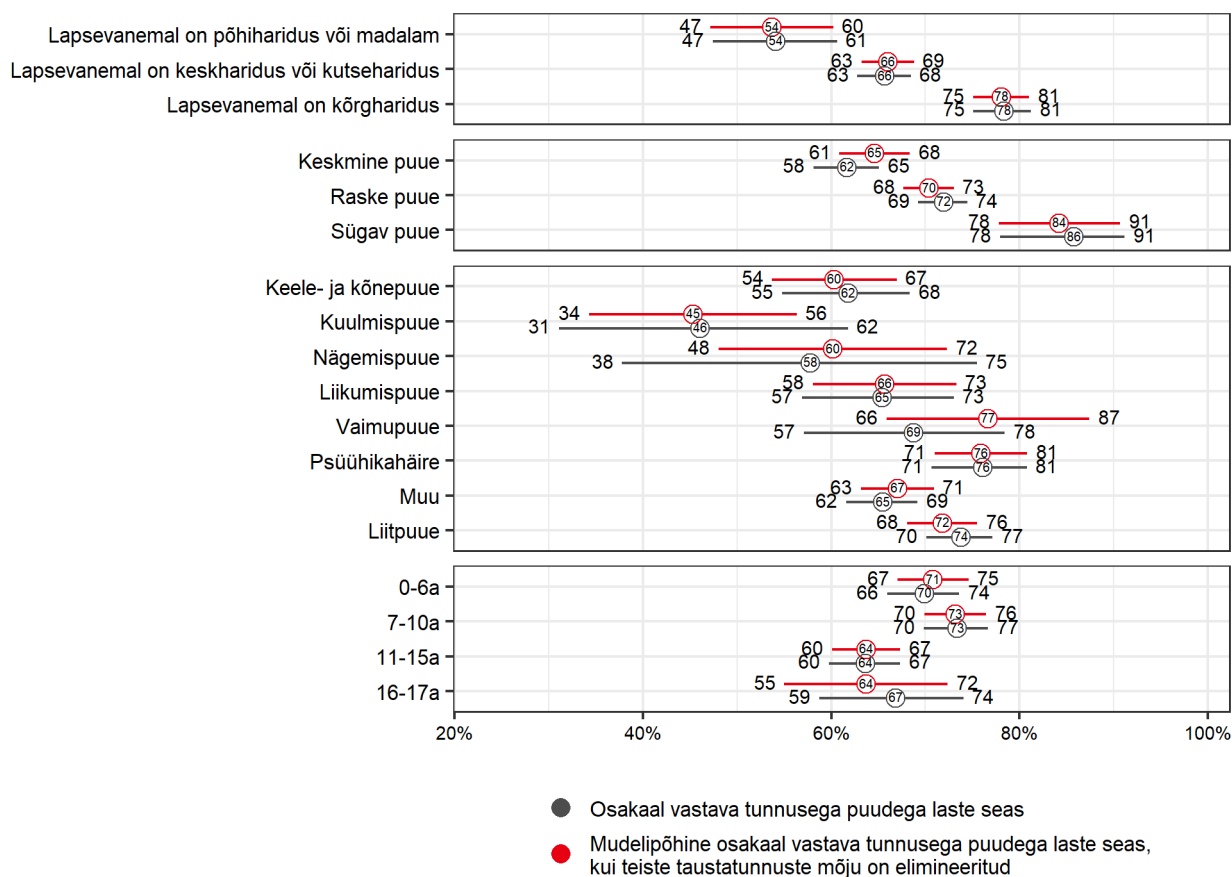
Oma huvialade, hobide ja meelelahutusega soovitud vähem tegelenud eristuvad lapsevanema hariduse ning lapse puude liigi, puude raskusastme ja vanuse lõikes. Mida kõrgem on puudega lapse vanema haridustase, seda enam esineb olukorda, et huvialade, hobide ja meelelahutusega on saadud tegeleda soovitud vähem (Joonis 159).

Samuti suureneb lapse puude raskusastme kasvades nende osakaal, kes on nimetatud tegevusi saanud teha soovitud vähem.

Lapse vanuse lõikes ilmneb, et 0–11-aastaste laste vanemate seas on huvialade hobide ja meelelahutusega soovitud vähem tegelenuid rohkem kui 11–15-aastaste laste vanemate seas (0-10-aastaste laste vanematest 66-77%, 11-15-aastaste laste vanematest 60-67%).

Lapse puude liigi lõikes väga tugevalt eristuvad grupid ei esine. Puudega lapse hoidmise või hooldamise tõttu on soovitud vähem huvide, hobide või meelelahutusega tegelenuid vähem kuulmispuudega (31-62%) ning mõnevõrra enam psüühikahäirega (71-81%) ja liitpuudega (70-77%) laste vanemate seas.

Joonis 159. Lapsevanem on viimase 12 kuu jooksul puudega lapse/laste hoidmise või hooldamise tõttu soovitud vähem tegelenud oma huvialade, hobide või meelelahutusega (% puudega lastest)



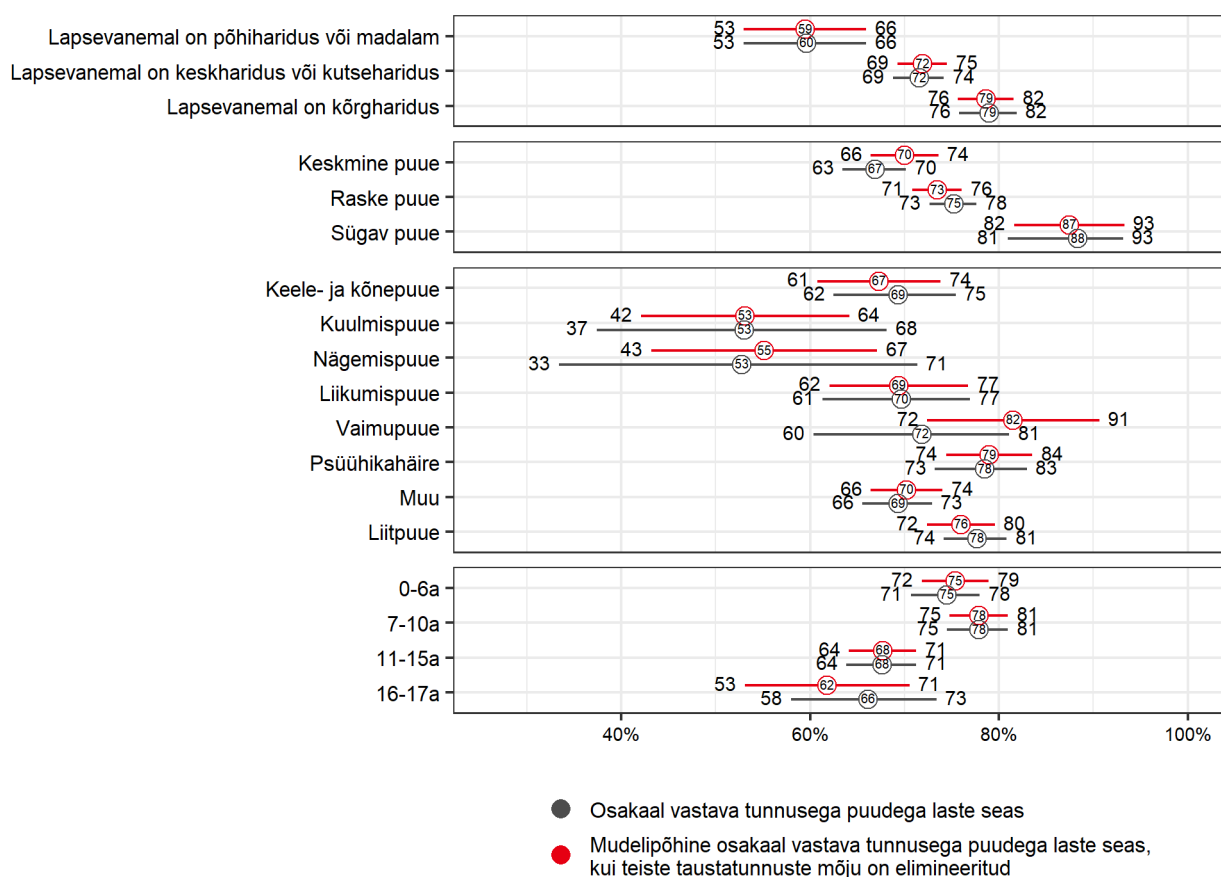
Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist välja jäetud muu koduse keelega lapsed. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul puudega lapse/laste hoidmise või hooldamise tõttu soovitud vähem tegelenud oma huvialade, hobide või meelelahutusega =1, ei ole viimase 12 kuu jooksul puudega lapse/laste hoidmise või hooldamise tõttu soovitud vähem tegelenud oma huvialade, hobide või meelelahutusega või ei oska öelda =0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapse puude liik, lapse puude raskusaste, kodune keel, lapsevanema haridus, lapse vanus, täiskasvanute arv, laste arv.

Kõrgharidusega lapsevanemate seas on neid, kes leiavad, et on omanud **soovitust vähem aega lihtsalt puhkamiseks**, enam kui madalamate haridustasemetega lapsevanemate seas (Joonis 160).

Lapse puude raskusastme lõikes ilmneb, et sügava puudega laste vanemate seas on neil, kellel on viimase 12 kuu jooksul soovitus vähem aega olnud lihtsalt puhkamiseks, suurem osakaal kui keskmise ning raske puudega laste vanemate seas (sügava puudega laste vanematest 81-93%, raske puudega laste vanematest 73-79% ning keskmise puudega laste vanematest 63-70%). Neid, kellel on olnud soovitus vähem aega lihtsalt puhkamiseks, on 0–10-aastaste laste vanemate seas enam kui vanematesse vanusegruppidesse kuuluvate laste vanemate seas.

Liitpuudega ning psüühikahäirega laste vanemate seas on puhkamiseks soovitus vähem aega olnud enamatel kui kuulmis- või nägemispuudega laste vanemate seas.

Joonis 160. Lapsevanem on viimase 12 kuu jooksul puudega lapse/laste hoidmise või hooldamise tõttu soovitus vähem omanud aega, et lihtsalt puhata (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist välja jäetud muu koduse keelega lapsed. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: on viimase 12 kuu jooksul puudega lapse/laste hoidmise või hooldamise tõttu soovitus vähem omanud aega, et lihtsalt puhata =1, ei ole viimase 12 kuu jooksul puudega lapse/laste hoidmise või hooldamise tõttu soovitus vähem omanud aega, et lihtsalt puhata või ei oska öelda =0. Mudelis kasutatud taustatunnused: lapse puude liik, lapse puude raskusaste, kodune keel, lapsevanema haridus, lapse vanus, täiskasvanute arv, laste arv.

Kõigi uuringus käsitletud tegevuste puhul on kõrgharidusega vastajad toonud madalamate haridustasemetega vastajatest enam välja, et on viimase 12 kuu jooksul puudega lapse/laste hooldamise või hoidmise tõttu saanud tegevusega soovitus vähem tegeleda. Siinkohal ei saa aga teha ühest järeldust, et

kõrgharidusega vastajatel oleks puudega lapse hooldamise tõttu vähem aega, vaid pigem võib eeldada, et kõrgharidusega vastajad tajuvad/teadvustavad ajapuudust teistest enam.

Lapse puude raskusastme lõikes on märkimisväärne, et valdav osa sügava puudega laste vanematest on enamiku tegevuste puhul saanud neid teha soovitusi vähem.

Lapse vanuse lõikes eristub kõigi tegevuste puhul 0–10-aastaste laste vanusegrupp. Selles vanuses laste vanemate seas on oluliselt enam kui vanemasse vanusegruppi kuuluvate laste vanemate seas neid, kes on saanud käsitletud tegevusi teha soovitusi vähem.

Lapse puude liigi lõikes vaadates eristuvad läbivalt kuulmispuudega laste vanemad, kelle seas on vähem neid, kes on teinud erinevaid tegevusi soovitusi vähem.

7.7 Kokkuvõte

Enam kui pooled puudega laste vanematest (53-57%) on kasutanud puudega lapse hoidmiseks küsitlusele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt ühte lapsehoidmise võimalust. Kõige enam on puudega laste vanemate seas lasteaia või –sõime teenuseid (29-33% puudega lastest) ja pikapäevarühma (13-16%) kasutanud. Lapse hoidmise teenuste kasutamine on tugevalt seotud lapse vanusega. Lapsevanemaid, kes ei ole lapse hoidmiseks viimase 12 kuu jooksul ühtegi teenust, on 16-17-aastaste laste vanemate seas 73-86% ning 0–6-aastaste laste vanemate seas vaid 10–15%.

Üle kolmandiku (ca 35-42%) lastevanematest vajab senisest rohkem või täiendavalt vähemalt ühte lapse hoidmise teenust. Kõige sagedasem on vajadus lapsehoidja järele, kes tuleb last hoidma lapse koju (14–17% puudega lastest). Pikapäevarühma senisest suurem või täiendav vajadus on 9-12% puudega laste vanematest. Muude lapsehoidmise teenuste puhul on neid teenuses senisest enam vajavate või täiendavalt vajavate osakaal alla 10%.

Pea kolmandik (29-33%) puudega laste vanematest tõi välja, et nende leibkonnas kasvava puudega lapse hoidmiseks ei ole vaja spetsiaalset ettevalmistust. Ligi pooled (47-51%) puudega laste vanemad peavad vajalikuks lapse puudest tulenevate erivajadustega toimetulemise oskust ning ligi viiendik (24-28%) peab vajalikuks puudega lapse hoidmise kogemust. Puudega laste vanematest 11-14% leiab, et vajalik on meditsiiniliste protseduuride läbiviimise oskus.

Ligikaudu pooli (53-57%) puudega lapsi hoiab või hooldab vähemalt kord nädalas mõni muu leibkonnaliige peale uuringus osalenud puudega lapse vanema. Umbes neljandikku (24-27%) puudega lapsi hoiab või hooldab vähemalt kord nädalas pereliige või sugulane väljastpoolt leibkonda. Teisi abilisi puudega lapse hoidmisel on nädalas vähemalt korra võimalik kasutada vähem kui kümnendikul puudega laste vanematel. 11-13% puudega lastest on sellised, kelle hooldamisel ei abista lapsevanemat mitte ükski teine isik. Olukordi, kui puudega lapse hoidmisel ja hooldamisel ei aita lapsevanemat ükski teine isik, esineb ka nendes leibkondades, kus on enam kui 1 täiskasvanu. 9-12% puudega laste vanematest, kes elavad 2 täiskasvanuga leibkondades, ei aita puudega lapse hooldamisel mitte ükski teine isik. 8-14% puudega laste vanematest, kes elavad 3 või enam täiskasvanuga leibkondades, ei aita puudega lapse hooldamisel ükski teine isik.

Kõigi hooldatavate (sh lapsed ning teised hooldatavad) abistamisel või hooldamisel vajab 35–39% kõigist puudega laste vanematest olulist või mõningat lisaabi. Sealjuures mõningat lisaabi vajab 29-33% ning olulist lisaabi vajab 5-7% lapsevanematest.

Kaks kolmandikku (ca 64%) puudega laste vanematest on pidanud lapse hoidmise ja hooldamise tõttu viimase 12 kuu jooksul töö või õpingute osas tegema järeleandmisi. Kõige enam esineb tööga seotud järeleandmisi: rohkem kui ühel korral viimase 12 kuu jooksul on 33-37% puudega laste vanematest pidanud

võtma tööst vabu päevi või tunde, mille peab hiljem tagasi töötama, 24-27% on pidanud võtma hoolduslehe, 14-17% vähendama töökoormust ja 9-11% loobuma üldse tööst.

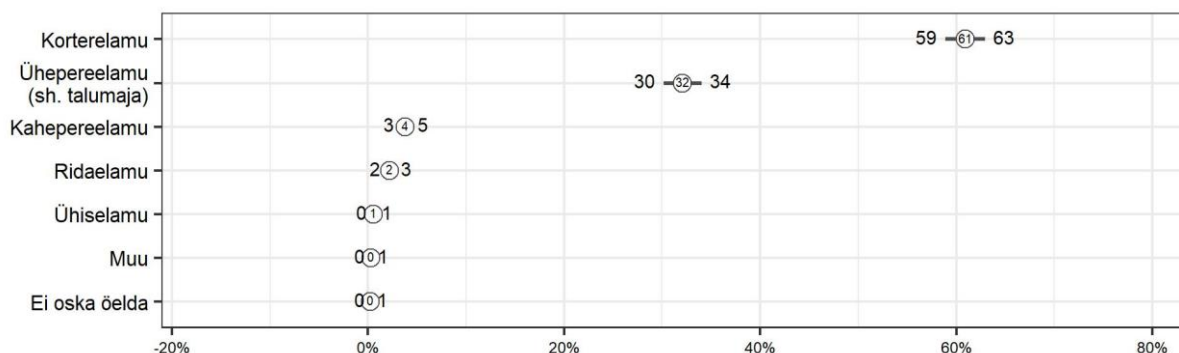
Puudega laste vanematest ligi 80% on viimase 12 kuu jooksul teinud mingit tegevust soovitud vähem. Ligi kolmandik (29-33%) puudega laste vanematest on sageli omanud soovitud vähem aega, et lihtsalt puhata, 27-31% on sageli tegelenud soovitud vähem huvialade, hobide või meelelahutusega ning 25-29% on sageli soovitud vähem veetnud aega koos sõprade ja tuttavatega.

8 Sotsiaal-majanduslik toimetulek

8.1 Eluruum ja selle kohandamisvajadus

Puudega lastega peredest elavad pereelamus 33–39% ja korter- või muus elamus 59–63% (Joonis 161). Võrreldes üldise leibkondade eluruumide jaotusega elavad puudega lastega pered enam pereelamus või ridaelamus. Eestis elas 2016. aastal⁴¹ keskmiselt 31% leibkondadest pere- või ridaelamus. 2009. aastaga võrreldes ei saa välja tuua statistiliselt olulisi erinevusi (pereelamu, kahepereelamu, talumaja või ridaelamu oli elukohaks 34%le puudega lastega peredest ja 64% elasid korterelamus).

Joonis 161. Puudega lastega perede eluaseme tüüp (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Keskmine eluruumi suurus on puudega lastega perekondadel 20,7–24,2 m² elaniku kohta (mediaan 18 m², ülemine kvartiil 45 m² ja alumine kvartiil 25 m²). 2011. aasta rahva- ja eluruumide loenduse põhjal⁴² oli Eestis keskmine eluruumi pind 22,6 m² elaniku kohta peredes, kus oli 0–17-aastaseid lapsi. Seega on puudega lastega perede eluruumide suurus keskmiselt üsna sarnane Eesti lastega perede keskmise eluruumiga.

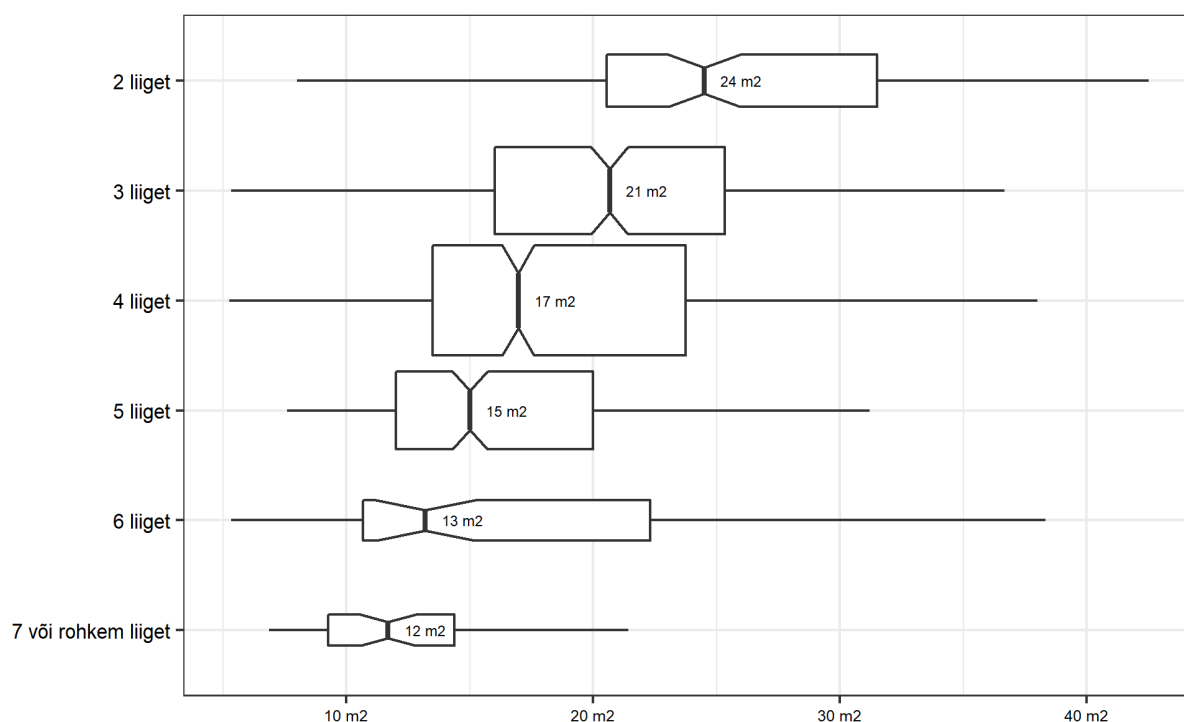
Eluruumi suurus sõltub küllaltki loogiliselt pere suurusest (Joonis 162). Kaheliikmeliste leibkondade puhul on eluruumi mediaansuuruseks ühe elaniku kohta ca 24 m² (23–26 m²). Kui leibkonnas on aga seitse või enam liiget, on mediaanpindala ühe elaniku kohta vaid ca 12 m² (11–13 m²). Pooltel sellistel leibkondadel jääb eluruumi pindala ühe elaniku kohta 9–14 m² vahele.

Leibkonna sissetuleku suuruse järgi eristuvad vaid need, kelle sissetulekud on suuremad kui 2300 eurot. Kui madalama sissetulekuga leibkondade eluruumide suurus ühe leibkonnaliikme kohta jäävad mediaanväärtustena vahemikku 16–19 m², siis kõrgemate sissetulekute korral on see suurus ca 22–29 m².

⁴¹ Statistikaamet, veebiandmebaas, tabel LER011: Leibkonnad - aasta, elukoht ning elamu tüüp (18.10.2017)

⁴² Statistikaamet, veebiandmebaas, tabel RL0807: Asustatud tavaeluruumide keskmine pind ja keskmine tubade arv elaniku kohta, 31. detsember 2011 (24.10.2017)

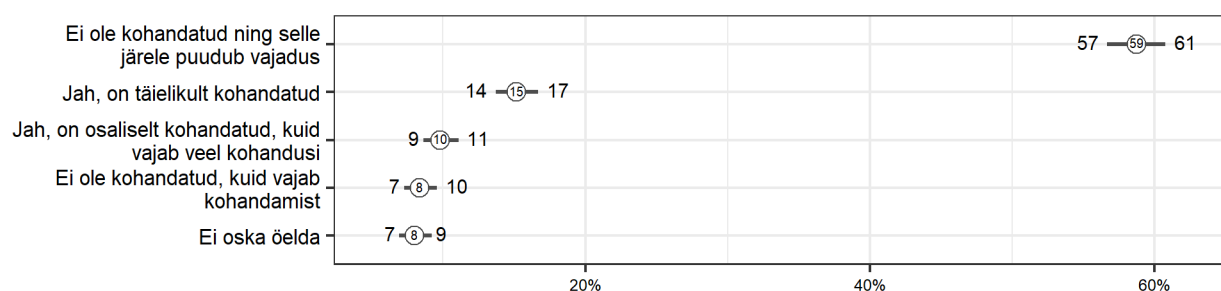
Joonis 162. Eluruumi suurus ühe elaniku kohta leibkonnaliikmete arvude lõikes



Märkus: Kulude suurus on esitatud karp-vurrud diagrammina. „Karbi“ keskel asuv joon tähistab kulude mediaanväärtust, karpide alumine ja ülemine ots vastavalt ülemist (75%) ja alumist (25%) kvartiili. Seega karbi laius tähistab vahemikku, kuhu jääb 50% vaatlusaluste leibkondade kuludest. „Vurrude“ otspunktid tähistavad maksimaalset ja minimaalset väärtust (maksimaalse ja minimaalse väärtusena arvestatakse 1,5-kordset kvartiilide vahet, suuremad väärtused on loetud eranditeks ja jooniselt välja jäetud). Karpide laius tähistab kulu esinemise sagedust. Paksemate karpide puhul esineb antud kulu enam, peenemate karpide puhul vähem. Sälgu laius ümber mediaani tähistab ligikaudset mediaani 95% usaldusintervalli.

Enam kui poolte puudega laste eluruumid on vajadustele vastavad ning ei vaja kohandamist (Joonis 163). Eluruumid on juba vastavaks kohandatud või ei vaja kohandamist 71-78% puudega laste jaoks. Osalist või täielikku kohandamist vajavad 16–21% puudega laste kodud.

Joonis 163. Eluruumi kohandamise vajadus (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

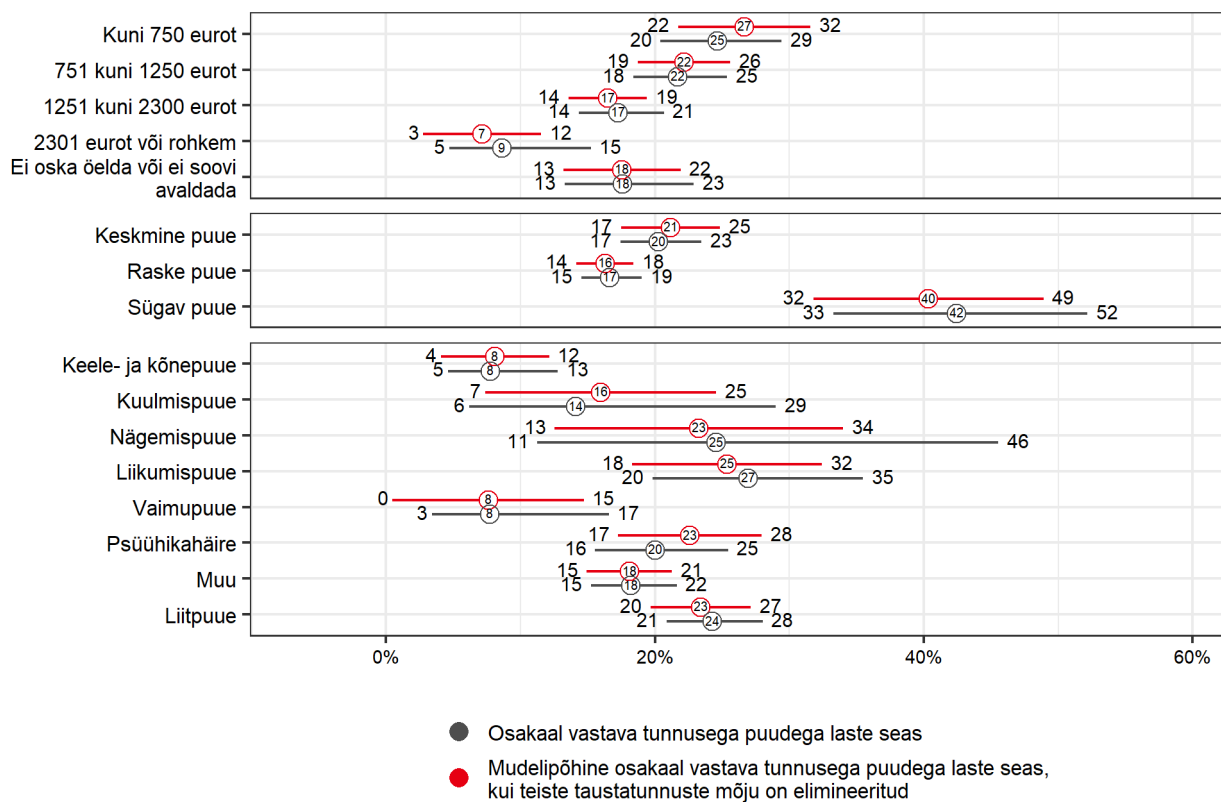
Eluruumide kohandamise vajadusega on seotud puudeliik ja raskusaste ning sissetuleku suurus.

Võrreldes teiste raskusastmetega on suurem selliste laste osakaal, kelle eluruum vajab kohandamist, sügava puudega laste seas (33–52%) (Joonis 164).

Teistest puudeliikidest vähem esineb kodu kohandamise vajadust keele- ja kõnepuude ning vaimupuudega laste seas (vastavalt 5–13% ja 3–17%), kuulmispuudest need siiski ei erine viimase laiade usalduspiiride tõttu.

Vähem on kohendamist vajavaid elusasemeid suurema sissetulekuga puudega lastega peredel (5–15%), kõrgeim osakaal kohendamist vajavaid eluruume on väikseima sissetulekuga perede grupis (20–29%).

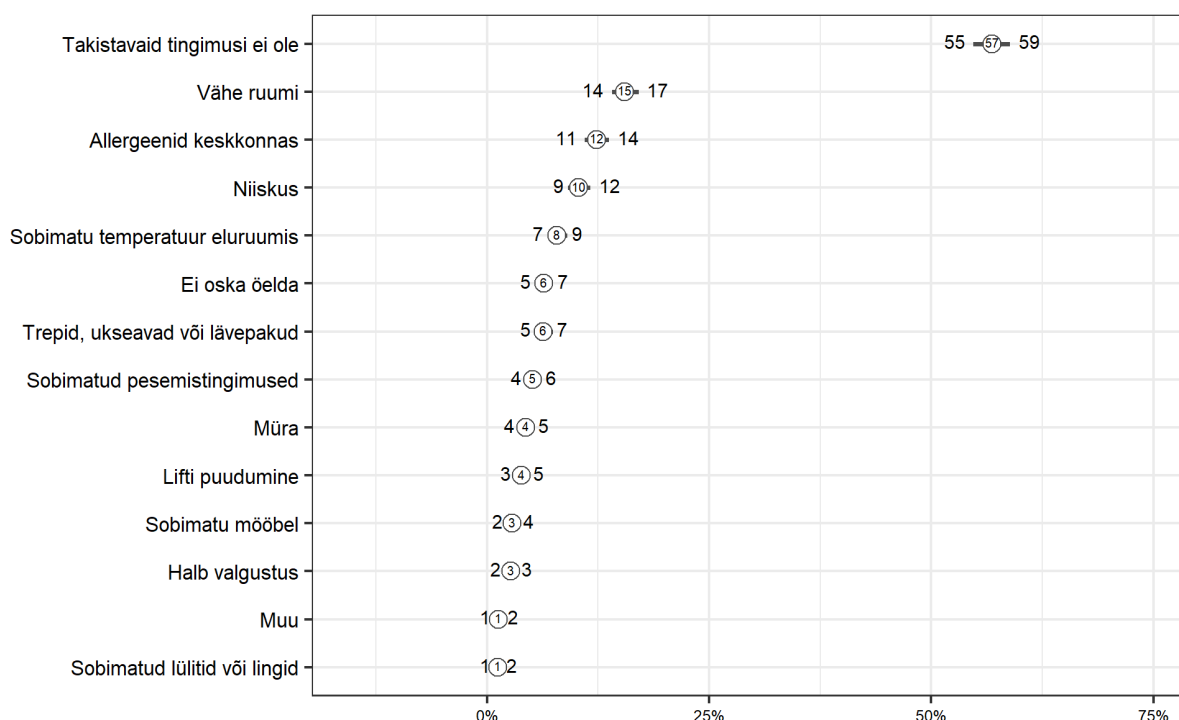
Joonis 164. Puudega laste perede osakaal, kelle eluruum vajab kohendamist



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: eluase vajab kohendamist = 1, eluase ei vaja kohendamist = 0. Hinnangud on 95%liste usaldusintervallidega. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanus, elukoha regioon, elukoha liik, kodune keel, vastaja haridustase, pere netosissetulek, inimeste arv perekonnas.

Eluruumi sissepääsemist või seal igapäevast toimetulekut takistavaid tingimusi ei ole ca 60% puudega laste kodudes (55–59%). Levinuim probleem on eluruumide väiksus (14–17%), pea sama levinud probleemiks on niiskus ja allergeenid keskkonnas (vastavalt 9–12% ja 11–14%) (Joonis 165). Sobimatu temperatuur ja trepid, ukseavad või lävepakud on probleemiks 5–9% puudega lastest. Ülejäänud takistused puudutavad vähem kui 5% puudega lastest.

Joonis 165. Takistused eluruumi sissepääsemisel või igapäevasel toimetulekul (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

2009. aasta küsitluses oli takistuste esinemise järjekord sama, kuid ruumi puuduse töid välja siis 21%, mis on suurem käesoleva küsitluse tulemustest.

Probleemid ruumidesse sissepääsemisel või igapäevatoimingute tegemisel on suurema tõenäosusega liikumispuudega, psüühikahäirega, muu puude või liitpuudega lastel⁴³ (vastavalt 38–56%, 35–47%, 37–45% ja 39–47%), samuti sügava puudega lapsega peredes (45–63%).

Väiksema sissetulekuga peredel (45–55% kuni 750-eurose sissetulekuga peredest) on probleeme suurema tõenäosusega. Vene keelt koduse keelena rääkivad pered märgivad sagedamini (45–55%) kui eestikeelsed (32–37%), et nende eluruumis on lapse igapäevast toimetulekut takistavaid tingimusi.

Ruumiväheesus on sagedamini probleemiks raske ja sügava puude korral (vastavalt 15-20% ja 21-40% vs keskmine puue 9-14%). Veidi sagedasem on see võrreldes muude asulatüüpidega ka Tallinnas (15-24% vs maa-asulates 10-16%), kuid teiste taustatunnuste mõju elimineerides statistiliselt olulist erinevust ei ole. Seos on olemas ka leibkonna sissetuleku ja ruumiväheuse probleemi esinemise vahel: leibkondadest sissetulekuga kuni 750 eurot on ruumiväheesus probleemiks 20-30%le, sissetulekuga 1251-2300 eurot 10-

⁴³ Taustatunnuste lõikes analüüsis on eluruumis esinevad toimetulekut takistavad tingimused analüüsitud gruppide lõikes kasutades selleks logit-mudelit, mille sõltuv muutuja on 1, juhul, kui tingimus esineb eluruumis ja 0 juhul, kui seda ei esine. Üldises probleemide esinemise analüüsis on välja on jäetud need, kes ei osanud öelda, kas neil on takistavaid tingimusi eluruumides, teiste konkreetsete probleemide lõikes on nad arvesse võetud. Andmetest on välja jäetud muud keelt koduse keelena kõnelevad inimesed. Mudelisse lülitatud sõltumatud muutujad on: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanusegrupp, kodune keel, elukoha regioon, elukoha asulatüüp, vastaja haridustase, pere netosissetulek, pereliikmete arv, eluruumi suurus (ruutmeetrit leibkonnaliikme kohta).

15%le ja 2301 või suurema sissetuleku korral 2-11%le. Ruumivähesus on loogiliselt seotud eluruumi suurusega: mida väiksem on eluruum, seda tõenäolisemalt on see probleemiks.

Allergeenid keskkonnas on sagedasem probleem muu puudeliigi korral (21-27%). Sügava ja raske puudega laste seas esineb seda probleemi vähem kui keskmise puudega laste seas (vastavalt 1-8%, 6-9% vs 19-25%). Vanuserühmadest on 7-10-aastastel see veidi sagedasem probleem (13-18%) kui noorematel (0-6-aastastel 8-13%) ja vanematel lastel (11-15-aastastel 10-16%), usalduspiirid ei kattu vaid 16-17-aastaste grupiga (3-10%).

Temperatuuri ebasobivus on samuti sagedasemaks probleemiks muu puudega lastel (9-14%) võrrelduna liitpuude ja psüühikahäirega lastega (5-9% ja 3-9%). Suurema sissetulekuga leibkondades on temperatuuri ebasobivus vähematele probleemiks. Kuni 750-eurose sissetulekuga puudega lapsega leibkondadest on temperatuuri ebasobivus probleemiks 10-16%le, 751-1250-eurose sissetuleku korral 7-11%le, 1251-2300-eurose sissetulekuga leibkondadest 4-8%le ja suurema sissetuleku korral 0-4%le.

Trepid, ukseavad või lävepakud on suurema tõenäosusega probleemiks liikumispuudega (16-30%) ja liitpuudega (9-14%) võrreldes keele- ja kõnepuudega, psüühikahäirega ja muu puudega lastega (vastavalt 0-4%, 1-5% ja 2-4%). Sügava puudega lastel (19-36%) on need probleemiks sagedamini kui raske või keskmise puude puhul (4-7% ja 3-6%). Samuti on kõige nooremal vanuserühmal (7-11%) mõnevõrra suurema tõenäosusega probleeme kui 7-15-aastastel (4-7%).

Sobimatud pesemistingimused on sagedasemaks probleemiks sügava puude korral (10-24%). Eesti keelt koduse keelena kõnelevad pered toovad seda probleemi välja sagedamini kui vene keelt koduse keelena kõnelevad (vastavalt 5-7% vs 2-5%).

Lifti puudumine on samuti suuremaks probleemiks sügava puude puhul (14-29%). Linnalistes asulates on lifti puudumine sagedasem probleem kui maa-asulates (Tallinnas 3-8%, muudes linnalistes asulates 4-7% ja maa-asulates 0-2%). Lapse vanuse kasvades see probleem väheneb: 7-10 ja 11-15-aastaste vanusegruppide seas on probleem vähem levinud (2-5% ja 1-4%) kui 0-6-aastaste seas (5-9%). 16-17-aastaste kohta ei saa laiade usalduspiiride tõttu statistiliselt olulist tulemust välja tuua.

Mööbli sobimatus on 16-17-aastastel lastel (4-13%) sagedasem probleem kui noorematel (kõigis gruppides jääb vahemikku 1-4%).

Halb valgustus on teistest puudeliikidest sagedasem probleem nägemispuudega lastel (3-28%).

Sobimatute lülitite või linkide, müra ja niiskuse osas statistiliselt olulisi erinevusi gruppide lõikes ei esine.

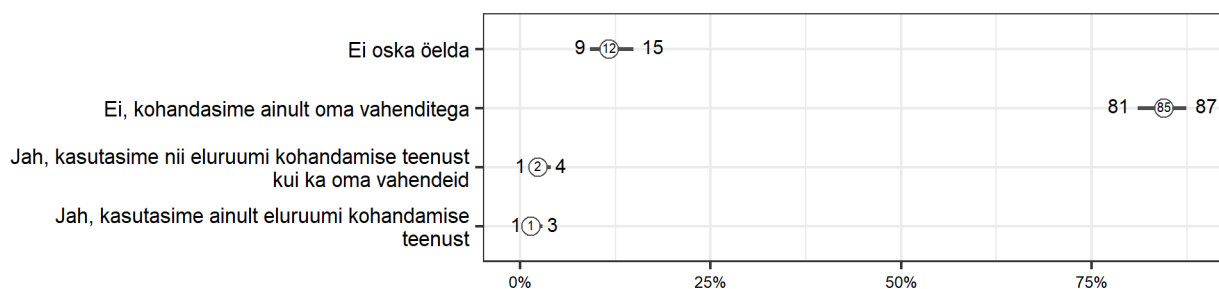
Vastajatel, kelle hinnangul leibkonna eluruum vajab kohandamist, paluti kirjeldada, mida on vaja kohandada, et eluruum vastaks puudega lapse erivajadustele. Kohandamist vajavana nimetati sagedamini:

1. Pesemisvõimalusi ja WC-d
2. Ventilatsiooni ja mikrokliimat
3. Eraldi tuba lapsele

Lisaks toodi välja ka kõikvõimalikke muid kohandamist vajavaid eluruumi osi nagu trepp, lift, kaldtee, põrandad, lävepakud, soojustus või küttesüsteem, piirded, toed, käsipuud, müratõke, valgustus, mööbel. Samuti on leibkondi, kellele on vaja üldisemalt suuremaid ruume või üldremonti kõikides ruumides.

Elukohti, mis on osaliselt või täielikult kohandatud vastavaks puudega laste vajadustele (kõikidest puudega laste elukohtadest 23-28%, vt Joonis 163), on kohandatud valdavalt perede endi finantsidega (81-87% kohandatud elukohtadest, vt Joonis 166). Kohandatud elukohtadest 1-4% on kohandatud vähemalt osaliselt eluruumi kohandamise teenust kasutades. Seejuures ainult eluruumi kohandamise teenust on kasutanud vaid 1-3% peredest, kus kohandamisi on tehtud.

Joonis 166. Eluruumi kohandamise teenuse kasutamine (% kohandatud eluruumidega puudega laste peredest)

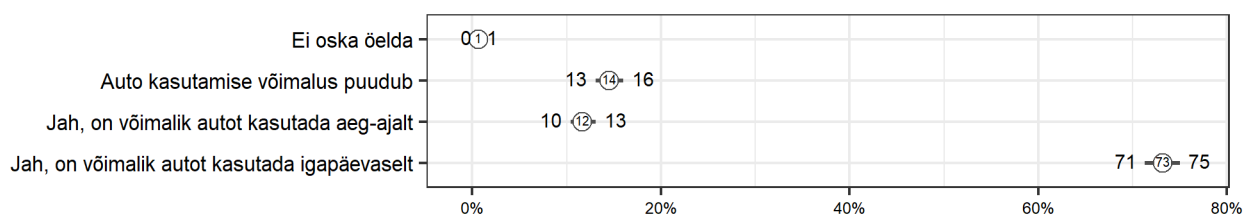


Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

8.2 Auto kasutamise võimalus

Auto kasutamise võimalus on puudega laste perekondadest igapäevaselt 71–75%l ja aeg-ajalt 10–13%l (Joonis 167). Auto kasutamise võimalus puudub 13–16%l puudega laste perekondadest. Auto kasutamise võimaluse küsimus ei ole 2009. aastaga otseselt võrreldav. 2009. aastal oli auto kasutamise võimalus 73%l (GfK. 2009: 80), kuid siis ei küsitud kasutamise ajalisi võimalusi.

Joonis 167. Auto kasutamise võimalus (% puudega laste peredest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Eestis keskmiselt oli 2016. aastal auto kasutamise võimalus 83%⁴⁴lastega peredest. Seega on puudega lastega pered selles osas küllaltki sarnased Eesti keskmisega.

Auto kasutamise võimalus on muude samade tingimuste korral vähematel madalama haridusega, madalama sissetulekuga ja linnades elavatel puudega lastega leibkondadel.

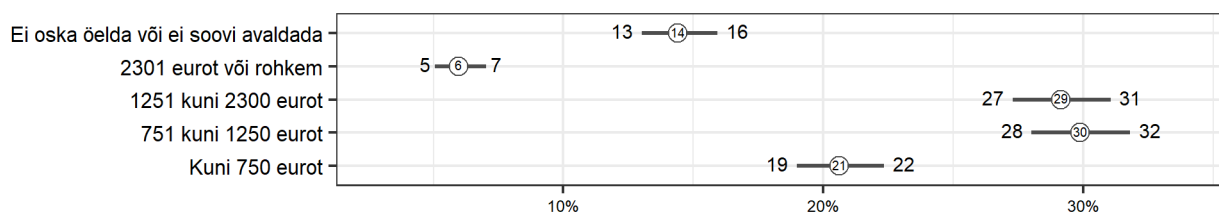
8.3 Sissetulekud ja kulutused

8.3.1 Pere sissetulekud, toetused ja üldine hakkamasaamine

Puudega lastega peredest 19–22% peavad kuus toime tulema 750 euro või vähemaga, ca veerand kuni kolmandik on peresid, kelle sissetulek on 751–1250 ja 1251–2300 eurot kuus. 2300 eurost enam on sissetulek 5–7%l peredest (Joonis 168).

⁴⁴ Statistikaamet veebiandmebaas, tabel LET209: Leibkonnad – aasta, leibkonnatüüp ning püsikaup. (25.10.2017)

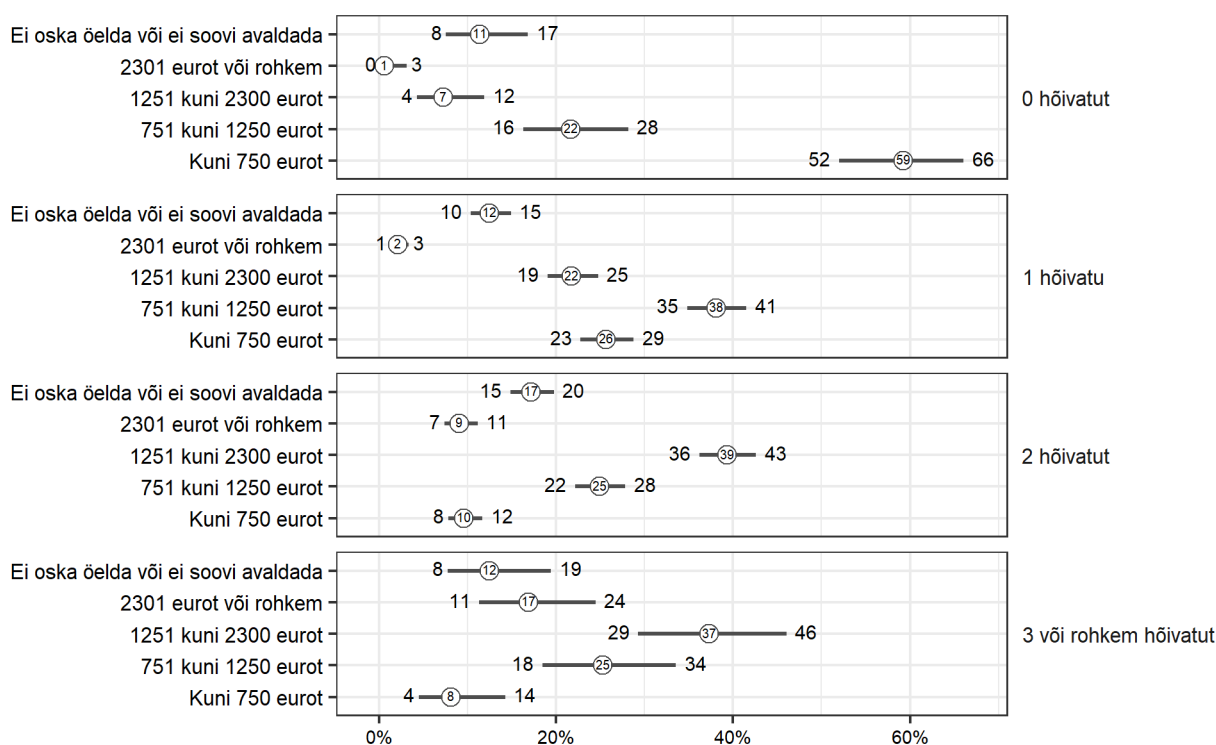
Joonis 168. Puudega lastega perede netosissetulek kuus (% puudega lastega peredest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Ilmne on seos töötavate inimeste arvu ja pere sissetuleku vahel: kui peres on rohkem töötavaid inimesi, on ka sissetulekud suuremad (Joonis 169). Ühegi hõivatuta leibkondadest enam kui poolte kogusissetulek jääb alla 750 euro. Kahe hõivatuga leibkondades on vastav osakaal ca 10%.

Joonis 169. Puudega lastega perede netosissetulek kuus leibkonna hõivatute arvu lõikes (% alagrupi lõikes)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Järgnevalt vaatame nii puudega lastele suunatud toetusi kui ka muid toetusi, mida leibkonnad saavad. Nii nagu sotsiaalteenused jagunevad riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandi vahel, jagunevad ka puudega lastele antavad rahalised toetused kahele tasandile. Puudega lastel vanuses 0–15 a on õigus saada puudega lapse toetust. Kui laps saab 16-aastaseks, siis saab ta puudega tööealise inimese toetust. Samuti on sellises vanuses võimalik saada õppetootust juhul, kui laps õpib gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis, täiendkoolitustoetust ja töövõimetoetust, kui on tuvastatud töövõimekadu. Lapsetoetust, mis pole seotud puudega, saavad Eestis kõik pered kuni lapse 16-aastaseks saamiseni ja lapse õppimise korral kuni tema 19-aastaseks saamiseni (sh jooksva õppeaasta lõpuni ka 19-aastaselt).

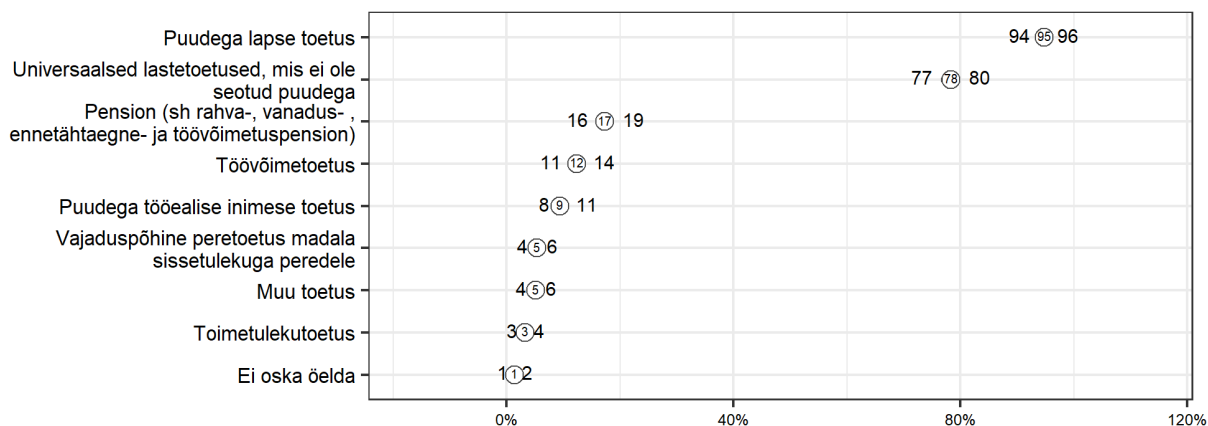
Lisaks nimetatud riiklikele toetustele on kohustus oma piirkonnas elavaid inimesi aidata kohalikul omavalitsusel. KOVid kehtestavad toetused ise ning nende suurus, taotlemise kord ja tingimused erinevad seetõttu omavalitsuseti. Enamasti on omavalitsustel olemas puudega lapse hooldaja toetus, mille alusel

makstakse hooldajate eest sotsiaalmaksu ja mis annab hooldajatele ravikindlustuse. Kohalikud omavalitsused maksavad puudega lastele ja nende peredele ka muid toetusi, lähtudes kuulumisest vastavas sihtgruppi (Kriisk 2012). Ühekordsete toetustena, mida kohalikud omavalitsused maksavad sissetulekutest ja vajadustest sõltumatult, makstakse puudega inimestele näiteks sünnipäevatoetust, jõulutoetust jms. Lisaks nimetatud rahalistele toetustele on puudega lastele kehtestatud muid soodustusi, millest puudub terviklik ülevaade: nt soodustused muuseumide ja kultuuriürituste külastamisel, ühistranspordi kasutamisel jmt.

Pea kõik puudega lastega leibkonnad saavad puudega lapse toetust (Joonis 170). Universaalseid lastetoetusi, mis ei ole seotud puudega, saab ca 77–80% leibkondadest. Siinkohal on tegemist üllatava tulemusega, kuna universaalset lastetoetust peaksid saama kõik 0-15-aastased lapsed ja 16-19-aastased õppivad noored. Mõnevõrra mõjutab tulemust 16-17-aastaste puudega laste grupp, kelle hulgas on neid, kes ei õpi ja seega universaalset lastetoetust ei saa. 16-17-aastaste seas on universaalseid lastetoetusi saavate osakaal 50-66%, nooremate laste puhul jääb see osakaal vahemikku 75-84%. Kuna ka 0-15-aastaste seas on universaalseid lastetoetusi saavate osakaal ootuspärasest madalam, on põhjus ilmselt selles, et lapsevanemad ei mõistnud, mida universaalsete lastetoetuste all silmas peetakse.

Teiste uuringus käsitletud toetuste puhul on nende saajate osakaal vähem kui 20% puudega lastega leibkondadest (Joonis 170).

Joonis 170. Puudega lastega leibkondade saadavad toetused (% puudega lastega leibkondadest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Lisaks etteantud toetuste loetelule tõid vastajad välja ka muid leibkonna poolt saadavaid toetusi. Nende hulgas nimetati järgnevaid: alimendid, elatisraha, toitjakaotuspension, paljulapselise pere toetus, üksikvanematoetus, tugiisiku toetus ja lapsehoiutoetus, koduse lapse toetus, hooldajatoetus, KOV transporditoetus, KOVi emadepäeva- või jõulutoetus, õppetootus, stipendium ülikoolist, vanemahüvitis, töötuskindlustushüvitis ja töötuebiraha.

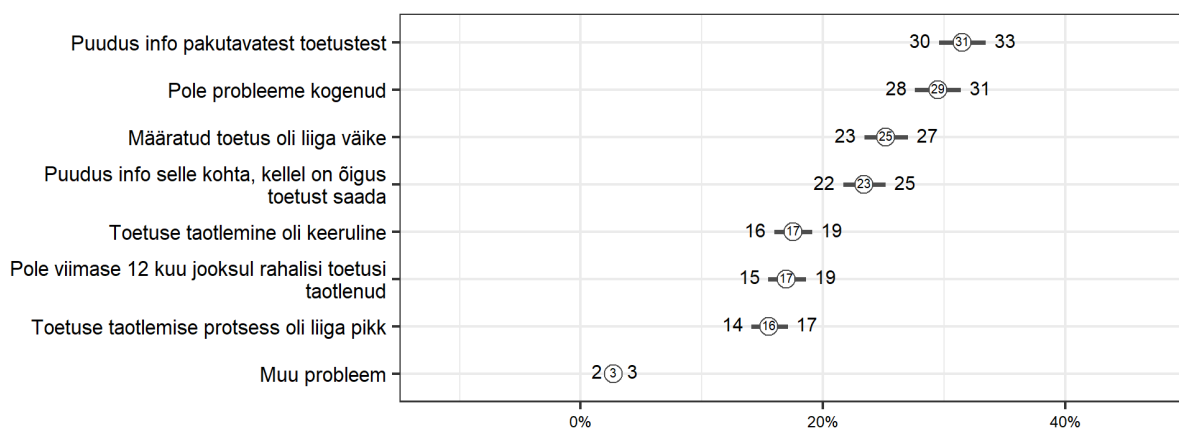
Toetuste taotlemisel esinevaid probleeme kaardistati käesolevas uuringus aga ainult puudega lastele suunatud rahaliste toetuste kohta. 15-19%le puudega lastest ei ole viimase 12 kuu jooksul rahalisi toetusi taotletud (Joonis 171). Probleemideta on rahaliste toetuste taotlemine viimase 12 kuu jooksul olnud 28-31% puudega laste jaoks. Seega on probleeme sotsiaaltoetuste taotlemisel viimase aasta jooksul esinenud umbes pooltel puudega lastest.

Toetuste taotlemisel on levinuimaks probleemiks infopuudus (Joonis 171). Kolmandiku (30-33%) puudega laste toetuste taotlemisel on olnud probleemiks info puudumine olemasolevate toetuste kohta. Ligi

neljandiku (23-27%) jaoks on olnud probleemiks, et määratud toetus oli liiga väike ja pea sama paljudele (22-25%) jaoks on olnud probleemiks selgusetus, kellel on õigus toetustele.

Keeruline ja pikk toetuste taotlemise protsess on olnud probleemiks väiksemale osa puudega laste vanematele (vastavalt 16-19% ja 14-17%).

Joonis 171. Viimase 12 kuu jooksul kogetud probleemid rahaliste toetuste taotlemisel



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Üle 7-aastaste puudega laste vanuserühmades on toetusi taotletud veidi väiksema osa vanemate poolt kui muude samade taustatunnustega noorema vanuserühma puhul⁴⁵. See on tõenäoliselt seotud toetuste taotlemise korralduse ja puude ajalise kestusega.

Rühmad, kellel on veidi suurema tõenäosusega probleeme toetuste taotlemisel, kui muude taustatunnuste mõju on elimineeritud, on järgmised: Põhja-Eestis elavad puudega lapsed võrrelduna Kesk- ja Lõuna-Eestiga ning liitpuudega lapsed võrrelduna keele- ja kõnepuudega lastega, 16-17-aastastel võrrelduna 0-6 ja 11-15-aastastega. 16-aastaselt muutuvad sotsiaaltoetused, millele puudega lapsel on õigus. Puudega lapse toetuse asemel tekib õigus puudega tööealise inimese toetusele, mis on madalam kui puudega lapse toetus⁴⁶. Samas tekib võimalus töövõimekao tuvastamiseks ning töövõimekao korral töövõimetoetusele, samuti õppetoetusele. Seega toimub 16-aastaselt puudega lapse toetamise süsteemis oluline muutus, mistõttu on ka probleemid tõenäoliselt veidi sagedasemad.

Süsteemaaliselt ei joonistu välja sihtrühmi, kelle jaoks oleks kõik probleemid sagedasemad kui teistele. Erinevate probleemide osas ilmneb üksikuid sihtrühmi, kelle jaoks on tegemist suurema probleemiga.

Näiteks **madalaid toetusi** peavad vähem probleemiks vaimupuudega laste pered (8-24%). Kui taustatunnuste mõju elimineerida, siis on see vähem probleemiks ka Tallinnas elavate puudega laste puhul (osakaal, kui taustatunnuste mõju on elimineeritud: 15-25%).

⁴⁵ Toetuste probleemid gruppide kaupa on välja toodud logit-mudeli põhjal, kus sõltuv muutuja on üks, kui F01 küsimuse alaküsimuse vastus on valitud. Sõltumatud muutujad on järgmised: puude liik, puude raskusaste, lapse vanus, rehabilitatsiooniplaani olemasolu, elukoha regioon, asula tüüp, pere sissetulek, vastaja haridustase.

⁴⁶ Puudega lapse toetus on 2017. aastal keskmise puude raskusastme korral 69,04 eurot kuus, raske ja sügava puude korral 80,55 eurot kuus. Tööealise inimese puude toetus on 28,64-53,7 eurot kuus.

Toetuste taotlemise **pikka protsessi** märgivad vene keelt koduse keelena kõnelevad inimesed harvem (10-15%) kui eesti keelt kõnelevad (15-19%). Nende seas, kellel on rehabilitatsiooniplaan, on seda probleemi maininud inimesi rohkem (15-19%) kui nende seas, kellel rehabilitatsiooniplaani pole (6-13%).

Taotlemise **keerukat protsessi** on maininud sagedamini eesti keelt kõnelevad inimesed (19-23%) võrreldes vene keelt koduse keelena (6-11%) kõnelevatega ja need, kellel on rehabilitatsiooniplaan (17-20%).

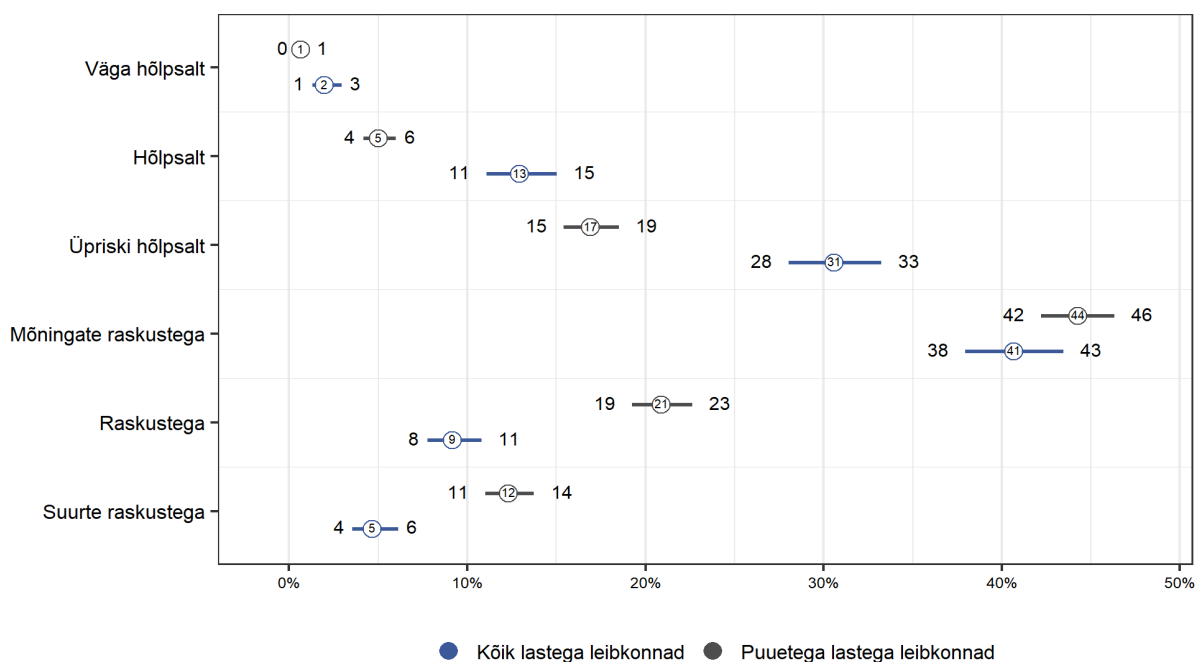
Probleeme **teadlikkusega toetuste saamise õiguse kohta** esineb rohkem kodus vene keelt kõnelevate seas (25-33%) võrreldes eestikeelsetega (19-23%).

Analüüsid, milline on seos probleemi „**puudus info pakutavatest toetustest**“ märkinute ja taustatunnuste vahel, eristusid olulisel määral liitpuudega (35-42%) laste vanemad, kellel on toetuste taotlemisel info-puudus probleemiks sagedamini võrreldes muu ja vaimupuudega laste vanematega (vastavalt 22-29% ja 17-37%).

Kokkuvõttes on puudega lastele suunatud rahaliste toetustega probleeme olnud ligikaudu pooltel puudega laste peredel ning enimlevinud probleemiks on infopuudus. Infopuudus tuleneb osaliselt ka puudega laste toetamise süsteemist, mis on killustunud riigi ja kohaliku omavalitsuse ning paljude erinevate eriotstarbeliste toetuste vahel. Tegemist ei ole mingis kindlas sihtrühmas, vaid kõikide puudega lastega perede seas sarnase tõenäosusega esineva probleemiga.

Majanduslikku toimetulekut puudega lastega leibkondades on võrreldud kõigi Eesti leibkondadega, kus on 0–17-aastaseid lapsi. Võrreldes kõikide lastega leibkondadega hinnatakse puudega lastega leibkondades oma majanduslikku toimetulekut keerulisemaks sagedamini (Joonis 172). Puudega laste leibkondadest 11–14% tuleb enda hinnangul oma igapäevaste kulutustega toime suurte raskustega (kõikide lastega leibkondade hulgas on vastav osakaal 4–6%) ja ligi 19–23% leibkondadest raskustega (kõikide lastega leibkondade hulgas on vastav osakaal 8-11%) toime. Väga hõlpsalt tuleb ots-otsaga kokku vaid kuni 1%, hõlpsalt ligi 4–6% ja üpriski hõlpsalt 15–19% puudega laste leibkondadest (kõikide lastega leibkondade hulgas on vastavad osakaalud 1-3, 11–15 ja 28–33%). Seega puudega lastega leibkondadest tajub vaid 19–26%, et tuleb hõlpsalt toime (sh vastusevariandid „üpriski hõlpsalt“, „hõlpsalt“, „väga hõlpsalt“). Tavaleibkondade hulgas on vastav osakaal 40–51%.

Joonis 172. Kas leibkond tuleb vajalike kulutuste tegemisel ots-otsaga kokku? (% kõigist lastega leibkondadest⁴⁷ ja % puudega lastega leibkondadest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Elimineerides teiste taustatunnuste mõju, osutub perekonna toimetulekule hinnangu andmisel kõige mõjuvamaks faktoriks (kui leibkonna otsene sissetulek kõrvale jätta) hõivatute arv leibkonnas (Joonis 173). Enam kui poolte (59–71%) ühegi hõivatuta leibkondades elavate puudega laste vanemad leiavad, et tulevad vajalike kulutuste tegemisel ots-otsaga kokku raskustega või suurte raskustega. Mida enam on peres puudega lapsi, seda raskemaks hinnatakse toimetulekut (samas laste koguarv olulist mõju ei avalda).

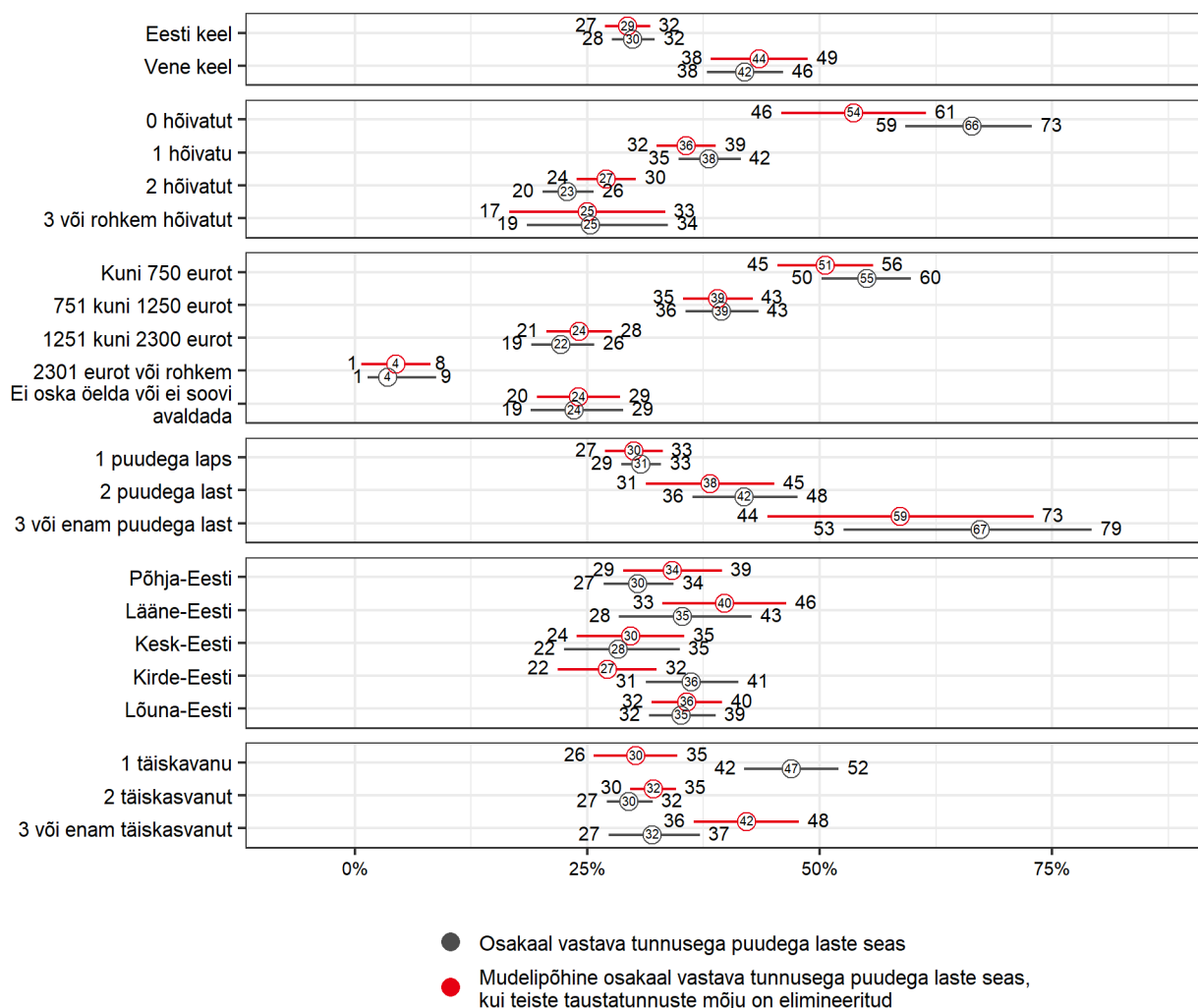
Venekeelsete leibkondade seas on hinnangud toimetulekule võrreldes eestikeelsetega oluliselt negatiivsemad (vastavalt 38–46% ja 28–32%).

Piirkondlike erisuste mõju toimetulekule on aga minimaalne. Vaid Lõuna- ja Lääne-Eestis (võrreldes Kirde-Eestiga) on mõnevõrra enam leibkondi, kes hindavad oma toimetulekut raskemaks.

Tähelepanuväärne on ka asjaolu, et täiskasvanute arv leibkonnas, teiste tunnuste mõju elimineerimisel, ei ole toimetuleku aspektist olulise tähtsusega. Seega näiteks üksikvanematega leibkonnad ei hinda oma toimetulekut oluliselt halvemaks (jättes aga teiste taustatunnuste mõju elimineerimata, oleks ühe täiskasvanuga leibkondade hinnangud oluliselt kehvemad). See viitab sellele, et täiskasvanute arv leibkonnas mõjutab toimetulekut läbi muude taustatunnuste, eeldatavalt eeskätt läbi sissetuleku.

⁴⁷ Eesti sotsiaaluuring 2016

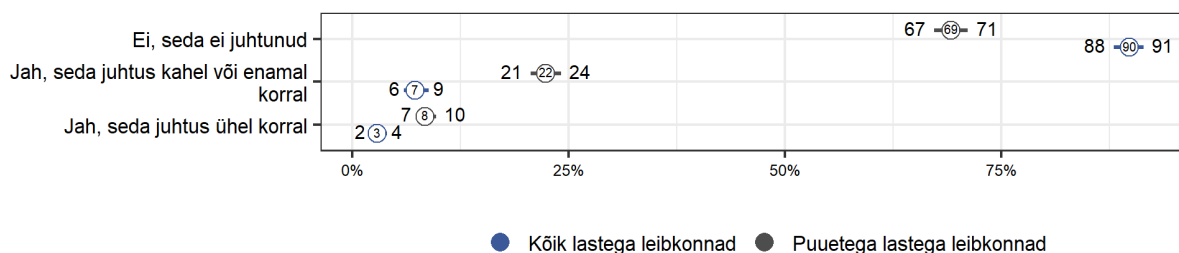
Joonis 173. Puudega laste leibkonnad, kes tulevad vajalike kulutuste tegemisel ots-otsaga kokku raskustega või suurte raskustega.



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud muu koduse keelega vastajad. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Hinnangud on 95%liste usaldusintervallidega. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanus, elukoha regioon, elukoha liik, kodune keel, hõivatute arv perekonnas, puudega laste arv perekonnas, täiskasvanute arv perekonnas, laste arv perekonnas, leibkonna sissetulek.

Võrreldes kõikide lastega leibkondadega tunnistab puudega lastega leibkondadest märksa suurem osa, et on kogenud probleeme jooksvate arvetega maksimisega (Joonis 174). Ligi 28–35% puudega lastega leibkondadest ei suutnud viimase aasta jooksul ühel või enamal korral maksta eluaseme kommunaalkulusid (lastega tavaleibkondade hulgas oli vastav osakaal 8–13%).

Joonis 174. Kas viimase 12 kuu jooksul juhtus, et leibkond ei suutnud majanduslikel põhjustel maksta eluaseme kommunaal-makseid? (% kõigist lastega leibkondadest⁴⁸ ja % puudega lastega leibkondadest)



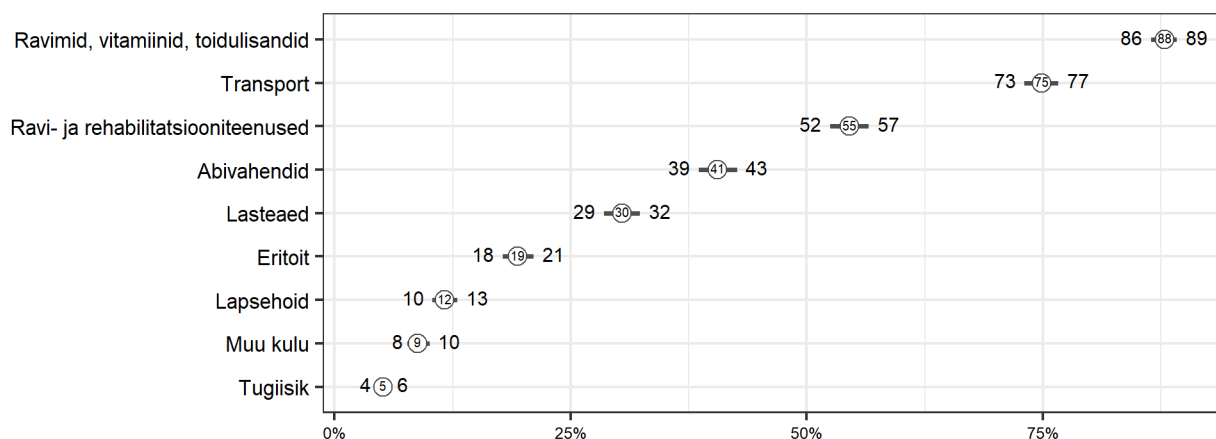
Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

8.3.2 Puudega laste tarbeks tehtud kulutused ja nende katmine

8.3.2.1 Kulude liigid

Ühtegi uuringus käsitletud kulutust puudega lapse tarbeks pole viimase 12 kuu jooksul olnud vaid 2% puudega lastega leibkondadel. Sagedamini esinev puudega lapse tarbeks tehtud kulutus on ravimitele, vitamiinidele ja toidulisanditele (86–89%). Transpordikulused on ca kolmel neljandikul leibkondadest (73–77%) ja ravi- ning rehabilitatsioonikulused veidi enam kui pooltel (52–57%) (Joonis 175).

Joonis 175. Puudega lapse tarbeks tehtud kulude esinemine leibkonnas (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire.

Ravimitele, vitamiinidele ja toidulisanditele on kulutusi kõikide puudeliikide lõikes. Kulused ravimitele, toidulisanditele ja vitamiinidele on keele- ja kõne- ning kuulmispuudega (vastavalt 68–81% ja 52–80%) lastest veidi sagedamini olnud liikumis- ja liitpuude ning psüühikahäirega laste seas (vastavalt 85–94%, 84–89%, 78–87%). Muu puudega lastest on koguni pea kõikidel (96–99%) sellised kulud olnud.

⁴⁸ Eesti sotsiaaluuring 2016

Transpordiga seotud kulused, mis tulenevad lapse puudest, esineb teistest veidi enam liikumispuudega lastel (81–92%)⁴⁹. Samuti on väiksemate lastega peredel (0–6-aastaste vanusegrupp: 76–82%) suurema tõenäosusega kulutusi transpordile kui 11–15-aastastel (65–72%). Võrrelduna Tallinnaga (52–62%) esineb kulused rohkematel teistes Eesti linnalistes asulates (72–78%) ja veelgi rohkematel maa-asulates (81–87%). Juhul, kui auto kasutamise võimalus peres puudub, siis on kulutusi transpordile tehtud väiksema tõenäosusega (51–62%). Kulused transpordile on olnud Lääne- ja Kesk-Eestis elavatel (vastavalt 79–90% ja 79–89%) puudega laste peredel suurema tõenäosusega kui teistes Eesti regioonides.

Ravi- ja rehabilitatsiooniteenuste kulused esineb kuulmis- ja nägemispuudega laste hulgas vähematel (vastavalt 22–52% ja 20–56%) kui näiteks keele- ja kõnepuude ning liikumispuudega laste hulgas (50–64% ja 56–72%).⁵⁰ Keskmise puudega lastel on kulused ravi- ja rehabilitatsiooniteenustele olnud suurema tõenäosusega (55–62%) kui raske puudega lastel (49–54%). Antud kulused on noorematel lastel (57–65%) suurema tõenäosusega kui vanematel lastel, oluline erinevus on vaid 11–15-aastaste vanusegrupiga (47–54%). Vene keelt koduse keelena rääkivatest puudega laste peredest on teinud kulutusi ravi- ja rehabilitatsiooniteenustele suurem osa (57–65%) kui eesti keelt koduse keelena rääkivatest peredest (49–54%).

Abivahenditele⁵¹ kulutusi teinute osakaal on kõrgem sügava puudega lastega perede hulgas (62–78%). Kuulmis- ja nägemispuudega lastest on abivahendite kulused olnud viimase 12 kuu jooksul ca 60–90%, liikumispuudega lastega peredest pooltel kuni kahel kolmandikul (50–68%), muu puude ja liitpuudega laste peredel ca pooltel (vastavalt 38–46% ja 43–51%) ja ülejäänud puudeliikide korral vähematel.

Lasteaiale⁵¹ tehtavad kulutused on kõige enam seotud laste vanusega. Juhul, kui laps on koolieelik, siis on lasteaia seotud kulused 77–83%l peredest, 7–10-aastaste puhul 19–25%l ja vanematel lastel on selliste kulutuste tekkimine väga vähe tõenäoline. Seos puude raskusastmega puudub, kuid kui elimineerida muude taustatunnuste mõju, ilmneb selge seos puude raskusastmega: sügava puudega lastel on vähem kulutusi lasteaiale kui raske puudega lastel ja keskmise puudega lastel omakorda on kulutusi rohkem kui raske puudega lastel. Elimineerides muude taustatunnuste mõju ilmneb, et Tallinnas elavatel peredel on suurem tõenäosus, et esinevad kulutused lasteaiale, korrigeerimata osakaalude põhjal erinevusi taas ei ilmne.

Eritoidule⁵¹ on olnud kulused raske ja sügava puudega lastel suurema tõenäosusega võrrelduna keskmise puudega lastega, kuid taoline seos ilmneb vaid siis, kui muude taustatunnuste mõju on elimineeritud. Muu puudega lastel on selliseid kuluseid tõenäolisemalt (26–34%). Maa-asulates elavatel peredel on kulused puudega lapse eritoidule olnud veidi väiksema tõenäosusega (13–19%).

Lapsehoiule⁵¹ on analoogselt lasteaia kulud suurema tõenäosusega nooremate lastega peredel, kuid erinevused pole suured: 0–6-aastaste puhul on kulused 14–21%l ja 11–15-aastaste puhul 4–8%l lastega

⁴⁹ Sõltuv muutuja: puudega lapse tarbeks tehti kulutusi = 1, puudega lapse tarbeks ei tehtud kulutusi, ei oska öelda, kas olid või ei soovi avaldada, kas kulud olid = 0. Hinnangud on 95%-liste usaldusintervallidega. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanus, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, auto kasutamise võimalus.

⁵⁰ Sõltuv muutuja: puudega lapse tarbeks tehti kulutusi = 1, puudega lapse tarbeks ei tehtud kulutusi, ei oska öelda, kas olid või ei soovi avaldada, kas kulud olid = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanus, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, auto kasutamise võimalus, kodune keel, pere netosissetulek ja inimeste arv peres.

⁵¹ Sõltuv muutuja: puudega lapse tarbeks tehti kulutusi = 1, puudega lapse tarbeks ei tehtud kulutusi, ei oska öelda, kas olid või ei soovi avaldada, kas kulud olid = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanus, elukoha regioon, elukoha asula tüüp, pere netosissetulek ja inimeste arv peres.

peredest. Sügava ja raske puudega lastel on kulusid lapsehoiule olnud tõenäolisemalt (vastavalt 11–25% ja 11–15%) kui keskmise puudega lastel (6–10%). Mida suurem on perekonna sissetulek, seda suurem on olnud ka tõenäosus lapsehoiu kulutuste tegemiseks viimase 12 kuu jooksul (nt kuni 750 eurose sissetulekuga perede grupid on lapsehoiuteenusega seotud väljaminekuid 6–11% ja üle 2 301 eurose sissetulekuga perede gruppis 17–31%).

Tugiisikule⁵¹ on kulutusi teinud suurema tõenäosusega pered, kelle sissetulek on olnud enam kui 2 301 eurot kuus (9–21%). Samuti on selliseid kulutusi sügava ja raske puudega lapsega peredel enam kui keskmise puudega lapsega peredel (5–15% ja 6–9% vs 1–2%). 7–10-aastaste laste puhul on tugiisikule tehtud kulud veidi tõenäolisemad (6–10%) kui vanema (3–6%) ja noorema (3–6%) vanusegrupi puhul.

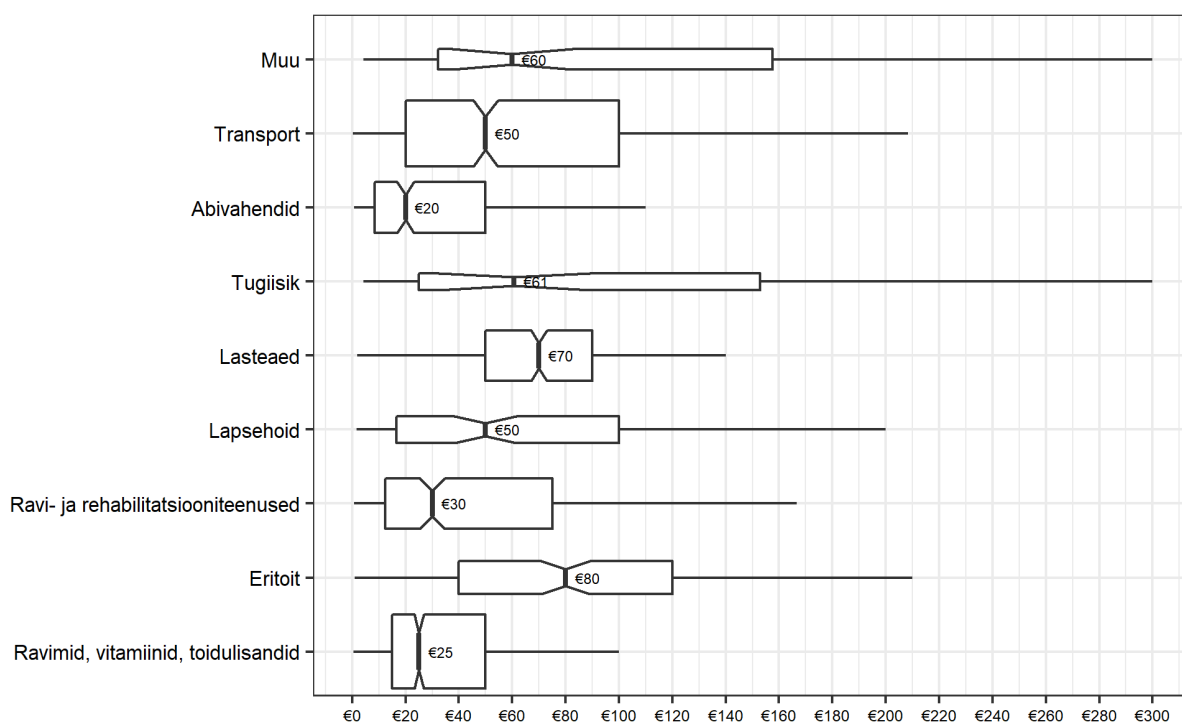
Muude kulude all nimetati järgmisi üldisemaid kategooriaid:

1. Spetsiaalsed riided ja jalatsid
2. Huvitegevus, huviharidus, trennid ja sportimine
3. Erikooli õppemaks
4. Eraõpetaja vajadus
5. Hooldusvahendid ja kodukeemia
6. Parkimine
7. Raviotstarbelised reisirid
8. Elamiskulud, mis kaasnevad raviga kodust kaugel

8.3.2.2 Kulude suurus

Puudega lapse tarbeks on tehtud kõige rohkem kulutusi eritoidule (mediaankulu 80 eurot), jäädes 50% puudega laste leibkondade jaoks (kellel antud kulusid on) vahemikku 40–120 eurot (Joonis 176). Kulud lasteaiale jäävad 50% puudega laste leibkondade jaoks vahemikku 50–90 eurot (mediaan 70 eurot). Kõige varieeruvamad on kulud tugiisikule (jäädes 50% vastavate kuludega leibkondade jaoks vahemikku 25–156 eurot) ja muud kulud (jäädes vahemikku 32–157 eurot). Antud kulutuste maksimaalsed suurused ulatuvad aga ligi 300 euronit kuus. Kõige vähem varieeruv, aga samas kõige enam esinev (vt. Joonis 175) on kulu ravimitele, vitamiinidele ja toidulisanditele, jäädes 50% leibkondade puhul vahemikku 15–50 eurot kuus. Eelnevaga küllaltki sarnane on muster abivahendite kulude osas (kuigi abivahendeid on vaja mõnevõrra vähemal lastel). Ka transpordile tehtavad kulutused on vajalikud suuremale osale puudega lastest. Kuised transpordikulud jäävad pooltel leibkondadel 20 ja 100 euro vahele, samas maksimaalsed kulud ulatuvad ligi 200 euronit. Lapsehoidjale tehtavad kulutused võivad samuti kühmuda ligi 200 euronit kuus, samas 75% leibkondade jaoks jäävad need siiski alla 100 euro.

Joonis 176. Puudega laste tarbeks tehtud kulutuste suurused kuus

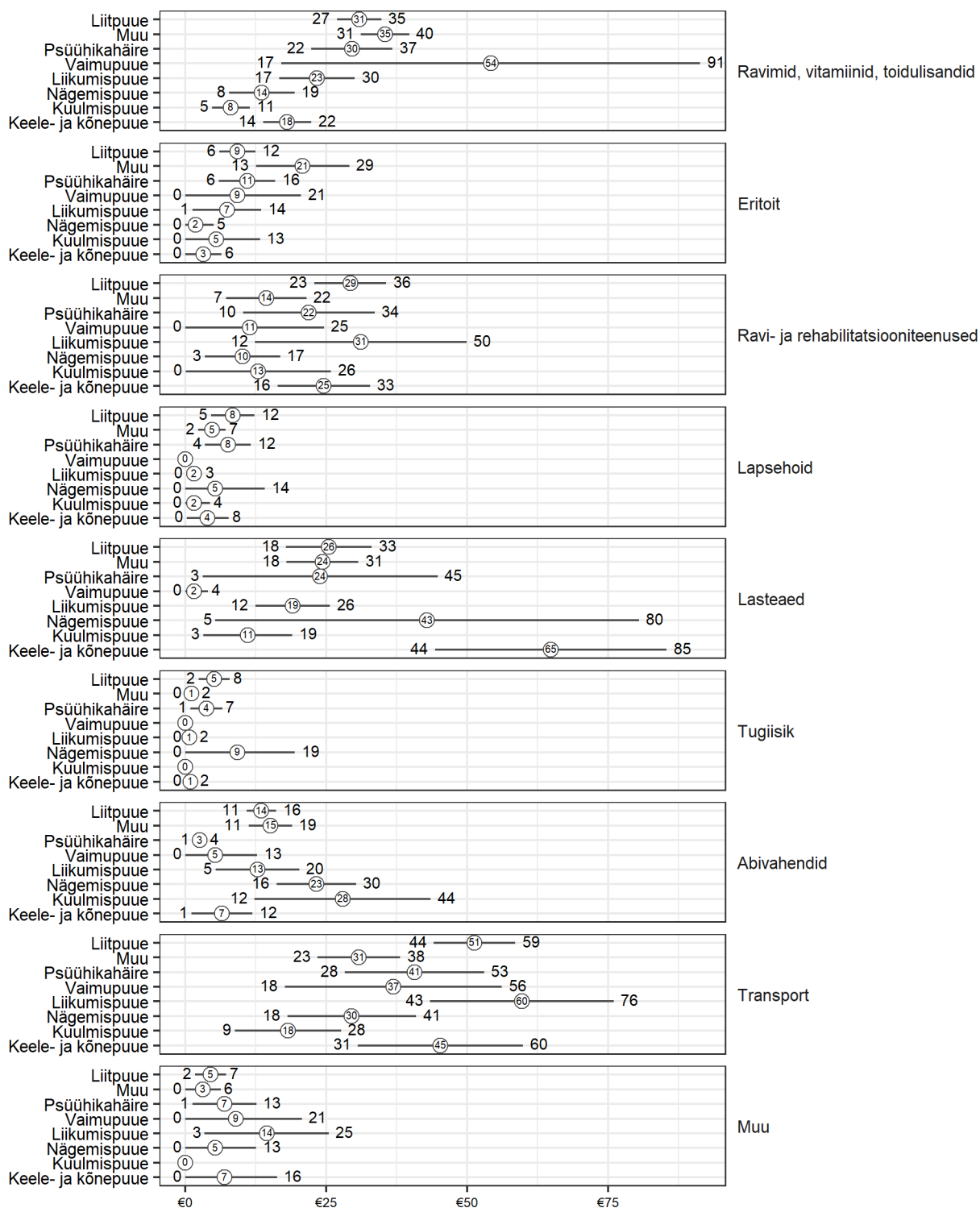


Märkus: kulude suurused on esitatud karp-vurrud diagrammina. „Karbi“ keskel asuv joon tähistab kulude mediaanväärtust, karpide alumine ja ülemine ots vastavalt ülemist (75%) ja alumist (25%) kvartiili. Seega karbi laius tähistab vahemikku, kuhu jääb 50% vaatlusaluste leibkondade kuludest. „Vurrude“ otspunktid tähistavad maksimaalset ja minimaalset väärtust (maksimaalse ja minimaalne väärtusena arvestatakse 1,5-kordset kvartiilide vahet, suuremad väärtused on loetud eranditeks ja jooniselt välja jäetud). Karpide laius tähistab kulu esinemise sagedust. Paksemate karpide puhul esineb antud kulu enam, peenemate karpide puhul vähem. Sälgu laius ümber mediaani tähistab ligikaudset mediaani 95% usaldusintervalli. Arvestatud on ainult tehtud kulutusi, st nullkulud on analüüsist välja jäetud)

Kulud **ravimitele, vitamiinidele ja toidulisanditele** on suuremad liitpuudega (27–35 eurot), muu puudega (31–40 eurot) ja psüühikahäiretega (22–37 eurot) laste puhul ning mõnevõrra madalamad nägemis-, keele- ja kõne- ning eriti kuulmispuudega laste puhul (Joonis 177).

Eritoidule tehtavad kulutused on suuremad muu puudega laste puhul (13–29 eurot), eristudes siinjuures eelkõige nägemis-, kuulmis- ning keele- ja kõnepuudega laste gruppidest.

Joonis 177. Keskmised puudega lapse tarbeks tehtud kulutused kuus puudeliikide lõikes (eurodes)



Märkus: arvestatud on nii tehtud kulutusi, kui ka nullkulusid. Ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

Ravi- ja rehabilitatsiooniteenustele kulub liitpuudega lastega leibkondadel enam (23–36 eurot) kui muu puudega ja nägemispuudega lastega leibkondadel.

Lasteaiale kuluvad summad on suurimad keele- ja kõnepuudega laste puhul (44–85 eurot). Kuid ka siinkohal tuleb tähele panna küllaltki laia usaldusintervalli (eelkõige nägemispuudega ja psüühikahäiretega laste puhul), mis viitavad ühelt poolt väikestele gruppidele, teisalt aga kulude suurele variatiivsusele.

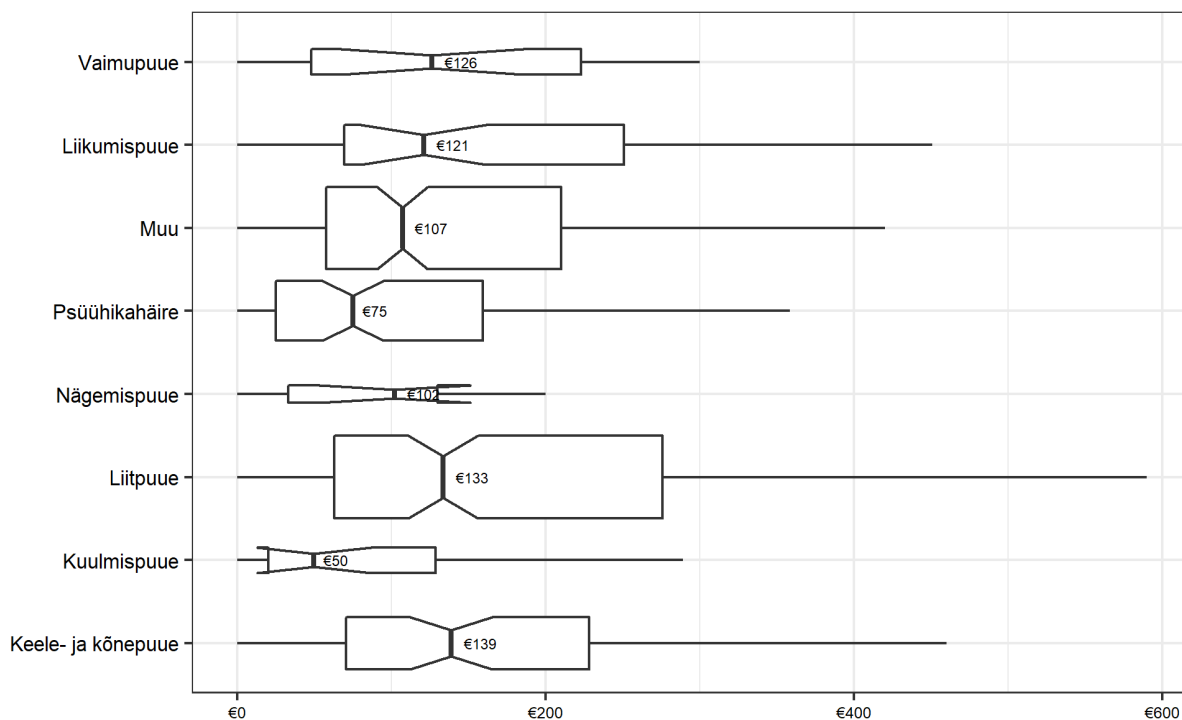
Kulutused **abivahenditele** on suuremad nägemis- (16–30 eurot) ja kuulmispuude (12–44 eurot) korral, seda eelkõige võrreldes psüühikahäirete, vaimupuude või keele- ja kõnepuudega.

Transpordikulud on suuremad liikumis- (42–76 eurot) ja liitpuudega (44–59 eurot) lastel ning mõnevõrra väiksemad kuulmis-, nägemis- ja muu puudega lastel. Samas on tähelepanuväärne, et transpordikulud on arvestatava suurusega kõikide gruppide puhul.

Lapsehoiu, tugiisiku ja muude kulude lõikes tugevaid eristusi puudeliikide lõikes välja ei joonistu.

Puudega lapse tarbeks tehtud kulutuste kogusummas enamike puudeliikide lõikes olulisi erinevusi ei esine (Joonis 178). Vaid kuulmispuude ja psüühikahäiretega laste tarbeks tehtud kulutuste mediaanväärtused on mõnevõrra väiksemad kui teiste puudeliikide puhul (jäädes alla 100 euro). Kõige varieeruvamad on kulud liitpuude korral. Poolte liitpuudega laste tarbeks tehtud kulutused jäävad vahemikku 63–276 eurot kuus, küündides aga maksimaalselt kuni 600 euroni.

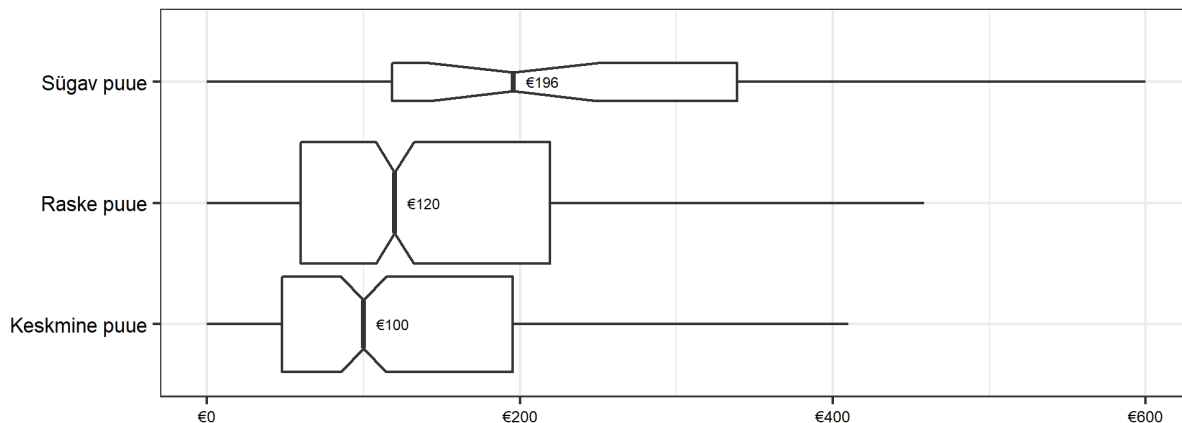
Joonis 178. Puudega lapse tarbeks tehtud kulutused kuus kokku puudeliikide lõikes



Märkus: kulude suurused on esitatud karp-vurrud diagrammina. „Karbi“ keskel asuv joon tähistab kulude mediaanväärtust, karpide alumine ja ülemine ots vastavalt ülemist (75%) ja alumist (25%) kvartiili. Seega karbi laius tähistab vahemikku, kuhu jääb 50% vaatlusaluste leibkondade kuludest. „Vurrude“ otspunktid tähistavad maksimaalset ja minimaalset väärtust (maksimaalse ja minimaalne väärtusena arvestatakse 1,5-kordset kvartiilide vahet, suuremad väärtused on loetud eranditeks ja jooniselt välja jäetud). Karpide laius tähistab kulu esinemise sagedust. Paksemate karpide puhul esineb antud kulu enam, peenemate karpide puhul vähem. Sälgu laius ümber mediaani tähistab ligikaudset mediaani 95% usaldusintervalli. Arvestatud on nii tehtud kulutusi, kui ka nullkulusid (ca 2% kõikidest leibkondadest), välja on jäetud need leibkonnad, kes vähemalt ühe kulu puhul märkisid, et ei oska või ei soovi kulu suurust öelda (ca 60% leibkondadest).

Sügava puudega laste tarbeks tehtud kulutused (kulude mediaanväärtus) on oluliselt suuremad kui raske ja keskmise puudega lastel (Joonis 179). 50% sügava puudega lastest jäävad kulud vahemikku 119–339 eurot, maksimaalselt võivad aga olla kuni 600 eurot. Raske puude korral jäävad kulud poolte leibkondade jaoks vahemikku 60–219 eurot ning keskmise puude korral vahemikku 48–195 eurot.

Joonis 179. Puudega lapse tarbeks tehtud kulutused kuus kokku puude raskusastmete lõikes

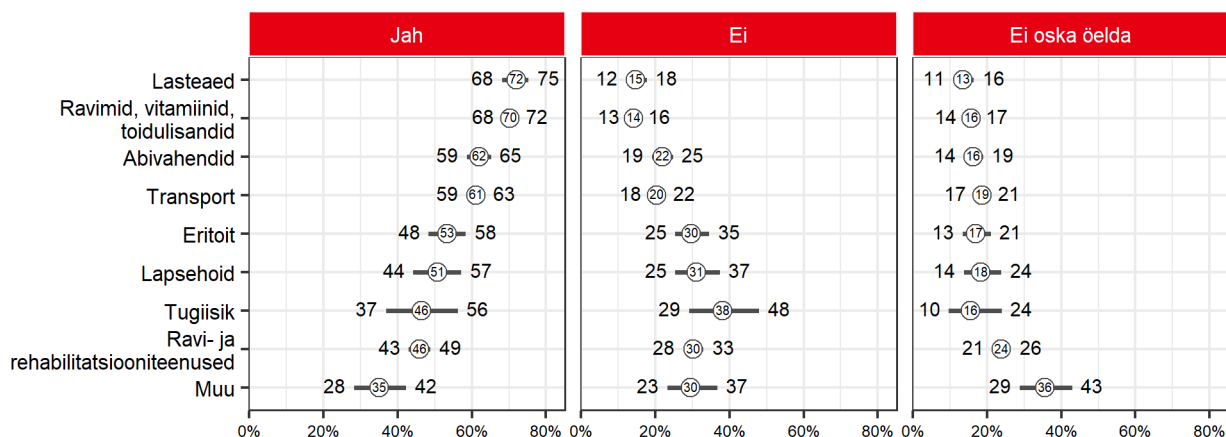


Märkus: Kulude suurus on esitatud karp-vurrud diagrammina. „Karbi“ keskel asuv joon tähistab kulude mediaanväärtust, karpide alumine ja ülemine ots vastavalt ülemist (75%) ja alumist (25%) kvartiili. Seega karbi laius tähistab vahemikku, kuhu jääb 50% vaatlusaluste leibkondade kuludest. „Vurrude“ otspunktid tähistavad maksimaalset ja minimaalset väärtust (maksimaalse ja minimaalne väärtusena arvestatakse 1,5-kordset kvartiilide vahet, suuremad väärtused on loetud eranditeks ja jooniselt välja jäetud). Karpide laius tähistab kulu esinemise sagedust. Paksemate karpide puhul esineb antud kulu enam, peenemate karpide puhul vähem. Sälgu laius ümber mediaani tähistab ligikaudset mediaani 95% usaldusintervalli. Arvestatud on nii tehtud kulutusi, kui ka nullkulusid (ca 2% kõikidest leibkondadest), välja on jäetud need leibkonnad, kes vähemalt ühe kulu puhul märkisid, et ei oska või ei soovi kulu suurust öelda (ca 60% leibkondadest).

8.3.2.3 Rahaliste vahendite piisavus puudega laste vajaduste katmiseks

Kulutused eritoidule, lapsehoiule, ravi- ja rehabilitatsiooniteenustele ning ka muude vajaduste katmiseks ei ole veerandi kuni kolmandiku puudega laste perede hinnangul olnud piisavad (Joonis 180). Veelgi halvem on olukord tugisikuteenusega, millele tehtud kulutused pole olnud piisavad 29–48% puudega laste jaoks. Lasteaia ja ravimite, vitamiinide ning toidulisandite kulutused on olnud suuremal osal peredel puudega lapse vajadustele vastavad (vastavalt 68–75% ja 68–72%) ning ebapiisavad on olnud kulutused 12–18% laste jaoks.

Joonis 180. Kas kulutused on olnud piisavad lapse vajaduste katmiseks (% puudega lastest, kelle leibkonnal vastavaid kulusid oli)



Märkus: arvestatud on nii tehtud kulutusi, kui ka nullkulusid. Ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

Kõige selgem on kõikide kululiikide korral seos lapse vajadustele vastavate kulutuste ja pere sissetuleku vahel. Mida suurem on pere sissetulek, seda enamad hindavad, et kulutused on olnud lapse vajadustele vastavad. Muud statistiliselt olulised seosed on järgmised:

Ravimite, vitamiinide ja toidulisandite kulutusi on piisavaks hinnanud veidi enamad sügava puudega laste peredest (73–89%) võrrelduna keskmise puudega lastega peredega (64–71%). 7–10-aastaste puudega laste perede seas on veidi vähem (61–69%) neid, kellel on kulutused olnud piisavad võrrelduna väiksemate lastega (70–78%).

Abivahendite kulutusi on hinnanud piisavaks veidi väiksema tõenäosusega psüühikahäirega laste vanemad (27–51%) võrreldes teiste puudeliikidega.

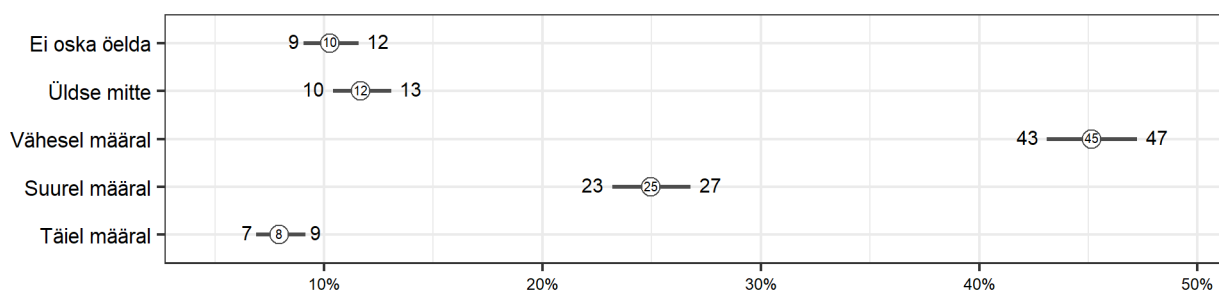
Transpordikulusid piisavaks hindavaid on sügava puudega lastega perede seas enam (64–82%) kui keskmise või raske puudega lastega peredes (vastavalt 55–63% ja 58–65%).

Lapsehoiuteenuse kulutusi on vanemates vanusegruppides (11–15 aastased ja 16–17-aastased) hinnanud piisavaks vähemad võrrelduna nooremate vanusegruppidega, statistiliselt oluline on erinevus vanusegruppide vahel vaid juhul, kui muude taustatunnuste mõju on elimineeritud.

Tugiisikuteenuse kulutusi piisavaks hindavaid esineb enam raske ja sügava puudega lastega perede seas (vastavalt 36–58% ja 40–90%) võrreldes keskmise puudega lastega peredega (5–52%), kuid seos on statistiliselt oluline vaid mudelipõhises analüüsis, kui taustatunnuste mõju on elimineeritud.

Ca kolmandiku puudega laste puudest tulenevad lisakulutused on kaetud kas täiel või suurel määral („täiel määral“ 7–9% ja „suurel määral“ 23–27%) puudega lastele suunatud toetustega (Joonis 181). Kuid üle poole on selliseid puudega lapsi, kelle puudest tulenevad lisakulutused on vähesel määral või ei ole üldse toetustega kaetud („vähesel määral“ 43–47% ja „üldse mitte“ 10–13%).

Joonis 181. Mil määral katavad puudega lapsele suunatud toetused tema puudest tingitud lisakulutusi? (% puudega lastest)



Märkus: arvestatud on nii tehtud kulutusi, kui ka nullkulusid. Ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire

8.4 Kokkuvõte

Eluruumide suuruse osas ei ilmne puudega laste leibkondadel võrreldes kõikide lastega leibkondadega märkimisväärsed erinevusi. Eluruumi suurus sõltub eelkõige leibkonna suurusest. Suuremate perede (5 või enam liiget) puhul jääb enam kui poolte leibkondade eluruumi pindala ühe liikme kohta alla 15 m².

16–21% puudega lastega leibkondadest tõdeb, et tulenevalt lapse puudest vajaksid eluruumid osalist või täielikku kohandamist. Taoline vajadus on oluliselt suurem sügava puudega laste korral ja mõnevõrra väiksem suurema sissetulekuga leibkondades. Kõige sagedasemateks kohandamist vajavateks probleemideks eluruumide juures on pesemisvõimaluste ja WC-ga seonduv.

Natuke üle poolte leibkondade puhul ei ole eluruumi kohandamine vajalik (57–61%). Samas nende puhul, kus see on vajalik olnud ja vastavad kohandused on tehtud, on selleks valdavalt kasutatud pere enda

vahendeid (81–87%). Eluruumi kohendamise teenust on selleks puhuks kasutanud kas täielikult või osaliselt küllaltki marginaalne osa leibkondadest (1-4% leibkondadest, kes on oma eluruume pidanud kohendama).

Levinuimaks probleemiks puudega laste kodudes on ruumivähesus (14-17% puudega laste kodudest). Aga ka allergeenid, niiskus ja sobimatu temperatuur on ligi kümnendikule puudega lastest probleemiks. Kuigi antud vajakajäämised ei ole mingil määral puudespetsiifilised, võivad nende esinemised puudega laste kodudes osutada lapse liikumisvõime või igapäevase toimetuleku seisukohast problemaatilisemaks kui tavaleibkondades.

Puudega lastega peredest 19–22% peavad kuus toime tulema 750 euro või vähemaga, ca veerand kuni kolmandik on peresid, kelle sissetulek on 751–1250 ja 1251–2300 eurot kuus (vastavalt 28–32% ja 27–31%). 2300 eurost enam on sissetulek 5–7% peredest. Üle poolte selliste leibkondade, kus ei ole ühtegi hõivatut, sissetulek jääb alla 750 euro.

Võrreldes kõikide lastega leibkondadega hindab oluliselt enam puudega lastega leibkondi oma majanduslikku toimetulekut keerulisemaks: 11–14% leibkondadest tuleb enda hinnangul oma igapäevaste kulutustega toime suurte raskustega (kõikide lastega leibkondade hulgas on vastav osakaal ca 4–6%) ja ligi 19–23% leibkondadest raskustega (kõikide lastega leibkondade hulgas on vastav osakaal ca 8-11%). Kõikidest puudega lastega leibkondadest tajub 19–26%, et tuleb hõlpsalt toime (sh vastusevariandid „üpriski hõlpsalt“, „hõlpsalt“, „väga hõlpsalt“). Tavaleibkondade hulgas on vastav osakaal 40–51%.

Lisaks leibkonna sissetuleku suurusele mõjutab leibkonna toimetuleku hinnangut hõivatute arv leibkonnas. Võib eeldada, et hõivatus on omakorda seotud hoolduskoormusega, kus näiteks üks vanem või muu leibkonna liige ei saa puudega lapse hooldamise kõrvalt töötada. Ka puudega laste arv peres mõjutab oluliselt hinnangut toimetulekule: mida enam on peres puudega lapsi, seda raskemaks hinnatakse toimetulekut (samas laste koguarv siinkohal olulist mõju ei avalda). Venekeelsetes leibkondades tajutakse raskusi majanduslikus toimetulekus oluliselt enamal määral kui eestikeelsetes perekondades. Seda ka juhul, kui on elimineeritud erinevate muude sotsiaalmajanduslike tegurite nagu sissetuleku suurus ja hõivatute arv, mõju.

Pea kõigi puudega laste vanemate hinnangul on leibkond puudega lapse tarbeks teinud kulutusi uuringus käsitletud kululiikide lõikes, ühtegi kulu polnud vaid 2-3% puudega lastega leibkondadest. Kõige sagedasemateks kuludeks on väljaminekud ravimitele, vitamiinidele ja toidulisanditele, mida esineb valdavas osas leibkondadest (86-89% kõigist leibkondadest). Ka transpordikulused on ca kolmel neljandikul (81–87%), ravi- ja rehabilitatsioonikulused veidi enam kui poolel (52-57%) ning kulused abivahenditele rohkem kui kolmandikul (39-43%) leibkondadest. Kõige suuremad kulud tekivad eritoiduga seoses (mediaankulu 80 eurot), jäädes 50% leibkondade jaoks (kellel antud kulud on) vahemikku 40–120 eurot. Kõige varieeruvamad on kulud tugiisikule (jäädes 50% vastavate kuludega leibkondade jaoks vahemikku 25–156 eurot). Kõige vähem varieeruv, aga samas kõige enam esinev on kulu ravimitele, vitamiinidele ja toidulisanditele, jäädes 50% leibkodade puhul vahemikku 15–50 eurot kuus. Kuised transpordikulud jäävad poolel leibkodadel 20 ja 100 euro vahele, samas maksimaalsed kulud ulatuvad ligi 200 euron.

Kulude jaotus sõltub eelkõige puude raskusastmest ja liigist, aga ka lapse vanusest. Sügava ja raske puudega laste puhul on erinevaid kulusid enam ja need on suuremad kui keskmise puudega laste korral. Kõige suuremad on kulud liitpuude korral ja kõige madalamad kuulmis- ning nägemispuude korral. On loogiline, et kulude iseloom sõltub paljuski puude liigist: näiteks kulusid transpordile on enam liikumispuudega lastel ja erinevatele abivahenditele kuulmis- või nägemispuudega lastel .

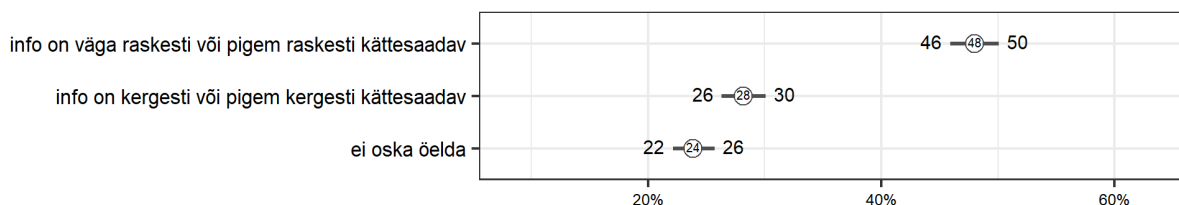
Ligi veerand kuni kolmandik leibkondadest hindab tehtud kulutusi eritoidule, lapsehoiule, ravi- ja rehabilitatsiooniteenustele ning ka muule puudega lapse vajaduste katmiseks liialt väikeseks. Kõige

halvem on olukord tugisikuteenusega, millele tehtud kulutused pole olnud piisavad peaaegu poolte leibkondade hinnangul. Huvitaval kombel hindavad sügavama puudega laste vanemad tehtud kulutusi piisavaks enamal määral kui raske või keskmise puudega laste vanemad.

9 Teave toetuste ja teenuste kohta

Sotsiaalteenuste ja -toetuste probleemide leviku tulemustega kooskõlas leiavad pooled (46–50%) puudega lastega pered, et info lastele suunatud toetuste, teenuste ja abi kohta on pigem raskesti või väga raskesti kättesaadav (Joonis 182). Lisaks sellele ei oska 22–26% info kättesaadavust hinnata.

Joonis 182. Kuivõrd kättesaadav on vanema hinnangul info puuetega lastele suunatud toetustes, teenuste ja abi kohta? (% puudega lastest)

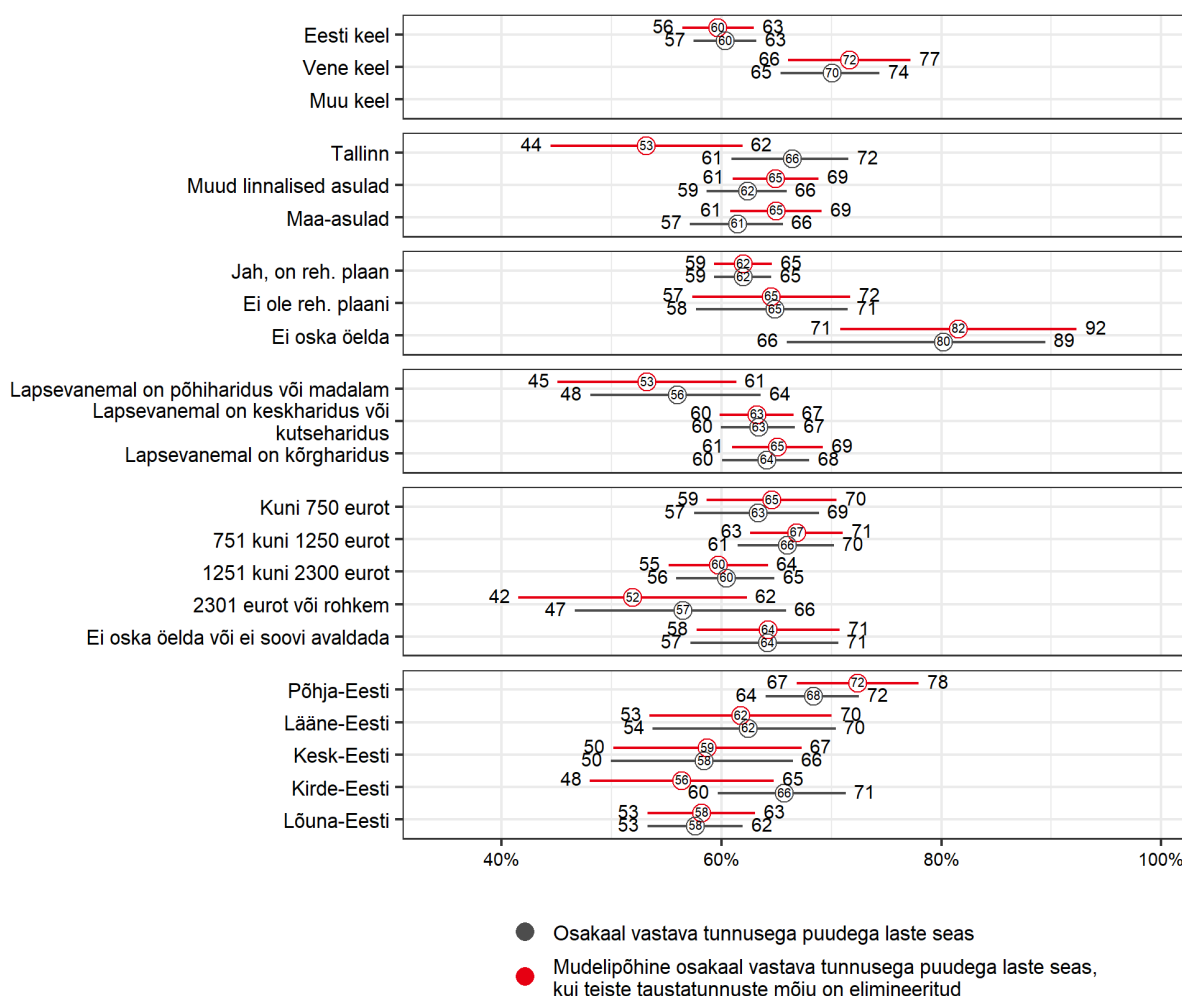


Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

Jättes kõrvale need, kes ei oska hinnata info kättesaadavust, on info halvemini kättesaadav vene keelt koduse keelena kõnelevatele inimestele, kellest 65-74%le on info pigem raskesti või väga raskesti kättesaadav. Eestikeelsetest peredest on see pigem raskesti või väga raskesti kättesaadav 57-63%le.

Kui vaadata puudega laste vanemate osakaalu, kes on välja toonud, et teave on pigem raskesti või väga raskesti kättesaadav, regionaalselt ja asulatüüpide lõikes keskmiselt, siis olulisi erinevusi ei ilmne. Tallinnas on see osakaal 61-72%, teistes linnalistes asulates 59-66% ja maa-asulates 57-66%, mis ei ole omavahel statistiliselt oluliselt erinevad (Joonis 183). Kui võrrelda aga samasuguste taustatunnustega lapsi Tallinnas ja teistes asulatüüpides, siis ilmneb, et Tallinnas on tõenäosus, et info kättesaadavus on raske, väiksem (44-62%) kui mujal (linnalistes asulates ja maa-asulates mõlemas 66-69%). Regioonidest erinevad Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti, kus on info pigem raskesti või väga raskesti kättesaadav vastavalt 64-72% ja 53-62% puudega laste vanematest, st Põhja-Eestis on info kättesaadavus halvem.

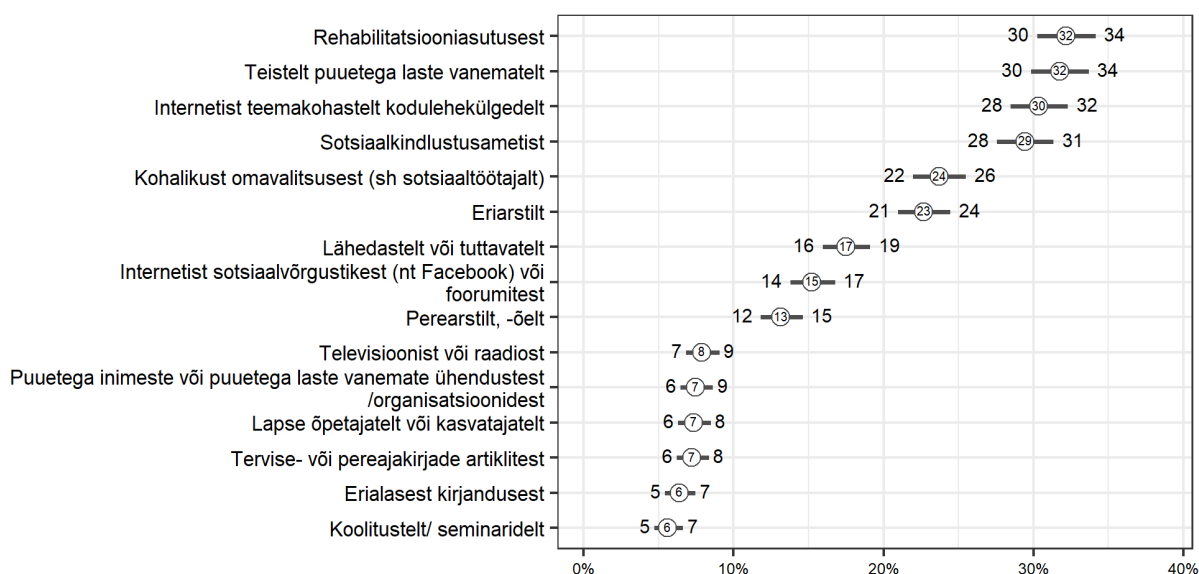
Joonis 183. Puudega lastele suunatud toetuste, teenuste ja abi kohta olev info on pigem raskesti või väga raskesti kättesaadav (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: info on kergesti või pigem kergesti kättesaadav = 0, info on pigem raskesti või pigem raskesti kättesaadav = 1. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanuserühm, asula tüüp, kodune keel, vastaja haridustase, elukoha regioon, rehabilitatsiooniplaani olemasolu.

Kuna puudega laste toetamise ja abi süsteem on killustunud riigi- ja kohaliku omavalitsuse, sotsiaal-, haridus- ja tervishoiusüsteemi vahel, siis ei ole ka ühte valdavalt kanalit, mille kaudu puudega laste pered toetuste, teenuste ja abi kohta infot saavad. Teabe saamise kanalid on killustunud ning hõlmavad nii ametlikke kui mitteametlikke kanaleid võrdväärse tähtsusega (vt Joonis 184). Infokanalitest on teabeallikana kõige levinumad rehabilitatsiooniasutused (30-34%), teised lapsevanemad (30-34%), teemakohased lehed internetis (28-32%) ja SKA (28-31%). Kõigist neist on saanud infot veerand kuni kolmandik puudega laste peredest. Levikult teise grupi moodustavad KOV (22-26%) ja eriarstid (21-24%), kust on saanud infot viiendik kuni veerand. Kolmanda grupi, kust infot teenuste ja toetuste ja abi kohta on saanud 10-20% puudega laste peredest, moodustavad lähedased ja tuttavad (16-19%), internetifoorumid (14-17%) ning perearstid (12-15%). Ülejäänud kanalite tähtsus on väiksem ning igapäheist neist on saanud infot alla 10% puudega laste peredest.

Joonis 184. Millistest allikatest on vanemad saanud infot puudega lastele suunatud toetuste, teenuste ja abi kohta (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid.

Lisaks etteantud infoallikate loetelule tõi 27 vastajat välja mõne muu infokanali, kust nad on saanud infot puudega lastele suunatud toetuste, teenuste ja abi kohta:

1. Kooli, haigla, või muu raviasutuse sotsiaaltöötaja
2. Töötukassa
3. Innove, Rajaleidja
4. Tööandja
5. Töökogemus või õppimine seonduvas valdkonnas
6. Ajaleht
7. Riigiteataja

Taustatunnuste lõikes on **rehabilitatsiooniasutused** infoallikana vähem olulised nendele gruppidele, kellel on vähem kokkupuuteid rehabilitatsiooniasutustega: kuulmis-, nägemis- ja muu puudega lastel (samasuguste taustatunnustega lastest saab nägemispuudega lapse vanem infot rehabilitatsiooniasutusest 7-25%lise tõenäosusega, kuulmispuudega 14-32% ja muu puudega 24-31%, samas kui keele- ja kõnepuudega 31-44%, psüühikahäirega 31-42% ja liitpuudega 30-38%lise tõenäosusega). Kuulmis- ja muu puudega laste seas on aga sagedasemaks infoallikaks **eriarst** (kuulmispuudega lastest on eriarsti käest saanud infot 29-59% , muu puudega lastest 22-29% ja psüühikahäirega lastest 13-22%, liitpuudega lastest 18-24%). **Perearsti** käest saavad mitmete teiste puudeliikidega võrreldes sagedamini infot muu puudega laste pered (17-23% muu puudega laste peredest vrld 5-12% keele- ja kõnepuudega, 0-12% kuulmispuudega, 5-11% psüühikahäirega, 9-14% liitpuudega).

Teistelt puudega laste vanematelt saavad infot sagedamini psüühikahäire (28-39%), muu puude (27-35%) ja liitpuudega (34-41%) laste vanemad võrreldes vaimupuudega (8-25%) ning keele- ja kõnepuudega (18-30%). Samuti sügava puudega (38-57%) laste vanemad (vrld keskmise puudega laste (24-30%) ja raske puudega laste (30-36%) vanematega). Seejuures on kõrgema haridusega (30-37% kõrgharidusega ja 31-36% kesk- või kutseharidusega) vanematel selliselt jagatava info saamisel paremad võimalused kui põhihariduse või madalama haridusega vanematel (13-23%). Ka **interneti** teemakohastelt lehekülgedelt info saamine on muude samade tingimuste korral vähem tõenäoline madalama haridusega inimeste seas.

Puudega laste kõrgharidusega vanematest on internetist teemakohastelt lehekülgedelt saanud infot 34-41%, kutse- või keskharidusega vanematest 26-31% ja põhi- või madalama haridusega vanematest 13-23%.

Vene keelt kõnelevatel inimestel on samuti väiksem tõenäosus saada **infot interneti asjakohastelt lehekülgedelt ja foorumitest või sotsiaalvõrgustikest**. Puudega laste vene keelt kõnelevatest peredest saab infot interneti asjakohastelt lehekülgedelt 10-16%, eestikeelsetest 35-40%. Foorumitest on saanud infot 6-11% vene koduse keelega puudega laste vanematest ja 16-20% eestikeelsetest. Venekeelsed pered saavad teistest veidi väiksema tõenäosusega infot **SKAst** (17-24% venekeelsetest puudega laste vanematest ja 30-35% eestikeelsetest) ja **rehabilitatsiooniasutustest** (19-26% venekeelsetest peredest ja 33-38% eestikeelsetest on saanud infot rehabilitatsiooniasutustest).

Internetifoorumid ja sotsiaalvõrgustikud on vähem kasutuses vanemate vanusegruppidega lastega peredes (11-15-aastaste puudega laste vanematest on saanud foorumitest infot 10-15%, 7-10-aastaste vanematest 15-21% ja 0-6-aastaste vanematest 13-19%).

KOV on infojagamise kanalina olulisemal kohal maa-asulates elavatele (KOVist on infot saanud 28-35% maa-asulates, 15-20% muudes linnalistes asulates ning 21-30% Tallinnas elavatest puudega laste vanematest) ning raske ja sügava puudega laste peredele võrreldes keskmise puudega lastega peredega (vastavalt on sügava puudega lastest saanud KOVist infot 31-50%, raske puudega lastest 23-30% ja keskmise puudega lastest 13-18%).

Vastajatel, kelle hinnangul on info puudega lastele suunatud toetuste, teenuste ja abi kohta raskesti kättesaadav, paluti täpsemalt kirjeldada, millise info kättesaadavusega on neil probleeme esinenud. Üldisemalt võib välja tuua järgmised vastuste rühmad:

1. **Puudub info, et lapsele võiks üldse puuet taotleda**, miks puude taotlemine kasulik oleks ja kuidas puude taotlemine käib.
„Puude vormistamise protseduur on väga keeruline ja osadeks hakitud. Teekonda alustades ei anna keegi infot, millised on järgmised sammud, mis läbida tuleb. Igaüks vastutab oma lõigu eest. Järjest uued ja uued komisjonid, taotlused, vormid, otsused. Protседuur oli väga pikk ja ülevaatlikku ja lihtsat infot, et miks on vaja puue määrata ning kuidas sealt edasi teenust saada, esimestes etappides ei antud. Ma polnud ju selliste asjadega kunagi kokku puutunud. Mul polnud õrna aimugi, milleks nt peale puude määramist peab kuhugi rehabilitatsioonikomisjoni minema. Ma ei teadnud, mis on rehabilitatsiooniplaan. Miks mul seda vaja on jne. Täiesti müstiline protseduur.“
„Puude määramise protsessis oli kogu info puudulik ja selged juhendid puudusid“
2. Puudu on teadmine **üldiselt puudega laste õigustest, teenustest, toetustest ja soodustustest**, mida ja kust puudega lastel oleks võimalik saada, ning puudub koht, kust seda infot võiks saada.
„Asi toimib nagu põhimõttel, et kui küsida ei oska, siis keegi asjast midagi ei räägi ka. Aga kuidas sa küsid, kui ei tea neist midagi?!“
„Ülevaatlikku infot võimaluste kohta ja teenuste valiku ning selle pakujate kohta ei ole ning puudub selgus, kes vastutab ühe või teise teenuse korraldamise eest - kelle ülesanne/kohustus on. Jooksutatakse ühest kohast teise ja lükatakse vastutust. Meie suurim probleem tugiisiku leidmine, sobiva kooli leidmine, õige / sobiva õppeprogrammi leidmine, transport kooli ja tagasi, jne“
„Mis järjekorras, kus ja kuidas toimub 16-aastase puude taotlemine, reh plaani koostamine, töövõime tuvastamine jm“
3. Puudu on teadmine mingist **spetsiifilisest teenusest, toetusest või soodustustest**, inimene ise sellist infot otsida ei oska ja ametnikud, arstid jt, kellega inimene kokku puutub, ei anna seda infot inimesele.

„Võimalus taotled lapsele **lasteaia erirühmas** kohta, puudus info, et sellised erirühmad üldse eksisteerivad, kuigi olime käinud kümneid kordi eriarsti juures.“

„Hetkel on probleemiks lapsele **kooli tugiisikuteenuse** taotlemine ja lapsele kooli individuaalse õppekava taotlemine, kuid info on nii puudulikult kättesaadav, et isegi valla sotsiaaltöötaja ei suutnud koheselt infot hankida.“

„**Tugiisikuteenuse** info. Kuulsin sellest oma tööalaselt koolituselt täiesti kõrvalise repliigina ja hakkasin asja uurima. Alguses ei osanud ka sotsiaaltöötaja selle koht infot anda.“

„**Tasustatud ja tasustamata puude päevade ja puhkuse võtmine.**“

„Täiesti juhuslikult kuulsin mõned aastad tagasi infot, et **riik maksab õppelaenu tagasi sügava puudega laste vanemate eest**. Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt seda infot ei suutnud leida, tegin neile isegi sellise ettepaneku, et selle võiks sinna lisada, kuid mulle vastati, et see pole nende asi ja nad ei tohi seda reklaamida.“

„Sotsiaaltöötajad pole andnud piisavalt informatsiooni Euroopa liidu poolt rahastatava fondi kohta, mis toetab **lastehoiu- ja tugiisikuteenuse** rahastamist. Tänu sellele on jäänud teenus aastaid juba kasutamata, kuigi selleks oli vajadus.“

„See kuidas saada lapsehoiuteenust või **rahastust erikooli õppemaksu tasumiseks**. See oleks justkui riiklik saladus. Kui ei tea, et sellised võimalused on olemas siis ei oska ka küsida.“

„Sain aastaid hiljem teada võimalusest lisapuhkusele ja **tasuta bussisõidu võimalusele**.“

„**REHA plaani teostamise võimalused**. REHA plaan tehti valmis, aga mis sellega edasi saab ei selgitanud keegi.“

„võttis üle aasta aega lapse puude taotlemise järel, enne kui ma sain teada, et on võimalik taotleda talle **pensioni**.“

„puudus info et puudega laps saab näiteks sellest aastast **ortopeedilisi jalanõusid 90% soodustusega**. Info edastas jalanõusid müüv kauplus. Info edastamine oli juhuslik ja info puudus teemakohastes kodulehtedes“

„Näiteks, et alates 3a. on puudega lastel õigus saada **mähkmeid ja muid hügieenitarbeid** soodustusega, seda sain juhuslikult teada ühelt lapsevanemalt“

„näiteks ei teavitanud puuet taotlema minnes keegi sellest, et **ka rahaline toetus on olemas** (läksime reh plaani pärast).“

„Kust ja kuidas alustada, et laps saaks diagnoositud ning **vastavat abi õppimisel**.“

„Nt sain tuttavalt teada, et lapsele on võimalik taotleda **nn rohelist kaarti**, et saada soodustust lapsele vajalike abivahendite ostmiseks.“

„Näiteks ei teadnud, kuskohast saab **invaparkimiskaarti taotleda**.“

„Kuidas pääseda puudega **lapsega hambaravile narkoosis**.“

„Milline on lapse tulevik peale toimetuleku kooli lõppemist, **erihariduseõpe**? Mis täpselt on vaja teha kui laps saab 16. a“

„Kui palju ja mis **taastusravi võimalused** on sellistele lastele.“

„Info nende asutuste ja soodustuste (näiteks: millistes **muuseumides** on soodustused puudega lastele)“

„Ei teadnud, et puudega isik saab **parvlaevaga Saaremaale ja Hiiumaale tasuta sõita**“

„**Kodukohandus**.“

„Info nt **tugigruppide** kohta, kuhu laps **suunata nt sporti tegema**“

„Alles hiljuti sain teada, et puudega laps saab **apteegist 90% soodustust mõnedelt asjadelt**“

4. **Info on keeruliselt esitatud, killustatud, raskesti kättesaadav** ja info võib olla eri allikates vasturääkiv või puudub üldse inimene või koht, kellel või kus oleks kõikehaarav info olemas, mida saaks inimestele jagada.

„Liiga keerulised juhendid, et mõista mida just meil on vaja täita.“

„Veebikeskkonnad on raskesti navigeeritavad ja info on erinevates kohtades laiali“

„Sotsiaalkindlustusameti koduleht ei ole lapsevanemale arusaadav. Osa blankette tuleb ühest, osa teisest kohast. Info on killustatud, segamini, keeruline leida.“

„Toetuste saamise kord on e-riigi põhimõtetele mitte vastav. Dokumentatsioon pole ühtselt kättesaadav ja palju on vaja ise tööendeid ja dokumente saata erinevate asutuste vahel.“

„Pole olemas inimest, kes kõiki valdkondi teaks ja oskaks soovitada.“

„Puudest tulenevate õpiraskuste lahendamine on peaaegu võimatu, sest kool, Innove, reh. asutus ja eriarstid räägivad kõik erinevat juttu. Lapsevanem on teadmatutes ja abitu.“

5. Teenuste ja toetuste saamine on väga **keerukas ja protsess on pikaajaline**

„Kuu aega toimetati avalduse kallal, st kuu aega polnud meil tugiisikut ja lasteaias kasvatajad polnud valmis meie lapsega ilma abistava inimeseta tegelema.“

„Tugiisiku lepingute vormistamine teenusepakkuja EELK ja KOViga on olnud aeganõudev ja vaevaline (eeskätt KOV osas). Puudub toimiv juhtumikorraldus KOVi poolt, kus pakutaks abi riigi poolt, kõike pead ise küsima.“

6. **Uuenevate** teenuste, toetuste ja protsesside info on puudulik

„Toetuste jagamine liikus riigilt vallale ning info puudus mida peab tegema et toetust saada või mis mahus saab. Aasta alguses ei teadnud ka vald seda.“

„Vald maksab sellest aastast kooli sõiduks transpordiraha 180 € kuus, sellest ei teavitatud.“

„Seaduseid muudetakse peaaegu igal aastal mis teeb teenuste info raskelt mõistetavaks, nt lapsehoiu-teenuse taotlemiseks tuleb igal aastal uus bürokraatia kuhi ületada.“

„Materjal mille olen leidnud, on tihti aegunud ja ei ole kindel kas hetkel need tingimused kehtivad.“

7. Need **isikud, ametnikud, kes peaksid inimesele infot andma, seda ei tee** või teevad ebapädevaid otsuseid. Nimetatakse kõiki puudega lastega kokku puutuvaid asutusi ja ametnikke, kellelt oodati infot, mida aga erinevatel põhjustel ei saadud.

„Kuulume küll ELDÜ'sse aga ikkagi on infot vähe. **Arstidelt** ei saa midagi, Valla **sotsiaaltöötaja** vaatab isegi lapsehoiuteenuse avaldusele paanikas ilma.“

„**Sotsiaalkindlustuse ametnikelt** tuleb infot tangidega välja kiskuda, või ise hästi tark olema, et teada, mida küsida.“

„Tihti on ka **KOV sotsiaaltöötajal** "sada" ametit ja ta ei teagi mida ja kellega tegema peab“

„Halb kogemus on selja taga **"Rajaleidja" asutusega**. Ja leian, et ka praegu on Rajaleidjal teatud valdkondades veel palju arenemisruumi. Seni kuni nad ei pea kliinilist diagnoosi mittemillekski, kahtlen ma nende antud soovitude pädevuses.“

„**Perearst või eriarst** üldiselt sellise teenuse juurde ei suuna. Kuulsin toetuse taotlemise võimalusest juhuslikult tuttava käest. Kuskilt mujalt selle kohta infot pole saanud.“

„Pakutavate teenuste info ja võimalikkus on **rehabilitatsiooni teenuseid pakkuvate asutuste** kodulehtedel puudulik või segane“

„Mul pole ülevaadet, milliseid toetusi on võimalik taotleda ja kahjuks ei ole seda mulle ka **sotsiaal- või lastekaitsetöötaja** tutvustanud“

„Ühest suurt pilti protsessist ei ole **Sotsiaalministeeriumi** lehel ega ka Sotsiaalkindlustusameti lehel.“

8. Ei mõista, **mille alusel toetuste suurus kujuneb ja miks teenusele ei suunata**

„Puudub igasugune info kuidas ja mille alusel toetust arvestatakse.“

„kui leiadki vajaliku teenuse üles, mis last aitaks. Siis selgub, et seda ikkagi ei taheta võimaldada. Õeldakse lihtsalt, et teie laps pole veel kõige hullemas seisus ja abi jääbki saamata.“

Lisaks puudulikule infole puudega lapse toetuste ja teenuste kohta toodi välja, et puudega laste vanematel on puudujääke ka teadmistes lapse tervisliku seisundi hindamisel ning sellest tulenevalt adekvaatse ravi korraldamisel ja abi pakkumisel ning oskustes kasutada interneti. Viimasel juhul on ligipääs infole oluliselt raskendatud, sest oluline osa infost liigub just vanemalt vanemale interneti vahendusel. Lapse kasvatamisega seotud valdkonna infovajadust käsitletakse hoolduskoormuse peatükis.

Pakuti ka üksikuid lahendusi, kuidas parandada info liikumise puudujääke. Laias laastus pakuti kolme lahendust. Ühe lahendusena pakuti, et oluline info peaks inimestele tulema otse meilile nii selle kohta, millised toetused ja teenused üldiselt on olemas, kui ka juhtudel, kui mingite toetuste või teenuste korralduses toimuvad muudatused.

„Kurvaks teeb, see et siis on mu meili aadress kättesaadav ja kasutatav, kui minult miskit tahetakse (näit. trahvid või kasvõi seegi uuring), aga miks ei võiks keegi ametnik, kellele me kõik maksumaksjad palka maksame, saata meili, et mis on minu lapsele ettenähtud soodustused, toetused ja mis on minu, kui puudega lapse ema võimalused, õigused ja kohustused.“

Teise korduvalt pakutud lahendusena nähakse:

„ühte ülevaatlisku kohta, kus leiaks kõik vajaliku – mida ja kust taotleda, millal taotleda, millised teenused ja soodustused on olemas, millised lisavõimalused jne.“

Kolmanda lahendusena toodi välja info jagamist inimestele ühe kindla kõikidest süsteemidest teadliku kõneisiku kaudu.

„Puudega laste vanematele/puudega inimestele peaks olema ühe kohustusliku nõustamisena määratud kohtumine sotsiaaltöötajaga, kes peab andma ülevaate õigustest ja kohustustest.“

Kokkuvõttes tunnetavad puudega lastega pered väga teravalt, et infot on vähe ja info puudega lastele mõeldud toetuste, teenuste ja abi kohta saadakse killustatult erinevate kanalite kaudu. Kanalid, mille kaudu infot saadakse, hõlmavad võrdväärse tähtsusega nii formaalseid kanaleid nagu SKA, KOV sotsiaaltöötaja, teenusepakkujaid nagu rehabilitatsiooniasutused, arstid kui ka informaalsete lapsevanemate võrgustikke. Infopuudus on laialdane alates puude taotlemise protsessist kuni toetuste ja teenuste olemasoluni. Venekeelsetel peredel on infopuudus suurem kui eestikeelsetel.

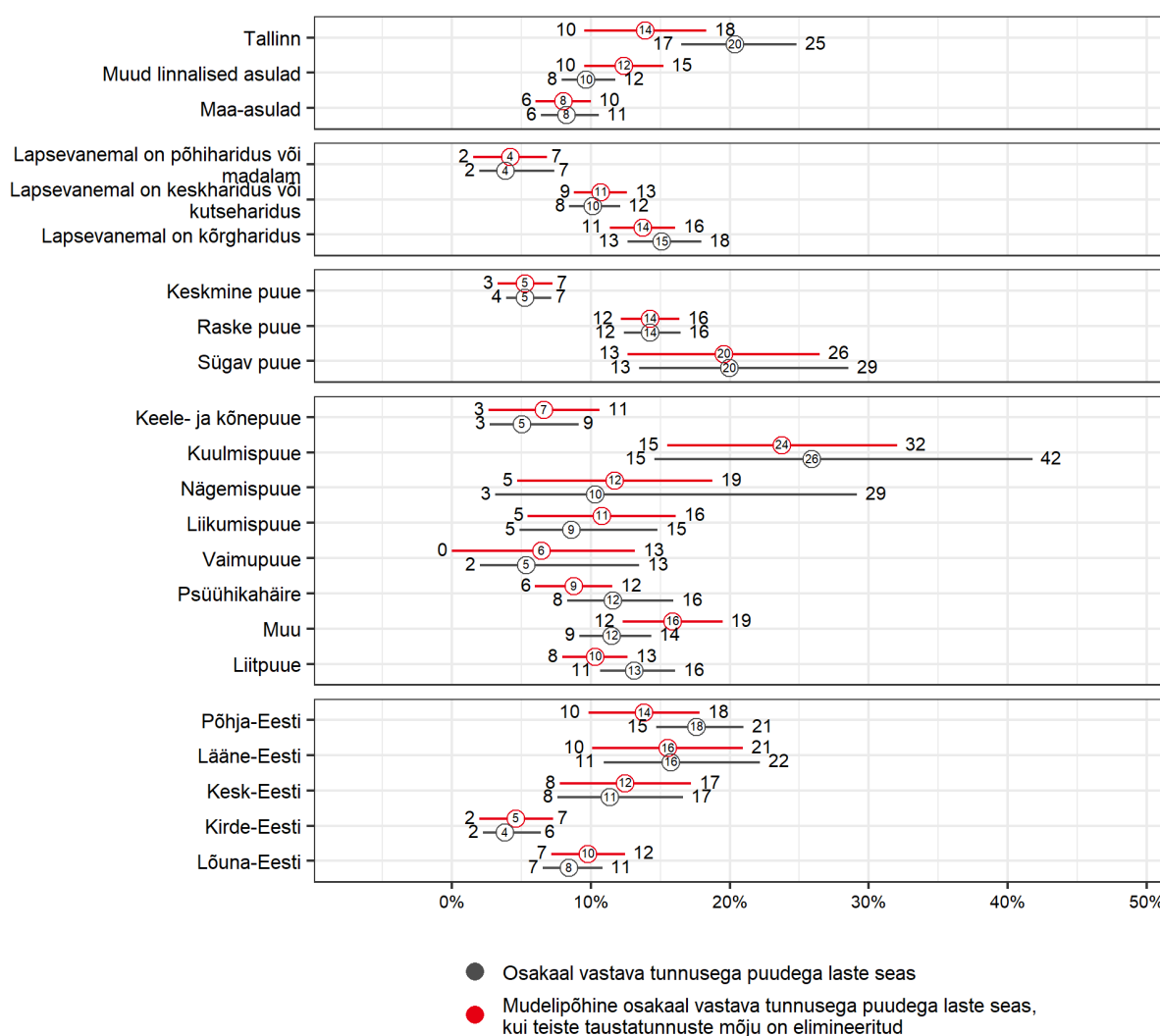
10 Sotsiaalsed suhted ja võrgustikud

10.1 Kuulumine puudega laste perede ühendustesse

Puudega laste vanemate või puudega inimeste ühenduse või organisatsiooni liikmeteks on käesoleva küsitluse põhjal üldistades 10-13% puudega laste vanematest või teistest puudega lapse leibkonnaliikmetest. See osakaal ei ole võrreldes 2009. aastaga statistiliselt oluliselt muutunud.

Teistest sagedamini on puudega inimeste või puudega laste vanemate ühenduste liikmed raske (12-16%) ja sügava puudega (13-29%) lastega pered (vrdl keskmise puudega lastega peredest 4-7%) (Joonis 185). Samuti on liikmelisus kõrgem kuulmis- (15-42%) ja muu puudega (11-16%) laste vanemate hulgas võrrelduna keele- ja kõnepuudega (3-9%) laste vanematega. Teistest harvem on puudega laste vanemate või puudega inimeste ühendustes pered, mille vastaja on muude samade tingimuste korral põhi- või madalama haridustasemega ja elab Kirde-Eestis.

Joonis 185. Puudega inimeste või puudega laste vanemate ühendustesse või organisatsioonidesse kuulumine (% puudega laste vanematest)



Märkus: Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal paiknevad arvud tähistavad 95%lisi usalduspiire. Analüüsi on kaasatud ainult need vastajad, kes andsid vastuse kõigi taustatunnuste lõikes. Analüüsist on välja jäetud vastajad, kes ei osanud nägemisabivahendite vajadust hinnata. Mudelipõhiste osakaalude leidmiseks kasutatakse logit-regressiooni. Sõltuv muutuja: kuulub ühendustesse = 1, ei kuulu ühendustesse = 0. Mudelisse lülitatud muutujad: puudeliik, puude raskusaste, lapse vanuserühm, asula tüüp, kodune keel, vastaja haridustase, elukoha regioon.

Puudega laste vanematest, kes on põhiharidusega, kuulub ühendustesse 2-7%, kesk- või kutseharidusega vanematest 8-12% ja sügava puudega lastest 13-29%.

Veidi tõenäolisemalt kuuluvad ühendustesse linnades elavad inimesed. Keskmine ühendustesse kuuluvate perede osakaal on Tallinnas 17-25%, muudes linnalistes asulates 8-12% ja maa-asulates 6-11%. Kui võrrelda samade taustatunnustega lapsi, siis ei ole Tallinna ja muude linnaliste asulate vahel erinevust, küll aga on mõlemast väiksem maa-asulates elavate puudega lastega perede liikmete esindusorganisatsioonidesse kuulumise tõenäosus.

Regiooniti paistavad silma Kirde-Eestis elavad puudega lapsed, kelle peredest kuulub ühendustesse vaid 2-6%, samas kui teistes Eesti regioonides on see osakaal suurem kui 7%.

10.2 Hoiakud

Puudega laste perede ühenduste mõju on suurem kui ainult info jagamine enda liikmetele. 42-46% puudega laste vanematest leiab, et puudega lastega peresid ühendavad organisatsioonid aitavad perede olukorra parandamisele oluliselt kaasa (vt Joonis 186). Samas on puudega lastega perede ühendused võrreldes informaalsete vanemate võrgustikega olnud väiksema osa puuetega laste vanematele oluliseks infoallikaks toetuste, teenuste ja seonduva abi teabe jagamisel (vastavalt on saanud puudega laste vanematest infot toetuste, teenuste ja abi kohta 7-9% ja teistelt lapsevanematelt 30-34%) (Joonis 184).

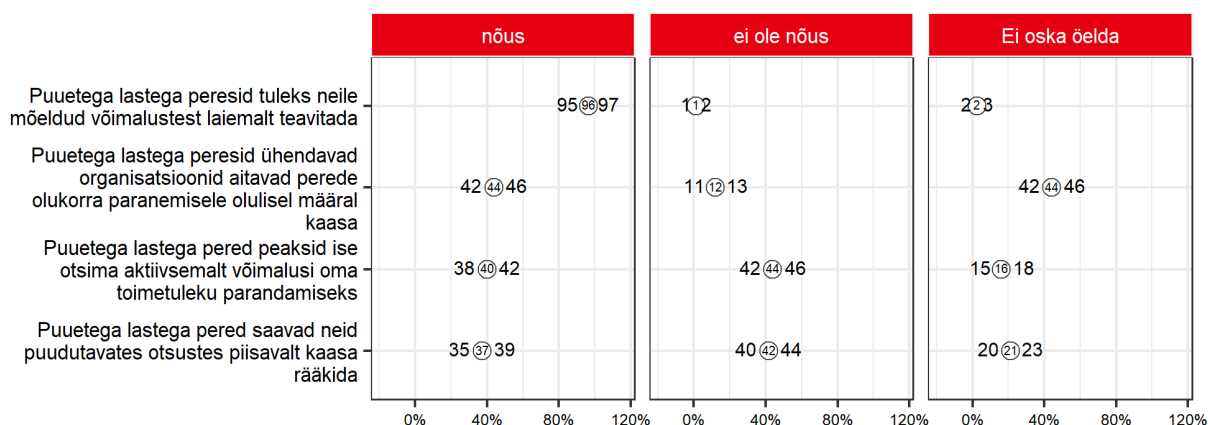
Võrreldes 2009. aastaga on väitega, et puudega lastega peresid ühendavad organisatsioonid aitavad perede olukorra paranemisele olulisel määral kaasa, nõustujate osakaal 2017. aastal veidi väiksem: 2009. aastal oli väitega nõus 50-57% puudega laste peredest. Tulemused ei ole aga otseselt võrreldavad, kuna 2009. aasta uuringus ei olnud valikvastusena inimestele antud võimalust valida „ei oska öelda“. Seetõttu olid inimesed esmalt sunnitud seisukoha võtma ka teemades, milles neil tegelikult seisukohta polnud, ja see selgitab süstemaatiliselt suuremat „ei oska öelda“ vastuste osakaalu käesolevas uuringus.

Teravalt tunnetatav teabepuuduse probleem (vt ptk 5.3, 4 ja 8) viib selleni, et pea kõik puudega laste vanemad leiavad, et vajalik oleks parem teavitamine puudega lastele mõeldud võimalustest. 95-97% puudega laste vanematest on seisukohal, et teavitamine peaks olema laialdasem. Ka 2009. aastal olid pea kõik puudega lastega pered selle väitega nõus (98-99%). Kuna peaaegu kõik on sellega nõus, siis ei ole võimalik tuua välja gruppidevahelisi erinevusi: kõiki puudega laste gruppe puudutab teavitamise probleem ühtlaselt.

Seisukohtadega, et „puudega lastega pered peaksid ise otsima aktiivsemalt võimalusi oma toimetuleku parandamiseks“, ja et „puudega lastega pered saavad piisavalt kaasa rääkida neid puudutavates otsustes“ nõustujaid ja mittenõustujaid on enam-vähem ühepalju, ca 40%. Väitega, et pered peaksid ise olema aktiivsemad oma toimetuleku parandamisel, on nõus 38-42% ja sellega ei ole nõus 42-46%. Väitega, et puudega lastega pered saavad piisavalt kaasa rääkida, on nõus 35-39% ja vastu 40-44%.

Võrreldes 2009. aastaga ei ole statistiliselt olulist erinevust nende osakaalus, kes leiavad, et puudega laste pered saavad rääkida piisavalt kaasa neid puudutavates otsustes. Nende osakaal, kes leiavad, et puudega laste pered peaksid ise olema aktiivsemad oma toimetuleku parandamisel, oli 2009. aastal rohkem: 2009. aastal oli sellisel seisukohal 53-60% puudega laste peredest, käesolevas uuringus aga 38-42%.

Joonis 186. Puudega laste perede kohta käivad väited (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid. Joonisel on ühendatud „pigem nõus“ ja „täiesti nõus“ vastusevariandid ning „pigem ei ole nõus“ ja „üldse ei ole nõus“ vastusevariandid.

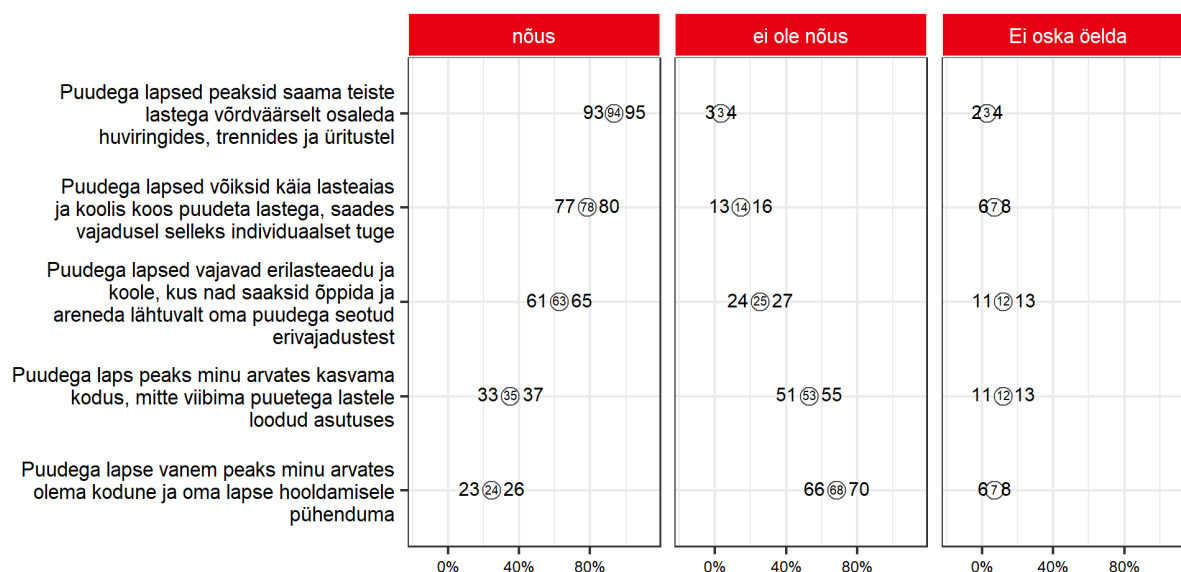
Kaasarääkimise võimalusi hindavad piisavaks muude samade tingimuste korral põhiharidusega inimesed rohkem ning kõrgharidusega vähem. Jättes kõrvale need, kes ei oska seisukohta võtta, leiab põhi- või madalama haridusega vanematest 55-70%, et kaasarääkimise võimalused on piisavad. Kõrgharidusega inimeste hulgas on selliseid oluliselt vähem – 33-41%. Puudega laste peresid ühendavate organisatsioonide abi hindavad kõrgemalt kõrgharidusega inimesed (seda, et ühendustest on abi, leiavad 81-88% kõrgharidusega vanematest, 72-79% kesk- või kutseharidusega vanematest ja 67-82% põhi- või madalama haridusega vanematest). Erinevused haridustasemetel jäävad püsima ka siis, kui võrrelda samasuguste taustatunnustega laste vanemaid⁵². Seega on kõrgema haridusega inimeste seas rohkem selliseid, kes tahavad olla kaasatud ning hindavad kõrgemalt ühendusi ja nende potentsiaali. Madalama haridustasemega inimeste oskus ja võimekus kaasa rääkida ning vastavalt ka ise infot kätte saada on nõrgem ning sellised pered vajavad seetõttu eraldi tähelepanu.

Vene keelt koduse keelena rääkivad inimesed hindavad kaasarääkimise võimalusi positiivsemalt (kaasarääkimise võimalusi hindavad piisavaks 34-39% eestikeelsete puudega laste perede vanematest ja 70-78% venekeelsete perede vanematest).

Valdav osa puudega laste vanematest leiab, et puudega laste osalemine huviringides, üritustel ja treeningutel peaks olema võrdväärne teiste lastega (93-95%) (Joonis 187). Laialdane on toetus sellele, et puudega lapsed võiksid õppida koos puudeta lastega, saades selleks vajalikku individuaalset tuge (77-80%). Samas on veidi väiksem osa, aga siiski kaks kolmandikku puudega lastega peredest seisukohal, et puudega lastel on vaja erilasteaedu ja -koole, kus nad saaksid õppida lähtuvalt puudest tulenevast erivajadusest (61-65%). Seega ühelt poolt toetatakse hariduslikku kaasamist, kuid samaaegselt toetatakse ka eraldamist. Sellist seisukohta selgitavad erinevad ootused erinevate puudeliikide ja puude raskusastmetega laste õppimise võimalustesse.

⁵² Kõik gruppidevahelised hinnangud põhinevad selles peatükis logit-regressioonidel, millega võetakse samaaegselt arvesse erinevate taustategurite mõju. Mudelid on koostatud nii, et sõltuv muutuja on 1, juhul, kui inimene nõustub või pigem nõustub väitega, ja null juhul, kui inimene pigem või üldse ei nõustu. Vastajad, kes vastasid „ei oska öelda“, on analüüsist välja jäetud. Mudelitesse on lülitatud järgmised sõltumatud muutujad: puude liik, puude raskusaste, lapse vanuse grupp, kodune keel, elukoha regioon ja tüüp, vastaja haridustase.

Joonis 187. Väited puudega laste ühiskonda integreerimise kohta (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskvärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid. Joonisel on ühendatud „pigem nõus“ ja „täiesti nõus“ vastusevariandid ning „pigem ei ole nõus“ ja „üldse ei ole nõus“ vastusevariandid.

Puudega laste osalemist treeningutel ja huviringides teistega võrdväärselt toetavad veidi vähem põhiharidusega vanemad (89-96% puudega laste põhi- või madalama haridusega vanematest ja 95-98% kõrgharidusega vanematest).

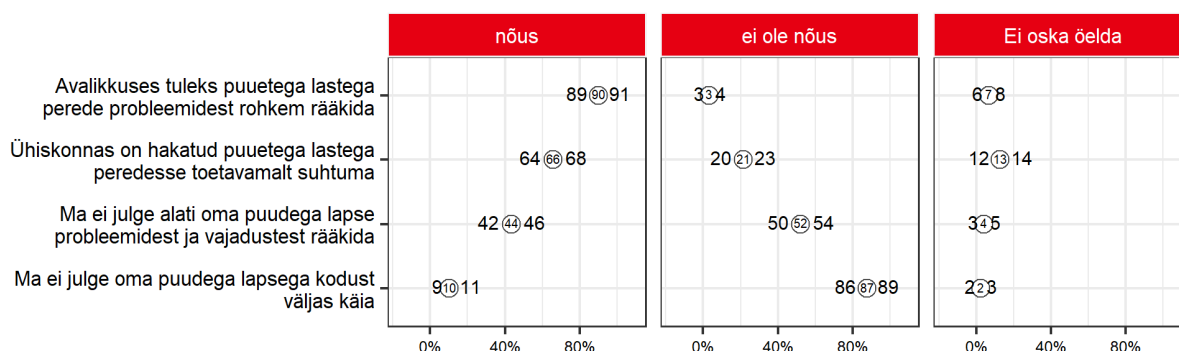
Tallinnas elavad puudega laste vanemad toetavad suhteliselt rohkem erikooli ja erilasteaedu (69-79% võrreldes maa-asulates elavatega laste vanematega, kellest seda toetas 61-69%). Neid toetavad teistest enam muude samade tingimuste korral ka sügava puudega laste vanemad (74-89%), võrreldes raske puudega laste (67-73%) ja keskmise puudega laste vanematega (68-75%ga).

Kolmandik (33-37%) vastajatest leiab, et puudega laps peaks kasvama kodus, mitte viibima puuetega lastele loodud asutuses. 2009. aastal olid sellisel seisukohal ligi pooled vastajad. Seega on praegu neid, kes leiavad, et puudega lapsed võiks kodu asemel kasvada ka puuetega lastele loodud asutuses, rohkem kui neid, kes arvavad, et laps peaks kasvama kodus. Selliseid inimesi, kes leiavad, et laps peaks kasvama kodus, on enam eesti keelt kõnelevate inimeste seas (eestikeelsetest peredest 45-50%) kui venekeelsete perede seas (18-26%).

Kaks kolmandikku või veidi enam (66-70%) ei nõustu sellega, et puudega lapse vanem peaks olema kodune ja pühenduma lapse hooldamisele (pea sama palju oli väitega mittenõustujaid ka 2009. aastal). Ka seda hoiakut selgitavad vastaja haridustase ja kodune keel. Madalama haridusega ja vene keelt koduse keelena rääkivad inimestest enamad on seisukohal, et puudega lapse vanem peaks olema kodune. Kõrgharidusega vanematest on sellisel seisukohal 17-23%, kesk- või kutseharidusega vanematest 26-32% ja põhi- või madalama haridusega vastajatest 28-41%. Venekeelsetest peredest pärit puudega laste vanematest on sellisel seisukohal 32-41% ja eestikeelsetest 20-25%.

Valdav osa (89-91%) puudega laste vanematest on nõus, et avalikkuses tuleks puudega lastega peredest rohkem rääkida (Joonis 188), ning see tulemus on analoogne 2009. aasta tulemusega (2009. aastal oli nõustujaid mõne protsendipunkti võrra enam). Väitega, et ühiskonnas on hakatud puudega laste peredesse positiivsemalt suhtuma, on nõus kaks kolmandikku (64-68%) ja see on samuti sarnane 2009. aastaga.

Joonis 188. Väited puudega laste avalikust kuvandist (% puudega lastest)



Märkus: ringid tähistavad keskväärtuse punkthinnanguid, ringidest vasakul ja paremal on 95%lised usalduspiirid. Joonisel on ühendatud „pigem nõus“ ja „täiesti nõus“ vastusevariandid ning „pigem ei ole nõus“ ja „üldse ei ole nõus“ vastusevariandid.

Põhi- või madalama haridusega puudega laste vanemate seas on vähem neid, kes leiavad, et puudega laste probleemidest tuleks rohkem rääkida (86-94%, kõrgharidusega vanematest 95-98%). Sügava puudega laste vanemate seas seevastu olid kõik seisukohal, et puudega laste probleemidest peaks rohkem rääkima. Raske ja keskmise puudega laste vanematest oli sellisel seisukohal vastavalt 96-98% ja 93-96%.

Nende vastajate osakaal, kes ei julge oma puudega lapse probleemidest rääkida ja ei julge lapsega kodust väljas käia, on käesolevas uuringus suurem kui 2009. aastal. Veidi vähem kui pooled (42-46%) ei julge oma puudega lapse probleemidest alati rääkida (2009. a 26-27% vastajatest) ja kümnendik (9-11%) lapsega väljas käia (2009. a 5-6% vastajatest). Sellist muutust võrreldes 2009. aastaga võivad selgitada erinevad tegurid, nagu näiteks oluline puudega laste ja psüühikahäirega laste arvu kasv, aga üheks osaks on ka küsitluse tehniline lahendus, mis erines 2009. ja 2017. aastal. 2009. aasta küsitlus viidi ellu näost näkku küsitlusena ja praegune uuring peamiselt veebiküsitlusena. Kuna puudega lapsega väljas käimine ja probleemidest rääkimine on delikaatsed teemad, siis võib olla, et näost näkku küsitluse korral ei sõandanud inimesed neid probleeme tunnistada ning seetõttu on osakaalud väiksemad.

Lapsega välja minemise probleem on teravam sügava puudega laste korral, kellest 16-32%ga ei julge vanemad väljas käia (raske puudega lastest 11-15% ja keskmise puudega 4-7%).

Vaimupuude (12-31%), liitpuude (11-17%) ja psüühikahäirega (17-27%) lastega esineb seda probleemi sagedamini kui keele- ja kõnepuude (5-14%), kuulmispuude (0-12%), liikumispuude (3-10%) ja muu puudega (2-5%) lastel.

Samuti on see probleemiks vene keelt koduse keelena kõnelevatest inimestest (13-19% puudega laste peredest) suuremale osale kui eesti keelt kõnelevatest (7-10%).

11-15-aastaste puudega lastega inimeste seas on see probleem harvem (5-9%) võrreldes nooremate lastega (0-6-aastastest 9-14% ja 7-10-aastastest 9-14%).

Samuti on probleemidest rääkimine keeruline enamatele psüühikahäirega laste vanematele (52-63%) võrreldes teiste puudeliikidega (keeles- ja kõnepuue 38-53%, kuulmispuue 21-50%, nägemispuue 13-48%, liikumispuue 29-46%, muu puue 36-44%, liitpuue 44-52%). Vaimupuudega laste kohta saab väga laiaade usalduspiiridega hinnanguid, mistõttu ei eristu nad selgelt (42-65% vaimupuudega laste probleemidest on vanematel keeruline rääkida).

Kodus vene keelt kõnelevate laste vanemate seas on neid, kes ei julge alati oma lapse probleemidest rääkida (52-61%), rohkem võrreldes eesti keelt rääkivate lastega (39-44%).

Kokkuvõttes ei ole võimalik 2009. aastaga võrreldes tuua välja muid olulisi erinevusi hoiakutes, kui praeguse uuringu järgi ligi kaks korda suurem osakaal vanemaid, kes ei julge lapse probleemidest rääkida ja lapsega väljas käia. Erinevad on hoiakud eesti ja vene keelt kõnelevatel peredel ning kõrgema ning madalama haridustasemega vanematel. Samuti on erinevusi hoiakutes lapse puudeliikide ja puude raskusastmete lõikes, mis peegeldavad erinevaid kogemusi.

11 Tulemused, järeldused ja soovitus

11.1 Puudega laste arv ja jagunemine

Puudega laste arv on 2009. aastast 2017. aastaks peaaegu kahekordistunud, samuti on puudega laste osakaal kõigist lastest kasvanud ligi kahekordseks. 2017. a 1. jaanuari seisuga oli Sotsiaalkindlustusameti andmetel Eestis 12 896 puudega last. Kasvanud on keskmise ja raske puudega laste arv, sügava puudega laste arv on jäänud samaks. Puudeliigiti on kasvanud kõigi puuete, välja arvatud mee- ja liikumispuudega laste arvud. Eriti suur on kasv olnud keele- ja kõnepuudega laste ning vaimupuudega laste arvudes.

Puudega laste arvu kasvu põhjuseid ei ole küsitlusandmete põhjal võimalik tuletada. Võimalikud selgitused, millest tulenevalt võib puudega laste arv olla kasvanud, on fookusgrupi arutelu põhjal järgnevad:

- 1) Haiguste diagnoosimise kasv. Juba varemalt eksisteerinud haiguseid diagnoositakse rohkem, diagnoositud haigus annab õiguse puude taotlemiseks ja seetõttu on rohkem puudega lapsi.
- 2) Meditsiini areng, mistõttu puudega lapsed elavad kauem.
- 3) Kasvanud on lapsevanemate teadlikkus sellest, et puue annab ligipääsu osadele tasuta teenustele, ja sellepärast taotletakse lapsele puue, mida analoogselt olukorras olnud lapse puhul varem poleks tehtud.

Puudega laste arvu kasvu ei saa lugeda negatiivseks nähtuseks. Laste puudest tulenevate erivajaduste märkamine ja lapse jõudmine läbi puudestaatuse vajaliku abi, teenuste ja toetusteni on positiivne. Puudega laste suurem arv näitab, et lapsele abi otsivaid vanemaid on rohkem. Siiski viitab võimalik olukord, kus puuet taotletakse vaid üksiku teenuse saamiseks, mille kättesaadavus haridussüsteemi kaudu on piiratud (nt logopeedi teenus), vajadusele üle vaadata, millistel alustel lapsed erinevate riiklike süsteemide kaudu teenuseid saavad ja mis eristab erinevate süsteemide kaudu pakutavaid teenuseid.

11.2 Kõrvalabi vajadus

Puudega laste vanematel paluti hinnata lapse kõrvalabi vajadust erinevate tegevuste juures: õppimisel ja muudel tegevustel koolis või lasteaias, suhtlemisel, kodus ja väljaspool kodu liikumisel, enda eest hoolitsemisel ning vaba aja veetmisel. Pea kõik puudega lapsed vajavad kõrvalabi vähemalt ühe küsitud tegevuse juures – kõrvalabi ei vaja vaid umbes 8% puudega lastest. Levinuim on kõrvalabi vajadus koolis või lasteaias (81–84% puudega lastest vajavad selles kõrvalabi). Suhtlemisel, väljaspool kodu liikumisel, enese eest hoolitsemisel ja vaba aja veetmisel vajab kõrvalabi 58–64% puudega lastest. Vaid kodus liikumisel vajab kõrvalabi väiksem osa, s.o viiendik kuni veerand puudega lastest.

Puudeliigiti on kõrvalabi vajadus erinev. Kodus liikumisel on suhteliselt suurem abivajadus nägemis-, liikumis- ja liitpuudega puudega lastel, väljas liikumisel lisanduvad neile ka vaimupuude ja psüühikahäirega lapsed, kelle abivajadus on teiste puudeliikidega võrreldes suurem. Suhtlemisel esineb kõrvalabi vajadust teiste puudeliikidega lastest harvemini muu puude ja liikumispuudega lastel. Enda eest hoolitsemisel esineb teistest puudeliikidest harvem kõrvalabi vajadust kuulmispuudega lastel. Liitpuudega lastel esineb kõrvalabi vajadust suhteliselt sagedamini kõikide tegevuste juures. Vaatamata sellele, et leidub mõningaid erinevusi, esineb iga käsitletud tegevuse puhul kõrvalabi vajadust kõikide puudeliikidega laste seas.

Puudega laste vanemate tunnetatud laste kõrvalabi vajadus on enamiku tegevuste juures vene keelt koduse keelena kõnelevate seas suhteliselt väiksem kui eesti keelt koduse keelena kõnelevate seas. Sellise olukorra selgituseks pakuti fookusgrupi intervjuus kultuurilisi erinevusi, mille tõttu vene keelt koduse keelena kõnelevad inimesed pelgavad rohkem sildistamist. Kartus, et lapse puudega kaasneb sildistamine, viib ka selleni, et kõrvalabi vajadust tunnistatakse harvem ja abi otsitakse vähem.

Kõrvalabi vajadusel esineb erisusi ka lapse vanuse ning puude raskusastme lõikes – kõrvalabi vajavaid on enam nooremate ja sügava puudega laste seas, sõltumata kõrvalabi valdkonnast. Sealjuures ilmnes, et nooremate seas on nende vanemate hinnangul kõrvalabi vajavaid rohkem ka siis, kui elimineerida teiste taustatunnuste mõju. Tõenäoliselt ei osanud lapsevanemad eristada puudest tulenevat kõrvalabi vajadust lapse vanusest tulenevast kõrvalabi vajadusest. Seetõttu tuleks lapse puudest tulenevat kõrvalabi vajadust hinnata pigem objektiivsetel alustel, mida küsitlusuuring, kus käsitletakse vanemate hinnanguid, ei võimalda. Samuti tuleks kõrvalabi vajadusest detailsema ülevaate saamiseks käsitleda lisaks kõrvalabi vajamisele või mittevajamisele ka abivajaduse määra.

11.3 Abivahendid

Umbes pooled puudega lastest vajavad igapäevaseks toimetulekuks mingit abivahendit. Kahte või enam abivahendit vajab ca 16% puudega lastest. Teatud abivahendite vajadus on selgelt puudespetsiifiline, kuid mõnede abivahendite osas on vajadus ka laiem ehk vajadus ei sõltu (ainult) puude liigist. Kõige sagedamini esineb puudega laste seas vajadust nägemisabivahendite järele (17-21% puudega lastest). Kuigi nägemisabivahendeid vajavad pea kõik nägemispuudega lapsed, leidub nägemisabivahendite vajajaid ka kõikide muude puudeliikidega laste seas. Kuulmisabivahendid on väga puudespetsiifilised ning neid vajavad eelkõige kuulmispuudega lapsed, kuid ka liitpuude, keele- ja kõnepuude ning muu puudega laste seas leidsid mõned lapsed, kellel oli neid vaja. Teistest enam vajavad liikumisabivahendeid ning proteese ja ortoosse liikumis- ja liitpuudega lapsed, kuid neid abivahendeid on vaja väikesel osal kõikide puudeliikidega lastest. Pöetus- ja hooldusabivahendeid on teistest puudeliikidest enam vaja muu puude, liikumispuude, liitpuude ja vaimupuudega lastel. Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendite vajajate osakaal on kõrgeim nägemispuudega laste seas.

Uuring näitab, et üldjuhul, kui lapsel on abivahendit vaja, siis ta seda ka kasutab. See tulemus on analoogne 2009. aasta tulemustega. Nägemisabivahendeid, pöetus- ja hooldusvahendeid ei kasuta vaid vähem kui 5% nende vajajatest. Teiste abivahendite vajajate hulgas on nende mittekasutajaid 5–15%. Veidi suurem on probleem spetsiifiliste suhtlus- ja teabevahenditega, mille mittekasutajaid on 17-37% neist, kellel on neid abivahendeid vaja. Spetsiifiliste suhtlus- ja teabevahendite vajajaid on vaid 3-5% puudega lastest ja kokku pole abivahendeid kasutada mittesaavaid lapsi palju.

Põhjendused abivahendite mitte kasutamiseks on majanduslikud (kas on abivahend ise liiga kallis või on lapse kasvamise ja abivahendi kasutamise tõttu seda vaja sageli vahetada), sobiva abivahendi puudumine, info puudumine abivahendite saamise kohta, pikad ootejärjekorrad või poldud küsitluse toimumise hetkeks jõutud veel abivahendit soetada.

Lapse vajadusele mittevastavate abivahendite kasutamine on suhteliselt vähelevinud. Enamike abivahendite vajajate hulgas on neid, kelle abivahend ei vasta tema vajadustele, ligikaudu kümnendik. Selliste laste osakaal, kellel abivahend ei vasta vajadustele, on suurim liikumisabivahendite puhul (8-18% liikumisabivahendeid vajanud lastest).

Abivahendite vajaduse ja kasutamise analüüsis eristusid mõned abivahendite kategooriad, mille kättesaadavust ja laste vajadustele vastavust tuleks põhjalikumalt edasi analüüsida, et hinnata, kas abivahendite tagamise süsteemis on vajalik teha muudatusi. See puudutab spetsiifiliste suhtlus- ja teabevahendite mittekasutamist ja vajadustele mittevastavate liikumisabivahendite kasutamist. Küsitlusuuringuga pole võimalik hinnata, millest selline olukord on tingitud ja kas nimetatud abivahendite kategooriate suhteliselt halvem kättesaadavus on aktsepteeritav või mitte.

11.4 Tervishoiuteenused

Tervishoiuteenustest on valdaval enamikul puudega lastest olnud viimase 12 kuu jooksul vaja perearsti (90–93%), eriarsti (89–92%) ja hambaarsti (76–80%). Erakorralise meditsiiniabi ja haiglaravi vajadus on olnud ligi kolmandikul puudega lastest, seejuures on erakorralise meditsiiniabi vajadus olnud veidi sagedasem kui haiglaravi vajadus. Eri- ja perearsti külastanud jagunevad enam-vähem võrdselt nende vahel, kes külastasid arsti 1–2 korda, 3–5 korda ja 6 või enam korda. Erakorralise meditsiini teenust kasutanud ja haiglaravil viibinud on seda teinud valdavalt 1–2 korda viimase aasta jooksul, 3–5 korda on kasutanud vähem kui viiendik ja enam kui kuus korda vähem kui kümnendik neist, kes vajasisid teenust. Neid, kes pole üldse saanud perearsti või eriarsti teenust, on kuni paar protsenti puudega lastest. Erakorralise meditsiini ja hambaarsti teenust pole neist, kes teenust vajasisid, üldse saanud 2–5% ja haiglaravi 5–9%.

Eriarstiabiga on olnud probleeme ca pooltel teenust kasutanutest. Perearsti- või pereõe-, hambaravi- ja haiglaraviteenusega on probleeme olnud ca kolmandikul teenust kasutanutest ja erakorralise meditsiiniabi teenusega 33–40%. Perearsti või pereõe-, eriarsti- ja hambaraviteenuse kasutamisel sagedamini esinenud probleemid on pikk ootejärjekord ja raskused aja broneerimisega. Erakorralise meditsiiniabi ja haiglaravi teenusega seoses oli samuti peamiseks probleemiks pikk ootejärjekord. Kõiki muid probleeme esineb oluliselt vähem.

Taastusraviteenuse vajadus on enam kui pooltel puudega lastest (57–61% puudega lastest), hooldusravi vajadus 6–8% ja koduõendusteenuse vajadus vaid paaril protsendil (2–3%) puudega lastest. Neist teenustest on kõige halvemini kättesaadav koduõendusteenus, mida ei ole saanud kasutada 70–91% neist, kes tunnetasid vajadust teenuse järele. Taastusravi ja hooldusraviteenusega ei ole olukord nii halb, kuid ka mitte hea. Taastusravi ja hooldusravi ei ole saanud üldse kasutada neljandik neist, kes seda vajasisid. Sealjuures on olukord hooldusraviga parem – seda on piisavalt saanud kasutada 61–76% teenust vajavatest puudega lastest ning taastusravi piisavalt kasutanuid on veidi alla poole (39–45%). Seega ei ole taastusravi, hooldusravi ja koduõendusteenuste kättesaadavus puudega laste jaoks olnud hea ning eriti kriitiline on olukord koduõendusteenusega, mida küll vajatakse vähem, aga vajaduse korral ei ole valdaval enamikul võimalik teenust üldse saada. On võimalik, et inimeste tunnetuslik vajadus ja koduõendusteenuse tegelik pakkumine on erinevad, st inimesed tunnetavad vajadust teenuse järele, kuid koduõendusteenus pole mõeldud sellise vajaduse katmiseks, nagu inimesed tunnetavad. Sellisel juhul tuleks tegeleda koduõendusteenuse alase informeerimisega, et inimesed mõistaksid, mida teenus sisaldab ning milliste vajaduste katmiseks see on mõeldud.

Alternatiivmeditsiini poole pöördunuid on alla viiendiku kõikidest puudega laste vanematest.

Tervishoiuteenused ei ole suunatud spetsiifiliselt puudega lastele, vaid üldiselt kõikidele inimestele. Kuigi puudega lapsed kasutavad tõenäoliselt tervishoiuteenuseid enam kui lapsed keskmiselt, ei võimalda praegune küsitlus võrrelda tulemusi kõikide Eesti laste olukorraga. Järgnevate puudega laste küsitluste kavandamisel on soovitatav kasutada ankeetides selliseid küsimusi, mis võimaldaksid võrrelda tulemusi mõne regulaarse tervishoiuteenuste vajaduse ja kättesaadavuse uuringuga.

11.5 Sotsiaalteenused

Peaaegu kõigil puudega lastel on vajadus vähemalt ühe sotsiaalteenuse järele (96–97%). Vajadus esineb kõigi uuringus käsitletud sotsiaalteenuste järele.

Rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise juhendamise ja hindamise teenust on kasutanud või vajanud, aga mitte kasutanud nelja viiendiku puudega laste vanemad⁵³. Rehabilitatsiooni raames pakutavaid psühholoogi (67-71%), füsioterapeudi (67-70%) või logopeedi (65-69%) teenust on vaja olnud kahel kolmandikul puudega lastest või enamatelgi.

Umbes pooltel puudega lastest on nende vanemate hinnangul vaja sotsiaaltöötaja nõustamist (50-54%), eripedagoogi (50-54%) või tegevusterapeudi (49-53%) teenust. Loovterapeudi ja tugiisiku teenust on vaja ca 40%l puudega lastest (vastavalt 41-45% ja 38-43%). Veerandil on vaja lapsehoiu (25-29%) või kogemusnõustaja (24-28%) teenust ja viiendikul (18-21%) sotsiaaltranspordi teenust.

Tegevusterapeudi, loovterapeudi ja kogemusnõustaja teenus on sellised, mille puhul puudega laste vanemad märkisid oluliselt sagedamini kui teiste teenuste puhul, et nad ei tea seda teenust või ei oska hinnata vajadust teenuse järele.

Tegevusterapeudi teenust ei tea või ei oska selle vajadust hinnata kuni viiendik, loovterapeudi teenust ligikaudu veerand ja kogemusnõustaja teenust veidi enam kui kolmandik puudega laste vanematest. Psühholoogi, füsioterapeudi ja logopeedi teenust ei tea või ei oska selle vajadust hinnata ca 5% puudega laste vanematest. Selline tulemus viitab asjaolule, et tegevusterapeudi, loovterapeudi ja eriti kogemusnõustaja teenused on uued ja/või ei ole inimesed nende teenuste olemasolust teadlikud ning ei oska seega ka formuleerida oma seisukohta nende vajaduse osas.

Sotsiaalteenuste kättesaadavus on halb. Kaks kolmandikku puudega lastest, kelle vanemad on tunnetanud teenuse vajadust, on saanud enamikku teenustest vähem kui vaja või üldse mitte. Rehabilitatsiooniplaani koostamise ja täitmise juhendamise ning sotsiaaltöötajapoolse nõustamise teenuse saamisega ei olda nii rahulolematud. Neid on saanud piisavas mahus enam kui pooled lastest, kellel seda on vaja olnud. Kõige suurem on suhteline puudujääk sotsiaaltranspordi, tugiisiku ja lapsehoiuteenuse osas, mida ei ole üldse saanud ligi pool neid teenuseid vajanutest. Nimetatud kolm teenust on sellised, mille üldine vajadus on suhteliselt väiksem.

Fookusgrupiintervjuus toodi välja, et halvemini kättesaadavad on kõik KOVide poolt puudega lastele pakutavad teenused. Leiti, et KOVi teenuste osas on üldisemaks probleemiks valitsev oskamatus sotsiaalteenuseid kujundada ja pakkuda ning prioriteetid, mis ei toeta puudega lastega perede toimetulekut. Seetõttu on KOVide poolt pakutavad sotsiaalteenused kujunenud ka raskemini kättesaadavaks. Seda probleemi võimendab teenusepakujate puudumine (tugiisiku ja lapsehoiuteenuse pakujate vähesus) ja paindlikkuse puudumine, mis aitaks teenuseid viia vastavusse perede vajadustega.

Sotsiaaltranspordi viimiseks paremasse vastavusse perede vajadustega pakuti fookusgruppis välja järgmised soovitusel:

- 1) Puudega lastega perede vajadustele vastavuse tagamiseks tuleks üle vaadata sotsiaaltranspordi marsruudid. Mõningatel juhtudel võib sotsiaaltranspordi asendada ühistranspordiga, kui marsruute muuta (nt marsruuti veidi pikendada).
- 2) Puudega laste koolibussis peaks lisaks bussijuhile olema saatja, kes aitab bussiga sõitvaid lapsi ja hoiab bussi korda.

⁵³ Rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise juhendamise või tulemuste hindamise teenus on teistest käsitletud teenustest erinev, kuna see on eeldus rehabilitatsiooniteenuste saamiseks. 2016. aastal lisandusid rehabilitatsiooniplaanile alternatiividena rehabilitatsiooniprogramm ja tegevuskava. Kuna rehabilitatsiooniplaan on varasemalt olnud eeldus rehabilitatsiooniteenuste saamiseks, siis võib olla tunnetatud vajadus selle teenuse järele sisuliselt erinev teiste teenuste tunnetatud vajadusest.

Küsitlustulemustest ilmneb, et sotsiaaltranspordi kättesaadavus on halvem alla 7-aastastele lastele. Fookusgrupist selgus, et sotsiaaltransport toimib väga paindumatult ning on kasutatav ainult laste kodust-kooli ja koolist-koju sõiduks, kuid mitte näiteks huviringides käimise vmt otstarbel.

Eelnevast lähtuvalt tuleks üle vaadata, millised on puudega laste transpordivajadused, ning hinnata, kas ja kuidas saaks kohandada teenuseid täiendavatele sihtrühmadele ning erinevatel eesmärkidel transpordi tagamiseks.

Tugiisiku ja lapsehoiuteenus on mõlemad raskesti kättesaadavad ja muid tingimusi arvesse võttes on keskmise puudega lastele raskemini kättesaadavad kui sügava ning raske puudega lastele. Teenuste põhiline probleem on sobivate teenusepakkujate nappus. Fookusgrupist ilmnas, et teenusepakkujate nappuse tõttu on lähedased sunnitud neid toetavaid tegevusi ise tegema. Süsteem on üles ehitatud aga selliselt, et juhul, kui leiduks teenusepakkuja, saaks pere kasutada riiklike ja kohalike omavalitsuste poolt finantseeritud teenust, kui aga teenusepakkujat pole, on pere sunnitud seda tegema ise ilma riikliku või kohaliku omavalitsuse rahalise finantseeringuta. Pered kasutavad oma toimetuleku parandamiseks näilikke tehinguid, kus tugiisiku või lapsehoidjana pannakse kirja keegi, kes selleks kvalifitseerub, kuid tegelikkuses teenust ei paku, ja pere korraldab vajaliku toe oma pereliikmete seas. Fookusgrupis pakuti lahendusena, et tuleks võimaldada riikliku ja/või kohaliku omavalitsuse poolt finantseeritud tugiisikuna töötada ka lapse pereliikmetel.

Lisaks teenusepakkujate nappusele on probleemiks teenusepakkumise paindumatud tingimused, mis on määratletud kogumahuga. Sellised tingimused tekitavad olukorra, kus ettenähtud mahu lõppedes on pered sunnitud vajaliku toe ise korraldama. Juhul, kui näiteks pool aastat on võimalik teenust kasutada ja teine pool aastast ei ole, ei ole ka võimalik ülejäänud pereliikmete elu mõistlikult planeerida.

Eelnevast lähtuvalt oleks vaja:

- 1) Arvestades lapsehoiu ja tugiisiku teenuse halba kättesaadavust, mis osaliselt tuleneb usaldusväärsete teenusepakkujate nappusest, suurendada kvalifitseeritud ja usaldusväärsete teenusepakkujate arvu.
- 2) Vaadata ümber teenuse pakkumise tingimused ning võimaldada suuremat paindlikkust, et tagada teenuse järjepidev pakkumine.

Fookusgrupi arutelul ilmnas asjaolu, et KOVi poolt pakutava ja riiklikult toetatava tugiisiku ja puudega lastele suunatud lastehoiu teenuse saamiseks on vaja KOViga koostöös lapsele koostada juhtumiplaan⁵⁴. Puudega lapsed on süsteemide killustatuse tõttu sunnitud läbima eraldiseisvaid hindamisi, kus koostatakse individuaalsed plaanid lastele nii sotsiaalteenuste ja -toetuste kui ka haridusteenuste saamiseks. Selline hindamiste ning plaanide rohkus on probleemiks paljudele puudega lastega peredele ning arvestades varasemaid diskussioone ja soovitusi, loodeti pigem selliste hindamiste ja plaanide vähenemist. Selle asemel on tekkinud aga üks plaan juurde.

Puudega lastega perede vajadustest lähtuvalt tuleks vaadata üle kogu puudega laste toetamise süsteem, ühendada erinevad hindamised ja plaanid üheks ühtseks süsteemiks, mis ühe lapse puhul piirdub ühe hindamise ja ühe plaaniga vähemalt hariduse ja sotsiaalteenuste osas ning katab nii riiklike kui KOVi teenuseid.

Kuigi osa teenustest paistis silma teistest halvema kättesaadavusega, on pea kõikide teenuste kättesaadavus halb. Arvestades rehabilitatsiooniteenuste suuremat nõudlust, on neid teenuseid mittedaanud või ebapiisavas mahus saanud laste koguarv isegi suurem kui sotsiaaltranspordi, tugiisiku ja

⁵⁴ Juhtumiplaan on kohustuslik alates 1.01.2018 ESF kaudu rahastatud tugiteenuste.

lapsehoiuteenuse korral. Rehabilitatsiooniteenuste pakkumise kitsaskohti fookusgrupis eraldi ei arutatud. Sotsiaalteenuste kõige sagedasema probleemina on üldiselt välja toodud teenuste liialt väike maht (41–47% puudega laste jaoks) ja teenustele saamise pikk järjekord (39–44%), mis mõlemad viitavad ka ülejäänud sotsiaalteenuste osas teenusepakkujate nappusele või tingimustele, mille tõttu teenusepakkujad ei paku teenuseid piisavas mahus. Teistest probleemidest sagedasem on veel keeruline asjaajamise korraldus (33–39% puudega laste jaoks), mis on fookusgruupiintervjuu põhjal seotud eelkõige süsteemide killustatusega erinevate valdkondade (tervishoid, haridus ja sotsiaalvaldkond) ja tasemete (riik, kohalik omavalitsus) vahel.

Arvestades, et puudega laste arv on võrreldes 2009. aastaga pea kahekordistunud ja teenust vajavate laste osakaal puudega lastest ei ole 2009. aastaga võrreldes vähenenud, vaid pigem kasvanud, on sotsiaalteenuste vajadus samuti kahekordistunud. Samal ajal on sotsiaalteenuste kättesaadavus 2017. aastal halvem kui 2009. aastal – nende osakaal, kes said teenuseid kasutada vähem kui vaja või üldse mitte, on 2017. aastal suurem. Sotsiaalteenuste pakkumine peab olema järjepidev ja võrdsetel alustel kättesaadav. Selles valguses tuleks vaadata üle sotsiaalteenuste pakkumine ning korrastada ja kaaluda, mida on võimalik sellistel tingimustel pakkuda ja kuidas.

11.6 Haridus

Puudega lapsed on enamasti kaasatud haridussüsteemi, sellest kõrvale jäänud on vaid 2–4% lastest. Valdav osa lastest käib tavakooli ja tavalasteaia tavarühmas või -klassis. Lasteaias käivatest puudega lastest on erilasteaias 8–12% ja tavalasteaia erirühmas või sobitusrühmas 20–26%. Koolis käivatest puudega lastest on erikoolis 20–24% ja eriklassis 16–21%. Seega on nende laste osakaal, kes õpivad eraldatuna erivajadustega lastele mõeldud haridusasutustes, kooliealiste laste hulgas suurem kui lasteaiaealiste hulgas. Erilasteaedades ja erikoolides õpivad suurema tõenäosusega raske ja sügava puude raskusastmega lapsed.

Enim levinud probleemiks on nii koolis kui lasteaias tugimeetmete kättesaadavus haridusasutuses kohapeal. Lasteaias oli probleemiks, et rehabilitatsiooniteenuseid ei saa kohapeal, 40–48%le puudega lasteaiastest, koolis oli see probleemiks 31–36%le. Erinevate tugiteenuste kättesaadavuse probleem koolis või lasteaias oli sellest veidi vähem levinud. Seejuures on erikoolides ja erilasteaedades õppivate lastel tugimeetmete kättesaadavusega vähem probleeme kui tavakoolides või -lasteaidades õppivate lastel.

Küsitluse vabadest vastustest ja fookusgrupi arutelust selgus, et lapsevanemate jaoks on rehabilitatsiooniteenused ja nendega analoogsed hariduse tugiteenused haridussüsteemis sisuliselt kattuvad asjad, mida tuleks käsitleda ühtse süsteemina. Selleks oleks vaja, et praegu haridussüsteemi kaudu pakutavad hariduse tugiteenused saaks arvestada rehabilitatsiooniteenustena.

Erikoolides ja erilasteaedades õppivate lastel on vähem probleeme tugiteenuste saamise ning õppekvaliteedi vastavusega õpilase vajadustele ja võimetele, samas on neil teistest enam probleemiks kooli või lasteaia kaugus ja transpordi kulukus. Probleemide amplituud, mis hariduse omandamisel ilmneb, on väga lai, ulatudes tugiteenuste kättesaadavusest ja õppekavade sobivusest kuni elukoha vahetuseni, et üldse sobivas koolis kohta saada.

11.7 Hoolduskoormus

Erinevaid lapsehoidmise võimalusi on viimase 12 kuu jooksul kasutanud 53–57% puudega laste vanematest. Kõige enam esineb lastehoiuvõimalusena lastead või -sõim, mida kasutati 29–33% puudega laste hoidmiseks. Sageduselt järgmine on pikapäevarühm, mida kasutati 13–16% laste hoidmiseks, ja lapsehoidja,

kes tuleb lapse juurde koju (6–8%). Iga ülejäänud lapsehoidmise võimalust kasutati vähem kui 5% puudega laste jaoks.

Vanemate puudega laste jaoks on lapsehoidmise võimalusi kasutatud märkimisväärselt vähem kui nooremate laste hoidmiseks: 16-17-aastaste puudega laste hoidmiseks ei ole viimase 12 kuu jooksul kasutanud ühtegi lapsehoidmise võimalust 73-86% puudega laste peredest, seevastu 0-6-aastaste laste puhul ei ole kasutanud ühtegi lapsehoidmise võimalust 10-15% puudega laste peredest.

Senisest rohkem või täiendavaid lapsehoiuvõimalusi vajab 35-42% puudega laste vanematest. Kõige sagedasem on vajadus lapsehoidja järele, kes tuleb last hoidma lapse koju (14–17% puudega lastest). Sageduselt järgmine on vajadus pikapäevarühma parema kättesaadavuse järele (9–12% puudega lastest). Iga ülejäänud lapsehoiuvõimalust vajab täiendavalt vähem kui kümnendik puudega laste vanematest.

Oskus lapse puudest tulenevate erivajadustega toimetulekuks on nende vanema hinnangul vajalik ligi poolte puudega laste ja spetsiaalset ettevalmistust pole vaja kolmandiku puudega laste hoidmiseks. Viieendiku vanemate hinnangul on vaja puudega lapse hoidmisel kogemust.

11-13% puudega lastest on sellised, kelle hooldamisel ei abista lapsevanemat mitte ükski teine isik. Ligi poolte laste puhul aitab lapsevanemat vähemalt kord nädalas mõni teine leibkonnaliige. Vähemalt kord nädalas aitab lapsevanemat puudega lastest neljandiku puhul mõni teine pereliige või sugulane väljastpoolt leibkonda ja kümnendikul juhtudest tugiisik. 27–33% puudega laste vanematest hooldab lisaks puudega lapsele veel mõnda inimest kas leibkonnas või väljastpoolt leibkonda.

Lisaabi puudega lapse või teiste hooldatavate hooldamisel vajaks 34–40% puudega laste vanematest. See osakaal on seda suurem, mida suurem on lapse puude raskusaste. Tunduvalt suurem on lisaabi vajadus nendel vanematel, kellel endalgi on tuvastatud puue.

Puudega lastest kahel kolmandikul on vanemad, kes on pidanud hoolduskohustuste tõttu viimase 12 kuu jooksul töö või õpingute osas tegema järeleandmisi (loobuma tööst, võtma tööst vabu päevi/tunde, võtma hoolduslehte, vähendama õppekoormust jmt). Ligi 80% lastest on vanemad, kes on viimase 12 kuu jooksul teinud mõnda tegevust soovitusi vähem. Seejuures on kolmel neljandikul puudega laste vanematest olnud vähem aega lihtsalt puhkamiseks, neist 31% on puhkamiseks aega puudu jäänud sageli.

11.8 Eluruumide kohandamise vajadus

Puudega lastega perede eluruumid on keskmiselt sama suured kui kõigil Eesti lastega peredel. Puudega lastest 71-78% on eluruumid juba vastavaks kohandatud või ei vajagi kohandamist. Osalist või täielikku kohandamist vajab 16–21% puudega laste kodudest. Sügava puudega lastel esineb sagedamini vajadust kodu kohandamise järele (33-52% sügava puudega lastest). Kodu kohandamise vajadus on seotud pere majandusliku olukorraga – madalama sissetulekuga perede seas on rohkem selliseid, kelle kodu vajab kohandamist.

Kohandusi on tehtud on 22–28% puudega laste kodudest. Valdavalt on seda tehtud pere enda finantsidega. Kohandamisteenust on finantseerimiseks osaliselt kasutatud 1,3–4% ja ainult kohandamisteenust on kasutatud 0,6–3,1% kohandatud elukohtade puhul.

11.9 Rahaline toimetulek ja kulud

Probleeme puudega lastele suunatud toetuste taotlemisel on viimase aasta jooksul olnud ligikaudu pooltel puudega lastega peredel. Levinuimaks probleemiks on info puudus olemasolevate toetuste kohta (30-33% puudega lastest). Pea sama levinud probleemiks on selgusetus, kellel on õigus toetustele (28-31%) ja toetuste väiksus (23-27%). Keeruline ja pikk toetuste taotlemise protsess on olnud probleemiks vähemale kui viiendikule puudega laste peredest.

Infopuudus tuleneb osaliselt puudega laste toetamise süsteemist, mis on killustunud riigi ja kohaliku omavalitsuse ning paljude erinevate eriotstarbeliste toetuste vahel. Tegemist ei ole mingi kindla sihtrühmaga seotud probleemiga, vaid kõikide puudega lastega perede seas sarnase tõenäosusega esineva probleemiga. Olukord, kus kolmandik puudega laste vanematest tunnetab, et neil puudub info olemasolevate toetuste kohta, viitab vajadusele teha süsteemi selgemaks, läbipaistvamaks ja informeerida inimesi nende võimalustest ja õigustest.

Puudega laste pered hindavad oma toimetulekut keskmiselt halvemini kui Eesti lastega pered üldiselt. Kõikidest puudega lastega leibkondadest tajub vaid 20–26%, et tuleb toime hõlpsalt (sh vastusevariandid „üpriski hõlpsalt“, „hõlpsalt“, „väga hõlpsalt“). Kõikide lastega leibkondade hulgas on selliseid peresid 40–51%. 28–34% puudega lastega leibkondadest, kellel oli eluaseme kommunaalkulusid, ei suutnud neid viimase aasta jooksul ühel või enamal korral maksta (kõikide lastega leibkondade hulgas oli vastav osakaal ca 8–13%).

Ühtegi uuringus käsitletud kulutust puudega lapse tarbeks pole viimase 12 kuu jooksul olnud vaid 2% puudega lastega leibkondadel. Sagedamini esinev puudega lapse tarbeks tehtud kulutus on ravimitele, vitamiinidele ja toidulisanditele (86–89%). Transpordikulused on ca kolmel neljandikul leibkondadest (73–77%), ravi- ning rehabilitatsioonikulused veidi enam kui pooltel (52–57%) ja kulused abivahenditele on 39–43% puudega lastega leibkondadel. Iga ülejäänud kululiiki esineb vähem kui kolmandiku puudega laste peredel. Kõige suuremad kulud tekivad seoses eritoiduga (mediaankulu 80 eurot), jäädes 50% puudega laste leibkondade jaoks (kellel antud kulud on) vahemikku 40–120 eurot. Kõige varieeruvamad on kulud tugiisikule (jäädes 50% vastavate kuludega puudega laste leibkondade jaoks vahemikku 25–153 eurot). Kõige vähem varieeruv, aga samas kõige sagedamini esinev, on kulu ravimitele, vitamiinidele ja toidulisanditele, jäädes 50% puudega laste leibkondade puhul vahemikku 15–50 eurot kuus. Kuised transpordikulud jäävad pooltel leibkondadel 20 ja 100 euro vahele, samas maksimaalsed kulud ulatuvad ligi 200 euroni.

Sügava ja raske puude raskusastmega laste tarbeks tehtud kulutused on suuremad kui keskmise puudega laste tarbeks tehtavad kulutused. 50% leibkondadel jäävad sügava puudega lapse tarbeks tehtud kulutused vahemikku 119–339 (mediaan 196) eurot kuus, aga võivad ulatuda ka kuni 600 euroni. Lapse raske puude korral kulutavad pooled leibkonnad puudega lapse tarbeks 60–219 (mediaan 120) eurot ja keskmise puude korral 48–159 (mediaan 100) eurot kuus.

Kulude jaotus sõltub eelkõige puude raskusastmest ja liigist, aga ka lapse vanusest. Sügava ja raske puudega laste puhul on erinevaid kulusid enam ja need on suuremad kui keskmise puudega laste puhul. Kõige suuremad on kulud liitpuude korral.

Ligi veerand kuni kolmandik puudega laste leibkondadest hindab tehtud kulutusi eritoidule, lapsehoiule, ravi- ja rehabilitatsiooniteenustele ning ka muule liialt väikesteks, et katta puudega lapse vajadusi. Kõige halvem on olukord tugiisiku teenusega, millele tehtud kulutused pole peaaegu poolte puudega laste leibkondade hinnangul olnud piisavad. Enamasti ei ole lapse puudega kaasnevad lisakulutused peredele kaetud puudega laste toetusega, mis 2017. aastal on keskmise puude raskusastme korral 69,04 eurot kuus, raske ja sügava puude korral 80,55 eurot kuus. Üle poole (53–60%) on selliseid puudega lapsi, kelle puudest tulenevad lisakulutused on vanemate hinnangul vähesel määral või ei ole üldse toetustega kaetud.

Puudega lapsega kaasnevad suurele osale peredest lisakulud, mis on seotud lapse puudega. Puudega lapse toetus ei kata ühegi puude raskusastmega laste peredel lapse tarbeks tehtud kulutuste mediaani. Sügava puudega lapse toetus on väiksem kui 75% sügava puudega lastega perede kulud puudega lapsele (119 eurot või rohkem). Mida raskema puude raskusastmega on laps, seda varieeruvamad on perede kulud puudega lapsele.

11.10 Teave

Pooled puudega laste vanemad leiavad, et teave lastele suunatud toetuste ja teenuste kohta on pigem raskesti või väga raskesti kättesaadav. Lisaks ei oska veerand puudega laste vanematest info kättesaadavust hinnata. Seejuures on info kättesaadavus suuremaks probleemiks vene keelt koduse keelena kõnelevatele inimestele. Fookusgrupis seda teemat käsitledes toodi välja, et venekeelsed inimesed on nagu topeltmüüri taga – esmalt on teabe saamine toetuste ja teenuste kohta üldiselt väga keeruline, kuna süsteemid on killustunud ja puudub inimene, kellel üldse on olemas terviklik ülevaade puudega laste toetamise süsteemist erinevates valdkondades, ja teiseks leidub vähe venekeelset infot ning eestikeelne info ei ole nende jaoks täielikult mõistetu. Isegi eesti keelt teatud tasemel oskavale võrkeelsele inimesele on eestikeelne info raskesti mõistetu spetsiifiliste terminite tõttu.

Puudega lastega pered tunnetavad väga teravalt, et infot on vähe ja infot puudega lastele mõeldud toetuste, teenuste ja abi kohta saadakse killustatult erinevate kanalite kaudu. Kanalid, mille kaudu infot saadakse, hõlmavad võrdväärse tähtsusega nii formaalseid kanaleid, nagu SKA, KOV sotsiaaltöötaja, teenusepakkuja, nagu rehabilitatsiooniasutused ja arstid, kui ka informaalsete lapsevanemate võrgustikke. Infopuudus on laialdane alates puude taotlemise protsessist, kuni toetuste ja teenuste olemasoluni. Venekeelsetel peredel on infopuudus suurem kui eestikeelsetel.

Pea kõik puudega lastega pered on veendunud, et teavitussüsteem ja info jagamine puudega lastega perede õiguste, toetuste ja teenuste kohta peaks olema parem. Laias laastus pakuti välja kolm soovitusi, kuidas seda teha:

- 4) teavitada e-maili teel kõiki puudega lastega peresid võimalikest toetustest, teenustest ja soodustustest ning muudatuste korral uuendustest;
- 5) koondada kõik info nii riikliku, KOV tasandi kui ka erinevate valdkondade (tervishoid, haridus ja sotsiaalvaldkond) kohta ühele veebilehele;
- 6) kõikides KOVides peaks olema eraldi isik, kellel on ülevaade kõikidest teenustest, toetustest ja abist ning kellel on kohustus puudega laste peredele anda kõikne ülevaade.

Fookusgrupis ilmnas, et luua tuleks kõik nimetatud kolm kanalit puudega lastega perede paremaks informeerimiseks.

11.11 Soovitused järgnevateks uuringuteks

Puudega laste toimetulek on kompleksne teema, mille analüüsimiseks tuleb vaadata nii sotsiaal-, tervishoiu- kui haridussüsteemist saadavaid teenuseid ja erinevatel riigi tasanditel pakutavat abi ja toetusi. Suuremahuline puudega laste perede küsitlusuuring võimaldab erinevate teemade lõikes anda vaid üldise ülevaate puudega lastega perede olukorrast ja vajadustest, kuid muudab näiteks teenuste disaini parandamiseks vajaliku detailsema informatsiooni kättesaamise keerukaks. Samuti on ainult puudega laste sihtrühma põhise uuringu puhul piiratud võimalused teostada võrdlusi teiste Eesti lastega ja leibkondadega tervikuna. Soovitame üldist pilti kaardistavate uuringute kõrval kindlasti tähelepanu pöörata teemapõhiselt süvitsi minevate detailsemate uurimisküsimustega uuringute läbiviimisele, mis võimaldaksid anda täpsema pildi sihtrühma spetsiifiliste vajaduste ja olukorra kohta ning oleksid vajalikuks sisendiks valdkonna poliitikakujundmiseks. Näiteks annab käesolev uuring ülevaate, kui levinud on puudest tulenev kõrvalabi vajadus puudega laste seas ning milliste taustatunnustega on kõrvalabi vajaduse esinemine enam seotud. Samas ei ole uuringust võimalik saada informatsiooni selle kohta, milles kõrvalabi vajadus seisneb ning milline on kõrvalabi vajaduse määr – need asjaolud vajaksid põhjalikumalt käsitlust, kui seada eesmärgiks kõrvalabi vajaduse täpsem kaardistamine.

Kavandades järgnevaid uuringuid tuleks silmas pidada, et tegemist on väga mahuka uuringuga, millele vastamine on vastajatele suur koormus. Samuti ei toimu sihtrühma üldises toimetulekus ja vajadustes muutused väga kiiresti. Seetõttu oleks mõistlik teha üldiseid puudega lastega perede toimetulekut kaardistavaid küsitlusuuringuid mitte sagedamini kui viie aasta või pikemaajalise vahega. Edaspidiste uuringute läbiviimisel võiks puudega lastega perede toimetuleku kaardistamiseks kasutada (nii palju kui võimalik) samas sõnastuses küsimusi, mida on kasutatud teistes suuremahulistes elanikkonna küsitlustes (nt eesti sotsiaaluuringu küsimused). See võimaldaks võrrelda uuringu sihtgruppi ülejäänud elanikkonnaga, ilma vajaduseta koguda selleks täiendavaid andmeid võrdlusgrupilt (ka käesoleva küsitluse puhul kasutati juba väikses mahus sotsiaaluuringu küsimusi).

Ühtlasi soovitame põhjalikult kaaluda seda, millist infot koguda küsitlusuuringuga ja mida analüüsida registrite põhiselt. Küsitlusuuring on asjakohane eeskätt sellise info kogumiseks, mida ei ole võimalik registritest saada. Puudega laste sotsiaaldemograafiline profiil, puudega laste poolt kasutatavad teenused, nende mahud ja saadavad toetused peaksid olema registrite põhiselt kättesaadavad. Nende kaardistamine küsitlusuuringuga on põhjendatud ainult selliste andmete saamiseks, mis pole registritest kättesaadavad. Juhul, kui registripõhised andmed on puudulikud, siis tuleks võtta ette samme registrite andmekvaliteedi parandamiseks. Küsitlusuuringuga võiks eelkõige koguda infot teenuste ja toetuste kättesaadavuse piisavuse ja teenuste kvaliteedi kohta. Seega oleks käesoleva uuringu autorite hinnangul kõige otstarbekam kasutada tulevikus registriandmete analüüsi ja küsitlusuuringu kombinatsiooni.

Lisa. Küsitluse ankeet



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti
tuleviku heaks



SOTSIAALMINISTEERIUM



EESTI RAKENDUSUURINGUTE
KESKUS CENTAR

Turu-uuringute AS

PUUETEGA LASTEGA PEREDE TOIMETULEKU JA VAJADUSTE UURING 2017

SISSEJUHATAV TEKST (AINULT SILMAST SILMA ANKEEDILE)

Viime koostöös Eesti Rakendusuuringu Keskusega CentAR ning Sotsiaalministeeriumiga läbi uuringut eesmärgiga selgitada puudega last kasvatavate perede toimetulekut ning vajadusi. Sooviksime Teie perest küsitleda inimest, kes puudega lapse eest hoolitsemisega kõige rohkem tegeleb. Ankeedi küsimustele vastamine ei eelda mingeid eriteadmisi.

Küsitluses osalemine on vabatahtlik. Olete valimisse sattunud juhuvalikuga Sotsiaalkindlustusameti registrist. Teie vastused jäävad anonüümseks ning neid ei seostata edasises analüüsis Teie isikuga. Intervjuu kestab umbes 40 minutit.

Hea vastaja, olete alustamas puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuringu küsimustele vastamist.

Küsitlusele vastamiseks on vajalik Teie nõusolek isikuandmete töötlemiseks. See on isikuandmete kaitse seadusest tulenev nõue. Nõusolekut andes kinnitate, et olete nõus enda ning oma leibkonnaliikmete isikuandmete (vanus, sugu, elukoht (linna või valla tasandil)), sh delikaatsete isikuandmete (puude raskusaste ja puudeliik) kasutamisega uuringus.

Nõusolekut on võimalik ka pärast küsitlusele vastamist tagasi võtta. Seda on võimalik teha, kontakteerudes Turu-uuringute AS-iga telefonil +372 585 29 700 või e-posti aadressil: plu@туру-uuringute.ee.

Uuringu andmeid kogub (Isikuandmete vastutav töötaja) Turu-uuringute AS (Reg.nr. 10220984, aadress: Pärnu mnt. 102A, tel. 585 29 700, e-post: post@туру-uuringute.ee) ning isiku otsest tuvastamist mitte võimaldaval kujul analüüsib (volitatud töötaja) Eesti Rakendusuuringu Keskus CentAR OÜ (Reg.nr. 11343217, aadress: Nunne tn 5-3, tel. 6173306). Uuringu tellija on Sotsiaalministeerium.

Kinnitame, et kasutame Teie ning Teie leibkonnaliikmete isikuandmeid vaid uuringu läbiviimise ja puuetega laste ja perede toimetulekut toetavate poliitikameetmete kavandamise eesmärgil ning andmeid ei edastata teistele osapooltele. Vastutav töötaja tagab uuringus osalejatele anonüümset - Teie poolt antud vastuseid ei viida kokku Teie nime ega kontaktandmetega.

Palume Teie nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.

☐ **Jah, ma olen nõus enda ja oma leibkonnaliikmete isikuandmete tunnuste (sugu, vanus, elukoht) ning puudega last (vm puudega leibkonnaliikmeid) puudutavate delikaatsete isikuandmete (sugu, vanus, puude liik ja -raskusaste) töötlemisega uuringu teostajate Turu-uuringute AS-i ja Eesti Rakendusuuringu Keskuse CentAR ning uuringu tellija Sotsiaalministeeriumi poolt**

☐ **Ei, ma ei ole nõus enda ja oma leibkonnaliikmete isikuandmete töötlemisega, loobun küsitluses osalemisest**

OSA X. Vastaja taustainfo

Mõnede küsimuste juures näete nuppu /Abistav teave/, millele vajutades näete küsimuse kohta lisateavet.

X01. Palun valige ankeedi keel

1. Eesti keel
2. Vene keel

Alustuseks mõned küsimused Teie enda kohta

X02. Palun märkige oma elukoht:

Maakond _____
Vald/ alev/ linn _____

X03. Palun märkige oma vanus (täisaastates): _____

X04. Palun märkige oma sugu:

1. Mees
2. Naine

KÜSIDA X05 JUHUL, KUI ANKEEDI KEELEKS VALITI VENE KEEL (X01=2)

X05. Kas Te saate igapäevasuhtluses eesti keeles hakkama? PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Jah, raskusteta
2. Jah, kuid raskustega
3. Ei saa üldse eesti keeles hakkama
98. Ei oska öelda

X06. Milline on Teie kõrgeim lõpetatud haridustase? PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Põhihariduseta
2. Põhiharidus
3. Kesk- või gümnaasiumiharidus
4. Kutseharidus põhihariduseta
5. Kutseharidus põhihariduse baasil
6. Kutsekeskharidus põhihariduse baasil (sh keskeri-/ tehnikumiharidus pärast põhiharidust)
7. Kutseharidus keskhariduse baasil (sh keskeri-/ tehnikumiharidus pärast keskharidust)
8. Kõrgharidus (sh rakenduskõrgharidus)
99. Ei soovi avaldada

X07. Milline on Teie peamine sotsiaalne seisund? PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Töötav (palgatöötaja, ettevõtja, pereettevõttes töötav jms) →X08
2. Töötu, st ei tööta, otsib tööd ja on valmis sobiva töö leides 2 nädala jooksul tööle asuma →X09
3. Pensionär (ennetähtaegne- või vanaduspensionär) →X08
4. Õpilane/üliõpilane →X08
5. Muu mittetöötav (sh lapsehooldus- või rasedus- ja sünnituspuhkus) →X09
6. Muu, kes? _____ →X08
98. Ei oska öelda →X08

X08. Kui Te teete tasustatud tööd, siis millise koormusega Te töötate? PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Ei tee tasustatud tööd→X09
2. Täiskoormusega (35 või rohkem tundi nädalas) →X10
3. Osakoormusega (vähem kui 35 tundi nädalas) →X10
98. Ei oska öelda→X10

X09. Mis põhjusel Te ei tööta? VÕIB VALIDA MITU VASTUST

1. Õpingud koolis/ülikoolis
2. Rasedus- või sünnituspuhkus
3. Lapsehoolduspuhkus
4. Vajadus hoolitseda puudega lapse/laste eest
5. Vajadus hoolitseda puudeta lapse/laste eest
6. Vajadus hoolitseda puudega täiskasvanud pereliikme(te) eest
7. Vajadus hoolitseda puudeta täiskasvanud pereliikme(te) eest
8. Enda puude või terviseprobleemi tõttu
9. Ei ole leidnud oma erialale või oskustele vastavat tööd
10. Ei ole leidnud sobiva töökoormuse või -graafikuga tööd
11. Puudub transport, et saaks tööl käia
12. Ei soovi tööl käia
13. Muu, mis? _____
98. Ei oska öelda

X10. Kas Teil on hetkel kehtiv, ametlikult määratud puue? PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Jah→X11
2. Ei →LIIGU EDASI OSA A
98. Ei soovi avaldada →LIIGU EDASI OSA A

X11. Milline on Teile ametlikult määratud puude raskusaste? PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Keskmine
2. Raske
3. Sügav
98. Ei oska öelda

OSA A. LEIBKONNAPILT

Järgnevad küsimused on Teie leibkonna kohta. Nende küsimuste eesmärk on saada ülevaade leibkondadest, kus kasvab puudega laps (või lapsed), mis omakorda võimaldab leibkondade vajadusi paremini mõista.

Leibkonnaks nimetame inimesi, kes jagavad ühte elamispinda ning kasutavad ühiseid rahalisi ja/või toiduressursse. Leibkonna hulka kuuluvad lisaks ka need inimesed, kes elavad ajutiselt mujal kas õpingute, töö, kohustusliku ajateenistuse või muude sarnaste põhjuste tõttu, kuid sõltuvad majanduslikult Teie leibkonnast.

A01. Milline on Teie leibkonna peamine kodune keel? PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Eesti keel
2. Vene keel
3. Muu keel, milline?__

A02. Mitu inimest on peale Teie veel Teie leibkonnas? Palun ärge iseennast siia hulka arvestage!

Kirjutage arv: _____

Järgnevalt küsime iga leibkonnaliikme kohta täpsemalt.

Palume Teil esmalt märkida andmed puudega lapse kohta (kellele viidati uuringut tutvustavas kirjas).

		1 Puudega laps	2	3	4	5	6	...12
								
A03.	Sugu							
	1. Mees	1	1	1	1	1	1	1
	2. Naine	2	2	2	2	2	2	2
A04.	Vanus (täisaastates)							
	Juhul, kui isik on alla 1-aastane, siis märkige vastuseks „0“							
								
A05.	Milline on tema seos Teiega? PALUN MÄRKIGE IGA LEIBKONNALIIKME KOHTA ÜKS VASTUS							
	1. Teie laps (ka lapsendatud)	1	1	1	1	1	1	1
	2. Teie elukaaslase/abikaasa laps (ka lapsendatud)	2	2	2	2	2	2	2
	3. Teie või Teie elukaaslase/abikaasa kasulaps	3	3	3	3	3	3	3

4. Õde, vend	4	4	4	4	4	4	4
5. Teie abikaasa		5	5	5	5	5	5
6. Teie elukaaslane		6	6	6	6	6	6
7. Teie vanem/kasuvanem või tema elukaaslane		7	7	7	7	7	7
8. Teie või Teie elukaaslase/abikaasa vanavanem või tema elukaaslane		8	8	8	8	8	8
9. Teie või Teie elukaaslase/abikaasa lapselaps (ka lapsendatud)		9	9	9	9	9	9
10. Teie või Teie elukaaslase/abikaasa poja või tütre abikaasa või elukaaslane – minia või väimees		10	10	10	10	10	10
11. Äi, ämm		11	11	11	11	11	11
12. Muu sugulane, palun täpsustage: _____	12	12	12	12	12	12	12
13. Mittesugulane	13	13	13	13	13	13	13
99. Ei soovi avaldada	99	99	99	99	99	99	99

A06	Milline on tema <u>peamine</u> sotsiaalne seisund? PALUN VALIGE ÜKS VASTUS	1	2	3	4	5	6	7
	1. Töötav (palgatöötaja, ettevõtja, pereettevõttes töötav jms) →A07	1	1	1	1	1	1	1
	2. Töotu, st ei tööta, otsib tööd ja on valmis sobiva töö leides 2 nädala jooksul tööle asuma →A08	2	2	2	2	2	2	2
	3. Pensionär (ennetähtaegne- või vanaduspensionär) →A07	3	3	3	3	3	3	3
	4. Õpilane/üliõpilane →A07	4	4	4	4	4	4	4
	5. Koolieelik →A09	5	5	5	5	5	5	5
	6. Muu mittetöötav (sh lapsehooldus- või rasedus- ja sünnituspuhkus) →A08	6	6	6	6	6	6	6
	7. Muu, kes? _____ →A07	7	7	7	7	7	7	7
	98. Ei oska öelda →A07	98	98	98	98	98	98	98

A07	KÜSIDA VÄHEMALT 16-AASTASTE LEIBKONNALIHKMETE KOHTA: Juhul, kui ta teeb tasustatud tööd, siis millise koormusega ta töötab? PALUN VALIGE ÜKS VASTUS	1	2	3	4	5	6	7
	1. Ei tee tasustatud tööd →A08	1	1	1	1	1	1	1
	2. Täiskoormusega (35 või rohkem tundi nädalas) →A09	2	2	2	2	2	2	2

	3. Osakoormusega (vähem kui 35 tundi nädalas)→A09	3	3	3	3	3	3	3
	98. Ei oska öelda→A09	4	4	4	4	4	4	4

A08	Mis põhjusel ta ei tööta? VÕIB VALIDA MITU VASTUST	1	2	3	4	5	6	7
	1. Õpib koolis/ülikoolis	1	1	1	1	1	1	1
	2. Rasedus- või sünnituspuhkus	2	2	2	2	2	2	2
	3. Lapsehoolduspuhkus	3	3	3	3	3	3	3
	4. Vajadus hoolitseda puudega lapse/laste eest	4	4	4	4	4	4	4
	5. Vajadus hoolitseda puudeta lapse/laste eest	5	5	5	5	5	5	5
	6. Vajadus hoolitseda puudega täiskasvanud pereliikme(te) eest	6	6	6	6	6	6	6
	7. Vajadus hoolitseda puudeta täiskasvanud pereliikme(te) eest	7	7	7	7	7	7	7
	8. Enda puude või terviseprobleemi tõttu	8	8	8	8	8	8	8
	9. Ei ole leidnud oma erialale või oskustele vastavat tööd	9	9	9	9	9	9	9
	10. Ei ole leidnud sobiva töökoormuse või -graafikuga tööd	10	10	10	10	10	10	10
	11. Puudub transport, et saaks tööl käia	11	11	11	11	11	11	11
	12. Ei soovi tööl käia	12	12	12	12	12	12	12
	13. Muu (mis?) _____	13	13	13	13	13	13	13
	98. Ei oska öelda	98	98	98	98	98	98	98

A09	Kas tal on hetkel kehtiv, ametlikult määratud puue? PALUN VALIGE ÜKS VASTUS	1	2	3	4	5	6	7
	1. Jah→A10	1	1	1	1	1	1	1
	2. Ei →LEIBKONNALIIKME OSA LÕPP	2	2	2	2	2	2	2
	98. Ei oska öelda →LEIBKONNALIIKME OSA LÕPP	98	98	98	98	98	98	98

A10	Milline on talle ametlikult määratud puuderaskusaste? PALUN VALIGE ÜKS VASTUS	1	2	3	4	5	6	7
	1. Keskmine →LEIBKONNALIIKME OSA LÕPP	1	1	1	1	1	1	1
	2. Raske →LEIBKONNALIIKME OSA LÕPP	2	2	2	2	2	2	2
	3. Sügav →LEIBKONNALIIKME OSA LÕPP	3	3	3	3	3	3	3
	98. Ei oska öelda →LEIBKONNALIIKME OSA LÕPP	98	98	98	98	98	98	98

OSA B. PUUDEGA LAPSE TERVIS

Järgnevatele küsimustele vastates mõelge oma leibkonnas kasvava puudega lapse peale.

Juhul, kui Teie leibkonnas on mitu puudega last, siis lähtuge vastamisel sellest lapsest, kellele viidati uuringut tutvustavas kirjas.

B01. Milliste funktsioonide kõrvalekalded on lapsel ametlikult tuvastatud?

Mitme funktsiooni kõrvalekalde puhul märkige kõik sobivad.

1. Keele- või kõnefunktsiooni kõrvalekalle →B03
2. Kuulmisfunktsiooni kõrvalekalle →B03
3. Nägemisfunktsiooni kõrvalekalle→B03
4. Liikumisfunktsiooni kõrvalekalle →B03
5. Vaimse funktsiooni kõrvalekalle → B03
6. Muu funktsiooni kõrvalekalle, mis? _____→B02
7. Ei oska öelda→B02

B02. Millise haiguse või terviseprobleemi tõttu tuvastati lapsel hetkel kehtiv funktsiooni kõrvalekalle?

Vajadusel valige mitu varianti, kui need olid funktsiooni kõrvalekalde määramisel aluseks.

1. Diabeet ehk suhkrutõbi
2. Epilepsia
3. Astma
4. Südamehaigus
5. Muu, mis? _____
98. Ei oska öelda

B03. Mitmel korral viimase 12 kuu jooksul on puudega laps kasutanud järgnevaid meditsiiniteenuseid?

Arvesse lähevad ka need korrad, kui seoses puudega lapse tervisega on arsti/õe poole pöördunud keegi teine.

PALUN MÄRKIGE ÜKS VASTUS IGAL REAL

	1-2 kord a	3-5 korda	6-10 korda	Enam kui 10 korda	Mitte kordagi, kuigi oleks teenust vajanud	Mitte kordagi, sest pole teenust vajanud	Ei oska öelda
1. Perearst/-õde (sh konsultatsioon telefoni teel)	1	2	3	4	5	6	98
2. Eriarst (sh konsultatsioon telefoni teel)	1	2	3	4	5	6	98
3. Kiirabi või erakorralise meditsiini osakond	1	2	3	4	5	6	98
4. Hambaarst	1	2	3	4	5	6	98
5. Haiglaravi	1	2	3	4	5	6	98

JUHUL KUI MÕNE TEENUSE OSAS B03=5, SIIS KÜSIDA:

B04A. Palun täpsustage, miks laps seda teenust ei kasutanud, kuigi ta teenust vajab?

KUVADA TEENUSE NIMI

KÜSIDA AINULT NENDE TEENUSTE KOHTA, MIDA ON KASUTATUD (B03 =1-4). JUHUL, KUI LAPS EI OLE ÜHTEGI KASUTANUD (KÕIK VASTUSED B03 = 5,6 VÕI 98), SIIS LIIGU EDASI B05

B04B. Kas nende meditsiiniteenustega, mida puudega laps viimase 12 kuu jooksul kasutas, esines järgnevaid probleeme? Hinnake iga meditsiiniteenust eraldi:

VÕIB OLLA MITU VASTUST

	Perearst/ -õde	Eriarst	Kiirabi või erakorralise meditsiini osakond	Hambaarst	Haiglaravi
Puudele vastavate ravi- või abivahendite puudumine	1	1	1	1	1
Vale ravi või diagnoosi määramine/õige diagnoosi määramata jätmine	2	2	2	2	2
Vajalikele uuringutele mitte suunamine/analüüside mitte tegemine	3	3	3	3	3
Vajaliku spetsialisti (nt füsioterapeudi, logopeedi jms) juurde mitte suunamine	4	4	4	4	4
Raskused vastuvõtuaaja broneerimisega	5	5	5	5	5
Pikk ootejärjekord	6	6	6	6	6
Füüsiline ligipääsetavus ruumidele oli takistatud	7	7	7	7	7
Halb suhtumine	8	8	8	8	8
Muu probleem, mis? _____	9	9	9	9	9
Ei ole probleeme olnud	10	10	10	10	10

B05. Kas puudega laps on viimase 12 kuu jooksul kasutanud järgnevaid meditsiiniteenuseid? Kui jah, siis kas laps on kasutanud teenust nii palju, kui vajab? Kui ei, siis kas laps vajab seda teenust?

PALUN MÄRKIGE ÜKS VASTUS IGAL REAL

	On kasutanud nii palju, kui vaja	On kasutanud, aga vähem, kui tegelikult vajaks	Ei ole kasutanud, aga vajaks	Ei ole kasutanud, sest ei vaja	Ei tea seda teenust	Ei oska öelda
1. Õöpäevaringne õendusabi raviastutuses (hooldusravi)	1	2	3	4	5	98
2. Koduõendusteenus	1	2	3	4	5	98
3. Taastusravi (pere- või eriarsti suunamisega taastusraviteenused)	1	2	3	4	5	98

B06. Kas olete kunagi puudega lapse tervisega seoses pöördunud mittetraditsioonilise ehk alternatiivse meditsiini poole?

PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Jah → *B07*
2. Ei → *LIIGU EDASI OSA C*
3. Ei oska öelda → *LIIGU EDASI OSA C*

B07. Mis põhjusel pöördusite puudega lapse tervisega seoses alternatiivse meditsiini poole?

OSA C PUUDEGA LAPSE TOIMETULEK

Järgnevatele küsimustele vastates mõelge jätkuvalt oma leibkonnas kasvava puudega lapse peale. Juhul, kui Teie leibkonnas on mitu puudega last, siis lähtuge vastamisel sellest lapsest, kellele viidati uuringut tutvustavas kirjas.

C01. Mil määral vajab laps puude tõttu järgnevate tegevuste juures kõrvalabi?

PALUN MÄRKIGE ÜKS VASTUS IGAL REAL

	Vajab pidevalt kõrvalabi	Vajab aeg-ajalt kõrvalabi	Ei vaja üldse kõrvalabi	Laps ei tegele sellega/ on liiga noor	Ei oska öelda
1. Tegevused ja õppimine koolis või lasteaias	1	2	3	4	98
2. Suhtlemine	1	2	3	4	98
3. Liikumine kodus	1	2	3	4	98
4. Liikumine väljaspool kodu	1	2	3	4	98
5. Enda eest hoolitsemine (nt söömine, pesemine, tualetis käimine, riietumine)	1	2	3	4	98
6. Vaba aja veetmine (sh huviringid)	1	2	3	4	98

C02. Kas laps vajab toimetulekuks järgnevaid abivahendeid?

PALUN MÄRKIGE ÜKS VASTUS IGAL REAL

	Jah, vajab	Ei vaja	Ei oska öelda
1. Nägemisabivahendid	1	2	98
2. Kuulmisabivahendid	1	2	98
3. Liikumisabivahendid	1	2	98
4. Proteesid ja ortoosid	1	2	98
5. Spetsiifilised suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid (nt punktkirja varustus, ekraani suurendaja)	1	2	98
6. Pöetus- ja hooldusvahendid	1	2	98
7. Muud, mida? _____	1	2	98

KÜSIDA AINULT NENDE ABIVAHENDITE KOHTA, MIS C02 = 1

C03. Kas laps kasutab järgnevaid abivahendeid? Kui jah, kas need vastavad lapse vajadustele?

PALUN MÄRKIGE ÜKS VASTUS IGAL REAL

	Kasutab ja abivahendid vastavad lapse vajadustele	Kasutab, aga abivahendid ei vasta lapse vajadustele	Ei kasuta	Ei oska öelda
1. Nägemisabivahendid	1	2	3	98
2. Kuulmisabivahendid	1	2	3	98
3. Liikumisabivahendid	1	2	3	98
4. Proteesid ja ortoosid	1	2	3	98
5. Spetsiifilised suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid (nt punktkirja varustus, ekraani suurendaja)	1	2	3	98
6. Põetus – ja hooldusvahendid	1	2	3	98
7. Muud	1	2	3	98

KÜSIDA IGA ABIVAHENDI KOHTA, MIS C03=3

C04. Miks laps neid abivahendeid ei kasuta?

KÜSIDA IGA ABIVAHENDI KOHTA, MIS C03=2

C05. Miks abivahend ei vasta lapse vajadustele?

OSA D. PUUDEGA LAPSE SOTSIAALTEENUSED

Järgnevatele küsimustele vastates mõelge jätkuvalt oma leibkonnas kasvava puudega lapse peale. Juhul, kui Teie leibkonnas on mitu puudega last, siis lähtuge vastamisel sellest lapsest, kellele viidati uuringut tutvustavas kirjas.

D01. Kas olete (laps või teised leibkonnaliikmed) lapse puude tõttu viimase 12 kuu jooksul kasutanud järgnevaid sotsiaalteenuseid?

Kui jah, siis kas olete kasutanud teenust nii palju, kui vajate? Kui ei, siis kas vajate seda teenust?

PALUN MÄRKIGE ÜKS VASTUS IGALE REALE

	On kasutanud nii palju, kui vaja	On kasutanud, aga vähem, kui tegelikult vajaks	Ei ole kasutanud, aga vajaks	Ei ole kasutanud, sest ei vaja	Ei tea seda teenust	Ei oska öelda
1. Tugiisik lapsele või perele	1	2	3	4	5	98
2. Sotsiaaltransport	1	2	3	4	5	98
3. Lapsehoiuteenus	1	2	3	4	5	98
4. Sotsiaaltöötaja poolne nõustamine	1	2	3	4	5	98

5. Rehabilitatsiooniplaani koostamine, täitmise juhendamine või tulemuste hindamine	1	2	3	4	5	98
6. Füsioterapeut	1	2	3	4	5	98
7. Tegevusterapeut	1	2	3	4	5	98
8. Loovterapeut	1	2	3	4	5	98
9. Logopeed	1	2	3	4	5	98
10. Eripedagoog	1	2	3	4	5	98
11. Psühholoog	1	2	3	4	5	98
12. Kogemusnõustaja	1	2	3	4	5	98
13. Mõni muu teenus, mis? _____	1	2	3	4	5	98
14. Mõni muu teenus, mis? _____	1	2	3	4	5	98
15. Mõni muu teenus, mis? _____	1	2	3	4	5	98

D02A. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul puudega lastele suunatud sotsiaalteenuste saamisel või taotlemisel kogenud järgnevaid probleeme?

VÕIB VALIDA MITU VASTUST

1. Teenuse maht oli liiga väike
2. Teenuse maksumus oli meie jaoks liiga kallis
3. Teenust pakuti meist liialt kaugel
4. Teenuse saamisega seotud asjaajamine oli keerukas
5. Teenuste pakkumise kohad olid liialt hajutatud
6. Teenusepakkuja lahtioleku aeg oli ebasobiv
7. Teenusele saamise järjekord oli pikk
8. Teenusepakkuja suhtus puudega lapsesse halvustavalt
9. Teenust pakkuvale asutusele oli halb juurdepääs
10. Puudus transport kohta, kus teenust osutatakse
11. Vanemal/hooldajal puudus majutusvõimalus teenuseosutaja juures või oli majutus liiga kallis
12. Vanem/hooldaja ei saanud töölt ära käia, mistõttu ei olnud võimalik lapsega teenusele minna
13. Teise lapse/teiste laste hooldamiskohustuse tõttu ei olnud võimalik lapsega teenusele minna
14. Teiste täiskasvanute hooldamiskohustuse tõttu ei olnud võimalik lapsega teenusele minna
15. Pakutav teenus ei vastanud lapse vajadustele
16. Ei olnud teadlik õigusest teenust saada
17. Ei olnud teadlik pakutavatest teenustest
18. Ei saanud kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötajalt vajalikku abi
19. Muu probleem, mis? _____
98. Pole probleeme kogenud
99. Pole viimase 12 kuu jooksul sotsiaalteenuseid saanud ega taotlenud

KÜSIDA D02B, KUI KÜSIMUSES D02A KATEGOORIA 15 =1 (ON KOGENUD)

D02B. Miks ei vastanud pakutav teenus lapse vajadustele?

D03. Kas lapsel oli viimase 12 kuu jooksul (sh ka lühema aja vältel) kehtiv rehabilitatsiooniplaan (sh rehabilitatsiooniprogramm või tegevuskava)? PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Jah → D04
2. Ei → LIIGU EDASI OSA E
98. Ei oska öelda → LIIGU EDASI OSA E

D04. Kas laps on saanud rehabilitatsiooniteenuseid viimase 12 kuu jooksul? PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Jah, on saanud kõiki teenuseid ettekirjutatud mahus → LIIGU EDASI OSA E
2. Jah, on saanud, kuid mitte kõiki teenuseid ettekirjutatud mahus → D05
3. Ei ole üldse saanud → D05
98. Ei oska öelda → LIIGU EDASI OSA E

D05. Miks laps pole rehabilitatsiooniteenuseid üldse saanud või pole saanud ettekirjutatud mahus? VÕIB OLLA MITU VASTUST

1. Puudus transport
2. Ei saanud võtta töölt vaba aega, et lapsega teenusele minna
3. Lapsel polnud tegelikult kõiki talle määratud teenuseid vaja
4. Teenusele oli liiga pikk järjekord
5. Muu põhjus, mis? _____
98. Ei oska öelda

D06. Palun nimetage, milliseid rehabilitatsiooniplaanis (sh -programmis või tegevuskavas) ette kirjutatud rehabilitatsiooniteenuseid pole laps saanud?

OSA E PUUDEGA LAPSE HARIDUS

Järgnevale küsimustele vastates mõelge jätkuvalt oma leibkonnas kasvava puudega lapse peale. Juhul, kui Teie leibkonnas on mitu puudega last, siis lähtuge vastamisel sellest lapsest, kellele viidati uuringut tutvustavas kirjas.

E01. Kas laps õppis või käis viimasel õppeaastal (2016/2017)...?

PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. lasteaias või sõimes → E03
2. koolis (sh koduõppel või haiglaõppel) → E04
3. ei käinud lasteaias/sõimes ega koolis, sest on liiga noor → LIIGU EDASI OSA F
4. ei käinud lasteaias/sõimes ega koolis muudel põhjustel. Palun täpsustage: _____ → E02

KÜSIDA E02, KUI LAPS ON VÄHEMALT 15-AASTANE. ÜLEJÄÄNUD LIIGUVAD EDASI OSA F

E02. Milline on lapse kõrgeim lõpetatud haridustase?

PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Põhihariduseta (vähem kui 9 klassi) → LIIGU EDASI OSA F
2. Põhiharidus (9 klassi) → LIIGU EDASI OSA F
3. Kesk- või gümnaasiumiharidus (12 klassi) → LIIGU EDASI OSA F
4. Kutseharidus põhihariduseta → LIIGU EDASI OSA F
5. Kutseharidus põhihariduse baasil → LIIGU EDASI OSA F
6. Kutsekeskharidus → LIIGU EDASI OSA F
98. Ei oska öelda → LIIGU EDASI OSA F

E03. Millises lasteaia ja rühmas laps viimasel õppeaastal (2016/2017) käis?

PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Tavalasteaia tavarühmas →E07A
2. Tavalasteaia erirühmas või sobitusrühmas →E07A
3. Erilasteaia →E07A
4. Muu, mis? _____ →E07A

E04. Millisel kooliastmel laps viimasel õppeaastal (2016/2017) õppis?

PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Põhiharidus 1. – 3. klass
2. Põhiharidus 4. – 6. klass
3. Põhiharidus 7. – 9. klass (sh pikendatud õpe)
4. Lisaõpe (põhihariduse järgne lisa-aasta põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi põhikooli lõpetanutele)
5. Üldkeskharidus (sh gümnaasium) →E07B
6. Põhihariduse nõudeta kutseõpe →E07B
7. Põhihariduse baasil kutseõpe →E07B
8. Kutsekeskhariduse õpe →E07B
98. Ei oska öelda

E05. Kas viimase õppeaasta (2016/2017) lõpus õppis laps...?

PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Tavakoolis tavaklassis
2. Tavakoolis eriklassis
3. Tavakoolis osaliselt tavaklassis ja osaliselt eraldi klassis/rühmas/individuaalselt
4. Erikoolis
5. Haiglaõppel
6. Koduõppel
7. Muu, mis? _____

E06. Millise õppekava alusel laps viimasel õppeaastal (2016/2017) õppis?

PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Põhikooli riiklik õppekava →E07B
2. Lihtsustatud õpe→E07B
3. Toimetulekuõpe →E07B
4. Hooldusõpe→E07B
98. Ei oska öelda →E07B

KÜSIDA E07A, KUI E01=1 (LAPS KÄIS LASTEAIAS VÕI SÕIMES)

E07A. Kas seoses puudega lapse käimisega lasteaias/sõimes esines viimasel õppeaastal (2016/2017) järgnevaid probleeme? PALUN MÄRKIGE ÜKS VASTUS IGAL REAL

	Jah, probleem esines	Probleemi ei esinenud	See teema last ei puuduta (pole meile oluline)	Ei oska öelda
1. Lasteaed on liiga kaugel	1	2	3	98
2. Transport lasteaeda on väga kulukas	1	2	3	98
3. Õpperuumid lasteaias ei vasta lapse vajadustele	1	2	3	98
4. Lapsel on raskused lasteaiahoonesse sissepääsemisel ja hoones liikumisel	1	2	3	98
5. Logopeedi abi lasteaias puudub või on ebapiisav	1	2	3	98
6. Eripedagoogi abi lasteaias puudub või on ebapiisav	1	2	3	98
7. Sotsiaalpedagoogi abi lasteaias puudub või on ebapiisav	1	2	3	98
8. Psühholoogi abi lasteaias puudub või on ebapiisav	1	2	3	98
9. Füsioterapeudi abi lasteaias puudub või on ebapiisav	1	2	3	98
10. Tugiisiku (kes vajadusel last lasteaias individuaalselt aitaks) abi lasteaias puudub või on ebapiisav	1	2	3	98
11. Lasteaias ei ole kohapeal vajadusel võimalik saada rehabilitatsiooniteenuseid	1	2	3	98
12. Puuduvad puudega lapsele vajalikud spetsiaalsed õppevahendid	1	2	3	98
13. Õpetajatel puuduvad oskused või teadmised puudega lapse õpetamiseks	1	2	3	98
14. Õpetajad suhtuvad puudega lapsesse eelarvamusega	1	2	3	98
15. Lapse puude tõttu esines probleeme teiste laste või nende vanematega	1	2	3	98
16. Muu oluline probleem, palun täpsusta: _____	1	2	3	98

KÜSIDA E07B, KUI E01=2 (LAPS KÄIS KOOLIS)

E07B. Kas seoses puudega lapse käimisega koolis esines viimasel õppeaastal (2016/2017) järgnevaid probleeme? PALUN MÄRKIGE ÜKS VASTUS IGAL REAL

	Jah, probleem esines	Probleemi ei esinenud	See teema last ei puuduta (pole meile oluline)	Ei oska öelda
Füüsiline kaugus ja ruumidele ligipääs				
1. Kool on liiga kaugel	1	2	3	98

2. Transport kooli on väga kulukas	1	2	3	98
3. Õpperuumid koolis ei vasta lapse vajadustele	1	2	3	98
4. Lapsel on raskused koolihoonesse sissepääsemisel ja hoones liikumisel	1	2	3	98
Tugimeetmete kättesaadavus ja olemasolu haridusasutuses				
5. Logopeedi abi koolis puudub või on ebapiisav	1	2	3	98
6. Eripedagoogi abi koolis puudub või on ebapiisav	1	2	3	98
7. Sotsiaalpedagoogi abi koolis puudub või on ebapiisav	1	2	3	98
8. Psühholoogi abi koolis puudub või on ebapiisav	1	2	3	98
9. Füsioterapeudi abi koolis puudub või on ebapiisav	1	2	3	98
10. Tugiisiku (kes vajadusel last koolis individuaalselt aitaks) abi koolis puudub või on ebapiisav	1	2	3	98
11. Koolis ei ole kohapeal vajadusel võimalik saada rehabilitatsiooniteenuseid	1	2	3	98
12. Pikapäevarühm või lapsehoiuteenus koolis ei vasta meie leibkonna vajadustele	1	2	3	98
Õppe vastavus vajadustele				
13. Puuduvad puudega lapsele vajalikud spetsiaalsed õppevahendid	1	2	3	98
14. Õppekava, mille järgi laps õpib, ei ole talle jõukohane	1	2	3	98
15. Õpetaja(te)l puuduvad oskused või teadmised puudega lapse õpetamiseks	1	2	3	98
16. Klassis puudub abiõpetaja	1	2	3	98
Sotsiaalne keskkond				
17. Õpetaja(d) suhtuvad puudega lapsesse eelarvamusega	1	2	3	98
18. Lapse puude tõttu esines probleeme kaasõpilaste või nende vanematega	1	2	3	98
Õppevormi vastavus				
19. Lapsele ei võimaldatud õppimist eriklassis, väikeklassis või üks-ühele õppel.	1	2	3	98
20. Lapsele ei võimaldatud õppimist tavaklassis või koos tavaklassi õpilastega	1	2	3	98
21. Laps on olnud sunnitud viibima koduõppel pikemalt või rohkem aega, kui soovitud	1	2	3	98
22. Lapsel pole võimaldatud õppida koduõppel või suurendada koduõppe mahtu	1	2	3	98
23. Muu oluline probleem, palun täpsusta: _____	1	2	3	98

OSA F. TEAVE PUUETEGA LASTELE SUUNATUD TOETUSTE JA TEENUSTE KOHTA JA PROBLEEMID

F01. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul puuetega lastele suunatud rahaliste toetuste taotlemisel kogenud järgnevaid probleeme?

VÕIB VALIDA MITU VASTUST

1. Puudus info pakutavatest toetustest
2. Puudus info selle kohta, kellel on õigus toetust saada
3. Toetuse taotlemine oli keeruline
4. Toetuse taotlemise protsess oli liiga pikk
5. Määratud toetus oli liiga väike
6. Muu probleem, mis? _____
98. Pole probleeme kogenud
99. Pole viimase 12 kuu jooksul rahalisi toetusi taotlenud

F02. Millistes allikatest Te olete saanud infot puuetega lastele suunatud toetuste, teenuste ja abi kohta?

VÕIB VALIDA MITU VASTUST

1. Kohalikust omavalitsusest (sh sotsiaaltöötajalt)
2. Sotsiaalkindlustusametist
3. Rehabilitatsiooniasutusest
4. Koolitustelt/ seminaridelt
5. Nõustamiskeskustest puuetega lastele ja nende vanematele ning hooldajatele
6. Puuetega inimeste või puuetega laste vanemate ühendustest /organisatsioonidest
7. Perearstilt, -õelt
8. Eriarstilt
9. Lapse õpetajatelt või kasvatajatelt
10. Tugiisikult
11. Teistelt puuetega laste vanematelt
12. Lähedastelt või tuttavatelt
13. Televisioonist või raadiost
14. Tervise- või pereajakirjade artiklitest
15. Erialasest kirjandusest
16. Internetist teemakohastelt kodulehekülgedelt
17. Internetist sotsiaalvõrgustikest (nt Facebook) või foorumitest
18. Mujalt, kust? _____
19. Mitte kuskilt (pole infot saanud)
98. Ei oska öelda

F03. Kuivõrd kättesaadav on Teie hinnangul info puuetega lastele suunatud toetuste, teenuste ja abi kohta? PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Info on väga raskesti kättesaadav → F04
2. Info on pigem raskesti kättesaadav → F04
3. Info on pigem kergesti kättesaadav → LIIGU EDASI OSA G
4. Info on väga kergesti kättesaadav → LIIGU EDASI OSA G
98. Ei oska öelda → LIIGU EDASI OSA G

F04. Palun kirjeldage täpsemalt, milline info on olnud Teile raskesti kättesaadav?

OSA G. HOOLDUSKOORMUS

G01. Milliseks Te hindate oma teadmisi järgnevates lapse kasvatamisega seotud valdkondades?

PALUN MÄRKIGE ÜKS VASTUS IGAL REAL

	Teadmised puuduvad	Vähe teadmisi	Piisavad teadmised	Head teadmised	Ei oska öelda
Lapse tervise ja tervisliku eluviisiga seonduv	1	2	3	4	98
Lapse areng (füüsiline, emotsionaalne, sotsiaalne)	1	2	3	4	98
Konfliktide lahendamine pereliikmete vahel	1	2	3	4	98
Korrale kutsumine ja jonniva lapse rahustamine	1	2	3	4	98
Laste internetiohutus	1	2	3	4	98

G02. Juhul, kui on mõni (Teie puudega lapsega seonduv) teema, mille osas vajaksite senisest rohkem infot, siis palun kirjeldage seda siin:

G03. Kui sageli lisaks Teile hoiab või hooldab puudega last keegi teine? Juhul, kui peres on mitu puudega last, siis mõelge sellele lapsele, kellele viitasime uuringut tutvustavas kirjas.

PALUN MÄRKIGE ÜKS VASTUS IGAL REAL

	Iga päev või peaaegu iga päev	Mõned korrad nädalas	Kord nädalas	Kord või mõned korrad kuus	Harve mini	Mitte üldse	Ei oska öelda
1. Mõni muu leibkonnaliige	1	2	3	4	5	6	98
2. Pereliige või sugulane väljastpoolt Teie leibkonda	1	2	3	4	5	6	98
3. Lapsehoidja	1	2	3	4	5	6	98
4. Tugiisik	1	2	3	4	5	6	98
5. Keegi muu, kes? _____	1	2	3	4	5	6	98

G04. Millal on Teil regulaarselt vaja puudega lapsele lapsehoiuvõimalust ja kas saate seda piisavalt kasutada? PALUN MÄRKIGE ÜKS VASTUS IGAL REAL

	Jah, on vaja ja saame piisavalt kasutada	Jah, on vaja, kuid ei saa piisavalt kasutada	Ei ole regulaarselt vaja	Ei oska öelda
1. Tööpäevade hommikul (enne lõunat)	1	2	3	98
2. Tööpäevade pärastlõunal	1	2	3	98
3. Tööpäevade õhtul	1	2	3	98
4. Öösiti	1	2	3	98
5. Nädalavahetustel või riiklikel pühadel	1	2	3	98
6. Koolivaheaegadel	1	2	3	98

G05. Millised järgnevaid lapse hoidmise võimalusi Te olete viimase 12 kuu jooksul puudega lapse jaoks kasutanud? VÕIB VALIDA MITU VASTUST

1. Lasteaed või lastesõim
2. Lapsehoidja, kes tuleb koju
3. Lapsehoidja, kes vaatab last enda kodus
4. Puudega laste lastehoid
5. Tavalaste hoid
6. Pikapäevarühm
7. Kooli juures asuv õpilaskodu
8. Päevakeskus
9. Muu, mis? _____
10. Ei ole kasutanud ühtegi lapse hoidmise võimalust

G06. Milliseid lapse hoidmise võimalusi oleks Teie leibkonnas kasvava puudega lapse jaoks täiendavalt vaja või mida oleks Teil vaja kasutada senisest rohkem? VÕIB VALIDA MITU VASTUST

1. Lasteaed või lastesõim
2. Lapsehoidja, kes tuleb koju
3. Lapsehoidja, kes vaatab last enda kodus
4. Puudega laste lastehoid
5. Tavalaste hoid
6. Pikapäevarühm
7. Kooli juures asuv õpilaskodu
8. Päevakeskus
9. Muu, mis? _____
10. Ei vaja täiendavaid lapse hoidmise võimalusi
98. Ei oska öelda

G07. Milline spetsiaalne ettevalmistus peaks olema Teie hinnangul Teie leibkonnas kasvava puudega lapse eest hoolitseval isikul või hoidjal?

VÕIB VALIDA MITU VASTUST

1. Meditsiiniliste protseduuride läbiviimise oskus
2. Lapse puudest tulenevate erivajadustega toimetulemise oskus
3. Puudega lapse hoidmise kogemus
4. Muu, mis? _____
5. Meie leibkonnas kasvava puudega lapse hoidmiseks ei ole vaja spetsiaalset ettevalmistust
98. Ei oska öelda

G08. Mitmel korral viimase 12 kuu jooksul olete Teie ise pidanud puudega lapse/laste hoidmise või hooldamise tõttu ...?

PALUN MÄRKIGE ÜKS VASTUS IGAL REAL

	Korduvalt	Ühel korral	Mitte kordagi	Ei käi minu kohta (kuna ei õppinud või ei töötanud)	Ei oska öelda
1. vahetama töökohta	1	2	3	97	98
2. vähendama töökoormust	1	2	3	97	98
3. loobuma tööl käimisest	1	2	3	97	98
4. võtma tööst vabu päevi või tunde, mille peab hiljem tagasi töötama	1	2	3	97	98
5. võtma palgata puhkust	1	2	3	97	98
6. võtma hoolduslehe	1	2	3	97	98
7. vähendama õppekoormust	1	2	3	97	98
8. loobuma õppimisest	1	2	3	97	98

G09. Kui sageli viimase 12 kuu jooksul olete puudega lapse/laste hoidmise või hooldamise tõttu soovitud vähem..?

PALUN MÄRKIGE ÜKS VASTUS IGAL REAL

	Sageli	Mõnikord	Harva	Mitte kunagi	Ei oska öelda
1. veetnud aega koos oma pere või leibkonnaliikmetega	1	2	3	4	98
2. veetnud aega koos oma sõprade ja tuttavatega	1	2	3	4	98
3. tegelenud oma huvialade, hobide või meelelahutusega.	1	2	3	4	98
4. omanud aega, et lihtsalt puhata.	1	2	3	4	98
5. teinud midagi muud soovitud vähem, mida? _____	1	2	3	4	98

G10. Kas Te abistate või hooldate peale Teie leibkonnas kasvava(te) lapse/laste veel kedagi oma leibkonnast või väljastpoolt leibkonda?

PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Jah, oma leibkonnas
2. Jah, väljastpoolt leibkonda
3. Ei

G11. Kuivõrd Teie ise vajate lisaabi puudega lapse või teiste hooldatavate abistamisel või hooldamisel?

PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Vajan olulist lisaabi →G12
2. Vajan mõningat lisaabi→G12
3. Ei vaja üldse lisaabi →LIIGU EDASI OSA H
98. Ei oska öelda →LIIGU EDASI OSA H

G12. Millist lisaabi puudega lapse või teiste hooldatavate abistamisel või hooldamisel Teie ise kõige enam vajaksite?

OSA H. LEIBKONNA SOTSIAALMAJANDUSLIK TOIMETULEK JA VÕIMALUSED

H01. Millist tüüpi elamus on Teie leibkonna eluruum?

PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Ühepereelamu (sh. talumaja)
2. Kahepereelamu
3. Ridaelamu
4. Kortereelamu
5. Ühiselamu
6. Muu (mis?) _____
98. Ei oska öelda

H02. Kui suur on Teie leibkonna käsutuses oleva eluruumi üldpind ruutmeetrites?

_____ m²

98 Ei oska öelda

Juhul, kui peres on mitu puudega last, siis mõelge järgnevatele küsimustele vastates sellele lapsele, kellele viitasime uuringut tutvustavas kirjas.

H03. Millised järgnevatest tingimustest takistavad puudega lapsel eluruumi sissepääsemist või eluruumis igapäevaste tegevustega toimetulekut?

VÕIB VALIDA MITU VASTUST

1. Sobimatu mööbel
2. Sobimatud lülitid või lingid
3. Trepid, ukseavad või lävepakud
4. Lifti puudumine
5. Sobimatu temperatuur eluruumis
6. Müra
7. Niisku
8. Allergeenid keskkonnas
9. Halb valgustus
10. Sobimatud pesemistingimused
11. Vähe ruumi
12. Muu, mis? _____
13. Takistavaid tingimusi ei ole
98. Ei oska öelda

H04. Kas Teie leibkonna eluruum on kohandatud puudega lapse erivajadusteks?

PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Jah, on täielikult kohandatud → H06
2. Jah, on osaliselt kohandatud, kuid vajab veel kohandusi → H05
3. Ei ole kohandatud, kuid vajab kohandamist → H05
4. Ei ole kohandatud ning selle järele puudub vajadus → H07
98. Ei oska öelda → H07

H05. Mida on vaja kohandada, et eluruum vastaks puudega lapse erivajadustele?

KÜSIDA H06 AINULT SIIS, KUID H04= 1 VÕI 2, ÜLEJÄÄNUD LIIGUVAD EDASI H07

H06. Kas Te kasutasite kohandamiseks eluruumi kohandamise teenust (eksperthinnanguga paika pandud kohandused, mille eest tasub kohalik omavalitsus)? PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Jah, kasutasime ainult eluruumi kohandamise teenust → *H07*
2. Jah, kasutasime nii eluruumi kohandamise teenust kui ka oma vahendeid → *H07*
3. Ei, kohandasime ainult oma vahenditega → *H07*
98. Ei oska öelda → *H07*

H07. Kas Teie leibkonnal on auto kasutamise võimalus?

PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Jah, on võimalik autot kasutada igapäevaselt
2. Jah, on võimalik autot kasutada aeg-ajalt
3. Auto kasutamise võimalus puudub
98. Ei oska öelda

H08. Millisesse järgmistest vahemikest jääb Teie leibkonna käsutuses olev raha ühes kuus, arvestades kõiki tulusid (st kui suur on kogu leibkonna netosissetulek)?

PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Kuni 350 eurot
2. 351 kuni 550 eurot
3. 551 kuni 750 eurot
4. 751 kuni 950 eurot
5. 951 kuni 1250 eurot
6. 1251 kuni 1650 eurot
7. 1651 kuni 2300 eurot
8. 2301 eurot või rohkem
98. Ei oska öelda
99. Ei soovi avaldada

H09. Milliseid toetusi Teie leibkond saab? Palun mõelge nii endale, lapsele/lastele kui ka teistele leibkonnaliikmetele.

VÕIB VALIDA MITU VASTUST

1. Puudega lapse toetus
2. Universaalsed lastetoetused, mis ei ole seotud puudega
3. Vajaduspõhine peretoetus madala sissetulekuga peredele
4. Puudega tööealise inimese toetus
5. Töövõimetoetus
6. Pension (sh rahva-, vanadus-, ennetähtaegne- ja töövõimetuspension)
7. Toimetulekutoetus
8. Muu toetus, mis? _____
98. Ei oska öelda

Juhul, kui peres on mitu puudega last, siis mõelge järgnevatele küsimustele vastates sellele lapsele, kellele viitasime uuringut tutvustavas kirjas.

H10. Mil määral katavad puudega lapsele suunatud toetused tema puudest tingitud lisakulutusi?

PALUN VALIGE ÜKS VASTUS

1. Täiel määral
2. Suurel määral
3. Vähesel määral
4. Üldse mitte
98. Ei oska öelda

H11A. Kas Teie leibkonnal kulus viimase 12 kuu jooksul puudega lapse tarbeks raha alljärgnevale?

PALUN MÄRKIGE ÜKS VASTUS IGAL REAL

	Jah, oli kulusid	Ei, kulusid polnud	Ei oska öelda	Ei soovi avaldada
1. Ravimid, vitamiinid, toidulisandid	1	2	98	99
2. Eritoit	1	2	98	99
3. Ravi- ja rehabilitatsiooniteenused	1	2	98	99
4. Lapsehoid	1	2	98	99
5. Lasteaed	1	2	98	99
6. Tugiisik	1	2	98	99
7. Abivahendid	1	2	98	99
8. Transport	1	2	98	99
9. Muu kulu, mis? _____	1	2	98	99

KÜSIDA H11B JA H11C IGA KULUALLIKA KOHTA, MILLELE VASTAJAL OLI KULUTUSED (KÜSIMUS H11A = 1):

H11B. Kui palju Teie leibkonnal sellele raha kulus? Palun valige, kas märgite kulud ühe kuu või viimase 12 kuu kohta.

PALUN MÄRKIGE ÜKS VASTUS IGAL REAL

	Kulud ühes kuus (keskmiselt)	Kulud viimase 12 kuu jooksul kokku	Ei oska öelda	Ei soovi avaldada
1. Ravimid, vitamiinid, toidulisandid	_____eurot kuus	_____eurot aastas	98	99
2. Eritoit	_____eurot kuus	_____eurot aastas	98	99
3. Ravi- ja rehabilitatsiooniteenused	_____eurot kuus	_____eurot aastas	98	99
4. Lapsehoid	_____eurot kuus	_____eurot aastas	98	99
5. Lasteaed				
6. Tugiisik	_____eurot kuus	_____eurot aastas	98	99
7. Abivahendid	_____eurot kuus	_____eurot aastas	98	99
8. Transport	_____eurot kuus	_____eurot aastas	98	99
9. Muu	_____eurot kuus	_____eurot aastas	98	99

H11C. Kas need kulutused olid piisavad, st kas need katsid puudega lapse vajadused?*PALUN MÄRKIGE ÜKS VASTUS IGAL REAL*

	Jah	Ei	Ei oska öelda
1. Ravimid, vitamiinid, toidulisandid	1	2	98
2. Eritoit	1	2	98
3. Ravi- ja rehabilitatsiooniteenused	1	2	98
4. Lapsehoid	1	2	98
5. Lasteaed	1	2	98
6. Tugiisik	1	2	98
7. Abivahendid	1	2	98
8. Transport	1	2	98
9. Muu	1	2	98

H12. Mõeldes oma leibkonna kogusissetulekule, kuidas Teie leibkond tuleb vajalike kulutuste tegemisel ots otsaga kokku?*PALUN VALIGE ÜKS VASTUS*

1. Suurte raskustega
2. Raskustega
3. Mõningate raskustega
4. Üpriski hõlpsalt
5. Hõlpsalt
6. Väga hõlpsalt

H13. Kas viimase 12 kuu jooksul juhtus, et Teie leibkond ei suutnud majanduslikel põhjustel maksta tähtjaks ...? PALUN MÄRKIGE ÜKS VASTUS IGAL REAL

	Jah, seda juhtus ühel korral	Jah, seda juhtus kahel või enamal korral	Ei, seda ei juhtunud	Seda kulu ei ole	Ei soovi vastata
1 ...üüri	1	2	3	4	99
2 ...kommunaalmakseid ja teenustasusid (küte, elekter, vesi, gaas jm)	1	2	3	4	99
3 ...eluasemelaenu tagasimakset	1	2	3	4	99

OSA I. SOTSIAALSED SUHTED JA VÕRGUSTIKUD**I01 Kas Teie või keegi Teie leibkonnast on mõne puuetega inimeste või puuetega laste vanemate ühenduse või organisatsiooni liige? PALUN VALIGE ÜKS VASTUS**

1. Jah
2. Ei
98. Ei oska öelda

I02 Kui mõtlete oma kogemustele puudega lapse hooldajana, siis kuivõrd nõustute järgnevate väidetega?

PALUN MÄRKIGE ÜKS VASTUS IGAL REAL

	Täiesti nõus	Pigem nõus	Pigem ei ole nõus	Üldse ei ole nõus	Ei oska öelda
Ma ei julge alati oma puudega lapse probleemidest ja vajadustest rääkida	1	2	3	4	98
Ma ei julge oma puudega lapsega kodust väljas käia	1	2	3	4	98
Puudega lapse vanem peaks minu arvates olema kodune ja oma lapse hooldamisele pühenduma	1	2	3	4	98
Puudega laps peaks minu arvates kasvama kodus, mitte viibima puuetega lastele loodud asutuses	1	2	3	4	98
Puudega lapsed peaksid saama teiste lastega võrdväärselt osaleda huviringides, trennides ja üritustel	1	2	3	4	98
Puudega lapsed võiksid käia lasteaias ja koolis koos ilma puudeta lastega, saades vajadusel selleks individuaalset tuge	1	2	3	4	98
Puudega lapsed vajavad erilasteaedu ja koole, kus nad saaksid õppida ja areneda lähtuvalt oma puudega seotud erivajadustest	1	2	3	4	98
Ühiskonnas on hakatud puuetega lastega peredesse toetavamalt suhtuma	1	2	3	4	98
Avalikkuses tuleks puuetega lastega perede probleemidest rohkem rääkida	1	2	3	4	98
Puuetega lastega peresid tuleks neile mõeldud võimalustest laiemalt teavitada	1	2	3	4	98
Puuetega lastega pered saavad neid puudutavates otsustes piisavalt kaasa rääkida	1	2	3	4	98
Puuetega lastega pered peaksid ise otsima aktiivsemalt võimalusi oma toimetuleku parandamiseks	1	2	3	4	98
Puuetega lastega peresid ühendavad organisatsioonid aitavad perede olukorra paranemisele olulisel määral kaasa	1	2	3	4	98

Kui soovite veel midagi omalt poolt täiendada või lisada, siis palun tehke seda siin.

Juhul, kui soovite, et teavitaksime Teid e-maili teel uuringu tulemustest, siis palun sisestage siia oma e-mail: _____

Täname Teid küsimustele vastamise eest!